

Nevrozların Psixopatologiyası

Antoni Kempinski

Krakov Tibb İnstitutunun Psixiatriya Klinikasının direktoru, professor Antoni Kempinski (1918-1972) Polşanın ən qabaqcıl alimlərindən biri, görkəmli filosof və humanist, həmçinin "Şizofreniya" (1972), "Həyatın Ritmi" (1972), "Melanxoliya" (1974), "Qorxu" (1975), "Psixopatiya" (mətbuatda) və digər monoqrafiyaların müəllifi idi.

Bəzi tənqidçilərə görə, "Nevrozların Psixopatologiyası" Polşa ədəbiyyatında nevrozlar haqqında ən dəyərli əsərdir. Monoqrafiyada klinisyen baxımından təqdim olunan nevroitik pozğunluqların orijinal konsepsiyaları (sözdə informasiya və enerji mübadiləsi nəzəriyyəsi) var. Müəllif nəzəri məsələləri özünün uzunmüddətli müşahidələri ilə müqayisə edir. Nevrozların psixopatologiyasına yeni bir perspektiv təqdim edən professor Kempinski geniş bioloji, psixoloji və sosioloji konteksti nəzərə alır.

O, psixoterapevtik prosesin spesifik aspektlərini və hər şeydən əvvəl xəstə-həkim münasibətlərini təsvir edir ki, bu da yalnız ən yüksək formada şəxslərarası əlaqəni təmsil etmir, həm də psixoterapiyada ən vacib müalicə amilidir.

Kitab psixiatrlar, digər həkimlər və nevroz problemi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

ÖN SÖZ

Hal-hazırda yalnız mütəxəssislər, yəni psixiatrlar və psixoloqlar üçün deyil, həm də xeyli sayda oxucu üçün maraqlı olan sinir sistemi pozğunusunun psixonevroz və ya nevroz adlanan növünü qısa, lakin dəqiq şəkildə müəyyən etmək çətinidir, çünki sürətli texnoloji tərəqqi və insan bioloji mühitinin getdikcə daha çox məhv olduğu dövrdə nevrozlar getdikcə insan vəziyyətinə çevrilir.

Müasir dövr, nevroitik xüsusiyyətləri və yüksək sivilizasiya səviyyəsi ilə, stress faktorlarının və dağıntıların (flusturasiya) kəskinləşməsinə getdikcə daha çox töhfə verir ki, bu da nəticədə orqan nevrozlarının və psixosomatik xəstəliklərin yaranmasına və ya kəskinləşməsinə səbəb olur. Onların dinamikasını köhnə düşüncə çərçivələri çərçivəsində təsvir etmək getdikcə çətinləşir və hətta bu gün də nevrozların mahiyyəti, səbəbləri, gedişi və nəticələri haqqında olduqca qeyri-müəyyən, tez-tez əks və məntiqsiz anlayışlarla qarşılaşıırıq.

Son illərdə nevroitik pozuntuların psixosomatik təbiəti vurğulanmışdır. Bu fonu nəzərə almaq nevrozlara fərqli bir işıq salır.

Bu kitab nevrozlar probleminin hərtərəfli araşdırılmasını təqdim edir.

Bu mövzuda əvvəlki nəşr olunmuş əsərlər bu məsələləri daha ətraflı şəkildə təqdim etmişdir.

Bu əsər müəllifin orijinal və yeni fikirlərinə əsaslanır. Professor Antoni Kempinski psixososioloji ilə yanaşı daha geniş bir fonu əhatə etməyə çalışır və xəstənin həyat vəziyyəti, münasibətləri, tipik təcrübələri və çətinlikləri, ətraf mühitlə təması və bir çox digər elementləri vurğulayır. Müəllif sırf praktik baxımdan bu məsələləri müasir Polşa sosial həyatı fonunda təqdim edir və eyni zamanda beynəlxalq müşahidələri də özündə birləşdirir.

Vurğulamaq lazımdır ki, professor Kempinski kitabındakı məsələləri əsasən psixoloq deyil, psixopatoloq baxımından təqdim edir. Lakin o, bu tədqiqat mövzusunun bioloji izahı ilə məhdudlaşmır. Buna görə də, bu əsər xüsusilə psixoloqlar üçün maraqlı ola biləcək bir çox məsələni tam şəkildə həll etmir. Professor Kempinskinin monoqrafiyasında, məsələn, tamamlayıcı ehtiyaclar nəzəriyyəsi kimi tanınmış psixoloji məsələlərə toxunulmaması təəccüblü deyil. Şəxsiyyət strukturundakı qüsurlar və nevrozların fonu kimi problemlər sadəcə eskiz şəklində təqdim olunur; psixoterapevtik metodların və psixofarmakoloji məsələlərin təsvirləri dar çərçivədə təqdim olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, professor Kempinski Polşa klinik psixiatriyasında qrup psixoterapiyasının və sözdə psixodramanın qabaqcıllarından biri idi.

Psixiatriyada nevroz problemi hələ də xeyli müzakirələrə səbəb olur və bu mövzuda geniş ədəbiyyatda əks fikirlər mövcuddur. Professor Kempinski həkimin gündəlik işində təsdiqlənə bilən obyektiv məlumatlar təqdim etmişdir. Onun kitabından hətta təlim keçməmiş bir oxucu belə nevrozların növləri, onların əsas simptomları, səbəbləri və mənşəyi, eləcə də müalicəsi haqqında məlumat əldə edə bilər. Bundan əlavə, müəllif, mənim fikrimcə, indiyə qədər çoxsaylı nəşrlərdə səpələnmiş və dəfələrlə zəif müəyyən edilmiş fikirləri sintez etməyə uğurla cəhd etmişdir. Müəllifin ətrafındakı dünyaya qeyri-adi dərəcədə spesifik, şəxsi perspektivdən baxdığını nəzərə alsaq, "Nevrozların psixopatologiyası"nın qabaqcıl təbiəti müasir Polşa və xarici nevroz ədəbiyyatı ilə müqayisədə daha başa düşüləndir.

Müəllif uzun illərini psixopatologiya problemlərinə həsr etmişdir. Psixiatr olaraq, o, bioloji mövqeyə malikdir, lakin onun baxışlarında fəlsəfi və psixoloji düşüncə mühüm yer tutur. Məhz bu kombinasiya ona kitabın məzmununun orijinal interpretasiyasını təklif etməyə imkan vermişdi. Mövzu ilə bağlı ədəbiyyat onun üçün ikinci dərəcəli məlumat mənbəyi idi, baxmayaraq ki, o, bunu yaxşı bilirdi. O, əsasən özünün psixiatr kimi uzunmüddətli təcrübəsinə və minlərlə xəstə ilə xəstə təmaslarına güvənirdi. Kitabın nəşrə hazırlanmasında ona kömək edən yaxın əməkdaşı Yan Maslovskiye dediyi kimi, o, terapevtik təmaslarından fərdi tematik motivlər toplamış, problemləri qruplaşdırmış və indi də göründüyü kimi, getdikcə daha çox fəvqəladə orijinallığını və yeniliyini nümayiş etdirən nəticələr hazırlamışdır. "Nevrozların psixopatologiyası" Krakovdakı Tibb İnstitutunun Psixiatriya Klinikasının elmi iclaslarında professor Kempinskinin müzakirələrini əks etdirir.

Məlumdur ki, nevrozlar müasir cəmiyyətdə ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir.

Onların etiologiyası və patogenezi ilə bağlı çoxlu sayda tədqiqat və fikir mövcuddur. Lakin, nevrozların hansı fonda inkişaf etdiyi sualına hələ də vahid cavab yoxdur. Professor Kempinski bioloji mövqe tutur. O, nevrotik simptomların orqanizmin daxilindən və ya onun mühitindən gələn həyəcan signalı olduğuna inanır. Birinci halda, o, psevdonevrozdan danışır ki, bu, tez-tez təhlükəli somatik xəstəliklərdən əvvəl baş verir və bu simptomlar çox vaxt bədənə daxili parçalanmasının ilk xəbərciləridir. İkinci versiyada Kempinski orqanizmin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirindəki pozuntuların nəticəsi olan, xarici mühitdə mövcud tarazlığın pozulmasına və orqanizmin inkişaf prosesində gecikməyə səbəb olan əsl nevrozlardan bəhs edir.

Müəllif nevrozlar haqqında düşüncələrinə bütün nevroz hallarında həmişə mövcud olmayan, lakin buna baxmayaraq müxtəlif növ nevrozların təsnifatına imkan verən marjinal və ya tipoloji simptomların təhlili ilə başlayır. Professor Kempinskinin fikrincə, nevrastenianın xarakterik simptomları - yorğunluq və əsəbilik - mərkəzi sinir sisteminin nasazlığının ifadəsidir.

Hər bir idarəetmə sisteminin öz məsuliyyət iyerarxiyası var.

Kiçik məsuliyyət aşağı səviyyələrdə görünür və bu prosesdə yüksək səviyyələrə əhatə etmir.

Yeri gəlmişkən, bu, müxtəlif funksiyaların avtomatlaşdırılmasının əsasını təşkil edir.

Gəzməyə başlayan uşaq bu fəaliyyətə maksimum, məqsədyönlü say göstərir. Bu çətinliyi dəf etdikdən sonra, sadə "get!" sözü kifayətdir və uşaq bu mürəkkəb funksiyaları avtomatik olaraq yerinə yetirir.

Eyni şey qavrayış proseslərinə də aiddir. Sinir sisteminin aşağı səviyyələrində müəyyən məlumatları kənarlaşdıran və digər məlumatları daha yüksək səviyyələrə ötürən bir signal görünür. Nevrotik sindromlarda bu iyerarxiya pozulur və eyni zamanda çox məlumat şüura nüfuz edir və xəstəni bürüyür; onlar zehnlərində qarışıqlıq və kaos yaşayırlar, digər tərəfdən isə avtomatik funksiyalar mənalı olur və nəticədə yorucu olur. İsterik nevrozda pozuntu əksinədir və dissosiasiyadan, yəni tənzimləyici sistemin bir hissəsinin bədən funksiyalarının bütövlüyünü nəzərə almadan öz planına uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyə başlamasından ibarətdir. İpoxondriakal nevrozda əsas məsələ interoseptiv stimullar üçün mənalı qavrayış həddidir.

Normal şəraitdə bu həddi eksteroseptiv stimullarla müqayisədə çox yüksəkdir və nəticədə bədənimizdə baş verən proseslərdən xəbərsizik. Müxtəlif emosional vəziyyətlər nəticəsində və ya bədən daxili tarazlığının pozulması nəticəsində bu hədd azalır, xəstənin baxışları içəri yönəlir və onlar normalda şüurun xaricində baş verən hər şeyi qavrayırlar. Obsesif-kompulsiv nevrozlarda mərkəzi məqam əhəmiyyətsiz bir vəziyyətdə fobiyanın "kristallaşması" və perseverasiya, yəni eyni təcrübə və davranış modelinin təkrarlanmasıdır. Depressiv nevrozda əsas simptom depressiv əhval-ruhiyyədir ki, bu da çox vaxt basdırılmış aqressivliyi ifadə edə bilməmək və ya onun gücü ilə əlaqələndirilir. Professor Kempinski fobiyaları, vegetativ disfunksiyaları, eqosentrizmi və sehlənmiş qüsurlu dövrün simptomunu bütün nevrozların əsas simptomları hesab edir. Fobiyanın yaranmasına gəldikdə, Kempinski dörd növ müəyyən edir:

1. İki fundamental bioloji qanuna qarşı təhdiddən yaranan bioloji qorxu, yəni öz həyatının qorunması və növün yaşaması;
2. ictimai qınaqla təhdid edən bir vəziyyətdə yaranan sosial qorxu;
3. superego(vicdandan) qaynaqlanan mənəvi qorxu;
4. Ətraf mühitlə inteqrasiyanın əvvəldən olan təcrübələrə zidd yeni bir reallığa inteqrasiya oluna bilməməkdən yaranan qorxu - adaptasiya olunmama qorxusu

Müəllif kitabın ayrıca bir hissəsini ən əhəmiyyətli nevroitik vəziyyətlərin təhlilinə* həsr edir və ailə mühitinə - həm genealoji, həm də şəxsi - və iş mühitinə diqqət yetirir.

Kempinski kitabın son hissəsini nevrozların müalicəsinə həsr edir. O, nevrozlar üçün müxtəlif müalicə növlərinin - somatik və psixoterapevtik müalicənin effektivliyini vurğulayır. O, nevrozların müalicəsində aşağıdakıların mühüm rol oynadığına inanır: xəstənin həkimə olan inamı, həkimin xəstəyə və öz müalicə metoduna olan inamı və həkimin səbri, yəni baxmayaraq ki, uzun müddət göstərdiyi səylərin dərhal terapevtik təsir göstərmədiyini nəzərə almalıdırlar. Həkim xəstəni nevroitik vəziyyətinə görə mühakimə etməməlidir; O, xəstəni başa düşməyə çalışmalıdır ki, bu da onun xaoslu emosional vəziyyətlərinin aydınlaşdırılmasını və nizam salınmasını (nə?, nə vaxt?, hansı hallarda?) asanlaşdırmalıdır.

Psixoterapiyada ən vacib element xəstə ilə həkim arasındakı emosional əlaqədir. Psixoterapevtik proses üçbucaq şəklində təmsil oluna bilər, onun əsasını xəstə ilə həkim arasında psixoterapiya zamanı inkişaf edən emosional əlaqə təşkil edir; zirvədə xəstənin şəxsiyyəti indiki anda, keçmişdə və gələcəkdə dayanır ki, bu da söhbətlər zamanı bir-bir aşkarlanır.

Qrup psixoterapiyasında vacib terapevtik element psixoterapiya prosesi zamanı iştirakçılar arasında inkişaf edən emosional əlaqədir. Müəllifin fikrincə, qrup psixoterapiyası çox güman ki, sosioloji müalicə metodlarına, fərdi psixoterapiya isə psixoloji müalicəyə aiddir.

Çoxsaylı spesifik müşahidələrlə dəstəklənən bu fərqli baxışlar, əsasən, müəllifin psixiatr kimi iyirmi beş illik təcrübəsinə əsaslanır. Elmi jurnallarda dərc olunmuş 100-dən çox əsərdən ibarət elmi irsi tədricən daha geniş auditoriyaya təqdim olunacaq.

Professor Kempinski 8 iyun 1972-ci ildə 54 yaşında vaxtından əvvəl vəfat etdi. Son günlərinə qədər o, aydın zehni və fəvqəladə enerjisini qoruyub saxladı.

Ölümündən sonra bir neçə makinada yazılmış monoqrafiya qaldı. "Nevrozların psixopatologiyası" onun həyatı boyu nəşr olunmuş yeganə kitabdır. Ölümündən əvvəl o, daha iki əsərinin - "Şizofreniya" (Polşa Tibb Nəşriyyatı, 1972) və bəzi elmi məqalələrinin antologiyasının, ümumilikdə "Həyat Ritmi" (Ədəbiyyat Nəşriyyatı, 1972) əsərlərinin əsasını qoymağı bacardı.

Professor Kempinskinin elmi inkişafını xronoloji olaraq izləməklə onun baxışlarının təkamülünü görmək olar. Bir tərəfdən, getdikcə daha dəqiq təriflərə can atmaq, digər tərəfdən isə psixoterapevtik biliklərə qarşı böyük tənqid, öz, tez-tez cəsarətli baxışlarının irəliləməsi və sınaqdan keçirilməsi ilə daha çox ümumiləşdirmələrə can atmaq var. Lakin bu olmadan elmdə irəliləyişi təsəvvür etmək çətinidir. Yagellon Universitetinin Psixonevroloji Klinikasının və Krakov Tibb İnstitutunun Psixiatriya Klinikasının keçmiş uzunmüddətli direktoru kimi, professor Kępiński'nin elmi inkişafının Krakov Psixiatriya Mərkəzinə xas olan spesifik "dahi lokus"la əlaqəli olduğunu da deyə bilərəm. Onun müxtəlif psixiatrik baxışlara, tez-tez ziddiyyətli və canlı müzakirələrə qarşı diqqətəlayiq tolerantlığı, pasientin talehinə, xəstəliyinə laqeyd qalmamaq bacarığı vardı.

Mövzular, həm fərdi xəstələr, həm də nəzəri təkliflər, xəstəyə və onun taleyinə həqiqi maraq - bütün bunlar onun elmi irsində ilk olan bu kitabın yarandığı mühiti yaratdı. Professor Kempinski ömrünün son illərində Krakov Tibb İnstitutunun Psixiatrik Klinikasına rəhbərlik etmişdir. Müəllifin bəzi fikirləri müzakirə tələb edir, lakin onlar buna baxmayaraq nevrozların fundamental problemləri üzərində daha çox tədqiqat aparmağa təşviq edir.

Bu monoqrafiya psixiatriyanın xüsusi bir bilik sahəsinə aid olduğunu göstərir, ona görə ki əsasında bioloji və riyazi düşüncənin humanitar, fəlsəfi və psixoloji düşüncə ilə inteqrasiya olunması durur. Belə bir inteqrasiya həmişə psixopatologiya üzrə əsərlərin müəlliflərində olmur, lakin professor Kempinski üçün bu, onun bütün elmi əsərlərində özünü qırmızı xəttlə göstərir. Məhz buna görə də o, psixonevrozlar problemini inkişaf etdirə bilmişdir.

Bu problemlərə yanaşmaların müxtəlifliyini dünya ədəbiyyatında görmək olar. Məsələn, ingilis tədqiqatçıları tez-tez psixiatrik problemlərə psixoloji baxımdan, alman tədqiqatçıları isə onlara ekzistensial fəlsəfə baxımından yanaşırlar. Professor Kempinski kimi biomolekulyar təməli olan yalnız bir neçə nəfər unudulmuş tədqiqat sahəsinə kəşf edir.

Mən professor Kempinskini psixiatriya və nevrologiya sahəsindəki işinin lap əvvəlindən tanıyırdım;

o, mənim tələbəm idi və mən onun psixiatrik istiqamətinin inkişafını birbaşa müşahidə edə bildim. Molekulyar bioloji metodlar psixonevrozların və onların praktik aspektlərinin təhlilində tam istifadə edilə bilməz, lakin onlar çox vacib bir mövqe təşkil edir və bu mövzunun inkişafında çox vacibdir.

Buna görə də, hər hansı bir təməldən asılı olmayaraq, professorun elmi irsinin, xüsusən də "Nevrozların psixopatologiyası"nın təkcə psixiatriya üçün deyil, ümumiyyətlə Polşa mədəniyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini qəbul etmək olar.

"Nevrozların psixopatologiyası"nın nəşri professor üçün böyük bir hadisə idi.

Ağır xəstə olan o, "Nevrozların psixopatologiyası"nın ilk nüsxəsinin olduğu paketi xüsusi diqqətlə və sevinclə açdı, kitabı ürəkdən araşdırdı. 1972-ci ilin mart ayında, ölümündən üç ay əvvəl, o, həvəssiz professorluq vəzifəsini qəbul etdi və Yovşan Dirçəlişi Ordeninin Cəngavər Xaçı ilə təltif edildikdən sonra az məmnunluq göstərdi. Professor Kempinskinin ilk kitabının nəşrinə verdiyi reaksiya, ölümündən əvvəl illərdir zehmində dəmlənən əsərini görməyə vaxt tapan Koperniki xatırlatdı.

"Nevrozların Psixopatologiyası"nın ilk nəşri bir neçə gün ərzində demək olar ki, tamamilə satıldı, baxmayaraq ki, çap tirajı 10.000 nüsxə idi. Bu, təkcə mütəxəssislər və praktiklər arasında deyil, həm də

geniş mədəni dairələr, xüsusən də humanistlər və ədəbi-bədii dünya arasında maraq oyatdı. Mətbuat rəylərində kitab sensasiya və bestseller kimi qiymətləndirildi.

Lakin, professor Kempinskinin bütün elmi əsərləri nəşr olunduqda onun elmi irsi tam qiymətləndiriləcək.

Professor Yevgeniusz Bjezitski

GİRİŞ MÜRACİƏTLƏRİ

NEVROZLARIN RASTGƏLMƏ TEZLİYİ

5

Nevrozların tezliyini, hətta təxmini olaraq belə müəyyən etmək çətinidir. Nevrozların davranışlarının dəqiqliyindən və nevrozla ruhi sağlamlıq, eləcə də nevrozla psixopatiya arasında müəyyən bir sərhədin qəbul edilməsindən asılı olan epidemioloji tədqiqatlar, əhali arasında nevrozlu xəstələrin nisbəti barədə bir neçə faizdən on faizə qədər dəyişən müxtəlif məlumatlar əldə etmişdir.

Müxtəlif ixtisaslardan (psixiatrlardan deyil) tibbi məsləhət alan xəstələrin böyük bir faizinin nevrozlu hesab edildiyi güman edilir. Belə xəstələrin 50%-dən çoxunun ümumi terapevtlərdən müalicə aldığı müşahidə olunur. Müasir cəmiyyətdə həyatında ən azı qısa müddət ərzində açıq-aşkar nevrotik simptomları yaşamayan bir insan demək olar ki, yoxdur. Buna görə də, hər kəsin bu xəstələrə xas olan təcrübələri başa düşməsi nisbətən asandır.

NEVROZLAR VƏ PSEVDONEVROZLAR

İki olduqca adi vəziyyət, müəyyən dərəcədə həqiqiliklə, nevrotik bir insanın təcrübələrini yaşamağa imkan verir. Biri çətin bir işin, məsələn, imtahanın, vacib bir şəxslə görüşün və ya ictimai çıxışın gözlənilməsi, ikincisi isə adi alkoqol intoksikasiyasından sonrakı vəziyyətdir (məşhur "baş ağrısı").

Narahatlıq, əsəbilik və vegetativ sinir sisteminin disbalansından (vegetativ distoniya) qaynaqlanan müxtəlif xoşagəlməz hisslər, məsələn, ürək döyüntüsü, mədə çuxurunda ağrı, baş ağrıları, qarın ağrısı, sidik ifrazı və nəcis ifrazı istəyi, tərləyən əllər, bədən titrəmələri və s. hər kəsə şəxsi təcrübəsindən yaxşı məlumdur. Nevrozlarda bu vəziyyət həftələrlə, aylarla və hətta illərlə davam edir. Buna görə də, hərtərəfli müayinə və əlavə testlərdən sonra həkim ona "xüsusi bir şey yoxdur", "sadəcə əsəblərdir" və s. dedikdə, xəstənin narazılığı və məyusluq hisslərinə təəccüblənməmək lazımdır.

Nevrozun müayinədən əvvəlki vəziyyətlə və alkoqol zəhərlənməsi ilə müqayisə edilməsi, həm zehni (məsələn, müayinə narahatlığı), həm də fiziki amillərin (məsələn, zəhərli maddəyə məruz qalma) təsiri

altında ortaya çıxa bilən eyni simptomların mövcudluğunun vacib faktını göstərir. Nəticə etibarilə, kökündən fərqli etioloji amillər mərkəzi sinir sisteminin oxşar disfunksiyasına səbəb ola bilər.

Tibbi praktikada tez-tez tipik nevrotik simptomların, somatik və ya ruhi xəstəliyin sələflərinin və ya onları müşayiət edən simptomların görünüşü ilə qarşılaşırıq. Onları yalnız emosional amillərin yaratdığı əsl nevrozlardan və ya psixonevrozlardan fərqləndirmək üçün yalançı nevrozlardan və ya "psevdonevrozlardan" danışırıq. Diaqnostik səhvlər qaçılmazdır, çünki nevrotik simptomlar tez-tez başlanğıc somatik xəstəliyin yeganə əlamətləridir və yalnız sonrakı inkişaf bu nevroz deyil, bədxassəli xəstəliyin başlanğıcı, serebral ateroskleroz, Qreyvs-Bazedo xəstəliyi və s. olduğunu göstərir. Eyni prinsip ruhi xəstəliklərə də aiddir. Nevrotik simptomlar şizofreniya, siklofreniya, üzvi psixozlar və epileptik tutmaların sələfləri ola bilər. Lakin, bu hallarda diaqnostik səhvdən danışmaq çətindir, çünki psixiatriyada diaqnoz əsasən simptomatikdir. Məsələn, şizofreniya simptomları yoxdursa, yalnız nevrotik əlamətlər varsa, şizofreniya diaqnozu qoyula bilməz. Nevrotik təzahürlər yalnız somatik və ruhi xəstəliklərdən əvvəl meydana çıxmır, həm də bu xəstəliklərin gedişi zamanı, xüsusilə son mərhələ və sağalma dövründə müşayiət olunur. Daha sonra, əsas xəstəlik məlum olduğuna görə, onlar heç bir ciddi diaqnostik çətinlik yaratmırlar.

NEVROZların DİAQNOZtikası

Nevrotik simptomları müəyyən etmək çətin deyil: xəstədən yayılan və ətrafındakılara təsir edən narahatlıq və zehni gərginlik, xəstənin tipik şikayətləri ilə birlikdə, hətta həkim olmayan bir şəxsə belə bir insanı "əsəbi" adlandırmağa imkan verir ki, bu da nevrozun ümumi anlayışına ən uyğun gəlir. Nevrotik vəziyyətin səbəbləri və onun qiymətləndirilməsi sualına cavab verməyə çalışarkən çətinliklər yaranır. Ola bilər ki, bu vəziyyət qısamüddətli və müəyyən bir vəziyyətlə (məsələn, görüş həyəcanı, müayinədən əvvəl narahatlıq və ya alkoqol zəhərlənməsi) əlaqədar yaranır, yaxud bu simptomların arxasında ciddi somatik və ya psixi xəstəliklər gizlənə bilər. .

Müxtəlif növ emosional münaqişələr belə bir vəziyyətin səbəbi ola bilər.

Yalnız bu sonuncu halda nevroz diaqnozu qoya bilərik.

Nevrotik simptomların bu qədər geniş yayılmış təbiəti tez-tez həkimdə spesifik diaqnostik şübhə vəziyyəti yaradır. Həkim nevroz əlamətlərinin daha ciddi bir şeyi gizlətdiyindən əmin deyil və yalnız bütün digər diaqnostik imkanları istisna etdikdən sonra nevroz diaqnozu qoyur.

Diaqnoz qoymaq çətinidir, çünki başqa nəyin nəzərdən keçirilə biləcəyi və nəyin ehtimal edilə biləcəyi heç vaxt aydın deyil və buna görə də xəstə sonsuz sayda müxtəlif əlavə müayinələrə göndərilə bilər.

Həkimin qeyri-müəyyənliyi xəstənin narahatlığını artırır və bununla da onun nevrotik xüsusiyyətlərini dərinləşdirir

Ümumiyyətlə, somatik xəstəliyi görməzdən gəlmək və onun simptomlarını nevrozla əlaqələndirmək, nevrozu somatik xəstəlik kimi diaqnoz qoymaqdan daha pis olduğuna inanılır. Bu ikinci tibbi səhv daha çox yayılmışdır. Funksional ürək küyləri, endokrin vəzilərin funksiyasında kiçik sapmalar və bu kimi hallar tez-tez həkimlər tərəfindən xəstənin nevrotik pozuntularının səbəbi kimi müəyyən edilir və bu ağrı hisslərini və bəzən hətta əmək qabiliyyətini itirdiyi düşüncəsini, illərlə hətta ömürlük davam etməsinə səbəb ola bilər.

Bu diaqnostik çətinliklər, müəyyən bir dərəcədə, bədən təhlükə altında olduqda və insan yaranan xarici və ya daxili çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə özünü aciz hiss etdikdə meydana çıxan nevrotik simptomların mahiyyətini anlamağa kömək edir. Təhlükə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müayinədən əvvəlki vəziyyət nümunəsində xaricdən və ya alkoqol zəhərlənməsi kimi daxildən gələ bilər.

Nevrozla az və ya çox dərəcədə müşayiət olunan qorxu hissi bədəni təhdid edən bir təhlükə signalıdır. Bu halda ağrı ilə müəyyən bir bənzətmə var, lakin ağrı ən azı təhlükə mənbəyinin axtarılmalı olduğu yeri təxminən göstərə bilər, fobiya isə zərərli amillə birbaşa təmas anını qabaqlayır. Bu şər mənbəyini kəşf etmək və ya ən azından onu intensiv şəkildə axtarmaq təkcə həkimin vəzifəsi deyil, həm də borcudur. Lakin bu, həmişə mümkün olmur. Buna baxmayaraq, həkimlə təmasın özü və ona etiraf etmək imkanı, eləcə də sinir gərginliyini azaldan və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran müxtəlif farmakoloji maddələr etiologiyasından asılı olmayaraq nevrotik xüsusiyyətləri azaldır.

Klassik bir nümunə, Jaspersin təsvir etdiyi, insipidus(şəkərsiz diabet) üçün intensiv psixoterapiya ilə müalicə olunan xəstədir və bu, bu xəstəliyin tanınmasının bu günkü qədər asan olmadığı bir dövrdə baş vermişdir.

Xəstənin vəziyyəti psixoterapiyanın köməyi ilə yaxşılaşdı və bu, digər şeylərlə yanaşı, sidik ifrazının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasında da özünü göstərdi. Bütün bunlara baxmayaraq, bir müddət sonra xəstə beynin hipotalamik bölgəsindəki şişdən öldü və bu, onun morbid vəziyyətinin səbəbi idi. Beləliklə, ağrıda olduğu kimi, nevroitik əzabları da azaltmaq olar, lakin onun səbəbini aradan qaldırmaq mümkün deyil.

NEVROZLARIN TƏSNİFATLARI

Nevrotik simptomların etiologiyasını axtarmaqda deyil, həm də onları təsnif etməyə çalışmaqda çətinliklər yaranır. Demək olar ki, hər kəs üçün açıq-aydın olmasına baxmayaraq, onları rəasional olaraq təsnif etmək, xüsusən də hər bir nevrozda mövcud olan əsas (axial) simptomları yalnız müəyyən nevroz növlərinə xas olan daha az əhəmiyyətli (marjinal və ya tipoloji) simptomlardan ayırmaq asan deyil. Bu günə qədər nevrozların təsnifatı müzakirə mövzusu olaraq qalır. (Sonrakı cümlənin altından xətt çək)Təsnifat çətinlikləri nevroitik təzahürlərin geniş çeşidi və onların fərdiliyi səbəbindən yaranır və hər bir xəstə fərqli simptomlar dəsti nümayiş etdirir. Təsvir nevrozun ikincili xüsusiyyətləri ilə başlaya bilər, çünki onlar bizi onları fərqli növlərə bölməyə imkan verir. Daha sonra, əsas simptomların təsvirinə keçəcəyik ki, bu da öz növbəsində nevrozların psixopatologiyasına daha dərindən nəzər salmağa imkan verəcəkdir.

Hər bir nevrozda mövcud olan və buna görə də təsnifat xüsusiyyətləri kimi xidmət edə bilən əsas simptomlardan fərqli olaraq, ikincili simptomlar həmişə özünü göstərmir və ya onların şiddəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Məhz bu simptomlar nevrozları dominant simptomlarına əsasən müxtəlif növlərə bölməyə imkan verir. Nevrozların müxtəlif təsnifatları mövcuddur. Bəzən əsas simptomlar təsnifat amilləri hesab olunur (məsələn, fobiya, vegetativ nevroz), lakin bunu etibarlı bir fakt kimi qəbul etmək çətinidir.

Psixiatriyadakı digər təsnifatlar kimi, nevrozların təsnifatı da əsasən simptomatologiyaya əsaslanır. Simptomlar müxtəlif yollarla qruplaşdırıla bilər və bu bölgü əsasən ixtiyari olaraq tətbiq olunur. Müxtəlif növ nevrozlarda baş verən simptomlar eyni xəstədə mövcud ola bilər, lakin onların şiddəti adətən dəyişir. Bu halda, dominant simptomlar nevrozun növünü müəyyən edir və ya seçmək çətin olduqda, qarışıq nevroz təyinatı istifadə olunur (məsələn, nevrastenik-isterik, hipoxondro-depressiv nevroz və s.).

Bu kitabda təqdim olunan nevrozların təsnifatı, ümumiyyətlə, müxtəlif kiçik kənara çıxmalarla, həm Polşa, həm də xarici psixiatriyada qəbul edilir. Beş növ nevroz fərqləndirilir: nevrasteniyə, isteriya, hipoxondriya, anankastik (obsesif) nevroz və depressif nevroz.

NEVRASTENİYA - YORĞUNLUQ

Nevrasteniya sözü hərfi mənada "sinirlərin zəifliyi" deməkdir (yunan sözü astenos = zəif). Bu nevrozda zəiflik və qıcıqlanma nəzərə çarpır.

Zəiflik adətən artan qıcıqlanma ilə müşayiət olunur. Zədələnmiş sinir lifi - simptomlar başlamazdan əvvəl - hiperesteziya ilə cavab verir və buna misal olaraq oturmaq sinirin iltihabını (işias) göstərmək olar. Əgər nevrasteniyada zəiflik üstünlük təşkil edirsə, onda bunun hipostenik olduğu deyilir və əgər əsasən qıcıqlanma daha üstündürsə hiperstenik forma olduğu deyilir. Zəiflik adətən daimi yorğunluq hissi, artan

fiziki və zehni yorğunluq şəklində olur. Bu hallarda psixofiziki vəhdət aydın şəkildə özünü göstərir; zehni yorğunluğu fiziki yorğunluqdan ayırmaq çətindir. Xəstənin davranışı, hərəkətləri və üz ifadəsi yorğunluq “möhrünü” daşıyır.

Fiziki olaraq, onlar sanki ağır işi yeni bitirmiş və ya zəiflədici bir xəstəlik keçirmiş kimi hiss edirlər, əzələ ağrısından, xüsusən də bel nahiyyəsində şikayət edirlər ki, bu da antiqravitasiya əzələlərində artan gərginliklə izah edilə bilər. Bununla yanaşı, xəstə baş ağrıları, ürək döyüntüsü, qarın ağrısı və cinsi disfunksiya kimi vegetativ təbiətli müxtəlif şikayətlər təqdim edir, əksər hallarda kişilərdə vaxtından əvvəl boşalma və impotensiya, qadınlarda isə anorgazm şəklində olur.

Baş ağrıları olduqca spesifikdir və sıxılma hissi (nevrastenik dəbilqə), başın içərisində təzyiq hissi (başda pambıq) və ya çəşqinlik hissi (sanki baş çartlayır, başı hərəkət etdirdikdə içərisində maye hərəkət edir hissi) kimi özünü göstərir. Nevrastenik dəbilqənin kəllə əzələlərində artan gərginlikdən qaynaqlanması mümkündür. Xəstə həmçinin bu gərginliyi üz əzələlərində hiss edir ki, bu da adətən onların üz ifadələrində əks olunur. Bəzən xəstələr göz qapaqlarında ağırlıq, titrəmə və göz yorğunluğundan şikayətlənirlər ki, bu da görünür, əzələ gərginliyinin artması ilə də əlaqələndirilə bilər (göz qapağı və göz almasının əzələləri).

Zehni yorğunluq əsasən diqqət çatışmazlığı, yaddaşın pozulması, diqqətsizlik hissi və ətrafdakı heç nəyə maraq olmaması ilə özünü göstərir.

Xəstə hər şeydən bezir, hər şey onu ruhdan salır, diqqətini cəmləyə bilmir, hər şey onları narahat edir, oxuduqlarını başa düşə bilmir, sadə bir məktub yazmaqda çətinlik çəkir, kiminsə dediklərini xatırlaya bilmir və s. Bu şikayətlər ən çox psixi yorğunluqla əlaqələndirilir.

Yorğunluq hissi həddindən artıq halsızlıq və təqətsizlik ilə əlaqələndirilir. Pilləkənlərlə yuxarı və aşağı gəzmək, hətta ən kiçik fiziki güc belə, ürək döyüntüsünə, əzələ ağrısına və s. səbəb olur. Hətta yataqdan qalxmaq belə böyük bir çətinliyə çevrilir. Hər şey yorur. Eyni şey zehni işə də aiddir. Sadə tapşırıqlar həddindən artıq və əzabverici olur.

Təkcə iş deyil, həm də istirahət də yorucu ola bilər. Kitablار, filmlər və teatr da yorğunluğa səbəb olur.

Yorğun insan yaxşı istirahət edən insandan daha tez yorulur. Bu halda yorğunluq nevrasteniyaya xas olan yorğunluq hissinin nəticəsidir.

İş gününün sonunda baş verən fiziki yorğunluqdan fərqli olaraq, nevrastenik yorğunluq, oyandıqdan dərhal sonra erkən başlaması ilə xarakterizə olunur. Nevrasteniklər yeni günün başlanğıcını kədərli bir zərurət kimi görürlər. Yalnız axşama doğru belə xəstələr daha enerjili olur, "yenidən aktivləşir" və yorğunluq hissi adətən azalır. Bu paradoksal fenomen yuxu pozuntuları ilə əlaqələndirilir; xəstə kabuslardan əziyyət çəkir, yuxu səthi olur, tez-tez oyanır və yuxuya getməkdə çətinlik çəkir. Bundan əlavə, bu hallarda xəstənin yeni günə qarşı mənfi emosional vəziyyəti rol oynaya bilər. Hər halda, ümumi boşluq hissi ilə nevrastenik sübh nevroz üçün xarakterikdir və bu, fizioloji yorğunluğu patoloji yorğunluqdan ayırmağı asanlaşdırır.

QICIQLANMA

Nevrastenik qıcıqlanma bütün qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək oyanıqlıqla əlaqələndirilir.

Qıcıqlandırıcılar və bu cür qıcıqlandırıcıların müxtəlif növləri ağırlı bir çalar alır. Xəstə sanki hər şeydən, məsələn, alkoqol abstinensiyasında olduğu kimi əzab çəkir və qıcıqlanır; onlar sanki “dərillərinin qoparıldığını” hiss edirlər, yaşadıkları hər şey ağırlı olur və sonra bütün hadisələrə reaksiyaları son dərəcə paradoksal olur. Xəstə bu reaksiyaları yatıra bilər; onlar qəzəblərini boğurlar, bunun ardınca

vegetativ-endokrin sistemin səfərbərliyi və qaynayan yorğunluq hissi (hipostenik nevrasteniya) gəlir. Xəstəliyin digər bir təzahürü qəzəb, qıcıqlanma və s. vulkan püskürməsi ola bilər ki, bu da öz növbəsində ətrafdakılarla münaqişələrə səbəb olur və bütün bunlar, qüsurlu dövrən kimi, heç bir təsəlli vermir və xəstənin qıcıqlanmasını dərinləşdirir (hiperstenik nevrasteniya).

İDARƏETMƏ NEVROZU (direktor nevrozu)

Hiperstenik formanın tipik nümunəsi, rəhbər vəzifələrdə olan və bu və ya digər səbəbdən məsuliyyətlərinin öhdəsindən gələ bilməyən və daim gərginlik içində yaşayan insanlarda baş verən sözdə idarəetmə nevrozudur. Onlar daim sənədləşmə işləri ilə məşğul olurlar, tez-tez bir neçə nəfərlə telefonda danışirlar, sadə suallara əsəbi reaksiya verirlər və tez-tez ziddiyyətli əmrlər verirlər. Onların davranışı sosial qrupu qıcıqlandırır; hər kəs təkərdəki dələ kimi fırlanır və bu da nəticədə ümumi qıcıqlanmaya səbəb olur.

TƏLƏSMƏK VƏ DARIXMAQ

Nevrasteniyada tez-tez tələsmə və ya darıxma hissi yaranır. Bu, yuxarıda qeyd olunan xarici amillərə qarşı artan qıcıqlanmanın və onları ifadə edən xəstəlik təzahürlərinin nəticəsidir. Xəstənin hazırkı anda qavradığı hər şey bədbin tonda səslənir; xəstə reallığı geridə qoymaq istəyir, bu, ona mane olur, o, ondan qaçmaq, onu məhv etmək, özünü başqa, daha yaxşı bir dünyada tapmaq istəyir.

"Tələsmək" və "darıxmaq" sözlərinin əksi "maraqlanmaq"dır. Bu son söz latınca "intereses" sözündən gəlir - bir şeydə olmaq, indiki zamanda, indiki vəziyyətdə olmaq. Yorğunluq hissi bir şeyə maraq yarandıqda yox olur. İnsan niyə saatlarla növbədə dayananda və ya bütün günü işdə qaçanda, əslində heç nə etmədən yorğunluq hiss edir? Birinci halda, onlar tələsirlər -

məqsədlərinə tez çatmaq və onları təyinat yerindən ayıran vaxtı geridə qoymaq istəyirlər. İkinci halda, onlar darıxırlar, əzabverici vaxtı geridə qoymağa çalışırlar; Fərq ondadır ki, tələsən insan qarşısında bir məqsəd görür, darıxmış insan isə bunu hiss etmir. Lakin, həm tələsiklik, həm də darıxmaqda onlar xoşagəlməz və özlərinə düşmən olan cari zamanla mübarizə aparırlar; sonra vegetativ və endokrin sistemlər mübarizə aparmaq və ya geri çəkilmək üçün səfərbər olurlar. Buna görə də artan yorğunluq hissi yaranır ki, bu da gərgin zehni və ya fiziki işdən sonra olduğundan xeyli çox ola bilər. Yorğunluq hissi ətrafdakı hər şeyə mənfi münasibəti daha da artırır. Nevrotik qapalı dairə yaranır.

Tələskənlik və darıxma müasir sivilizasiyanın xüsusiyyətləri hesab olunur. Bu simptomlar texnoloji tərəqqi yolu ilə cəmiyyətin müəyyən bir "nevrastenikləşməsinin" göstəriciləri kimi qəbul edilə bilər.

ÜZVİ FONDA NEVRASTENİYANIN SİMPTOMLARI

Nevrastenik simptomlar somatik etiologiyalı psevdonevrozların ən çox yayılmış xüsusiyyətlərindəndir. Onlar alkoqol intoksikasiyasının nəticəsi kimi ortaya çıxır. Baş beyin travmalarının gec nəticələri ən çox xroniki nevrastenik sindrom (posttravmatik serebrasteniyə) kimi özünü göstərir.

Beyin damarlarının ateroskleroza adətən nevrastenik sindromla başlayır.

Zəhərli maddələrlə (məsələn, karbon qazı) kəskin və xroniki zəhərlənmə tipik nevrastenik simptomlara səbəb olur. Sağalma dövründə müxtəlif somatik xəstəliklər (xüsusilə yoluxucu xəstəliklər) əsasən nevrastenik yorğunluq və qıcıqlanma mənzərəsini təqdim edir. Yoluxucu xəstəliklər də tez-tez nevrastenik simptomlarla başlayır (məsələn, grip).

Lakin bunu endogen psixozlarda (şizofreniya və siklofreniya) ya prekursor, ya da son vəziyyət kimi görünən psevdonevrozlar haqqında demək olmaz. Nevrastenik sindromla yanaşı, burada nevrozların digər formalarına da tez-tez rast gəlinir.

Nevrastenik simptomların açıq üzvi etiologiyalı xəstəliklərlə birlikdə mövcud olması aşağıdakı kimi izah edilə bilər. Canlı hüceyrə istənilən növ zədəyə öz funksiyasını zəiflətməklə, zədələnmənin ilk mərhələsində isə oyanıqlığı artırmaqla reaksiya verir. Bu fenomen xüsusilə zərərli amillərə qarşı həssas olan beyin hüceyrələrində özünü göstərir.

Əlbəttə ki, bütün orqanizmin reaksiyasını fərdi hüceyrənin reaksiyası ilə müqayisə etmək olduqca risklidir, lakin müəyyən bir bənzətmə mövcuddur. Xarakterik bir fakt budur ki, insan bədənə haqqında danışarkən zərərli amillərə mexaniki, kimyəvi və digər amillər daxil ola bilər. Travma və buna görə də "üzvi" termini ilə təyin olunan bütün amillər, eləcə də emosional xarakterli travma. Görünür, həm üzvi, həm də psixoloji travmatik amillər avtonom və endokrin sistemlərin səfərbər edilməsi şəklində oxşar müdafiə reaksiyası yaradır və Selyenin məşhur nəzəriyyəsi (stress, distress) məhz bu əsasda qurulub.

"Anadangəlmə" NEVRASTENİKLƏR

Lakin, "anadangəlmə" nevrasteniklər də var - erkən gənclikdən demək olar ki, daim yorğun və əsəbi hiss edən, həyatdan əziyyət çəkən və bunu tez-tez acınacaqlı bir vəzifə hesab edən insanlar. Deyə bilərik ki, onlar üçün həyatın özü bir travmadır. Belə insanlar tez-tez ətraf mühitə və tez-tez özlərinə qarşı kök salmış mənfi emosional münasibətə malikdirlər. Davamlı mənfi emosional vəziyyət avtonom və endokrin sistemlərin daimi gərginliyinə gətirib çıxarır ki, bu da davamlı nevrastenik sindroma səbəb olur.

// NEYROFİZİOLOJİ NÖQTEYİ NƏZƏRDƏN BAXIŞ SINAĞI

Sinir sistemi bir idarəetmə sistemi, yəni bədəndəki milyardlarla hüceyrə üzərində güc aparatı kimi fəaliyyət göstərir. Onların fəaliyyətini birləşdirir və onları mövcud mühitdəki həyata uyğunlaşdırır. Hər bir idarə aparatında əhəmiyyətli bir problem ilkin problemləri ikinci dərəcəli məsələlərdən ayırmaq qabiliyyətidir. Müəyyən bir sistemə verilən tapşırıqlardan, mövcud ehtiyaclardan və xarici və daxili vəziyyətdən asılı olaraq, ətraf mühitə daxil olan və çıxan siqnalları (məlumatları) seçən bir proqram hazırlanır.

Müəyyən məqamlarda ikincili məlumatlar həlledici əhəmiyyət kəsb edə bilər.

Məsələn, ac bir insan restoranlara və ləzzətli yeməxanalara diqqət yetirməyə başlayır və o doyduqda laqeyd yanaşırlar. İdarəetmə aparatı hər şeyi bilmək və qərar vermək istəyirsə, zəifdir. O, vacib və ikincili məlumatların xaosuna qarq olur, vacib olanın ikincililərlə qarışdırıldığı və bir çoxunun sadəcə bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etdiyi çoxsaylı əmrlər verir.

Bu əmrləri alanlar sonda onlara diqqət yetirməyi dayandırır.

Sxematik olaraq, hər bir idarəetmə sistemi - texniki, bioloji və sosial - piramida şəklində təmsil oluna bilər, onun zirvəsi sistemin əsas planını (məsələn, texniki sistemdə proqramlaşdırma, bioloji sistemdə genetik plan, sosial sistemdə siyasi proqram) təmsil edir və baza isə eyni planın həyata keçirilməsinin son təsirini (məsələn, maşının faktiki məhsulu, faktiki fenotip, mövcud siyasi vəziyyət) təmsil edir. Zirvə ilə baza arasında daimi iki istiqamətli məlumat axını mövcuddur: dərhal icra üçün aşağıya doğru əmrlər, yuxarıya doğru isə tapşırığın yerinə yetirilməsi (geribildiriş) və ətraf mühit üzrə baş verən hər şey haqqında məlumat axır. Piramidanın zirvəsi ilə bazası arasında bir sıra informasiya emalı stansiyaları mövcuddur. Bir tərəfdən, aşağıya doğru əmrlər tətbiq olunana qədər tədricən emal olunur, digər tərəfdən isə yuxarıya doğru məlumat tədricən seçim prosesindən keçir, beləliklə, yalnız ümumiləşdirilmiş məlumat və ya ən aktual məlumat zirvəyə çatır.

Sinir sisteminin morfoloji quruluşu bu cür seçimi göstərir.

Məsələn, insan gözünün tor qişası təxminən 6 milyon kolbacıq və 110 milyon çöpçükdən ibarətdir, görmə siniri isə yalnız bir milyon lifdən ibarətdir.

Torlu qişada görünən vizual görüntünün çoxsaylı elementləri vizual korteksə çatana qədər yox olur. Beyin qabığında (sözdə homunkulus) nəhəng ağız, dil, qollar və nazik aşağı ətrafları olan kiçik bir gövdə olan insan karikaturası məhz bu şəkildə təmsil olunur, çünki bu karikaturadan müəyyən əzələ qruplarına uzanan əmrlər funksional əhəmiyyətindən asılı olaraq müxtəlif seçim proseslərinə məruz qalır (nitq aparatının və qolların əzələləri gövdə və ayaqların əzələlərindən daha vacibdir).

Əgər bir insan yerimək, danışmaq və ya yazmaq kimi bir funksiyanı mənimsəyirsə, onda sadə, daxili "get", "danış" və ya "yaz" signalı kifayətdir; icranın nüanslarına girməyə ehtiyac yoxdur; hər şey piramidanın aşağı səviyyələrində, şüurun iştirakı olmadan baş verir. Lakin, bu funksiyaları hələ inkişaf etdirməmiş bir uşaq bütün diqqətini və şüurlu fəaliyyətini onlara həsr edir. Yetkin bir insan yolda çətinliklərlə qarşılaşdıqda eyni şey baş verir. Oxşar seçim əks istiqamətdə (piramidanın dibindən zirvəsinə qədər) baş verir. Hisslərimizin qavradığı çoxsaylı görüntülər arasında yalnız bir neçəsi şüurumuza çatır; əksəriyyəti yol boyu atılır.

Eliminasiya (nəzərdən buraxma) prosesi bir çox amillərdən, məsələn, orqanizmin cari ehtiyaclarından, onun fərdi və növə xas quruluşundan (hər növdə fərqli görünür) və nəhayət, orqanizmin fərdi tarixindən, yəni öyrənmə prosesindən asılıdır. İnsanlar, heyvanlar kimi, həyatlarının lap əvvəlindən etibarən vacib və əhəmiyyətsiz şeyləri ayırd etməyi daim öyrənirlər. Başqa bir problem isə bu vacib və əhəmiyyətsiz şeyləri düzgün müəyyən etməkdir. Uşaqlıqda hər şey bizi maraqlandırır, hər şey vacib görünür və hər şey bizə sevinc gətirir. Lakin insan inkişaf etdikcə "ciddiləşir" və diqqətini əsasən özünün qorunması ilə birbaşa və ya dolaylı şəkildə əlaqəli olan məsələlərə yönəldir.

Nevrastenik sindromun xarakterik xüsusiyyətlərindən biri sinir sisteminin nəzərdən buraxma qabiliyyətinin pozulmasıdır. Həm vacib, həm də əhəmiyyətsiz siqnallar şüura nüfuz edir, diqqət dağınıqlaşır, xəstə zəif yaddaşdan şikayətlənir, hər şeyi unudur və həddindən artıq sayda stimül səbəbindən başında yalnız səs-küy və xaos hökm sürür. Eyni şey xarici dünyaya ötürülən siqnallara da aiddir. Adətən avtomatik olaraq, şüuraltı və ya minimal şüurlu səylə verilən qərarları nevrastenik xəstədə yerinə yetirmək çətinləşir; onlar çoxlu enerji səfərbərliyi tələb edir və nəticədə əzabverici həyat hissi yaranır. O, o qədər çox qərar və onların həyata keçirilməsi ilə yüklənir ki ("başımda o qədər çox şey", daimi tələsiklik və daxili gərginlik hissi) bütün bunların nəticəsində onun əməlləri və ya istəkləri impulsiv, güclü emosional yüklə olur ki, bu da xüsusilə nevrastenik sindromun hiperstenik formasında özünü göstərir.

Beləliklə, nevrastenik sindromu zəif bir idarəetmə sistemi ilə müqayisə etmək olar, burada hər şeyə nəzarət edən aparıcı şəxslər hər şeyi bilmək və hər kəs üçün qərar vermək istəyirlər, amma əslində heç nə bilmirlər və heç nəyə qərar vermirlər.

İSTERİK NEVROZ

// TARİXİ QEYDLƏR

İsteriya adı yunanca hystera = uşaqlıq sözündən gəlir (19-cu əsrdə Polşa tibbi lüğətində "uterus" sözü istifadə olunurdu). Qədim dövrlərdə bu xəstəliyin qadın bədənindəki uşaqlığın hərəkəti ilə əlaqəli olduğuna inanılırdı. Freydin dövründən əvvəl belə bir inanc var idi ki, isteriya yalnız qadınlarda baş verirdi.

Freydin müasirləri onu isterik prosesin təbiəti ilə bağlı fikirlərinə görə sərt tənqid edirdilər.

Lakin Platon artıq isteriyanın kişilər arasında da rast gəldiyini müşahidə etmişdi. "Timaios" əsərində o yazırdı: "Buna görə də kişilərdə təvazökar orqanlar ağıla qulaq asmayan, lakin şəhvətin kəskin ucu ilə idarə olunan və hər şeyə hakim olmağa çalışan heyvanlar kimi itaətsiz və özbaşınadırlar. Qadınlarda isə vagina və uşaqlıq eyni səbəbdən belə adlandırılır. Bu, bədənində gizlənmiş və uşaq dünyaya gətirmək istəyən heyvandır. Yetkinlik yaşına çatdıqda uzun müddət meyvə vermədikdə, əziyyət çəkir və qəzəblənir. Bütün bədənini əl ilə gəzdirir, hava yollarını tıxayır, nəfəs almağa mane olur, ən pis problemləri və hər cür digər xəstəlikləri yaradır, ta ki, şəhvət və sevgi hər iki cinsi bükür, beləliklə, ağaclar kimi, meyvə verir və sonra o qoparılır."*

Sitatdan aydın olduğu kimi, isterik nevrozun cinsi fonuna inam hətta Platonun dövründə də yeni bir şey deyildi.

Freydin panseksualizmə dair qeyd-şərtsiz mövqeyi, onun təcrübəsində əsasən isterik tipli xəstələrlə qarşılaşmasından irəli gələ bilər. Həqiqətən də, onlar cinsi istək sahəsində bir sıra pozuntular göstərə bilər, əksər hallarda onun tam inkişafının gecikməsi (infantilizm) şəklində; lakin bu, qayda deyildi.

// "LA GRANDE SIMULATRICE"

Babinski* isteriyanı "La grande simulatrice" (böyük saxtakar qadın) adlandırırdı. Lakin bu tərif xəstənin digər xəstəliklərin xüsusiyyətlərini mənimsədiyini, yəni yalnız bundan sonra saxtakar olacağını nəzərdə tutmur. Əksinə, bu, isteriyanın özünün digər xəstəliklərə xas olan simptomları təqlid etdiyini göstərir. Beləliklə, müəyyən üzvi dəyişikliklərin yaratdığı simptomlarla, bu cür dəyişikliklər olmadıqda baş verən sözdə funksional simptomlar arasında spesifik böyük oxşarlıq var. Yəni isteriya ilə əsl simptom çox oxşayır.

Nevrozlarda tez-tez rast gəlinən bir sıra vegetativ pozuntular bu simptomlar qrupuna aiddir. Nevrotik baş ağrıları, məsələn, beyin şişlərindən qaynaqlanan baş ağrıları ilə eyni və ya daha ağır ola bilər.

Ürək və qarındakı sinir ağrısını üzvi mənşəli oxşar ağrılardan ayırmaq çox vaxt çətindir. Ürək döyüntüsü emosional həyəcan və ürək çatışmazlığının əlaməti ola bilər, qusma ikrah və ya ciddi mədə-bağırsaq pozuntusunun əlaməti ola bilər, çəki itkisi iştahsızlıq və sinir mənşəli metabolik pozuntuları, eləcə də kaxeziyaya səbəb olan ciddi xəstəlikləri göstərə bilər və s.

Həkimin vəzifəsi müşahidə olunan dəyişikliklərin əsl etiologiyasını müəyyən etməkdir. Eyni zamanda, həkim biologiyanın, bir qayda olaraq, polietiologiyalı xəstəliyi unutmamalıdır. Nəticə etibarilə, açıq-aşkar "üzvi" proseslərdə (məsələn, xoranın yaratdığı qarın ağrısı) psixogen amillər (xəstənin emosional vəziyyəti, travma və münasibətlər) də əhəmiyyətlidir. Əksinə, psixogen şəraitdə (məsələn, nevrotik qarın ağrısı) üzvi amillər (məsələn, zəif qidalanma, mədə-bağırsaq pozuntularına genetik meyil və s.) əhəmiyyətli ola bilər.

* Babinski (1857-1932), məşhur nevroloq və psixiatr, Şarko tələbəsi.

// KONVERSIYA

Emosional (psixogen) amillərin fiziki rifaha təsir etdiyi yerlərdə konversiyadan danışırıq (konverto = dönmə, istiqamətləndirmə). Hərfi mənada, vegetativ simptomlar da konversiya anlayışına daxil edilməlidir.

Bəzi psixiatrlar, xüsusən də fransız psixiatrları bunu məhz bu şəkildə izah edirlər.

Lakin əksər tədqiqatçılar konversiya anlayışını "somatik" sinir sistemi tərəfindən tənzimlənən funksiyalarda özünü göstərən və buna görə də insan iradəsindən asılı olan simptomlarla məhdudlaşdırır və məqsədyönlü hərəkətdən asılı olmayan vegetativ sistem tərəfindən tənzimlənən funksiyalarda baş verən simptomları istisna edirlər.

Konversiya simptomları ən çox üç pozuntu qrupuna bölünür: motor fəaliyyəti, həssaslıq və bütün davranış formaları, eləcə də insanın öz təcrübəsi və ətrafdakı reallığın qiymətləndirilməsi. Nevrozun digər formalarında emosional münaqişələr əsasən daxilə nüfuz edir və endokrin sistem pozğunluqları ilə yanaşı vegetativ sistemin disfunksiyalarına səbəb olursa, isterik nevrozda bu təsir xaricə yönəlir. Bu, sinir sisteminin xarici mühitlə signal mübadiləsini idarə edən hissəsinin ("somatik" sinir sistemi) funksiyasına təsir göstərir və subyektiv mənada normal olaraq iradə aktına tabedir. İsterik konversiya simptomunun özü ekstroversiya xüsusiyyətlərinə malik kimi görünə bilər. Vegetativ sinir sisteminin pozuntuları daxilə baş verir, heç kim onlar haqqında bilmir, halbuki isterik konversiya simptomları xaricə yönəlmişdir; onlar çox vaxt kömək üçün fəryad və ya ətraf mühitə qarşı etiraz ifadəsidir.

// İSTERİK ŞƏXSİYYƏT

İsterik nevroz anlayışı tez-tez isterik şəxsiyyət anlayışı ilə qarışdırılır. Bu

konsepsiya səhvdir, çünki isterik konversiya simptomları tez-tez isterik şəxsiyyət xüsusiyyətləri olmayan insanlarda özünü göstərir və əksinə, fərqli tipli nevrozlar açıq-aşkar isterik xarakter xüsusiyyətləri olan insanlarda rast gəlinir. Bu sonuncu halda, psixiatrlar, açıq şəkildə isterik şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik bir insanda fərqli bir nevrozun xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə çalışaraq, nevroz növünün əsl diaqnozuna "isterik" sifətini əlavə edərək, "nevrazenik-isterika nevroz", "depressivo-isterika", "anankastiko-isterika" və s. diaqnoz qoyurlar, baxmayaraq ki, daha düzgün tanınma "individuo isterik nevroz nevrazenika" və s. olardı və beləliklə, isterik simptomlardan daha çox isterik şəxsiyyəti vurğulayırlar. Buna baxmayaraq, bir çox nevrotik sindromlarda - yalnız psixogen mənşəli sindromlarda deyil, həm də üzvi dəyişikliklərdən və ya başlanğıc psixozlardan qaynaqlanan sindromlarda - isterik şəxsiyyət xüsusiyyətləri əvvəllər nəzərə çarpmırdısa, daha da kəskinləşir və ya özünü göstərir. Bu, isterik şəxsiyyət infantil tipi təmsil etdiyi üçün daha erkən və daha ibtidai davranış və təcrübə formalarına spesifik

regressiya ilə müəyyən edilə bilər. Etioloji fonundan asılı olmayaraq, istənilən xəstəlik regressiv meyllərə səbəb olur - xəstəlik zamanı insan yenidən uşaq olmaq, yaxınlarından kömək və diqqət istəmək arzusunda olur.

Konversiyanın cizgiləri

İsterik konversiyanın bütün ən xarakterik cizgilərini, hətta təxminən belə müəyyən etmək çətindir. Bunlar o qədər çoxdur, dövrdən və sosial mühitdən asılı olaraq dəyişkənlik o qədər əhəmiyyətlidir ki, hansının qeyd edildiyi hec vaxt məlum deyil. Artıq qeyd edildiyi kimi, isterik (konversion) simptomlar üç qrupa bölünür:

motor, sensor və ruhi pozuntular. Hər bir qrup daxilində öz növbəsində həyəcan və ya funksiyanın zəifləməsi kimi özünü göstərən pozuntular müəyyən edilə bilər.

Beləliklə, hərəkət pozuntuları müxtəlif növ hiperkinez (geniş amplitudalı hərəkətləri) və müxtəlif növ zədələnmələri əhatə edir. Sensor pozuntuları bu qavrayış funksiyasında azalma (ağrı reaksiyasının olmaması, isterik karlıq və korluq) və ya onun artması (hiperhəssaslıq, davamlı ağrı, vizual və ya eşitmə hiperhəssaslığı və s.) ilə əlaqəlidir. Psixi pozuntular həddindən artıq həyəcan və ya apatiya, əla yaddaş (hipermneziya) və ya onun itirilməsi (amneziya) hallarını əhatə edir.

Əlbəttə ki, hər hansı bir təsnifat kimi, bu da ağrılı simptomların təzahürü üçün bütün imkanları tükəndirmir.

// KONVERSIYANIN MOTOR SİMPTOMLARI

İsterik hemiplegiya və pozuntuları üzvi olanlardan fərqləndirmək, bir qayda olaraq, nevrologiya haqqında müəyyən biliklərlə çətin deyil. Üzvi pozuntular kifayət qədər aydın və spesifik simptomatologiyaya malikdir və motor pozuntuları halında xarakterik xüsusiyyətlərə ətrafların mövqeyi, əzələ tonusunda tipik dəyişikliklər və dərin reflekslərdəki fərqlər daxildir. Funksional (isterik) pozuntularda üzvi pozuntunun kifayət qədər sabit mənzərəsinə uyğun olmayan çoxsaylı simptomlarla qarşılaşırıq və nəticədə təsirlənmiş ətrafın mövqeyi atipikdir və əzələ gərginliyindəki dəyişikliklər müşahidə olunanlardan fərqlidir.

Üzvi boş və ya spastik iflicdə hər iki əzadakı vətər refleksləri simmetrikdir və patoloji reflekslər yoxdur (məsələn, Babinskinin). Lakin bəzən hətta təcrübəli nevroloqlar belə müəyyən bir diaqnozu dərhal aşkar edə bilmirlər.

Bu, ən çox üzvi dəyişikliklər funksional dəyişikliklərin üzərinə qoyulduqda baş verir. İsterik pozuntuların olduqca xarakterik xüsusiyyəti xəstənin iradi motor effekti əldə etmək üçün həddindən artıq səy göstərməsidir: onlar bütün əzələləri gərginləşdirir, tərləyir və üzlərini bükürlər, lakin təsirlənmiş əzələ qıvrılmaz. Bəzən təsirlənmiş əzələdə hərəkət xəstənin diqqətini çəkməməsi halında hiss edilə bilər.

İndi illərlə yataqda uzanan, isterik ayaq iflici səbəbindən ayağa qalxa bilməyən xəstələrə rast gəlmək nadir haldır. Onların iflici o qədər uzun çəkirdi ki, kontrakturalar və əzələ atrofiyası inkişaf edirdi və dırnaqları ovuclarına qədər böyüyürdü, çünki hərəkətsiz əl illərlə yumruğa sıxılmışdı. Belə xəstələr bir neçə onilliklər əvvəl nadir deyildi və bu cür halların təsvirlərinə köhnə nevrologiya və psixiatriya dərslərində rast gəlmək olar.

Hazırda isterik astaziya-abaziya, yəni ayaq üstə dura və ya yeriyə bilməmək olduqca yaygındır. Belə bir xəstə ayaqlarında güc saxlayır, lakin dik vəziyyətdə ayaqları onların altından boşalır və yerə yığılır.

Yazıçı qıcolmaları (qrafospazm) da tez-tez rast gəlinir, burada xəstə yazarkən əzələlərini o qədər gərginləşdirir ki, əli hərəkətsiz qalır və bu proses üçün lazım olan incə hərəkətlərə mane olur. Xəstə kağızda yalnız ziqzaqlar qoyur və ya digər əli ilə onlara kömək etmək üçün çox oxunmaz şəkildə yazır. Bu pozuntu müəyyən dərəcədə peşə xarakterlidir və zərurət üzündən çox yazan insanlarda (xüsusən müəllimlərdə) daha tez-tez baş verir.

Həddindən artıq sayda olan əks hərəkət pozuntu növü tez-tez müxtəlif növ qeyri-iradi hərəkətlər şəklində özünü göstərir. Bunlara yuxarı və ya aşağı ətrafların "əsməsi" daxildir ki, bu da tez-tez yalnız isterik nevroza xas deyil, titrəmə (əsmə) və xoreya, atetoz və s. kimi məcburi hərəkətlərdən şikayətlənən xəstələrdə də istisna olunmur. Bu hərəkətləri subkortikal sahələrin, əsasən də korpus kallosumun zədələnməsi ilə baş verən oxşar qeyri-iradi hərəkətlərdən ayırmaq çətindir.

Emosional stimullar üzvi zədələnməni təqlid edə bilər.

Funksional təbiətli məcburi hərəkətlərə göz qapaqlarının tez-tez yanıb-sönməsi, stereotipik üz ayrılıqları və iradədən asılı olmayan və ya yalnız bir qədər idarə olunan qeyri-adi qol və ya ayaq hərəkətləri kimi müxtəlif növ tiklər daxildir. Əksər müəlliflər onları isterik konversiya kimi təsnif etmirlər. Onlar tez-tez bir hərəkətin şüurlu təkrarlanması ilə başlayırlar ki, bu da sonradan xəstənin iradəsindən asılı olmayaraq ortaya çıxır və böyük səylə belə, onu saxlamaq çətin və ya həтта mümkünsüz olur. Bu cür hərəkətlər tez-tez təbiətə obsesifdir və zaman keçdikcə motor obsessiyası ilə əlaqəli emosional məzmun yox olur və yalnız tiklər qalır. Uşaqlarda tiklər, psevd-xoreoform hərəkətləri və dırnaq dişləmə kimi obsesif hərəkətlər şəklində müxtəlif qeyri-iradi hərəkətlər xüsusilə tez-tez rast gəlir. Hər bir hərəkət, xarici yönümlü fəaliyyət forması kimi əsas əhəmiyyətinə əlavə olaraq, emosional gərginliyi aradan qaldırmağın sadə bir yolu kimi də xidmət edir. Bu əsasda, məsələn, imtahan və ya vacib görüş gözləyərkən, ona dözmək daha asandır; daxili gərginlik, oturub-durmaq əvəzinə, irəli-geri yerimək və ya məqsədsiz şəkildə qollarını yelləmək. Tiklər emosional azadlığın gücləndirilmiş forması hesab edilə bilər.

Sensor konversion SİMPTOMLAR

Toxunma və ağrı itkisi əksər hallarda ifliclə eyni vaxtda özünü göstərir. İflic olmuş ətrafda toxunma hissi olmur. İflic hallarında olduğu kimi, konversiya duyğu pozuntularının paylanması üzvi pozuntularda baş verən paylanmaya uyğun gəlmir. Əksər hallarda konversiya pozuntuları bədənənin yarisına, bir və ya hər iki ətrafa təsir göstərir. Buna "əlcək" və ya "corab" duyğu itkisi deyilir, yəni təsirlənmiş sahə məhz bu şəkildə görünür. Bəzən həssaslığın olmaması ləkələr kimi görünür və bu tip pozuntu əvvəllər "stigmata diaboli" kimi təsvir edilmişdir, çünki belə bir anesteziya edilmiş sahənin yaradılması fərdin şeytani gücünü sınaq üçün əsas idi. Çox vaxt həssaslığın olmaması boğazda və ya vaginada özünü göstərir. Bir vaxtlar boğaz refleksinin olmaması isteriya patonomonik hesab olunurdu. Anorgazm, tez-tez açıq şəkildə isterik şəxsiyyət xüsusiyyətləri olan qadınlarda müşahidə olunsada, vaginal həssaslığın olmamasının səbəbi hesab edilə bilməz. Həssaslığın olmaması bölgələrində bəzən dərin dəri yaralarından belə qanaxmanın qarşısını alan damar spazmları kimi vegetativ pozuntular yaranır. Məlumdur ki, şamanlar ritual rəqs zamanı hipnotik transa girərək, bir damla qan çəkmədən bədənlərini bıçaqla sərbəst şəkildə deşə bilirdilər. İsterik korluq nisbətən nadirdir, lakin görmə sahəsinin konsentrik daralması tez-tez müşahidə olunur (bu simptom tez-tez isteriyaya aid edilir). Göz qapaqlarının spazmodik sıxılması ilə xarakterizə olunan blefarospazm, görmə funksiyasını pozan bir motor pozğunluğudur. (Krakov psixiatriya klinikasında ambulator müalicə alan bir xəstə özünə yuxarı göz qapaqlarını dəstəkləyən xüsusi tel eynəklər düzəltdi və yalnız bundan sonra görə bildi.)

İsterik karlıq da nadirdir. İsterik korluq kimi, bu da əksər hallarda güclü emosional stressin təsiri altında, məsələn, döyüş meydanında, bombardman zamanı və ya beyin silkələnməsindən sonra özünü göstərir.

Daha az hallarda isterik korluq və ya karlıq təqaüdə çıxma zamanı baş verir və sonra onu yalan danışmaqdan ayırmaq çətinidir.

İsterik dad itkisi adətən ammonyak kimi kəskin qoxuları qavramaq qabiliyyətinin itirilməsi ilə əlaqələndirilir ki, bunun qavranılması trigeminal sinirin stimullaşdırılmasından asılıdır və üzvi mənşəli qoxu itkisində yoxdur.

İsterik dad itkisi tez-tez patoloji iştaha itkisi (anoreksiya nervozu) ilə birlikdə baş verir.

Hiss orqanlarının hiperhəssaslığı nevrastenik sindromlar üçün xarakterikdir və yuxarıda qeyd edildiyi kimi, siqnalları seçmək qabiliyyətinin azalması ilə əlaqələndirilir.

Ekstazın isterik vəziyyətlərində ətrafdakı reallığın qeyri-adi dərəcədə intensiv qavranılması, tez-tez keyfiyyətcə dəyişdirilmiş şəkildə özünü göstərə bilər. Qavrayışın bu cür intensivləşməsinə kəskin şizofreniya və ya epilepsiyada rast gəlinən oxşar vəziyyətlərdən ayırmaq çətinidir. Əşyaların kiçildilmiş nisbətə (mikropsiya) və ya əksinə, böyüdülmüş nisbətə (makropsiya) görülməsi ən çox psixozüvi sindromlarda (məsələn, intoksikasiya psixozlarında, alkoqol intoksikasiyasında) rast gəlinir, eyni zamanda isteriyada da baş verir.

İsterik konversiyanın ən çox rast gəlinən simptomlarından biri ağrı qavrayışının güclənməsidir. İsterikdə ağrı adətən lokal olur, əsas simptomlardan biridir və vegetativ sistemin disfunksiyası səbəbindən digər nevrozlardakı ağrıdan daha kəskin şəkildə qəbul edilir. İsterik və vegetativ ağrıları ayırd etmək çox güman ki, akademik müzakirə mövzudur. Konversiyanın tərifinə ciddi şəkildə riayət etməklə, bədənin daxilindən qaynaqlanan ağrı bu anlayışdan tamamilə çıxarılmalıdır, çünki bu, vegetativ sinir sistemində deyil, somatik sinir sistemində yaranan funksional pozuntulara aiddir.

İsterik nevrozda ən çox rast gəlinən ağrılara ürək ağrısı, baş ağrıları, qarın ağrısı və cinsiyyət orqanı ağrısı daxildir. Bu ağrılar davamlıdır, bəzən qeyri-adi bir xarakter alır və bir yerdə məhdudlaşır. (Məsələn, isterik baş ağrısı clavus hystericus - isterik mismar kimi müəyyən edilir.) Ağrıkəsicilərin qəbulundan sonra onlar keçmir, vegetativ distoniya ilə əlaqəli ağrı isə xəstə bu cür dərmanları qəbul etdikdən sonra keçir.

Davamlı ağrı xəstəni əməliyyat otağına apara bilər.

Bəzən cərrah, xüsusən də klinik mənzərənin aydın olmadığı hallarda xəstənin təzyiqinə tab gətirə bilmir. Nadir hallarda olsa da, termorequlyasiya mərkəzlərinin həssaslığının artması səbəbindən bədən istiliyinin yüksəlməsi və ya qan damarlarının keçiriciliyinin artması səbəbindən tənəffüs yollarından, həzm sistemindən və ya doğum kanalından qanaxma kimi digər, daha obyektiv funksional simptomlar da yarana bilər.

Zəif klinik mənzərəyə nümunə olaraq isterik hamiləliyi göstərmək olar ki, bu da yalnız menstruasiyanın gecikməsi və tipik qarın böyüməsi ilə deyil, həm də süd vəzilərində dəyişikliklərlə, kolostrumun ifrazı ilə xarakterizə olunur.

Maraqlıdır ki, isterik hamiləlik, isterik konversiyanın bəzi digər simptomları (iflic, konvulsiyalar) kimi, ev heyvanlarında da baş verə bilər (ən çox pişiklərdə və itlərdə).

// XƏSTƏLİYƏ QAÇIŞ

Üzvi proseslər zamanı (məsələn, baş zədələrindən, sınıqlardan və ya əməliyyatdan sonra) baş verən isterik təbiətli ağrı ilə böyük diaqnostik və terapeutik çətinliklər yaranır. Travmadan sonra belə ağrının öz fizioloji izahı var. Lakin, ağrıkəsicilərdən istifadə edərkən onun sabitliyi, güclənməsi və tez-tez təsirsizliyi funksional təbiətindən şübhələnməyə əsas verir.

Xəstə ilə söhbət zamanı onun ruhdan düşmüş əhval-ruhiyyəsini, məsələn, başına gələn və ətrafdakılar tərəfindən düzgün qəbul edilməmiş qəza ilə əlaqəli kin-küdurət hissini hiss etmək olar. Xəstəlik, həmişə konkret olmasa da, bir məqsədə çatmaq üçün vasitə kimi xidmət edə bilər.

Belə vəziyyətlər pensiya proseslərində yaranır. Pensiya almağa çalışan xəstə özünü qapalı bir dairədə tapır - nə qədər çox istəsə, ağrılı nevroitik xüsusiyyətləri bir o qədər artır. Ətrafındakıların, xüsusən də vəziyyətlərini pis qiymətləndirən həkimlərin kin-küdurəti və əzablarını anlaşılmazlıq hissi artır. Bütün bunlar nevroitik simptomların artmasına səbəb olur. Sağalma qeyri-mümkün olur, çünki bu, xəstənin mübarizə apardığı həqiqət hissini itirməsinə bərabər olardı.

18

Hər bir xəstəliyin mənfi cəhətləri ilə yanaşı, müsbət cəhətləri də var, məsələn, buraya nevroitik simptomların davamlılığı və ya üzvi zədələnmə aradan qalxdıqdan sonra belə subyektiv şikayətlərin uzun müddət davam etməsi aid edilə bilər. Bu fenomen xalq arasında "xəstəliyə qaçmaq" adlanır. Lakin, ağrılı simptomların bu cür istifadəsi xəstənin xoşagəlməz məsuliyyətlərdən və ya başqa bir xoşagəlməz vəziyyətdən qaçmaq istəyində şüuraltı müsbət hərəkətidir, yəni bu hallarda simulyasiyadan şübhələnməmək lazımdır. Nevrozdan xəstə həqiqətən əziyyət çəkir. Və hətta xəstəlikləri sayəsində çətin problemlərini həll etsələr belə, məsələn, pensiya alsalar, ətrafdakı insanlar onlara qarşı münasibətlərini yaxşılığa doğru dəyişsələr, həyat yoldaşı daha qayğıkeş olsa, işdə daha asan tapşırıqlar götürsələr və s., bu məqsədə şüuraltı olaraq, simulyasiyada olduğu kimi deyil, xəstənin xəbərsiz olduğu zehni mexanizmlər vasitəsilə nail olunur.

NİTQ POZUNTULARI

İsterik konversiya nəticəsində pozulmuş daha mürəkkəb fəaliyyət formalarına keçərək, nitq pozuntularını nəzərə almaq lazımdır. Ən çox,

səsin itirilməsi (aphonia hysterica) baş verir və xəstə pıçıltı ilə güclə danışa bilər. Nitq pozuntusu funksional və ya üzvi mənşəli olub-olmaması qeyri-müəyyən təbiətdədirsə, qırtlaq müayinələri çox vacibdir. İsterik afoniya

adətən qəfil qorxu kimi ağır psixoloji şok zamanı,

daha az hallarda qəzəb tutması zamanı baş verir. Afoniya həmçinin ən çox qəfil emosional amilin təsiri altında aradan qalxır (afoniya üçün köhnə və tez-tez təsirli müalicə qırtlaqın elektriklişdirilməsidir; gözlənilməz ağrılı stimulun yaratdığı qorxu qırtlaq əzələlərinin funksional iflicini kəsir və xəstənin ucadan qışqırmasına səbəb olur). İsterik iflic və hiss pozuntularında simptomların başlanğıcı ilə emosional stimul arasında müvəqqəti əlaqə nadirdir.

Digər tərəfdən, ağrılı simptomlar nisbətən tez-tez aşkar səbəb olmadan ortaya çıxır; Məsələn, xəstə səhərlər hərəkətsiz bir ətraflar ilə oyanır. Bu hallarda yuxuların birbaşa emosional amil kimi çıxış edə biləcəyi istisna edilə bilməz. Bir qayda olaraq, yuxuların məzmunu şüurlu həyatın mənasına ziddir və şüur

tərəfindən zorla basdırılır; əks məzmunlar arasındakı bu mübarizə ilə əlaqəli olan və şüura nüfuz etməyən emosional gərginlik somatik sinir sisteminin funksiyasına təsir göstərir.

Afoniya kimi, icraedici motor aparatının özü (tənəffüs, qırtlaq, dil və dodaq əzələləri) ilə əlaqəli nitq pozuntularına kəkələmə, söhbətlə müşayiət olunan tiklər, skan edilmiş nitq, battarizm və dizartriya daxildir. Bunlardan bəziləri müəyyən üzvi pozğunluqlarla (skleroz disseminata zamanı skan edilmiş nitq, paralizis progressiva zamanı dizartriya) baş verir, lakin onlar konversiya ilə də ortaya çıxa bilər.

Kəkələmə ən çox uşaqlıqda, güclü, qəfil, təhdid edən emosional amilin nəticəsi olaraq dəfələrlə ortaya çıxır (məsələn, uşağa it hücum edir, suya düşür və boğulmağa başlayır, yanğından qorxur və s.).

Əksər müəlliflər bu tip kəkələməni konversiya simptomu kimi təsnif etmirlər, onlar bunu Uşağın inkişafının müəyyən mərhələsində yaranan emosional travmanın həmin dövrdə ən həssas və ən son inkişaf edən funksiyaya təsiri ilə əlaqələndirirlər.

Tiklərə bənzər şəkildə, kəkələmə fiksə olunmuş hərəkəti stereotipdir.

Daha ifadəli isterik kəkələmə yetkinlərdə özünü göstərir və daha az stereotipik və daha dramatikdir. Xəstə danışarkən üzünü qırışdırır, şişirir və qızarır. Yetişkinlərdə Digər

nitq pozğunluqları növləri (battarizm, dizartriya, skan edilmiş nitq) daha az rast gəlinir.

Üzvi səbəblərdən yaranan pozğunluqlardan fərqli olaraq, onlar daha az stereotipikdir, daha müxtəlifdir və təzahürləri ilə zəngindir və buna görə də isterik

konversiya diaqnozu qoymaq çətin deyil, xüsusən də pozğunluğun üzvi təbiətini göstərən digər nevroloji təzahürlər olmadıqda.

Afaziya bənzər və buna görə də, yaddaşda sözlərin fiksasiyası ilə əlaqəli nitq pozuntuları nadir rast gəlinir. Ən çox yayılmış afaziya amnestik tiptir, bu zaman emosional bloklanma səbəbindən zəruri, tanınmış bir sözü xatırlamaq mümkün deyil. Bu tip afaziya ümumiyyətlə isterik simptom hesab edilmir, çünki normal halda da tez-tez rast gəlinməyindən xəstəlik kimi təsnif edilmir. Motor və ya sensor afaziya bənzər isterik afaziya nadirdir. Dərin həyəcan zamanı insan "dilini uda" bilər və sonra - motor afaziyasında olduğu kimi - yalnız təcrid olunmuş sözlər və ya hecalar ortaya çıxır, başqaları üçün anlaşılmazdır və ya - sensor afaziyasında olduğu kimi - sözlər bir-birinə yapışdırılır, lakin onlar məna və ya məzmun baxımından bir-biri ilə əlaqəli deyil. Lakin nadir hallarda bu tip emosional nitq pozuntusu çox uzun müddət davam edir və onu isterik konversiya simptomu kimi təsnif etmək çətinidir. Digər tərəfdən, əsl afaziyada, yəni müvafiq beyin mərkəzlərinə üzvi pozuntu nəticəsində yaranan nitq pozuntularında, emosional amillər reabilitasiya prosesində mühüm rol oynayan nitqə mane ola və ya onu asanlaşdırma bilər.

Nitq funksiyasında tam gecikmə mutizm kimi müəyyən edilir. Yuxarıda qeyd olunan nitq pozuntuları kimi, mutizm də güclü emosional stimulun təsiri altında baş verə bilər ki, bu da xalq arasında "həyəcandan lal olmaq" kimi təsvir olunur.

İsterik mutizmi şizofreniya zamanı katatonik formada, ağır depressiyada, epileptik tutmadan sonra və ya epileptik əlaqədarlıq vəziyyətində və müəyyən üzvi beyin zədələnmələrində, xüsusən də beyin

kötüyündə lokallaşdırılmış mutizmdə (sözdə mutizm akinetique) olduqca asanlıqla ayırd etmək olar. İsterik mutizmdə, digər mutizm növlərindən fərqli olaraq, xəstə üz ifadələri, jestlər və yazı vasitəsilə başqaları ilə əlaqə qura bilir. İsterik mutizm bəzən başqalarına qarşı mənfi emosional vəziyyətin ifadəsidir; xəstə, incimiş uşaq kimi, susur. İsterik şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik şəxslərdə artan danışiq elementləri müşahidə edilə bilər. Bu isterik nazlanma (ishal verborum və ya loqoreya) adətən emosional gərginlik vəziyyətlərində güclənir. Söz axını daxili gərginliyi aradan qaldıran bir amilə çevrilir. Bu hallarda ümumi prinsip emosional gərginliyin motor fəaliyyətinin oyanmasına və ya tormozlanmasına səbəb olmasıdır.

Psixi POZUNTULAR

İsterik konversiya kimi təyin edilə bilən ən çox yayılmış ruhi pozuntular arasında müxtəlif klinik təzahürlərlə şüurun müxtəlif dərəcələrdə daralması var. Ən sadə nümunə isterik tutmadır. Belə bir vəziyyətdə olan insan həyəcanlı, heyrətlənmiş və dərin emosional gərginlik içində görünür. Onlar qışqırır, ağlayır, saçlarını və paltarlarını cırır, özlərini yerə atır və bədənlərini gərginləşdirirlər. (Bir neçə onillik əvvəl, İsteriya üzrə məşhur tədqiqatçı Şarkonun dövründə isterik qövslər — qövs en cercle — məşhur idi. Tutma zamanı xəstə bədənini mümkün qədər əyərək, yalnız başı və dabanları üzərində dayanır.) Tutma adətən bir neçə dəqiqədən sonra kortəbii şəkildə keçir; tez-tez qəfil ağrı və ya emosional stimullar (məsələn, qorxu) ilə kəsilə bilər. Xəstənin adətən tutma haqqında heç bir xatirəsi olmur.

Şüurun daralması qıcolmalarla əlaqələndirilə bilər.

Epileptik tutmadan fərqli olaraq, isterik tutma daha xaotik və müxtəlifdir və

xeşli uzun müddət davam edir. Tutma zamanı xəstə yerə qərribə bir şəkildə

güclü zərbə vurmada və bir qayda olaraq, nəcis buraxmadan yığılır.

Həmçinin, epileptik tutmada müşahidə olunan patoloji nevroloji simptomlar (göz bəbəklərinin hərəkətsizliyi, Babinski əlaməti) yoxdur; Dərin yuxu epileptik tutma üçün tipikdir, isterik deyil. Lakin, differensial diaqnozun çətin və ya hətta qeyri-mümkün olduğu qıcolmalar var.

Bəzən epileptik tutmalar isterik tutmalarla üst-üstə düşür.

Elektroensefaloqramdakı paroksizmal elementlər, əvvəllər yalnız klinik mənzərəyə əsasən isterik kimi təsnif edilən tutma formalarında belə, tutmanın epileptik təbiətini göstərir.

Digər tərəfdən, isterik, infantil və impulsiv şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik insanlarda elektroensefaloqramda patoloji anomaliyalar göstərmə ehtimalı ümumi əhaliyə nisbətən daha yüksəkdir ki, bu da bioloji yetkinlik yaşına çatmamışlığı əks etdirir və paroksizmal boşalmalara artan meyl ilə müşayiət olunur. Belə insanlarda paroksizmal da daxil olmaqla isterik reaksiyalar da olur. 19-cu əsrdə "isterik epilepsiya" termini istifadə olunurdu, lakin psixiatrik diaqnostika inkişaf etdikcə ondan imtina edildi.

İsterik tutmalar zamanı bəzən xəstədə sevgi ekstazları, dini qəzəb, nifrət, qorxu və s. kimi yuxuda olan emosional vəziyyətləri ifadə edən davranış nümunələri ortaya çıxır. Əks vəziyyət isterik daşlaşma (stupor) halıdır. Burada emosional gərginlik hərəkətin tamamilə dayandırılmasına səbəb olur. Xəstə, sabit baxışlarla, heç nəyə reaksiya vermir; hərəkətsiz və çarəsiz olduqları üçün onlar rəğbət və ya qıcıqlanma yaradırlar. İsterik stuporu katatonik, depressiv və ya üzvi stupordan olduqca asanlıqla ayırd

etmək olar. Daha səthi olur və xəstənin hərəkətsizliyinə baxmayaraq, insanın üz ifadələrində, təsadüfi jestlərində və məqsədyönlü hərəkətlərində onun köhnə şəxsiyyətinin izlərini görmək olar. Eyni şey isterik əlaqədarlıq vəziyyətlərinə də aiddir; əvvəlkilər kimi, onlar kəskin şizofreniya və üzvi psixozlarda oxşar sindromlardan daha az dərindir. Bəzən isterik əlaqədarlıq vəziyyətlərində xəstənin münaqişələri və xəyalları ilə əlaqəli mövzuları qeyd etmək olar. Şüurun daralma dərəcəsi müxtəlifdir və tez-tez dəyişir. Şüurun daralma dərəcəsi yüngüldür və keçmişi yaddaşdan silməkdən ibarətdir. Xəstələr soyadlarını, ünvanlarını və ya bu ana qədər baş verən hər hansı bir şeyi xatırlamırlar. Xəstə yenidən yaşamağa başlayır. Artıq baş verənləri asanlıqla silmək meylli də isterik şəxsiyyət üçün xarakterikdir. **Aydın əlaqədarlıq vəziyyətində yenidən başlamaq və artıq baş verənləri silmək istəyi gerçəkləşir. Aydın əlaqədarlıq vəziyyətləri nadir** hallarda olur. Bu hallarda, bütün həyat tarixinin yaddaşdan çıxarılmasından ibarət şüurun daralmasının nə dərəcədə epileptik mənşəli olduğunu və nə dərəcədə isterik olduğunu müəyyən etmək çox vaxt çətindir.

21

Bu tip çətinliklər, əsasən, baş zədəsindən dərhal və ya bir müddət sonra aydın əlaqədarlıq vəziyyətinin yarandığı hallarda yaranır. Travma keçirdikdən sonra xəstə xoş xatirələri ilə əlaqəli yerlərdə dəfələrlə gəzməyə başlayır. O, keçmişini, hətta soyadını belə xatırlaya bilmir. Bəzən bu cür gəzishmələr heç bir səbəb olmadan kortəbii şəkildə başlayır, digər vaxtlarda isə səbəb həyat şəraiti, məsələn, gərgin ev mühiti, işdəki çətinliklər, hərbi xidmət və ya hüquqi məsuliyyət qorxusu olur.

Qaçmaq üçün qarşısıalınmaz bir istək (poriomaniya, fuqalar) həmçinin çətin həyat vəziyyətindən qaçmaq üçün gizli bir istəyin isterik şəkildə reallaşması və ya uşaqlarda və yeniyetmələrdə olduğu kimi macəra susuzluğu ola bilər. Bəzən bütün qaçış epizodu amneziya ilə örtülür və ya yalnız onun fraqmentləri yaddaşda qalır. Poriomaniya zehni cəhətdən geri qalmış şəxslərdə, əlaqədarlıq şüurunun qocalıq vəziyyətlərində və şizofreniya və epilepsiyada rast gəlinir.

Dünyada, yəqin ki, heç olmasa bir anlıq da olsa, həyatdakı rolunu dəyişdirmək, ətrafındakı hər şeydən qaçmaq üçün başqası olmağı arzulamayan bir nəfər yoxdur. Lakin, bu cür istəklər yalnız az-çox şüurlu düşüncə aləmində mövcud ola bilər və yalnız isteriyada gerçəkləşə bilər.

Hər bir insanın daxilində gizlənən pis niyyətlərin gerçəkləşməsinin ədəbi nümunəsi Stivensonun məşhur "Doktor Cekil və cənab Hayd" povestidir. Uilyam Ceyms "Psixologiyanın Prinsipləri" əsərində aydın, əlaqədarlıq bir vəziyyətdə İngiltərəni tərk edərək Amerikaya gedən, orada cənab Braun kimi bir mağaza açan və bir neçə ay sonra bir gözəl səhər pastor Bourne kimi oyanan, bir pastorun özünü evindən bu qədər uzaqda tapmasına təəccüb və anlaşılmazlıq hissi ilə oyanan Pastor Bornu nümunə gətirir. Bu hal tez-tez psixiatriya dərsləklərində isterik şəxsiyyət dəyişikliyinə nümunə kimi göstərilir. Qanser sindromu və ya Vernike psevdodemansı (yalançı axmaqlıq) ən çox xəbərxanada rast gəlinir, baxmayaraq ki, bu qayda deyil və bu sindromlar digər çətin vəziyyətlərdə də özünü göstərə bilər. Belə xəstələr çarəsizdirlər, hətta ən sadə suallara belə anlaşılmaz cavab verirlər və davranışları ibtidai böhtan təəssüratı yaradır, inəyin beş ayağı olduğunu və iki ilə ikinin beşə bərabər olduğunu təkrarlayırlar. Onların əhval-ruhiyyəsi depressiv və ya yersiz yumoristikdir. Xəstə üçün "axmaq" rolunu qəbul etməyin çətin vəziyyətdən yeganə çıxış yolu olduğunu düşünmək olar. Bəlkə də əvvəlcə şüurlu şəkildə mənimsənilən bu rol sonda onların ikinci şəxsiyyətinə çevrilir. Xəbərxana şəraitində də ən çox görülən puerilizm çarəsiz bir uşağı xatırladan davranışdan ibarətdir.

Nadir hallarda xəstənin heyvanlara çevrildiyi şəxsiyyət dəyişiklikləri daxildir. Orta əsrlərdə likantropiya epidemiyaları baş vermişdi. Təsirə məruz qalanlar heyvanlara, əksər hallarda canavarlara çevrildiklərinə və onları təqlid etdiklərinə qəti şəkildə inanırdılar. Şizofreniya xəstələri də onların arasında ola bilər, çünki bu sonuncu xəstəlikdə heyvana çevrilmək hissi qeyri-adi hal deyil. Lakin, bu fenomenin epidemik təbiətini nəzərə alsaq, bu cür pozğunluqlar çox güman ki, isterik şəxsiyyət dəyişiklikləri kimi təsnif

edilməlidir. Bunun kökündə xəstənin insan olmasına mane olan günahkarlıq hissi və ya heyvan rolunda özünü "vəhşi instinktlərindən" azad etmək istəyi dayana bilər.

22

Təxminən 1700-cü ildə bir Fransız monastırında bütün rahibələr pişiklərə çevrildiklərinə qəti şəkildə əmin olaraq miyovlamağa başladılar. Eskimoslar arasında, zahirən isterik təbiətli, whitico adlanan bir psixoz meydana gəlir. Bu, iştahsızlıq, ürəkbulanma, qusma və ishal ilə müşayiət olunan dərin depresif-fobik vəziyyətlə başlayır. Xəstə whiticoya, yəni insanları udan nəhəng buz skeleti şəklində bir cimə çevrilməkdən qorxur. Əgər xeyirxah bir şaman xəstəyə tətbiq olunan pis sehri dağıtmasa, whitico əslində bir qohumuna hücum edə, öldürə və yeyə bilər. Bu psixozun mənzərəsi Stivensonun novellasını xatırladır: insan adətən özlərində gizlətdiyi vəhşi alter eqosuna çevrilir.* Jan M. Şarko (1825-1893); Məşhur fransız psixiatri və nevroloqu.

// İSTERİYANIN "YOLUXUCULUĞU"

İsterik davranış modellərinin xüsusiyyətlərindən biri onların ətraf mühitə asanlıqla ötürülməsidir. Əgər xəstə isterik şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik, emosional gərginliyi aradan qaldırmaq ehtiyacı olan insanlarla əhatə olunubsa, xəstənin davranışı asanlıqla "yoluxmuş" ola bilər. Bu, təzyiqli gərginlikdən azad olmaq üçün yol açır. İnsan kütləsinin davranışını müşahidə edərkən çoxsaylı nümunələrə rast gəlmək olar. Bir insanın reaksiyası - teatrallığı ilə isterik reaksiyaya bənzəyən panik, həvəs, nifrət - ətrafdakılara asanlıqla ötürülür. Psixiatriya şöbələrində xəstələr tez-tez qarşılıqlı olaraq ağrı və ya motor çevrilməsi və ya isterik davranış kimi öz simptomlarını yaradırlar.

İsterika üzrə böyük mütəxəssis olan Şarko, bu xəstəliyə və xəstələrin teatr nümayişlərinə olan marağı ilə xəstəxanalarda dramatik isteriya formalarının epidemiyalarına səbəb oldu. XI-XV əsrlərdə Alman və Fləmand kəndlərində Müqəddəs Vitus Rəqsi epidemiyaları baş verdi. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar bir neçə gün və gecə huşunu itirənə qədər kilsələrin yaxınlığında toplaşır, mahnı oxuyur və rəqs edirdilər. Çoxları qıcolmalardan əziyyət çəkirdi. Cinsi əlaqə bəzən ümumi həyəcan arasında baş verirdi və qadınlar hamilə qalırdılar. Müqəddəs Vitus Rəqsinin adı, görünür, insanların bu xəstəlikdən müalicə olunduğu Zaberidəki Müqəddəs Vitus kilsəsindən gəlir. Oxşar epidemiya XV əsrdə Şimali İtaliyada da baş vermişdi. Xəstələr Lycosa tarentula hörümçəyi tərəfindən dişləndiklərini düşünürdülər, buna görə də "tarantulizm" adı verilmişdir.

Musiqi təsirli bir müalicə hesab olunurdu və tarantellanın rəqs melodiyası bu gün də istifadə olunur. Tanrının tərifini görmək üçün başlarını göbəklərinə toxundurmağa çalışan Bayraqlıların, Palamitlərin və çılpaq gedən Adamitlərin məşhur orta əsr təriqətləri isteriyadan daha çox kütləvi fanatizmin əlaməti idi.

Bəzən Malay adalarında ilk dəfə latah adı ilə təsvir edilən bir xəstəlik epidemiya şəklində görünür. Yaponiya, Birma, Sibir, Filippin, Madaqaskar və Konqoda başqa adlarla da tanınır. Xəstəlik yaşlı qadınlarda müşahidə olunur.

Bu, qorxu tutması ilə başlayır və tez-tez xəstənin zəhərli bir hörümçəyə basdığı təxəyyülü ilə müşayiət olunur. Əvvəlcə xəstələr öz sözlərini və bütöv ifadələri dayanmadan təkrarlayırlar, sonra müəyyən bir sosial statusa malik insanların sözlərini təkrarlayırlar (exolaliya). Xəstəliyin sonrakı dövrlərində onlar başqalarının hərəkətlərini təqlid edirlər (exopraksiya) və bəzən ətraflarındakıların hərəkətlərinin əksinə olan hərəkətləri təkrarlayırlar. Sonra onlar anlaşılmaz sözləri tələffüz etməyə başlayırlar ki, bu sözlər daha aydın şəkildə ifadə olunduqca vulqar və ya yaltaq səslənir (koprolaliya).

Yuxarıda təsvir edilən Likantropiya (insandan heyvana çevrilən əfsaməvi varlıq) da epidemiya şəklində özünü göstərmişdir.

İsterik simptomların "yoluxuculuğu" davranış modellərimizin ortaya çıxmasına bir qədər işıq salır. Onlar fərdi olaraq deyil, kollektiv olaraq daha asan inkişaf edir. "Biz" "Mən"-i üstələyir. Bu fenomen xüsusilə çətin, yeni vəziyyətlərdə, məsələn, müharibədə, həbs düşərgələrində və s. müşahidə edilə bilər. Bir insanın nümunəsi digərlərinin müəyyən davranış modellərini mənimsəməsinə yol açır. Eyni əsasda, fərdi olaraq rezonans tapmır, müəyyən davranış modelləri kollektiv formada daha asan ortaya çıxır. Oğlanlar, bir qayda olaraq, siqaret çəkməyə, spirtli içki içməyə və qrup halında mastürbasiya etməyə başlayırlar. Elementar aqressiya partlayışlarının izdihamda və s. baş vermə ehtimalı daha yüksəkdir. "Biz" "Mən"-dən daha asan oyanır; bu, "Senatores boni viri, **senatus mala bestia**" tərcümə et atalar sözünü izah edir. /

İSTERİYA VƏ HİPNOZ

Həm duyğu, həm də motor, eləcə də daha yüksək davranış formalarını əhatə edən bütün isterik konversiya simptomları hipnotik transda "təklifin" təsiri altında yarana bilər. Hipnoz edilmiş insan, isterik insan kimi, bədənini müəyyən bir hissəsində həssaslığını itirə bilər və damar spazmı səbəbindən iynə ilə dəşildikdə anesteziya edilmiş ərazidə bir damla qan görünməyə bilər. Onlar əzalarını tərpədə, bədənlərini isterik qövsdəki kimi gərginləşdirə, qıcolmalar yaşaya, uşaq kimi, sevgili kimi, heyvan kimi və s. davranırsa, qeyri-adi bir yaddaşla (hipermneziya) və ya onun tamamilə itirilməsi ilə (amneziya) təəccübləndirə və halüsinasiyalar yaşaya bilərlər.

Bütün bu davranış formaları hipnoz edilmiş şəxsin iradəsindən deyil, yalnız hipnozçunun özündən asılıdır.

Hipnoz edilmiş şəxs hipnozçu tərəfindən idarə olunan avtomat kimi hərəkət edir. İsterik bir insan da oxşar şəkildə davranır; o, özünü tamamilə idarə edə bilmir və bədəninin və ya psixikasının bir hissəsi onun nəzarətindən kənardadır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, xəstə itirilmiş nəzarəti bərpa etməyə nə qədər çox çalışsa, konversiya simptomları bir o qədər şiddətlənir. Xəstə dəfələrlə başa düşür ki, öhdəsindən gələ bilmədiyi bir qüvvə tərəfindən ələ keçirilir. Somatik konversiya hallarında bu digər nəzarətçi, dözülməz ağrı, iflic, obsesif hərəkətlər, hipoesteziya və s. yaradan sirli bir xəstəlikdir. İsterik zehni pozuntularda isə bu digər usta, adətən diqqətlə gizlədilən "ikinci mən", "alter ego"dur. Eynilə, qəzəb və ya başqa bir duyğu ilə məğlub olan bir insan özünə nəzarəti dayandırır; bəzən ona elə gəlir ki, o, özü deyil,

anlaşılmaz, dərinliyindəki bir şey onun davranışını idarə edir.

// Dissosiasiya (ayrılma)

Şarkotun tələbəsi Pyer Canet* — müasir psixopatologiyanın banilərindən biri — isteriyanın əsas mexanizminin ayrılma (qopma), dissosiasiya olduğuna inanırdı. Psixikanın normal olaraq basdırılan və heç bir fəaliyyət formasında özünü göstərə bilməyən bir hissəsi zehni həyatın bütövlüyündən ayrılır, öz muxtariyyətini qazanır və müəyyən zehni və ya fiziki prosesləri müstəqil şəkildə idarə etməyə başlayır. Sonra onlar artıq bütövlükdə psixikaya, onun iradə aktlarına tabe deyil, sadəcə ayrılmış bir hissədir.

İnteqrasiya problemi şizofreniyanın əsas problemidir. Lakin, bunda bu parçalanma isteriyadan daha dərinidir. Xəstə əks hissləri, istəkləri və düşüncələri sintez edə bilmir və nəticədə onların qərarları, yəni iradə hərəkətləri ziddiyyətli olur və hətta reallaşdırılması mümkün deyil. Digər tərəfdən, isteriyada daha böyük bir hissə ayrılır - hansısa vacib münaqişə, xəstənin həll edə bilmədiyi hisslər şəbəkəsi - başqa sözlə, bir kompleks. Bu kompleks somatik və ya zehni pozuntuların mənbəyinə çevrilir, öz muxtariyyətini qazanır, sanki öz planlarına uyğun olaraq prosesləri idarə edir, normal şəraitdə sinir sisteminin inteqrasiya olunmuş fəaliyyətinə tabe olur və "Mən" kimi yaşanır.

* Pyer Kanet (1859-1947), məşhur fransız psixopatoloqu.

// NEYROFİZİOLOJİ bucaqdan baxış sınaqları

Sinir sisteminin funksiyası baxımından isterik konversiya problemi nevrastenik sindromların probleminə zidd görünür. Sonuncuda, signal seçimindəki pozuntu səbəbindən nəzarət olduqca çətindir, məsələn, pis bürokratik sistemdə olduğu kimi, mərkəzi orqanlara çoxlu məlumatın axdığı və oradan çoxlu əmrin çıxdığı kimi. İsterik çevrilmədə, öz qaydaları ilə idarə olunan, qrupların yaradıldığı mənfi bürokratik sistemdə olduğu kimi, bütövlükdən təcrid olunmuş muxtar idarəetmə mərkəzi yaranır.

Psixiatrlar öz fikirlərində haqlıdırlar və avtonom sinir sisteminin pozuntularını çevirmə simptomları arasında sayırlar, çünki bu sistem təbiətinə görə muxtardır. İsterik çevirmə normal şəraitdə maksimum inteqrativ səyinə tabe olan, subyektiv olaraq iradə aktı kimi yaşanan bədən funksiyalarını əhatə edir.

Nevrastenik sindromlarda bədənə inteqrasiya prosesləri pozulur, çünki o,

çoxlu məlumat axınının öhdəsindən gələ bilmir və ya vacib olanı əhəmiyyətsizdən ayıra bilmir.

İsterik çevrilmədə inteqrasiya qorunub saxlanılır, çünki

seçimə məruz qalmalı olan hər şey ayrı, muxtar bir bütöv yaradır və bununla da qalanları inteqrasiya səylərindən azad edir.

// "GÖZƏL Laqeydlik"

Əvvəllər müəlliflər vurğulamışdılar ki, isterik çevirmə olan xəstələr dəfələrlə

"gözəl laqeydlik" ilə xarakterizə olunurlar - tez-tez

dramatik təzahürlərə qarşı təəccüblü bir laqeydlik. Konversiya simptomları xəstədən kənarda özünü göstərir;

bəzən xəstə hətta öz bədəninin belə əzablara məruz qalmasından məmnun görünür. Bu qayda deyil; xəstələr tez-tez ağrılı hisslərini böyük çətinliklə yaşayırlar. Lakin, belə hallarda nevroitik narahatlıq azalır və yalnız xəstəliklə məhdudlaşır. Bu laqeydlik sayəsində əvvəllər xəstənin narahatlıq mənbəyi olan münaqişələr, travmalar və ağır təcrübələr onların şüurunun arxa planına keçir və bəzən hətta bilinçaltına keçir.

// "ABREAKSİYA"

Freyd dövründən bəri konversiyayı müalicə etmək üçün tez-tez istifadə edilən üsullardan biri münaqişə vəziyyətini "həyata keçirmək" metodudur. Hipnotik transda dalğa, rauschda

Narkotik (narkoanaliz) qəbul etdikdən sonra və ya həkimlə söhbət zamanı xəstə nevroitik reaksiyasına səbəb olanı yaşamalıdır. İlk növbədə, bu hallarda dissosiativ faktora çevrilmiş, yəni muxtar integrasiya mərkəzi yaratmış gizli hissləri boşaltmaq lazımdır.

// KONVERSIYA POZULMUŞ İNTEQRASIYANIN SİMPTOMU KİMİ

Bəzi hallarda konversiya simptomları şizofreniya və ya

psixozvi sindromdan əvvəl baş verir. Bu hallarda isterik dissosiasiya integrasiya proseslərində pozulmanın ilk simptomudur.

Həkim üçün bu cür səhvlər diaqnostik narahatlıq mənbəyidir; isterik konversiya beyin şişi olduğu ortaya çıxdıqda, bu, yalnız bir kompromis deyil. Buna baxmayaraq,

bu cür səhvlər

integrasiya funksiyasının pozulmasını təşkil edən müxtəlif xəstəlik sindromları arasında müəyyən oxşarlığı göstərə bilər.

Nizam canlı təbiətin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Ətraf mühitlə enerji mübadiləsi səviyyəsində bu, əsasən avtomatik olaraq baş verir, yəni heç bir xüsusi səy tələb etmir. Lakin, informasiya mübadiləsi səviyyəsində bu səy zəruri hala gəlir, çünki orqanizmə axan informasiya xaosundan vacib olanları seçmək və mümkün fəaliyyət formaları arasından mövcud vəziyyətdə daha uyğun olanları seçmək lazımdır. Bu səyin nə dərəcədə şüurlu olduğunu və canlı orqanizmlərin aşağı formalarında şüurun necə formalaşdığını bilmirik. Yalnız məlumdur ki, insan şüurunun məzmunu əsasən informasiya mübadiləsi ilə bağlıdır və enerji mübadiləsi (anabolik və katabolik proseslər) dolayı yolla olsa da, əhval dəyişikliklərinə, emosional vəziyyətə və şüurun dərəcəsinə təsir göstərə bilər. Lakin, bu, birbaşa şüurlu təcrübələrin məzmununu təşkil etmir.

"İnformasiya mübadiləsi üçün tələb olunan səy uyğun funksional struktur seçmək ehtiyacı ilə bağlıdır. Nəyi atmaq və nəyi saxlamaq barədə qərar verilməlidir. İntegrasiya orqanizmin fəaliyyətinin müxtəlif formalarının inkişafı üçün potensialı azaltmaqla baş verir. Atılan şey tamamilə yox olmur; o, birtəhər yaddaş qeydlərində sabit qalır" və integrasiya prosesi pozulduqda aktivləşdirilə bilər. Beləliklə, yuxu zamanı funksional strukturlar

reallıqda heç vaxt

görünməyəcək yuxular şəklində görünə bilər. İsteriya və ya hipnoz zamanı insanın normal həyatında ehtimal olunmayan, lakin öz daxilində mövcud olan somatik və ya zehni simptomlar görünə bilər. İstifadə olunmamış insan qabiliyyətlərinin

təzahürü problemi şizofreniyada daha da kəskin və tam olur.

İsterik konversiya zamanı integrasiya problemi nisbətən sadə şəkildə həll olunur; insanı əzablandıran və narahatlıq, kin, günahkarlıq və s. mənbəyi olan şey, bütövdən ayrılır və ontogenetik təkamül zamanı atılan funksional strukturları aktivləşdirən muxtar integrasiya mərkəzi yaradır.

HİPOXONDRİK NEVROZ

// XƏSTƏNİN ROLU

Əgər isterik nevroz dəfələrlə xəstənin mühitində pozğunluqlara səbəb olarsa

Dramatik gərginlik tez-tez hipoxondriakal nevrozla müşayiət olursa da, çox vaxt yüngül qəbul edilir, rədd cavabı verən, himayədarlıqla yanaşılır. "Xəyalı əlil" uzun müddətdir ki, ən yaxşı və ən pis zarafatların mövzusu olub.

Sosioloji baxımdan xəstənin vəziyyəti hətta əlverişli də ola bilər.

Xəstə insan bütün sosial məsuliyyətlərdən yayınır və yaxınları onu diqqət və qayğı ilə əhatə edir. Xəstəlik zamanı xəstə uşaqlığa qaytarılır - işləməyə məcbur edilmir, gündəlik narahatlıqlardan və çətin vəziyyətlərdən qorunur, onlara qayğı göstərilir və qayğı göstərilir. Təəccüblü deyil ki, kimsə əsassız olaraq, yəni əslində xəstə olmadan xəstənin mövqeyini qəbul edərsə, bu, ətrafdakılarda narazılıq və etiraz hissləri oyadır.

Məlum olduğu kimi, istehza ən çox istifadə edilən və ən təsirli sosial təcavüz formasıdır. Həkimlər bu hallarda istisna deyil; Şikayətləri ilə onlara əzab verən və heç bir şeyin kömək etmədiyi və hətta çox ətraflı obyektiv müayinə belə heç bir anormallıq aşkar etmədiyi bir xəstə qıcıqlandırıcıdır. Belə bir xəstə həkimin dəyərli vaxtını boşa sərf edir. Şəxsi praktika dövründə hipoxondriya xəstələrinə qarşı mənfi emosional münasibətlər maddi nemətlərlə kompensasiya olunurdu. Bu xəstələr həkimlər və əcazılar üçün qızıl mədən idi.

Həkimlə hipoxondriya xəstələri arasında tipik bir nevrotik qapalı dairə yaranır.

Həkim özünü gücsüz hiss edir, çünki çoxlu vaxt sərf etməsinə baxmayaraq, xəstəliyi anlama bilmirlər və bütün terapevtik tədbirlər təsirsizdir. Xəstə özünü incidir, həkimin onun əzablarını başa düşmədiyinə və inanmaq istəmədiyinə inanır, bu da öz növbəsində ağrıları artırır və həkim getdikcə daha çox yorulur.

// XƏSTƏLİYİN OBYEKTİV VƏ SUBYEKTİV HİSSLƏRİ

Hipoxondriya, xəstəliyin obyektiv və subyektiv anlayışları arasındakı fərq məsələsini kəskin şəkildə ortaya qoyur. Hipoxondriya xəstə hiss edir, amma həkim belə bir xəstəlik görmür. Tibbi praktikada əks vəziyyət də baş verir, burada xəstə özünü sağlam hiss edir, lakin həkim tez-tez çox ciddi bir xəstəlik tapır (məsələn, vərəm, xərçəngin erkən mərhələləri, hipertoniya, ateroskleroz və s.).

Hipoxondriya xəyalı deyil; O, həqiqətən xəstədir. Baş və ürək ağrıları yaranır, qarın spazmları və əzələ ağrıları dözülməz olur, sümüklər və oynaq da reaksiya verir, barmaqlar və ayaq barmaqları keyiyir, ağrılar bir yerdən digərinə keçir. Baş ağrıları dayandıqda ürək ağrısına başlayır və s. Ağrı xəstənin diqqətini ətraf mühətdən öz bədənə yönəldir və bu, onların zehni təcrübələrinin mənbəyinə çevrilir.

Zehni təcrübələrin iyerarxiyasında ağrı mərkəzi yer tutur, yəni o, oyaq və yuxu vəziyyətindəki digər problemləri sıxışdırır. Dış ağrısı gözəl erotik xəyalları, bədii fantaziyaları, elmi düşüncələri və s. şüurdan sıxışdırır bilər. Yalnız böyük intensivlikdəki təcrübələr ağrını şüurdan sıxışdırır bilər. Döyüşün qızğın çağında olan əsgər ağır yarasını hiss etməyə bilər və cinsi ekstazda olan qız partlamış qızlıq pərdəsinin yaratdığı ağrını hiss etmir.

Buna görə də, hipoxondriakın bütün fikirlərini cəmləşdirməsi təəccüblü deyil.

Öz bədənini; axı, keyiməsi ona bu qədər ağır təcrübələr verir. Baxışları ətrafındakı dünyadan üz çevirir və içəri yönəlir. Bəs xəstənin əzablarını yüngülləşdirməyə çalışması təəccüblüdürmü? O, həkimlərə və bahalı dərmanlara pul xərcləmir, gündəlik həyatın depresif bir hissəsinə çevrilən müxtəlif məhdudiyyətlər tətbiq edir - hamısı sadəcə zəifləyən sağlamlığını bərpa etmək üçün.

İpoxondriyanın əsas simptomları xəstəlik və ağır hissidir.

İpoxondriyanın özünü pis hiss etməsi və həkimlərin zəmanətləri və

mənfi laboratoriya testlərinin az kömək etməsi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yaxşı

rifah həmişə obyektiv sağlamlıqla, yəni həqiqətən yaxşı ümumi vəziyyətin obyektiv təsdiqi ilə əl-ələ getmir. Obyektiv xəstə olan insan özünü sağlam hiss edə bilər və əksinə. Yaxşı sağlamlıq yalnız insanın daxili orqanlarının düzgün işləməsindən deyil, həm də bütün bədən düzgün işləməsindən asılıdır. Bu o deməkdir ki, insan haqqında danışarkən, onun rifahı eyni dərəcədə orqanlarının yaxşı işləməsindən, həyatdakı uğurlarından və ümumi rifahından, insanlarla təmasdan və ətrafındakı hər şeylə emosional əlaqələrdən asılıdır.

İnsan qan dövranı və ya həzm sistemi pozğunluğu və s. səbəbindən özünü pis hiss edə bilər, eyni zamanda işdəki problemlər, erotik həyatındakı uğursuzluqlar və ya sevilən birinin itkisi səbəbindən də özünü pis hiss edə bilər. Müəyyən bir dərstdən qorxan uşaq səhər özünü pis hiss edir və bu halda onu pis niyyətli adlandırmaq olmaz.

Uğursuzluq qorxusu sağlamlığın pisləşməsinə səbəb olur. Bu nümunə sağlamlığın pisləşməsinə təsir edən iki əsas amili göstərir: müxtəlif növ vegetativ pozğunluqlara səbəb ola bilən mənfi emosional vəziyyət (sınıf qorxusu) və onu sosial məsuliyyətlərdən azad edən xəstə insan rolunu mənimsəməyin məqsəduyğunluğu.

// SOMA VƏ PSİXE

İnsan özünü dualist şəkildə yaşayır: soma (bədən) və psixika kimi. Bədən müəyyən dərəcədə ətrafdakı təbiətin bir hissəsidir; O, idarə olunmalı olan, xəyalların və planların gerçəkləşməsinə mane olan və sevinc və kədər mənbəyi ola bilən bir obyekt kimi qəbul edilir. Digər tərəfdən, hisslər, düşüncələr, xəyallar, iradə hərəkətləri və s. subyektiv olaraq "mən" in bir hissəsi kimi qəbul edilir. İnformasiya mübadiləsinin təbiətindən irəli gələn zehni təcrübələrin fəvqəladə dəyişkənliyinə baxmayaraq - yeni stimullar əsasən mənimsənilir, köhnə stimullar isə ümumiyyətlə atılır - subyektiv "Mən" ətrafımızdakı və içimizdəki hər şey üçün müəyyən dərəcədə əbədi və ya daha dəqiq desək, zamansız bir şey kimi qəbul edilir, yalnız "Mən" isə bütün dünya ilə əlaqənin mərkəzi nöqtəsi olaraq dəyişməz qalır. Subyektiv olaraq, dünya "Mən" mövcud olduğu müddətcə mövcuddur. Bu mənada o, ölməzdir. Həyat prosesi ilə əlaqəli fundamental təcrübə hesab edilə bilən öz "mən" hissi, enerjili və informasiya mübadiləsinin təbiətindən qaynaqlanan sabit dəyişkənliyi ilə müqayisədə və orqanizmin integrativ qabiliyyətlərinin subyektiv əks olunmasıdır, görünür, soma və psixikanın ikili bölünməsinin başlanğıc nöqtəsidir.

Bu bölünmənin süniliyi təcrübələri zehni və somatik olaraq təsnif etməyə çalışarkən ortaya çıxır. Hər bir təcrübə mahiyyət etibarilə zehnidir, çünki həyat prosesinin subyektiv hissini əks etdirir.

Xoş bir hiss, nə olmasından asılı olmayaraq, zehni təcrübə növünə aiddir.

Bu, qıdıqlama və ya sənət əsərlərini araşdırmaqla yaranmışdır. Eyni şey fiziki və ya zehni ağrıdan qaynaqlanan əzablara da aiddir.

İnsan təcrübələrini nə qədər uzaqda yerləşməsindən asılı olaraq zehni və duyğu və ya bədənə bölür: obyektə (bədənə) və ya subyektə ("Mən") daha yaxın. Dış ağrısı bədəndəki müəyyən bir yerlə əlaqələndirilir; bu ağrılı nöqtə çıxarıla və ya anesteziya edilə bilər və sonra ağrı azalacaq. Dış mahiyyət etibarilə bir obyektədir,

çünki onun üzərində edilən bütün əməliyyatlar dərhal xoş (ağrı azaldıqda) və ya xoşagəlməz (ağrı gücləndikdə) hisslərlə siqnal verilir,

bu hisslər başqa bir şəxsə məxsus xəstə dış, süni dış və ya artıq anesteziya edilmiş dış, yəni mərkəzi sinir sistemi ilə siqnal əlaqəsi kəsilmiş dış halında yoxdur. Dış bir obyektədir, amma çox "mənim"dir; üzərindəki bütün manipulyasiyalar fəvqəladə canlılıqla hiss olunur. Sinir yolları zədələndikdə o, yad bir obyektə çevrilir. Sərt bədən hissi, məsələn, siyatik sinirin sıxılması və nəticədə mərkəzi sinir sistemi ilə siqnal kəsilməsi səbəbindən hissiyyətini itirən ayaq da oxşar şəkildə qəbul edilir. Bu, insanın öz bədənini hiss etməsi üçün zəruridir; bu siqnal əlaqəsinin pozulması insanın öz bədənindən yadlaşma hissəsinə səbəb olur.

Bədənin daxili orqanları xarici hissələrinə nisbətən daha az "obyektəbənzərdir". Onlar manipulyasiya üçün əlçatmazdır və buna görə də bir obyektin əsas xüsusiyyətlərinə malik deyillər. Onlarla mübarizə aparmaq, dəyişdirmək, toxunmaq və ya hərəkət etdirmək olmaz. Bundan əlavə, bədənin daxili mənzərəsi, xarici mənzərəsi ilə müqayisədə, reseptorlardakı fərqlərdən təsirlənən qeyri-müəyyən və qeyri-müəyyəndir (eksteroreseptorlar bədənin səthindən, interoreseptorlar isə daxildən siqnallar alır). Bədənin dərinliyi səthindən daha çox "mən"imizə daha yaxındır.

Zehni təcrübələrin müxtəlif bədən orqanlarında (ürək, qaraciyər, dalaq, beyin və s.) hamı tərəfindən qəbul edilmiş lokalizasiyası bu yaxınlığı göstərir.

Bədənin dərinliyinin, xarici səthi ilə müqayisədə, eksterosepsiya və manipulyasiya üçün əlçatan olan aşağı dərəcədə obyektivliyi, hisslərin daxildən qaynaqlandığı hallarda, təcrübələrin zehni və somatik bölünməsinin bulanıqlaşmasına gətirib çıxarır (interosepsiya). Depressiyaya düşmüş insan özünü fiziki cəhətdən xəstə, yorğun, zəif hiss edir və müxtəlif daxili orqanlardan dəfələrlə ağrı hiss edir.

Əksinə, yaxşı əhval-ruhiyyədə olduqda, obyektiv vəziyyəti pozulsa belə, adətən özlərini şən hiss edirlər. Depressiyalar tez-tez zəif fiziki sağlamlıq və müxtəlif növ hipoxondriakal şikayətlərlə başlayır.

Xüsusilə fiziki əməklə məşğul olan insanlarda depressiya hipoxondriak sindromu kimi özünü göstərə bilər. Sözdə ibtidai xalqlar arasında işləyən psixiatrlar, xəstələrinin depressiyasının ən çox məhz bu simptomlarla başladığına xüsusi diqqət yetirirlər. Fiziki əməklə məşğul olan insanların yaxşı fiziki vəziyyəti bədənin düzgün işləməsini təsdiqləyir və buna görə də aşağı əhval-ruhiyyənin və ümumi zəifləmənin ilk növbədə onların fiziki rifahına təsir etməsi təəccüblü deyil. Zehni əməklə məşğul olan insanlarda əhval-ruhiyyənin aşağı olması onların zehni funksiyalarına mənfi təsir göstərir və yaddaşın zəifliyi, diqqətin cəmlənməməsi, məntiqi düşüncə bilməməsi, yorğunluq və təşəbbüskarlığın olmaması kimi şikayətlərə səbəb olur. Yuxarıdakı müşahidələr qayda deyil; depressiyası məhz hipoxondriakal formada özünü göstərən ziyalılar, eləcə də təhsilsiz insanlar var.

Dərin əhval-ruhiyyə depressiyasına baxmayaraq, hipoxondriakal şikayətləri olmayanlar. Depressiya insan üçün ən dəyərli olanı yaralayır. Məsələn, güclü ədalət və əxlaq hissi olan bir insanda depressiya günahkarlıq hisslərinə və günah xəyallarına səbəb ola bilər. İpoxondriakal sindrom belə hallarda təsirlənmiş şəxsin öz bədəninin imicinin nevroz problemi olduğunun göstəricisi ola bilər.

Xəstənin həyat tarixində narsizmin izləri öz bədənini ilə şişirdilmiş əlaqə şəklində tapıla bilər. Bu hisslər müsbət və ya mənfi ola bilər. İnsanın öz bədənini sevmə, qurur, özünəinam və ya alçaldılma, narazılıq və acılıq mənbəyi ola bilər. Bədən insanın məhv etmək istədiyi bir maneə ola bilər və ya həyatın əsas məqsədi və mənası ola bilər.

Lakin, digər tərəfdən, hansısa patoloji prosesin bədənini daxili orqanlarına vurduğu ziyan ümumi vəziyyətə təsir edir; xəstə insan özünü zəif, yorğun və depressiyada hiss edir. Bəzən hipoxondriakal simptomların konqlomeratı somatik xəstəliyin yeganə əlamətidir və yalnız sonradan fiziki və ya laboratoriya müayinəsi ilə aşkar edilə bilən dəyişikliklər ortaya çıxır. Uzun müddətdir hipoxondriak hesab edilən xəstə həkimlərin nəzərində reabilitasiya olunur, lakin onların öz diaqnostik qabiliyyətlərinə olan inamları zəifləyir. Həmçinin, fiziki xəstənin xəstənin rifahına heç bir təsiri olmadığı da olur. Onlar özlərini sağlam hiss edirlər və yalnız hərtərəfli tibbi müayinə xəstəliyi aşkar edir. Yaxşı və ya pis sağlamlıq obyektiv somatik vəziyyət həmişə həlledici rol oynamayan müxtəlif amillərin mürəkkəb dəsti baxımından nəzərdən keçirilməlidir. Həkim kimin xəstə, kimin sağlam olduğunu müəyyən etmək kimi çətin bir vəzifə ilə qarşılaşa bilər. Özünü yaxşı hiss edən, lakin obyektiv müayinə əks nəticələr verən və ya obyektiv olaraq sağlam olan, lakin rifahı

arzuolunan dərəcədə yüksək olan biri.

HİPOXONDRİK NEVROZ // BƏDƏN TƏSVİRİ

Bədənini özünü təsəvvürü ətraf aləmin təsvirindən fərqli bir əsasda qurulur.

Əsas informasiya kanalları — görmə və eşitmə — onun qurulmasında əhəmiyyətsiz rol oynayır. Bədənini yalnız bir hissəsi — bədənini ön hissəsi və ətraflar — birbaşa müayinə edilə bilər, lakin insan üzünü kimi vacib bir hissə görünür. İnsan öz səsinə yalnız sümük keçiriciliyi vasitəsilə eşidir və nəticədə başqalarının qəbul etdiyindən (bir az daha yüksək) fərqli bir ton yaranır. Güzgüdə əks olunan üz adətən başqalarının gördüyü üz deyil, çünki hər kəs güzgü qarşısında üz ifadələri vasitəsilə şüuraltı olaraq ifadəsini dəyişir. İnsan özünə təəccüblə film çərçivəsinə baxır, adi bir fotosəkildən daha az öyrəşib. Digər hissələrin qavranılması da dəyişir. Öz bədənini qoxusu digər insanların və ətrafdakı əşyaların qoxusundan xeyli zəif qəbul edilir və ya ümumiyyətlə qəbul edilmir. Xoşagəlməz bədən qoxusu hissi çox vaxt ciddi ruhi pozğunluqları (məsələn, şizofreniya) göstərir və halüsinasiya hesab olunur. İnsanın öz bədənini toxunma hissi yad bir əşyaya toxunma hissindən fərqlidir, çünki insan öz bədənini toxunduqda iki hissə yaranır: əşyaya toxunan və toxunulan (bədən öyrənilən bir əşyaya çevrilir). Digər tərəfdən, ətrafdakı əşyalar sadəcə cansız əşyalar olaraq qalır. İnsan zehniində bu qədər inkişaf etmiş səbəb və nəticənin yaxın ardıcılığının ilk rudimentinin məhz öz bədənini toxunmağın tədqiqat aspekti olması mümkündür ki, bu da tez-tez kiçik uşaqlarda müşahidə olunur. Məhz bu aspektdə insanın öz hərəkəti həmin hərəkətin nəticəsi ilə sıx bağlıdır.

Tədqiqat; səbəb və nəticə eyni şəxs tərəfindən eyni vaxtda qəbul edilir.

Beləliklə, hətta bədənimizin səthinin təsviri belə, onu eksteroreseptorlar vasitəsilə ətraf aləm kimi qəbul etməyimizə baxmayaraq, xarici mühitdən fərqli olaraq qiymətləndirilir. Bədənimizin təsviri parçalanmış və qeyri-müəyyəndir.

Bədənimizin daxili quruluşu haqqında nə deyə bilərik? Burada sual daha da çətin görünür. Xarici mühitdən gələn siqnallardan daha böyük bir axın mərkəzi sinir sisteminə çatsa da, bu siqnallar şüurumuzda əks olunmur. Daxili orqanlarımızın təsviri qeyri-müəyyən və anlaşılmaz olaraq qalır. Hətta həkimlər kimi bədənin quruluşunu dərinlən başa düşən insanlar üçün belə, öz bədənləri sirr olaraq qalır və onlar buna sırf şəxsi, tibbi olmayan bir perspektivdən baxırlar. İpoxondriakal sindromlar həkimlərdə insan bədəninin həm quruluşundan, həm də funksiyasından xəbərsiz insanlara nisbətən eyni şəkildə, çox vaxt daha dramatik şəkildə özünü göstərir.

// NEYROFİZİOLOJİ QEYDLƏR

Histoloji tədqiqatlara əsasən, yüksək ehtimalla fərz etmək olar ki, bədəndə sinir sistemi ilə əlaqəli olmayan heç bir hüceyrə yoxdur. Sinir lifi, görünür, bədəndəki hər bir hüceyrənin nüvəsinə çatır. Beləliklə, bədənin tənzimləyici sistemi milyardlarla hüceyrəli cəmiyyətin bütün vahidlərinin tənzimləyici sistemləri (hüceyrə nüvələri) ilə daim təmasdadır.

Bu cəmiyyətdə nizamın qorunmasının qeyri-adi dərəcədə mürəkkəb prosesi, istehsal etdiyi funksiyalar baxımından bu qədər fərqlənir, sinir sisteminin, daha dəqiq desək, avtonom və ya vegetativ sistemin vəziyyəti ilə müəyyən edilir.

Endokrin sistem ikinci dərəcəli rol oynayır. Endokrin vəzi tərəfindən ifraz olunan kimyəvi birləşmə şəklində göndərilən signal bədənin bütün toxumalarına çatır, lakin yalnız bəziləri onu qavraya və cavab verə bilər.

Bu signal hamıya ümumi bir çağırış kimi qəbul edilə bilər ki, ona yalnız bir neçə nəfər cavab verə bilər. Wiener özünütənzimləmə sistemlərindəki bu tip signalı "kimlərə aid ola bilər" başlığı ilə yazılmış hərflərlə müqayisə edir. Digər tərəfdən, sinir sistemi tərəfindən göndərilən siqnallar daha seçicidir və bu halda ünvan alan şəxs dəqiq bilinə bilər. İki sistem funksional olaraq bir-biri ilə sıx bağlıdır və sinir sistemi endokrin sistemə münasibətdə aparıcı mövqe tutur.

Əlaqə bütün özünütənzimləmə sistemlərinin əsasını təşkil edir; Gedən siqnallarla yanaşı, məqsədi xarici mühitə göndərilən siqnallar, onların qəbulu və cavabı haqqında məlumat vermək olan daxil olan siqnallar da mövcuddur.

Mərkəzi sinir sistemi yalnız bədənin milyardlarla hüceyrəli mühitinə signal göndərmir, həm də ondan daim siqnallar alır. Bu siqnallar sayəsində o, tabeliyində olan hüceyrə icmasında baş verən hər şeylə daim "təmasdadır"; o, əməllərinin necə yerinə yetirildiyini bilir. Bu geniş hüceyrə icmasını idarə etmək çox mürəkkəb bir funksiyadır, bütün orqanizmi xarici mühitlə əlaqəli idarə etməkdən daha mürəkkəbdir, yəni ondan siqnallar almaq və xarici mühitə siqnallar göndərməkdən daha mürəkkəbdir, əsasən nitq (somatik və ya iradi sistem). Beyin qabığı həm somatik, həm də vegetativ sistemlərin fəaliyyətini tənzimləyir. Vegetativ funksiyalardan danışırıqsa, onlar xüsusilə beyin qabığının ən qədim və ən gənc nəhiyələrində, yəni qoxu beyində (visseral beyin) və

Sözdə prefrontal korteks (frontal payların motor sahəsindən öndə yerləşən hissəsi).

Neyrofizioloji tədqiqatlar prefrontal korteksin daxili orqanlar üçün proyeksiya rolunu göstərir; o, vissero-reseptorlardan (daxili orqanların reseptorları) siqnallar alır. Daxili orqanlardan prefrontal korteksə siqnalların axını onların düzgün funksiyasını qorumaq üçün əhəmiyyətsiz görünür. Lobotomiya zamanı baş verdiyi kimi, hipotalamusu prefrontal korteksə bağlayan liflərin və nəticədə bütün proyeksiyalarda olduğu kimi, siqnal axını reseptordan proyeksiya sahəsinə və proyeksiya sahəsindən reseptora iki istiqamətli olan vissero-reseptor proyeksiyasının liflərinin kəsilməsi daxili orqanların fəaliyyətində görünən pozuntulara səbəb olmur. Buna görə də, vissero funksiyalarının kortikal analizatoru somatik funksiyaların kortikal analizatorları ilə eyni rol oynamır. Eksteroreseptorlar və proprioreseptorlar (hərəkət orqanlarının reseptorları - əzələlər, vətərlər və tarazlıq orqanı) üçün kortikal proyeksiya sahələrinin məhv edilməsinin çox ağır pozğunluqlara, insanlarda isə verilən hiss orqanının funksiyasının tamamilə itirilməsinə səbəb olduğu məlumdur. Daxili orqan funksiyalarının idarə olunmasının prefrontal korteksin integrasiyasını tələb etmədiyini güman etmək olar; burada refleks qövsü daha qısadır, onun ən yüksək mərkəzi hipotalamusda və qoxu beyində yerləşir və hipotalamus-beyin qabığı seqmenti bir növ əlavə təşkil edir və bunsuz daxili orqanların tənzimlənməsi pozulmadan davam edə bilər. Bədənin içərisindən siqnallar beyin qabığına axsa da, onlar şüura nüfuz etmir, ən azından bədənin səthindən və xarici mühitdən gələn siqnallar kimi deyil. Daxili orqanlardan gələn hisslər qeyri-müəyyəndir və insan bir şeyin harada və nə vaxt baş verdiyini dəqiq bilmir və buna görə də bu orqanların fəaliyyətini tənzimləyə bilmir. Bədəndə baş verən proseslərin fərqiində olmaq, ağrı paroksizmlərindən tutmuş lüks paroksizmlərinə qədər intensivliyi dəyişən qeyri-müəyyən xoş və ya xoşagəlməz hisslərlə məhdudlaşır. Bu hisslərin lokalizasiyası adətən qeyri-müəyyəndir. Hindu yoqlarının etdiyi kimi, müvafiq məşqlər vasitəsilə avtonom funksiyalar üzərində daha çox nəzarətə nail olmaq mümkündür, lakin orta statistik insan iradə hərəkəti ilə ürək döyüntüsünə, bağırsağ hərəkətlərinə, bazal metabolik sürətə və s. təsir göstərə bilmir. Müvafiq dərin hipnotik transda hipnoz edilmiş şəxsin avtonom funksiyalarının bəzilərini idarə etmək mümkündür. Bu halda, normal olaraq idarə oluna bilən şeylərə nəzarət hipnozçuya keçir. Bu istisnalar bədənin daxili orqanlarının şüurlu iradə hərəkətlərinə tabe ola biləcəyini göstərir, lakin normalda avtonom funksiyalarla bağlı bütün qərarlar şüurumuzdan kənarda qəbul edilir. Avtonom sistem müstəqil olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirir. Bu, onun muxtariyyətidir. Bütün avtomatik funksiyalarda olduğu kimi, şüurun müdaxiləsi hətta düzgün nəzarət prosesini də pozur. Vegetativ pozğunluqların müalicəsində xəstənin artıq onlara diqqət yetirmədiyi bir vəziyyətə nail olmaq lazımdır. Məlumdur ki, xəstə ürək döyüntüsünü sakitləşdirməyə və ya normal ereksiya nail olmağa nə qədər çox çalışsa, bu funksiya bir o qədər pis olacaq. Oxşar vəziyyət avtomatik funksiyalarla da baş verir; onlara diqqət yetirmək onların fəaliyyətini pozur (birdən "Baxın, təkəriniz necə fırlanır" deyilən velosipedçi adətən tarazlığını itirir, çünki o, uzun müddətdir avtomatik olaraq yerinə yetirdiyi bir fəaliyyətə diqqət yetirir). Avtomatik fəaliyyətdən (gəzmək, danışmaq, yazmaq və s.) fərqli olaraq,

Vegetativ proseslər bir vaxtlar şüurun mərkəzində olub və nəzarət etmək üçün böyük səy tələb edirdisə, vegetativ proseslər həmişə nəzarətsiz olmaq mənasında şüurdan kənarda olub. Xoş və ya xoşagəlməz hisslər, müxtəlif çarələrində, daxili orqanların idarə olunması ilə əlaqəli müvafiq mürəkkəb funksiyaların subyektiv göstəriciləri ola bilər.

Roland çatı beyin qabığını ön və arxa hissələrə bölür. Arxa hissə

dad və qoxu siqnalları istisna olmaqla, xarici mühitdən siqnalları qəbul edir və emal edir, bu siqnallar qoxu beyninə çatır.

Ön hissə bədən daxilindən siqnallar alır. Roland çatının yaxınlığında motor aparatından (propriosepsiya) siqnallar sözdə motor sahələrinə çatır və hərəkət nəzarəti üçün geribildirim təmin edir; onlar hərəkət planının həyata keçirilməsini məlumatlandırırlar. Daxili orqanlardan (visceroception) siqnallar frontal payların ("prefrontal korteks") ön hissələrinə nüfuz edir. Bu siqnallar, görünür, orqanizmin daxili ehtiyacları haqqında məlumat verməklə ətraf mühitdəki davranışını müəyyən edir. Buna görə də davranış modelinin (motor siqnalının) inkişafı bədən daxilili orqanlarından və ətraf mühitdən axan məlumatların toqquşmasının nəticəsi olardı.

Beyin qabığının ön və arxa hissələrə (korteks pre-rolandika, korteks post-rolandika) bölünməsi də gələcəyə aid ön hissə, arxa hissə isə keçmişə aid hissə kimi təmsil oluna bilər. Ön qabıq hərəkət planı hazırlamaqdan məsuldur, arxa qabıq isə ən azı müəyyən dərəcədə öz hərəkətləri ilə müəyyən edilən ətraf mühit planı hazırlayır. Ətraf aləmin mənzərəsi hərəkətlərimizdən asılı olaraq dəyişir.

// QARŞILAŞMA ÜÇÜN ŞÜUR HƏDDİNDƏKİ DALĞALANMALAR

Yuxarıdakı neyrofizioloji mülahizələr müəyyən dərəcədə hipokondriakal sindromların genezisinin başa düşülməsini asanlaşdırır bilər. Onlar ən çox fəaliyyət planı təşkil etmək qabiliyyətinin məhdud olduğu vəziyyətlərdə ortaya çıxır. Nevrozda bu məhdudiyyət iki meyl arasındakı münasibətdən irəli gəlir. Qərar verə bilməmək insanın öz bədənində diqqət yetirməsinə gətirib çıxarır. Normalda şüurun astanasından aşağıda fəaliyyət göstərən interosepsiya bu həddi keçir. Fəaliyyət planı yoxdur və buna görə də dayaq nöqtəsi yoxdur. Davranış nümunələrinin formalaşmasına avtomatik təsirdən azad olan fəaliyyət,

şüurlu bir təcrübəyə çevrilir. Baş ağrısı və ya mədə ağrısı olan uşaq

məktəbə getməzdən əvvəl iki əks seçimlə qarşılaşır:

məktəb qorxusunun öhdəsindən gəlməyi tələb edən bir vəzifəni yerinə yetirmək və çətin vəziyyətdən qaçmaq. Qərar verə bilməmək, nəzarət sisteminin gələcək sektorunda bir növ boşluq yaradır. Bu boşluq interosepsiya ilə doldurulur.

Müxtəlif növ hipoxondriakal şikayətlər interoreseptorların şüurlu qavranılması halında ortaya çıxan imkanları göstərir. Həqiqətən də,

bədən daxilindən gələn çox sayda siqnalın şüura çatmaması diqqətəlayiqdir. Əks təqdirdə, insan bədənindən gələn hisslərin xaosu ilə boğulacaq.

Ətraf mühitlə siqnal mübadiləsi sürəti azaldıqda, daxili siqnalların axını şüura daha asan nüfuz edir. Məlumdur ki, ağrı gecələr daha şiddətlidir; gecə xəstə üçün həmişə daha çətinidir. Əksinə, xarici mühitdən siqnalların intensiv qəbulu mövcud qarşılıqlı əlaqəni şüurdan kənaraşdırır. Dış ağrısı azalır

Maraqlı bir performans.

Yuxu zamanı xarici siqnallardan ayrılma olur. Bəzi müəlliflərə görə, eksterosepsiya interosepsiyaya keçir. Lakin, yuxulardakı interoseptiv siqnallar

bədənə daxilində deyil, ətraf aləmdə baş verən səhnələrə çevrilir. Nümunələrə kabuslar və ya gecə cinsi oyanış zamanı erotik məzmunlu yuxular daxildir. Hətta xəstəlik zamanı belə yuxular ətraf mühitin faktları ilə bağlıdır. Psixikamız daxili siqnalları qəbul etməyə uyğunlaşmayıb; hətta gözlərimiz yuxu zamanı xaricə çevrilir.

Buna görə də daxili siqnalların şüura nüfuz etməsi

müstəsna bir vəziyyət hesab edilməlidir. Bu, həyatın

bədənə öz avtomatizmlərinin

şüurun iştirakı olmadan

vegetativ funksiyaların tənzimlənməsi ilə öhdəsindən gələ bilmədiyi

anlarda baş verə bilər. Daha sonra, şüura nüfuz edən daxili siqnallar

diqqəti bədənə ehtiyaclarına yönəldir, insanı

ətraf mühit fəaliyyətini azaltmağa və xəstə rolunu qəbul etməyə məcbur edir ki, bu da müəyyən dərəcədə ətrafdakılardan qayğı axtaran uşağın roluna yaxındır. Texniki müqayisədən istifadə edərək, bu vəziyyətin avtomatik pilotun canlı pilot tələb edən qırmızı siqnal verdiyi vəziyyətə bənzədiyi demək olar. Nevrozlarda, xəstəliyin əsas simptomlarından birini təşkil edən vegetativ sistemin pozğunluqları, bir qayda olaraq, bədənə öz avtomatizmləri daxilində tənzimlənməyə təbə olmayan eyni sistemin disfunksiyasını təmsil edir. Xroniki təcili vəziyyət yaranır və şüurlu yardım tələb edir. Hər bir nevrozun daha çox və ya daha az hipokondriakal komponenti var.

// XƏSTƏLİYİN ÜSTÜNLÜKLÜ ASPEKTLƏRİ

Xəstənin rolu bəzi perspektivlərdən sosial cəhətdən faydalı hesab edilə bilər, çünki o,

xəstəni bir çox sosial, çox vaxt çətin olan məsuliyyətlərdən azad edir və ətrafındakıların

münasibətlərini dəyişdirməsini və onlara diqqət yetirməsini tələb edir; Çox vaxt xəstəyə qarşı laqeyd və çox vaxt hətta pis niyyətli münasibət daha yaxşıya doğru dəyişikliyə - xəstəyə rəğbətə və yardıma gətirib çıxarır. Nevrozun sözdə "məqsədəyönlülüyü" məhz xəstənin rolunu qəbul etməkdən irəli gələn faydalardan ibarətdir. Ailə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması, çətin sosial məsuliyyətlərdən məharətlə uzaqlaşmaq, daha rahat həyat tərzini və s. kimi faydalar bilinçaltı şəkildə əldə edilir, yəni bu hallarda xəstəlik xəyali deyil, realdır. Nevroz yalan danışmaqla qarışdırılmamalıdır.

Xəstə nadir hallarda nevrozundan bir şey qazandığını anlayır. Və bu barədə düşüncələr belə, tez unudurlar, çünki nevroitik hisslər o qədər xoşagəlməzdir ki, xəstəliyinin faydalarını qəbul etmək çətindir.

Bundan əlavə, başqalarının güman edilən xəstəliyi ilə bağlı incidici şərtləri onların öz xəstə vəziyyətləri barədə məlumatlılığını daha da artırır, başqalarına qarşı kin və təcavüz hisslərini artırır, mənfi emosional reaksiyalar isə vegetativ sinir sistemində daha çox disfunksiyaya səbəb olur. Tipik bir nevroitik qapalı dairə yaranır ki, bu da xəstənin davranışını dəyişdirmək üçün edilən hər hansı bir cəhdin nevroitik təzahürləri artırdığı deməkdir. Hücuma məruz qalan və saxtalaşdırmaqda ittiham olunan xəstə xəstəliyini öz simptomları ilə daha da inadkarlıqla müdafiə edir. Bu simptomlar xəstəliyinin sübutu kimi qəbul edilir və ətrafdakılar onları inamsızlıqları ilə incidirlər.

Bəzən hipoxondriakal nevrozlar qeyri-adi dərəcədə davamlı olur. Xəstələr illərlə işləmədən, evdən çıxmadan və hətta yataqdan qalxmadan yaşayırlar. Polşada bu tip nevroz kənd əhalisi arasında geniş yayılmışdır, buna görə də "rusticana nevrozu" adlandırılır. Belə hallarda nevrozun davamlılığı xəstənin özünəməxsus rolu ilə asanlaşdırılır. Mövcud xəstəliyin olması faktı xəstəni dəfələrlə həyatı təhlükə yaradan bir fəlakətin baş verməsindən qoruyur, məsələn, universitetdə uğursuzluq hallarında, kəndlərinə qayıtmalı olduqları zaman, qocalıq hallarında və s. Bəzən xəstənin mövqeyini qəbul edərək, xəstə bilinçaltı olaraq yaxınlarından - valideynlərindən və ya həyat yoldaşlarından qisas alır. "Mənə qarşı amansız idin, indi əzab çəkdiyimə baxın."

Həmçinin, nisbətən yüngül fiziki xəstəlikdən, qripdən və ya yüngül baş zədəsindən sonra hipoxondriakal nevrozun qəfildən ortaya çıxdığı hallar da var. Belə hallarda somatik xəstəlik təhrikəedici amil (sözdə "tetikləyici reaksiya") rolunu oynayır. Emosional vəziyyət bir müddətdir ki, gərginləşirdi, insan hazırkı vəziyyətini qorumaq üçün mübarizə aparırdı və xəstəlik onu yeni bir vəziyyətə (xəstə insanın rolu) saldı ki, bütün funksiyalar o qədər zəifləmişdi ki, köhnə qaydaya qayıtmaq mümkün olmadı. Yuxarıda qeyd olunan münaqişələr əlavə edildikdə (məsələn, xəstə qəza və ya xəstəlik səbəbindən pensiya almağa çalışdıqda) vəziyyət xeyli pisləşir.

// HIPOXONDRİK SİNDROMLARININ GENESİSİNDƏ BƏDƏN TƏSVİRİ POZUNTULARININ ROLU

Bədən təsviri hipoxondriakal sindromların genezisində mühüm elementə çevrilir. Bu problemə bir neçə baxımdan baxmaq olar.

Neyrofizioloji baxımdan, insanın özünü təsviri və ya sxemi xarici mühitlə zaman-məkan münasibətlərinin qurulduğu əsas strukturu təşkil edir. Sinir sisteminə daxil olan və çıxan siqnalların sıralanmasının əsasını təşkil edir. Öz imicindəki pozğunluqlar ən çox tabe yarımkürənin (yəni, sağ əlli fərdlərdə sağ yarımkürənin, parietotemporo-okspital qovşağında) zədələnməsi ilə baş verir.

Psixoloji baxımdan, öz imici, insanın cinsiyyətinin müəyyən edilməsi ilə yanaşı, insanın öz imicinin yaradılmasında həlledici rol oynayır ki, bu da öz növbəsində insanın öz fərdiliyi və mənası hissi ilə əlaqələndirilir.

İpoxondriyalı insanlar tez-tez öz imiclərinin formalaşmasında pozğunluqlar nümayiş etdirirlər, əksər hallarda müsbət və ya mənfi narsistik maraq şəklində. Bunlara uşaqlıqdan sağlamlığının zəif olması və ya daha çox həddindən artıq qoruyucu valideynlər tərəfindən aşılana xəstəliklər səbəbindən bədənlərinə xüsusi diqqət yetirən xəstələr daxildir. Bu xəstələrin həmçinin gözəlliyi və ya incəliyi səbəbindən bədənlərinin daim qürur və artan maraq mənbəyi olduğu bir bədəni var. Başqa bir qrup bədən imicindəki pozğunluqlar cinsiyyətləri ilə bağlı şübhələrlə əlaqəli olan xəstələrdən ibarətdir. Bu tip hipoxondriya sindromu yetkinlik və menopoz dövründə baş verir və əsasən kişi və ya qadın hisslərinə zərər verir. Bu tip xəstəlik, cinsi həyatı nizamsız olan və ya cinsi əlaqədən məmnun olmayan insanlarda da baş verir. Beləliklə, onların cinsi həyatı risk altında ola bilər.

İpoxondriakal şikayətlər həmçinin özünə şüuraltı olaraq hansısa pis əmələ (məsələn, mastürbasiya, zina) görə tətbiq edilən cəzanın ifadəsi ola bilər. Onlar mənəvi narahatlığın bədən təzahürü kimi özünü göstərir.

Beləliklə, öz bədəninin obrazı vicdanın cəzalandırıcı icraçısına çevrilir.

Bu elementlər (pozulmuş üzvi integrasiya, gələcək perspektivdə boşluq, gələcəyə proyeksiyaya mane olan əks meyillər arasında münaqişə, xəstənin rolunu öz üzərinə götürməyin faydaları, öz bədəninin pozulmuş obrazı, mənəvi narahatlıq) bir-biri ilə əlaqəli ola bilər. Xəstə ilə söhbətlər zamanı bu elementlərin təhlili onları emosional həyatlarını yenidən qiymətləndirməyə vadar edir, mövcud pozğunluğu azaldır və ziddiyyətli təcrübələrin qiymətləndirilməsini asanlaşdırır. Bütün bunlar xəstənin daxili gərginliyini və əlaqəli hipoxondriakal əhval-ruhiyyəni azaltmağa imkan verir.

// AĞRI QABİLƏMƏSİ

İpoxondriakın əzabı xəyali deyil; o, xəstəliyini saxtalaşdırmır; bədəni həqiqətən xəstədir. Ağrı hissi haradan gəlir? Bu problem fəvqəladə dərəcədə mürəkkəbdir və mənim fikrimcə, tam həll olunmamış və ya öyrənilməmişdir və buna görə də özümüzü yalnız ümumi anlayışlar və ideyalarla məhdudlaşdırmaq lazımdır.

Ağrı reseptorları ən az fərqlənəndir, sadəcə çılpəq

(miyelinsiz) sinir liflərinin uclarından ibarətdir. Bədən xarici və ya daxili mühitindən spesifik siqnalları qəbul etmək rolunu öz üzərinə götürən və diapazonlarından kənarda olan bütün digər

enerjili zondlara həssas olmayan digər reseptorlardan fərqli olaraq, ağrı reseptorları daha böyük qavrayış qabiliyyətlərinə malikdir. Onlar mexaniki, kimyəvi, istilik, elektrik enerjilərindən təsirlənirlər.

Digər tərəfdən, onların həssaslığı digər reseptorlarla müqayisədə çox

aşağıdır. Sinir signalını tetiklemek üçün digər reseptorlara nisbətən xeyli çox enerji tələb olunur. Digər reseptorlar sinir sistemini xarici və daxili mühitdəki hadisələr haqqında həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə dəqiq siqnallarla təmin etsələr də, ağrı reseptorları insan bədəninin xarici və ya daxili mühitinə zərər vurma potensialının ümumi göstəricisini təmin edir. Onların ikinci adı buradan gəlir: nosiseptiv reseptorlar (poha - qüsür, zərər). Təcrübələrin əsas dixotomiyasında: xoş və xoşagəlməz, ağrı stimulları tarazlığı mənfi (xoşagəlməz) tərəfə doğru dəyişir. Lakin, kiçik dozalarda eyni stimulların xoş hisslər mənbəyi ola bilməsi mümkündür (məsələn, ağrı reseptorları ilə zəngin olan genital sahədə stimulun gücü xoş və ya xoşagəlməz hissin qavranılmasında həlledici rol oynayır). Görünür, qıdıqlama ağrı reseptorlarının incə stimullaşdırılmasından ibarətdir. Qaşım,

bəlkə də ağrı reseptorlarının stimullaşdırılmasından qaynaqlanır, baxmayaraq ki, bu, xüsusilə xoş, lakin ağrısız bir hiss deyil, əksinə, qıdıqlama kimi ağrı və zövq arasındakı sərhədi əhatə edir, sonuncu

müsbət qütbə daha yaxın, qaşıma isə mənfiyə daha yaxındır. Qaşım halında qaşıma nəticəsində yaranan ağrılı stimullar xoş bir hiss kimi qəbul edilir; bədən daxili boşluqlarından qaynaqlanan nosiseptiv reseptorlar halında, onların açıq şəkildə əksəriyyəti təşkil etdikləri yerlərdə, onların tamamilə xoşagəlməz keyfiyyətini qəbul etmək də çətinidir. Mədə divarının qida ilə dolması nəticəsində genişlənməsi insanlar tərəfindən xoş bir hiss kimi qəbul edilir, lakin bu sərhədlər aşılırsa,

Bu genişlənmə bütün xoşagəlməz nəticələri ilə birlikdə şişməyə gətirib çıxarır. Ağrılı və xoş arasındakı emosional bipolyarlığın ağrı reseptorlarının fəaliyyətində əks olunması mümkündür ki, bu da yüngül stimullaşdırma ilə xoş bir hiss, şiddətli stimullaşdırma ilə isə ağrılı bir hiss yaradır.

Digər siqnallar emosional olaraq neytraldır; yalnız fərdi neytral siqnallardan əmələ gələn daha yüksək funksional strukturlar xoş və ya xoşagəlməz hisslərin mənbəyidir. Yalnız ağrı siqnallarının özünəməxsus emosional keyfiyyəti var. Əgər ağrı reseptorları yalnız ağrı mənbəyi olsaydı, xoş hisslər üçün ayrı reseptorlar olmadığı üçün əks emosional qütblər arasındakı bütün tarazlıq pozulardı.

Ağrı siqnalları mövcud təhlükəni bildirir, eyni zamanda onun yerini göstərir ki, bu da bədənin səthinin zədələnməsi halında olduqca dəqiq, interoretseptor siqnalları halında isə daha qeyri-müəyyəndir. Bədənin səthindən gələn ağrılı stimullarla əvvəlcə qısamüddətli, dəqiq lokallaşdırılmış ağrı hiss olunur, ardınca uzunmüddətli, ümumiləşdirilmiş ağrı gəlir.

Hər iki növ ağrının sürətli və yavaş keçiriciliklə müxtəlif sinir lifləri ilə ötürüldüyü fərz edilir. Ağrılı interoretseptiv stimullar, görünür, yalnız bir növ ağrı yaradır - dəqiq lokalizasiyası olmadan.

Ağrı reseptorları, digər reseptorlardan fərqli olaraq, eyni zamanda iki əsas sinfə aiddir: eksteroreseptorlar və interoreseptorlar (bədənin səthinin və daxili boşluqlarının reseptorları). Eksteroreseptor xüsusiyyətlərinə şüurlu təcrübə daxildir, interoreseptor xüsusiyyətləri isə uzun müddətli adaptasiya tələb edir. Stimul çox uzun müddət təkrarlandığında sinir impulsu yaratmağı dayandıran və bununla da köhnə məlumat əhəmiyyətini itirdikdə yeni ətraf mühit məlumatlarını almağa uyğunlaşan eksteroreseptorlardan fərqli olaraq, interoreseptorlar və ağrı reseptorları yalnız stimullaşdırıcı vəziyyət dəyişənə qədər (məsələn, ağrı mənbələri aradan qaldırılana qədər) boşalır. Beləliklə, onlar kimsə gəlib onu söndürənə qədər uzun müddət çalan həyəcan signalı kimi çıxış edirlər. İnteroreseptorlara gəldikdə isə, adaptasiya məsələsi əsasən proprioreseptorlarda (hərəkət orqanının reseptorları) öyrənilmişdir, lakin bu hallarda adaptasiyanın çox uzun çəkməsi viseroreseptorlara (daxili orqanların reseptorları) da aiddir. Eksteroreseptorlar informativ rol oynayarkən (yaxşı müxbirlər kimi davranaraq, yalnız yeni hadisələri aşkarlayaraq), interoreseptorlar isə tənzimləyir, yəni narahatedici amil (stimul) aradan qaldırılana qədər və ya bu mümkün deyilsə, yeni tarazlıq vəziyyətinə çatana qədər müəyyən bir müddət ərzində təsir göstərir.

Ağrı reseptorlarının bədənin səthində paylanması qeyri-bərabərdir. Onların əksəriyyəti bədənin ön səthində yerləşir (ətraflarda, ön səthlər ovuqlarda və ya dabanlarda, arxa səthlər isə əllərin və ayaqların arxasıdır). Hərəkət istiqaməti irəli olduğundan, bədənin ön səthi ətraf mühitdən gələn hər cür travmaya arxa səthdən daha həssasdır. Xarici mühitlə təmas tezliyindən və buna görə də bədənin müəyyən bir səthinin funksional əhəmiyyətindən asılı olaraq, ağrı reseptorlarının sıxlığı paylanır (onların sayı torsoya nisbətən barmaq uclarında daha çoxdur). Ağrı reseptorlarının sıxlığı bədənin səthi ilə daxili boşluqları arasındakı sərhəd zonasında (ağız boşluğu, anus, cinsiyyət orqanları sahəsində) və hiss orqanlarının (gözlər, burun; yalnız buynuz qışanının öz ağrı reseptorları var) artır.

Ağrı reseptorlarının bədən səthində paylanması onların qoruyucu funksiyasını açıq şəkildə göstərir. Onlar təhlükə barədə xəbərdarlıq edirlər və buna görə də xarici mühitlə tez-tez təmasda olduqları və ya bədən bu hissəsinin xüsusi əhəmiyyəti səbəbindən təhlükənin ən böyük olduğu yerlərdə daha çox olurlar. Dış ağrısı alveolyar çuxurda bu qədər çox sayda reseptorun olmasına şübhə yaranır. Lakin, xarici dünya ilə ən sıx təmasda olan ağız boşluğudur. Dişlər, filogenetik rollarında, tutma və aqressiv funksiya yerinə yetirirlər. Bu, ağrı reseptorlarının xəbərdarlıq siqnalları mənbəyi kimi xarici mühitlə ən çox təmas konsentrasiyasının olduğu yerdə sıx paylanmasını izah edir.

Bədən daxili boşluqlarına gəldikdə, cərrahi müşahidələr parenximatöz orqanların ağrısız olduğunu göstərir. Hamar əzələlər və birləşdirici toxuma ağrıya həssasdır. Məsələn, neyrocərrah ağrı reaksiyasına səbəb olmadan anesteziya olmadan beyinə kəsik edə bilər, lakin ağrı qan damarları və ya beyin qışaları zədələndikdə yaranır. Daxili orqanlar üçün ətraf mühit bədən ətraf toxumalarından ibarətdir; ağrı reseptorları sərhəd qütblərində cəmləşmişdir. Bədəndəki hər bir hüceyrəyə çatan və görünür, onun hüceyrə nüvəsində bitən sinir uclarının ağrı qəbul etməsində oynadığı rol məlum deyil. Bunların yalnız efferent liflər, yəni hüceyrənin fəaliyyətini idarə edənlər deyil, həm də afferent liflər (hüceyrədən məlumat alanlar) olması mümkündür. Yalnız efferent liflərin olması həm məlumatın (giriş və çıxış) daxil olmasını, həm də xaric olmasını tələb edən idarəetmə sistemlərinin əsas qaydasına uyğun gəlmir. Bədən hüceyrələrindən gələn siqnallar, ilk növbədə, çoxmilyard hüceyrəli cəmiyyətdə sabit tarazlığın qorunmasında rol oynayır, eyni zamanda zəhndə ümumi rifah halı şəklində zəif əks-səda yarada bilər.

Hərəkət orqanlarına gəldikdə isə, ən çox sayda ağrı reseptoru sərhəd səthlərində - oynaqalarda, vətərlərdə, əzələ fassiyasında, fərdi əzələ liflərini ayıran birləşdirici toxumada yerləşir. Mexaniki stimullara əlavə olaraq, kimyəvi stimullar da təsir göstərir, yəni intensiv əzələ səyi zamanı əhəmiyyətli konsentrasiyalarda görünən metabolik məhsullar. Bu halda əsas amil, görünür, süd turşusunun yığılması nəticəsində ətraf mühitdəki hidrogen ionlarının (pH) konsentrasiyasının turşuluğun artmasına doğru dəyişməsidir. Hərəkət və əzələ səyi zamanı yaranan xoş hisslərin, güclü stimullaşdırıldıqda xoşagəlməz yorğunluq və əzələ ağrısı hisslərinə səbəb olan eyni reseptorların zəif stimullaşdırılması ilə əlaqəli olması mümkündür.

Aktivləşdirici

tor sistemində qarışıq olan bir çox siqnal arasında ağrı siqnalı üstünlük təşkil edə bilər, çünki o, beyin qabığının fəaliyyətini ən asanlıqla həyəcanlandırır. Gündəlik müşahidələrdən məlum olduğu kimi, digər stimullar olmadıqda, ağrı stimulu canlı orqanizmi dərin yuxudan oyadacaq; o, həmçinin daha güclü istiqamətləndirici stimuldur, çünki o, ətraf mühitlə davam edən siqnal mübadiləsini həmişə poza bilər və digər istiqamətləndirici stimullar qədər asanlıqla yox olmur. Ağrı stimulu bədən reaksiya verə bilməyəcəyi və ya qısa müddətdən sonra reaksiya verməyi dayandıra biləcəyi neytral stimula deyil. O, həmişə əhəmiyyətlidir və təhlükə siqnalı verir. Siqnal sistemində daimi siqnal seçimi mövcuddur; daha az əhəmiyyətli olanlar gecikir, daha vacib olanlar isə sistemin daha yüksək səviyyələrinə ötürülür.

Seçim ən aşağı səviyyədə, reseptorlarda baş verir. Reseptora təsir edən müəyyən sayda müxtəlif amillərdən yalnız bir neçəsi sinir signalına çevrilir. Signal sisteminin daha yüksək səviyyələrindən reseptora axan məlumat, hansı signalın olması və hansının dərhal rədd edilməsinin "qərar verməsində" əsas rol oynayır; bu məlumat, müəyyən bir təsir edən amillər növü ilə əlaqəli həm ümumi, həm də selektiv həssaslığını modelləşdirir.

Reseptor adaptasiyası fenomeni məhz seçimdən ibarətdir. Müəyyən köhnə stimullar reseptor tərəfindən rədd edilir. Bu seçim mərkəzi sinir sisteminin daha yüksək səviyyələrində daha aydın görünür. Bunun sayəsində filogenetik və ontogenetik inkişafımızın nəyə yönəldiyini və mövcud ehtiyaclarımızın bizi nəyə yönəltiyini dəqiq görə bilərik.

Reseptor səviyyəsində ağırlı stimulların seçilməsi zəifdir. Artıq qeyd edildiyi kimi, bu reseptorlar eyni stimulun təkrarlanmasına baxmayaraq sinir signalı yaradırlar. Bununla belə, o, sinir sisteminin daha yüksək səviyyələrində də mövcuddur. Kant padaqra ağrısı ilə mübarizə üçün öz metodunu necə inkişaf etdirdiyindən yazır. Şiddətli ağrı dövrlərində Kant onu maraqlandıran bəzi fəlsəfi suallara diqqət yetirərdi.

Ağrı həddi ümumi həyat dinamikası ilə tərs mütənəsb görünür. Şən, nikbin və ya məşğul insan yorğun, kədərli, qapalı və ya darıxdırıcı insana nisbətən daha az ağrı hiss edir. Həm endogen, həm də reaktiv mənşəli depressiyalar yaygındır,

bu hallarda yeganə simptomlar somatik şikayətlərdir. Zehni ağrı

fiziki ağrı kimi ifadə olunur. Belə xəstələrə faktiki, əsas xəstəlik diaqnozu qoyulmazdan əvvəl terapevtlər tərəfindən təkrarlanan, uzunmüddətli müalicələr aparılır.

Manik və ya şizofreniya həyəcanı vəziyyətində olan xəstə çox vaxt

fiziki ağrı hiss etmir; onların şüuru müxtəlif problemlərlə o qədər məşğuldur ki, ağrı onlara çatı bilmir.

Leykotomiya, yəni prefrontal korteksi subkortikal nüvələrlə, əsasən talamus və hipotalamusla birləşdirən sinir liflərinin kəsilməsi ağrı hissiyyatını azaldır, buna görə də davamlı ağrılarda istifadə olunur, bu halda analjeziklər və narkotik maddələr istənilən effekti vermir.

Prefrontal korteks həm zehni, həm də fiziki ağrının qavranılmasında rol oynaya bilər.

Leykotomiya əvvəllər müxtəlif göstərişlər üçün çox tez-tez istifadə olunurdu və hazırda bu müdaxilə bütün digər müalicə üsullarına davamlı olan uzunmüddətli depressiya hallarında həyata keçirilir. Somatik xəstəliklərdə leykotomiya ağrı qavranılmasını aradan qaldırmır; xəstə ağırlı yeri dəqiq göstərə bilər; digər tərəfdən, ağrı ilə əlaqəli qorxu və depressiya yox olur.

Ağrının zehni komponentinin "prefrontal" korteks funksiyası ilə əlaqəli olduğunu güman etmək olar.

Əgər filogenetik baxımdan beyin qabığının ən gənc hissəsi olan bu hissə,

qısa və ya daha uzun müddət ərzində reallaşdırıla bilən funksional strukturların inkişafında həqiqətən fundamental rol oynayarsa,

visseral və ağrı signalınının məhz ona çatdığı aydın olur. Birincisi bədən ehtiyacları haqqında məlumatı, ikincisi isə onu təhdid edən birbaşa təhlükə haqqında məlumatı təmsil edir. Bu məlumatlardan asılı olaraq, mövcud

funksional strukturlar dəfələrlə köklü dəyişikliklərə məruz qalmalıdır.

Dəyişikliklər. Əgər struktur kifayət qədər güclüdürsə, bu cür dəyişikliklər müşahidə olunmur (məsələn, mübarizə, sevgi ekstazı, problemə intensiv diqqət yetirmə və s. hallarında). Digər tərəfdən, bədən daxili boşluqlarından (viseroreseptiv) və ağrı siqnallarından gələn siqnallar, zəif və ya xaotik olduqda, mövcud funksional strukturların pozulmasına daha asanlıqla səbəb olur (məsələn, həyatda boşluq hissi ilə üzləşən, darıxan və ya çıxış yolu görməyən münasıqlar yaşayan bir insanda).

İpoxondriak nevrozlar yaxşı sosial statusa və əlverişli ev mühitinə malik insanlarda olduqca yaygındır və əslində onlar özlərini olduqca xoşbəxt hiss etməlidirlər. Lakin məhz bu zahiri xoşbəxtlik onların bədbəxtliyinə çevrilir, halbuki onlar özləri həyatdan bezərək boşluqda yaşayırlar. Boşluq isə ağrı və interoreseptor qavrayışının həddini aşağı salır. Müəyyən dərəcədə oxşar vəziyyət bəzən şizofreniyanın sadə formasında, həyatdakı boşluq insanın öz bədənində artan maraqla doldurulduqda rast gəlinə bilər. //

HİPOXONDRIK XƏSTƏLƏR İLƏ ƏLAQƏLƏR HAQQINDA BƏZİ PRAKTİK QEYDLƏR

Hipoxondriaz sindromlu xəstəyə qarşı çox səbirli olmaq lazımdır.

"Xəstə həmişə haqlıdır" prinsipinə əsasən, onun "fikirlərinə" əməl etmək lazımdır. Xəstə diqqətini daxili orqanlarına yönəltdiyindən, buradan başlamalıdır. İlk növbədə, xəstəni, bütün şikayətlərini səbirlə dinləmək, hərtərəfli tibbi və laboratoriya müayinəsi, zəruri hallarda isə digər, daha mürəkkəb testlər aparmaq lazımdır.

Məlumdur ki, az sayda hallarda hipoxondriakal sindrom vegetativ funksiyaların mövcud dağılmasının ilk göstəricisi ola bilər və yalnız müəyyən bir müddətdən sonra somatik xəstəliyin digər, daha obyektiv simptomları ortaya çıxır. Ətraflı müayinə həkimə və xəstəyə xəstəliyi obyektiv qiymətləndirməyə imkan verir, həmçinin xəstədə həkimə və xəstənin şikayətlərinə ciddi münasibətinə inam yaradır. Xəstə həkimə yalnız narahatlıqları ciddi qəbul edildikdə etibar edir.

İpoxondriak ətrafındakılarla dafələrlə mübarizə aparır, onlar isə onun şikayətlərini qəbul etmək istəmirlər. Onun ağır vəziyyətini anlamamaqla əlaqəli narazılıq hissi, qapalı bir dairədə olduğu kimi, bəzən illərlə davam edən fiziki əzabları artırən nevrotik amillər kompleksini tamamlayır. Bu ağrılı, hipoxondriak hisslər ağır somatik xəstəlik zamanı yox olur ki, bu da ətrafındakıların və həkimlərinin münasibətində dəyişiklik yaradır. Bu paradoksal vəziyyətdə xəstəliyinin tanınması ona səbirlə, çox vaxt ağır əzablara dözməyə imkan verir.

İpoxondriak xəstələrin terapevtik müalicəsində, mümkün olduqda, onların öz xəstəlikləri ilə mübarizə hisslərini aradan qaldırmaq lazımdır. Buna xəstəyə ciddi münasibət və hərtərəfli müayinə ilə nail olmaq olar. Və yalnız xəstə ilə söhbətin sonrakı mərhələlərində onun hipoxondriyasının əsasını anlamaq olar:

boşluq və həyatdan bezmə hissi, mövcud münasıqla səbəbindən həyatını planlaşdırma bilməməsi, yaxud gələcəyin depresif şəkildə qara ümitsizlik pərdəsi ilə örtülməsi, yaxud mövcud vəziyyətdən daha əlverişli sosial mühitə qaçmaq istəyi, yaxud bəlkə də başqalarından daha yaxşı şərait və münasibətlər təmin etmək istəyi, yaxud nəhayət, öz bədəninin, xüsusən də onun pozulmuş təsviri.

Cinsi komponent. Adətən, bir neçə birgə mövcud olan

amil bir-biri ilə əlaqəlidir. Xəstə ilə hipoxondriakal sahədən kənarda ağrıları haqqında söhbət, onlara vəziyyətlərini daha yaxşı başa düşməyə, əks emosional münasibətlərini bir qədər barışdırmağa və bununla da mövcud daxili gərginliyi aradan qaldırmağa imkan verir. Və sonra tədricən hipoxondriakal təbəqə solur.

OBSESSİYA-KOMPULSİV NEVROZ

// GÜNDƏLİK HƏYATDA ANANKASTİK SİMPTOMLAR

Anankastik nevrozda və ya obsesif-kompulsiv nevrozda nevrotik qorxu

mənasız bir vəziyyətə və ya xəstənin əsas təcrübələri ilə ziddiyyət təşkil edən bir vəziyyətə yönəlir və beləliklə, psixikanın qalan hissəsinin zahirən muxtar və müstəqil bir varlığını formalaşdırır ki, bu da xəstəyə əzmkarlıqla varlığını xatırladır və

dəfələrlə xəstənin normal həyat tərzinə müdaxilə edir.

Yunan dilində Ananke zərurət, taley və ya taley deməkdir. Obsesif-kompulsiv nevrozun xarakterik

simptomu məcburiyyətdir; Xəstə ağrılı simptomları nə qədər çox müqavimət göstərsə və onlarla mübarizə aparsa, bir o qədər şiddətlənir; könüllü səylər cavabsız qalır və bəzən hətta bu cür müqavimət qarşısında zərərli hala gəlir.

Sonrakı təsirlərdəki anankastik simptomlar sağlam insanların gündəlik həyatında özünü göstərir; bunlara sosial həyatın bəzi formalarında rast gəlmək olar. Hər kəs

bir melodiya, düşüncə, az-çox mənasız bir söz və ya

rəqəm "başında ilişib" qaldığını, davamlı olaraq əks-səda verdiyini və sarsıla bilmədiyini hiss edə bilər. Bəzən yatmadan əvvəl insan narahat olur: qapını kilidləyibmi, qazı söndürübümü, işıqları söndürübümü və s. İnsan qalxıb yoxlayır və bir müddət sonra yenidən narahat olur və artıq yoxladıklarını yenidən yoxlayır. Həmçinin cibində biletin, açarın və pulun olub-olmadığını dəfələrlə yoxlaya bilərlər.

Bəzi insanlar həyatlarında müəyyən bir nizamı qorumaq üçün qeyri-adi dərəcədə diqqətliirlər. Onlar əşyalarını, kiçik əşyalarını gödəkçələrinin ciblərində və masalarında özlərinə məxsus şəkildə yerləşdirir, işə yalnız bir yolla gedirlər və s. Gündəlik həyatın bu "rituallarının" pozulması onlarda narahatlığa səbəb olur; günləri pozulur və onlar yalnız pozulmuş qaydanı bərpa edə bildikdə rahatlayırlar. Bəzi insanlar siçanlardan, fırtınalardan (bu tip fobiya adətən qadınlarda olur), yüksək hündürlüklərdən və qapalı məkanlardan qorxurlar. Böyük hündürlüklər onları "cəlb edir", aşağı tullanmaq istəyi yaradır, bu mənasız istəyin qorxusu; bəzən əziyyət çəkənin dayandığı məkan çox darısqal görünür və onlar tarazlığını itirib uçuruma düşməkdən qorxurlar.

Sosial həyatda anankastik meyillər rituallar şəklində və nəticədə stereotipik olaraq təkrarlanan hərəkətlərdə özünü göstərir. Ritualın yaxşı tapdalanmış yolu insanı Tanrının və ya insanın hakimiyyəti ilə qarşılaşdıqda onların anlayışında yaranan və ya heç olmasa yaranmalı olan qorxudan qoruyur. Ritual dini kultlarda, orduda, diplomatiyada, kral saraylarında və s. baş verir. Ritual ilahi və ya insan ağaya gedən sehrli bir yol kimi çıxış edir; ona çatmağın başqa yolu yoxdur. Ritualı dəyişdirmək qorxu yaradır, sanki bu sehrli yoldan yayınmaq laesio majestatis olardı.

Daha az dərəcədə və bəlkə də daha az sərt şəkildə, müxtəlif sosial həyat formaları birbaşa insan-insana qarşıdurmadan qorunma təmin edir. Onlar bu yolun insanın insanlar arasında dinc şəkildə hərəkət etməsinə imkan verdiyinə zəmanət verirlər. Qəbul edilmiş sosial davranış formalarını pozmaq bəzən böyük narahatlıq və günahkarlıq hissi doğurur, bu da çox vaxt başqa bir insana edilən təhqirdən daha güclüdür, halbuki bu qəbul edilmiş formalar qorunur. Məcburi hərəkətlər və sosial rituallar arasındakı bənzətmə təkcə onların stereotipik təkrarlanmasında deyil, həm də qorxu hisslərindən qoruyan sehrli təsirindədir.

Uşaq oyunlarında bəzən anankastik elementləri, məsələn, çəkilmiş xətti keçmədən gəzmək, daim bir əşyanı daşımaq (uşaqlar bir vaxtlar yaşıllıqlarla oynayırdılar - "almaq olmaz, dəymək olmaz, sadəcə yaşıllıqlarını mənə göstər" və bu gün onların talismanı şerif ulduzudur), sehrli tilsimlər söyləmək və ya oyunda müəyyən bir məna daşıyan anlaşılmaz hərəkətlər müşahidə etmək olar. Bu və oxşar

hərəkətlər, oynaq fəaliyyətdən qaynaqlanır, iradə ilə idarə olunur,

məqsədyönlüdür, elə bir vərdiş çevrilə bilər ki, uşaq yerinə yetirilmədikdə narahatlıq hiss edir və buna görə də onları daim təkrarlayır.

OBSESSİONAL DÜŞÜNCƏLƏR

Anankastik simptomlar üç formada özünü göstərə bilər ki, bunlar tez-tez eyni xəstədə bir-biri ilə qarışır: obsesif düşüncələr (obsessiyalar), kompulsiv hərəkətlər (kompulsiyalar) və obsesif qorxular (fobiylar). Onların ortaq xüsusiyyəti perseverativ kompulsiyadır, yəni eyni, stereotipik şəkildə təkrarlanma və bir qayda olaraq, xəstənin iradəsinə və qəribəliyinə qarşı; xəstə onları lazımsız hiss edir, onlar onun aradan qaldırmağa çalışdığı bir maneə təşkil edir. Bu qəribəlik hissi obsesif düşüncə ilə xəyal arasındakı əsas fərkdir; xəyal xəstə tərəfindən onun təcrübələrinin əsasını təşkil edən şəxsi bir şey kimi qiymətləndirilir; obsesif düşüncə onun təcrübələrinin dairəsindən kənarda, sanki muxtar və buna görə də mənasız kimi mövcuddur. Məna və mənasızlıq hissi əsasən müəyyən bir şeyi "həzm etmək", yəni onu öz təcrübə dünyasına inteqrasiya etmək qabiliyyətindən asılıdır. Yalnız daxili nizamımıza uyğun olmayan şey mənasızdır. Obsesif düşüncələrin mövzuları müxtəlifdir. Nisbətən nadir olsa da, emosional çarları olmayan obsesif düşüncələrə də rast gəlinir, məsələn, müəyyən rəqəmlərin məcburi təkrarlanması, müəyyən riyazi əməliyyatların zehni olaraq yerinə yetirilməsi, eşidilən sözü və ya oxunan ifadəni təkrarlamaq və s.

Lakin, əksər hallarda obsesif düşüncələrin mövzusu xəstənin maraqlarına toxunur; çox vaxt,

bu, onların təcrübələrinin əsas mövzuları ilə ziddiyyət təşkil edir. Yeni doğulmuş uşağına (xüsusən də ilk övladına) bütün hisslərini verən ana, uşağı boğmaq və ya bıçaqlamaq obsesif düşüncəsindən dəhşətə gəlir. Belə bir qorxulu düşüncənin gerçəkləşmə ehtimalından qorxaraq, bütün iti əşyaları özündən dəfələrlə gizlədir və onların görünüşü onda qorxu oyadır. Dərin dindar bir insan küfr düşüncələri ilə qarşılaşa bilər və ya ikonalara baxarkən qorxunc cinsi səhnələr təsəvvürlərinə qapıla bilər. Bu cür düşüncələr onları qorxudur; onlar onları günahkar hesab edirlər və nə qədər çox müqavimət göstərsələr, bir o qədər tez-tez onları təqib edirlər. Yüksək əxlaqi xarakterə malik bir insan erotik təbiətli cilovsuz düşüncələr və ya yaxınlarına qarşı təcavüz dolu düşüncələrlə əzab çəkə bilər. Ziddiyyətli tipli obsesif düşüncələr insanın psixikasının sikkəsinin digər tərəflərini də ortaya qoyur.

Onlar Yunqun "kölgə" anlayışını təsdiqləyə bilər (hər bir təcrübə

şüuraltı olaraq əks emosional işarə ilə öz kölgəsini daşıyır).

Obsesif düşüncələrin mövzusu sabit bir mövzu ətrafında mərkəzləşə bilər.

Özünüidarəetmə funksiyaları – "Düzgün işi gördümmü?", "Düzgün işi dedimmi?", "Nəyisə unuttummu?" Normal özünüidarəetmə patoloji nisbətlərə çatır.

Düzgün yerinə yetirilən hərəkətlə bağlı şübhələr xəstəni onu təkrarlamağa məcbur edir.

Yoxlamadan qısa müddət sonra şübhələr yenidən yaranır. Narahatlıq aradan qalxmır, özünüidarəetmə xəstəni yalnız qısa müddətə sakitləşdirir.

Obsessiyalar, bir qayda olaraq, sadə hərəkətlərlə bağlıdır və onların tez-tez təkrarlanması müəyyən bir avtomatlaşdırmaya gətirib çıxarır. Nəticə etibarilə, həkim dərmanı düzgün təyin edib-etmədiyindən, əcaçı onu düzgün təyin edib-etmədiyindən, mühasib hesablamada səhv edib-etmədiyindən, keşş dini mərasimin vacib bir hissəsində bir sözü buraxıb-çatlamadığından və tez-tez etirafa gedən şəxs etirafının doğruluğundan narahat olacaq. Bütün bu hərəkətlər bu insanlar üçün çox vacibdir və onların tez-tez təkrarlanması nəticəsində onlar avtomatik hala gəlir.

Onların icrası zamanı özünüidarəetmə qismən şüurlu şüurdan kənarda həyata keçirilir.

Obsesif şübhələrlə özünənəzarət şüurun periferiyasına düşməsinin qisasını alır və israrla onun mərkəzi olmağa çalışır.

Xəstə əvvəllər dəqiq və düşünmədən yerinə yetirdikləri yaxşı bir işi görüb-görmədiyinə daim şübhə edir. Onlar sanki şübhələrə qapılıblar və digər zehni fəaliyyətlər üçün az enerji və ya vaxt qoyurlar.

Obsesif düşüncələrin başqa bir forması, xəstə üçün heç bir maraq kəsb etməyən eyni mövzuya tez-tez qayıtmaq ola bilər. Düşüncələr adi gündəlik hadisələr, "mən kiməm", "niyə mövcudam?", "həqiqətən sağam?" kimi "fəlsəfi" suallar və keçmiş zamanların dəqiq xatirələri ilə əlaqəli ola bilər. Xəstə, həmişə olduğu kimi, obsessiyalarla bu düşüncələrdən uzaqlaşmaq istəyir, lakin onlarla nə qədər çox mübarizə aparırsa, onlar onu bir o qədər narahat edir.

Bu cür düşüncələrin fonunda derealizasiya və ya depersonalizasiya epizodları baş verə bilər. Birinci halda, xəstə ətraf aləmin qeyri-reallığını hiss edir;

Onlara elə gəlir ki, ətraflarındakı hər şey qeyri-real, qeyri-realdır, bəzən üçüncü ölçüdə məhrumdur, düz və ya rəngi dəyişdirilmiş, əksər hallarda boz, bəzən isə dördüncü ölçüdə - zamanla dəyişdirilmişdir. Sonra onlara elə gəlir ki, gördükləri hər şey yeni və qeyri-adidir (jamais vu) və ya əksinə, gördükləri hər şey artıq tanışdır (deja vu).

İkinci halda - depersonalizasiya - xəstə özünü qeyri-real görür,

bəzən hətta yoxlamaq üçün özünü çimdikləyir. Belə hallarda, insanın öz varlığının reallıq hissi pozulur və buna görə də, həyatın özündən danışırıqsa, təcrübə ən vacib şeydir.

Depersonalizasiya hadisələrinə bədən sxemində dəyişiklik daxildir;

xəstə bütün dünyanın kiçildiyini və ya genişləndiyini, yaxud bədəninin bir hissəsinin ölçüsündə dəyişdiyini, məsələn, başın şişdiyini, əllərin nəhəngləşdiyini və s. hiss edir. "Mən"imizin reallıq hissi bədənimizin reallıq hissi ilə sıx bağlıdır. "Mən"in reallığı maddidir və onun pozulması, ilk növbədə, fiziki aspektdə əks olunur. Derealizasiya və depersonalizasiya simptomları anankastik təzahürlər hesab edilmir. Onlara ən çox şizofreniya və epilepsiyada, xüsusən də gicgah formasında rast gəlinir. Bu simptomlar bölünmə (şizofrenik) simptomları kimi qiymətləndirilməlidir, çünki onlar insanın öz şəxsiyyətinin və ya ətraf aləmin strukturunu pozur. Əgər onlar nevrozlarda özünü göstərsə, onda necə

Adətən, özünə və başqalarına qarşı aqressiv hisslər fonunda.

Öz əhəmiyyətsizliyi və ətrafındakı dünyanın dəyərsizliyi haqqında düşüncələr, nəticədə, onların reallığının təkzib olunmasına gətirib çıxara bilər.

// OBSESSİONAL HƏRƏKƏTLƏR

Obsesif hərəkətlər (kompulsiyalar) öz ağılına və iradəsinə qarşı bir hərəkətin stereotipik təkrarlanmasından ibarətdir. Xəstə onlarla nə qədər səylə mübarizə aparırsa, onları yerinə yetirmək ehtiyacı bir o qədər artır. Kompulsiv hərəkəti yerinə yetirmək müvəqqəti rahatlıq gətirir, lakin tezliklə onu təkrarlamaq ehtiyacı xəstəyə qaydır. Kompulsiv hərəkətlərin simptomatologiyası zəngin və müxtəlifdir.

Ən çox yayılmışları obsesif əl yuma, geyinərkən və soyunarkən rituallar, özünü yoxlama (müəyyən bir tapşırıq düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsi) və "əks təsir"dir (bədbəxtliyin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif hərəkətlər).

Kompulsiv hərəkətlərin təkrarlanmasına baxmayaraq, onlar heç vaxt avtomatlaşmır; Onlar həmişə şüurlu bir qərarla müşayiət olunurlar və hətta o zaman da yüksək dərəcədə dəyişkənliyə malik bir qərar: nə etmək, ya etməmək? Lakin, qərar artıq əvvəlcədən müəyyən edilmişdir; qətiyyətsizliyə və daxili mübarizəyə baxmayaraq, kompulsiv hərəkət həyata keçirilir. Kompulsiv hərəkət etmək ehtiyacı əksər hallarda fobiya, obsesif şübhələrdən və ya kompulsiv hərəkətin sehrli gücünə inamdan yaranır. Ümumi motor obsessiyası obsesif əl yumadır. Bu, toxunma obsessiyaları fonunda baş verir. Xəstələr çirkli bir şeyə toxunduqları və buna görə də dərhal bu çirkədən təmizlənməli olduqları təəssüratını yaradırlar. Xəstələr bir şeyə toxunmamaq üçün əllərini dəfələrlə eyni vəziyyətdə tuturlar (məsələn, dua edirmiş kimi). Bütün tədbirlərə baxmayaraq, onlar daim çirkə sızdığı hiss edirlər və əllərini daim yuyurlar. Belə xəstələrin ovuclarında ekzema nə qədər tez-tez görünür! Xəstələrlə söhbətlərdə bu çirkənmənin simvolik əhəmiyyətini hiss etmək olar. Çox vaxt çirkənmə qorxusu cinsi əlaqə qorxusunu ifadə edir; bu tip kompulsiv hərəkətlər ən çox qadınlarda rast gəlinir. Bir tapşırığın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsi ilə bağlı şübhələr onun təkrarlanmasına səbəb olur (məsələn, qapının bağlı olub-olmadığını, rəqəmsal sütunun düzgün sayıldığını, reseptin düzgün yazıldığını və s. yoxlamaq halında). Bəzən müəyyən bir hərəkət müəyyən sayda dəfə təkrarlanır, məsələn, üç, yeddi və s. Lazımı təkrarların müəyyən sayı sehrli bir rəqəm kimi çıxış edir və yalnız bu rəqəm səhvin qarşısını ala bilər. Kompulsiv hərəkətin yerinə yetirilməsindəki detallılıq birdən çox təkrara səbəb olur, çünki xəstə həmişə onun icrasında kiçik bir səhv tapır və hər şey yenidən başlayır. Və nəhayət, bu obsesif hərəkətin məqsədi şərdən qorunmaq ola bilər. Xəstə müəyyən bir şəkildə yataqdan qalxır, müəyyən bir qaydada paltar geyinir, işə gedərkən müəyyən bir marşrut tutur və s. Əksini etsələr, hər şey onlar üçün pis olacaq və xəstədə qorxu və narahatlıq yaranır ki, bu da onları bu obsesif hərəkətləri təkrarlamağa məcbur edir. Bəzən ritual hərəkətlər sadəcə gülüncdür və ətrafdakılarda çaşqınlığa səbəb olur, məsələn, xəstə küçə lampasının ətrafında müəyyən bir tərəfdən gəzəndə və ya başını, qolunu və ya ayağını müəyyən bir şəkildə hərəkət etdirdikdə. Bu sonuncu halda, obsesif hərəkətlər sinir tiklərinə bənzəyə bilər; xəstə bəzən başını yelləyir, əli ilə bir şey yelləyir və ya xarakterik bir şəkildə ayağını təpikləyir. Lakin bunlar isterik tiklərdə olduğu kimi avtomatik, qeyri-iradi hərəkətlər deyil.

Motor aktının çevrilməsi və ya güclənməsi, lakin xəstənin diqqətini cəmləşdirən və uğursuz müqavimət göstərməyə çalışdığı tamamilə şüurlu hadisələrdir.

Bəzən obsesif hərəkət açıq şəkildə simvolik xarakter daşıyır; bu, cinsi və ya aqressiv bir hərəkəti simvollaşdırır və sanki onların kiçik bir hissəsini təşkil edir. Elə olur ki, xəstə sevilən birinin fotosəklinin gözlərini deşir və ya tramvayda gənc bir qadının sinəsinə toxunur.

// FOBİYALAR

Bəzi müəlliflər dominant qorxu hissi səbəbindən obsesif qorxuları (fobiyları) digər anankastik simptomlardan ayrı hesab edirlər. Lakin bu mövqeyi haqlı hesab etmək çətindir, çünki obsesif düşüncələrlə müşayiət olunan qorxu (fikrin özü məzmunu vasitəsilə narahatlıq yarada bilər və ondan ayrılma bilməmək də tez-tez ağır narahatlıq yaradır) və kompulsiv hərəkətlər (kompulsiv hərəkəti yerinə yetirməmək, xəstə nəzərdə tutulan hərəkəti yerinə yetirdikdə qısa müddətə aradan qaldırıla bilən narahatlığın artmasına səbəb olur). Fobiylar, digər anankastik simptomlar kimi,

perseverativ obsessiya ilə xarakterizə olunur və müəyyən bir vəziyyətdə təkrarlanır.

Bundan əlavə, fobiylar adətən obsesif düşüncələr və hərəkətlərlə bir-birinə qarışır.

Çox vaxt kompulsiv hərəkətlər obsesif əl yuma kimi bir fobiya nəticəsində yaranır.

Psixiatrik nomenklatura

müxtəlif fobiya növləri üçün çoxsaylı təriflər təklif edir, məsələn, klaustrofobiya (qapalı məkanlardan qorxmaq), aqorafobiya (açıq məkanlardan qorxmaq), ereutofobiya (yadların yanında qızarmaq qorxusu) və s. Yunan lüğətindən istifadə edərək, bu terminləri sonsuz sayda istinad etmək olar, çünki istənilən vəziyyət, obyekt və ya şəxs

obsesif qorxu mənbəyi ola bilər. Buna görə də, bu terminlər bu günlərdə getdikcə daha az istifadə olunur.

Ölüm və ya ruhi xəstəlik qorxusu müxtəlif növ nevrozlarda və yalançı nevrozlarda o qədər yaygındır ki, onu obsesif-kompulsiv nevroz baxımından nəzərdən keçirmək çətindir. Ölüm hər şeyi öz sonu ilə taclandırır — konsepsiya anından başlayan müəyyən bir nizamın sonu. Ruhi xəstəlik də subyektiv olaraq əvvəllər mövcud olan bir nizamın sonu deməkdir; keçmiş insan özü və cəmiyyət üçün ölürlər. Bioloji və ya psixoloji ölümün paroksizmal qorxusu, az və ya çox dərəcədə insanın daxilində gizlənən qorxuları ifadə edir, çünki onların integrasiyası həmişə qeyri-sabitdir və parçalanma ilə məhdudlaşır. Bu qorxudan qaçmaq olmaz, çünki onu təhrik edən vəziyyət insanın öz daxilindədir, xaricində deyil. Obsesif qorxularla qaçış imkanı həmişə mümkündür; axı açıq məkanlardan, çirkənlənmədən, zöhrəvi xəstəliyi təhdid edən təmaslardan, yanında qızarmaq mümkün olan insanlardan, dəhşətli, nəzarətsiz istəklərini yerinə yetirə biləcəyi iti aşıyalardan və s. qaçınmaq olar.

Fobiyalarda nevrozun, eləcə də bir çox digər ruhi pozğunluqların və somatik xəstəliklərin əsas simptomu olan qorxu, sanki konkret, tez-tez absurd bir vəziyyətdə kilidlənir. Deyəsən, onda kristallaşır və bunun sayəsində artıq başqa vəziyyətlərdə görünmür. Bu vəziyyətdən qaçmağın mümkün olmadığı üçün qorxudan qaçmaq ümidi yaranır. Amma təəssüf ki, bu ehtimal

Qorxu xəyali bir şeydir, daim qayıdır və bununla birlikdə onu tetikləyən vəziyyət haqqında düşüncə yaranır və qaçmaq mümkün deyil. Qalan hər şey əhəmiyyətsiz hala gəlir; sadəcə böyük qorxu doğuran şeylə qarşılaşmamaq lazımdır.

Qeyri-müəyyən narahatlıqdan fərqli olaraq, anankastik qorxu

qeyri-adi dərəcədə güclüdür və tez-tez vegetativ pozğunluqlarla müşayiət olunur - ürək döyüntüsü, tərləmə, ürəkbulanma, balanssızlıq və s. Belə bir qorxu hücumundan qorxan xəstənin intihar etdiyi hallar var, məsələn, klaustrofobiya əziyyət çəkən həbs olunmuş xəstə. Buna görə də, belə bir qorxu konqlomeratı halında xəstənin fobiyanı tetikləyən vəziyyətdən qaçmaq üçün hər cür səy göstərməsi təəccüblü deyil. Ağır hallarda xəstə heç nə düşünə bilmir, heç nə edə bilmir,

qorxusunun köləsinə çevrilir. Xəstələr illərlə küçəni keçmək perspektivindən qorxaraq çölə çıxmırlar.

Obsesif qorxunun absurdluğu tək-cə kənar insanlar üçün deyil, həm də əziyyət çəkən şəxsin özləri üçün aydındır. Onlar çox yaxşı başa düşürlər ki, nə qapalı, nə də açıq məkanlardan, nə də müəyyən əşyalara əllərini çirkəndirməkdən qorxmaq üçün heç nə və heç kim yoxdur, amma bunu özlərinə izah edə bilmirlər. Fobiyaları ilə nə qədər çox mübarizə aparsalar, bu, bir o qədər aydın olur.

Həmçinin, əziyyət çəkən şəxs sonda fobiyanın yaranmasına səbəb olan təhlükəli vəziyyətin (məsələn, müəyyən əşyalara toxunmaq onlar üçün təhlükəli olacaq, evdən çıxmaq ölümə səbəb ola bilər və ya əslində xərcəng və ya sifilis xəstəliyinə tutulurlar) faktiki mövcudluğuna inanmağa başlayır. Bu hallarda obsesif vəziyyətlə xəyal arasındakı xətt qərarlı. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, onların məzmununa tənqid anankastik simptomları xəyallardan fərqləndirir.

Bəzən, çox tez-tez olmasa da, fobiyanın mənşəyi müəyyən edilə bilər. Bu, Pavlovun təsvir etdiyi itdə olduğu kimi, patoloji şərtlə refleksin inkişafından ibarət ola bilər. Laboratoriyada baş verən daşqından sonra bir neçə il ərzində sudan qorxu hissi keçirən itdə olduğu kimi. Bəzən obsesif qorxular cinsi və ya aqressiv təbiətin basdırılmış meyllərini əks etdirə bilər. Məsələn, çirkənmə qorxusu cinsi əlaqə qorxusunu, ikili qorxunu təmsil edə bilər və əksər hallarda "Mən bunu istəyirəm, amma qaşınıram, amma anam icazə vermir" anlayışına əsaslanır. Kəskin əşyalardan qorxmaq mənə ən yaxın və əziz olan insanlara qarşı gizli aqressiv motivlərin ifadəsi ola bilər (bu tip fobiya analarda, xüsusən də ilk dəfə ana olanlarda özünü göstərir). Çölə çıxmaq qorxusu tez-tez evliliklərində cinsi narazılığı olan, lakin ərləri ilə yaxşı münasibətləri olan qadınlarda olur. Onlar çölə çıxmağı daha sərbəst, daha erotik bir həyat sürməyin bir yolu kimi görürlər. Luofobiya (zöhrəvi xəstəlik qorxusu) tez-tez xəstə tərəfindən əxlaqsız hesab edilən cinsi əlaqə ilə əlaqəli günahkarlıq hissidir.

Anankastik simptomlar uşaqlıqdan (az və ya çox) daha qısa və ya daha uzun fasilələrlə ortaya çıxır və ya yetkinlik dövründə ortaya çıxır. Sonuncu halda, nevrozun müalicəsi daha təsirli olur.

// DİGƏR RUHİ POZUNTULARDA ANANKASTİK SİMPTOMLAR

Anankastik simptomlar* yalnız obsesif-kompulsiv pozğunluqla məhdudlaşmır,

həmçinin digər nevroitik təzahürlərlə eyni vaxtda yox olan digər nevrozlarda da baş verir. Bu simptomlar şizofreniyada, əksər hallarda derealizasiya və ya

depersonalizasiya, fobiyalar və xəyallarla həmsərhəd olan vəziyyətlər və zehni avtomatizmlərə (uzaqdan idarə olunma təəssüratı) bənzər obsesif hərəkətlər şəklində baş verə bilər.

Depressiyalar adətən davamlı, xoşagəlməz düşüncələrə meyl göstərir. Psixozvi sindromlarda və epilepsiyada perseverativ meyllər anankastik simptomlar xarakteri ala bilər və ətraf mühitin və öz şəxsiyyətinin zaman-məkan strukturunun pozulması ilkin mərhələlərdə déjà vu və jamais vu kimi depersonalizasiya və derealizasiya simptomları kimi özünü göstərə bilər.

/ MƏCBURİYYƏT (ANANKE) VƏ İRADƏ AZADLIĞI

Obsesif-kompulsiv nevroz təhlil edilərkən dörd problem ortaya çıxır: məcburiyyət, qorxu kristallaşması, sehrli düşüncə və perseverasiya.

Əsas insan təcrübələrindən biri seçim etmək qabiliyyətidir. Sonda iki əksinə endirilən çoxsaylı mümkün davranış formaları arasında insan birini seçə bilər. Əgər insanın belə bir seçimi yoxdursa, o zaman özünü avtomat kimi hiss edir və zorakılığa qarşı üsyan aktının özü seçimə çevrilir. Subyektiv baxımdan azad iradənin mövcudluğu danılmaz bir faktdır. Hər şüurlu hərəkətdən əvvəl bir şübhə anı yaranır: necə hərəkət etməliyəm? Şüurlu qərar aktı, canlı orqanizmdə daim ortaya çıxan potensial funksional strukturların reallaşmasına aparan uzun bir hadisə zəncirinin son halqasıdır. Qərar qəbul edildiyi anda keçmiş gələcəyə çevrilir. İmkanların sayı azalır və realılıqla əvəz olunur.

Xarici baxımdan, az və ya çox əminliklə insanlar da daxil olmaqla hər bir canlı orqanizmin davranışını proqnozlaşdırmaq olar (düzgün proqnozlaşdırma ehtimalı potensial davranış tərzlərinin sayı artdıqca azalır və buna görə də insanlar üçün meymunlardan, məməlilər üçün balıqlardan, heyvanlar üçün bitkilərdən və s. azdır). Bir davranışa aparan, digərinə aparmayan bir səbəb zənciri qurmaq mümkündür - buna görə də canlı təbiətdə hökm sürən determinizmə inam yaranır.

Müəyyən bir davranışın genetik və sosial olaraq müəyyən edilməsi, səbəb zəncirində müəyyən bir sərbəstliyin mövcudluğuna zidd deyil (bu cür sərbəstlik hətta cansız təbiət hadisələrində də mövcuddur;

ehtimal problemi müasir fizikada görkəmli yer tutur). Bu sərbəstlik sayəsində eyni bürəddən fərqli nəticələr yarana bilər.

Eyni sosial dairədə böyümüş (və buna görə də eyni genetik və oxşar sosial determinantlara malik) eyni əkilərin həyatını müşahidə etdikdə, bir çox fərqli davranış xüsusiyyətlərini,

və çox vaxt tamamilə əks olanları görmək olar. Əkilərdən biri enerjili və

dominant ola bilər, digəri isə itaətkar və təşəbbüskar deyil; Biri altruizm, digəri egoizm və s. xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. Görünür, səbəb-nəticə əlaqələrinin çox dəqiq qurulması ilə belə, gələcəyi etibarlı şəkildə qabaqcadan görmək mümkün deyil, çünki

həmişə müəyyən hərəkət azadlığı, yəni fərqli və tez-tez ziddiyyətli davranış tərzləri arasında seçim etmək imkanı mövcuddur. Hər bir qərar

mövcud imkanların sayını azaldır və inkişaf xəttində

bir istiqamətdə deyil, digərində dəyişikliyə səbəb olur. Demək olar ki, eyni şəraitdə böyümüş iki eyni əkidən biri dominant, digəri isə itaətkar, biri autizmlə, digəri isə sintonik olursa, onda müəyyən bir nöqtədə onların

inkişaf zamanı iki əks davranış modeli (dominant-itaətkar, sintonik-autistik) arasında seçim etmək imkanı yarandı. Bu iki variantdan birinin seçilməsi hadisələrin sonrakı gedişatını əvvəlcədən müəyyən edir. Bu konkret nümunədə, itaətkar davranış modeli olan əkiz başqaları tərəfindən qiymətləndirilməyə davam edəcək, əkiz qardaşı və ya bacısı isə dominant mövqə tutacaq. Beləliklə, onun imkan radiusu azalacaq və onun üçün indiki anda dominant mövqə tutmaq kritik qərar verməzdən əvvəl olduğundan daha çətin olacaq. Bu, bu mövqenin mövcudluğunu dayandıracağı anlamına gəlmir; o, qalacaq, lakin məyus formada olacaq və onun reallaşması imkanları hər yeni seçimlə azalacaq.

İnsanın özünü və ətraf dünyanı əks qütblər baxımından qiymətləndirmək meylinin güclü şəkildə ifadə olunması mümkündür: yaxşı-pis, gözəllik-çirkinlik, sevgi-nifrət, ağ-qara, +1-1 və s. Bu, son formasında həmişə əks hisslər arasında seçim olacaq bir qərar vermək ehtiyacından irəli gəlir.

Əgər canlı orqanizmə tənzimləyici sistem baxımından baxsaq, qərar anını onun fəaliyyətinin əsası kimi qəbul etməliyik, çünki hətta texniki özünü-tənzimləyən sistemlərdə belə, onların əsas vəzifəsi mümkün fəaliyyət formaları arasında düzgün seçimdir (termostat iki variantdan birini seçməlidir: temperaturu artırmaq və ya azaltmaq; avtomatik nişan cihazı güllə üçün uyğun istiqaməti seçməlidir və s.). Seçim proqramdan (canlı orqanizmlərdə genetik plana uyğun olan), siqnalların axınından, xüsusən də bu planın necə yerinə yetirildiyini bildirən təkrarlanan siqnallardan və sistemdə baş verən dəyişikliklərin yaddaşının qeydindən və nəticədə ona çatan siqnallardan və nəticədə verilən qərarlardan asılıdır.

Genetik plan hər bir canlı hüceyrə üçün inkişaf yolunu göstərir, lakin bu planın içində gizlənən potensialın reallaşması ətraf mühit şəraitindən asılıdır. Bu, çoxhüceyrəli orqanizmlərdə ən asanlıqla nümunə kimi göstərilir: hər bir hüceyrə eyni genetik plana malikdir, lakin onların funksiyaları fərqlidir. Sinir hüceyrəsi cinsi və ya hematopoetik funksiyaları yerinə yetirə bilməz, baxmayaraq ki, sonrakı inkişaf seçimi gələnə qədər bu potensiallar mövcud idi və bəlkə də mövcud olmağa davam edir, yalnız çox gizli formada, reallaşma potensialı olmadan. Onlar əsas proqram (genetik struktur) bədənə bütün hüceyrələrində eyni olduğundan mövcuddur.

Qərar qəbul etmə problemi xüsusilə sinir sisteminə aydın görünür. Sinir hüceyrəsinin quruluşu, hüceyrə bədənə siqnal ötürən çoxsaylı proseslərin (dendritlərin) və siqnal göndərən yalnız bir gedən prosesin (aksonun) olması səbəbindən onun müəyyən bir fəaliyyət növü üçün qərar qəbul etməsinin zəruriliyini göstərir. Sinir sisteminə gələn müxtəlif siqnalların təsiri altında o, öz reaksiyasını inkişaf etdirməlidir və yalnız ikisi var: "bəli" və ya "xeyr" (funksional potensialın görünməsi və ya olmaması). Bundan əlavə, lokal potensiallar yalnız sinir hüceyrəsinin daxil olan siqnala lokal reaksiyası ilə ortaya çıxıb bilər ki, bunlar funksional siqnallar kimi bütün sinir hüceyrəsini əhatə etmir. Onlar sinir hüceyrəsini son qərara (bəli və ya yox) hazırlayırlar, lakin qərarı özləri vermirlər. Eynilə, insan son qərara gəlməzdən əvvəl "bəli" və ya "xeyr" deməzdən əvvəl bütün müsbət və mənfi cəhətləri ölçüb-biçir. Sinir sisteminin işinə qərar qəbul etmə baxımından baxmaq olar ki, bu da başa düşüləndir, çünki sinir sistemi nəzarət rolunu oynayır və bu cür sistemlərin (texniki, bioloji və s.) işi...

Sosial qarşılıqlı əlaqə qərarlar və seçimlər qəbul etməkdən ibarətdir.

Hər bir qərar bir fəaliyyət ehtimalını qəbul etməkdən və ikincisini rədd etməkdən ibarətdir. Beləliklə, hər bir qərar sistemdəki imkanların azalmasıdır, çünki rədd edilmiş seçimin xaric edilməzdən əvvəlkindən daha az reallaşma ehtimalı var. Sonrakı hadisələr zənciri seçilmiş seçimin ehtimal xəttini izləyir. Sinir sistemində rədd edilmiş seçimlər məhv olmur; onlar bir şəkildə qeydə alınır və həmişə mövcudluqlarını bildirə bilirlər. Lakin, seçilmiş seçim təkrarlandıqca bu şanslar azalır.

İlk həyatda sürünmək və ya gəzmək problemi bütün zehni fəaliyyəti məşğul edirdi. Ayaq üstə durmaq üçün qərar vermək, ehtimal ki, səy tələb edirdi. Təkrarlama artdıqca seçim getdikcə asanlaşdı və müəyyən bir yaşda hərəkət tamamilə problem olmaqdan çıxdı. Lakin bu, rədd edilmiş formaya qayıtmağın mümkün olmadığı anlamına gəlmir; hətta yetkinlik dövründə belə sürünə bilər. Psixanalitik repressiya anlayışı məhz bu tərs fəaliyyət versiyasını ifadə edir. Atılan hər şey ölmür; bilinçaltıda yanır və tez-tez ciddi zehni pozğunluqlara səbəb olur.

Təkrarlama ilə qərar prosesi avtomatlaşdırılır və qərar şüurun həddinin kənarında ortaya çıxır. Əlbəttə ki, bu, qərarın heç vaxt yaranmadığı anlamına gəlmir.

Uşaqlıqdan qaşiq, bıçaq və çəngəl ilə yeməyə öyrəşmiş insan bu fəaliyyət haqqında düşünmür, lakin sinir sisteminin funksiyası bu proses üçün uyğun hərəkətləri seçməkdir. Canlı bir orqanizmi bir nəzarət sistemi, sinir sistemini isə xüsusi bir nəzarət funksiyasına malik bir orqanizmin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirərək, qərar qəbul etmə problemi yalnız bir şüurlu funksiya ilə məhdudlaşa bilməz, yəni iradə aktından asılıdır. Qərar qəbul etmə hər bir tənzimləmə sisteminin əsas funksiyasını təşkil edir. Şüurlu qərar bu funksiyanın yalnız çox kiçik, lakin vacib bir hissəsidir. Qərar prosesinin fərqi olmaq, yalnız qərar vacib olduqda, bütün bədəni, xüsusən də sinir sistemini əhatə etdikdə ortaya çıxır. Bir insanın hərəkətləri ilə bağlı qərarlar onun şüurundan kənarda yaranır, lakin uçuşun üstündən, diqqətsiz bir addım ölümə səbəb ola biləcəyi zaman bu funksiya yenidən şüurlu olur. Eynilə, süfrə davranışına xüsusi diqqət yetirən bir cəmiyyətdə bıçaq və çəngəl necə tutmağı düşünmək olar.

Təhsil prosesi əsasən bəzi davranış nümunələrini gücləndirməkdən və digərlərini yatırmaqdan, yəni qərarı şərtləndirməkdən və avtomatlaşdırmaqdan ibarətdir. Müəyyən bir təlimdən sonra bəzi funksiyalar avtomatik olaraq, başqa bir seçim seçimini təhlil etmədən yerinə yetirilir. Lakin rədd edilmiş seçimlər tamamilə yox olmur və müəyyən vəziyyətlərdə onlardan istifadə etmək olar, baxmayaraq ki, cəmiyyətdə bu cür uyğunsuz davranışı düşünən başqalarını təəccübləndirə bilirlər.

Anankastik məcburiyyət seçim mexanizminin zəifləməsindən ibarətdir. Xəstə mənasız bir hərəkət etmək ehtiyacı ilə bağlı obsesif düşüncədən əl çəkə bilmir və ya özlərini əsassız qorxudan azad edə bilmir. Onlar vəziyyətdən ilhamlanmamış hiss edirlər, davranışlarını sərbəst idarə edə və düşüncələrini tənzimləyə bilmirlər. Onlar hiss edirlər ki, içərilərində bir şey gizləni, seçim azadlığını iflic edir. Bəzən anankastik təcrübənin məzmunu, bu meylin xəstənin psixikasında iyləndiyini, lakin qəti şəkildə rədd edildiyini və indi sanki qisas alaraq özlərini atmalarının qarşısını aldığı düşünməyə imkan verir.

Cinsi və ya aqressiv təbiətli obsesif düşüncələr, böyük ölçüdə imkan verir

Çox güman ki, bu cür təfsir bu cür düşüncələrin mənbəyi olacaq. Sevilən birini öldürmək, dini əşyaları təhqir etmək və sair kimi düşüncələr obsesif düşüncələrə çevrilməzdən əvvəl insanın içində dərin bir şəkildə basdırılmış, atılmış davranış seçimləri kimi. Obsesif-kompulsiv pozğunluğu olan insanlar tez-tez qərar verməkdə çətinlik çəkən şəxsiyyət tipinə və buna görə də obsesif şəxsiyyətə sahib olurlar. Uşaqlıqdan bəri onlar müxtəlif normalara bağlı, qərar qəbul edə bilməyən təəssürat yaradırlar, çünki onların əsl istəkləri və arzuları həmişə öhdəlik hissi ilə boğulur. Qərar qəbul etmə məsələsi ən çətinidir, çünki psixastenik şəxsiyyətlər üçün qətiyyətsizliyi və əbədi "bunu necə etmək"; "bəli və ya yox deyin" ilə. Körpə şəxsiyyətlər ətraf mühitlə, inkişafın erkən dövrünə xas olan bir münasibət, tam asılılığa əsaslanan ağa və qul arasında bir münasibət inkişaf etdiriblər - biri digəri olmadan yaşaya bilməz. Bu münasibət azadlıq istəyindən qaynaqlanan bir üsyana, bu azadlığın həqiqətən baş verməsi üçün hələ çox zəif olduğu üçün heç bir nəticə verməyən bir üsyana səbəb olur. Hər bir üsyan cəhdi uğursuzluqla və daha da böyük asılıqla başa çatır və sonra tamamilə aydın olur ki, digər insan olmadan həyat qeyri-mümkündür. Simbiotik münasibətin qapalı dairəsi məhz ondan qurtulmaq üçün edilən bütün cəhdlərin daha böyük asılıqla başa çatmasıdır.

Hər şeyin asılı olduğu insanla emosional əlaqə həmişə ikili olur;

müsbət hisslər mənfi hisslərlə iç-içə keçir; basdırılmış hisslər

anankastik simptomlar şəklində görünə bilər.

Şizofreniyada, xüsusən də kəskin fazanın əvvəlində və sonunda,

müxtəlif növ obsesif-kompulsiv simptomlara rast gəlinir. Onlar həmçinin

qərar qəbul etmə və seçim prosesində pozğunluğu əks etdirə bilər ki, bu da bu xəstəlikdə

bifurkasiyaya məruz qalır.

// "QORXUN KRİSTALLAŞMASI"

Qorxunun kristallaşması onun obsessiya mövzusu ilə əlaqəli bir vəziyyətlə məhdudlaşdırılmasından ibarətdir. Bu, fobiyalarda daha aydın görünür: müəyyən bir vəziyyət

qorxu doğurur, lakin bu fenomen obsesif hərəkətlər və düşüncələrlə baş verir və

hər ikisi adətən qorxu hissi ilə müşayiət olunur. Xəstə obsesif hərəkətlərindən və fobiyalarından qorxur; onlardan qurtulmaq istəyirlər. Onlar düşüncələrinin əsas mövzusunə çevrilir və bu da öz növbəsində onların sayını artırır. Bu hallarda,

ümumi prinsip təsdiqlənir: bir şeydən nə qədər çox qorxsaq, onunla üzləşmək bir o qədər asan olur.

Bəzən anankastik mövzuların genezisini izləmək mümkündür və sonra obsessiya simptomları ilə müşayiət olunan qorxu şərti görünür (məsələn, uşağı qaranlıq otağa bağlamaqdan qaynaqlanan klaustrofobiya). Lakin, əksər hallarda qorxu bizim üçün tamamilə mənasız və hər halda qeyri-mütənasib görünür (məsələn, niyə siçanlardan, müəyyən əşyalara toxunmaqdan qorxmalı, əgər anankastik ritualın müəyyən hərəkətləri yerinə yetirilməyibsə, niyə panikaya düşməli və s.).

Qorxunun kristallaşması, hətta genezisinin müəyyən dərəcədə haqlı olduğu hallarda belə, məsələn, siçan qorxusundan belə, onun məzmununun şişirdilməsinə gətirib çıxarır. Adi nevroitik qorxuda bu qorxunun altında yatan müxtəlif səbəblər tapıla bilər (sinir narahatlığı müxtəlif həyat çətinlikləri və münasibətlərlə, kəskin qorxu hücumu isə xəstəni panik vəziyyətinə salan vegetativ pozğunluqlarla izah edilə bilər). Obsesif-kompulsiv nevrozda qorxu, adətən, doğurduğu hisslərlə qeyri-mütənasib bir vəziyyətdə yaranır. Buna görə də, belə bir vəziyyət qorxunun əhəmiyyətli bir səbəbi ola bilməz. Qorxunun anankastik kristallaşması emosional vəziyyətdə səbəbiyyət hissinə yönəldilir.

vəziyyətlər. Bu hallarda səbəb reaksiya ilə o qədər qeyri-mütənəssibdir ki, xəstə də daxil olmaqla hər kəs səbəbi belə bir reaksiya üçün çox əhəmiyyətsiz bir hal kimi qiymətləndirir, əsl səbəb isə tanınmamış qalır və başqa yerdədir.

İnsanların səbəb düşüncəsinə meyli tez-tez verilən suala gətirib çıxarır:

"Nədən qorxursunuz? Niyə kədərli, qəzəbli və s.siniz?" Bu suallar səbəb-nəticə əlaqəsi ilə emosional vəziyyətləri təyin etməyə yönəlib.

Bu cavab doğrudurmu? Yoxsa əsas səbəb sadəcə obsesif-kompulsiv pozğunluqda olduğu kimi, müəyyən bir affektiv vəziyyətin əlaqəli olduğu görünüş ola bilərmi?

Kütləvi qorxu və nifrət fenomenləri müharibə dövründə müşahidə olunur; onlar insanlarda emosional gərginliyi aradan qaldırmaq üçün gizli potensialı göstərir.

Bir-birini tanıyan iki insan, ortaq maraqları və mənəvi keyfiyyətləri səbəbindən yaxşı dost ola bilərlər, lakin sadəcə formalarının kəsimi və ya dərilərinin rəngi fərqli olduğu üçün barışmaz düşmənə çevrilirlər. Qadınların gizli qorxu və ikrah hissi siçanlarda cəmləşdiyi kimi, normal şəraitdə ifrazı çətin olan bütün mənfi hisslər də siçanlarda cəmləşib. Burada əsas məsələ hiss və obyekt arasındakı faktiki və ya zahiri əlaqəni qiymətləndirməkdir. Yeri gəlmişkən, bu məsələnin xalq ənənələrində (sehrli otların təsiri altında hissin dəyişməsi) zəngin bir tarixi var və ədəbiyyatda bu, Şekspir tərəfindən "Yay gecəsinin yuxusu" komediyasında ən aydın şəkildə təmsil olunur. // SEHİRLİ DÜŞÜNCƏ

Obsessiv-kompulsiv nevrozda sehrli düşüncə, xəstənin yaxınlaşan təhlükə qarşısında müəyyən fəaliyyət formalarının qoruyucu funksiyasına inamında özünü göstərir. Bu formaların pozulması və ya yerinə yetirilməməsi güclü qorxu hissi yaradır.

Artıq qeyd edildiyi kimi, xəstə əllərini müəyyən sayda dəfə yuyur və ya işə getmək üçün müəyyən küçələrdə gəzir, ya da ciddi şəkildə müəyyən edilmiş qaydada geyinir və soyunur və s. Sehrli düşüncə obsessiv hərəkətlərdə daha çox özünü göstərir, lakin müəyyən xüsusiyyətlər obsessiv düşüncələrdə və fobiyalarda da müşahidə edilə bilər. İradə gücü ilə aradan qaldırıla bilməyən yad, irrasional bir hissin xəstənin şüurunu ələ keçirməsi və onu sehrli düşüncə tərzinə meyl etməsi. Bu hallarda ənənəvi vasitələr təsirsizdir və xəstənin anlayışında yalnız sehr qalır.

// DÖVRƏT

Dövr və ya xarici aləmdən gələn stimullardan asılı olmayaraq eyni fəaliyyət modelinin təkrarlanması anankastik simptomların əhəmiyyətli bir xüsusiyyətidir. Xəstənin əzabı obsesif düşüncələrin və xəstənin dayandırıla bilmədiyi stereotipik hərəkətlərin daimi təkrarlanmasından qaynaqlanır.

Neyrofizioloji səviyyədə dözümlülük sinir sisteminin fəaliyyətinin fundamental elementidir. Hər bir hüceyrənin kortəbii şəkildə boşalma qabiliyyəti var,

bu siqnallar digər sinir hüceyrələrindən və ya reseptorlardan gələn siqnallar tərəfindən basdırılır. Hüceyrənin dözümlülüyə gizli meyli olduğunu demək olar.

Bundan əlavə, neyronlar arasındakı spesifik əlaqələrə görə (bu, əsasən sözdə "qapalı dövrlərə" aiddir), onlarda yaranan fəaliyyət nümunələri nəzəri olaraq qeyri-müəyyən müddətə və praktikada təkrarlana bilər.

Növbəti siqnal axını perseverativ fəaliyyəti pozur. Perseverasiya sayəsində reseptora gələn, bəzən saniyənin bir hissəsinin bir hissəsindən az müddətə davam edən siqnal gecikdirilə və bununla da sinir sistemində möhkəmlənə bilər (yaddaş qeydinin inkişafı). Perseverasiya sinir sisteminin ümumi fəaliyyətində özünü göstərmir, çünki ona və yeni yaranan funksional strukturlara (neyron nümunələrinə) daim daxil olan siqnal axınları müdaxilə edir.

Lakin müəyyən şərtlər altında sinir sisteminin antiperseverativ meyli, yeni funksional strukturların daimi formalaşması üçün demək olar ki, limitsiz potensialdan irəli gəlir, gecikir və sonra sinir sisteminin ümumi fəaliyyətində özünü göstərən perseverativ meyllər normal olaraq yatırılır.

Perseverativ meyllərin yayılmasının klassik nümunəsi epilepsiyadır. Bu vəziyyətdə müəyyən bir sinir hüceyrələri qrupunun (epileptoid fokus) spontan, perseverativ ritmi digər sinir hüceyrələrini və nəticədə bütün sinir sistemini əhatə edir. Davranış və təcrübə səviyyəsində epilepsiyada perseverasiya eyni tutma nümunələrinin, auraların, avtomatizmlərin və s. təkrarlanmasında özünü göstərir. Kəskin və xroniki psixozlarda tez-tez perseverativ davranış və təcrübələr - eyni ifadələrin, hərəkətlərin və üz ifadələrinin təkrarlanması müşahidə olunur. Sinir sisteminin zədələnməsi müxtəlif funksional strukturlar yaratmaq qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Beləliklə, perseverativ meyllər antiperseverativ meylləri üstələyir. Oxşar bir təmkin yuxu və yarıyuxu zamanı, eləcə də güclü emosional stress vəziyyətlərində özünü göstərir. Bundan əlavə, perseverasiyaya bənzər davranış və təcrübələr də müşahidə edilə bilər (məsələn, əsəbi olduqda, insan eyni sözləri və ya hərəkətləri dəfələrlə təkrarlayır). Perseverativ komponent anankastik simptomların yaranmasında mühüm rol oynayır.

Bəzən bu simptomlar mərkəzi sinir sistemində üzvi ziyan nəticəsində (məsələn, beyin iltihabından sonrakı vəziyyətlərdə) ortaya çıxır. Çox vaxt, obsesif-kompulsiv pozğunluğun təmiz hallarında mərkəzi sinir sistemində kiçik ziyan əlamətləri aşkar edilə bilər. Obsesif-kompulsiv pozğunluqda genetik amilin artan perseverativ meyl vasitəsilə təsir göstərməsi mümkündür.

DEPRESSİV NEVROZ

// NEVROTİK VƏ DAVRA (ENDOGEN) DEPRESSİYA

Hər bir nevroz əzab və əhval-ruhiyyənin aşağı olması ilə müşayiət olunur. Hər şey sizi qıcıqlandırdıqda, daim yorğun hiss etdikdə, bədəniniz ağrıdıqda və daimi daxili gərginlik və narahatlıqla üzləşdikdə, pis düşüncələr, fobiya və bu kimi şeylər sizi təqib etdikdə tarazlığı qorumaq çətinidir. Buna görə də, depresif nevrozu ayrı bir nozoloji varlıq kimi təcrid etmək əsassız görünə bilər. Buna baxmayaraq,

xüsusilə indiki dövrdə əhval-ruhiyyənin azalması nəzərə qarpan nevrozlar çox yaygındır. Məhz bunlar üçün "depresif nevrozlar" termini istifadə edilə bilər. Depressiv nevroz tez-tez diaqnostik çətinliklər yaradır, çünki onu siklofreniya depressiv fazasının daha yüngül formalarından ayırmaq o qədər də asan deyil. Hər iki halda kədər və donmuş duruş eyni ola bilər. Nevrozun daha ətraflı müayinəsi adətən uzunmüddətli emosional stressə səbəb olan münaqişə vəziyyətlərini aşkar edə bilər ki, bu da

Səbəb amilləri. Lakin, endogen mənşəli depressiyada (siklofreniya) müxtəlif münəqişə vəziyyətlərinə də rast gəlinə bilər, çünki çox aşağı əhval-ruhiyyə gündəlik anlaşılmazlıqlara və münəqişələrə səbəb olur, həll olunmaz problemlər yaradır və depressiyanın səbəbləri ilə səhv salına bilər.

Təkrarlanan depressiya tutmaları hallarında diaqnostik çətinliklər azalır və

sonra siklofreniya diaqnozu qəbul etmək daha asandır. Lakin təkrarlanma argumenti nevrozu istisna etmir. Nevrozlarda müəyyən bir endogen elementi var və bu da nevrotik simptomların müəyyən bir spontan təkrarlanmasına səbəb olur. Bu aspekt terapevtik müdaxilələri qiymətləndirərkən olduqca əhəmiyyətlidir, çünki spontan remissiya bəzən terapevtik nəticə kimi qiymətləndirilə bilər.

Endogen depressiya ağır simptomlar aradan qaldırıldıqdan sonra depressiv nevrozdan ən asan fərqləndirilir. Daha sonra, depressiyalı bir insan bizə şəxsiyyət təhrifləri və ya nevrotik münəqişələr olmadan "təmizlənmiş" kimi görünür, nevrotik bir xəstə isə problemlərindən və daxili münəqişələrindən azad deyil, baxmayaraq ki, onlar artıq real nevrotik amillər olmaqdan çıxıblar.

Psixopatoloji analiz bəzən nevrotik depressiyanı dairəvi depressiyadan fərqləndirməyə imkan verir. Birincisində, depressiv əhval-ruhiyyə müxtəlif münəqişələrdə, kin, günahkarlıq hisslərində, yerinə yetirilməmiş arzularda,

başqalarına və özünə qarşı düşmənçilikdə ikinci dərəcəli amildir. İkincisində, depressiv əhval-ruhiyyə ilkindir və yalnız bundan günahkarlıq, özünə və başqalarına qarşı təcavüz, gələcəyə qayğı və s. şəklində müxtəlif emosional əhval-ruhiyyələr inkişaf edir. Lakin ilkin və ikinci dərəcəli arasında fərq qoymaq çətin bir işdir.

Digər nevrotik simptomların olması daha çox nevrozu göstərir. Bununla belə, endogen depressiyanın hipoxondriakal, anankastik, nevrastenik və hətta isterik simptomlarla gizlənməsi mümkündür.

Bu diaqnostik çətinliklər adətən hər iki depressiya formasında (nevrotik və endogen) o qədər də böyük deyil ki, onları klinik praktikada ayırd etmək mümkün olmasın və buna görə də uzun illərdə psixiatriyada məcburi olan nozoloji təsnifat uyğun deyil. Bu məlumatlara diqqət yetirildikdə, ilk növbədə kiçik və böyük psixiatriya (siklofreniya endogen psixozdur) arasındakı sərhədin həmişə kəskin olmadığını və endogen psixozlar qrupuna xas olan endogenliyin komponentinin müəyyən dərəcədə nevrozlarda da mövcud olduğunu vurğulamaq lazımdır. Nevrotik və endogen depressiya arasında diferensial diaqnozu asanlaşdırmağın bir yolu xəstəyə qarşı öz emosional reaksiyalarını qiymətləndirmək ola bilər. Endogen depressiya hallarında xəstə həmişə rəğbət bəsləyir; onların kədərini və ümitsizliyini asanlıqla başa düşmək olar. Xəstədə bu hisslərin mənbəyi məlum olmasa da, onlar bizə toxunur. Depressiv nevrozda xəstə ilə sintoniya (emosional uyğunluq) nadirdir. Nevrotik xəstə, bir qayda olaraq, xüsusilə müsbət olmayan psixotik xəstəyə nisbətən mühakimə yolu ilə daha asan oya bilər. Onların dünyaya və özlərinə qarşı tələbləri, əsassız kin hissləri, gizli nifrət hissləri, narazı ego və s. qıcıqlandırıcıdır. Xəstənin əzablarına şəfqət göstərmək üçün bu mühakimə yürütmə tərzini aradan qaldırmaq lazımdır.

Bu qarışıq hisslər psixotik vəziyyətləri qiymətləndirərkən adətən olmur. Psixozu olanlar, sanki, "psixotik" olduqları üçün qiymətləndirmədən azaddırlar. Onlar xəstəlikdən "təsirlənirlər", nevrotik əzablar isə müxtəlif növ zərərli emosional vəziyyətlərin nəticəsi və buna görə də "günahlara görə cəza" kimi qiymətləndirilir. Psixotik təcrübələr adi bir insanın təcrübələrindən tamamilə fərqli olduqda, tamamilə yadlaşdıqda, onların qiymətləndirilməsi çox çətin, bəlkə də qeyri-mümkündür (çox vaxt şizofreniya və psixozvi sindromlarda olduğu kimi). Siklofreniya zamanı, xüsusən də ləng proseslərlə, sözdə zehni norma ilə patologiya arasındakı sərhəd xüsusilə kəskin deyil. Buna görə də, siklofrenik özünü müəyyən dərəcədə imtiyazlı vəziyyətdə tapır. O, mühakimə olunmadan başa düşülür. Bundan əlavə, onun konstitusiyaya təbiətinin aspektləri başa düşülür. Kretschmer tərəfindən ilk dəfə qeyd edildiyi kimi, konstitusiyaya sintoniyası tez-tez siklofreniklərdə olur. // BASILMIŞ AQRESİYA

Nevrotik kədər tez-tez gizli aqressiya ilə birləşir. Bu aqressiya müxtəlif səbəblərdən, məsələn, kin, günahkarlıq və ya despotik xarakter ifadə edə bilməməkdən qaynaqlana bilər. Sual yaranır: basdırılmış aqressiya niyə əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsinə səbəb olur? Emosiyalar xaricə yönəlmiş bir vektor kimi təmsil oluna bilər, lakin bu əsas istiqamətə əlavə olaraq, daxilə yönəlmiş bir ox var. Sevdığımız zaman özümüzü də sevirik; nifrət etdiyimiz zaman özümüzdən nifrət edirik. Təcrübələrimizdə ətraf aləmi təşkil edən şeylə özümüzü təşkil edən şey arasındakı sərhəd o qədər də fərqli deyil ki, bu iki dünyanın rəngləri əksinə olsun. Müsbət hisslər üçün işıq, mənfi hisslər üçün isə qaranlıqdır.

Mənfi hisslər, hazırda hərəkətə və ya əksinə gətirib çıxarmasından asılı olmayaraq, bədənə mübarizə aparmaq və ya qaçmaq üçün əhəmiyyətli dərəcədə səfərbər olması ilə əlaqələndirilir. Bu, bir insanın ağılında olan hər şeyi söylədikdə və ya qəzəbini cansız əşyalara tökdükdə yaranan məlum rahatlama hissidir.

Lakin aqressiyanı buraxmaq mənfi emosiyalar üçün zəif bir müalicədir. Adətən, qapalı bir dairə yaranır. Təcavüz aktından sonra günahkarlıq və özündən narazılıq hissləri oyanır ki, bu da nifrət obyektinə qarşı aqressiya hissini daha da alovlandırır, çünki bütün acı hisslərin səbəbi məhz bu obyekt olur.

Davamlı şikayətlər daimi daxili gərginlik yaradır ki, bu da fizioloji baxımdan bədənə vegetativ və endokrin

səfərbərliyi ilə izah edilə bilər. Bu vəziyyət xoşagəlməz deyil və məhz bu, əsasən nevrotik depressiyaya gətirib çıxarır.

// EMOSİONAL YÜK

Nevrozlarda, uşaqlıqdan bəri tez-tez mövcud olan gizli nifrət və ya kin hissləri tez-tez kədər pərdəsi altında gizlənir. Psixoloji mexanizmə əsaslanan bu hisslər, mövcud vəziyyət köhnə travmatik hadisələri bir az belə xatırlatdıqda yenidən canlanır. Beləliklə, cəza qorxusu səbəbindən yatırılmalı olan həddindən artıq sərt ataya qarşı mənfi hisslər,

məsələn, beləliklə, ata fiquruna çevrilən bir müdirə qarşı eyni qüvvə ilə qayıdır. Subyektiv olaraq həssas olmayan və qayğıkeş olan bir anaya qarşı kin, o zamanlarda qayıdır.

İnsan ətrafı tərəfindən rədd edildiyini hiss etdiyi hallarda, sanki uşaqlıqda bu çatışmazlığı kompensasiya etmək üçün ətrafdakılardan ana istiliyi axtarır. Bunu tapa bilmədikdə, kədərli bir əhval-ruhiyyəyə düşür və bunun əsasında ətrafına qarşı mənfi hisslər yatır. Ailədə dominant mövqeyə öyrəşmiş uşaq, çoxdan uşaqlıqdan çıxsa da, özünü imtiyazsız vəziyyətdə tapdıqda inciyir. Bu şəkildə, insan emosional reaksiyalarında keçmişin yükünü daşıyır və bu yük nəticəsində mövcud vəziyyətlə uyğunsuz görünə bilər. Pavlova görə, ontogenetik baxımdan emosional reaksiyalar idrak və ya manipulyativ reaksiyalardan daha qədimdir, bunun nəticəsində yaranan refleksiv əlaqələr daha güclü və daha daimi olur.

Digər stereotiplərlə müqayisədə dinamik emosional stereotip ən az dəyişkəndir.

Nevrotik, depressiv əhval-ruhiyyənin altında özünə ən yaxın olanlara qarşı düşmənçilik hissləri, nifrət, ikrah, kin və nifrət tapmaq olar. Lakin, əsas amili qiymətləndirərkən və ətraf mühitə qarşı mənfi emosional vəziyyəti depressiv əhval-ruhiyyədən ayırd edərkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Depressiv əhval-ruhiyyə tez-tez başqalarına qarşı qorxu və ya təcavüz hissləri ilə yanaşı mövcuddur. Amerikalı psixiatrlar bu faktı xüsusilə vurğulayırlar, çünki bu, onların tətbiq etdiyi davranış nümunələrindən, yəni "gülümsəməyə davam et" - "Kədərli olan sosial cəhətdən qınanır və buna görə də sadəcə pisdir!"-dən qaynaqlana bilər.

// DUYĞULARIN KONSENTRASIYASI VƏ ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏSİ

Başqa bir insanla sıx təmas həmişə emosional konsentrasiyaya və emosional amplitudanın artmasına gətirib çıxarır. Bu, demək olar ki, həmişə müəyyən bir emosional ambivalensiyaya, məsəl kimi "sevgi-nifrət" dioxotomiyasına gətirib çıxarır.

Patologiya emosional vəziyyət mənfi qütbə möhkəmləndikdə başlayır. Daimi, sıx təmasda olan insan davamlı mənfi emosiyalara dözə bilmir. Hətta cəlladla qurban arasında belə, onlar sıx əlaqədə olmağa məcbur edildikdə, qarşılıqlı, spesifik rəğbət ipi yaranır.

Birinə daim nifrət etmək mümkün deyil, çünki belə bir vəziyyət bədənin mübarizə üçün çox uzun müddətli səfərbərliyini yaradır; Daimi daxili gərginlik, nəticədə yorğunluğa və güc itkisinə gətirib çıxarır. Duyğular ümumiləşir; Sevilən birindən nifrət etməklə bütün dünyadan nifrət etmək olar. Artıq qeyd edildiyi kimi, duyğuların eyni adlı iki vektor oxu var: xarici və daxili. Yaxın birindən nifrət edərkən, özündən də nifrət etməyə başlayır. Bu səbəblər, dərin mənfi hisslər bəsləyən bir insanın əhval-ruhiyyəsinin aşağı düşməsi üçün kifayətdir.

// KİNİŞ VƏ GÜNAHKARLIQ HISSLƏRİ

Başqalarına və özünə qarşı mənfi emosional münasibətin ümumi səbəbi, kin və günahkarlıq hissidir. Başqa bir insan tərəfindən incik hiss edən bir insan, bir qayda olaraq, mənfi hisslərini yalnız incidən şəxsə məhdudlaşdırmır, əksinə, onları ümumiləşdirmə yolu ilə ətrafdakı hər kəsə yayır və hər kəsdən incimiş hiss edir.

Günahkarlıq hisslərində mənfi emosiyalar əsasən daşıyıcısına qarşı yönəlir.

Lakin tezliklə onların xarici əks olunması baş verir. Nəticədə, incimiş insan özünü hər kəsə daha qara rəngdə təqdim edir və nəticədə özünəinam yetkinləşir.

Cinayətkar ona verilən təhqirə tam layiq olduğuna əmindir. Üstəlik, təhqir olunmuş şəxsin həqiqətən də cinayətkarın əzablarına görə günahkar olduğu təəssüratı yaranır. Günahkarlıq və kin-küdurət bir-biri ilə sıx bağlıdır. Həmçinin, günahkarlıqda ümumiləşdirmə meylli var; bu hissdən təsirlənən şəxs özünü daim təqsirləndirilən şəxs mövqeyində tapır. Kin-küdurətdə bütün dünya günahlandırılır; günahkarlıqda isə bütün dünya ittiham olunur. Hər iki emosional vəziyyətdə ədalətli ata modelləşdirilmiş dünya anlayışları tapmaq olar. Kin-küdurətdə bu ideal konsepsiya ilə razılaşmayan hər kəsə qarşı üsyan var və günahkarlıqda isə "ədalətli" dünyanın hökmünü istəksiz olsa da qəbul etmək var. Kin-küdurət daha çox isterik şəxsiyyət xüsusiyyətləri olan insanlarda, günahkarlıq isə psixastenik xüsusiyyətlərə malik insanlarda daha çox rast gəlinir. Birincilər başqalarının mühakiməsindən yuxarı qalxmaq istəyirlər, ikincilər isə bundan əziyyət çəkirlər. Lakin heç biri özünüqiymətləndirmə miqyasını tapmayıb və buna görə də hər iki şəxsiyyət növü yetkinlik yaşına çatmamış kimi qiymətləndirilməlidir.

/ DESPOTİK ŞƏXSİYYƏT

Başqalarına qarşı aqressiya, despotik davranış tərzindən yaranan məyusluqdan yarana bilər. Onun mexanizmi aşağıdakı kimi ola bilər. Dünya

istədiyimiz kimi deyil. Tələblərimizi yerinə yetirmir, bir çox niyyət və planlarımızı reallaşdırmağa imkan vermir; dünya müqavimət göstərir. Buna görə də, o, pisdir və

məhv olmağa məruz qalır. Yaxın münasibətdə olmalı olduğumuz insan

bizə şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə cavab vermir; biz onları dəyişdirmək istəyirik və əgər bu uğursuz olarsa, onda daxili aqressiyaya səbəb olur. Və aqressiyanın son mərhələsi yalnız

məhv ola bilər. Ailə nevrozlarında, yəni həyat yoldaşının patoloji həyat tərzindən qaynaqlanan disfunksional münasibətlərdə depressiv komponent tez-tez ön plana çıxır. Həyat yoldaşı olmalı olduğu kim deyil, evlilikdən əvvəl özlərini təsəvvür etdikləri kim deyil; dəyişiklik cəhdləri anlaşılmazlıq və inamsızlıqla qarşılanır və nəticədə basdırılmış aqressiya hissi qalır.

Hər bir insana xas olan yaradıcı impulsları, ətraf mühiti "yaradıcının surətində və bənzərliyində" dəyişdirmək istəyini reallaşdırmağa çalışarkən başqalarının qarşılaşdığı müqavimət də aqressiv hisslər oyadır. Bu hisslər insanın öz acizliyini ortaya qoyur və insanın özünüdərk etməsinə mane olan dünya yad, boz və hətta düşmən olur. Bu, sivilizasiyamızın kədərli reallığının problemidir, bu, böyük nailiyyətlərinə baxmayaraq, digər şeylərlə yanaşı, insan məmnuniyyətini təmin edə bilmir, çünki qeyri-adi dərəcədə mürəkkəb istehsal prosesi və nəticədə mürəkkəb sosial münasibətlər nəticəsində öz planlarını reallaşdırmaq üçün edilən hər bir cəhd müqavimətlə qarşılaşır.

Digər tərəfdən, ünsiyyət və informasiyanın inkişafı sayəsində tələblərin səviyyəsi artır.

Despotik davranış mahiyyət etibarilə körpəlik davranışdır.

Körpənin istəkləri yerinə yetirilmədikdə, o, qışqırır, ağlayır və motor həyəcanı ilə reaksiya verir və əgər bu baş verməzsə, az-çox uzun müddət ərzində o, apatiya və demensiya vəziyyətinə düşür ki, bu da - əgər insan bu inkişaf dövrünün təcrübələri haqqında məlumat əldə edə bilsəydi - depressiya vəziyyətinə uyğun gələrdi. Şəxsiyyət inkişaf etdikcə, despotik nisbət zəifləyir, çünki başqaları ilə təmaslar müəyyən istəklərdən imtina etmək və müəyyən həyat şəraitində digər, daha təsirli istəkləri gerçəkləşdirməyə çalışmaq ehtiyacını öyrədir. Despotik rejimdən məyusluq nəticəsində yaranan depresif vəziyyətdə olan insan

davranış, körpə despotizmini saxlayır və gəncliyin dinamizmini və elastikliyi boşa çıxarır ki, bu da planların aktiv şəkildə dəyişməsinə imkan verir. Eyni tip depresif nevroz tez-tez yaşlı insanlarda rast gəlinir, onlar üçün hər şey istədikləri kimi deyil;

ətrafındakı dünya qıcıqlandırır və ehtiyaclarını ödəmir. Onlar gənc insanlardan

dəyişən həyat şərtlərinə uyğunlaşmaqda daha çətinlik çəkirlər.

// RƏDD ETMƏ

İnsan həyatı boyu imtina sənətini öyrənir. Lakin, uzun müddətdir mövcud olan elmə baxmayaraq, imtina özünü tam şəkildə bürüzə verir. Adətən, "İstəyirəm" və "Bacarıram" arasındakı uyğunsuzluq üsyan qalıqları, kin hissi və özündən və hər kəsdən narazılıq qoyur. Kədər imtinanın nəticəsi ola bilər. Bir şeydən sakitcə imtina etmək çox nadir bir fenomendir

və dərin müdriklik tələb edir.

Məğlubiyyətlərinizi sakitcə qəbul etmək üçün özünü və ətrafınızdakılara real baxmağı öyrənməlisiniz. Uşaqlıqdan uduzmağı ("ingilislərin dediyi kimi, yaxşı

uduzan olmaq") öyrənməlisiniz.

// "KİM SEVMİR, ÖLÜMDƏKİ SAKİNLƏR"

Kədər rəngi boz rəngdədir. Ətrafdakı hər şey boz, boş və maraqsız olur. Həyatın bozluğu və boşluğu əhval-ruhiyyənin aşağı olmasından irəli gəlir və bu, əksinə də ola bilər - həyatın boşluğu depressiyaya gətirib çıxarır. Ətraf aləmin rəngi ona qarşı emosional münasibətinizdən asılıdır. Aşiq olanlar üçün dünya gözəl, parlaq və

sevincli olur. Qorxu və ya nifrət içində yaşayan biri üçün dünya duyğunun gücündən asılı olaraq dar, tutqun, təhdidedici və

rəngsizdir. Şüalanma qanununa görə, bir insana yönəlmiş emosiyalar hər kəsə və hər şeyə şüalanır. Bir insanı sevmək bütün dünyanı sevmək deməkdir, nifrət etmək isə ətrafınızdakı hər kəsə və hər şeyə yanaşı özünü nifrət etmək deməkdir. Uzunmüddətli depresif nevrozları olan insanlar var; onlar üçün dünya boz və kədərli və özləri də eyni dərəcədə tutqun görünürlər. Onların həyat hekayəsi faciəli bir emosional boşluğu ortaya qoyur: onlar heç kimi sevmirlər. Bəzən, illərlə təsirsiz müalicədən sonra, birdən sevincli və həyat dolu tapıla bilərlər; Məlum olur ki, onlar sevgi və qayğı obyektini tapıblar - bəzən sadəcə kiçik bir it.

Ən dramatik formasında boşluq depressiyası sevilən birinin ölümündən sonra baş verir.

Ölümün yaratdığı ilkin şok azaldıqda, öz ətrafında ümitsiz bir boşluq yaranır ki, bu da zamanla yeni emosional əlaqələrlə doldurula bilər, lakin bəzən ömürlük davam edir. Görünür, müalicənin uğuru əsasən xəstənin başqalarına qarşı müsbət münasibətinin təzahüründən asılıdır.

// AVTOAQRESİYA

Xəstənin problemlərini anlamaq bizə depressiv nevrozun yaranmasına yanaşmağa imkan verir. Adətən, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ətrafınızdakılara və eyni zamanda özünü qarşı kök salmış mənfi münasibətlə qarşılaşırıq. Bu mənfi əlamət həmişə emosiyaları iki istiqamətə - xaricə və daxilə yönəldir. Əsas məqsəd çevrilən mənfi hisslər obyektinin məhv edilməsi daxildən və xaricdən, yəni təcavüz və ya autoaqressiya yolu ilə həyata keçirilə bilər. "Anama kin bəsləmək, qulaqlarımı donduracağam" atalar sözü yalnız uşaqlara aid deyil. Mənfi hisslərini başqalarına tökə bilməyən böyüklər də özlərinə tökürlər. Avtoaqressiya özünü aşağıdakılarda göstərir:

İntihar və özünə zərər vermək şəklində. Lakin nadir hallarda mənfi emosiyalar son məqsədlərinə gətirib çıxarır. Ölüm adətən kiçik dəyişikliklərə - özünə və başqalarına əzab verməyə sərf olunur. Əgər mənfi emosiyaların son məqsədi məhv olmaq, ölümdürsə, müsbət emosiyaların ekvivalenti yaradılış və ətrafdakı dünya ilə cinsi əlaqədə birləşməkdir. Bu, mədəniyyətin ölməzliyini və növün həyatını qorumaqla ölümə qarşı durmağın yeganə yoludur.

Fromm düzgün olaraq vurğulayır ki, insanlarda hər iki emosional vəziyyət təbiətcə transsendentaldır. İnsanlar əsas emosional vəziyyətlərin reallaşmasının heyvani konkretliyini aşırırlar. Yalnız insanlar məhv etmək naminə məhv edir və yaradılış naminə yaradırlar. Onlar ölməzliyə sevginin, yəni yaradılışın, eləcə də nifrətin, yəni Məhv etmənin reallaşması vasitəsilə nail olurlar (demək lazımdır ki, bu günə qədər tarix bu ikinci emosional vəziyyətin reallaşmasına daha çox yer ayırıb). Heyvanlar insanlardan daha "əxlaqlıdirlar"; Onlar öldürmək və əzab vermək naminə öldürmələr və ya işgəncə vermirlər, eyni zamanda mədəniyyət yaratmırlar, çünki onlar yaradılış naminə yaratmağa qadir deyillər. Görünür, insanlar heç vaxt özlərini qorxu və nifrət kimi mənfi emosiyalarından azad edə bilməyəcəklər ki, bu da sonda ölümə aparır. Texnoloji sivilizasiya məhv olmaq üçün o qədər böyük imkanlar yaratmışdır ki, insanlar mənfi emosiyalarını reallaşdırmaq təhlükəsindən qorxurlar.

Məhv yolu ilə ölümsüzlük axtarışı tam dəliliyə çevrilir.

QORXU

// NEVROTİK QORXUNUN FORMALARI

Nevrozun əsas simptomları bunlardır: qorxu, vegetativ disfunksiya, eqosentrizm və nevrotik "qəddar dairə".

Qorxu insan təcrübəsində mühüm rol oynayır və buna görə də təcrübələrin sözdə normanı aşması və qorxunun daha tez-tez və artan intensivliklə ortaya çıxması təəccüblü deyil. Qorxu müxtəlif ruhi sağlamlıq simptomları ilə ön plana çıxır və buna görə də qorxu nevrozların patognomonikliyi deyil. Lakin qorxu hər nevrozda özünü göstərir və digər simptomlar üçün bir növ kristallaşma nöqtəsi əmələ gətirir.

Nevrozlarda qorxunun forması və intensivliyi müxtəlifdir. Nevrotik qorxu ən çox aşağıdakı formalarda özünü göstərir: 1) daimi (qeyri-müəyyən narahatlıq), 2) paroksizmal (ağır vegetativ pozğunluqlarla müşayiət olunan qorxu paroksizmləri, tez-tez ölüm və ya zehni xəstəlik qorxusu ilə müşayiət olunur) və 3) lokal (qorxu hissi bədən müəyyən bir hissəsinə və ya müəyyən bir vəziyyətə aid olduqda).

Sərbəst üzən narahatlıq, ən azından sivilizasiyamızda və dövrümüzdə nevrozun ən çox yayılmış formalarından biridir. Digər dövrlərdə və sosial dairələrdə qorxunun daha dramatik formalarının üstünlük təşkil etməsi mümkündür. Bu hissi müəyyən etmək çətindir; xəstə daim daxili gərginlik vəziyyətindədir, bədbəxtlik və təhlükə gözləyir.

Bəzən bu cür narahatlıq, kəskinləşməyə və böyük bir problemə çevrilməyə başlayan və eyni zamanda aqressiyaya səbəb olan kiçik çətinliklər və münaqişələr üzərində cəmləşir; bu hisslər (qorxu və aqressiya) adətən ortaya çıxır.

Birlikdə. Daimi daxili stress vegetativ sinir sisteminin funksiyasına təsir göstərir. Bu sistem daim gərgindir və mübarizə-qaçış reaksiyasına hazırdır ki, bu da öz növbəsində qəddar bir dövrədə daxili stress vəziyyətini artırır. Eyni şey motor sisteminə də aiddir: əzələ gərginliyi artır, dərin vətər reflekslərinin artmasına və nevrozlarda, xüsusən də nevrasteniyada tez-tez rast gəlinən yorğunluq və əzələ ağrısı hissinə səbəb olur.

Əgər nevroitik narahatlıq xəstəni daim təqib edirsə və onun şiddəti dəyişirsə, qorxu paroksizmləri bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər davam edən qəfil hücumlar şəklində özünü göstərir və bu, sürətli ürək döyüntüsü, çoxlu tərləmə, ishal, sidik ifrazı, spastik sidik ifrazı və s. kimi ağır vegetativ pozğunluqlarla müşayiət olunur. Xəstələr ya öləcəklərini, ya da dəli olacaqlarını hiss edirlər.

Bu tip hücum, nevrozdan əlavə, miokard infarktı, epilepsiya (gicbox epilepsiyasının bir forması) və kəskin psixozlarda, xüsusən də şizofreniyada baş verir.

Lokal qorxu, adətən onun mənşəyi ilə əlaqəsi olmayan müəyyən obyektlərə diqqət yetirməklə özünü göstərir. Belə bir obyekt insanın öz bədənini və ya müəyyən bir vəziyyət ola bilər. Bir halda, narahatlığın mənbəyi insanın öz bədənini və ya onun bir hissəsidir: müəyyən bir orqan — ürək, beyin, həzm sistemi, cinsiyyət orqanları və s. Diqqət bu orqanlara yönəlir; xəstə heç nə düşünmür, bu da interoseptiv stimullar üçün şüurlu qavrayış həddini aşağı salır və nəticədə onların şüura çatması ilə nəticələnir, halbuki normal vəziyyətdə onlar şüurdan kənarlaşdırılırlar. Qorxunun bu cür lokalizasiyası hipokondriakal vəziyyətlərdə müşahidə olunur. Anankastik sindromlarda (obsessiyalar) qorxu, qovulması mümkün olmayan bir düşüncə (obsessiya), davamlı olaraq təkrarlanmalı olan bir hərəkət (kompulsiv hərəkətlər) və nəhayət, qorxunu doğuran vəziyyət (fobiyalar) ətrafında lokallaşdırılır. // HEYVANLAR ALƏMİNDƏ QORXU

Heyvan müşahidələrinə əsasən, qorxunun heyvanlar arasında geniş yayıldığını və hətta filogenetik inkişafın ən aşağı mərhələlərində belə müşahidə olunduğunu etibarlı şəkildə demək olar. Üstəlik, filogenetik inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq qorxu reaksiyaları oxşardır. Sadə bir təcrübə inandırıcı dəlil təqdim edə bilər: məsələn, bir qurda və ya böcəyə ot yarpağı ilə toxunduqda, iflic vəziyyəti, sözdə Totstellrefleks və ya qəfil, xaotik, uçuş xüsusiyyətlərinə malik hərəkətlər və bəzən hətta aqressivlik müşahidə olunur. Oxşar reaksiyalar insanlarda da təhdidedici vəziyyətlərdə müşahidə olunur; bir insanın qorxudan "donduğu" və ya "şoka düşdüyü" deyilir.

Şizofreniyada qorxu dəfələrlə insan dözümlülüyünün həddini aşdıqda, hərəkətsizlik (stupor catatonicus) və ya impulsiv oyanış (furor catatonicus) halları baş verir.

Ətraf mühitdə aktiv hərəkət etmək qabiliyyəti, müxtəlif filogenetik inkişaf səviyyələrində olan heyvanlar və insanlar arasında əsas motor reaksiyalarında müəyyən analogiyaların müşahidə edilməsinə imkan verir ki, bu da öz növbəsində bu əsas motor aktları ilə müşayiət olunan təcrübələrdə oxşarlıqların axtarışına gətirib çıxarır. Heyvanlar aləmi ilə insanlar arasında nitq əlaqəsinin olmaması bu ümumi motor aktları ilə müşayiət olunan təcrübələrlə bağlı fərziyyələrini sınaqdan keçirməyi qeyri-mümkün edir. Motordan məhrum olan bitki aləmi

İfadə həyatın subyektiv tərəfini qiymətləndirmək üçün hətta hipotetik cəhdlərə belə imkan vermir: insan üçün tamamilə lal qalır.

// ƏSAS İSTİQAMƏT: "Ə" VƏ "Ə" MÖVQELƏRİ

Pavlova görə, xarici mühitdə motor oriyentasiyası iki əsas vektora birləşdirilə bilər: stimula mənbəyindən "ə" və "uzaq". Birinci halda, canlı orqanizmə təsir edən stimula mənbəyinə yaxınlaşma reaksiyasını doğurur. Bu siqnal ətraf aləmdən müsbət reaksiyanı, həyatın və növün qorunması ilə əlaqəli bioloji ehtiyaclarını ödəmək ehtimalını göstərir. İkinci halda, stimula əks reaksiya - qaçış və ya mübarizə - doğurur - bu, xarici aləmdən gələn təhlükə siqnalıdır. Bu tip motor davranışı, itələmə və geriçək kimi müəyyən edilir, filogenetik inkişafın ən aşağı mərhələlərindən ən yüksək mərhələlərinə qədər müşahidə olunur. Amöb bəzi stimullara psevdopodlarına yaxınlaşmaq və uzatmaqla cavab verir, digərlərindən isə qaçır; Uşaq qollarını uzadıb bəzi insanlara gülümsəyir, digərlərindən isə gizlənib qışqırır.

Əsasən Freydin "Şəhvət və Şəhvətsizlik Prinsipi"nə uyğun gələn ətraf aləmdəki bu əsas motor oriyentasiyası canlı orqanizmin

xarici mühitdən sıx asılılığını göstərir. Onları ayrıca nəzərdən keçirmək olmaz. Xarici mühitlə siqnal mübadiləsi (məlumat mübadiləsi), yəni ətraf mühit stimullarının qəbulu və onlara əsasən hərəkət vasitəsilə reaksiya, bu da öz növbəsində ətraf mühitə siqnal ötürür,

onunla daha yaxın təmas üçün həddir. Canlı təbiətdə ətraf mühitlə bu yaxın təmas iki formada olur: enerji metabolizması və

cinsi çoxalma. Hər bir canlı orqanizm öz ətraf mühitinin hesabına yaşayır. O, həyat üçün lazım olan maddələri ondan alır və onları sadə elementlərə parçalayaraq onlardan öz orqanizmini yaradır. Əsas bioloji qanun - öz həyatının qorunması - fiziki terminologiyada** canlı orqanizmin ətraf mühitinin mənfə entropiyası səbəbindən mənfə entropiyasının (bir növ nizamın) böyüməsi kimi müəyyən edilə bilər. Bu qanun, heyvanlar və insanlara münasibətdə, "qəddar" adlandırılabilir, çünki yaşamaq üçün insan digər canlı orqanizmləri (bitkiləri, heyvanları) məhv etməlidir. Bitki aləmi daha "humanistdir", çünki o, ehtiyac duyduğu enerji ehtiyatlarını əsasən günəşdən alır. Hər bir canlı orqanizm

asanlıqla başqa bir canlı orqanizm üçün mühitə çevrilə bilər və oradan da enerji ehtiyatlarını əldə edəcək. Bir sözlə, biri digəri tərəfindən yeyilir.

Beləliklə, birinci bioloji qanun mənfə hisslərin mənbəyi hesab edilə bilər - insan öz mühitini məhv etmək istədikdə nifrət və ətraf mühitin məhvindən sığınaraq ondan qaçdıqda qorxu. Bu mənfə hisslər ətraf mühitdən "uzaqlaşmaq" vektoru ilə müşayiət olunur. Təcavüz ətraf mühitə yaxınlaşmağı tələb etsə də, insan yalnız onu məhv etmək istədiyi üçün yaxınlaşır. Müəyyən mənada eyni məqsədə təhlükədən qaçmaqla nail olunur. Bəlkə də buna görə təcavüz və qorxu əl-ələ verir.

İkinci fundamental bioloji qanun - növün qorunması - görünür, "əvvəlki" mühitin motor vektoru tərəfindən ifadə edilən müsbət hisslərin əsasını təşkil edir. Bunu yerinə yetirmək üçün ətraf mühitlə erotik və ya ana sevgisi vasitəsilə əlaqə qurmaq lazımdır.

Cinsi çoxalma yeni genetik planların yaranmasını və bunun sayəsində canlı təbiətdə fərdiliyin dominant mövqeyini təmin edir, qeyri-üzvi təbiət və texnologiyadan fərqli olaraq, burada ardıcılığın hökm sürdüyü yer.

Fərdiləşmə müsbət hisslərə xasdır - sevgi obyektini həmişə unikal və təkrarlanmazdır.

Birinci bioloji qanuna (öz həyatının qorunması) bənzər şəkildə, ikincisi mənfi entropiyanı artırmağa çalışır. Birinci qanunda orqanizmin səyi öz entropiyasını artırmağa yönəldilsə də (buna görə də bu qanun müəyyən dərəcədə eqoistdir), ikinci qanunda isə söhbət öz mənfi entropiyasından deyil, cinsi əlaqədən yaranan yeni entropiyadan gedir (bu qanun daha çox altruistikdir). Bəzən, xüsusən də ali həyat formaları arasında, öz həyatının növbəti nəslin qorunmasına həsr olunması baş verə bilər.

İnsanlarda üçüncü vektor - "yuxarıda" tapıla bilər.

Buraya yaradıcı fəaliyyət daxildir, insan öz nizamını ətraf mühitə daxil etməyə (onu öz planına uyğun olaraq yenidən təşkil etməyə) çalışır. Bu, daha çox sırf insani bir xüsusiyyətdir, lakin yaradıcı aspektində ikinci bioloji qanundan irəli gəlir.

Həm birinci, həm də ikinci bioloji qanunların təmin edilməsi ətraf mühitdə istiqamət tələb edir. Buna görə də, hətta ən sadə orqanizmlərdə belə, enerji mübadiləsi ilə yanaşı, informasiya mübadiləsi, yəni xarici mühitdən siqnalları qəbul etmək və onlara cavab vermək qabiliyyəti ortaya çıxır (orqanizmin reaksiyasına xarici mühitə göndərilən siqnal kimi baxmaq olar).

Filogenetik inkişaf irəlilədikcə, informasiya mübadiləsi getdikcə daha zənginləşir və insanlarda enerji mübadiləsini üstələyir.

Həyatın əsas xüsusiyyətini təşkil edən xarici mühitlə informasiya-enerji mübadiləsinin bu prosesində ətraf aləm "yaxşı" və "pis"ə bölünür.

Xeyir orqanizmin quruluşunun ətraf mühit üzərində qələbəsinə təmin edir, şər isə məhv olmaq təhlükəsi yaradır. Bu dixotomiyanı fizika dilində ifadə etsək, "xeyir" mənfi entropiyanı (bu halda, orqanizmin spesifik qaydasını) artıran hər şeydir, "pis" isə əks istiqamətdə hərəkət edir, yəni entropiyanı artırır (orqanizmin quruluşunu məhv edir).

Əsas motor istiqaməti "xeyir" in cəlb etməsi və "pis" in dəf etməsidir. Bu əsas motor vektorları (ətraf aləmdən əvvəl və "uzaq") subyektiv aspektdə (canlı orqanizmin təcrübələri) müsbət və mənfi hisslərə uyğundur. Bu mövqenin keyfiyyəti və müxtəlifliyi orqanizmin filogenetik və ontogenetik inkişaf dərəcəsindən asılıdır. Lakin, ən böyük fərqlərlə belə, onlar həmişə müsbət və ya mənfi işarəyə, cazibəyə və ya itələməyə malikdirlər. Birinci halda, orqanizmin ehtiyaclarının ödənilməsinə, fiziki terminologiyada isə mənfi entropiyasının artmasını, ikinci halda isə narazılığını və həyat prosesinin davam etməsinə təhlükə yaratmasını və bununla da entropiyanın artmasını gözləmək olar. Ölüm, maddənin hissəciklərin nizamsız hərəkətinə meylinin (entropiya) orqanizmin öz nizamını qorumaq meyli (mənfi entropiya) üzərində son qələbəsidir ki, bu da həyatın əsas xüsusiyyəti adlandırıla bilər. Emosional vəziyyətlər ətraf aləmin dördüncü ölçüsü kimi zaman nəzərə alınmadan təhlil edilə bilməz. "Yaxşı" dünyaya doğru hərəkət və "pis" dünyaya qaçış və ya təcavüz gələcəkdə baş verəcək hadisələrin gözləntisindən irəli gəlir: "yaxşı" dünya ilə təmasda olduqda əzəmət və lüks, "pis" dünya ilə qarşılaşdıqda isə acı və ağrı. Subyektiv baxımdan, məqsədə çatmaq ona can atmaqdan fərqlənmir; hər ikisi müsbət və ya mənfi hisslərlə müşayiət olunur. Müsbət hisslər müsbət məqsədə ("yaxşı dünya") çatmaqla əlaqələndirilir.

Hisslər, yəni xoş hisslər müsbət əlamətə malikdir, əks halda ("pis" dünya), mənfi hisslər, xoşagəlməz hisslər isə mənfi əlamətə malikdir. Üstəlik, ilkin xoş məmnuniyyət anından sonra müsbət məqsədə çatmaq mənfi hisslər mənbəyi ola bilər, çünki insan yenidən yeni məqsədlərə can atmalıdır.

Əksinə, "pis" dünya ilə qarşılaşma, onun üzərində qələbə qazanıldığı və öz məhvini əvəzinə onun məhvini görə biləcəyi və ya heç olmasa zərər görmədən xilas ola biləcəyi halda xoş təəssürlər mənbəyi ola bilər.

Xarici dünya ilə mübadilə (enerji və informasiya mübadiləsi)

dördölçülü məkanda baş verir. Mübadilənin istiqaməti orqanizmin keçmiş, həm filogenetik, həm də ontogenetik təcrübəsi ilə müəyyən edilir

(irsiyyət və öz həyat tarixi), lakin eyni zamanda, bu mübadilə

gələcəyə baxır, müəyyən bir məqsədə doğru can atır ki, bu da ən çox termodinamikanın ikinci qanununa qarşı çıxmaq cəhdi kimi müəyyən edilə bilər,

bu qanuna görə maddə hissəciklərinin nizamsız hərəkətinə doğru meyl edir. Sözü bu mənasında, maddənin entropiyaya təbii cəlbediciliyinə baxmayaraq, həyat bu nizamı qorumaq üçün böyük səy tələb edir.

İnformasiya mübadiləsi sayəsində ətraf aləmin mənzərəsi yaranır. Hər bir canlı orqanizm üçün bu dünya fərqli görünür, çünki hər birinin digər orqanizmlərdən fərqli olaraq özünəməxsus quruluşu var. Fərdilik canlı təbiətin bir xüsusiyyətidir və artıq enerji mübadiləsində (orqanizmin biokimyasının fərdiliyi), lakin daha çox dərəcədə informasiya mübadiləsində ifadə olunur. Buna görə də, ətraf aləm, obyektiv olaraq hamı üçün ortaq olsa da, hər bir fərdi canlıya özünəməxsus, unikal və təkrarolunmaz dünya kimi görünür. "Yaxşı" və "pis" dünyalar arasında nəyin cəlb etdiyi və nəyin dəf etdiyi arasındakı dioxotomiya da fərdidir. Bu dioxotomiya informasiya mübadiləsinin inkişaf etdiyi genetik quruluşla müəyyən edilir və bu inkişafın tarixinin özü də ətraf aləmin obyektiv həyat şəraitindən böyük dərəcədə asılıdır. Əgər canlı təbiətin proseslərinin xüsusiyyətlərindən biri dəyişkənlik və sabitlik dialektikasıdırsa - orqanizmdə heç bir atom eyni qalmır, hər şey dəyişir, amma orqanizm eyni qalır (kimlik prinsipi) - bu paradoks xüsusilə informasiya mübadiləsində aydın şəkildə özünü göstərir.

Orqanizm davamlı olaraq yeni siqnallar alır və onun daxilində yeni reaksiyalar yaranır. Xarici mühitə yeni siqnallar göndərilir, lakin həyatı boyu orqanizm eyni fərd olaraq qalır və dünyası, amansız dəyişkənliyinə baxmayaraq, dəyişməz qalır. Bəzən bu dünya kədərli və acı, bəzən təhdidedici və xoşagəlməz, bəzən xoş və sevincli, cəlbedici və cazibədar olur - buna baxmayaraq, eyni dünya olaraq qalır.

Burada ətraf mühitdəki əsas motor istiqamətinin subyektiv ifadəsi kimi təqdim olunan emosional həyat, ətraf mühitlə siqnal mübadiləsinə, onunla daha yaxın təmasa doğru ilk addımdır. Bu mübadilə "əvvəl" mövqeyi "uzaq" mövqeyindən üstün olduqda mümkün olur. İnsan ətraf mühitdən qaçmaq və ya onu məhv etmək istəyirsə, ona yaxınlaşa və onunla tanış ola bilməz.

"Uzaq" mövqeyi orqanizm tərəfindən "əvvəl" mövqeyinə nisbətən daha çox enerji səfərbərliyi tələb edir. Ətraf mühitlə mübarizə aparmaq və ya qaçmaq üçün əsas vəziyyəti təmin etmək üçün sakitcə ona yaxınlaşmaqdan daha çox enerji tələb olunur.

Həyatı ehtiyaclar. Enerji mübadiləsində "əvvəl" mövqeyi anabolik proseslərin yayılması ilə, "uzaqlaşma" mövqeyi isə katabolik proseslərin yayılması ilə əlaqələndirilir. Birinci halda, bədənin öz quruluşu ətraf mühitin quruluşu hesabına qurulur (ətraf mühitin mənfi entropiyası səbəbindən bədənin mənfi entropiyası artır). İkinci halda, bədənin mənfi entropiyası azalır və bununla da mübarizə və ya qaçış üçün lazım olan enerji artır.

Eynilə, enerji mübadiləsində olduğu kimi, tikinti və məhv prosesləri, yəni inkişaf və ölüm birlikdə davam etməlidir. Eynilə, informasiya mübadiləsində ətraf aləmə qarşı hər iki əks mövqe bir-birinə qarışmalıdır ki, bu da subyektiv aspektdə ətraf mühitlə bağlı müsbət və mənfi emosiyalar arasında daimi salınım kimi təmsil olunur. Ətraf mühitdən öz məqsədləri üçün istifadə etmək, öz həyatını və növün həyatını qorumaq üçün fəth edilməlidir və bütün bunlarla birlikdə mübarizə aparmaq və ya qaçmaq ehtiyacı yaranır. Anabolik proseslər katabolik proseslər olmadan baş verə bilmədiyi kimi, "başla" mövqeyi olmadan "əvvəl" mövqeyi ola bilməz.

İnsanlarda hər iki əsas oriyentasiya mövqeyi ilə əlaqəli emosiyaların diapazonu olduqca genişdir. Hər bir dildə mənfi və müsbət emosiyalar üçün bir çox tərif var ki, bu da, ən azı ümumi mənada, aralarındakı kəmiyyət və keyfiyyət fərqlərini əks etdirir. Dil, hərəkətin ən yüksək forması olaraq, ətraf aləmə yönəldilir, orada formalaşır, lakin öz dünyasının hadisələri ilə münasibətdə çox zəif qalır.

Qorxu, narahatlıq, narahatlıq, qorxu, gərginlik, qorxu və s. uçuş mövqeyi ilə əlaqəli müxtəlif emosional vəziyyətləri təyin etmək üçün istifadə olunan anlayışlardır.

Onların hər biri müəyyən edilməsi çətin, lakin asanlıqla hiss olunan fərqli bir emosional vəziyyəti əks etdirir, xüsusən də bu termin səhv istifadə edildikdə.

* S. Szuman: "Zagadnienia psychologii uczuc" w Świetle nauki Pawlowa. Poznan, 1956, s. 36.

** E. Şrödinger: Həyat nədir? Kembriç Universiteti Nəşriyyatı, 1948.

// TİBBDƏ QORXU PROBLEMİ

Həkimlər daim qorxu ilə qarşılaşırlar, çünki xəstələr ölüm, ağrı, zəiflik, qocalma və xəstəlikləri səbəbindən əlillikdən qorxurlar. Həkim çətin qərarlar, tibbi qabiliyyətlərinə və biliklərinə inamsızlıq, təcili tibbi yardım hallarında və s. qarşısında bu qorxunu dəfələrlə aradan qaldırmalıdır.

Qədim tibbdə sehrli maskalar, ritual mahnılar və müxtəlif rituallar şəklində bir çox müalicəvi təsir xəstəliklə əlaqəli qorxunu müalicə aktının özü ilə əlaqəli narahatlığa çevirmişdir. Müasir tibbdə tibbi praktikanın sehrli aspekti lovğalıq hesab olunur; lakin, əsl tibbi texnikalar xəstələrdə qədim həkimlərin sehrli təcrübələri ilə oxşar reaksiya yarada bilər. Görünür, tibbi yardımın fəaliyyəti ilə əlaqəli qorxu hissi ilə ağırlaşan bir vəziyyətdə terapevtik təsir, hər iki halda da, bədən disfunksiyası ilə əlaqəli ilkin qorxunun tibbi biliklərin gücündən qorxmağa çevrilməsindən, qurtuluşun daxildən gələ biləcəyinə inamla müşayiət olunan qorxudan ibarətdir. Bu, tibbdə istifadə edilən daha az pisliklə pisliyi qovma metodunun başqa bir nümunəsi ola bilər. Bütün tibbi təcrübə qorxunun intensivliyini artırmağa deyil, azaltmağa yönəlib.

Psixiatrlar xəstələrində qorxu ilə digər ixtisaslardakı həkimlərdən daha çox qarşılaşırlar. Qorxu, xüsusən də psixozlarda, o qədər güclü ola bilər ki, bu ağrılı vəziyyəti anlamaq və yaşamaq üçün insanın qabiliyyətini aşır. Qorxu, müəyyən xəyali təcrübələr, halüsinasiyalar və aqressivlik aktları kimi bir çox digər psixopatoloji hadisələrin əsasını təşkil edir.

Qorxu xəstənin inkişaf yolunu təhrif edə, sosial qarşılıqlı əlaqələrinə mane ola və təcrid olunmağa və sosial hərəkətsizliyə səbəb ola bilər. "Geri çəkilmə" mövqeyi (qorxu və aqressivliklə əlaqəli) avtonom sinir sistemində artan gərginliklə müşayiət olunur ki, bu da öz növbəsində nevrozlara xas olan müxtəlif növ somatik ağrı hisslərinə və bəzən psixosomatik xəstəliklərdə olduğu kimi müəyyən bədən sistemlərinə üzvi zədələnməyə səbəb olur.

Emosional vəziyyətlərin şüalanması, yəni onların başqalarına yayılması fenomeni,

müsbət emosional vəziyyətlərə nisbətən mənfi emosional vəziyyətlərdə daha çox özünü göstərir.

Qorxu və aqressivlik, müəyyən bir insanın sosial mühitində oxşar hissləri

onların müsbət emosiyalarından: sevgi, dostluq, özündənrazılıqdan daha asanlıqla oyadır. Zehni

təsirlər bu mənfi

şüalanmaların qarşısını almağa yönəldilməlidir. Əksinə, xəstənin müalicə heyətinə ötürülən qorxusu və aqressiyası xəstədə bu hissləri gücləndirir. Xəstə ilə onun terapevtik mühiti arasında terapevtik əleyhinə təsirin qəddar emosional dairəsi yaranır.

// BİOLOJİ QORXU: Kənardan gələn təhlükə

Qorxunun müxtəlif formaları və güclü tərəfləri var və bu fərqlər dildə əks olunur.

Məsələn sadələşdirmək üçün, uçuş duruşuna müşayiət olunan təcrübələri müəyyən etmək üçün ümumi mənada qorxu anlayışı qəbul edilmişdir. Bu, dilin ruhuna uyğun görünür, çünki digər terminlər vəziyyəti daha dəqiq müəyyən edir (məsələn, hansısa təhlükə və ya obyektin yaratdığı qorxu; narahatlıq daha az intensivlik qorxusudur; narahatlıq müəyyən bir obyektin yanında narahatlıqdır; dəhşət bütün fəaliyyəti iflic edən təhdidedici və qeyri-adi bir şeydən qorxudur).

Qorxu xüsusiyyətlərini daşıyan təcrübələrin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlar tamamilə fərqli vəziyyətlərdə eyni və ya çox oxşar qala bilərlər. Beləliklə, oxşar hisslər həyatı təhlükə, eləcə də ictimai istehza təhlükəsi, vicdanının pozulması və ya başqa bir vəziyyətlə yarana bilər.

Qorxu hissini doğuran vəziyyətdən asılı olaraq, onu dörd qrupa bölmək olar. Bunlara bioloji, sosial, mənəvi və parçalanma qorxusu daxildir. Gündəlik nitqdə istifadə olunan təsnifatdan fərqli olaraq, bu təsnifat fenomenin özünü (qorxu təcrübəsini) təhlil etməklə edilə bilməz; onun mənşəyi məlum olmalıdır. Buna görə də, bu, simptomatik deyil, genetik təsnifatdır. Müxtəlif mənşələrə baxmayaraq simptomlar eyni ola bilər.

Müəyyən bir vəziyyət tərəfindən yaranan bioloji qorxu, iki əsas bioloji qanundan birini təhdid edir: öz həyatının qorunması və növün yaşaması.

Kənardan gələn həyat təhlükəsini anlamaq ən asandır - onda qorxudan danışırıq.

Belə bir vəziyyətdə tipik reaksiya qaçış və ya mübarizədir, baxmayaraq ki, qaçış, görünür, mübarizədən daha əsasdır, çünki təhlükə ilə üzləşmək üçün insan özünü dəf etməlidir.

Sivil cəmiyyətdə gündəlik həyat bu cür həyatı təhlükə yaradan vəziyyətlər yaratmır. Yemək əldə edərkən insan vəhşi heyvanların hücumuna məruz qalmır, suda boğulmur, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmır və ya öz nüfuzunu və ya qəbiləsinin nüfuzunu qorumaq üçün mübarizə aparmır. Əlbəttə ki, bu, müasir cəmiyyətin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir, lakin ölüm sənaye zəhərlənmələrində olduğu kimi gizli şəkildə və ya qəzalarda qəfil gəlir. Üstəlik, insan qorxusunu dəf etmək və onu dəf etmək üçün təhlükəli bir vəziyyət axtarır. Bu, kişiliyin sınağında rol oynayır və bu da öz növbəsində erotik əlaqələr qurmaq üçün zəruridir. Təhlükə ilə təmas insanın daxilindəki gizli narahatlığı aradan qaldırır. Bəlkə də bu hal həyatın çətin dövrlərində, məsələn, müharibə zamanı, konsentrasiya düşərgələrində və ya təbii fəlakətlər zamanı ölümün insanın üzünə baxdığı zaman, nevroitik təzahürlərin yoxa çıxmasını izah edir. Oxşar fenomen fərdi həyatda da müşahidə olunur: məsələn, illərdir nevrozdan əziyyət çəkən xəstə ölümə hədələyən ağır somatik xəstəlikdən "sağalır". Ölüm təhlükəsinə məruz qalma ehtimalı daha yüksək olan təhlükəli peşələrdə çalışan insanlar - məsələn, dənizçilər, pilotlar, mədənçilər, alpinistlər - nevroitik simptomlar göstərmə ehtimalı daha azdır. Bəziləri nevroitik narahatlığı azaltmaq üçün qəsdən təhlükə axtarırlar. Kənardan təhdid edən ölüm, yalnız göründüyü zaman qorxu yaradır. Qorxu hissinin yaranması üçün təhlükə şüura nüfuz etməlidir. Təhdid edən vəziyyətin qavranılması tez-tez emosional vəziyyətlə təhrif olunur. Aktiv mövqe təhlükə hissini azaldır ("Cəsarətlə döyüşə girəcəyik..."), mənfi emosiyalar isə onu artırır ("qorxunun böyük gözləri var"). Bu sonuncu halda, qapalı bir dairə yaranır: təhdid edən təhlükədən irəli gələn qorxu bu təhlükəni şişirdir, bu da öz növbəsində qorxu hissini artırır və s. Qorxunun təsiri altında, subyektiv mənada həqiqətən təhlükəsiz bir vəziyyət təhlükəli hala gəlir ki, bu da tez-tez xəyali vəziyyətlərdə müşahidə olunur. Bəzən bəzi insanların yaxınlaşan təhlükəni qabaqcadan görə bildikləri müşahidə edilə bilər: reallığın mövcud mənzərəsində bunu göstərə biləcək heç nə yoxdur, lakin yaxınlaşan bir fəlakətin yuxu və ya oyaq görüntüsü ilə müşayiət olunan narahatlıq yaranır. Bu hadisələr parapsixologiyaya aiddir.

Bu günə qədər bir insanın onu əhatə edən dördölçülü məkanda nə dərəcədə irəliləyə biləcəyi, yəni gələcəyini görə biləcəyi məlum deyil. Artıq qeyd edildiyi kimi, emosional vəziyyətin özü müəyyən dərəcədə reallığın qabaqcadan görülməsi, gələcək üçün hazırlıq hesab edilə bilər. Lakin, insanların gələcəyi daha aydın görmək potensialına malik olması mümkündür. Bundan əlavə, şüura nüfuz etməyən alt həddi stimulları yaxınlaşan təhlükəni signal edə bilər. Heyvanların davranışlarına əsasən, dəfələrlə yaxınlaşan zəlzələni, günəş tutulmasını, sərt qışı və nəticədə təhlükəli vəziyyətləri qabaqcadan görmək olar. Əlbəttə ki, bu davranışı heyvanın şüuruna çatır, insanlar üçün görünməz və hiss olunmayan alt hədd stimulları və ya amilləri ilə müəyyən edildiyini izah etmək çətinidir, lakin hər halda, burada gələcəyə dair aydın bir fikir nümunələri var.

Hər bir təhdid edici vəziyyət, bir qayda olaraq, müəyyən dərəcədə reallıqdan kənara çıxır və nəticədə baş verə biləcək şey təxəyyüldə yaşanır.

Və qorxunu oyadan, real reallığın mənzərəsi deyil, məhz bu təxəyyüldür.

Edam cəzasını gözləyən məhkum, bu anda onun real vəziyyətini təşkil edən kamerada saxlanılmadan, edamın özündən qorxur. Qorxu, adətən, insan təhlükə ilə üzləşdikdə yox olur; sonra aktiv hərəkət - qaçmaq və ya döyüşmək cəhdləri - baş verir və qorxunun yeri yoxdur. Ümumiyyətlə, bu fenomenin gedişi belə ola bilər: təhlükəli vəziyyət yaxınlaşdıqca qorxu hissi artır və güclü emosional gərginlik nəticəsində bu dövrdə zaman və məkan qeyri-adi şəkildə uzanır. Əgər şəxs artıq bu vəziyyətlə birbaşa qarşılaşıbsa, qorxu hissi qəfildən zəifləyir və bu vəziyyət hərəkət vasitəsilə emosional gərginliyin aradan qaldırılması ilə izah edilə bilər. Nəticədə, qorxu hissi yaxınlaşan təhdid hadisəsinə bir növ hazırlıq kimi qəbul edilə bilər və bu an gəldikdə qorxu öz mənasını itirir. Təhdidli bir vəziyyətdən qaçdıqdan sonra rahatlama, istirahət, qələbə, təhlükə üzərində qələbə və ya sadəcə çətin vəziyyətdən çıxmaqdan məmnunluq hissi yaranır.

Bu üç element: gözləmə, azadlıq və sülh, həm müsbət, həm də mənfi güclü emosional gərginliklə əlaqəli bütün vəziyyətlər üçün olduqca tipikdir.

Qorxu gərginliyi hərəkətlə onu azad etmək mümkün olmadıqda artır. Məsələn, yuxuda qorxu ilə əlaqəli bir vəziyyət reallıqda yaşanan vəziyyətlə müqayisədə daha intensiv şəkildə yaşanır, çünki əslində insan hərəkət edə bilər, yuxuda isə insan tamamilə acizdir. Əlləri bağlı olan bir insan sərbəst hərəkət edəndən daha intensiv şəkildə təhlükə yaşayır. Təcavüzkar qarşı tam acizlik hallarında intihar ehtimalının fərqi olmaq cəsarət aşılır (buna görə də Gestapo tərəfindən işgəncə verilən insanların siyanid zəhərlənməsi). Əgər təhlükəli bir vəziyyət o qədər tez inkişaf edərsə ki, müdafiə demək olar ki, avtomatik olaraq baş verir və qorxu yaşamağa vaxt yoxdursa, bu hiss təhlükə keçdikdən sonra üçüncü mərhələdə ortaya çıxır. Sonra qorxu bu mərhələyə xas olan rahatlama hissi ilə qarışdırılır.

(Məsələn, əgər insan avtomobil qəzasından zərərsiz çıxmağı bacarırsa, onda qorxu reaksiyası onunla müşayiət olunan vegetativ təzahürləri ilə daha sonra baş verir.) Bu, təsvir edilən vəziyyətdə hər üç mərhələnin mövcudluğunu göstərir və onlardan biri üçün kifayət qədər vaxt yoxdursa, daha sonra baş verir.

// BİOLOJİ QORXU: Daxildən Təhdid

Xarici təhlükə yalnız qiymətləndirilə və başa düşülə bildikdə qorxu reaksiyası doğurur (məsələn, uşaq qorxusuz yüksək gərginlikli naqillərə toxuna bilər və ya böyük təhlükədən xəbərsiz olduqları üçün radiasiyaya ölümcül şəkildə məruz qala bilər), bədənin daxilindən gələn təhlükə isə təhlükənin təbiətini anlamadan qorxu vəziyyətini doğurur.

İnsan səbəbini bilmədən qorxu ilə doludur. Qorxu hissi ağrı ilə müşayiət olunursa, pisliyin mənbəyi ən azı təxminən lokal ola bilər; məsələn, ürək nahiyyəsindəki ağrı miokard infarktını göstərə bilər. Xarici mühit üçün şüurlu qavrayış həddi bədənin daxili orqanlarından daha aşağıdır. Qorxu oyandıran xarici stimül şüura nüfuz edir, oxşar vəziyyətə səbəb olan daxili stimül isə nüfuz etmir.

Daxili təhlükələrə qarşı müdafiə şüurun xaricində baş verir.

Onun iştirakı olmadan müxtəlif müdafiə mexanizmləri - avtonom, endokrin, biokimyəvi və digərləri - patofizioloji tədqiqatların mövzusudur. Bu hallarda muxtariyyət prinsipi vacibdir.

Bədənin daxili həyatı: bədənin daxilində baş verən mürəkkəb reaksiyalar avtomatik olaraq, şüurun iştirakı olmadan baş verir və yalnız müsbət və mənfi əlamətlər (xoş və xoşagəlməz hisslər) arasında dəyişən müxtəlif növ emosional vəziyyətlər şəklində şüurlu nəticələrə səbəb olur.

Daxili təhlükənin səbəbləri müxtəlif ola bilər. Onlar enerji mübadiləsinin pozulması ilə əlaqələndirilir. Ümumiyyətlə, bilirik ki, bu təhlükə oksigen çatışmazlığı, su çatışmazlığı və ya qida çatışmazlığından yaranır. Müəyyən bir müddətdən sonra bunlardan birinin olmaması ölümə səbəb olur. Vaxt dəyişəcək - oksigen olmadıqda dəqiqələr, hətta saniyələr; su olmadıqda saatlar; qida olmadıqda günlər ola bilər. Təhlükənin və buna görə də qorxunun artma sürəti oksigen olmadıqda su və ya qida olmadıqda olduğundan xeyli yüksəkdir. Oksigenin olmaması müvafiq hərəkət üçün vaxtın olmadığı narahat bir vəziyyətə səbəb olur. Digər tərəfdən, su və ya qida olmadıqda hələ də bir müddət var və qorxu xeyli zəifdir; Əksinə, bu, güclü aqressivlik qarışığı olan narahatlıqdır; Təcrübə dünyası su və ya qida əldə etmək ehtimalı düşüncəsinə endirilir. Bu halda təhdid yaradan vəziyyətin mahiyyətini təhlil etmək oksigenin olmamasından daha asandır, çünki düşünmək üçün daha çox vaxt qalır.

Qorxu mənbəyinin təhlili təhdid yaradan vəziyyətin anını ölümdən ayıran vaxtdan çox deyil, bu təhdid mənbəyinin yerindən asılıdır. Təhdid yaradan vəziyyət, oksigen çatışmazlığının tənəffüs yollarının zədələnməsi, məsələn, sıxılma və ya su və qida çatışmazlığının onları əldə edə bilməməsi səbəbindən yarandığı hallarda aydın olur. Lakin, oksigen çatışmazlığının ürək əzələsinin zədələnməsi, hemoglobin çatışmazlığı və ya tənəffüs fermentlərinin tıxanması səbəbindən nə vaxt yarandığı hələ də məlum deyil. Bədənin daxili toxumalarında su və qida maddələrinin çatışmazlığı assimilyasiya proseslərinin və hüceyrə metabolizmasının pozulmasından qaynaqlana bilər. Bir sözlə, insan təhlükənin şüurlu şəkildə qarşısını ala biləcəyi hallarda (məsələn, ağciyərlərə hava axınına maneəni aradan qaldırmaqla, su və qida əldə etməklə və s.) təhlükədən xəbərdardır, lakin şüurlu fəaliyyət mənasız olduqda, yəni təhlükəyə qarşı mübarizə bədənin xarici mühitində deyil, daxilində baş verdikdə təhlükədən xəbərsizdir.

Şüur, sanki bədənin daxili mühiti üçün deyil, xarici mühit üçün qorunur. Lakin qorxu hissi həm xarici, həm də daxili təhdidlər qarşısında yaranır. Sonuncu halda, qorxu obyeksizdir, çünki bu hissin təsiri altında olan insan onu nəyin təhdid etdiyini bilmir; bu "bilik" bədənin daxili mühitinin, şüurun iştirakı olmadan baş verən muxtar proseslərinin bir atributudur.

Bu prosesləri öyrənmək və idarə etmək tibbin əsas məqsədidir.

Tibbi bilikləri sayəsində həkim qorxunun mənsəyi haqqında təlim keçməmiş bir fərddən daha çox şey deyə bilər; Həkim qorxu yaşayan şəxs üçün şüurlu proseslər çərçivəsindən kənarda olan daxili təhlükənin mənbəyini müəyyən edə bilər. Beləliklə, həkim qorxunun miokard infarktı və ya daxili qanaxma, ağır anemiya, zəhərlənmə və s. nəticəsində oksigen çatışmazlığından qaynaqlandığını sübut edə bilər.

// BİOLOJİ QORXU: Növlərin Qorunması Qanununa Təhdid

Bioloji qorxu təkə öz həyatını qorumaq qanunu ilə deyil, həm də növün qorunması qanunu ilə əlaqələndirilir. Lakin bu iki vəziyyət arasında əhəmiyyətli fərqlər var. Biri canlı orqanizmin spesifik "eqoizmindən", digəri isə...

Təhdid və onun müddəti arasındakı fərqdən. Öz həyatını qorumaq orqanizm üçün həmişə növün həyatını qorumaqdan daha vacibdir. Hava, su və qidaya ehtiyac cinsi əlaqəyə olan ehtiyacdən daha güclüdür və hər ikisi birlikdə baş verdikdə, adətən sonuncu əvəz olunur.

Bu o demək deyil ki, növün qorunması qanunu ilə əlaqəli qəhrəmanlıq nümunələri təbiətdə müşahidə edilə bilməz. Heyvanlar, xüsusən də daha yüksək növlərə mənsub olanlar, tez-tez nəsilələrinin həyatını qorumaq üçün həyatlarını təhlükəyə atırlar; erkəklər tez-tez dişilər uğrunda yarışirlar; bəzi həşəratlarda cinsi əlaqə ölümlə başa çatır; insanlarda cinsi istək tez-tez müharibələr və ya fəlakətlər kimi kütləvi təhlükə dövrlərində artır. Bəşər tarixi öz həyatının sevimli tərəfdaşı, nəslin qorunması və ya hətta daha geniş sosial qrup - qəbilə, millət və s. naminə təhlükəyə atıldığı hallarla doludur.

Buna baxmayaraq, ikinci bioloji qanunu qorumaq üçün başlanğıc nöqtəsi həmişə birinci bioloji qanun olaraq qalır. Təbiətin ikinci qanununun işləməsi və cinsi əlaqə istəyinin yaranması üçün bədənəin əsas ehtiyacları, ən azı minimal dərəcədə ödənilməlidir. İnsanlar, heyvanlarda olduğu kimi, estrus dövrü ilə əlaqəli olmadığı üçün, partnyorla cinsi əlaqəni heyvanlara nisbətən daha asan təxirə sala bilərlər. İnsanın cinsi istəyi demək olar ki, bütün həyatı boyu kifayət qədər bərabər paylanır. Cinsi əlaqəni tənzimləmək qabiliyyətinin də mənfi cəhətləri var. Birinci bioloji qanunla əlaqəli bioloji qorxu qısa müddətli olsa da, qorxu vasitəsilə signal vermək ehtiyacı müəyyən bir müddət ərzində ödənilməlidir, əks halda ölüm baş verir, ikinci bioloji qanunla əlaqəli qorxu sonsuza qədər davam edə bilər, çünki bu ehtiyacı ödəmək üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdur.

Cinsi fəaliyyətlə əlaqəli qorxu gərginliyini azaldan amil cinsi aktın özü deyil, müşayiət olunan hisslərdir. Xüsusilə qadınlarda cinsi əlaqə zamanı müəyyən hisslərin olmaması (anorqazmiya) normal cinsi həyat sürsələr də, cinsi narahatlıq hücumlarına səbəb olan vəziyyətlər var. Bu cür hadisələr kişilərdə daha az yaygındır.

Bu narahatlıq asanlıqla aqressiv davranışla (aclıqdan qaynaqlanan qorxuya bənzər) birləşdirilə bilər. Aqressiv davranış yetkinlik dövründə tipikdir. Cinsi məmnuniyyətin olmaması qorxu və aqressivlik gərginliyini artırır. Müharibə dövründə pozğunluğun artması bu gərginliyi aradan qaldırmaq ehtiyacı ilə izah edilə bilər.

Lakin, cinsi məmnuniyyətin olmamasının aqressivlik və qorxu xüsusiyyətlərinə malik emosional vəziyyətin səbəbi olduğunu iddia etmək yalançı həddindən artıq sadələşdirmə olardı. Cinsi akt münasibətin ətraf mühitdən "əvvəl" son nöqtəsini təşkil etsə də, aqressiyanın son nöqtəsi - qətl - münasibətin ətraf mühitdən "son nöqtəsini" təşkil etdiyi kimi, iki formadan birinin yayılması bu son nöqtələrə çatmaqdan asılı deyil.

Davranış bir məqsədə çatmağı müəyyən edir və onun nailiyyəti bu davranışı dəyişdirir və əks istiqamətə yönəldə bilər. Məlumdur ki, cinsi məmnuniyyətdən sonra tərəfdaşa mənfi*

münasibət yaranır və incimiş insana qarşı müsbət hisslər ona qarşı aqressiv hərəkətdən sonra yaranır. Bir emosional əhval-ruhiyyə formasının digərindən üstünlüyü, onların gücü və sabitliyi müəyyən bir insanın əsas psixoloji quruluşuna aiddir və məhz bu, əsas quruluş olduğuna görə, onların əsasən inkişafın erkən dövrünün genetik və sosial amillərindən asılı olduğunu güman etmək olar.

(erkən uşaqlıq mühiti).

// SOSIAL QORXU. "ANA MÜHİTİ"

İnsanların cəmiyyətin məhsulu olduğuna dair heç kimin sübuta ehtiyacı yoxdur. Lakin bu, sosial həyatın heyvanlarda müəyyən bir rol oynamadığı anlamına gəlmir, lakin insanlar üçün bu rol xeyli böyükdür və insan həyatını və inkişafını sosial mühit olmadan təsəvvür etmək çətindir. Uşaqlıqda, xüsusən də erkən uşaqlıqda, uşağın sosial mühitindən qısa müddətə təcrid olunması belə ölüm hökmünə bərabərdir. İnsanlar inkişaf etdikcə getdikcə müstəqilləşirlər, lakin sosial dəstək olmadan öz başlarına buraxıldıqda, uzun müddət yaşaya bilməzlər. Xüsusilə müasir mədəni cəmiyyətlərdə, vəhşi təbiətdə həyata öyrəşməmiş, bu cəmiyyətdən asılı olanlar, onsuz özlərini tamamilə çarəsiz hiss edirlər.

Sosial mühitdən asılılığın nəticəsi, bu mühitlə əlaqənin kəsilməsindən qaynaqlanan təhlükədir. Bu, təbii mühitlə əlaqənin pozulması halında olduğu kimi, əsas metabolitlərin (oksigen, su və ya qida) olmaması səbəbindən ölümə səbəb olan birbaşa təhlükə olmasa da, dolayı təsir göstərir.

Təbii mühitlə əlaqə sosial təmas, yəni eyni növün başqa bir üzvü ilə təmas yolu ilə qurulur. Bu, prenatal dövrdə və erkən uşaqlıq dövründə daha aydın şəkildə nümayiş etdirilə bilər. Prenatal dövrdə təbii mühit ananın bədənidir. Erkən uşaqlıq dövründə ana və ya onun əvəzedicisi kimi çıxış edən biri bu mühiti yaradır, uşağa inkişafı üçün lazımı şərait yaradır və onu xarici mühitdə həmişə mövcud olan təhlükədən qoruyur.

Ana mühiti, ya ananın öz bədənə şəklində, ya da sonradan xarici mühitdə qayğı şəklində gənc orqanizmi təhlükəli realıqla təmasdan təcrid edərək, onu mövcud nizamdan qoruyur ki, bu da canlı orqanizm baxımından "Mən qalib gələcəyəm və ya məğlub olacağam" düsturu ilə təmsil olunur. Təbii mühitdən təcrid olunmaq gənc orqanizmin təhlükəsiz inkişafını təmin etməklə yanaşı, informasiya mübadiləsinin inkişafını da müəyyən edir. Ətraf mühitlə informasiya mübadiləsi yalnız təhlükəsizlik əsasında inkişaf edə bilər.

Şübhəsiz ki, ətraf mühitə əsas istiqamətlənmə və informasiya mübadiləsinin əlaqəli strukturu qismən anadangəlmədir. Lakin, ali heyvanlarda və xüsusən də insanlarda siqnal sisteminin zəngin inkişafı səbəbindən anadangəlmə və qazanılmış reaksiyaların nisbəti sonunculara doğru əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və nəticədə əsas istiqamətlənmə anadangəlmə deyil, getdikcə daha çox öyrənilir.

Həyatın ilk günlərindən heyvanlar və insanlar təhlükəni göstərə biləcək siqnalları ayırd etməyi öyrənirlər.

Ətraf mühitin təhlükəsizliyini göstərən siqnallar tam təsdiqlənə bilsə də, təhlükə siqnalları yalnız qismən təsdiqlənir və onların tam təsdiqlənməsi hər şeyə son qoya bilər və bununla da xarici mühitlə siqnalların daha da mübadiləsinə qeyri-mümkün edə bilər. Uşaq barmağını yanan kibritdə yandırmaqla odun gücü, yolun təhlükələri barədə isə şillə və ya ananın qışqırığı ilə öyrənir. Digər tərəfdən, ətraf mühitin müsbət keyfiyyətləri onun istəkləri yerinə yetirildikdə tanınır.

arzular. Əgər ətraf aləm pis və xoşagəlməz görünürsə, bu xoşagəlməzlik yalnız şam alovu ilə yandırılmış barmaq və ya ananın şillələri kimi görünür; bu xoşagəlməzlik heç bir böyük təhlükə yaratmır.

"Ana" mühiti sayəsində ətraf aləm öz caynaqlarını gizlədir, həyatın digər canlı orqanizmlərin məhv edilməsini tələb etdiyi qəddar həyat qanununu gizlədir. Ətraf mühiti və öz taleyini qiymətləndirməkdə bu "yalançı" nikbinlik xarici mühitdə təhlükə və ya təhlükəsizliyi göstərən siqnalların müxtəlif dərəcələrdə yoxlanılmasından irəli gəlir. Müsbət hadisələr yoxlanılır, mənfi hadisələr isə yoxlanılmadan qəbul edilir. Təhlükə mənbəyinə yaxınlaşıb onu yoxlamaq olmaz, çünki belə yoxlama ölümlə təhdid edə bilər. Mənfi siqnallar müsbət siqnallardan daha uydurmadır;

ətrafımızdakı dünyaya yaxınlaşaraq onu daha yaxşı tanıyırsınız və qaçaraq və ya məhv edərək onu öyrənmə və ya tanıya bilmirik; biz onun yalnız az-çox uydurma obrazını yaradırsınız. "Əvvəl" mövqeyi koqnitiv realizmi, "başla" mövqeyi isə mücərrəd mövqeyi təşviq edir.

Müsbət stimulun mənbəyinə çatmaq tez-tez "bu deyil" kimi narazılıq hissi yaradır və irəliləmək istəyi yaranır. Mənfi stimulun mənbəyi tapıla bilmirsə, qorxu və aqressiya gərginliyi (şər gözləməsi) artır. Bu, mənfi emosional vəziyyətlərin, bir qayda olaraq, daha uzun sürdüyünü və müsbət vəziyyətlərdən daha aydın olduğunu izah edə bilər. Arzuların yerinə yetirilməsi sonsuzluqda, yəni ölümdə həll olur.

Ətraf aləmdə əsas istiqaməti təşkil edən ətraf mühitin əks "başla" və "başla" mövqeləri, bütün əks proseslər kimi, balanslaşdırılmışdır, yəni birinin gücü digərindən əhəmiyyətli dərəcədə çox ola bilməz, əks halda daha zəif proses Zamanla bu tarazlıq tamamilə yox olmalıdır. (Bu tarazlıqdakı pozğunluqlar müxtəlif növ ruhi pozğunluqlarda və nevrozlarda müşahidə olunur). Əks proseslərin tarazlıq prinsipi, ən azı qismən, onların xarici amillərdən müstəqilliyini təmin edir. Müəyyən hallarda, onlar endogen şəkildə, yəni ətraf aləmdən gələn siqnallardan asılı olmayaraq görünə bilər. Eyni signal, çatdığı orqanizmin tarazlıq vəziyyətindən asılı olaraq, ətraf aləmlə "-dən" və ya "-ə" münasibətini oyada bilər.

Gənc yaşda ətraf aləm yaşlı yaşdan daha cəlbedici olur ki, bu da

həyatın ümumi dinamikasından qaynaqlanır ki, bu da gənclikdə qocalığa nisbətən xeyli yüksəkdir.

Həyat dinamikasının subyektiv ekvivalenti əhval-ruhiyyədir; yaxşı əhval-ruhiyyə, bir qayda olaraq, "-ə" mövqeyi ilə müşayiət olunur, pis əhval-ruhiyyə isə "-dən" mövqeyi ilə müşayiət olunur və sonra dünya "dəf edir". Ətraf aləmdən gələn signalın əhəmiyyəti ilk baxışdan göründüyü qədər böyük deyil; canlı orqanizm öz inkişaf yolunu izləyir və ətraf mühitdən gələn müsbət və ya mənfi siqnallar yalnız müvəqqəti səbəblərə səbəb olur.

Filogenetik inkişaf irəlilədikcə, ətraf aləmlə məlumat mübadiləsi prosesləri artır və daha mürəkkəbləşir, ana qayğısı isə dərhal ətraf mühit təhdidlərindən qorunma təmin etməyə davam edir.

Ətraf aləmdən gələn siqnallar, xüsusən də mənfi siqnallar, sanki sosial süzgəcdən keçir və sosial mühit tərəfindən qiymətləndirilir. Müsbət və ya neytral signal sosial dairənin qiymətləndirməsindən asılı olaraq mənfi və ya əksinə çevrilə bilər.

Bu hallarda, sosial mühit təcrübə aparan rolunu oynayır və məsələn, uşaqda müəyyən bir sosial qrupda qadağan olunmuş müəyyən bir qidaya və ya həmin sosial qrupdan xaric edilmiş bir şəxsin görünüşünə qarşı müdafiə reaksiyası inkişaf etdirə bilər, bu, Pavlovun təcrübələrindəki bir itin zəng səsi və ya yemək qabı görəndə necə qaça biləcəyinə bənzəyir. Köpəklərdə müdafiə reaksiyasının inkişafı üçün ümumiyyətlə neytral (zəng kimi) və ya müsbət (qida) stimulların mənfi amillə (məsələn, ağrı) cütləşməsi tələb olunur, insanlarda isə sosial təzyiq, hətta şifahi qadağa şəklində olsa belə, kifayətdir. Sosial filtr reallığın mənzərəsini təhrif edir; yaxşı, gözəl, xoş olanlar cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş hər şeyi təşkil edir və əksinə, həmişə reallığa uyğun olmayan pis, çirkin və ya təhdidedici hesab edilən hər şeyi dəf edir. Sosial mühitin təmin etməli olduğu nizam və təhlükəsizlik üçün reallıq mənzərəmizi təhrif etməyin bədəlini ödəyirik. İnsanların meydana gəlməsi ilə bağlı filogenetik sıçrayış, ilk növbədə, heyvanlar aləmi ilə müqayisədə signal sisteminin fəvqəladə inkişafına gətirib çıxarır, xüsusən də onun müxtəlif signalları bir-biri ilə əlaqələndirən ən zəngin nümunələri təqdim edən hissəsi (beyin qabığı). Bədənə daxil olan signal müxtəlif funksional strukturları aktivləşdirə bilər və bu imkanlar faktiki olaraq sonsuzdur.

Informasiya metabolizması həm xaricdən, həm də bədənin daxilindən gələn xaosla təhdid olunur:

reseptorların həssaslığı və onlara təsir edən çoxsaylı signallar səbəbindən xaricdən və müxtəlif funksional strukturların yaranması səbəbindən daxildən.

İnsanlarda signal sistemi o qədər inkişaf etmişdir ki, xarici vəziyyətdən ayrılmaq mümkün olur; onun yaratdığı funksional strukturlar onunla güclü şəkildə bağlı ola bilər və ya ümumiyyətlə bağlı olmaya bilər. Digər tərəfdən, heyvanların signal sisteminin inkişafı bu cür proseslərə imkan vermir; onlar ətraf mühitlə daha çox qaynayıb-qarışırlar.

Onlar üçün konkret vəziyyətlər tipikdir, insanlar üçün isə mücərrəd vəziyyətlər tipikdir.

("Concrete" sözü "concrete" - "bir şeylə birlikdə böyümək" və "abstract" isə "abstrahere" - "qoparmaq" sözlərindən gəlir).

İnsanlara xas olan uzun müddətli asılılıq və qayğıya ehtiyac dövrü təkcə belə qayğı olmadan ölməyə məhkum olan gənc orqanizmin həyatı ehtiyaclarını ödəmək ehtiyacından deyil, həm də sosial təzyiq olmadan pozula və sosial reallıqdan ayrıla bilən informasiya mübadiləsinin inkişaf etdirmək ehtiyacından irəli gəlir. Uşaq ətraf mühiti qavramağı və ona sosial mühiti ilə eyni şəkildə reaksiya verməyi öyrənir.

Dünyadakı əsas istiqamət sosial istiqamətə çevrilir. Ətraf mühit signallarının müsbət və ya mənfi əlaməti təbii əlamət deyil, sosial əlamətdir. Ətraf mühit müəyyən bir anda necə göründüyünə görə deyil, məhz sosial qaydaya əsasən onun imicinin necə formalaşdığına görə cəlb edir və ya dəf edir. İnsanın ətraf mühitlə birləşməsi birbaşa təmas və konkret vəziyyət vasitəsilə deyil, mürəkkəb sosial əlaqələr vasitəsilə baş verir. Bu sosial əlaqələrin içərisində həm fərdin öz tarixi, həm də mümkün gələcəyi, eləcə də mənsub olduğu sosial qrupun tarixi və onun gələcəyi gizlənilir. Müəyyən bir mühitə qarşı rəğbət aktını təhlil etməklə, mövcud vəziyyətdən daha çox fərdin keçmişini, yarandığı sosial mühiti və s. daha yaxşı əks etdirmək olar. Eyni signal bəzilərini digərlərinə cəlb edə bilər,

və başqalarını uzaqlaşdırın.

// Qorxu - Sosial və Bioloji

İnsanın enerji və informasiya mübadiləsi onun sosial mühitlə əlaqələri vasitəsilə baş verir və bu əlaqənin pozulması metabolik proseslərin pozulması ilə təhdid yaradır və bu da təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarır. Bu mənada sosial qorxu bioloji qorxuya bərabərdir. Müəyyən bir vəziyyətdə, bəzi insanların ictimaiyyət qarşısında çıxış etməzdən əvvəl edam olunmuş kimi niyə belə böyük bir qorxu hiss etmələri anlaşılmaz görünə bilər; niyə kimsə qorxaq hesab edilməmək və ya şübhəli maddi dəyər əldə etmək üçün həyatını ölümcül təhlükəyə atır? Niyə kimsə sosial qınaq qorxusundan intihar edir?

Bu qorxu, insanın sosial əlaqəsinin gücünü nəzərə alsaq, başa düşüləndir. Bu əlaqənin kəsilməsinin yalnız uşaqlıqda ölümlə təhdid etdiyi və yetkinin ətraf mühitdə olduqca sərbəst hərəkət edə biləcəyi görünərsə də, bu azadlıq yalnız göz qabağındadır. Uzunmüddətli inkişaf dövründə bir insanın onu lazım olan hər şeylə təmin edən sosial mühitdən tamamilə asılı olması və informasiya mübadiləsinin onun normaları ilə formalaşması, insanın bütün sonrakı həyatına elə bir qüvvə ilə iz buraxmışdır ki, onlar heç vaxt özlərini sosial təsirdən azad edə bilməzlər. Müəyyən bir vəziyyətdə mənasız görünən qorxu, tarixi baxımdan başa düşüləndir. Ətraf aləmlə güclü əlaqənin təməli inkişafın erkən mərhələlərində qoyulur və sonrakı həyatın istənilən mərhələsində onun pozulması təhlükəli bir vəziyyət yaradır.

// Sosial əks olunma (əks əlaqə)

Sosial əlaqənin pozulması və ya kəsilməsi, hazırda sosial mühiti təşkil edən bir fərd və ya bir qrup insan tərəfindən rədd edilməkdən, tənqid edilməkdən, istehza edilməkdən və s. ibarətdir. Sosial ünsiyyət ətraf aləmdə hərəkət azadlığını məhdudlaşdırır; sanki bir insanı daim müşahidə edir; hər bir hərəkət bu ünsiyyətin pozulmasına səbəb ola bilər. Sosial mühit, davranışımızı qeyd edən və bununla da düzəlişlər etməyə imkan verən bir əks etdirici rolunu oynayır. Sosial mühitdən gələn siqnallar mövcud funksional strukturu zəiflədən, gücləndirən və ya dəyişdirən geribildirim rolunu oynayır.

Sinir sisteminin fəaliyyəti, istənilən idarəetmə sisteminin - texniki, bioloji və ya sosial - fəaliyyəti geribildirim olmadan davam edə bilməz. Sistemdən gələn bəzi siqnallar ətraf mühitdəki hərəkətlərinin nəticələri barədə məlumat verərək geri qayıtmalıdır. Bu məlumatdan asılı olaraq, fəaliyyət planı (funksional struktur) dəyişir. Bu məlumat olmadan idarəetmə sistemi kor-koranə hərəkət edir və heç vaxt hədəfinə çatmazdı. Silahın idarəetmə mexanizmi güllənin zərbəsi barədə məlumatlandırılmalı və sonra nişan alma yoxlanıla bilər.

Hüceyrənin həyatı proseslərini idarə edən xromosom sistemi, xarici stimullardan asılı olaraq bütün hüceyrənin fəaliyyəti üçün bir plan kimi çıxış edərək fəaliyyətini dəyişdirir. Onların təsiri altında bəzi genlər aktivləşir, digərləri isə inhibə olunur.

Əzələ funksiyasını idarə edən sinir hüceyrələri onlardan mövcud vəziyyətləri haqqında daim məlumat alırlar. Əzələlərdən geribildirim siqnallarını ötürən sinir yollarının zədələnməsi, məsələn, tabes dorsalis və ya beyincik zədələnməsi və s., səbəb olur.

Bu, ciddi hərəkət pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Sinir və endokrin sistemlərdə əks əlaqənin bir çox nümunəsi var. Sinir sisteminin özünün, xüsusən də filogenetik cəhətdən gənc hissələrinin və hər şeydən əvvəl beyin qabığının morfoloji quruluşu qapalı dövrə prinsipi üzərində qurulub: sinir hüceyrəsindən çıxan bəzi siqnallar ətraf mühitdəki, yəni siqnalların göndərildiyi digər sinir hüceyrələrindəki hadisələr haqqında məlumatla geri qaydır.

Orqanizmin bütövlüyünə gəldikdə, onun davranışı adlanan hər bir hərəkəti xarici mühitə göndərilən signal hesab edilə bilər. Bu signal boş yerə daxil ola bilməz; müəyyən bir təsir yaratmalıdır, əks halda məqsədsiz və lazımsız bir signala çevrilərdi. Əks əlaqə siqnalları xarici mühitlə siqnalların mübadiləsində mühüm rol oynayır və ətraf mühitdə yaratdığı təsir haqqında məlumat verir. Onlar orqanizmə daxil olan siqnalların cəmləşdiyi bir növ nüvə təşkil edirlər. Xarici mühitdəki potensial siqnalların xaosundan bir şey seçilməlidir; Bu seçimdə geribildirim siqnalları üstünlük təşkil edir və beləliklə, insan öz hərəkətinin təsirini müşahidə edə bilər.

Fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq, ətraf mühit fərqli şəkildə qəbul edilir; təbiətdə yaşayan insan onu şəhər sakini, polis, aktyor və s.-dən fərqli görür.

Hərəkətlərimizin təsiri barədə bizə məlumat verən geribildirim siqnalları arasında sosial mühitdən gələn siqnallar ən vacib rol oynayır. İnsan həyatında heyvanlardan daha çox özünü göstərən sosial mühitdən asılılıq faktının informasiya mübadiləsinin bütün inkişafında əks olunması və həm gedən, həm də gələn hər bir signala sosial xarakter verməsi mümkündür.

Əgər körpənin ağlaması anasını çağırırsa, anası fəaliyyəti ilə təcili təhlükəni aradan qaldırır və narahatlıq məmnuniyyətə və dincliyə yol verirsə, bu ağlamanın güclü bir signalı var və pisliyi yaxşılığa çevirir. Lakin onun gücü tamamilə sosial mühitdən, yəni anadan asılıdır. Buna görə də, bu signal ətraf mühit tərəfindən başa düşülməli və qəbul edilməlidir. Əgər bu ağlama, dəfələrlə təkrarlansa belə, boşluğa düşüb cavabsız qalarsa, nəticədə uşaq ağlamağı dayandırır və yuxuya gedir. Əgər bu vəziyyət xroniki hala gəlersə, yəni uşağın fəaliyyəti sosial mühitdən reaksiya ilə qarşılanmadıqda, uşaq demensiya, apatiya və fiziki tənəzzül vəziyyətinə düşür və tez-tez ölümlə nəticələnir. İnkişafın sonrakı dövründə uşaq davranış qabiliyyətlərini modelləşdirməyi öyrənir, onları başqalarının reaksiyalarına uyğunlaşdırır; əgər onun ağlaması anasını cəlb etmirsə, onda təbəssümü onu özünə cəlb edə bilər və ya əksinə.

Əsas emosional reaksiya ("əvvəl" və ya "başla" mövqeyinin üstünlük təşkil etməsi), görünür, böyük ölçüdə uşağın həyatının ilk illərində sosial mühitin ona münasibətindən asılıdır. Uşaq üçün əks əlaqə sosial siqnalları kimi çıxış edən bu mühitin reaksiyaları bəzi fəaliyyət formalarını maneə törədə və digərlərini stimullaşdıra bilər. Uşaqla onun sosial mühiti, xüsusən də ana arasında çox əlverişsiz münasibətlərdə bu reaksiyalar ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəyə fitri meyli ("əvvəlki" mövqe) tamamilə boğa bilər, beləliklə, emosional struktur daim qaçış və aqressivlik xüsusiyyətlərinə malik bir mövqe ilə dominantlıq edəcək. Əgər ana uşağının hər bir spontan davranışına narahatlıq, əsəbilik, laqeydlilik və ya hətta açıq şəkildə qınaqla reaksiya verirsə, onda

Spontan fəaliyyətin inhibisiyonu baş verə bilər. Belə hallarda, o, yalnız bir neçə funksional strukturun keçə biləcəyi dar, seçici bir kanal kimi çıxış edir, digərləri isə basdırılır.

İmprinting

Hər yaş dövrü özünəməxsus potensialını göstərir.

Müəyyən davranış formaları (funksional strukturlar) müəyyən bir dövrdə daha asan inkişaf edə bilər, digər bir dövrdə isə xeyli çətin inkişaf edə bilər və ya hətta qeyri-mümkün hala gələ bilər. Lakin, hər yaş dövründə az sayda amil onun spesifik funksional strukturlarının inkişafı üçün kifayətdir və ətraf mühit siqnallarının modelləşdirmə gücü bu inkişaf dövründə digər inkişaf dövrlərinə nisbətən xeyli artır.

Ümumi bir nümunə, inkişafının müəyyən bir mərhələsində bir insanla qarşılaşdıqda, onu anası, ördək kimi izləyən yumurtadan çıxan ördək balasıdır. Bu dövrdə canlı orqanizmlə ətraf mühit arasında başlayan spesifik reaksiya imprintinq anlayışı ilə müəyyən edilir. Funksional struktur olduqca güclü olur. Bir heyvan psixoloqu, basdırma dövründə onu özünə yoldaş seçən bir quş haqqında olduqca gülməli bir hekayə danışır. Müəyyən bir müddətdən sonra, uzun bir ayrılıqdan sonra, psixoloq quşu yenidən görəndə, quş öz cütlüyünü yuvadan qovdu və onu ucadan qışqırıqlarla çağırmağa, özünə tərəf çəkməyə başladı və qanad döyüntüləri ilə boş məkanı göstərdi.

Heyvanlara nisbətən davranış modellərinin xeyli müxtəlifliyinə malik insanlarda, sözün dəqiq mənasında basdırma haqqında danışmaq çətinidir. Buna baxmayaraq, insanların da müəyyən davranış modellərinin daha asan gücləndirildiyi həyat dövrləri olur və bu dövrlərdə sosial mühitin onların formalaşmasına təsiri xeyli böyükdür. Məsələn, həyatın müəyyən bir dövründə masada necə gəzməyi, danışmağı və davranmağı öyrənmək daha asandır. Müəyyən bir yaşda bu bacarıqlara yiyələnmək çox asandır və uşaq eyni zamanda ana dilini öyrənərkən xarici dil asanlıqla öyrənə bilər. Oxumağı və yazmağı öyrənmək böyükklər üçün xeyli çətinidir. Təsir dövründə formalaşmış davranış nümunələri ömür boyu davam edir və sonradan onları aradan qaldırmaq çətinidir (məsələn, stəkanda və ya fincanda qaşıqla çay və ya qəhvə içmək və ya boşqabdan çay içmək). İngiltərədə süfrə davranışları sinif mənsəyinin həssas göstəricisi olaraq qalır.

Həyatın ilk illərinin sosial mühitlə qarşılıqlı əlaqənin əsas formaları üçün təsir yaratması çox ehtimal olunur. Bu dövrün bu sosial dairəsindəki insanlar həyatları boyu vacib olaraq qalırlar və sonrakı münasibətlərin digər insanlara qarşı qurulduğu xüsusi bir təməl rolunu oynayırlar. Eyni dövrdə başqaları və özü ilə emosional münasibətlərin əsas strukturu qurulur. Bu halda, əksər psixiatrlar həyatın ilk illərinin əsas emosional reaksiyaların inkişafı üçün əhəmiyyəti barədə psixoanalitiklərlə razılaşırlar. İnsan həyatının bu vacib dövrünün unudulmazlıq pərdəsi ilə örtülməsi, ətraf mühitlə əlaqəli əsas emosional formaların ("dan" və "a" mövqeləri) niyə avtomatik olaraq, onları şüurlu şəkildə idarə etmək imkanı olmadan qəbul edildiyini izah edə bilər.

Gəzintidə olduğu kimi, hərəkətlər də avtomatikdir və yalnız anın içindədir.

Yorğun və ya çətin bir yolda olanda insan hansı addımı atacağını düşünür. Eynilə, heç bir şüurlu hərəkət etmədən müəyyən insanlara qarşı rəğbət və ya antipatiya hissləri yaranır. İnsan özünü sevməyə, nifrət etməyə və ya qorxudan azad olmağa məcbur edə bilməz və s.

Hisslərini gizlətmək mümkündür, lakin çox vaxt böyük çətinliklə. Bədii şəkildə

tamaşa göstərmək, "fasad" saxlamaq, əslində yaşadıklarını gizlətmək bacarığı

cəmiyyətdəki mövqeyini qorumağın vacib elementidir, lakin bütün bunlar

insanın əsl emosional vəziyyətini əks etdirmir. Belə bir

rolu, belə bir davranışı öz üzərinə götürmək qərarı, avtomatlaşdırılmış funksiyalarda bir fəaliyyət formasını digərindən üstün tutarkən baş verdiyi kimi, şüurumuzdan kənarda baş verir.

Bu cür fəaliyyətləri əldə etdiyimiz dövrləri xatırlayaraq, düzgün fəaliyyət formasını seçməyin çətinliklərini izləyə bilərik. Məsələn, üzməyi, xizək sürməyi, at sürməyi və ya çap etməyi öyrənərkən bir çox variantdan ən yaxşısını seçir və onları mümkün qədər səylə yerinə yetirməyə çalışırıq.

Uşağın ilk addımlarını atmasını izləyərkən, onun bu fəaliyyətdəki söylərini, təəddüdlərini, sınaqlarını və səhvlərini görə bilərik.

Ətraf mühitdə əsas oriyentasiyanın qurulması prosesini, yəni "əvvəl" və ya "uzaq" mövqeyini qəbul etmək qərarını izləmək daha çətinidir. Bu oriyentasiya fərd ilə onun mühiti arasındakı sərhədin hələ ortaya çıxmamışdan əvvəlki dövrdə ortaya çıxır. Bu sərhəd tədricən, xarici mühitdən gələn stimullar qavranıldıqca və reaksiya inkişaf etdikcə, yəni informasiya mübadiləsi və bununla birlikdə məkan və zaman kateqoriyaları inkişaf etdikcə ortaya çıxır. Doğuşdan əvvəlki və erkən inkişaf dövrlərində "məkan və zaman" doldurulur; "mən" və ya "ətraf dünya", səbəb və ya nəticə, deməli, keçmiş və ya gələcək yoxdur; bu əsas anlayışlar insanın öz hərəkətləri və onların nəticələrini qəbul etməsi yolu ilə yaranır.

Ətraf mühitlə ilk signal mübadiləsi sosial mühitdə baş verir. Ana bu signalların qəbulunda fəal iştirak edir və onun fəaliyyəti onlara təsir göstərir.

İnformasiya mübadiləsinin bu ilk dövründə əsas emosional vəziyyətin ("əvvəl" və "başla" mövqelərinin) izlənməsi çox ehtimal olunur. Hətta körpələrdə belə, onların davranışlarında fərqlər müşahidə edilə bilər. Bəziləri dünyanı "bəli" ilə qəbul edir və bu, onları sevindirir və cəlb edir, digərləri isə "yox" ilə qəbul edir və sonra dünya darıxdırıcı və iyrənc olur. Əsas emosional davranışa genetik quruluş, prenatal dövrün gedişi, doğuş travması və ətraf aləmlə signal mübadiləsinin nə dərəcədə təsir etdiyini müəyyən etmək çətinidir. Hər halda, signal mübadiləsinin emosional həyatın sonrakı gedişatını müəyyən edən qalıcı bir iz buraxdığı görünür.

Əsas emosional oriyentasiya müəyyən bir şəxs və onun mühiti arasında müəyyən bir sərhədin olmadığı bir dövrdə ortaya çıxır. Görünür, bu, emosional vəziyyətin iki istiqamətliliyinin mənbəyidir. Obyekt və subyektiv qiymətləndirmə arasındakı sərhədin dəqiq müəyyən edildiyi idrak proseslərindən fərqli olaraq, emosional proseslərdə bu sərhədi müəyyən etmək çətinidir. Emosional vektorun eyni vaxtda iki oxu var - biri xaricə, digəri isə daxilə yönəlir. Ətrafımızdakı dünyaya qarşı mənfi hissləri gizlətməklə, eyni zamanda özümüz haqqında da onları gizlədirik; eyni şey müsbət emosiyalara da aiddir. Emosional həyatın təkamülü zehni inkişafdan xeyli yavaş gedir və bu amil onun əsas formalarının erkən uşaqlıqdan qalmasını izah edə bilər. // MƏNƏVİ QORXU (SOSIAL REFLEKSİYANIN DAXİLİLƏŞDİRİLMƏSİ)

Mənəvi qorxu sosial qorxunun sonrakı inkişafı kimi qəbul edilə bilər. Bu halda sosial refleksiya

daxililəşmədən, yəni başqaları (məsələn, valideynlər, sosial qrup) tərəfindən təklif edilən müəyyən fikirlərin, davranış formalarının və normaların özününkü kimi qəbul edilməsindən keçir. Əvvəlcə bunlar hörmətlə qəbul edilir, lakin yenə də başqalarının reaksiyaları kimi.

Davranışımızı qiymətləndirən və hər addımımızı izləyən hakim

daxilimizə daxil olur və şəxsiyyətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilir — Sokrat daimoniyası,

vicdanın səsi və ya Freyd supereqosu (supereqo anlayışı vicdan anlayışından daha genişdir, çünki o, bilinçaltı prosesləri əhatə edir, vicdan isə yalnız

şüurlu hərəkətlərə aiddir).

Yuxarıda təqdim olunan modelə görə, sosial refleksiyanın daxililəşməsi

sosial mühitdən gələn əks əlaqə siqnallarını şəxsi yaddaş qeydlərindən gələn siqnallarla əvəz etməkdən ibarətdir. Yaddaş ətraf aləmdən müstəqillik hissi yaradır; yaddaş sabitləşdirici qüvvə kimi çıxış edir; onsuz ətraf mühitdən dəyişən siqnalların təsiri altında daimi dalğalanmalar baş verərdi.

İlk sosial geribildirim siqnallarının izlənməsi daha erkən, hətta insanı ətraf aləmdən ayıran sərhədin qeyri-müəyyən şəkildə çəkildiyi dövrdə belə baş verir və bu da inkişafın birinci mərhələsində daxililəşməni asanlaşdırır. Əvvəlcə xarici olan hər şey sonradan şəxsiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir.

Xaricdən daxilə keçid müəyyən bir əks olunma deformasiyası ilə əlaqələndirilir.

Daxili sosial əks olunma, bir qayda olaraq, daxili əks olunma ilə müqayisədə güclü bir inkişaf təmin edir ki, bu da "insan özünün ən qorxunc hakimidir" və bəzən hətta "öz cəlladıdır" kimi məşhur deyimlərdə ifadə olunur.

Freyd və onun davamçıları supereqonun dəhşətli ölçülərini vurğulayırlar və psixiatrik praktikada şüurlu və ya bilinçaltı özünü qınaqdan irəli gələn nevroitik və hətta psixotik simptomlara tez-tez rast gəlinir.

// Daxililəşmə nəticəsində öz əksinin təhrif olunması

Daxililəşmə nəticəsində öz əksinin təhrif olunması iki amilə aid edilə bilər. Birincisi, sosial əks olunmanın izlənməsinin baş verdiyi dövrün özüdür. Uşaqlıqda sosial mühitə baxış mahiyyət etibarilə yuxarıya doğru baxışdır; Bu baxımdan, realıq böyük bir deformasiyaya məruz qalır. Bu deformasiya, uşaq böyüdükcə belə davam edir, çünki vacib fiqurların obrazı daha əvvəl sabitləşib və sabitləşdikləri formada özünü göstərir.

İkinci amil daxililəşmənin özüdür; hansısa elementin xarici dünyadan daxili məkana nüfuz etməsi insanı ona təsir etmək qabiliyyətindən məhrum edir; o, qeyri-əməliyyat xarakterli, muxtar bir elementə çevrilir. İnsan yalnız zahirən hərəkət edə bilər; daxilə olan hər şey fəaliyyətimiz üçün əlçatmazdır. Buna görə də, cəmiyyətin xarici əksi daxili əksindən daha az təhlükəlidir. Xarici təsir insanın davranışı ilə dəyişdirilə və dəyişdirilə bilər, lakin daxili ilə bağlı olaraq biz aciz qalırıq.

Eyni səbəbdən, yuxu vəziyyətləri oyaq həyatdakı eyni vəziyyətlərdən xeyli təhlükəli görünür. Yuxu zamanı insan hərəkət etmək və realığa təsir etmək qabiliyyətindən məhrum olur. Belə acizlik özünə münasibətdədir.

yuxularda müşahidə olunur.

Sosial əksin daxililəşməsi faktından iki ümumi nəticə çıxarmaq olar.

Birincisi, sosial mühitin insan strukturunun inkişafı üçün əhəmiyyəti, ikincisi isə eyni strukturun şizləri (bifurkasiyası) ilə bağlıdır.

// Sosial İrs

Sosial mühit bizə yalnız xaricdən deyil, həm də daxildən təsir edir və bu ikinci təsir daha da güclüdür. Əhəmiyyətli fiqurların izlənməsi uşaqlıqda ən güclü olsa da, insan həyat boyu sosial mühitin elementlərini mənimsəyir: ya davranışlarının nümunəsi və hakimi olan canlı insanların obrazı, ya da tarixdən, ədəbiyyatdan, dindən və s. ideal fiqurlar,

onlar yaddaşlarına, bədənlərinə daxil olduqları üçün yenidən canlanmış kimi görünürlər, ya da müəyyən bir insanın istəklərinin obyektinə və

öz dəyərlərinin ölçüsünə çevrilən mücərrəd dəyərlər.

Beləliklə, nəsildən-nəslə miras qalma mexanizmi vasitəsilə ötürülən və əsasən təsadüfə əsaslanan (reproduktiv hüceyrələrin meiozu və onların birləşməsi) ötürülmə anında transformasiyalara məruz qalan insan bioloji quruluşu ilə yanaşı, müəyyən dərəcədə təsadüfi bir sosial quruluş da yaradılır, çünki insan təsadüfi olaraq müəyyən bir sosial qrupa düşür və onun hansı ətraf mühit təsirlərinə məruz qalacağı məlum deyil.

Bu iki strukturun (bioloji və sosial miras) ayrılması yalnız uydurmadır - onlar ayrılmaz şəkildə bağlıdır.

Genetik plan yalnız ətraf mühitlə enerjili və informasiya mübadiləsi yolu ilə həyata keçirilə bilər və məlum olduğu kimi, ətraf mühit amillərinin təsiri altında dəyişə bilər. Sosial mühitdən gələn siqnallar insan orqanizminin bütövlüyünə (davranışına) nəzarət etməkdə əsas rol oynayır; onlar ən vacib geribildirim döngələrini təşkil edir, genetik planın inkişafını stimullaşdırır və ya maneə törədir.

// Şizis

Hər iki strukturun - genetik və sosial (bioloji və sosial miras) integrasiyasına baxmayaraq, aralarında ətraf mühitlə signal mübadiləsində müəyyən bir bifurkasiya mövcuddur. Bu, ətraf mühitlə mübadilə prosesi sabit olduğundan və doğumdan ölümə qədər fəaliyyət planı ətraf mühitin təzyiqi altında dəyişdiyindən baş verir. Xarici aləmdən gələn siqnallar əks əlaqə, yəni mövcud fəaliyyət planının korrektor kimi çıxış etdiyindən, şüur tərəfindən daha yaxşı bir şey, insanın can atdığı ideal kimi qəbul edilir.

Sosial əksin idealizasiyasına, artıq qeyd olunan fakt təsir göstərir ki, onun

izlənməsi uşaqlıqda, ətraf mühitə mütləq baxdığımız zaman baş verir. Sosial əksin daxililəşdirilməsinin nəticəsi daxili bir "bifurkasiya"dır - id və superego, Dr. Jekyll və cənab Hyde, şeytan və mələk, şər və xeyir.

Xeyir hakim rolunu oynayan şeydir, yəni davranış ölçüsü və arzu məqsədi kimi xidmət edən bir quruluşdur.

Hər bir idarəetmə sistemində, hətta texniki sistemdə belə, əks fəaliyyət planları arasında rəqabətə ehtiyac var; ən yaxşı plan...

Geribildirimin korreksiyaedici təsiri altında yaranan qorxu. Bu anlayışda, mənəvi qorxu fəaliyyət planlarından biri ilə geribildirim arasında uyğunsuzluq signalı olardı.

// DƏYİŞMƏ QORXUSU. MƏLUMAT METABOLİZMİNİN DİNAMİK STRUKTURU

Dəyişmə qorxusu informasiya mübadiləsinin strukturundakı hər bir dəyişikliklə yaranır. Xarici mühitlə signal mübadiləsinin xarakterik xüsusiyyəti

daimi dəyişkənlikdir. Yeni stimullar bədənə daim təsir göstərir və

onların təsiri altında onun daxilində daim yeni reaksiyalar baş verir ki, bunlar

ətraf mühitə göndərilən siqnallara çevrilir. Lakin bu dəyişkənlik daxilində

açıq-aşkar bir sabitlik var; enerji mübadiləsinin strukturuna bənzər bir şəkildə informasiya mübadiləsinin spesifik strukturu

yaranır.

Müəyyən bir orqanizm tərəfindən yalnız müəyyən ətraf mühit enerjisi formaları istifadə edilə və unikal şəkildə dəyişdirilə bildiyi kimi, yalnız müəyyən ətraf mühit siqnalları da orqanizm tərəfindən vurğulanır və spesifik, öz-özünə yaradılmış şəkildə emal olunur ki, bu da spesifik təcrübələrə və spesifik reaksiya formalarına gətirib çıxarır.

Bu hallarda müxtəliflik enerji mübadiləsindən xeyli böyükdür, yəni fərdi növlər və növ cəmiyyəti daxilindəki vahidlər arasında daha böyük fərq var.

Struktur təbiətə dinamikdir, yəni daim məhv edilməli və

yenidən yaradılmalıdır. Təkrarlanan xarici siqnallar orqanizmin reaksiyalarının tükənməsinə səbəb olur; onlar fərqli keyfiyyət xarakteri qazanır və orqanizmin təkrarlanan siqnalları (onun motor, şifahi reaksiyaları və s.) müəyyən bir müddətdən sonra

avtomatlaşdırmaya məruz qalır, yəni onlar informasiya mübadiləsinə idarə edən sistemin ən iqtisadi əməliyyatı ilə istehsal olunur ki, bu da subyektiv olaraq onların şüurlu fəaliyyətdən kənarlaşdırılmasında ifadə olunur. Bədən daim ətraf aləmdən yeni siqnallarla təmin edilməli və daim yeni reaksiya nümunələri inkişaf etdirməlidir. Digər tərəfdən, informasiya mübadiləsinin bu daimi dəyişkənliyində o, özünəməxsus strukturunu aş a bilməz. Alınan və göndərilən siqnallar yeni olmalıdır, lakin tamamilə yeni olmamalıdır; onlar müəyyən bir orqanizmin özünəməxsus strukturunu aş a bilməzlər. Hər bir orqanizm özünəməxsus zülal qurduğu kimi, daxil olan siqnallardan da özünəməxsus naxışlar qurur və bu naxışlar xarici aləmdə ətraf mühitə göndərilən siqnallar kimi özünü göstərir. Bu quruluşa uyğun olmayan hər şey qəbul edilmir və bədənə görünmür.

Elektromaqnit dalğaları dar bir işıq dalğası şüası xaricində görünmür; spesifik reseptorları qıcıqlandırmayan kimyəvi maddələr qoxu və ya dadla aşkar edilə bilməz; hava titrəmələri eşidilən tezlik diapazonundan kənardadırsa, eşidilə bilməz. İnsanlar polyarlaşdırılmış və ya ultrabənövşəyi işığı qəbul etmirlər, baxmayaraq ki, bəzi həşəratlar bunu hiss edirlər.

Ətraflarında baş verən hər şeyin yalnız kiçik bir hissəsi bədənə nüfuz edir, reseptorlarını qıcıqlandırır və sinir impulsuna səbəb olur (əlbəttə ki, reseptor-sinir-effektor aparatına malik olan orqanizmlərdə, yəni stimül qəbul edən (reseptorlar), onları ötürən və integrasiya edən (neyronlar) və bədənədən göndərilən siqnallar hesab edilə bilən müxtəlif hərəkət formaları ilə cavab verən ixtisaslaşmış hüceyrələr qrupunda). Aşağı səviyyəli orqanizmlərdə

Filogenetik inkişaf zamanı fərdi hüceyrə signal sistemi (yəni reseptor, effektor və sinir hüceyrələri) üçün nəzərdə tutulmuş rolu yerinə yetirə bilər.

Reseptorlarda xarici siqnallar bədənə daxili siqnallarına - sinir impulslarına çevrilir. Sinir impulslarının məkan və zaman paylanması, yəni onların quruluşu, xarici mühitdə baş verənlər və subyektiv olaraq ətraf aləmin mənzərəsi kimi qəbul edilənlər haqqında bizə məlumat verir. Bu günə qədər ətraf aləmin qavranılan mənzərəsinin reallığa nə dərəcədə uyğun gəldiyi məlum deyil. Bədənə hərəkətlərinin boşluğa deyil, real dünyaya daxil olması və onu müəyyən bir şəkildə dəyişdirməsi, yaradılan mənzərənin reallığını göstərir.

// Ehtimal Prinsipi

Signal metabolizmasının xarakterik bir xüsusiyyəti, müəyyən dərəcədə enerji metabolizmasının strukturuna bənzər quruluşudur. Ehtimal prinsipi xarici mühitlə signal mübadiləsinin strukturundan irəli gəlir - ətraf mühitə uyğun gələn hər şey ehtimal olunur. Bu mübadilənin strukturu qeyri-mümkündür və ona uyğun olmayan hər şey qeyri-mümkündür. Bədənə daxil olan və çıxan siqnalların müəyyən dərəcədə ehtimalı var, bu, müəyyən bir quruluşun fəaliyyətini nə dərəcədə gücləndirdiyindən asılıdır. Günəşin səhər doğması ehtimalı var, bu, uşaqlıqdan bəri öyrəşdiyimiz bir şeydir; bu quruluş

mənimsəyib və onun pozulması, məsələn, günəş tutulması zamanı qorxu hissi yaradır.

Gəzərkən ayaqlarımızın möhkəm, sarsılmaz yerə düşməsi ehtimalı var. Əksi, məsələn, zəlzələ zamanı və ya bataqlıqda, yaxud gəminin göyertəsindəki fırtına zamanı tarazlığın pozulması nəticəsində baş verərsə, bu gücləndirilmiş quruluşun pozulması qorxu ilə müşayiət olunur.

Həmsöhbətimizin üzünün birdən canavar ağzına çevrilməməsi ehtimalı var və

əgər bu baş verərsə, dəhşətə, sonra isə maskarad geyiminin maskasını kəşf etdiyimiz zaman gülüşə səbəb olardı. Komik effekt əldə etməyin bir yolu, lakin təhlükəsiz olduğunu sübut edən və dünyanı qavramağın müəyyən edilmiş tərzini pozmayan inanılmaz bir quruluş təqdim etməkdir. Ən yüksək ehtimal dərəcəsinə malik olan hər şey nəticədə üstünlük təşkil edir.

Psixiatriyada aşağı ehtimal dərəcəsinə malik təcrübələrə adi şəxslərarası münasibətlərə nisbətən daha tez-tez rast gəlinir. Buna görə də, onlar

möcüzəli və ya qəribə görünürlər və buna görə də qorxu və ya gülüş hissləri yaradırlar. "Möcüzəli" sözünün etimologiyasını xatırlamağa dəyər: o, ari kökü olan "diw" - aydın, parlaq və buna görə də hindu ("dewas") və latınca "deus" tanrı mənasını verir. Qeyri-mümkün olan, xarici mühitlə informasiya mübadiləsinin normal strukturuna sığmayan hər şey insanda qorxu və maraq hisslərini əks etdirir: fəvqəladə şeylər cəlb edir və dəf edir.

Qorxu hissi xarici mühitlə signal mübadiləsinin iki ucunda özünü göstərir: çox yüksək ehtimalın sonunda, yeni və ya qeyri-adi bir şeyin baş verə bilmədiyi zaman və aşağı ehtimalın sonunda, ətrafdakı hər şey möcüzəli və qeyri-adi hala gəldikdə. Birinci halda, həyatın monotonluğu və cansıxıcılığı ilə müşayiət olunan daxili gərginlik və narahatlıq var; digərində isə qeyri-adi təcrübələrlə müşayiət olunan qeyri-müəyyənlik, təhlükə və qarışıqlıq hissi var.

Reseptoru effektorla birləşdirən refleks qövsü insanlarda hətta ali heyvanlarla müqayisədə müqayisəolunmaz dərəcədə uzundur. Milyardlarla sinir hüceyrəsi ola bilər

Aktivləşdirildikdən sonra onlar bir-biri ilə çoxsaylı kombinasiyalar, yəni müxtəlif funksional strukturlar əmələ gətirirlər. Sinir sistemindəki potensial funksional strukturların sayını saymaq asan deyil və ümumiyyətlə sayla biləcəyi məlum deyil.

Çox böyük bir sadələşdirmədən istifadə edərək, bu halda sözdə permutasiyalardan istifadə edə bilərik. Əgər sinir sistemi yalnız iki neyrona, A və B-dən ibarət olsaydı, onda onlar arasında AB və BA funksional əlaqələri yaranardı. (Morfoloji və funksional əlaqələr arasındakı fərqi qeyd etmək lazımdır. Birinci halda, yalnız AB = BA əlaqəsi mümkün olardı, digər halda isə iki əlaqə mümkündür, çünki informasiya axınının istiqaməti AB BA burada rol oynayır.) Üç hüceyrə halında altı əlaqə olardı: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA; dörd ilə 4×4 , yəni 24 olardı. "Kombinasiyaların sayı

faktorial ($n!$) adlanan riyazi düsturla müəyyən edilir $1 \times 2 \times 3 \times 4$ və s. n -ə qədər.

Bu düstur sinir sisteminin bir çox digər mövcud imkanlarını nəzərə almır. Məlumdur ki, hüceyrələr arasındakı funksional əlaqə

müsbət (həyəcan) və ya mənfi (inhibə) işarələrə malik ola bilər; bu əlaqə

lokal olaraq potensialı dəyişdirir və ya bütün hüceyrənin boşalmasına səbəb ola bilər. Sinir

hüceyrələrinin digər hüceyrələrlə əlaqə qurma ehtimalları fərqlidir və əslində,

bu düsturun proqnozlaşdırdığından xeyli çox mümkün kombinasiyalar mövcuddur.

İnsan sinir sistemində 10 milyarddan çox (10^{10}) neyron var, yəni sadələşdirmə tətbiq edildikdə, potensial funksional strukturların sayı

təxminən 10^{10} olmalıdır! (10 milyardın faktorialı). Bu sayı hesablamaq üçün

fərdi amillərin loqarifmini götürürük ki, bu da müəyyən bir vaxt, məsələn, saniyə çəkir.

Üçün Loqarifmləri tapın, 10^{10} saniyə tələb olunur. Daha sonra, loqarifmlərin cəmini qurmalyıq ki, bu da 10^{10} saniyə vaxt tələb edir. Cəm 2×10^{10} saniyə olmalıdır. 10^6 saniyə təxminən iki həftə olduğundan, hesablama 2×10^{10} saniyə, yəni təxminən 800 il tələb edir. Verilən hesablama təxmini xarakter daşıyır.*

Müxtəlif funksional strukturların əmələ gəlməsi üçün bu fəvqəladə imkanlar, xaricdən gələn hər şeyin hazırlanmış torpağa düşməsinə və buna görə də həmişə az-çox uyğun bir quruluş tapa bilməsinə gətirib çıxarır. Məşhur deyimi parodiya edərək, "beyincikdə nihil novi" demək olar.

Müşahidə edilən reallıq planlar, xəyallar və xəyallar, nağıllar, şizofreniya xəyalları və halüsinasiyalarla dəfələrlə üstələnir.

// Qrادیент Sabitliyi

İnsan öz siqnal strukturunun sərhədlərini aşma bilməz, lakin siqnal sistemi daim dəyişkənlik qabiliyyətinə malikdir. Xarici mühitdən təkrarlanan siqnallar reseptor reaksiyalarını doğurmağı dayandırır. Sürətli adaptasiya fenomeni eksteroseptorlarda, yəni ətraf aləmdən stimula qəbul edən reseptorlarda özünü göstərir. İnteroreseptorlar (bədənin daxili boşluqlarından siqnal qəbul edən reseptorlar) daha yavaş uyğunlaşırlar. Dəyişkənlik daxili mühitlə deyil, xarici mühitlə əlaqəli olaraq zəruridir. Bədəndə müəyyən sabitlər, məsələn, bədən temperaturu, hidrogen ionlarının konsentrasiyası (toxumaların və bioloji mayələrin turşuluğu), kalium və natrium ionları, şəkər miqdarı və s. saxlanılmalıdır. Bu sabitlər pozulduqda, müvafiq reseptorlar müəyyən bir müddət ərzində reaksiya verməlidirlər (yəni, istehsal edirlər)

Sinir impulsları) tarazlıq bərpa olunana qədər. Daxili mühitdəki stimullara sürətli uyğunlaşma, strukturun həyatı üçün zəruri şərt olan bədənə sabitlərinin pozulmasına səbəb olardı.

Bədənin daxili siqnalları pozulmuş tarazlığı bərpa etmək üçün müəyyən bir müddət ərzində təsir göstərməlidir. Tarazlıq visseral mexanizmlərin təsiri ilə bərpa olunur. Məsələn, qan şəkərinin azalması adrenalin və qlükotrop hormonların adrenalin və qlükotrop hormonların adrenalin və qlükotrop hormonların sərbəst buraxılmasını stimullaşdırır ki, bu da öz növbəsində qlükogeni qlükozaya parçalayır. Və ya qidanın alınması və onun qəbulu qan şəkərinin normallaşmasına gətirib çıxarır.

Beləliklə, siqnal metabolizmasının ümumi bir prinsiplə idarə olunduğunu demək olar: ətraf mühit dəyişkəndir, bədənin özü isə dəyişməzdir. Bu təklif yalnız reseptorlara deyil, siqnal mübadiləsi zəncirindəki bütün halqalara da aiddir. Reseptorlar kimi, onlar da təkrarlanan siqnallara cavab verməyi dayandırır.

Xarici mühitdən alınan və monoton şəkildə təkrarlanan siqnallar xarici dünya ilə siqnal mübadiləsinin qismən və ya tamamilə dayandırılmasına səbəb olur. Belə hallarda, diqqət yayınma, yəni ətraf mühitlə müəyyən bir təmas müddətində informasiya mübadiləsinin zəifləməsi, ardınca yorğunluq, yuxululuq və nəhayət, yuxu baş verir ki, bu da xarici dünya ilə təmasın bütün səthində bu informasiya mübadiləsinə pozur.

İnformasiya mübadiləsinin strukturu müəyyən bir sabit qradiyentə malik olmalıdır; ən kiçiki xarici mühitlə sərhəddə, ən böyüyü isə daxili mühitlə. Birincisinin dəyişkənliyinə heç bir fəsad olmadan dözülmür, ikincisinə isə böyük çətinliklə dözülmür.

* Bu şərtlərə görə Krakovdakı Mədən və Metallurgiya İnstitutunun Avtomatlaşdırma kafedrasının doktoru Stanislav Olszevskiye təşəkkür etmək istədim.

// İstiqamətləndirmə refleksi

Ətraf mühitlə siqnal mübadiləsinin strukturunda dəyişiklik Pavlovun istiqamətləndirmə refleksi konsepsiyası ilə müəyyən edilir. Yeni bir stimulun təsiri altında bədənin cari fəaliyyəti müvəqqəti olaraq kəsilir (məsələn, qəfil bir səs-küy bir müddət söhbəti kəsir və hamı yaranan səs-küyü dinləyir) və baş, bəzən də bədənin özü stimulun mənbəyinə tərəf dönmür.

Nəticədə, başda telereseptorlar, yəni məsafədən siqnal qəbul edən hiss orqanları olduğundan, reseptor səthinə daha çox siqnal axını çatır.

İstiqamətləndirmə refleksinin bu iki komponenti (xarici dünya ilə cari siqnal mübadiləsinin kəsilməsi və telereseptorların stimullaşdırma mənbəyinə doğru istiqaməti) ürək fəaliyyətinin artması, qan təzyiqinin artması, tənəffüs tezliyinin dəyişməsi və xüsusilə barmaqlarda və ayaq barmaqlarında artan tərləmə şəklində avtonom reaksiyalarla müşayiət olunur ki, bu da görünür ki, dərinin elektrik müqavimətini (qalvanik dəri refleksi) dəyişdirir.

Xarici stimulun təsiri altında beynin bioelektrik fəaliyyətindəki dəyişikliyin ifadəsi inhibə reaksiyasıdır, yəni sakit alfa ritmindən daha çox ritmə keçid.

Daha sürətli və daha az müntəzəm ritm (desinxronizasiya), yəni beta ritm.

Bu, istiqamətləndirmə refleksinin birinci mərhələsini yekunlaşdırır. Kəşfiyyat termini ilə təyin olunan ikinci mərhələ yalnız yeni stimulun ehtimalı ilə bağlı müəyyən bir qərar verildikdən sonra başlaya bilər. Üç seçim mümkündür: artı, mənfi və sıfır. Birinci halda, stimulun mənbəyinə yanaşma, ikinci halda ondan uzaqlaşma və üçüncü halda, stimula tərəfindən kəsilən fəaliyyətə qayıtmaq var. Yalnız birinci halda stimula araşdırıla bilər, yəni istiqamətləndirmə reaksiyasının kəşfiyyat mərhələsi kimi təyin olunan fəaliyyət.

Xarici signal tərəfindən tetiklənən hadisələrin subyektiv mənzərəsinə gəldikdə isə, onu sxematik olaraq aşağıdakı kimi təmsil etmək olar: birinci reaksiya, mövcud vəziyyəti pozan bir səbəbdən yaranan yüngül və keçici narazılıq hissindən gözlənilməz, naməlum stimula yaratdığı güclü və qəfil təəccüb hissi ilə özünü müxtəlif intensivliklə göstərə bilən narahatlıq hissi ilə əlaqələndirilir. Avtonom reaksiyanın gücü adətən emosional reaksiyanın gücü ilə korrelyasiya olunur. Avtonom reaksiya, müşayiət olunan anlaşılmaz narahatlıq hissi ilə birlikdə, hətta istiqamətləndirici stimula şüura çatmadığı hallarda da özünü göstərir. O, istiqamətləndirici reaksiyanın motor komponentindən xeyli uzun müddət davam edir. Bəzən yalnız avtonom komponent və yüngül bir narahatlıq hissi xarici stimula bədənə təsirini göstərir.

Gündəlik müşahidələr göstərir ki, xarici stimula qarşı avtonom və emosional reaksiyaların gücü yalnız həmin stimula gücündən deyil, həm də onun qeyri-adilik dərəcəsindən və şüurun hazırkı vəziyyətindən asılıdır. Bəzi qeyri-adi xışiltılı səslər, şəhər sakininin o qədər tez alışdığı və reaksiya verməyi dayandırdığı daha yüksək küçə səs-küyündən daha güclü istiqamətləndirici reaksiya doğurur.

Yuxudan əvvəl, ətraf mühitlə signal mübadiləsi minimuma endirildikdə, gün ərzində təsirini dayandıran eyni küçə səs-küyü sürətli ürək döyüntüsünə, qəfil qorxu hissəsinə və s. səbəb olur. İstiqamətləndirici stimula yenidən güclü olur, çünki signal mübadiləsinin dayandırıldığı və bədənə stimulları qəbul etməyə hazır olmadığı bir vaxtda bədənə daxil olur.

Nevrasteniya da oxşar vəziyyət baş verir: adi stimullar, məsələn, telefon zəngi, təsadüfi səs, kiminsə səsi, qeyri-mütənasib dərəcədə güclü reaksiyaya səbəb olur. İstiqamətləndirici reaksiya. Başqaları ilə təmas, özlüyündə xoşagəlməz, digər nevroitik təzahürlərə görə, bu artan qıcıqlanma nəticəsində daha da narahatedici olur.

Kəskin və xroniki psixozvi sindromlarda, yəni ümumiyyətlə, ətraf mühitlə signal mübadiləsinin strukturunun əhəmiyyətli dərəcədə pozulduğu hallarda, qeyri-mütənasib istiqamətləndirici reaksiya, huşun itirilməsindən və ya anesteziyadan, epileptik tutmadan və s. oyanma zamanı da özünü göstərir.

Bu pozğunluğun əsas simptomu signal sisteminin seçmə qabiliyyətinin azalmasıdır. Normalda reseptor səthində və ya daha tez-tez refleks zəncirinin ilk halqalarında saxlanılan stimullar,

burada bütün signal sistemini fərqləndirmədən aktivləşdirir. Bu sistemin iki əsas fəaliyyət növündən - həyəcanlanma və inhibədən - sonuncu daha həssasdır, birincisi isə müdaxiləyə həssasdır.

Xarici stimulları seçmək qabiliyyəti, orqanizmin və ya onun mühitinin mövcud vəziyyətindən asılı olaraq dəyişikliklərin baş verdiyi dəyişkənlik şkalası kimi qəbul edilə bilər. Bu şkala boyunca bəzi siqnallar digərlərindən daha asan ötürülür.

Xarici mühitlə normal siqnal mübadiləsi zamanı sıfır dəyişkənliyə yaxınlaşan siqnallar reseptor səthində və ya refleks zəncirinin sonrakı

əlaqələrində dərhal azalır. Yalnız yuxarıda qeyd olunan informasiya mübadiləsinin pozulması vəziyyətlərində onlar selektiv maneəni aşmağa bilirlər. Belə hallarda dəyişkənlik şkalası dəyişir və aşağı dəyərli siqnallar

yüksək dəyərli siqnallar kimi hərəkət edə bilər və əksinə.

Buna görə də, xarici siqnal tamamilə yeni deyil; orqanizmə təsiri ilə onun xarakteri dərhal müəyyən edilir və gələcək taleyi orqanizm tərəfindən necə istifadə olunması ilə müəyyən edilir. O, ümumiyyətlə istiqamətləndirici reaksiya doğura bilməz və ya əksinə, onu doğura bilər; Siqnal diqqətdən kənarda qala bilər, şüura çatma bilər və ya şüurlu iştirak olmadan motor reaksiyasını tetikleyebilir (məsələn, gəzinti zamanı hərəkətlərin əksəriyyəti bilinçaltı siqnallar tərəfindən yaranır) və ya şüurlu reaksiyanı tetikleyebilir. Siqnal yaddaşda şüurlu və ya şüuraltı iz qoya bilər.

// Gözləmə

Reseptor səthindən keçən hər bir xarici siqnal müəyyən dərəcədə siqnal metabolizmasının strukturunu dəyişdirir və eyni zamanda onu zənginləşdirir;

xarici siqnallar informasiya metabolizması üçün qida enerji metabolizması üçün nə deməkdir. Digər tərəfdən, onlar müəyyən dərəcədə bu struktura uyğun olmalıdırlar; onlar tamamilə yeni ola bilməzlər; onların xüsusiyyətləri

təsirlərinin lap əvvəlindən müəyyən edilir. Bu mənada, bədən xarici mühitdə qarşılaşa biləcəyi hər şeyi qabaqcadan görür.

Həm enerji, həm də informasiya metabolizmasının strukturunun pozulması həmişə bədəni təhdid edir, çünki belə bir pozulmanın nəticələri məlum deyil. Subyektiv təhdid siqnalı qorxu hissidir. Enerji strukturunun ətraf mühitlə pozulması halında, bioloji qorxudan, informasiya strukturunun pozulması halında isə parçalanma qorxusundan danışa bilərik.

Qorxu reaksiyasının gücü strukturun pozulması dərəcəsi ilə mütənasibdir. Enerji mübadiləsi halında, məsələn, oksigenin olmaması qidanın olmamasından daha çox; qəfil hormonal disfunksiya halında isə tədricən başlamasından daha çox olacaq. İnformasiya mübadiləsi halında, qorxu reaksiyasının gücü daxil olan siqnal nə qədər az məlum olsa və buna görə də ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqənin mövcud strukturuna bir o qədər az uyğunlaşsa, o qədər çox olar. Revolver atəşi eyni həcmli mühərrikin səs-küyündən daha güclü istiqamətləndirici reaksiya doğurur; müharibə zamanı,

bomba və mərmə partlayışları vərdiş halına gəldikdə, qəfil sükut

o qədər güclü bir siqnala çevrilir ki, birdən çox yatan insanı oyadacaq. Günəş tutulmasının yaratdığı qaranlıq,

elektrik cərəyanının olmamasından

yaranan qaranlıqdan daha güclü qorxu reaksiyası yaradır. LSD və ya başqa bir halüsinogenin təsiri altında ətraf mühitin qavranılmasının dəyişdirilməsi, şüurlu şəkildə qəbul edildikdə, ruhi xəstəlik və ya digər xəstəliklərdə baş verən oxşar vəziyyətlə müqayisədə daha zəif reaksiya yaradır.

Halüsinasiyalara səbəb olan kimyəvi maddə ilə təsadüfən zəhərlənmə.

Qəbul yalnız şüurlu fəaliyyətlə məhdudlaşmır. Bir şəxs gözlənilmədən səkidə bədrəyirsə, xarici mühitlə qarşılıqlı təsirin müəyyən bir seqmentinin strukturunun pozulması ilə əlaqəli qorxu reaksiyası yaranır - hamar yolun ehtimallarına əsaslanan yerləş funksiyası. Bu fərziyyə sayəsində,

yerləş avtomatik olaraq baş verir, bu, hər addımın şüurlu bir hərəkətə çevrildiyi uçurum üzərindən dar yolları keçərkən belə deyil.

Adətən, kiçik bir xüsusiyyət, tək bir işarə, məlum bir obyektə müəyyən etmək üçün kifayətdir və səhv halında, məsələn, zahirən tanış bir şəxs naməlum bir şəxs olduğu ortaya çıxdıqda təəccüb reaksiyası baş verir. Görünür, yaddaş qeydinin daxil olan siqnallarını sıralamaqdan ibarət olan qavrayış təhlili ilə əlaqəli funksiyaların mürəkkəb zənciri şüurun xaricində oynanır. Müşahidə edilən obyektin müəyyən bir yaddaş qeydi kateqoriyasına aid edilə biləcəyinə dair son nəticə şüurlu olur. İstiqamətləndirmə refleksinə qarşı unikal qorxu reaksiyası hesab edilə bilən sürpriz reaksiyası, informasiya mübadiləsinin gözlənilən və faktiki pozulması formaları arasındakı qeyri-mütənasibliklə mütənasibdir.

Şüurlu səviyyədə uzaqgörənlik qabiliyyəti kimi qəbul edilən gələcəyə proyeksiya, enerji mübadiləsi ilə yanaşı, informasiya mübadiləsinin və ümumiyyətlə, metabolizmin vacib xüsusiyyətini təşkil edir. Bu proyeksiya canlı təbiətin fundamental xüsusiyyəti hesab edilə bilər. Ən sadə təkhüceyrəli orqanizmdən tutmuş insanlar da daxil olmaqla, çoxhüceyrəli orqanizmlərin ən inkişaf etmiş formalarına qədər hər bir canlı öz genetik planını ətraf mühitlə enerji və məlumat mübadiləsi apararaq həyata keçirir. Sosial şəraitdən asılı olaraq, genetik planı həyata keçirmək imkanı daralır və ya genişlənir. Planın özü xarici mühitin təsiri altında dəyişikliklərə məruz qala bilər. Belə modifikasiyanın mümkün dərəcəsi hələ dəqiq müəyyən edilməyib. Plan anlayışı gələcəyə baxışı, uzaqgörənliyi əhatə edir.

Təbiətin realizmi planın ətraf mühitin imkanları ilə ümumi uyğunluğundan ibarətdir.

Yalnız ətraf mühitlə daimi mübadilə yolu ilə reallaşa bilən inkişafının gələcək mərhələlərini "gözləyərək", orqanizm, ən azı müəyyən dərəcədə, ətraf mühitin ona münasibətini "gözləməlidir". İnsan şüurunda keçmiş və ya artıq əldə edilmiş şey gələcəkdən və hələ də edilməli olan şeylərdən kəskin şəkildə fərqlənir. Bəlkə də heyvanlar aləmində bu sərhəd o qədər də kəskin deyil.

Zaman koordinatı, məkan koordinatlarla birlikdə, informasiya mübadiləsi strukturunun ən əhəmiyyətli elementini təşkil edir, çünki sinir signalı xarici stimulların növündən keyfiyyətcə müstəqildir və ətraf mühitin mənzərəsi sinir siqnallarının zaman-məkan kətanında heterojen lokalizasiyasına əsaslanaraq yaradılır. Siqnalların bu düzülüşü signal mübadiləsinin faktiki funksional strukturunu təşkil edir; əvvəlki struktur məhv edilməli və onun yerinə yenisi qurulmalıdır. Bu daimi məhv və tikinti signal sisteminin işinin ən xarakterik xüsusiyyətidir.

İnteqrasiya və parçalanma

Xarici və ya daxili siqnal axınının yaratdığı informasiya mübadiləsi strukturunun dağılması mövcud dağılmanın üzərinə qoyulur; bu üst-üstə düşmə nəticəsində onlar ümumilikdə arta və ya azala bilər. Məsələn, işə qarışan bir insanda yeni bir stimula dağılmanı artırır, onu dağıdır. Əksinə, istirahət edən bir insanda oxşar bir stimula dağılmanı azalda bilər, yəni onun sayəsində informasiya mübadiləsinin yeni bir strukturu yarana bilər (yeni bir fikir, yeni bir təəssürat, bir yaddaş və s. yarana bilər).

Bu anlayışda, informasiya mübadiləsi qaydasının pozulmasının subyektiv ifadəsi kimi qorxu, mövcud qaydanın tamamilə məhv edilməsindən qaynaqlanan panikaya normal yönümlü reaksiya zamanı, məsələn, fəlakət və ya kəskin şizofreniya vəziyyətində, demək olar ki, hiss olunmayan bir narahatlıqdan insana həmişə müşayiət edərdi. Bəzi psixiatrlar qorxuya hazırlıqdan danışirlər. Əsasən, bu hazırlıq hər bir insanda müxtəlif dərəcələrdə özünü göstərir, çünki informasiya mübadiləsində mövcud olan müəyyən bir qayda ilə əlaqələndirilir. Siqnal sistemi nə qədər dəqiqdirsə və xarici mühitlə informasiya mübadiləsi nə qədər mürəkkəbdirsə, sabit tarazlığı qorumaq bir o qədər çətinləşir.

AVTOMATİK POZUNTULAR

// SOMATİK VƏ AVTOMATİK SİNİR SİSTEMLƏRİ

Siqnal sistemi tez-tez somatik və vegetativ (avtonom) bölünür.

Birincisi xarici mühitlə, ikincisi isə daxili mühitlə siqnal mübadiləsi ilə məşğul olur. Bu bölmə tamamilə dəqiq deyil, çünki hərəkət sistemindən gələn siqnallar (əzələlərdən, oynaqlardan, vətərlərdən və s.), proprioceptorlar adı ilə təyin olunsa da, bədən boşluqlarında əmələ gəlsələr də, somatik sistemin siqnallarına aiddir, çünki onlar bədənədən kənarda, yəni bütün hərəkət formaları üçün əmələ gələn siqnallara bir növ cavab təşkil edirlər. Digər tərəfdən, uzun solğunluğu və ya qızarması, ovucların həddindən artıq tərləməsi, göz bəbəklərinin genişlənməsi, qaz qabarması və s. kimi müəyyən vegetativ reaksiyalar xarici mühitə göndərilən və insanın emosional vəziyyətini dəfələrlə göstərən siqnallar kimi qəbul edilə bilər.

Bütün bunlar vegetativ reaksiyalar hesab edilməsinə baxmayaraq, onların xarici təzahürləri

çox vaxt arxa plana keçir və mahiyyəti daxili

informasiya mübadiləsinə aid edilir. Vegetativ sistem həmçinin vegetativ olaraq təyin olunur. Bu konsepsiya onun şüurlu zehni

proseslərdən, xüsusən də müəyyən bir funksional

strukturu seçmək qərarından, yəni iradə aktından müstəqilliyini vurğulayır. Vegetativ sistemdən fərqli olaraq, somatik

sistem də oxşar şəkildə iradə sistemi adlanır. Somatik sistem tərəfindən idarə olunan bir çox funksiyalar - gəzmək, danışmaq, yazmaq və bu kimi avtomatlaşdırılmış funksiyalar - şüurun xaricində yerinə yetirilsə də, zəruri hallarda şüurlu şəkildə idarə oluna bilər. Digər tərəfdən, vegetativ funksiyalar sözün əsl mənasında avtomatik hesab edilə bilər; onları öz iradəsi ilə idarə etmək olmaz.

İradədən asılı funksiyalarla avtomatik funksiyalar arasındakı sərhəd də kəskin deyil.

Əsasən avtonom funksiyaları təmsil edən nəfəs alma tam avtomatlaşdırılmayıb və iradə aktından asılı ola bilər. Bu asılılıq, ehtimal ki, nəfəs almanın mühüm rol oynadığı nitq funksiyası ilə əlaqədardır.

Anatomik baxımdan, avtonom və somatik sistemlər arasındakı fərq xüsusilə periferiyada aydın görünür və mərkəzi bölgədə bulanıqdır. Xeyr.

Anatomik nüanslara nəzər saldıqda, bu fərqi avtonom sistemin daha böyük bir mərkəzdən kənarlaşması kimi görmək olar. Onun idarəetmə vahidləri - neyronların hüceyrə cisimləri - somatik sistemə nisbətən fəaliyyət ərazisinə daha yaxın yerləşir. Avtonom sistem üçün fəaliyyət ərazisi bədən özüdür; o, daxili signal sistemi kimidir: signal bədən müxtəlif orqanlarından alınır və sonra onlara geri göndərilir. Somatik sistem üçün fəaliyyət ərazisi xarici mühitdir: signal oradan gəlir və hərəkət şəklində geri göndərilir. Öz ərazisində qalaraq avtonom sistem, sanki öz təhlükəsizliyini təmin edirmiş kimi, fəaliyyət yerinə yaxınlaşa bilər, somatik sistem isə yad ərazidən uzaqlaşır və ondan daha təcrid olunur. Simpatik və Parasimpatik Sinir Sistemləri

Parasimpatik sinir sistemi daxili orqanlara daha yaxın yerləşir (bəzi sinir hüceyrələri koloniyaları daxili orqanların özlərində və ya onların yaxınlığında yerləşir), simpatik sinir sistemi isə fəaliyyət sahəsindən daha uzaqda yerləşir (hüceyrə koloniyaları onurğa sütununun qarşısında - prevertebral pleksuslarda yerləşir).

Lokalizasiyadakı bu fərq, ehtimal ki, iki sistemin fərqli fəaliyyət nümunələrindən qaynaqlanır. Parasimpatik sistem anabolik prosesləri, yəni struktur prosesləri gücləndirir; enerji mübadiləsi vektoru bədəninə yönəldilir və xarici mühitin maddəsi və enerjisi bədənə spesifik enerji strukturuna və maddəsinə çevrilir.

Simpatik sistem katabolik prosesləri, yəni parçalanma proseslərini gücləndirir;

ətraf mühitlə enerji mübadiləsi vektoru xaricə yönəldilir. Bədənə spesifik energetik-maddi quruluşu qeyri-spesifik mexaniki və istilik enerjisi, bədən tərəfindən ifraz olunan nisbətən sadə kimyəvi maddələr və s. ilə mübadilə olunur. Quruluş prosesi məhv prosesindən daha mürəkkəbdir, buna görə də idarəetmə mərkəzləri təsir yerinə daha yaxın yerləşir.

İkinci lokalizasiya fərqi simpatik sistemin mərkəzi sistemlə orta hissəsində (döş-bel bölgəsi), parasimpatik sistemin isə ekstremal hissələrlə (beyin və sakral bölgələr) birləşməsidir. Sinir sisteminin oxu ilə bu qədər təəccüblü əlaqə, dağıdıcı prosesləri stimullaşdıran simpatik sistemin bədənə döyüşə və ya qaçmağa hazırlaşdığı zaman ən aktiv olması faktından irəli gələ bilər. Daha sonra böyük əzələ kütlələri aktivləşir və onlar bədənə oxunun tam orta hissəsində yerləşir. Digər tərəfdən, struktur prosesləri stimullaşdıran parasimpatik sistem, bədənə baş segmentində (ağız dəliyi) və terminal segmentində (ilkin dəlik) lokallaşdırılmış qidalanma və cinsi funksiyalara hazırlığı zamanı ən aktivdir. Sinir sisteminin mərkəzi oxu boyunca simpatik və parasimpatik sistemlər arasındakı lokalizasiya fərqləri bulanıqdır. Hansı hüceyrə sinir koloniyalarının birinə və ya digərinə aid olduğunu müəyyən etmək çətindir. Lokalizasiya fərdi funksiyaları əhatə edir: tənəffüsü və qan dövrənini idarə edən sinir hüceyrələrinin əsas aqlomerasiyaları beyin kötyünün aşağı segmentlərində (medulla oblongata və körpülərdə), su, enerji və lipid metabolizması, termorequlyasiya, həzm və reproduktiv funksiyalar və s. üçün sinir mərkəzləri isə subtalamik bölgədə yerləşir. Bu mərkəzlər həm simpatik, həm də parasimpatik sistemləri idarə edir. Anabolik və katabolik proseslər -

Tikinti və dağıdıcılıq bir-biri ilə sıx bağlıdır və onların müstəqil idarə olunması qeyri-mümkün olur. Bütün deyilənlərdən aydın olur ki, bu iki proses - tikinti və dağıdıcılıq - bir-biri ilə sıx bağlıdır və həyatın dialektikası məhz onların üzərindədir.

// Hipotalamus və Qoxu Beyni

Hipotalamus vegetativ funksiyaların əsas mərkəzi hesab olunur. Hipofiz vəzi vasitəsilə hipotalamus endokrin sistemlə bağlıdır. Vegetativ sistemdəki hipotalamus kimi hipofiz vəzi endokrin sistemdə mərkəzi rol oynayır. Bu o demək deyil ki,

sinir sisteminin filogenetik cəhətdən daha yaşlı hissələrində - onurğa beyni və beyin kötüyündə yerləşən vegetativ mərkəzlər daha az əhəmiyyətli və onlara (məsələn, medulla oblongatadakı tənəffüs və qan dövranı mərkəzləri) zərər vurulması ölümə səbəb ola bilər. Beynin filogenetik cəhətdən daha gənc hissələrində həmçinin somatik mərkəzlərlə (yəni xarici mühitlə signal mübadiləsini idarə edənlər) sıx bağlı olan vacib vegetativ mərkəzlər də var və onların ayrılması çox vaxt mümkün deyil. Məsələn, beyin qabığına motor və ya hiss sahəsinin stimullaşdırılması eyni zamanda bədənə kortikal təmsilçiliyi stimullaşdırılan bölgələrində damar-motor dəyişikliklərinə səbəb olur. Beyin qabığının filogenetik cəhətdən daha yaşlı hissələrinin (qoxu beyni) stimullaşdırılması güclü avtonom reaksiyalara, eləcə də davranış dəyişikliklərinə - qəzəb, panik və cinsi oyanışın yaranmasına səbəb olur.

İnsanlarda qoxu hissi heyvanlardakı qədər görkəmli yer tutmur, lakin görünür, beyin qabığının filogenezdə əhəmiyyətli rol oynayır. Qoxu signalı ətraf aləmdə əsas istiqaməti müəyyən edir. Qoxu signal sistemi, ən yüksək, kortikal informasiya mübadiləsi səviyyəsinin böyüdüyü bir növ nüvə əmələ gətirir. İnsan qoxu beyni qoxu hissi ilə yalnız cüzi şəkildə bağlıdır (qoxu soğanağı və görünür, amigdala birbaşa ona bağlıdır); buna baxmayaraq, filogenetik olaraq, ondan törəyir. Qoxu, signalı əsas ötürmə stansiyasından, yəni talamusdan keçməyən, birbaşa beyin qabığına nüfuz edən yeganə hiss orqanıdır ki, bu da onun spesifik əhəmiyyətini göstərə bilər. Neyrofizioloji tədqiqatlar göstərir ki, qoxu beyninin və hipotalamusun stimullaşdırılması, vegetativ reaksiyalarla yanaşı, güclü emosional təcrübələr doğurur. Buna görə də, beyin bu hissələrinin, zehni funksiyaların lokalizasiyası konsepsiyasında tam ehtiyatla, emosional həyatın əsas mərkəzi olduğu ümumiyyətlə qəbul edilir.

Gəmiricilər kimi aşağı səviyyəli məməlilərin beyinlərini insan beyni ilə müqayisə etdikdə, beyin qabığının yuxarı hissələrinin (neokorteks) *beyin qabığının filogenetik cəhətdən daha yaşlı hissələri (arxikorteks, mezokorteks), yəni qoxu beyni və hipotalamusla müqayisədə qeyri-mütənasib olaraq daha böyük inkişafını görürük. Beynin bu hissələri aşağı və ali məməlilərdə demək olar ki, eynidir. Beyin inkişafındakı filogenetik sıçrayış insanlarda neokorteksdə cəmləşmişdir.

Yuxarıdakı faktlar sözdə "ali insan hissləri"ni müzakirə edərkən neyroanatomik və neyrofizioloji baxışları olan psixiatrlara mənfi təsir göstərir. Daha yüksək heyvan siniflərinin (məməlilər, quşlar) emosional reaksiyalarını müşahidə edərək, onların emosional həyatının insanlardan daha ahəngdar və nəcib olduğu qənaətinə gəlmək olar. "Yeni" beyin qabığının sürətli inkişafı ilə "köhnə" beyin qabığının qeyri-adi dərəcədə yavaş inkişafı arasındakı uyğunsuzluq açıq-aydın deyil

Bu, emosional harmoniyaya çox müsbət təsir göstərir.

Nəhayət, yaddaşın neyrofizioloji tədqiqatları göstərir ki, yaddaş qeydinin formalaşması üçün informasiya qoxu beyni və hipotalamusdan keçməlidir. Yaddaş qeydinin gücünə, digər şeylərlə yanaşı, emosional amil də təsir göstərir.

Həyatda insanın "bağırsağ hissi" ilə idarə olunması lazım olduğu barədə məşhur deyim öz mənasını daşıyır.

Güclü emosional yüklə əsas davranış xüsusiyyətlərini ("dan və -a" mövqeyi), eləcə də vegetativ və endokrin funksiyaları idarə edən strukturlar bu hiss orqanı ilə əlaqəli anatomik strukturlar ətrafında cəmləşmişdir.

Filogenetik baxımdan qoxu ətraf mühitdə ilkin oriyentasiya üçün ən vacib hiss orqanıdır.

Əhəmiyyətinə görə yaxından əlaqəli hiss orqanları olan qoxu və dad informasiya və enerji mübadiləsi arasındakı sərhədi təşkil edir. Onlar xarici mühitin bir hissəsini bədən öz quruluşuna mənimsəmək və çevirmək və ya rədd etmək qərarına təsir göstərir. Qoxu stimulları cinsi seçimdə vacib siqnallar hesab edilə bilər. Qoxu və dad hissləri insanlarda heyvanlar qədər əhəmiyyətli olmasa da, qidalanma və cinsi seçimdə əhəmiyyətli rol oynayırlar.

Digər hisslərdən gələn siqnallar yaddaşda saxlanılmaq üçün qoxu beynindən keçməlidir. Məlumdur ki, qoxu və ya dad stimulları uzun müddət yaddaşda qalır və xatirələri orijinal təcrübənin plastik canlılığı ilə canlandırır. Mərkəzi sinir sisteminin qoxu və dad hissləri ilə əlaqəli strukturları ətraf aləmin udulmasını və ya rədd edilməsini yalnız enerji mübadiləsi baxımından deyil, həm də informasiya mübadiləsi baxımından müəyyən edir. "Həyatın dadı" termini yerində istifadə olunur, çünki ətrafımızda baş verən hər şeyin udulması sinir sisteminin morfoloji və funksional strukturlarında qoxu və dad hissləri ilə sıx bağlıdır.

Müxtəlif reseptor sahələrindən beyin qabığına gələn siqnallar qoxu beyninə axır və burada əsas mövqə seçilir:

yaxınlaşmaq və ya uzaqlaşmaq. Bu proses beynə gələn siqnalların yaratdığı təcrübənin əsas emosional tonunu, eləcə də onların yaddaşda möhkəmlənməsini müəyyən edir.

Heyvan təcrübələri və insanlarda neyrocərrahi müşahidələr müəyyən dərəcədə qoxu beyninin zədələnməsi hallarında yeni yaddaş girişlərinin yaradılması ehtimalının aradan qalxdığını, əməliyyatdan əvvəl hazırlanmış köhnələrinin isə qorunub saxlanıldığını göstərə bilər.

Sonrakı siqnal axını qoxu beynindən hipotalamusa gedir və burada qoxu beynində baş verən reaksiyalardan asılı olaraq bədən daha çox və ya daha az səfərbər olunması prosesi baş verir. "Başla" vəziyyətində bu səfərbərlik "əvvəl" vəziyyətindən daha böyükdür. Döyüş və qaçış dostcasına yanaşmadan daha çox say tələb edir. "Əvvəl" mövqeyi vegetativ sistemi anabolik istiqamətə, "başla" mövqeyi isə katabolik istiqamətə yönəldir.

Beləliklə, xarici stimullar bütün bədəndə rezonans doğurur və insan dünyanı yalnız gözlər, qulaqlar, qoxu hissi və s. vasitəsilə deyil, həm də ürək, mədə və s. vasitəsilə qavrayır.

Bağırsaqlar, qan damarları və s. Bütün orqanlar informasiya mübadiləsini əks etdirir. Endokrin sistem hipotalamus və hipofiz vəzi vasitəsilə orqanizmi qarşıdan gələn hadisələrə hazırlamaqda fəal rol oynayır. Xüsusilə Selye özünün "stress" nəzəriyyəsində bu qədər əhəmiyyət verdiyi "hipofiz-böyrəküstü vəzi oxu" (hipofiz vəzi və böyrəküstü vəzi qabığı) adlanan hissə vacibdir.

Bu nəzəriyyə məşhur Amerika fizioloqu Kennonun bəzi neqro qəbilələri arasında etnoqraflar tərəfindən təsvir edilən "vudu" ölümü ilə bağlı tədqiqatının sonrakı inkişafı idi. Şaman sehləri və ya tabuların pozulması ilə yaranan qorxu,

ifrat səcdə vəziyyətinə və bir neçə gün ərzində ölümə gətirib çıxarır.

Elmi Tibb Haqqında Bəzi Qeydlər

Müxtəlif emosional vəziyyətlərlə müşayiət olunan fizioloji və biokimyəvi dəyişikliklərin tədqiqi hazırda psixosomatikanın əsasını təşkil edən böyük bir bilik sahəsini təşkil edir. Somatik funksiyalara zehni təsir anlayışı elmi tibbin aparıcı ideyası idi. Məhz bu ideya şaman həkimlərinin istifadə etdiyi müxtəlif təcrübələrin əsasını təşkil edirdi: sehlər, ritual rəqslər, maskalar, tilsimlər və sair, bunlar xəstələrin sağlamlığını bərpa etməli,

bəzən isə sağlam insanlara zərər verməli idi (qara sehr halında).

Tibbin elmi əsaslarının ortaya çıxması psixikanın somadan ayrılması ilə əlaqələndirilirdi. Bədənin

anatomik quruluşunun və fizioloji və kimyəvi mexanizmlərinin öyrənilməsi üçün zəruri olan sərbəst manipulyasiya obyektinin olması nəzərdə tutulmuşdu.

Tədqiqatçının sərbəstlik dərəcəsi araşdırılan subyektin sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması dərəcəsi ilə artır. Bir kəpənəyi daha yaxşı tanımaq istəyən uşaq,

başının üstündə qazonda fırlanaraq onu tutmağa çalışır, sonra əlində tutur və

tez-tez hətta öldürür, onu "əbədi" saxlamaq və daha yaxından araşdırmaq istəyir.

Tibbi təlim anatomiya və histologiyadan başlayır, burada tədqiqat subyekti

ölür. Əks təqdirdə, insan bədəninin morfologiyasını anlamaq mümkün olmazdı. Ölüm sayəsində

morfoloji mənzərə sabitləşir. Bütün canlılara xas olan həyat və ölümün — ölmə və yenidən doğulmanın — hərəkəti və dialektikası yox olur.

Elmi tibbin əsasını təcrübə və onun qiymətləndirilməsi təşkil edir: Mən hərəkət edirəm və hərəkətimin nəticələrini müşahidə edirəm. Müşahidə obyektini manipulyasiya etmək nə qədər asan olarsa, təcrübə aparının imkanları bir o qədər çoxdur. Bu mənada, ölü obyektlər üzərində canlı obyektlərdən, bitkilər və heyvanlar üzərində insanlardan daha çox təcrübə aparmaq daha asandır.

Təcrübə aparın asanlıqla iki səhv edə bilər: sərhəd səhvi və yalançı determinizmin səhvi. Birincisi, öz hərəkətinin nəticələrinə həddindən artıq diqqət yetirməkdən, orqanizmi xarici mühitdən ayıran sərhəd prinsipini və orqanizm daxilində baş verən proseslərin spesifikliyini unudaraq ibarətdir.

Təcrübə aparın hesab edir ki, müşahidə olunan sistemdəki yeganə və məcburi proseslər yalnız sərhədi pozmaq sayəsində özünün eksperimental olaraq kəşf etdiyi proseslər ola bilər. İkinci səhv, təcrübə aparının hər bir sistemin özünəməxsus funksional təşkilata malik olduğunu və sistem üzərində öz hərəkətinin nəticəsi olaraq müşahidə edilən hər şeyin yalnız fraqmentar və çox vaxt səhv nəticə verdiyini nəzərə almadan hərəkətini səbəblə çox asanlıqla bərabərləşdirməsi ilə əlaqədardır.

Orqanizmin fəaliyyət mexanizmlərinə nəzər. Bu, "qara qutu"nın məşhur problemidir; o, müxtəlif yollarla manipulyasiya edilir və nəticədə qutudan müxtəlif obyektlər çıxır, lakin əslində içində nə gizləndiyi məlum deyil. Təcrübə aparan şəxs sınaqdan keçirməyə başlayır; bu hərəkət olmadan heç nə əldə etmək mümkün deyil. O, prosesin gedişatını planlaşdırır, gələcəyə baxır və müşahidə olunan obyekt onun hərəkətinə bu və ya digər şəkildə reaksiya verir. Tədqiqatçı səbəb, öyrənilən obyekt isə nəticədir. Öyrənilən obyektin gələcəyi yoxdur, çünki o, tədqiqatçının əlindədir; o, keçmişə baxır və onu indiki vəziyyətinə gətirən səbəblər araşdırılır. Bu arada, təkcə canlı təbiətdə deyil, həm də cansız obyektlərdə, texniki cihazlarda gələcəyin problemi öyrənilən obyektin xarakteristikası üçün onun keçmişi və hazırkı vəziyyəti problemi qədər vacibdir.

İnformasiya mübadiləsinin spesifikliyini və onun daxili determinizmini nəzərə almamağın bir nümunəsinə son zamanlar eksperimental psixologiyada böyük həvəslə istifadə edilən müəyyən təcrübələrdə rast gəlmək olar. Sınaq heyvanları, əksər hallarda siçovullar (psixoloqlar adətən siçovullar üzərində, neyrofizioloqlar isə pişiklər üzərində təcrübələr aparırlar), müxtəlif zəka testlərinə (labirintlər və bu kimi) məruz qalmış, heyvanlardan daha çox insanlara uyğunlaşdırılmışdır. Əks vəziyyəti təsəvvür etmək asandır: əgər siçovullar insan zəkasını özlərinə xas testlərlə, məsələn, qoxu və dad stimullarına əsaslanaraq sınaqdan keçirildilsə, onda insanların onların təsəvvüründə necə görünəcəyi məlum deyil.

Orqanizmdəki avtonom və endokrin sistemlərin rolunu nəzərdən keçirərkən, həmişə zehni amillərin, xüsusən də emosional amillərin, bütün orqanizmin fəaliyyətində əhəmiyyəti və bu baxımdan müasir tibbdə istifadə olunan müəyyən elmi metodlar haqqında tənqidi fikirlər gəlir.

Genetik, Endokrin və Sinir İnteqrasiyası

Hər bir çoxhüceyrəli orqanizm çoxsaylı vahidlərdən (hüceyrələr) ibarət bir cəmiyyət kimi qəbul edilə bilər. Bu sosial vahidlər filogenetik olaraq inkişaf etdikcə,

getdikcə daha çox ixtisaslaşırlar. Beləliklə,

fərqli məqsəd və funksiyaları olan müxtəlif toxuma və orqan növləri ortaya çıxır.

Buna baxmayaraq, bütün hüceyrələrin eyni genetik planı olduğundan, ortaq bir fəaliyyət planı qalır.

Bizə məlum olmayan amillərin təsiri altında bu plan onlardan birində dəyişdirildikdə, şiş hüceyrəsi meydana çıxır, çoxalır və

ana orqanizmində yad, tez-tez düşmən (bədxassəli şişlər halında) bir koloniya əmələ gətirir.

Bu günə qədər genetik planın müəyyən bir orqanizmin gələcəyinə nə dərəcədə təsir etdiyi sualı cavabsız qalır. Hər halda, ətraf mühitin iştirakı olmadan inkişaf etmir. Həyatın mahiyyəti orqanizmlə ətraf mühit arasında daimi enerji və siqnal mübadiləsindən ibarətdir.

Həyatın nə olduğunu bilmirik, amma fizik Şreodingerə görə, onu entropiyaya qarşı çıxmaq - maddənin hissəciklərin xaoslu hərəkətinə meyli kimi təyin etsək, genetik plan həyatın səylərinin asanlaşdırıcısı kimi qəbul edilə bilər. Genetik ötürücü olmadan hər bir canlı orqanizm əvvəldən canlı təbiətin təkamülündən keçməli olardı. Və beləliklə, o, həyata hazır bir nizam planı ilə - mənfi entropiya ilə başlayır.

Müasir genetiklər, əvvəlkilərdən fərqli olaraq, genetik plana daha çox plastiklik aid etməyə meyllidirlər. Ətraf mühit amilləri geribildirim vasitəsilə genetik fəaliyyət planını dəyişdirir. Bu amillər bu planın nəyin və necə həyata keçiriləcəyini müəyyən edir.

Çoxhüceyrəli orqanizmlər yarandıqca və fərdi hüceyrələr müəyyən funksiyaları yerinə yetirmək üçün ixtisaslaşdıqca, genetik plan gücləndirmə, yəni çoxhüceyrəli cəmiyyətin funksiyalarını inteqrasiya edən və eyni zamanda onu ətrafdakı vəziyyətə uyğunlaşdıran xüsusi bir sistem tələb edirdi. Beləliklə, endokrin inteqrasiya meydana gəldi, burada siqnal rolunu qan axını vasitəsilə bədənin yayılan kimyəvi maddə oynayır və onu gözləyən orqanlarda reaksiyalara səbəb olur. Artıq qeyd edildiyi kimi, bu, "kimlə əlaqəli ola bilər" siqnalıdır - hər kəs onu ala bilər, ancaq mesajın ünvanlandığı şəxslər reaksiya verir.

Endokrin sistem nisbətən çevik deyil; Onun hərəkəti yavaşdır və reaksiyasının dəqiqliyi çox yüksək deyil.

Sinir sistemi çoxhüceyrəli orqanizmin inteqrasiyasını daha dəqiq idarə edir.

Siqnallar nəzərdə tutulan alıcılarına daha tez və asanlıqla çatır. Lakin, filogenetik inkişaf zamanı endokrin sistem sinir sistemi tərəfindən sıxışdırılır; onunla paralel olaraq inkişaf edir, lakin daha yavaş. Görünür, endokrin sistem də zəruridir və sinir sistemi ilə əvəz edilə bilməz.

Endokrin vəzindən gələn siqnal bütün bədəninə təsir edir və ən güclü şəkildə müəyyən bir orqana təsir göstərir; onun təsiri sinir impulsundan xeyli uzun müddət davam edir.

Buna görə də, sinir sistemi tərəfindən idarə olunan bədənin fəaliyyətinin daha ətraflı və dəyişkən reaksiyalarının inkişaf edə biləcəyi bir növ fon yaranır. Subyektiv həyatda, bu halda, emosional vəziyyətlərlə müəyyən bir bənzətmə olardı ki, bu da öz növbəsində daha incə və dəyişkən təcrübələr üçün fon təşkil edir. Bu təcrübələr formal olaraq eyni ola bilər, lakin fərqli kontekstə görə fərqli olurlar. Məsələn, formal olaraq eyni qalmasına baxmayaraq, yaxşı və ya pis əhval-ruhiyyədə, xeyirxahlıq hissi ilə və ya nifrət hissi ilə baxılan eyni şey fərqli şəkildə qəbul edilir.

// AVTOMATİK POZĞUNLUQLARININ SİMPTOMATOLOGİYASI. SOMATİK XƏSTƏLİKLƏRDƏ VƏ NEVROZLARDA SUBYEKTİV ŞİKAYƏTLƏR

Nevrotik xəstələr nadir hallarda dərhal psixiatrların köməyinə müraciət edirlər; bir qayda olaraq, onlar şikayətin növündən asılı olaraq daxili xəstəliklər həkimlərinə və ya digər mütəxəssislərə yönləndirilirlər. Bu, tamamilə başa düşüləndir, çünki xəstə müəyyən ağrı hissləri ilə narahat olur və müvafiq ixtisas üzrə həkimdən kömək istəyir. Zehni xoşagəlməz hissləri - narahatlıq, kədər, narazılıq və kompleksləri - xəstə özünə izah edə bilər və birtəhər onların öhdəsindən gələ bilər, lakin fiziki ağrı ilə o, bunu edə bilmir. Bədən xaricə çevrilir, ona bir obyekt kimi baxmaq olar və buna görə də onu həkimin əlinə vermək daha asandır.

Nevrozlarda xəstələr həkimə müxtəlif şikayətlər təqdim edirlər və hamısını sadalamaq çətin olardı. Lakin, onlardan bəziləri daha tez-tez olur və nevrozlar üçün olduqca tipikdir. Bundan əlavə, nevrozlu xəstələrin şikayətlərini təqdim etmə tərzində də xarakterikdir:

Xəstə adətən somatik xəstəliklərdən daha çox simptomları ilə məşğul olur. Bundan əlavə, onlar, sanki, bu simptomlarla dolaşırlar, yəni heç nə haqqında düşüncə və ya onlara daha obyektiv baxa bilmirlər. Somatik xəstələr ağrılı hisslərini özlərindən daha asanlıqla ayırırlar və onlarla daha az emosional əlaqədə olurlar.

Beləliklə, həm şikayətlərin növü, həm də təqdim olunma tərzii adətən nevrozdan dərhal şübhələnməyə imkan verir. Əlbəttə ki, bu, diaqnozla eyni deyil; artıq qeyd edildiyi kimi, nevroitik təzahürlər tez-tez somatik və ya ruhi xəstəlikləri gizlədir.

Ən çox görülən nevroitik simptomlara yuxusuzluq,

baş ağrıları, ürək ağrısı, qarın ağrısı, iştahsızlıq və əlaqəli çəki itkisi,

cinsi disfunksiya, bədən müxtəlif yerlərində lokallaşdırılmış "uçan" ağrılar, qaz tükləri və barmaqların və ayaq barmaqlarının sərtliyi daxildir.

// Yuxu Pozuntuları

Yuxu təbiətdə geniş yayılmış, tanınmış bir vəziyyətdir. Bu, fundamental bioloji ritm - gecə-gündüz, səy və istirahət ritmi hesab olunur. Digər tanınmış ritm, həyatın fəsilələrinə - yaz, yay və payıza uyğun inkişaf ritmidir.

Yuxunun əsas xüsusiyyətlərinə xarici mühitlə enerji və informasiya mübadiləsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması daxildir. Geri çəkilmə baş verir, xarici aktivlik demək olar ki, sıfıra endirilir; insan gün ərzində yığılan ehtiyatları istifadə edir (əgər gün oyaq keçiribse). Oksigendən başqa, xarici mühitdən başqa heç nə alınmır.

İnformasiya axını minimuma endirilir. Enerji metabolizmi əhəmiyyətli dərəcədə anabolik proseslərə doğru dəyişir; gün ərzində qəbul edilən hər şey sorulur və bədən öz quruluşuna çevrilir.

Anabolik proseslərin yayılmasının informasiya mübadiləsi ilə nə dərəcədə əlaqəli olduğu məlum deyil. Yuxu zamanı zehni həyat haqqında hələ də az şey məlumdur. REM (sürətli göz hərəkətləri) kimi tanınan xarakterik elektroensefaloqrafik qeydlərlə sübut olunduğu kimi, az-çox hər saat yarımında müntəzəm olaraq baş verən yuxular - beynin bioelektrik ritminin sürətlənməsi və sürətli göz hərəkətlərinin görünüşü - müəyyən dərəcədə anabolik proseslərin yayılmasını göstərir. Əvvəlki gün və həyatın daha uzaq dövrlərində toplanmış məlumat fraqmentlərindən qısametrajlı filmlər kimi yuxu səhnələri yaradılır. Yuxular müəyyən dərəcədə yaradıcı fəaliyyət hesab edilə bilər. Enerji mübadiləsində olduğu kimi, yaranan funksional strukturların xarakteristikasının onların spesifikliyi olduğunu qəbul etsək, yuxuların daha çox dərəcədə müəyyən bir insan haqqında həqiqəti əks etdirdiyini düşünə bilərik. Yuxular ətrafdakı reallığın daha böyük təzyiqi altında formalaşan oyaq görüntülərdən daha spesifik bir quruluşa malikdir.

Lakin yuxularda hər yaradıcı prosesdə bu qədər vacib və zəruri olan iradə elementləri yoxdur.

Yuxu pozğunluqları psixiatriyada ən çox yayılmış simptomlardan biridir.

Həm endogen, həm də ekzogen kəskin psixozlar adətən yuxusuzluqla başlayır və

bu simptom tez-tez yaxınlaşan psixozu göstərir. Üzvi

psixozlarda, xüsusən də qocalıq demansında, tərs yuxu ritmi tez-tez görünür:

Xəstə gündüzlər mürgüləyir, gecələr isə oyaq qalır. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra tez-tez diaqnoz qoyulan virus epidemik ensefalit qış yuxusu vəziyyətinə gətirib çıxarır və buna görə də onun adı letargik ensefalitdir.

Bu xəstəliklər hipotalamik bölgənin zədələnməsi ilə əlaqələndirilirdi. 1930-cu illərdə Hess heyvanlar üzərində apardığı təcrübələrə əsaslanaraq yuxu mərkəzini eyni bölgədə lokallaşdırdı. Ön hipotalamus parasimpatik sistemlə, arxa hipotalamus isə simpatik sistemlə əlaqələndirilir. Məsələn, şiş tərəfindən arxa hipotalamusun məhv edilməsi qış yuxusu vəziyyətinə gətirib çıxarır.

Oxşar təsirlər, eləcə də müxtəlif növ şüur pozğunluqları, bütün mərkəzdənqaçma və mərkəzdənqaçma yollarının kiçik bir sahədə cəmləşdiyi beyin kötüyünə (daha dəqiq desək, medulla oblongata, pons və beyin kötüyünə) ziyan vurmaqla yaranır. Nəticədə, onlar asanlıqla zədələnə bilər və bu da şüurun pozulmasına səbəb olur. Yuxu-oyanma ritmi həmçinin stimulların beyin qabığına daxil olmasından asılı ola bilər. Bu mövqe Hessin lokalizasiya konsepsiyasının əleyhdarları tərəfindən tutulur (yeri gəlmişkən, Pavlov məktəbi).

Moruzzi və Maqunun (1949) tədqiqatları göstərdiyi kimi, bütün yüksələn yollar oyaqlıq vəziyyətinə təsir etmir. Yalnız bir neçə neyronun ibarət olan və beyindəki spesifik reseptor sahələrinə çatan klassik duyğu yollarının məhv edilməsi şüurun vəziyyətinə təsir etmir. Retikulyar formasıyanın, yəni qısa aksonları olan neyronlardan ibarət və beləliklə, çoxsaylı neyronlardan ibarət olan sinir yollarının məhv edilməsi oyaqlığı pozur və retikulyar formasıyanın stimullaşdırılması dərin, komatik yuxudan oyanmağa səbəb olur.

Klassik duyğu yollarından fərqli olaraq, retikulyar formasıya qeyri-spesifik bir yoldur, yəni müxtəlif duyğu orqanlarından gələn impulslar orada qarışır və bu formada bütün beyin qabığına və onun təbəqələrinə nüfuz edir (klassik yollar, sözdə spesifik olanlar, müvafiq reseptor sahələrinin yalnız dördüncü təbəqəsinə çatır).

Hazırda yuxu-oyanma ritminin retikulyar formasıyanın fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğuna inanılır. Hess yuxu mərkəzi bu sistemin bir hissəsi hesab olunur.

Aydınlıq və huşsuzluq arasındakı sərhəd aydın deyil. Maksimum konsentrasiya vəziyyəti və emosional stimulların oyanma reaksiyasına səbəb olmadığı koma vəziyyəti, müxtəlif şüur vəziyyətlərini əks etdirən kontinuumun əks qütblərinə aiddir. Bu iki qütb arasındakı mövcud mövqe retikulyar formasıyanın fəaliyyətindən asılıdır. Bu fəaliyyət yalnız bədən xarici və daxili mühitindən gələn siqnallardan deyil, həm də beyin qabığından gələn siqnallardan (sonuncu geribildirim sistemi kimi çıxış edir) asılıdır. Bundan əlavə, retikulyar aktivləşdirici formasıya yaxın mühitindəki hər cür kimyəvi dəyişikliklərə xüsusilə həssasdır.

Elektroensefalografik tədqiqatlara əsasən, yuxu zamanı yuxu dərinliyinin müxtəlif fazaları fərqləndirilir: yuxarıda qeyd olunan REM yuxusu yuxuya bərabər hesab olunur və bu fazalardan birini təşkil edir. Yuxu zamanı, oyaqlıq dövründə olduğu kimi, kontinuum anlayışına uyğun olaraq müxtəlif dərəcədə intensivləşmə olur. Nevrozlar tez-tez yuxuya getməkdə ciddi çətinliklərlə üzləşirlər, siklofreniya isə, xüsusən də depressiv fazada, erkən oyanma ilə xarakterizə olunur. Nevrozlu xəstələr qorxu ilə yatmağa gedirlər; yuxusuz bir gecənin düşüncəsi belə, bu müddət ərzində...

Ən acı düşüncələr və obrazlar onların zehmində fırlanır, kirpiklərindən yuxunu süpürür. Xəstələr yuxuya getmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər: saymaq, darıxdırıcı kitablar oxumaq, yatmadan əvvəl gəzintiyə çıxmaq, vanna qəbul etmək və s., adətən heç bir əhəmiyyətli təsir göstərmir. İnanılmaz miqdarda istehlak edilən yuxu dərmanlarını qəbul etmək üçün daha az səy tələb olunur.

Kapitalist ölkələrində yuxu dərmanları istehsalçıları tez bir zamanda varlanırlar.

Bütün dərmanların, xüsusən də sinir sisteminə təsir edən dərmanların xarakterik xüsusiyyəti,

onların asan uyğunlaşmasıdır və az-çox uzun müddətdən sonra onların

təsiri zəifləyir. Nəticədə, getdikcə daha çox miqdarda

dərman istifadə etmək və ya hətta onları dəyişdirmək lazımdır. Əgər yuxu dərmanı kiçik dozalarda,

hətta uzun müddət istifadə edildikdə belə, təsirlidirsə, bu,

"Bu gecə yatacağam?" obsesif düşüncəsinin yaratdığı gərginliyin azalması ilə əlaqədardır. Yuxu dərmanının faydalı təsirlərinə inam narahatlığı azaldır; xəstə yuxuya gedəcəyinə inanır və yatır. Bu halda, dərmanın təsiri o qədər də vacib deyil,

yoxsa xəstənin dərmanın effektivliyinə inamı da vacibdir. Xəstənin inandığı hər hansı bir vasitə, hətta hipnotik təsir göstərməsə belə, bu əsasda təsir göstərə bilər.

Yuxusuz bir gecə, ilk növbədə, yuxuya getmək istəyinin məcburi olması səbəbindən əzaba çevrilir. Bu, yuxuya qarşı mübarizə aparıldığı, yuxuya getməmək üçün bütün səyləri göstərməli olduğu əks vəziyyəti təmsil edir. Nə qədər yuxulu olarsa, yuxu bir o qədər uzun olar.

Yuxu sırf vegetativ bir fenomen olmasa da, bütün həyati funksiyaları əhatə etdiyi üçün muxtariyyət prinsipi ilə bağlıdır: ciddi vegetativ funksiyalar kimi, yuxu da iradənin təsir dairəsindən kənardadır. Üstəlik, iradə muxtar və avtomatik hərəkətlərin axınına pozur; Buraya məlum iktidarsızlıq problemi də daxildir: nə qədər çox istəsəniz, bir o qədər az edə bilərsiniz.

Gücsüzlük hissi qorxu və ya təcavüz və ya hər ikisini oyadır. Bu reaksiya, mahiyyət etibarilə, infantildir. Körpə də oxşar reaksiya verir (ac və ya ıslak olanda, bir şeyə çata bilmədikdə və s. ağlayır). Gücsüzlük uşaqlığın erkən mərhələləri üçün xarakterikdir. İnkişaf irəlilədikcə bilik və başqaları üzərində güc toplanır və onlar, ən azı müəyyən dərəcədə, onun iradəsinə tabe olurlar.

Dialektik müxalifətə əsaslanan gücsüzlük hissi və müşayiət olunan hər şeyə qadirlik hissləri körpəlik dövrünə xasdır və uşaqlıqda yox olur və ya ən azı azalır. Avtonom disfunksiya insanı yenidən körpə vəziyyətinə gətirir; onlar gücsüz olduqları hadisələrə diqqət yetirirlər. Gücsüzlük nə qədər böyükdürsə, iradəyə nəzarət etmək üçün güc (körpə hər şeyə qadirlik) istəyi bir o qədər güclü olur. İradəyə müqavimət göstərən hər şey mənfi hissləri oyadır və bu da yuxusuzluq da daxil olmaqla avtonom pozğunluqları gücləndirir. Tipik bir nevroitik dairə yaranır. Buna görə də, nevroitik yuxusuzluğun müalicəsində xəstənin artıq yata bilməmək qorxusundan əziyyət çəkməməsi vacibdir.

Yuxusuz gecənin nevroitik qorxusu tənhalıq qorxusu ilə əlaqələndirilir. Gecələr tənhalıq hissi artır; insan düşüncələri, qorxusu, təhdid edici görüntüləri ilə tək qalır. Qaranlıq narahatlığa, reallıq səhnələrinin dəyişməsinə səbəb olur; onlar sirli, təhdidedici hala gəlir və insan özünü gücsüz hiss edir. Gün ərzində dünya yenidən adi və daha əlçatan olur. Çox vaxt,

yuxuya gedərkən uşaq oyuncaq ayıya və ya anasının və ya atasının əlinə sarılır. Görünür,

Bu yolla gecə və tənhalıq qorxusu azala bilər. Nevrozlu xəstə tez-tez özünü tənha, səhv başa düşülən, hər kəs tərəfindən tərk edilmiş hiss edir.

Onlar söykənib təhlükəsiz şəkildə yuxuya gedə biləcəkləri "mehriban aylarını" darırırlar.

Xəstələr tez-tez bütün gecəni göz qırpmadan yatmaqdan şikayətlənirlər. Bu cür şikayətləri sözün əsl mənasında qəbul etmək olmaz. Yuxu hava, su və yemək qədər vacibdir. 3-4 gün ərzində tam yuxusuzluq adətən zehni pozğunluqlara səbəb olur və bu, yuxuların məzmununun gerçəkləşməsi ilə xarakterizə olunur.

Xəstə qısa müddət ərzində oyaq yatır. Eksperimental yuxu tədqiqatları REM fazasının (yuxu görmə) bu pozğunluqlarda əhəmiyyətli rolunu göstərir.

Zehni pozğunluqlar subyektin yuxusu bu fazada kəsildikdə, yəni bu faza elektroensefalografik qeyddə göründüyü zaman oyandıqda baş verir. Ədəbiyyatda uzunmüddətli yuxusuzluq hallarının təsvirləri var, hətta illərlə davam edən, məsələn, epidemik ensefalitdən və ya başına güllə yarası aldıqdan sonra. Bu hallar nadirdir və görünür, yoxlama tələb edir.

"Bütün gecəni göz qırpmadan yatmadığından" şikayətlənən xəstələr tez-tez fasilələrlə yatırlar; şüurlarında yalnız oyaqlıq dövrləri qalır. Gecənin tamamilə yuxusuz olmadığına inam onlarda narazılıq hissi oyadır; onlar yuxusuzluqdan və onun öhdəsindən gəlmək üçün mübarizədən sanki bütün gecəni oyaq qalmış kimi yorğun olurlar. Yuxunun bioloji rolu istirahətdir. İnsanın yatdığı saatların sayı əhəmiyyətsizdir, lakin oyandığı vəziyyət əhəmiyyətsizdir. Bir neçə saat və ya cəmi bir saatdan sonra istirahət edə və sonra uzun bir yuxudan sonra yorğun və halsız oyanmaq olar. Səhər yorğunluğu nevrozlar, xüsusən də nevrastenik tip üçün olduqca xarakterikdir. Nevrozlarda yuxu istirahət gətirmir. Bunun niyə belə olduğunu cavablandırmaq çətinidir. Nevrotik gərginlik vəziyyəti - narahatlıq, acı düşüncələr, fiziki ağrı və s. - yuxuya hazırlaşarkən azalmır, əksinə, gündüz fəaliyyəti dayandırıldıqda güclənir. Yeri gəlmişkən, yuxu eksterosepsiya ilə interosepsiya keçidlə xarakterizə olunur; yəni yuxu zamanı bədən daxili siqnalları xarici siqnallardan daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yuxudan əvvəl insan özünü ətraf mühitdən təcrid edir, ən sakit yeri axtarır və motor fəaliyyətini minimuma endirən və cazibə qüvvəsinə müqavimət göstərmək ehtiyacını aradan qaldıran bədən mövqeyini, yəni tez-tez dölün vəziyyətinə bənzər uzanmış vəziyyət qəbul edir. Gözlərini yummaqla insan

xarici stimulların ən böyük axınıni kəsir. Gündüz o qədər də intensiv olmayan ağırlı təcrübələr (və buna görə də interoseptiv təcrübələr) gecələr dözülməz hala gəlir.

Nevrozda normal fəaliyyət və istirahət ritmi pozulur. Pavlov nevroitik vəziyyətləri həyəcanlanma və inhibə proseslərinin pozulması kimi izah edirdi. Məşhur terminlərlə desək, nevroitik insanın gün ərzində kifayət qədər oyanmadığını və yuxu zamanı kifayət qədər dərin yatmadığını demək olar.

Əvvəlki gecənin yuxuları xəstənin rifahına və əhval-ruhiyyəsinə müəyyən təsir göstərir. Nevrozlarda yuxular çox vaxt kabus kimi olur. Xəstə gecə qorxu, ürək döyüntüsü və tər içində oyanır. Emosional stress və xoşagəlməz yuxularla müşayiət olunan vegetativ və endokrin sistemlərin stimullaşdırılması səhər yorğunluğunu izah edə bilər.

Nevrotik gərginlik gecə istirahəti zamanı azalmır. Gündüz fəaliyyətlərinin kəsilməsi xəstənin düşüncələrini ziddiyyətli təcrübələrə yönəldir; hərəkətsizlik narahatlığı artırır və bununla birlikdə ağrı da artır; əzələlər rahatlaşmır, qaçmağa və ya döyüşməyə hazır olurlar. Görünür, qalan əzələ gərginliyi səbəbindən, yatmadan əvvəl bütün bədən və ya əzələlərin qəfil qıcqırması (ayaq və ya qolun öz-özünə tullanması), barmaqların və ayaq barmaqlarının uyuşması, sürünmə hissləri yaranır. Nevrotik gərginlik vəziyyətində, ziddiyyətli təcrübələrdən və davamlı "Mən yata bilmirəm" düşüncəsindən uzaqlaşmaq çətindir. Bu gərginlik gecə tez-tez oyanmalara səbəb olur və xəstənin yuxuları gündüz münaqişələri ilə əlaqələndirilir və mənfi emosional fondan, yəni qorxu və aqressiya hissi yaranır.

// Nevrotik Avtonom Pozuntuların "Yoluxuculuğu"

Bəzi insanlar gənc yaşlarından yuxu pozğunluqlarından əziyyət çəkirlər. Onlar tez-tez yuxusuzluqdan, yuxuya gedə bilməməkdən, gecə oyanmaqdan və səhər yorğun oyanmaqdan şikayətlənirlər. Çətin həyat vəziyyətlərinə yuxusuzluqla reaksiya verirlər. Digərləri, artıq gənc yaşlarında, baş ağrısı, ürək ağrısı, mədə ağrısı, iştahsızlıq və s. şikayət edirlər. Selektiv ağrının bu cür xroniki hallarında, avtonom sistemin selektiv pozğunluğundan, bir növ punctum minoris resistentiae-dən şübhələnmə bilirlər.

Somatik xəstəliklər həmçinin müəyyən sistemlərin, məsələn, tənəffüs, qan dövranı, həzm və digər sistemlərin zəif müqavimətini də əhatə edir. Müəyyən xəstəliklərə meyillər tez-tez ailələrdə olur, buna görə də onların genetik əsasla malik olduğu düzgün fərziyyədir. Avtonom sinir sistemi xəstəliklərinin ailəvi baş verməsi hallarında genetik fonu müəyyən edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, nənə, ana və qızı hamısı gənc yaşlarından bəri baş ağrısından əziyyət çəkirsə, bu, mütləq irsi meyl göstərmir.

Nevrotik şikayətlər "yoluxucu"dur, yəni nevrotik reaksiya nümunəsi adətən yaxın qohumlardan şüursuz şəkildə mənimsənilir. Bu model, xüsusən də gənclərdə asanlıqla güclənir. Nevrotik baş ağrıları çətin həyat vəziyyətində ortaya çıxarsa, sonradan münaqişə vəziyyətləri ilə müşayiət oluna bilər. Nevrotik pozğunluqların "yoluxuculuğu" müəyyən tarixi dövrlərdə və ya sosial dairələrdə müşahidə olunan müəyyən avtonom reaksiyalardakı tendensiyaları izah edə bilər. Məsələn, huşunu itirmə 19-cu və 20-ci əsrlərin sonlarında qadınlar arasında baş ağrıları və ya ürək ağrıları qədər geniş yayılmışdı.

Nevrotik simptomların "yoluxuculuğunu" izah etmək çətindir; hər halda, təqliddən danışmaq çətindir, çünki əksər simptomları şüurlu şəkildə təkrarlamaq çətindir. Bu faktın izahını hipnotik vəziyyətlərdə axtarmaq olar, burada məlum olduğu kimi, avtonom reaksiyalarda və digər nevrotik pozğunluqlarda müxtəlif dəyişikliklər təklifin təsiri altında, eləcə də əsas emosional vəziyyətlərin (emosional iqlimin "yoluxuculuğu") qəbul edilməsində asanlıqla yarana bilər.

// İştaha pozğunluqları

Nevrozlarda iştaha pozğunluqları iki formada özünü göstərir: onun olmaması və ya

Nevrotik gərginlik gecə istirahəti zamanı azalmır. Gündüz fəaliyyətinin kəsilməsi xəstənin düşüncələrini ziddiyyətli təcrübələrə yönəldir; hərəkətsizlik narahatlığı artırır və birlikdə ağrı da artır; döyüşlər rahatlaşmır, qaçmağa və ya döyüşə hazır olurlar. Görünür, qalan enerji yüklənməsi, yatmadan əvvəl bütün xəstəliklər və ya ələrin qəfil qıcqırması (ayaq və ya qolun öz-özünə tullanması), barmaqların və ayaq barmaqlarının uyuşması, sürünmə hissləri yaranır. Nevrotik gərginlik vəziyyətində, ziddiyyətli təcrübələrdən və davamlı "Mən yata bilmirəm" düşüncəsindən uzaqlaşmaq çətinidir. İndi al aqressiya hissi yaranır.

// Nevrotik Avtonom Pozuntuların "Yoluxuculuğu"

Bəzi insanlar gənc yaşlarından yuxu pozğunluqlarından çəkirlər. Onlar tez-tez yuxusuzluqdan, yuxuya gedə bilməməkdən, gecə oyanmaqdan və səhər yorğundan oyanmaqdan şikayətlənirlər. Çətin həyat vəziyyətlərinə yuxusuzluqla reaksiya verirlər. Digərləri, artıq gənc yaşlarında, baş ağrısı, ürək ağrısı, mədə ağrısı, iştahsızlıq və s. şikayət edirlər. Selektiv ağrının bu cür xroniki hallarında, avtonom sistemin selektiv pozğunluğundan, bir növ punctum minoris resistentiae-dən olana görə bilərsiniz.

Somatik idarə sistemlərin, məncə, tənəffüs, qan dövranı, həzm və digər sistemlərin zəifləməsinə dəlalət edir. Müəyyən ailə üzvlərinə meyllər tez-tez olur, buna görə də genetik əsaslı malik olduğu düzgün fərziyyədir. Avtonom sinir sisteminin xəstəliklərinin ailəvi baş verməsi hallarında genetik fonu saxlamaq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, nənə, ana və hamısı gənc yaşlarından bəri baş ağrısından çəkirsə, bu, ondan irsi meyl göstərmir.

Nevrotik şikayətlər "yoluxucu"dur, yəni nevrotik reaksiya nümunəsi yaxın qohumlardan şüursuz şəkildə mənimsənilir. Bu model, də gənclərdə güclənir. Nevrotik baş ağrıları çətin həyat vəziyyətində ortaya çıxs, sonradan vəziyyətin vəziyyəti ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi mümkündür. Nevrotik poz? bilər. Məsələn, huşunu itirmə 19-cu və 20-ci əsrlərin sonlarında qadınlar arasında baş ağrıları və ya ürək ağrıları daha geniş yayıldı.

Nevrotik simptomların "yoluxuculuğunu" izah etmək çətinidir; Hər halda, təkrarlamaq çətinidir, təqlid simptomları. Bu faktın izahını hipnotik vəziyyətdə ola bilər, burada məlum olduğu kimi, avtonom reaksiyalarda digər nevrotik pozğunluqlarda müxtəlif təkliflərin təsiri altında, hər bir əsas emosional vəziyyətin (esional iqlimin "yoluxuculuq vəziyyəti") qəbul edilməsində yarana bilər.

// İştaha pozğunluqları

Nevrozlarda iştaha pozğunluqları iki formada özünü göstərir: onun olmaması və ya

Nevrotik piylənmə və ya çəki itkisinin müalicəsi fərdi xəstənin iştahına yönəlmə bilməz. Müxtəlif pəhrizlər təyin etmək və xəstənin çəkisini tez-tez yoxlamaq yalnız onların emosional vəziyyətini və bu problemə münasibətini gücləndirir. Digər tərəfdən, artıq çəkili insanlar asanlıqla arıqlayır, arıq insanlar isə pəhrizləri barədə narahat olmamalı olduqları uyğun şərait tapdıqda - orduda, sanatoriyada, xəstəxanada və s. çəki qazanırlar.

// Cinsi Pozğunluqlar

Nevrotik yuxu və iştaha pozğunluqları birinci bioloji qanuna, yəni həyatın qorunmasına təhlükə yaradır - axı insan istirahət və yeməksiz yaşaya bilməz. Bu mənada onları yalnız vegetativ pozğunluqlardan daha çox hesab etmək olar.

Əsas bioloji qanunlarla əlaqəli funksiyalar yalnız vegetativ sinir sistemi tərəfindən deyil, bütün sinir sistemi tərəfindən idarə olunur. Lakin, məhz bu funksiyalar öz həyatlarını və növün həyatını qorumaqdan məsul olduqları üçün onlar mahiyyət etibarilə muxtar və iradədən asılı deyillər.

Bu pozğunluqların üçüncü qrupu cinsi pozğunluqlardan ibarətdir. Onlar ikinci bioloji qanunun - növün həyatının qorunmasının pozulması ilə əlaqələndirilir. Nevrozlar daha çox mənfi pozğunluqlar - cinsi istəyin və cinsi aktivliyin azalması - və daha az hallarda müsbət pozğunluqlar - cinsi istəyin artması şəklində xarakterizə olunur.

Cinsi istəyin artması təbiətə nevroz deyil, xəstəlikdir; xəstələr nevroz narahatlığı azaltmaq üçün cinsi azadlığa can atırlar; cinsi partnyor sakitləşdirici kimi qiymətləndirilir, tez darıxdırıcı olur və buna görə də tez-tez dəyişiklik və yeni bir şey axtarır. Autoerotizm tez-tez azadlığın ən yüngül forması kimi görünür. Artan cinsi istəyin nevroz təbiəti, məsələn, alkoqol tərəfindən artdıqda - Şekspirin artıq qeyd etdiyi kimi - zəif və ya uğursuz cinsi əlaqəyə səbəb olur.

Lakin nevrozlar ən çox əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsi və bununla birlikdə ümumi bir həyat dinamikası ilə müşayiət olunur ki, bu da təsadüfən cinsi istəyin azalmasında özünü göstərir.

Nevrozlardan əziyyət çəkənlər üçün dünya xoşagəlməz, qıcıqlandırıcı və onunla təmasda olmaq ağrılı olur. Ətraf mühiti qavramağın bu yolu onlara ən yaxın obyektə təmsil edən cinsi partnyora yönəlir; münasibətlər güclənir, düşmənçilik və laqeydlilik artır, bu da təbii ki, erotik yaxınlığa ehtiyacı zəiflədir.

Cinsi aktın özü əsasən vegetativ sistem tərəfindən idarə olunur və beləliklə, iradədən asılı olmayan muxtar bir akta çevrilir. Orqazm əmrə induksiya edilə bilməz; o, yalnız avtoerotizm hallarında olduğu kimi müxtəlif üsullarla və ya sevgi münasibətləri yolu ilə yaranı bilər.

Vegetativ sinir sistemi baxımından cinsi əlaqəni iki mərhələyə bölmək olar: cinsiyyət orqanlarında qan damarlarının genişlənməsini (kişilərdə bu, ereksiya kimi özünü göstərir) və selikli vəzilərin ifrazının artması (sürtünmə əmsalını azaldır) əhatə edən parasimpatik mərhələ. Cinsi əlaqənin sərbəst buraxılmasına (kişilərdə boşalma və qadınlarda orqazm) səbəb olan simpatik mərhələ də mövcuddur. Kişilər daha çox birinci mərhələdə, qadınlar isə ikinci mərhələdə pozulurlar. Kişilər tez-tez ereksiya çatışmazlığından (impotentiya), qadınlar isə orqazm çatışmazlığından (anorqazmiya) əziyyət çəkirlər. Nadir hallarda boşalmanın olmaması da var.

(boşalma). Belə hallarda, nevroz diaqnozu qoyulmazdan əvvəl üzvi dəyişiklikləri istisna etmək lazımdır. Çox vaxt boşalmanın zəifləməsi müşahidə olunur və boşalma sızma ilə əvəz olunur. Bu sperma sızması ereksiya olmadan belə baş verir.

Cinsi əlaqə zamanı xoş hisslərin azalması həm nevrozdan əziyyət çəkən kişilər, həm də qadınlar üçün olduqca tipikdir. Kişilər cinsi əlaqə zamanı və sonra yorğunluq hiss edirlər və nevrotik simptomları artır. Kişilər cinsi əlaqənin onlara zərər verə biləcəyindən qorxurlar; onlar emosional olaraq soyuqdurlar, nevrotik mövzulardan ayrılma bilmirlər. Qadınlar cinsi əlaqə zamanı kişilərə nisbətən daha kəskin məmnuniyyətsizlik hiss edirlər. Cinsi əlaqə onlarda ikrah hissi yarada bilər ki, bu da tez-tez onların partnyorlarına və ya ümumiyyətlə cinsi həyatına qarşı emosional münasibətlərini əks etdirir.

Əgər bir qadın cinsi partnyoru haqqında səhv edirsə, bu, evlilikdə nadir hal deyil, onda onların bir vaxtlar xoş olan cinsi həyatı partnyorları qədər iyrənc olur; sonra ikinci dərəcəli anorgazm baş verir. Əgər cinsi istəyin natamam inkişaf etməsi və ya təcavüzə məruz qalma, valideynlərlə cinsi əlaqəyə şahid olma və s. kimi xoşagəlməz təcrübələr səbəbindən onun inhibə edilməsi nəticəsində qadın cinsi əlaqə zamanı heç vaxt məmnunluq hiss etmirsə, əksinə dəfələrlə ikrah hissi keçirirsə, onda ikinci dərəcəli anorgazmdan daha çətin müalicə olunan ilkin anorgazmdan danışa bilərik. Cinsi əlaqə ağrılı ola bilər (dispareuniya) və bu ağrı əlavələrin, vaginanın, servikal eroziya və s. iltihabı kimi üzvi dəyişikliklərdən qaynaqlanırsa, onda bu, isterik konversiyaya bənzər nevrotik təzahür hesab edilə bilər. Oxşar simptom, lakin motor xarakterli, vaginizmdir - nisbətən nadir simptom, lakin zarafatlarda məşhurdur. Partnyorları ayıra bilməmək (penis captivus) tez-tez kompromis səbəbidir.

Digər avtonom xəstəliklərdə olduğu kimi, cinsi disfunksiya nevrozun yeganə simptomu ola bilər. Bu halda cinsi nevrozdan danışmaq olar. Belə hallarda yalnız cinsi məsələlərə diqqət yetirməmək lazımdır; Xəstənin bütün həyat tarixi araşdırılmalıdır, burada pozğunluğun səbəbi tez-tez tapıla bilər. Üstəlik, bu simptomu çox diqqət yetirmək onun təzahürünü daha da şiddətləndirir."

Cinsi pozğunluqlar ilkin və ikinci dərəcəli olmaqla iki yerə bölünür. İlkin pozğunluqlar, onların lap əvvəldən ortaya çıxdığı pozğunluqlardır (məsələn, kişi heç vaxt cinsi əlaqədə ola bilməyib və qadın heç vaxt cinsi əlaqə zamanı orqazm yaşamayıb), ikinci dərəcəli pozğunluqlar isə müəyyən bir normal fəaliyyət dövründən sonra ortaya çıxır. İlkin pozğunluqların müalicəsinin xeyli çətin olduğu olduqca aydındır.

// Digər vegetativ pozğunluqlar

Yuxarıda qeyd olunan pozğunluqlardan fərqli olaraq, baş ağrısı və başgicəllənmə, ürək və qarın ağrısı, qəbizlik və ishal, sidik ifrazında çətinlik, sərtlik, qaz qabarcıqları, qolların və ayaqların isti dərisi, əzələ ağrısı, xüsusən də bel-sakral nəhiyədə və s. kimi əzablar selektivdir və bədənə və onun əsas funksiyalarının hər yerini əhatə etmir. Lakin, onlar tez-tez o qədər şiddətlidir ki, xəstənin bütün diqqəti onlara yönəlir. Patofizioloji mexanizm

Bu tip vegetativ disfunksiyanın təbiəti hələ tam aydınlaşdırılmayıb.

Ümumi qayda olaraq, onların əsasən hamar əzələlərin yığılması ilə əlaqəli olduğunu güman etmək olar. Məsələn, nevrozlarla əlaqəli baş ağrıları vazomotor pozğunluqlarla əlaqələndirilir, yəni qan damarlarının yığılmasından qaynaqlanır. Bəzi müəlliflər kəllə örtüyünün zolaqlı əzələlərinin yığılmasının baş ağrılarının inkişafında rol oynadığına inanırlar. Nevrotik başgicəllənmə labirintdəki vazomotor dəyişikliklərdən qaynaqlanır. Nevrotik ürək ağrısının ən çox yayılmış səbəbi elektrokardiogramda (EKQ) əks oluna bilən koronar damar spazmlarıdır. Qarın ağrısı həzm sisteminin müxtəlif hissələrində (qida borusu, mədə, onikibarmaq bağırsaq, yoğun bağırsaq, öd kisəsi) hamar əzələlərin spastik yığılmasından qaynaqlanır. Adi qəbizlik və ya ishal şəklində bağırsaq pozğunluqları da vegetativ motor sisteminin disfunksiyasından qaynaqlanır. Eyni şey sidik ifrazı pozğunluqlarına (tez-tez sidik ifrazı, sidik qaçaqlığı, ictimai tualetlərdə sidik ifraz edə bilməmək və s.) da aiddir. Yuxarıda müzakirə olunan cinsi pozğunluqlar, əsasən, hamar və müəyyən dərəcədə zolaqlı əzələlərin yığılmasındakı pozğunluqlar kimi də qəbul edilə bilər. Erektıl disfunksiya penisin damar boşluqlarının kifayət qədər genişlənməməsindən qaynaqlanır; qadınlarda cinsi əlaqə zamanı ağrı (dispareuniya) tez-tez vagina və uşaqlığın hamar əzələlərinin və aralığın zolaqlı əzələlərinin spastik vəziyyətlərindən qaynaqlanır. Nevrotiklər tez-tez, xüsusən də ayaqların ovuclarında və dabanlarında üşümə simptomu (soyuq, yapışqan ovuc) yaşayırlar ki, bu da dəridə və dərialtı toxumada qan damarlarının daralması ilə eyni vaxtda tərz vəzilərinin aktivliyinin artması ilə əlaqələndirilir. Qan damarlarının daralması sürünmə hissini, sərtliyi və barmaqlarda və ayaq barmaqlarında ağrının olmamasını izah edir. Bel-sakral nahiyyədə ağrı, bədən müxtəlif yerlərində əzələ ağrısı, yorğun gözlər və titrəyən göz qapaqları hissi, ümumi fiziki yorğunluq hissi - bütün bunlar müvafiq zolaqlı əzələlərdə gərginlikdən qaynaqlana bilər. Təqdim olunan vegetativ pozğunluqların əhəmiyyətli bir hissəsi anormal hərəkət funksiyası ilə əlaqələndirilə bilər - əsasən daxili orqanların yığılma fəaliyyəti (əsasən hamar əzələlərin yığılması), ikinci dərəcəli narahatlıqlar isə yığılma fəaliyyətinin xarici təzahürləri ilə əlaqəli pozğunluqlardır (zolaqlı əzələlərin təsir diapazonu). Birinci qrupda pozğunluqlar ən çox qan damarlarının və həzm sisteminin hamar əzələlərində, ikinci qrupda isə zolaqlı antiqravitasiya əzələlərində (dik duruş saxlayan və cazibə qüvvəsinin təsiri altında bədən hissələrinin, məsələn, gövdə, baş və göz qapaqlarının sallanmasına müqavimət göstərən) rast gəlinir.

Nevrozlu xəstələr tez-tez çıxılmazlıq hissindən şikayətlənir, mövcud vəziyyətlərindən çıxış yolu görmür və həyatda yerlərini itirirlər. Xəstələrin həyat tarixçələrini təhlil etdikdə, həqiqətən də belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, onlar həyat yollarında dayanıblar və şəxsi təkamülləri çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Artan motor gərginliyi, sanki, həyat səyahətindəki bu gecikmənin əvəzedicisidir. Əlbəttə ki, bu tərif çox güman ki, simvolikdir; buna baxmayaraq, motor fəaliyyətinin bütün heyvanlar aləmində olduğu kimi, insanların da fundamental xüsusiyyəti olduğu ümumi təməlin mahiyyətini əks etdirir. Əgər məqsədyönlü fəaliyyətdə çıxış yolu tapmırsa, onda özünü məqsədsiz və çox vaxt zərərli formalarda təzahür etdirir; məsələn, bükülmüş körpə müxtəlif, lazımsız hərəkətlər edərək ağlayır və gərginləşir. Bir insan məqsədyönlü davranış imkanından məhrum olduqda, bu, planlarının, öz "İstəyirəm" ifadəsinin reallaşması ola bilər, onda onlar məqsədsiz fəaliyyətə ehtiyaclarını dərk edirlər.

hərəkətlər.

Fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdıran qundaqlama və ya vacib bir görüşün iştirakçılarının əsəbi şəkildə gözlədiyi bağlı qapı müxtəlif növ maneələr, məsələn, məcburi sosial davranış normaları, başqaları tərəfindən qınanmaq qorxusu, əks fəaliyyət planları arasında seçim edə bilməmək və s. ola bilər. Lakin ən güclü maneələr xaricdən hərəkət edən maneələr deyil, insanın öz daxilində gizlənən maneələrdir.

Fəaliyyətə ən böyük ehtiyac, emosiyaların iki əks qütbədən birinə yaxınlaşması - ətrafdakı dünya ilə cinsi əlaqədə birləşməsi və ya qətl aktında onun məhv olması zamanı yaranır. Bu fəaliyyətlərin hər ikisi həm daxili, həm də xarici ən güclü mübarizə hissi ilə qarşılanır. Digər mümkün fəaliyyət formaları ilə müqayisədə, bir qayda olaraq, nadir hallarda reallaşır. Xarici hərəkətin qeyri-mümkünlüyü daxili hərəkətdə fəaliyyətin reallaşmasına gətirib çıxarır. Qəzəb içində bir insan düşməninə məmnuniyyətlə öldürmək istədikdə, təkcə yumruqları sıxılmaz, həm də qan damarları, həzm sisteminin divarları və s. sıxılır. Hisslər ifrat qütblərinə çatdıqda, onlar tez-tez bir-birinə qarışır, aqressiya sevinc mənbəyinə çevrilir və cinsi əlaqə aqressiya ilə birləşir.

Nevrozlarda müşahidə olunan bütün vegetativ pozğunluqlar bədənin özündəki motor fəaliyyətinə aid edilsəydi, bu, çox sadə olardı. Vegetativ pozğunluqlar bütün bədənin mübarizə və ya qaçış üçün səfərbər olunmasından qaynaqlanır. Bu səfərbərlik əsas emosional fonla əlaqələndirilir. Bu, yalnız motor funksiyalarını deyil, bədənin bütün funksiyalarını əhatə edir. Biokimyəvi, fizioloji və zehni proseslər dəyişir. Buna baxmayaraq, məqsədyönlü hərəkətdə fəaliyyətin xaricdən təzahür etməsinin və fəaliyyət gücünün daxili hərəkətə ötürülməsinin mümkünsüzlüyü, görünür, nevrozlarda rast gəlinən vegetativ pozğunluqların mahiyyətini əks etdirir.

Hər halda, nevrozların müalicəsində vacib bir aspekt prosesin tərsidir: daxili hərəkətdən xarici hərəkətə keçid. Əgər xəstə şikayətlərini ifadə edə bilirsə, narahatlıqları və münaqişələri barədə danışa bilirsə, bütün bunlar vegetativ pozğunluqların gərginliyini azaldır, çünki xarici fəaliyyət forması kimi nitq hərəkət etməyə mane olan meyl üçün bir çıxış yolu təmin edir və bununla da onun daxili fəaliyyətini zəiflədir.

Nevrozlar üçün təyin olunan fiziki iş oxşar təsirə malikdir; xarici fəaliyyət müxtəlif somatik nevroitik şikayətlərdə əsasən səbəb rolunu oynayan daxili gərginliyi azaldır.

Vegetativ disfunksiyalar mənfi emosional vəziyyətlərlə müşayiət olunan bədənin səfərbərliyini ifadə edirsə, onda onların uzun müddət davam etməsini (aylar və hətta illər) necə izah etmək sualı yaranır. Bu halda, görünür, üç amil rol oynayır. Mənfi emosional vəziyyətlər asanlıqla kök salır. Onlar "qurumuş hisslərdən" danışirlar. Ən yaxınlarımıza, bütün dünyaya qarşı nifrət hissləri, kin, qisas və günahkarlıq hissləri demək olar ki, bütün ömür boyu insanın daxilində gizli qala bilər və bununla da daimi gərginlik və heç vaxt gəlməyən, lakin bədən hazır olan bir mübarizəyə hazırlıq yaradır.

Vegetativ proseslər yüksək dərəcədə ətalətə malikdir. Ətraf mühitlə münasibətimizi idarə edən somatik sistemdən fərqli olaraq, bədəndəki daxili nizamdan məsul olan avtonom sistem daha sabitdir. Buna görə də, avtonom disfunksiyalar daha uzun müddət davam edir və daha yavaş aradan qalxır.

somatik sistemdə (yəni ətraf mühitlə əlaqəni idarə edən sistemdə).

Və nəhayət, üçüncü amil, görünür, avtonom sistemin fitri artan həyəcanlılığı ola bilər. Bəzi insanlarda avtonom reaksiyalar nisbətən zəif, digərlərində isə çox güclüdür. Çox vaxt müəyyən avtonom pozğunluqlarla, məsələn, baş ağrısı, qarın ağrısı, nəfəs darlığı tutmaları və s. ilə reaksiya vermə meyli olur, çünki müəyyən bir insanda avtonom sistemin müəyyən bir seqmenti mənfi ətraf mühit təsirlərinə daha çox həssas idi və artıq qeyd edildiyi kimi, motor fəaliyyətinin boşaldılması üçün əsas çıxış nöqtəsini təşkil edirdi. Bəlkə də bu halda, avtonom sistemin müəyyən bir seqmentinin fitri zəifliyi var, baxmayaraq ki, erkən həyatda müəyyən davranış nümunələrinin güclənməsini istisna etmək olmaz. Yuxarıda qeyd edildi ki, avtonom reaksiyaların müəyyən bir "yoluxucu" olması var. Əsnəmək belə bir "yoluxucu" fenomendir. Son Dünya Müharibəsi zamanı əsgərlər, xüsusən də Britaniya və Amerika ordularında,

tez-tez avtonom ürək pozğunluqlarından əziyyət çəkirdilər. Terapevtlər ürək, mədə, yoğun bağırsaq və s. nevrozları kimi orqanla əlaqəli nevrozları diaqnoz qoyurlar, bu, çox vaxt psixiatrik baxımdan səhv hesab olunur, çünki nevroz tək bir orqanın deyil, bütün insanın xəstəliyidir. Lakin, vegetativ sistemin disfunksiyasına və onun lokalizasiyasına diqqət yetirmək bəzən diaqnozu və terapeutik müdaxiləni asanlaşdırır. Belə hallarda, sözügedən orqanın daha ətraflı müayinəsi aparılır və vegetativ sistemin müəyyən bir hissəsini hədəf alan dərmanlar təyin olunur. Lakin, müalicənin sonrakı mərhələsində nevroitik prosesdən "təsirlənən" orqana həddindən artıq diqqət yetirmək çox zərərli ola bilər.

Tibbi praktikada gənc yaşlarından müəyyən bir vegetativ disfunksiya növündən əziyyət çəkən insanlarla qarşılaşmaq nadir deyil. Adətən, valideynlərdən birinin də oxşar ağrılı hisslər yaşadığı məlum olur; belə hallarda bu əzabların mənşəyini müəyyən etmək, yəni onları anadangəlmə və ya qazanılmış tipə aid etmək çətinidir.

Meteopatiya olduqca maraqlı, lakin xüsusilə yaxşı öyrənilməmiş bir fenomendir. Bu, atmosfer dəyişiklikləri zamanı narahatlıq hissi ilə müşayiət olunan avtonom sinir sisteminin güclü reaksiyasından ibarətdir. İnsan, sanki "canlı barometr"ə çevrilir və bu dəyişikliklərə baş ağrısı, ürək döyüntüsü, ümumi zehni zəiflik, narahatlıq, əsəbilik və s. ilə reaksiya verir (əksər hallarda barometrik təzyiq düşəndə). Bu qabiliyyət sayəsində onlar Viçerek*-dən dəfələrlə daha yaxşı hava proqnozlaşdırırlar. Ağrılı hisslərdə oxşar artım revmatizmdə müşahidə olunur, lakin burada fərqli bir mənşə rol oynaya bilər.

Vetonom tipli meteopatiya tez-tez nevrotiklərdə və konstitusional olaraq qeyri-sabit avtonom sinir sistemi olan insanlarda özünü göstərir. Avtonom sinir sisteminə hansı siqnalların təsir etdiyi məlum deyil. Bəzi tədqiqatlar hava ionlaşmasının müəyyən bir rolunu göstərir. Hər halda, bu siqnallar şüurlu qavrayış üçün əlçatmazdır. Heyvanlarda oxşar davranış dəyişiklikləri, daha aydın olsa da, oxşar şəkildə izah edilə bilər və bu da onlara yaxınlaşan hava dəyişikliklərinə hazırlaşmağa imkan verir. Müəyyən mənada bu fenomen gələcəyi qabaqcadan görmək qabiliyyəti adlandırıla bilər.

Vegetativ disfunksiyalar müasir tibbdə ciddi problem yaradır və əksər dərmanların vegetativ sinir sisteminə təsir etməsi faktı bunu sübut edir.

Dövrümüzdə bu qədər inkişaf etmiş farmakoterapiya əsasən vegetativ sinir sisteminin farmakoterapiyasına yönəlmişdir.

* Viçerek (Kiçik Külək) Polşa televiziyasında hava proqnozu aparıcısıdır.

Eqosentrizm

// NİYƏ QICIQLANIR?

Nevrozlu xəstələr qəti şəkildə əmindirlər ki, başqa heç kim onlardan daha çox əziyyət çəkmir və ya onlardan daha çox bədbəxt deyil. Onlara başqalarının əzablarını göstərmək üçün edilən bütün cəhdlər uğursuz olur. Əgər ağır vəziyyətdə olan bir şəxs nevroz şöbəsinə yerləşdirilsə, nevrotiklər belə bir xəstənin vəziyyətinin ciddiliyindən xəbərdar olsalar da, özlərini yenə də daha çox əzab çəkən və bədbəxt hesab edirlər.

İlk ifadələrdən sonra həmsöhbətin nevrotik vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verən xarakterik nitqləri əsasən "mən", "mənim" əvəzliliklərindən və əzablarının şiddətini ətraflı şəkildə göstərən sifətlərdən ibarətdir. Bu xüsusiyyət, isterik şəxsiyyətə daha çox xas olsa da, demək olar ki, hər nevrozda rast gəlinir.

Nevrotik xəstə ilə söhbət əsnasında insan özünün toxunmuş əzablar, münaqişələr və şikayətlər içində qaldığı təəssüratı yaranır. Onlar bu "kokon"dan qaça bilmirlər və xarici dünya travmatik təcrübələrinin dolaşlıq telləri vasitəsilə onlarla təmasa girir. Bu vəziyyətlərin müalicəsinin açarı bu "kokon" eqosentrizmini qırmaqdır. Əgər xəstə özündən daha bədbəxt olan başqalarının əzablarını görürsə, onda onların eqosentrik inadkarlığının qırılması və özlərinə daha tənqidi baxmağa başlamalarının anının çatdığına ümid etmək olar.

Eqosentrizm həkimlər də daxil olmaqla, ətrafdakılar üçün ən qıcıqlandırıcı şeydir. Bu, onların dünyanı ortaq şəkildə anlamaq hissində xələl gətirir. Hər bir insan öz dünyasını qursa da, hamısı bütün insanlar üçün ortaq olan dünyanın bir hissəsi olaraq qalır (Heraklitin "koinos kosmos"u). İnsan cəmiyyəti ilə bu birləşmə ən intim şəxsi ehtiyaclardan imtina etməyi tələb edir. Ən intim təcrübələr başqalarının təcrübələrinə uyğunlaşdırılmalıdır, əks halda insan özünü sosial dairələrdən kənarda tapa bilər ki, bu da tez-tez ruhi xəstələrin həyatında baş verir.

Nevrozdan əziyyət çəkənlərin dünyası "fərqli" bir dünya deyil. Onlar da hər kəs kimi eyni münaqişələr, şikayətlər və əks hisslərdən əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə, onların əzabları qısa müddətə olsa da, sağlam insanlar üçün adi haldır. Buna görə də, sağlam insan sadəcə bir şeydən imtina etməli olduqda, "başqalıqlarını" vurğulaması, diqqəti özünə çəkməsi ilə qıcıqlanır. Nevrozdan əziyyət çəkənlər üçün "Özünüzü toparlamalısınız", "Hər kəs öz uğursuzluqlarını yaşayır", "Yalnız özünüzü düşünməməlisiniz" və s. kimi məsləhətlər buradan gəlir. Bu tip məsləhətlər heç bir rahatlıq gətirmir.

// MÜNASİBƏTİN MƏRKƏZİ MÜSTƏVƏSİ

Nevrotik eqosentrizm mahiyyət etibarilə hər bir insanda və bəlkə də hətta hər bir canlıda normal şəkildə özünü göstərən, hiss etmək qabiliyyətinə malik olan bir xüsusiyyətin kəskinləşməsi kimi qəbul edilə bilər. Eqosentrizm münasibətin mərkəzi müstəvisinin faktının ifadəsi kimi qəbul edilə bilər. Hər bir canlı orqanizm enerjinin və xarici siqnalların spesifik və unikal bir təşkilatlanmadan keçdiyi bir sistem hesab edilə bilər; beləliklə, bu sistem mərkəzi nöqtəyə çevrilir.

insanın dünyasının, çünki bu dünyanı özünəməxsus şəkildə təşkil edir.

Bu sistemdə zaman və məkan koordinatlarının mərkəzi nöqtəsi mənlidir və bu nöqtədən zaman və məkanın məsafəsi ölçülür. Daha yaxın olan həmişə insanın təsir edə bilmədiyi deyil, birbaşa qarşılaşdığı şeydir. İnsanın yaşadığı zaman onun öz vaxtıdır; başqa bir zaman ona yaddır, burada məsafələri üfünün uclarındakı məkan məsafələri qədər qiymətləndirmək çətinidir. Son müharibədən sağ çıxmayan gənc üçün bu, Napoleon müharibələri qədər uzaqdır və aralarındakı zaman məsafəsi silinir. Zamanın koordinatı indiki anda mənlilik nöqtəsindən keçmiş və gələcəyə bölünür. Məkan koordinatları üçün mərkəzi nöqtə (ön-arxa, yuxarı-aşağı, sağ-sol) həm də insanın hazırkı yeridir. Zaman və məkan koordinatları həm enerji, həm də siqnal mübadiləsində mühüm rol oynayır, çünki onlar orqanizmin morfoloji və funksional sırasının əsasını təşkil edir. Bu koordinatların mərkəzi nöqtəsi mənlidir. Buna görə də, canlı orqanizmin ilk hissəsinin eqosentrizm hissi ola biləcəyini düşünmək lazımdır.

// "MƏN GÖTÜRƏM" VƏ "MƏN VERİRƏM"

"Kainatın mərkəzində olmaq" hissi "Mən alıram" mövqeyi "Mən verirəm" mövqeyindən nə qədər çox üstünlük təşkil etsə, bir o qədər güclü olur. Birinci halda, ətraf aləm verir, insanın bütün istəklərini yerinə yetirir,

onlara xidmət edir. İkinci halda, ətraf aləm əksinə, tərəfdaş kimi dayanır,

ondan götürmək mümkün deyil, amma özündən bir şey də verməlisən. Beləliklə,

eqosentrik mövqeyin əksini təşkil edən müəyyən bir animistik mövqe yaranır; dünya özünə bənzər,

öz hüquqlarına və tələblərinə malik varlıqlarla doludur. Bəzən verməli olduğun, bəzən də götürə biləcəyin, nəzarət edə bildiyin və ya nəzarət altına alına bildiyin xarici aləmlə qarşılıqlı əlaqə insanın eqosentrik vəziyyətini azaldır, xarici aləmdə oxşar orqanizmləri tanımağı öyrədir və "Mən" ilə ətraf aləm arasındakı nisbət daha real olur.

"Mən alıram" və "Mən verirəm" arasındakı tarazlıq müəyyən dərəcədə enerji və informasiya mübadiləsinin anabolik və katabolik prosesləri arasındakı tarazlığa bənzəyir. Xarici mühitdən bərabər miqdarda enerji və siqnallar götürülür və geri göndərilir. Böyümə dövründə anabolik proseslər ("Mən alıram") katabolik proseslərdən ("Mən verirəm") üstün gəlir və buna görə də uşaqlıq və erkən yeniyetməlik dövründə eqosentrik əhval-ruhiyyə fizioloji fenomen hesab edilə bilər. Ümumi prinsip olaraq, ontogenetik inkişafı eqosentrizmin azaldığını güman etmək olar.

Eqosentrik əhval-ruhiyyədə oxşar azalmanın filogenetik inkişaf prosesində olub-olmadığını demək çətinidir, çünki insanlardan başqa canlı orqanizmlərin təcrübə dünyasına daxil olmaq çətinidir. Lakin, siqnal sisteminin inkişafı insanın xarici dünya ilə öz münasibətinin obyektivləşməsini asanlaşdırdığını və beləliklə,

ehtimal ki, eqosentrizmin azalmasına səbəb olduğunu güman etmək olar. Heyvanlar üzərində aparılan müşahidələr müəyyən dərəcədə filogenezin aşağı mərhələlərində eqosentrik davranışın daha yüksək səviyyələrə nisbətən daha çox özünü göstərdiyini göstərir. Qayğı və sevgi yalnız daha yüksək heyvan növlərində özünü göstərir.

// NEVROTİK EQOSENTRİZMİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hər bir xəstə insan özünü bir az uşaq kimi hiss edir və başqalarının qayğısına ehtiyac duyur,

Çarəsiz qalan o, mövcud vəziyyətdə zərurətə əsaslanan "Mən qəbul edəcəyəm" münasibətini qəbul edir. Hər bir xəstəlik uşaqlıq eqosentrizminə müəyyən bir qayidişlə əlaqələndirilir. Lakin nevrozda eqosentrizm bu hədləri aşır. Somatik xəstələr heç vaxt nevrotiklər qədər öz əzablarına diqqət yetirmirlər və özlərini bədbəxt hiss etmirlər.

Uşağın eqosentrizmi də nevrotik xəstədən fərqli bir xarakter daşıyır. Uşaq özünü dünyanın diqqət mərkəzində hiss edir, lakin bu faktı vurğulamır və bundan bədbəxt hiss etmir. Nevrotik eqosentrizmdə başqaları haqqında açıq bir şikayət var: "məni heç kim başa düşmür", "heç kim mənə kömək etmək istəmir". Uşağın eqosentrizmi ətraf mühitin ana dəstəyi verdiyi bir başlanğıc nöqtəsini tutur; uşaq onun mərkəzindədir və bütün ehtiyacları ödənilir. Bu vəziyyət insana cəsarətlə "dünyanı fəth etməyə" - hər bir obyektə əl uzatmağa və toxunmağa, bu şəkildə bütün ətraf dünyanı mənimsəməyə çalışmağa imkan verir. Yalnız hadisələrin sonrakı inkişafında ətrafdakı reallığın obyektləri müqavimət göstərir; Onları qavramaq və mənimsəmək mümkün deyil; onların öz həyatı var və uşağın gözündə ona bənzəyirlər.

O, onlarla oynamağa və lağ etməyə başlayır və beləliklə, eqosentrik vəziyyətdən, sonuncusunun əksi olan animistik vəziyyətə keçir.

Xəstə insanın eqosentrizmi zəiflik nöqtəsidir, ətrafındakılardan qayğıya ehtiyac duyur. Yaşlıların eqosentrizmi də oxşardır; bu,

əlavə olaraq başqalarına qarşı tələbkarlıq xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir - "Onlara verdiyim hər şey üçün onların qayğısını tələb etmək hüququm var."

Somatik xəstəliklə bədənin xəstə hissəsi ilə bütün orqanizm arasında bir növ mübarizə yaranır, sanki yalnız müəyyən bir orqan xəstədir, bütün orqanizm yox.

Parçalanma hətta gündəlik nitqdə də ifadə olunur: biz deyirik: "Məndə mədə,

ağciyərlər və s. xəstədir", baxmayaraq ki, daha dəqiq və dəqiq tərif "Mən tamamilə xəstəyəm" olardı,

çünki hər xəstəlik bütün orqanizmin disfunksiyasına səbəb olur. Bu hallarda parçalanma müdafiə mexanizmi kimi çıxış edir, bunun vasitəsilə hər şey "pis" rədd edilir və özünəinam hissi yaradan bütövlüyün ayrılmaz hissəsi olmaqdan çıxır. Və bu bütövlük sağlam qalır.

Somatik xəstəliyin başlanğıcında, yuxarıda qeyd olunan mexanizm işə düşməmişdən əvvəl, xəstəliyin bütün orqanizmə təhdidi, artıq qeyd edildiyi kimi, tez-tez nevrotik simptomlara səbəb olur. Sonra insan özünü tamamilə xəstə hiss edir.

Oxşar müdafiə mexanizmi özünüqiymətləndirmədə, davranışımızdakı bir şey özümüz tərəfindən qınandıqda işləyir. Sonra bu element ayrılır və vəziyyəti obyektiv qiymətləndirə bilməməsi və s. səbəbindən xarici məcburiyyət altında affekt vəziyyətində baş verən təsadüfi bir hərəkət kimi qəbul edilir. Somatik olaraq, xəstəliyi olan bir insan xəstə hissəyə (bu hissə hətta bütün bədən ola bilər) bölünür ki, bu da ona yad və düşməndir, eyni zamanda yaxındır, çünki o, daim bu barədə düşünür və ona qayğı göstərir. Və bu hissə xəstəlikdən əvvəlki kimi qalır. Onun eqosentrizmi bədənin bu ayrılmış hissəsinə diqqət yetirmək ehtiyacından irəli gəlir; xəstənin başqa problemlər üçün vaxtı yoxdur və tez-tez kənar köməyə ehtiyac duyur.

Bunun əksi ruhi xəstəlik ola bilər, burada "şərin" ayrılması mümkün deyil; xəstə buna görə sarsılır; o, xəstəlikdən əvvəlki insan olmaqdan çıxır, yeni, fərqli, yad bir şeyə çevrilir. Ruhi xəstə insan edə bilməz

Eqosentrik olmaq, çünki onların "mən"i fərqlidir və dünyaları da fərqlidir.

Nevrotik xəstə somatik və ruhi xəstəliklər arasındakı sərhədi keçir.

Onlar xəstə hissəni sağlam hissədən ayıra bilmirlər; özlərini tamamilə xəstə hiss edirlər, lakin xəstəlik yaşama faktı onların sərhədin digər tərəfinə keçmədiklərini və "mən"ləri və dünyaları eyni qaldığını göstərir. Eyni dünyada olmalarına baxmayaraq, nevroitik xəstə özlərini bu dünyada hiss etmir, ətrafındakı hər kəsi daha sağlam və daha xoşbəxt hesab edir və buna görə də ətrafdakılardan anlayış və rəğbət istəyir. Onların xarici dünya ilə təması həmişə ağırlı olur, çünki somatik xəstədən fərqli olaraq, onlar tamamilə xəstədirlər; onların vəziyyətlərində onlara kömək edə biləcək tək bir sağlam hissəsi yoxdur. Nevrotik xəstə, nisbətlərin tamamilə əks olduğu fərqli bir dünyada yaşayan ruhi xəstədən fərqli yaşayır.

Nevrozda eqosentrizm xəstənin yeganə mövqeyi ola bilər, çünki xəstəlik hissi onun bütün orqanizmini ələ keçirir (onun "mən"i xəstədir, yəni "mən"i tamamilə xəstədir). O, özünə qulluq etməlidir; xarici dünya ilə hər təmas çətin və ağırlı olduğundan, heç nə və ya kimsə ilə maraqlanmağa vaxtı yoxdur. O, dərisinin soyulduğunu hiss edir, hər şey ona zərər verir, çünki hər şüurlu təmas integrasiya olunmuş "mən"dən keçməlidir və bu "mən" xəstədir.

Nevrotik xəstənin başqalarını xüsusilə qıcıqlandıran eqosentrizmi, mənə elə gəlir ki, bizi bu günə qədər aydın olmayan xəstəliyin mahiyyəti ilə tanış edir. Normal yaşamaq, həyatdan zövq almaq və onda kədərlənmək, xoşbəxt olmaq və əziyyət çəkmək, dünya ilə maraqlanmaq və yorğun olmaq, həyatın məqsədini müəyyən etmək və onun mənasızlığını hiss etmək - xəstə ola bilməz. Xəstə insan həyatdan uzaqlaşır. Artıq qeyd edildiyi kimi, hətta ağır somatik xəstəliklə belə, ölümcül "mən xəstəyəm" ifadə olunmur; Xəstə bədənin xəstə hissəsini sağlam hissədən ayırmağa çalışır, bu hissə subyektiv "mən"in bir hissəsi olmaqdan çıxıb mütəxəssislərin əlinə asanlıqla həvalə edilən bir obyektə çevrilib. Digər tərəfdən, nevrozlarda bu ölümcül "mən xəstəyəm" ifadə olunur. Əslində, nevrozlu xəstə özünü xəstəliyə "məhkum edilmiş" xəstə kimi hiss edir, yəni artıq özünü xəstə hissədən ayıra bilməyən və tamamilə xəstəliyin mərhəmətində hiss edən ağır somatik vəziyyətdə olan bir xəstə kimi. Əlbəttə ki, hər bir həkim bu mövqeyi qəbul etməkdə çətinlik çəkir, çünki obyektiv müayinə somatik xəstəlikdə bu qədər açıq-aşkar görünən ağırlı əzabları izah edən heç bir patoloji dəyişiklik aşkar etmir.

Xəstəni yalnız özünə və əzablarına diqqət yetirməyə məcbur edən və onu normal həyatdan uzaqlaşdıran bu "mən xəstəyəm" hissi nədir? Bu ifadədəki açar söz "mən"dir! Artıq qeyd edildiyi kimi, "xəstə" termini bədənin bir hissəsinə və ya bütün orqanizmə aiddir. "Mən sağlamam" demək, insanın eyni, dəyişməz qalması və ətrafdakı dünyaya münasibətinin dəyişməməsi, əksinə indiki anı əks etdirməsi deməkdir. Nevrotik simptomlar yaşamayan, yorğun, bədbəxt, kədərli olmayan, ən azı qısa müddətə yox olan bir insan yoxdur, amma bu vəziyyət bir neçə saat və ya gün ərzində keçir. Yalnız "Mən" sözü ağırlı vəziyyətə sabitlik verir. "Xəstə" anlayışı ilə nə qədər sıx əlaqədirsə, insanın özünə qayğı göstərməsi, özünü düşünməsi bir o qədər çox lazımdır, ətraf aləmdə öz yerini tapmaq bir o qədər çətinləşir, çünki "Mən" hər şeyi özü ilə doldurur. Əgər bu "Mən" ətraf mühitdən və bu "Mən"in sahibindən qorunma, qayğı tələb edirsə, onda bütün bunlar yaranmış bir dəyişikliyi göstərə bilər ki, bu da mövcud vəziyyətdə bu "Mən"in qeyri-kafi olduğunu və dəyişiklik zəruri olduğunu göstərir.

Özündə və ya ətrafında. Eqosentrizm müəyyən dərəcədə insanın daxili proseslərində deyil, həm də xarici dünya ilə təmaslarında pozğunluğu göstərən bir simptom ola bilər.

Bu pozğunluqlar uzunmüddətli və özünə yaxından diqqət yetirməyə ehtiyac yaranır. Əgər zehni tarazlığın qısamüddətli pozulması ilə özünüdərk baş verərsə, bu, eqosentrik nisbət itkisi xüsusiyyətlərinə malik deyil, bu zaman insanın öz "mən"-i hər şeyi gizlədir. Eynilə, bir insan bürəyib ayağını ağrıda bir müddət ona diqqət yetirir və ağrı azaldıqda, bu barədə düşünməyi dayandırır. Lakin bu pozğunluq keçicidir; əks halda, insanın öz qüsurları və başqalarının qüsurları vərdiş halına gələr və insan onlara tamamilə diqqət yetirməyi dayandıra bilər.

Eqosentrizm insanın öz taleyinə qarşı etirazını ifadə edir; o, həm özünə, həm də dünyaya qarşı aqressivliyi ehtiva edir. Eqosentrizm, insanın öz şəxsiyyətini tamamilə qəbul edib, çox vaxt başqalarının hesabına öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan eqoizm deyil.

Eqosentrizmdə özünə münasibət ikimənəli olur - "Mən həm sevirəm, həm də nifrət edirəm". Özünə qarşı bu qədər geniş emosional konqlomerasiya, emosiyaların xaricdən ifadə edildiyi zaman tıxanması səbəbindən yaranır. Nevrozlu xəstələrlə söhbətlərdə, adətən, onların yaxınları ilə emosional münasibətini anlamaq mümkündür. Həkimlə söhbətlər zamanı yaxınlarına qarşı mənfi hissləri buraxmaq onlar üçün müəyyən bir rahatlıq hissi yaradır və nəticədə xəstənin eqosentrik vəziyyəti azalır.

Həkim müayinəsi zamanı xəstənin eqosentrik əhval-ruhiyyəsini azaldan ikinci amil özünə daha sakit və daha obyektiv baxışdır. Bütün bunlar özünə hörməti artırır.

Eqosentrizm, geniş yayılmış inancın əksinə olaraq, narsisizm xüsusiyyətlərinə malik deyil.

Xəstənin daim diqqətini cəlb edən və hər kəsin ona diqqət yetirməsini tələb edən "mən"-i xoş hisslər mənbəyi kimi qiymətləndirilmir, əksinə, "narahatlıq və ikili hisslər yaradır, mənfi hisslər üstünlük təşkil edir".

Həkimlə müzakirələrdən sonra özünün portretinin obyektivləşdirilməsi yolu ilə özünə qarşı emosional münasibətin müəyyən dərəcədə sabitləşməsi xəstənin başqalarına qarşı emosional münasibətinə təsir göstərir. Özünü sevməklə başqalarını sevmək daha asandır. Qonşunu sevməklə bağlı tanınmış etik düsturdə ən çətin hissə ikinci hissədir: "özün kimi".

Eqosentrizm məhz özünə qarşı bu pozulmuş münasibəti təmsil edir.

// Eqosentrizm və şəxsiyyətin təkamülü

Eqosentrik əhval-ruhiyyəni azaldan üçüncü amil, çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu axtarmaq ola bilər. Nevrozda həm xəstə, həm də ətrafındakılar çıxılmaz vəziyyətə düşmüş kimi təəssürat yaradırlar. Təbiətə məcburi olan təkamül qanunu yalnız bütün növə deyil, həm də onun fərdi nümayəndəsinə aiddir. Belə bir nümayəndənin həyat tarixi ən sadə nümunələrdən ən mürəkkəb nümunələrə qədər uzanan inkişaf əyrisi kimi təsvir edilə bilər. İnsanlar, təbiətin üzvləri olaraq, təkamül qanunundan azad deyillər; mayalanmadan ölümə qədər inkişaf etməlidirlər.

İnkişaf daim yeni morfoloji və funksional formaların əmələ gəlməsindən ibarətdir. İnsanlarda, heyvanlar aləminə nisbətən siqnal sisteminin fəvqəladə inkişafı səbəbindən təkamül əsasən funksional formalarla bağlıdır.

İnsan daim yeni fəaliyyət formaları yarada bilər; sinir sisteminin quruluşu o qədər zəngindir ki, mövcud potensiallarından heç vaxt istifadə edə bilməyəcək. Subyektiv olaraq, insan öz funksional formalarının təkamülünü fəaliyyətə ehtiyac kimi - yaradıcı fəaliyyət kimi yaşaya bilər, bu fəaliyyətdə insan yalnız özünü deyil, həm də ətraf aləmi öz planına uyğun olaraq dəyişdirir. Bu, "əvvəl" və "sonradan" vektorları ilə birlikdə insan fəaliyyətinin əsas istiqamətini müəyyən edən "yuxarı" vektordur. Əgər nevrozlara inkişaf gecikmələrinə reaksiyalar kimi baxılırsa, eqosentrizm başa düşülən bir fenomenə çevrilir. Bu, irəli hərəkəti gecikmiş bir insanın öz oxu ətrafında fırlanmasıdır. Müalicədə istifadə edilən peşə terapiyası çərçivəsində belə, istənilən yaradıcı fəaliyyət eqosentrik vəziyyəti azaldır, dünyanı "öz şablonuna uyğun" formalaşdırmaq üçün insan ehtiyaclarının reallaşmasına kömək edir. Xəstəni eqosentrik vəziyyətdən çıxarmaqda rol oynayan üç amil - yəni xarici mühit və özü ilə emosional əlaqəni tənzimləmək və yaradıcı fəaliyyət potensialını təşkil etmək - insan fəaliyyətinin yerləşdiyi üç əsas vektorla əlaqəlidir ("əvvəl" və "başla" və

yaradıcı "yuxarı" fundamental mövqeləri). Eyni amillər nevrozun sağlamlığında mühüm rol oynayır.

Eqosentrik vəziyyəti anlamaq nevrozun mahiyyətini anlamağa kömək edir, çünki insan fəaliyyətinin üç əsas vektorunun pozulmasıdır və bu da

inkişaf əyrisində çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxarır.

ƏYİRƏLİ DAİRƏ

// NÜMUNƏLƏR

Fırlanan bir zirvədə ilişib qalma, ümitsiz bir vəziyyətdə ilişib qalma hissləri nevrozun dördüncü aksial simptomu, yəni qapalı bir dairə simptomu ilə əlaqələndirilir. Bu simptom nevroitik zəncirin bağlanmasıdır - səbəb və nəticə. Bir neçə nümunə məsələnin mahiyyətini

izah etməyə xidmət edə bilər.

Nevrotik qorxu bir sıra vegetativ pozğunluqlara səbəb olur ki, bu da öz növbəsində

qorxu hissini artırır. Məsələn, kimsə qəfildən baş ağrısı, ürək döyüntüsü və ya mədə sancıları hiss edərsə, narahatlığı artır; onlar sadəcə bədənində ağrılı bir prosesin baş verdiyindən qorxurlar.

Qorxunun artan intensivliyi vegetativ simptomları artırır. Diqqəti cəmləşdirə bilməmək onların diqqətini diqqət prosesinin özünə və müdaxilə edən amillərə yönəldir və bu da xəstənin zehni çatışmazlıqları və işinə mane olan şeylər barədə düşünməsinə səbəb olur; diqqət daha da pisləşir. Nevrozlarda tez-tez rast gəlinən qıcıqlanma müəyyən bir ətraf mühit reaksiyasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində daxili gərginliyi və qıcıqlanmanı və s. artırır, nəzəri olaraq sonsuzdur. Narazılıq hissi xəstənin başqalarına qarşı davranışında əks olunur, sonuncular buna adətən xəstəyə mənfi münasibətlə reaksiya verir və narazılıq hissini daha da artırır. Günahkarlıq hissi xəstəni hər şeydə günah axtarmağa vadar edir və bununla da hissi artırır və bu hiss nə qədər böyükdürsə, özünü günahlandırma meyli bir o qədər güclü olur. Nevrotik eqosentrizm xəstənin ətraf mühitdən uzaqlaşmasına səbəb olur ki, bu da onun eqosentrik mövqeyini daha da artırır; Onların kömək üçün fəryadları getdikcə boşluğa yox olur və buna görə də getdikcə daha güclü olur. Bir çox tədqiqatlardan sonra bunun "sadəcə nevroz" olduğu qənaətinə gəldikləri üçün nevroitik simptomlardan çəşqinliyi yaşayan həkim, çox vaxt şüursuz şəkildə xəstəyə məyusluğunu hiss etdirir və bu da öz növbəsində nevroitik simptomları artırır.

Çünkü xəstə bir daha özünü səhv başa düşülmüş və rədd edilmiş hiss edir. Nevrotik simptomların artması həkimin xəstəyə qarşı mənfi münasibətini artırır və bu hal xəstənin nevrotik təzahürlərini daha da artırır.

Bu cür nümunələri daha çox göstərmək olar. Hər bir xəstənin qaça bilmədiyi öz qapalı dairəsi var və onlar nə qədər çox

azad olmağa çalışsalar, dairə bir o qədər sıxlaşır.

Xəstənin səyləri ən narahatedici simptomlara yönəlir. Nəticə etibarilə, iktidarsızlıqdan əziyyət çəkən xəstə diqqətini buna yönəldir və nəticədə getdikcə daha çox narahatedici simptomlar yaranır;

Digər vegetativ pozğunluqlar da oxşardır. Obsesif-kompulsiv pozğunluğu olan xəstələr nə qədər davamlı olaraq onlarla mübarizə aparırsa, onlardan bir o qədər çox əziyyət çəkirlər. Günahkar xəstələr nə qədər çox ədalət axtarırsa, bir o qədər çox haqsızlığa uğradıqlarını hiss edirlər. Əsəbi xəstə onları qıcıqlandıran insanlar və əşyalarla mübarizə aparacaq və bu, onların mənfi hisslərini daha da gücləndirəcək və s.

Nevrotik dövrdə səbəb faktorları arasındakı əlaqə təbiətə hipertrofikdir, hər sonrakı əlaqə güclənir - bir amilin güclənməsi digərində də eyni şeyə gətirib çıxarır. Nevrotik təzahürlə mübarizə səbəb zəncirinin bir halqasında simptomların artmasına səbəb olur ki, bu da nəticədə xəstənin mübarizə apardığı simptomun şişirdilməsinə gətirib çıxarır.

// MÜSBƏT ƏLAQƏ

Vəziyyət quyruğunu dişləyən itə bənzəyir. Köpək quyruğunu nə qədər çox dişləyirsə, bir o qədər ağrıyır, bir o qədər qıcıqlanır və bir o qədər çox dişləyir. Bu, müsbət əks-əlaqəyə nümunədir. Mənfi əks-əlaqədə geribildirimin artması bu sistem tərəfindən göndərilən siqnalların sayının azalmasına səbəb olur. Beləliklə, sistemin sabitliyi qorunur. (Məsələn, termostatda temperaturun müəyyən edilmiş limitdən yuxarı qaldırılması istilik istehsalının azalmasına səbəb olur.) Müsbət əks-əlaqə ilə, əksinə, onun artması bu sistem tərəfindən göndərilən siqnalların sayının artmasına səbəb olur. (Termostatın temperaturunun artması, onu azaltmaq əvəzinə, istehsal olunan istilik miqdarını artıracaq. Bir it vəziyyətində, geribildirim dişlənmiş quyruqdan gələn ağırlı stimullardır ki, bu da daha çox çeynəməyə səbəb olur.) Müsbət geribildirim olan bir sistem, özünü məhv etməyə meyilli qeyri-sabit bir sistemdir.

"Qaribə dairə"yə yalnız nevrozlarda deyil, həm də digər ruhi pozğunluqlarda, eləcə də somatik xəstəliklərdə rast gəlinə bilər. Məsələn, şizofreniya xəstəsi insanlardan qorxu hiss edir, ətraf mühitdən uzaqlaşır və getdikcə öz dünyasına qərq olur ki, bu da onların onlarla əlaqə qurmasını getdikcə çətinləşdirir; artan qorxu onları uzaqlaşdırır. Böyrək iltihabı adətən anemiya ilə müşayiət olunur ki, bu da öz növbəsində toxuma qan axınının zəifləməsinə və müqavimətin azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da əsas xəstəliyə mənfi təsir göstərir və s.

Görünür, qaribə dairə fenomeni hər bir xəstəliyə xasdır. Hər bir xəstəlik müəyyən dərəcədə bədənin mövcud tarazlığını pozur və bu pozğunluq sistemin özünü tənzimləmə qabiliyyətini aşır. Bu qabiliyyətlər mənfi rəydən ibarətdir və bunun sayəsində sistem

sabitliyini bərpa edir. Münaqişə vəziyyətində sakit bir insan həmçinin

nevrotik simptomları - narahatlıq, vegetativ disfunksiyanı göstərə bilər.

Qıcıqlanma, zehni depressiya və s. Bir müddət sonra bu simptomlar

yox olur və itirilmiş tarazlıq bərpa olunur. Daim münaqişə içində olan nevroitik xəstədən fərqli olaraq, sağlam insan gündəlik fəaliyyətlərinə qayıdır və həyat adi qaydada davam edir. Beləliklə, mənfi stimulların axını azalır və zamanla tamamilə dayanır.

İtlə bağlı nümunə, ağrı hiss etdikdə quyruğunu dişləmək əvəzinə, itin bu fəaliyyəti dayandırdığı və məsələn, sümük gəmərməyə başladığı, nəticədə ağrı siqnallarının tədricən azaldığı bir vəziyyətə uyğundur.

Nevrotik qapalı dairə, xəstənin öz oxu ətrafında eqosentrik fırlanmadan çıxmaqda çətinlik çəkməsinin səbəblərindən biridir. Nevrozların müalicəsində qapalı dairəni qırmaq çox vacib bir məqamdır; bu, xəstəyə irəliləməyə imkan verir, yəni xəstəni təkamül yoluna qoyur. Bəzən qorxunu azaldan dərmanların tətbiqi qapalı dairədəki bir halqanı (nevrotik qorxu) zəiflətmək üçün kifayətdir. Bəzən həyat şəraitindəki dəyişikliklər, həkimlə müzakirələr, xəstənin dəstək tapması və həkimə basdırılmış hissləri barədə danışa bilməsi və öz kimliyini tapması və s., qapalı dairəni pozmağa kömək edə bilər.

// POLİFAKTORIAL ETİOLOGİYA

Xəstə ilə danışarkən, onun nevroitik vəziyyətinə girməyə çalışırıq, yəni, belə bir reaksiyaya səbəb ola biləcək xarici dünya ilə emosional münasibətlərindəki ən əhəmiyyətli pozuntuları müəyyən etmək istəyirik. Unutmaq olmaz ki, nevroitik vəziyyətin mövcudluğunda belə, nevroz simptomları somatik xəstəliyin və ya endogen psixozlardan birinin, hətta üzvi psixozlardan birinin əlaməti ola bilər.

Psixiatriyada, tibb elminin digər sahələrindən daha çox, çoxfaktorlu etiologiya prinsipi vacibdir. Bu qaydadan yayınmaq və yalnız bir etioloji yolu tanımaq daha böyük elmi əsaslandırma təmin edir, lakin bu tip etioloji tədqiqatlar əsasında çəkilmiş xəstənin profili adətən karikatura və daralma ilə xarakterizə olunur və buna görə də xəstə üçün qeyri-dəqiq və təhqiramizdir.

Həqiqi etioloji amillər dəstini müəyyən etmək ehtimalı artdıqca azalır. Mümkün amillərin sayını hesablamaq üçün əvvəllər verilmiş permutasiya düsturundan istifadə etmək olar. Əgər iki etioloji amil, A və B varsa, onda yalnız iki sistem mümkündür: AB və BA; üç amil ilə onların sayı altıya qədər artır (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA), yəni hasil $1 \times 2 \times 3$. Mümkün kombinasiyaların sayı etioloji amillərin sayının faktorialıdır.* Nevrozlar da daxil olmaqla, hər cür psixi pozğunluqların genezisini nəzərdən keçirərkən əsl etioloji sistemin tapılmasının bu kiçik ehtimalı unudulmamalıdır. Psixiatriyada etioloji fərziyyələr həmişə yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənlikdən əziyyət çəkir. Nevrozun dəqiq, faktiki səbəbini çoxsaylı nevroitik vəziyyətlər arasında müəyyən etmək çox vaxt mümkün deyil və buna görə də eyni vaxtda bir neçə vəziyyəti nevrozun mümkün səbəbləri kimi nəzərdən keçirmək daha yaxşıdır.

* Müəllif bu şərhlərə görə tibb elmləri doktoru, professor B. Xalikovskiye təşəkkür edir.

// AİLƏ VƏ İŞ MÜHİTİ

Məlumdur ki, hər bir xəstənin nevroitik vəziyyəti fərqli şəkildə inkişaf edir və

Ümumi bir çərçivə təqdim etmək çox çətinidir. Praktikada ən çox istifadə edilən metod xəstənin cari şikayətlərinin ətraflı müzakirəsi və ardınca onların ailə və iş mühitlərinin təhlilidir. Bu iki mühitdə emosional əlaqələrin konsentrasiyası ən intensivdir və nevroitik münacişələrin mənbələri məhz orada tapıla bilər. Qadınlarda nevroitik vəziyyətlər daha çox ailə mühitində, kişilərdə isə işdə müşahidə olunur.

Qadınlar üçün, azadlıq olsa da, ev həmişə ən vacib fəaliyyət sahəsi olaraq qalır, çünki onu yaradan və qoruyan onlardır.

Lakin hər iki sosial dairənin emosional məsələləri fərqlidir. Ev mühitində (həm genealoji ailədə, yəni xəstənin gəldiyi ailədə, həm də öz ailəsində) bu məsələlər iki əsas emosional mövqeyə aiddir - "əvvəl" və "başlayan" mövqeləri, sevgi və nifrət. İş mühitində, məktəb və oyun mühitlərində gənclərdə isə onlar "yuxarıdakı" mövqe ilə, yəni "dünyanı öz imicində yenidən formalaşdırmaq üçün spesifik insan meyli" ilə əlaqələndirilir.

Yuxarıdakı fərq, əlbəttə ki, fərdi emosional əhval-ruhiyyələrin qarşılıqlı qarışmasını istisna etmir. Ev mühitində münacişə,

uşağının və ya cinsi partnyorunun davranışını dəyişdirmək istəyindən,

bu insanları öz idealına uyğun olaraq,

yəni "yuxarıdakı" mövqe perspektivindən modelləşdirməkdən qaynaqlana bilər. İş mühitində insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlər

güclü mənfi emosional gərginliklərin (və nəticədə "danışan" mövqeyinin) toplanmasına səbəb olur. Hər bir sosial qrupun özünəməxsus yanaşma metodu (sosial sərhəd) var. Bir qayda olaraq, iş mühitindən daha yaxın münasibətlər evdə olur.

// SOSIAL SƏRHƏD

İnsanlar arasında təmasın və onlar arasındakı optimal məsafənin müəyyən edilməsi problemi bioloji, sosial və psixoloji təbiətin müxtəlif aspektlərini əhatə edir. Hər bir canlı varlığın öz optimal həyat dövrü var.

məkan. Bitkilər çox sıx əkilə bilməz, çünki onlar sadəcə olaraq böyüməyəcəklər; heyvanlar dar qəfəslərdə saxlanıla bilməz, eyni zamanda onları bir-birindən çox böyük məsafə ilə ayırmaq da olmaz, çünki bu, onların inkişafını pozacaq. Həyatın müəyyən dövrlərində bioloji ehtiyaclarla görə onları ayıran məsafə daha kiçik olmalıdır. Məsələn, məməlilərdə inkişafın ilk dövründə yeni canlı məxluq anası ilə ayrılmaz şəkildə birləşir; çoxalma aktı bu heyvanları birləşdirmək üçün bu məsafənin azaldılmasını tələb edir.

Bioloji baxımdan növün qorunma qanununun sosial sərhədi (yəni, müəyyən bir növün fərdi vahidləri arasındakı məsafəni) azaldan əsas amillərdən biri olması mümkündür, öz həyatının qorunma qanunu isə bu məsafəni artıran amillərdən biridir, çünki həyatı ehtiyaclar enerji almaq üçün müəyyən miqdarda məkan tələb edir. Heyvanlar üçün bu məkan digər canlı orqanizmlərin - fərqli bir növün bitkiləri və ya heyvanlarının məhv edilməsidir.

və onları orqanizmin öz quruluşuna yenidən formalaşdırmaqdır. Nəticə etibarilə, "əvvəl" mövqeyi növün həyatının qorunması qanununa, "başlayan" mövqeyi isə öz həyatının qorunması qanununa əsaslanacaqdı. Bu mövqələrdən birincisi altruistik, ikincisi isə egoist adlandırıla bilər. Birincisi, öz həyatı bahasına olsa belə, ölümsüzlük üçün yatmış təbii istəkdən, ikincisi isə öz həyatını başqalarının həyatı bahasına qorumaq istəyindən irəli gəlir (ən azından heyvanlarda; bitkilər daha az aqressivdir). Qanun

Növlərin qorunması qanunu eyni növün üzvlərini bir araya gətirir, özünüqoruma qanunu isə bir-birindən uzaqlaşdırır. Əgər ikinci bioloji qanundan qaynaqlanan sevgi canlı təbiətdə mövcud olmasaydı, yer üzündə həyat yox olardı və ölüm hər kəsi və hər şeyi bürüyərdi.

İnsanlar öz aralarında konstitusiya xüsusiyyətləri, müəyyən bir sosial mühitdə hökm sürən adət və mənəviyyətləri, mövcud sosial rolu və vəziyyəti ilə əlaqəli fərqli məsafələr və sərhədlər müəyyən edirlər.

Ən populyar tipoloji təsnifatlarda (Kretschmerin siklotimiyası-şizotimiyası, Yunqun ekstroversiyası-introversiyası, Bleulerin sintoniyası-autizmi) sosial fərqlər onların əsas meyarı kimi çıxış edir. Təsnifat şkalasının əks qütblərində başqaları ilə münasibətlərində həm ən kiçik, həm də ən böyük məsafələr yarada bilən insanlar var.

İngilislərin ümumi anlayışı yüksək sosial məsafə ilə, italyanların anlayışı isə aşağı sosial məsafə ilə əlaqələndirilir. Hakim siniflər, bir qayda olaraq, aşağı siniflərdən daha böyük sosial sərhəd tələb edirlər. Güc iyerarxiyalarını əhatə edən vəziyyətlər sərbəst vəziyyətlərdən daha böyük məsafə tələb edir (məsələn, oyun zamanı).

Psixoloji baxımdan, sosial sərhəd adətən yalnız müəyyən bir insanın mövcud psixoloji vəziyyətinə uyğun gəlmədiyi hallarda hiss olunur, yəni kimsə ortaq heç bir şey istəmədiyi bir insanla daha sıx qarşılıqlı əlaqə qurmağa məcbur olduqda və ya əksinə, bir şəxs başqa bir insana yaxınlaşmağa çalışdıqda, lakin bu və ya digər səbəbdən bu əlaqə mümkün deyil (məsələn, şizoid və ya psixastenik bir şəxs seçdiyi şəxslə yaxın əlaqə qurmaqda çətinlik çəkə bilər, çünki konstitusional xüsusiyyətləri onlara mane olur; digər hallarda isə dil çətinlikləri, sosial fərqlər və ya sosial sərhədləri azaltmağa və silməyə mane olan vəziyyətlər ola bilər).

Seçilmiş şəxslə faktiki məsafə ilə istənilən vəziyyət arasındakı uyğunsuzluq ən aydın şəkildə erotik münasibətlərdə özünü göstərir, bu da başa düşüləndir, çünki bu halda ən böyük yaxınlıq müşahidə olunur. Bir tərəfdən, əlaqə qura bilmədiyi bir insanla birlikdə olmaq üçün həsrət və istək, yaxud ayrılma bilmədiyi bu insana qarşı nifrət, nifrət, hətta ikrah hissi yaranır. Güclü emosiyaların dalğalanması çox vaxt insanlar arasında son dərəcə ziddiyyətli münasibətlərə səbəb olur.

Ətrafda insanlar olsa belə, faktiki sərhədlər və istəklər arasındakı uyğunsuzluq boşluq hissinə, yoxsa xüsusilə yaxın olmasalar da, mövcud əlaqələri kəsmək istəyinə səbəb olurmu? Frommun xüsusi diqqət yetirdiyi insanlarda azadlıq istəyi ilə ətraf mühitlə yaxınlıq istəyi arasındakı gizli ziddiyyət əsasən bu ziddiyyətdən qaynaqlanır.

Ev mühitində sosial sərhədlər ən kiçikdir və güman etmək olar ki, ən çox nevroitik münaqişələr məhz burada baş verir. Həqiqətən də,

çox vaxt, hətta xəstə ilə ilk müsahibədə belə,

onların ən yaxın çevrəsindən olan insanlar - valideynlər, bacı-qardaşlar, həyat yoldaşı, uşaqlar - onların hekayəsində görkəmli yer tuturlar.

Gənc insanlarda onların genealoji ailəsinin nümayəndələri üstünlük təşkil edir, yaşlı insanlarda isə öz ailələri üstünlük təşkil edir. Lakin, hər bir insanın ətraf mühitlə emosional əlaqəsinin xarakterik tərzı daha erkən inkişaf edir və buna görə də genealoji ailə qrupu həmişə emosional strukturun təhlili baxımından ən vacib qrup olaraq qalır.

müəyyən bir insanın (bu fakt Freydin konsepsiyasının və bütün sonrakı psixoanalitik məktəblərin əsas problemini təşkil edir).

ŞƏCƏRƏ AİLƏSİ

// GÖBƏYİN KƏSİLMƏSİ

Şəcərə ailəsinin fundamental nevroitik problemi çox sıx qarşılıqlı asılılığın kəsilməsi ilə bağlıdır. Hər iki tərəf - valideynlər və uşaqlar üçün "göbək bağının kəsilməsi" ağırlıdır, lakin zəruridir. Özlərini vaxtında şəcərə ailə bağlarından azad etməyən və

valideynlərinə qarşı ziddiyyətli hisslərlə boğulmuş yetkin qadın və kişilərin faciəvi obrazları,

fərdi azadlıq bahasına yaxın münasibətləri qorumağa qarşı xəbərdarlıq ola bilər.

Bitki böyüdükcə getdikcə daha çox torpaq tələb etdiyi kimi, insan da

yaşayış sahəsini genişləndirir. Onlar ailə qrupunda saxlanıla bilməzlər; artıq həyatın ilk illərində uşaq digər uşaqlarla əlaqə axtarır və onlarla birlikdə

üfüqi müstəvidə yaşamağı öyrənir; valideynlərlə təmas müstəvisi əyri olur.

Uşaq böyüklərə baxır və nəticədə onların obrazı həmişə nəhəng olur.

Uşaqlıqda yaşadlarından təcrid olunmuş insanlar, sonrakı həyatlarında, həmişə kiminsə üstündə və ya altında əyri bir əlaqə müstəvisi saxlayırlar.

Onlar körpə despotizmi xüsusiyyətlərini nümayiş etdirirlər və yaxınları ilə münasibətləri simbiotikdir (ağanın köləsi olmadan, kölənin isə ağası olmadan yaşaya bilmədiyi kimi, birinin digəri olmadan yaşaya bilmədiyi qarşılıqlı asılılıq münasibəti). Uşaqlıqda yaşlı oyun qrupundan məhrum olan bu cür insanlar bu itirilmiş vaxtı heç vaxt kompensasiya edə bilməzlər.

// OYUN

Oyun, reallığın "uydurma" qiymətləndirməsi ilə real vəziyyətə ən yaxşı şəkildə hazırlaşır. Oyunda oyunçu bəzən qalib, bəzən məğlub olur; bəzən o, qulaq asır, bəzən də onlar onu dinləyirlər. Buna görə də, başqaları ilə münasibətlərin aşağı spiralından qaynaqlanan xüsusiyyətlər - despotizm və həddindən artıq asılılıq xüsusiyyətləri - yox olur. Bu əks xüsusiyyətlər cüt-cüt mövcuddur:

despotik şəxsiyyət, özündən aşağı olanlara münasibətdə, özündən yuxarıdakılardan asılı olur.

Oyun qrupu tərəfindən yeni bir insanın qəbul edilməsi, onun ailə qrupundan müstəqilliyinə doğru ilk addımdır. Valideynlərin daxil olması qadağan olan öz qanunları, kəşfləri və sirləri ilə yeni bir dünya yaradılır və əgər onlar gizlicə girsələr, bu, yalnız gizli bir künc kəşf etməklə olacaq. Oyun qrupu tərəfindən iştirakçının qəbul edilməsi olmadan ilk erotik qarşılaşmalar mümkün deyil. Yetkinlik dövründə bu cür vəziyyətlər əks cinsdən olan birinə qarşı həddindən artıq utancaqlığa və ya hətta kobudluğa səbəb olur. Oyun qrupunda uşaqlıq erotizmi sərbəst buraxılır və bununla da valideynlərlə münasibətlərin erotizasiyası zəifləyir. Əgər uşaq nadir hallarda həmyaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqədə olursa, onda ailə qrupunda uşaqlıq erotizmi yatırılır. Erotizmlə rənglənmiş hisslər asanlıqla ikili bifurkasiyaya (sevgi - nifrət) məruz qalır. Sevdiklərinə qarşı ikili münasibət əhəmiyyətli bir nevroitik amildir. Üstəlik, belə bir münasibət sonradan digər insanlarla emosional münasibətlərə təsir göstərə bilər. Freyd nəzəriyyəsinin əsas sualı olan uşağın valideynlərlə münasibətlərinin erotizasiyası mümkündür.

Xəstələrinin əsasən ailə qrupu ilə sıx bağlı olması faktı.

// VALİDEYNLƏR VƏ UŞAQ ARASINDA MÜNAQİŞƏ

Ailə qrupunun strukturunda* gizli qalan münaqişə, gənclərin bu əlaqədən qurtulmaq istəyindən irəli gəlir, yaşlılar isə bunu mümkün qədər uzun müddət qorumağa çalışırlar. Valideynlər gəncləri həyat təhlükələrindən qorumaq, təcrübələrini bölüşmək, özlərinin etdikləri səhvlər barədə xəbərdarlıq etmək, gənclər isə dünyanı özləri üçün yaşamaq istəyirlər. Bu münaqişə çoxsaylı qarşılıqlı mənfi emosiyalar yaradır; valideynlər uşaqlarından məyus olurlar, onları fərqli görmək istəyirlər və sonra onları dəyişdirmək üçün daha çox çalışırlar ki, bu da öz növbəsində uşaqda üsyan doğurur. Üsyan isə müsbət əhval-ruhiyyənin mənbəyi ola bilməz!

Şübhəsiz ki, uşaq və valideynlər arasındakı əlaqə ən güclü şəxslərarası əlaqələrdən biridir. Bu, bioloji təbiətlidir. Canlı orqanizm nə qədər mürəkkəbdirsə, anasından bir o qədər çox asılı qalmalıdır; onsuz inkişaf mümkün deyil və bu əlaqəni çox erkən kəsmək ölümə səbəb olur. Bioloji baxımdan, analıq daha mürəkkəb və buna görə də daha incə həyat formalarının inkişaf mənbəyini təmsil edir. Bu mənada insanlar, xüsusən də həyatın çətin anlarında ana və ya ataya olan ehtiyacları ölümünə qədər davam etdiyindən, həqiqətən də canlı təbiətin zirvəsində dayanırlar. İnsanlar mürəkkəb strukturlara mənsubdurlar və heç vaxt tam yetkin və müstəqil olmayacaqlar.

Canlı təbiətin strukturlarının xarakterik xüsusiyyəti onların fərdiliyidir. Hər bir canlı orqanizmin öz morfoloji, biokimyəvi, fizioloji və hətta psixoloji strukturları var, çünki təcrübələr və buna görə də psixoloji amillər hər bir həyatın xüsusiyyətlərindən birinə aiddir. Cinsi çoxalma canlı təbiətin strukturlarının fərdiliyini təmin edir. Hər bir cinsi qarşılaşma yeni bir struktur müstəvisi yaradır. Cinsi olmayan təbiətdə və texnologiyada olduğu kimi, cinsi olmayan növün çoxalmasında nəslin orqanizmi prototipin etibarlı surətini təmsil edir.

Sözügedən ailə münaqişəsi müxtəlif strukturlarla bağlıdır: uşağın strukturu və valideynlərin strukturu. Görünür, həm canlı, həm də cansız aləmlərdə vacib olan ümumi bir qanunauyğunluq mövcuddur, yəni, yaxınlıqda və qarşılıqlı asılılıqda olan müxtəlif strukturlar arasında hər birinin qələbə istəyindən ibarət spesifik bir antaqonizm yaranır.

Daha az antropomorfik baxımdan deyə bilərik ki, fərdi strukturların müəyyən bir yaxınlaşması ilə bir-biri ilə təmasda olan və bir-birindən asılı olan ayrı-ayrı vahidləri əhatə edən yeni bir struktur yaranmağa başlayır. Bu yeni qrup strukturu fərdi strukturların hərəkətlərinin təsiri altında formalaşır və buna görə də onlar arasında "rəqabət" və ya "hakimiyyət uğrunda mübarizə" yaranır.

Müxtəlif strukturlar arasındakı münaqişə despotik münaqişənin bir növüdür -

hakimiyyət uğrunda mübarizə, öz strukturunun tətbiqi. Ailə qrupu vəziyyətində uşaq valideynlərindən daha pis vəziyyətdədir; onların strukturu yalnız yeni yaradılır, valideynlərinin strukturu isə az-çox tamdır. Lakin, uşaq hələ də valideynlərindən daha yaxşı vəziyyətdədir, çünki onlar bioloji gücləri, yəni yuxuda olan potensiallarını reallaşdırmaq istəyi ilə onları məğlub edirlər. Uşağın istək və arzularını yerinə yetirmək üçün qabaqda bir vaxtı var, halbuki valideynləri artıq vaxtlarının çox hissəsini özləri üçün ayırıblar.

Uşaq yetkinlik yaşına yaxınlaşdıqca valideynlərə qarşı üsyan artır. Bioloji baxımdan bu fenomen başa düşüləndir. Cinsi partnyor ailə qrupundan mümkün qədər uzaq bir dairədən gəlməlidir. Ailə bağları kəsilməsəydi, bu qrup daxilində cinsi münasibətlər yaranardı ki, bu da nəsle mənfi təsir göstərərdi. Zərərli genetik xüsusiyyətlər ortaya çıxardı ki, bu da ailə dairəsindən kənar münasibətlərdə xarici partnyorun əks genetik strukturu tərəfindən basdırılır.

// "AİLƏ İSTİLİYİ" (DUYGU REZONANSI)

Ailədən ayrılmaq ehtiyacından irəli gələn münasibətin əksi uşaqla ailə arasında çox az əlaqədən qaynaqlanan münasibətdir ki, bu da özlərini yad və istənməyən hiss edirlər. Bu, istənməyən və istənməyən uşağın problemidir.

"Ailə istiliyi" anlayışının məşhur tərfi çətin olsa da, uşağın maddi qayğıdan daha çox, eyni dərəcədə, bəlkə də daha çox ehtiyac duyduğu şeyi ən yaxşı şəkildə əks etdirir.

Ailədə hökm sürən emosional iqlim bir çox amillərdən asılıdır: valideynlərin emosional münasibətləri, uşağa münasibəti və ailə quruluşu.

Ailə qrupunda, hər bir qrupda olduğu kimi, hər bir üzvün müəyyən bir rol oynamasından, müəyyən vəzifələri yerinə yetirməsindən və müəyyən imtiyazlardan istifadə etməsindən ibarət müəyyən bir quruluş formalaşır. Bu qrupun ayrı-ayrı üzvləri arasındakı asılılıq sistemi az-çox daimi olur.

Başqasının ruhi vəziyyətini qavramaq qabiliyyəti insanlarda artıq körpəlik dövründə ortaya çıxır. Məlumdur ki, kiçik bir uşaq ananın narahatlığını hiss edir və

bunu öz narahatlığı ilə cavablandırır (Sullivan empatiyası), bu da ağlamaq, qışqırmaq, iştahsızlıq, qusma və digər emosional və vegetativ reaksiyalarla özünü göstərir. Hətta insanlarla birlikdə yaşayan heyvanlar da bu qabiliyyəti nümayiş etdirir; məsələn, bir it ilk növbədə ondan qorxanlara hücum edəcək.

Görünür, bu emosional rezonans qabiliyyəti zamanla azalır.

İnsanlar getdikcə aktiv həyat tərzinə öyrəşir, başqalarını fəaliyyət nümunələrinə görə qiymətləndirir və onların daxili təcrübə dünyası ilə getdikcə daha az maraqlanırlar.

"Biz onları hərəkətlərindən tanıyıırıq" anlayışına uyğunlaşaraq, onlar

hisslərini idarə etməyə və mövcud sosial vəziyyətə uyğun davranmağa çalışırlar. Emosional rezonans qabiliyyəti daha qeyri-adi hallarda, məsələn, erotik yaxınlıq zamanı, iki düşmən qarşılaşdıqda, izdihamın coşğusu və ya panikası zamanı və s. qayıdır. Nevrotik xəstələrdə və xüsusən də ruhi xəstələrdə başqasının ruhi vəziyyətinə uşaq kimi həssaslıqla qayıtma müşahidə olunur. Xəstə bir insanın yanında özünü maskalamamalıdır; onlar maskanın aldadıcılığını hiss edəcəklər və maska onların narahatlığını artıracaq. Xəstə ilə, uşaqda olduğu kimi, açıq olmaq lazımdır.

Buna görə də, ailə mühitini müzakirə edərkən, gizlədilməmiş, real hisslər haqqında düşünmək lazımdır. İki pisləkdən, valideynlərin valideynlərinin səs-küylü səhnələrə çıxdığı və ardınca sevincli barışıqların olduğu bir ev, uşaq üçün valideynlərin birlikdə həyatının xoşməramlılıq örtüyünü qorumağa əsaslandığı bir evdən daha yaxşıdır. Uşaq valideynləri arasındakı gizli düşmənçiliyi asanlıqla hiss edir. Valideynlər arasındakı münasibətə uşağın gözü ilə baxmaq lazımdır. Valideyn obrazları uşaq üçün çox böyükdür, çünki uşaq onlara aşağıdan baxır.

Yuxarı. Valideynlər arasında mübahisələr uşağın gözündə fəlakətli ölçülər alır və uşağın tez-tez etdiyi barışıq jesti öyrənilmiş deyil, həqiqətlə dolu bir jest olacaq. Bu jestlə onlar dünyalarının faciəsinin qarşısını almağa çalışırlar.

Gizli düşmənçilik vəziyyətində uşaq çarəsiz qalır, təhlükəni hiss edir, lakin qarşısını ala bilmir və daim qorxu içində yaşayır.

Rəsmi əlaqə saxlayan dağılmış ailələrdə uşaq ailəni bir yerdə saxlayan bir növ halqaya çevrilir və onsuz ailə mövcud ola bilməzdi. Uşaq üçün bu, çox emosional təzyiqdır.

Digər tərəfdən, rəsmi olaraq dağılmış ailələrdə valideynlərdən birinin ayrılması onun bütün strukturunu məhv edir. Normal bir ailədə iki nəfərdən ibarət bir səth əmələ gətirən, uşağa təhlükəsizlik hissi verən və eyni zamanda uşağın sosial dünyanın ilk modelini və ilk sosial əksini təşkil edən hər şey dəyişir və

yalnız bir nəfər qalır, iki nəfər rolunu oynamağa məcbur olur. Bu rolların hər ikisi uşağın normal inkişafı üçün vacibdir. Görünür, reallıqda mövcud olmayan ideal ailə modelində ana, genetik amilləri istisna etsək, uşağın əsas emosional strukturunun formalaşması əsasən bundan asılı olan emosional bir mühit yaradır. Bu mühitdən asılı olaraq, gələcək dünya daim cəlb edəcək və ya dəf edəcək. Digər tərəfdən, ata uşağın dünyasının normativ

formalaşdırılmasında, dəyərlər iyerarxiyasının, fundamental etik

qiymətləndirmələrin və özünəinamın formalaşmasında rol oynayır.

Valideynlərdən biri bu rolların hər ikisini oynadıqda, bu, emosional və ya normativ olsun, əsas zehni funksiyalardan birinin inkişafındakı çatışmazlığa səbəb olur. Ailənin dağılması halında, uşağın vəziyyəti valideynlərdən birinin ölümündən daha pisdir. Uşağın özü üçün vacib olan bir insanın onunla olmaq əvəzinə, uzaq bir yerdə olduğunu bilməsi,

daimi gərginlik, gözlənti, mühakimə, narazılıq hissləri və s. yaradır. // SOSIAL MÜHİT İLƏ İLK ƏLAQƏ

Valideynlər uşağın ilk sosial dünyasını təşkil edirlər. İnsanlar, heyvanlardan daha çox, sosial dünyalarından asılı olduqları üçün, çünki onsuz onlar ölümə məhkumdurlar, valideynlərin şəxsiyyəti hər bir insanın həyatında çox vacib rol oynayır. Onlar həyatlarının hər çətin anında onlara müraciət edirlər və ömrünün sonunda onlara daha da yaxınlaşırlar. Hər bir nevrozda, mövcud nevroitik münaqişələrin səthi altında, həmişə sosial mühitin ilk nümayəndələri ilə münaqişələrə çatmaq olar. Sosial mühitlə bu ilk əlaqə digər, sonrakı əlaqələrin formalaşması üçün kətan olur. Sonrakı münaqişə vəziyyətləri isə müəyyən dərəcədə sosial mühitlə ilk münaqişələri əks etdirir. Lakin sosial mühitlə bu ilk əlaqə sırf sosial xarakter daşımır. Uşağın orqanizminin ananın orqanizmində doğulması faktı bu əlaqəyə insanlar arasındakı digər əlaqələrdə olmayan spesifiklik verir. Ananı uşağı ilə bağlayan hisslər digər şəxslərarası əlaqələr kateqoriyalarına uyğun gəlmir. Əgər belədirsə, onda ana hisslərinin patologiyası ilə qarşılaşırıq. Daha sonra analıq üçün emosional yetkinlikdən danışmaq adi haldır ki, bu da bəzən bioloji yetkinliyin müəyyən xüsusiyyətləri ilə birləşir (məsələn, inkişaf etməmiş uşaqlıqla).

İnsanlar, heyvanlardan fərqli olaraq, ətraf mühitlə əlaqələrinin bioloji təbiəti ilə müəyyən edilmiş sərhədləri aşma biləcək qədər çox sayda potensial davranış formalarına (potensial funksional strukturlara) malikdirlər. Bu, insanlarla ətraf mühit arasında heyvanlar aləmində görünməmiş bir uyğunsuzluğa səbəb olur. Heyvanlar analıqlarında sadə, ağıllı və nəcib olsalar da, insan analıq formaları, bu formalara müxtəlif rənglər vermək üçün mövcud imkanlar nəzərə alınmaqla belə, asanlıqla deformasiyaya uğrayır.

// ANA

Yeni rollarında özlərini etibarsız hiss edən analar var. Onlar uşaq tərbiyəsi ilə bağlı ixtisaslaşmış ədəbiyyatdan faydasızdırlar və uşağın görünüşü onlarda qorxu oyadır və öz qadınlıqları ilə bağlı gizli narahatlıq yaradır. Uşağın əhatə etməyə çalışdıqları artan qayğı, uşağın onlarda yaratdığı narahatlığı aradan qaldırmır və bu da öz növbəsində uşağa ötürülür.

Uşağın planlaşdırılan həyatına maneə olduğu analar var. Onların "yuxarıdakı" mövqeyi — dünyanı öz iradələrinə uyğun olaraq yenidən formalaşdırmaq — ətraf mühitlə bağlı emosional vəziyyətlərinə ("əvvəl" və "başlayan") üstünlük təşkil edir.

Analıq hissləri müxtəlif ali mülahizələr tərəfindən yatırılır;

yeni təcrübə və sevinc mənbəyi olmaq əvəzinə, onlar narahatlıq yaradır və nevroitik amilə çevrilir. Analıq hisslərindən məhrum olan uşaq isə soyuq, bəlkə də düşmən atmosferində böyüyür.

Artıq hər şeydən — ərdən, uşaqlardan və evdən — bezmiş müxtəlif məsuliyyətlərlə yüklənmiş analar var. Müasir həyatın şərtlərinin yaratdığı əsəbilik analıq hisslərini, eləcə də cinsi münasibətləri əks etdirir. Analıq və cinsi həyat eyni bioloji qanuna — növün qorunmasına tabe olmaqla sıx bağlıdır. Qadınlarda əsəbilik adətən yalnız cinsi əlaqəyə deyil, həm də analığa qarşı soyumağa səbəb olur. Və bütün bunlar, qapalı bir dairədə, nevroitik narahatlığı artırır.

Uşaqla münasibət valideynlər arasındakı emosional əlaqələr sistemini əks etdirir. İnsan öz uşağında nifrət hissləri oyadan cinsi partnyor xüsusiyyətlərini aşkar edə bilər. Bir vaxtlar partnyora yönəlmiş hisslər uşağa da ötürülə bilər. Bu tip emosional əlaqə ərləri tərəfindən tərk edilmiş və ya onlarla yalnız rəsmi münasibətdə yaşayan subay qadınlarda özünü göstərir. Belə bir vəziyyətdə olan uşaq sonsuz hisslər və bütün həyatının ona həsr olunduğu iddiası ilə boğulur.

"Yuxarıda" despotik mövqeyi ilə ətraf mühitin emosional "aşağıda" mövqeyi arasında tərs əlaqə mövcuddur. İnsan dünyanı nə qədər az seversə, onu bir o qədər çox dəyişdirmək istəyir. Bu, valideynlərin uşaqlarına münasibətinə də aiddir. Uşaq valideynlərinə həddindən artıq bağlı olduqda, valideynlərin onlara qarşı emosional münasibətinin uyğun olmadığından və despotik davranışın emosional nəzarəti aşdığından şübhələnməyə bilər.

Yuxarıda müzakirə edilən ailə qrupundakı iki əsas münaqişə növü - biri qrupdan ayrılmaq ehtiyacından qaynaqlanır, digəri isə mövcud ailə mühitinin patologiyasından doğan münaqişələr - bir-biri ilə əlaqəlidir. Despotik nizamın hökm sürdüyü yerdə birinci tip münaqişələrin yaranma ehtimalı daha yüksəkdir.

ÖZ AİLƏSİ

// TƏKAMÜL PROBLEMİ

Birindən insanın (şəcərə ailəsi) yarandığı və ikincisindən, insanın özü tərəfindən yaradılan iki ailə qrupu əks yollarla inkişaf edir. Birinci qrupda, inkişaf xətti diasporaya aparır. Əvvəlcə ailə ilə qaynayıb qarışan uşaq, bu ailə əlaqələrini qırmalı, müstəqil, fərdi həyata başlamalı və öz ailəsini yaratmalıdır. Digər ailə qrupunda (ailə) inkişaf xətti sıx birləşməyə aparmalıdır. Əvvəlcə yad olan iki insan yeni bir ailə yaradır və ya ən azından yeni bir ailə üçün zəmin yaratmalıdır. Gələcək uşağın böyüdülməsi üçün atmosfer bu birləşmədən, bu birlikdən asılıdır.

Həyat yoldaşları arasında müxtəlif münaqişələr tək bir problemə endirilə bilər: necə

birləşmək olar? İki insanın birləşməsi prosesi öz təkamülündən keçir. O, ləngiyə bilməz və əgər ləngisəydi, bu iki insanın birləşməsi prosesi qeyri-mümkün olardı. Üstəlik, tərs inkişaf başlayacaq, aralarında uzaqlaşma və nəticədə ailənin dağılması baş verəcəkdir. Bu proses hər iki tərəfdədən səy tələb edir - qarşılıqlı anlaşma, tolerantlıq, bağışlamaq bacarığı ("sevginin hər şeyi bağışlamaq və unutmaqdan daha böyük gücü yoxdur"), qayğı, məsuliyyət, kin-küdurətdən qaçınmaq və s. Təbiətdəki çürümə prosesləri həmişə yaradılış proseslərindən daha sadədir - entropiya qanununa görə. Daha böyük nizama, mənfəət entropiyaya doğru təkamül səy tələb edir; bu mənada həyat çətinlikdir, çünki dağıdıcı hadisələrin aradan qaldırılması lazımdır.

Görünür, bu fundamental problem ailə həyatına da aiddir.

Təbiətin iki fundamental qanunu - öz həyatının və növün həyatının qorunması -

digər qanunlardan, hətta insanlar tərəfindən yaradılan qanunlardan fərqləndirir, çünki onların

riayəti bəzən çox böyük məmnuniyyət hissi ilə mükafatlandırılır. İnsanlarda bu qaydadan sapmalar (anoreksiya, anorgazmiya) xoş bir hiss şəklində mükafat götürüldükdə baş verir. Lakin bu şərtlər patoloji xarakter daşıyır və qayda deyil, istisna hesab edilməlidir. Lakin təbiət qanunlarına riayət etməyin məmnunluq və bəzən dəbdəbə gətirməsi, onların səy tələb etməməsi və çox vaxt bunun üçün böyük səy tələb etməsi demək deyil.

// QƏHRƏMANLIQ DAVRANIŞI

İkinci bioloji qanuna riayət etmək gücün səfərbər edilməsini və müəyyən dərəcədə qəhrəmanlıq davranışını tələb edir. Kişilərdə bu səfərbərlik qanuna riayət etməzdən əvvəl, qadınlarda isə sonra baş verir. Partnyora sahib olmaq, qəhrəmanlığın əsas davranış xüsusiyyətlərindən birini təşkil etdiyi kişiliyin az və ya çox nümayişi ilə əlaqələndirilir.

Qadın üçün həyatın qəhrəmanlıq dövrü cinsi əlaqədən sonra başlayır və analıqla əlaqələndirilir.

Müasir texnoloji sivilizasiya təbiət qanunları ilə əlaqəli səy və qəhrəmanlığı xeyli azaltmışdır. Yemək əldə etmək çətinliklərlə əlaqəli deyil və cəmiyyətin imtiyazlı hissəsində heç kim aclıqdan ölmür; qadına sahib olmaq da asan bir prosesə çevrilib; qadınlar analıq çətinliklərindən mümkün qədər uzaqlaşmağa çalışırlar və doğuş riski xeyli azalıb. Lakin, müasir sivilizasiyanın müxtəlif qıcıqlanma formalarında təzahür edən yorğunluğunun təbiətin iki əsas qanunu ilə əlaqəli məmnuniyyətin çox asan əldə edilməsindən qaynaqlandığını istisna etmək olmaz, yəni:

Bu çətinlik çatışmazlığı məmnuniyyət hissini əlindən alıb. Eyni hiss, reallaşma yolunda qarşılaşılan çətinliklər artdıqca artır.

// QOŞULMA

Növlərin qorunub saxlanması qanununun dərk edilməsi, insanın təbiətlə birləşmək, onu ətraf aləmdən ayıran sərhədləri aşmaq, ana qoynuna qayıtmaq (Rank, Fromm) kimi yuxuda olan həsrətini və istəyini sakitləşdirir, çünki ətraf aləmlə birləşmə ən yüksək həddə çatmışdı. İnsan inkişafı, ailə dairəsi daxilində birləşmə anından öz ailəsində eyni birləşməyə qədər davam edir. "Kişi atasını və anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və onlar bir bədəndə iki olacaqlar." Bütün çətinlik bu bütövlüyü yaratmaqdadır; yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu proses uzun və mütərəqqi olur və əgər yoxdursa, dərhal geriləmə baş verir.

Ailə kimi ən kiçik sosial qrup daxilində birləşmə, görünür, vahidin müəyyən bir ayrılmaz səviyyəsinin qorunmasını asanlaşdırır. İnteqrasiyanın pozulması ən asan yeniyetməlik dövründə, insanın ailə qrupundan ayrıldığı və ya ailəyə az bağlı olduğunu hiss etdiyi və hələ öz ailəsini qurmadığı yaşda (bu, şizofreniyanın ən çox özünü göstərdiyi həyat dövrüdür) baş verir.

İnsan tək olmaqdan, qrupda daha inamlı hiss edir; qrupun dəstəyinin fərqində olmaq təhlükəsizlik hissi yaradır və daxilindəki mövcud struktur onun fərdi üzünlərinin strukturunun sabitliyini artırır.

Əgər ailə qrupları heyvanlar aləmində yaranırsa, onlar, bir qayda olaraq, insanlardan daha çox birləşirlər. Bu vəziyyət təbiətdəki insanların

ən mürəkkəb təşkilatı və eyni zamanda ən az sabit olanı təmsil etməsi faktından təsirlənir. Sistem daha mürəkkəbləşdikcə onun sabitliyi azalır. Bundan əlavə, heyvanlar aləmində təbii seleksiya insan mühitinə nisbətən daha az pozuntuya məruz qalır.

// TƏBİİ SEÇİM

Həyatın mahiyyətini təşkil edən əksər problemlər kimi, təbii seleksiya

hələ də qeyri-müəyyən bir fenomen olaraq qalır. Kim seçilir, kim seçir və bu seçim hansı əsasda baş verir? Bu seçim Darvinin təkamül nəzəriyyəsi baxımından vacibdir, çünki seçilmiş nümayəndələr ən yaxşı bioloji keyfiyyətlərə malikdirlər və sonra canlı təbiətin inkişafı mümkün olur.

İnsanlarda təbii seleksiya problemi daxildən, yəni təcrübələri təhlil etməklə izlənilə bilsə də, prosesin subyektiv tərəfi haqqında bilik hələ də problemi həll etmir. Və niyə başqa bir insanın deyil, məhz bu şəxsin sevgi obyektinə çevrildiyi sualına cavab vermək çətinidir və cavab verən şəxs qərarının bütün motivlərini bilmədiyi üçün cavab həmişə qeyri-dəqiqdir. Və naməlum motivlər çox vaxt ən vacibidir.

Bioloji baxımdan təbii seleksiya ailə qrupunu bağlayan əsas amillərdən biridir. İki insanı cəlb edən bu sirli qüvvə yoxdursa, mənəvi nizam, iqtisadi şərtlər və s. kimi digər birləşdirici amillər kömək etmir. Cinsi əlaqə iki insan arasında ən böyük yaxınlığı yaradır və təbii seleksiyanın müəyyən etdiyi bioloji cazibədən məhrumdursa, bu hal...

Güclü qarşılıqlı itələmə və digər cəlbədicə qüvvələr bunun öhdəsindən gələ bilmir.

Əlbəttə ki, təbii seleksiya anlayışını rədd edib panmiksianın mövcudluğunu qəbul etmək olar, yəni hər kəs istənilən şəxslə cinsi əlaqədə ola bilər. Hər iki heyvanın, xüsusən də filogenetik inkişafın ən yüksək mərhələlərində olanların və insanların cinsi davranışlarının müşahidələrinə əsasən, bu mövqe, görünür, səhvdir.

Məlumdur ki, cinsi istəyin artdığı hallarda təbii seleksiyanın selektiv qüvvəsi zəifləyir və hər kəs potensial cinsi tərəfdaş ola bilər ki, bu da panmiksianın təəssüratını yarada bilər, lakin bu, yalnız göz qabağındadır. Bəzən təbii seleksiyanın mövcudluğunu qəbul etməyin çətin olduğu münasibətlər olur və daha çox təsadüfi seçim haqqında düşünmək olar, məsələn, seçim olmadığı zaman ("çətin vəziyyətdə belə xərçəngkimilər balıqdır"), alkoqolun təsiri altında və ya başqalarının böyük təzyiqi altında edilən seçimdə (keçmişdə olduğu kimi, valideynlər uşaqlarının taleyini həll etdikdə) və ya qisasla motivasiya edilən seçimdə (cinayətkardan qisas almaq üçün ilk qarşılaşdığım şəxslə evlənəcəyəm) və s. Bundan əlavə, iqtisadi, sosial və mənəvi mülahizələr cütləşmədə rol oynayır, məsələn: o, yaxşı maddi imkanlara malik və ailəni təmin edə bilən xeyirxah bir insandır,

yüksək sosial mövqe tutur və s. Lakin bütün bu istisnalar insanı təbii seleksiya qanunundan kənarlaşdırmır.

Evlilikdə təbii seleksiyanın olmaması daimi nevroitik gərginliyə səbəb olur. Artıq qeyd edildiyi kimi, başqa bir insanla ən böyük yaxınlıq anı gəldikdə, bu yaxınlığı gətirən təbii qüvvənin olmaması əks mənfi hissləri - laqeydlilik, nifrət, ikrah, xor və s. oyadır. İnsanlarda, bütün heyvanlar aləmində olduğu kimi, ən böyük zövq mənbəyi olmalı olan hər şey narazılığa və ya sadəcə ikraha səbəb olur. Əlbəttə ki, insanlar mürəkkəb quruluşlarına görə ətraf aləmlə əlaqələrinin sadə təbiiliyindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər, lakin onların partnyor seçiminin təbii seleksiya qüvvəsinin ən azı minimal təsiri olmadan tamamilə süni olması nadir haldır. Daha çox rast gəlinən hallar, iki insanın birlikdə yaşadığı müddətdə mövcud təbii seleksiya qüvvələrinin daimi, sıx təmasdan yaranan mərkəzi qüvvələr tərəfindən yatırıldığı vəziyyətlərdir. Tipik bir nümunə, toydan əvvəl aşiq olan və sonradan bir-birlərindən nifrət edən iki insanın hekayəsidir. // ÇƏTİN YAXINLIQ

İnsan ətraf mühitlə əlaqə qurmağa çalışır, tənhalığının dairəsindən qaçmaq istəyir,

lakin bu birləşməyə uyğunlaşma qədər çətinlik çəkir. Başqa bir insanla sıx təmas,

əgər partnyor yalnız cinsi məmnuniyyət üçün bir obyekt kimi qəbul edilmirsə,

cinsi həyatda qaçılmazdır,

sosial sərhədlərə olan təbii insanın ehtiyacını pozur. Hər bir şəxs üçün fərqli olan və onların konstitusional quruluşundan, sosial

mövqeyindən və həyat tarixindən asılı olan məqbul yaxınlıq sərhədini keçmək narahatlığa səbəb olur.

Başqa bir nümunə üçün, bu tip narahatlıq psixoterapevtik

təmaslarda (terapevt və müalicə alan arasında) özünü göstərir.

Buna görə də, təbii seleksiyanın tələb etdiyi daimi yaxınlıq, eləcə də

Ailə qrupunu birləşdirmək ehtiyacı müəyyən miqdarda səylə əlaqələndirilir. Bu səy normal, müəyyən edilmiş sərhədləri qorumağa çalışan mərkəzi qüvvələrlə mübarizə aparmaq üçün lazımdır. Bu mənada ailə həyatının tarixi

inkişaf edir. Bu təkamül,

fərqli həyat tarixçələrinə, fərqli şəxsiyyət tiplərinə, fərqli adət-ənənələrə və s. malik iki insanın birləşməsinə gətirib çıxarmalıdır.

Ən çox ailə integrasiyası prosesini gecikdirən bir sıra amillər müəyyən edilə bilər.

// "XARAKTER FƏRQLƏRİ"

"Xarakter fərqləri" tez-tez boşanmanın səbəbi hesab olunur. Hər iki tərəfdaşla daha yaxından tanış olduqda, onların fərqləri deyil, oxşarlıqları aşkar edilir. Oxşarlıqlar,

xüsusilə də "psixopatik tikan" və ya "psixi donqar" adlandırılan patoloji xarakter xüsusiyyətlərinə, şəxsiyyət təhriflərinə aiddir. Belə insanlar arasında yaxın münasibətlər münaqişələrə səbəb olur, çünki onlar daim "donqarlarının" və ya "tırmanışlarının" toqquşmasına məruz qalırlar. Əgər hər iki partnyor impulsivlik, eqosentrizm, despotizm, diqqətsizlik, cinsi alçaqlıq hissi, natamam cinsi identifikasiya, emosional soyuqluq və bu kimi xüsusiyyətlərə malikdirsə, onda birlikdə olmaq bəzi xüsusiyyətlərin partnyordakı digər xüsusiyyətlərlə kompensasiya edildiyi hallara nisbətən xeyli çətinləşir ("Tanrı cütlüyü bir araya gətirir"). "Les extremes se touchent" qaydası təbii seleksiyada tətbiq olunur. Bu qayda sayəsində təbiət ifratların (natura horret extrema) ortaya çıxmasına qarşı çıxır; eyni ifrat xüsusiyyətlərə malik valideynlərin övladları bu xüsusiyyətləri əks xarakter xüsusiyyətlərinə malik valideynlərin övladlarından daha çox miras alırlar.

Əslində oxşarlıqları təmsil edən "xarakter fərqləri" halında, psixopatik xüsusiyyətlər baxımından təbii seleksiyanın natamam hərəkətini nəzərə almaq lazımdır. Hər bir ailənin təkamülü böyük çətinliklərlə üzləşir və münaqişəyə səbəb olan patoloji xüsusiyyətlərini yatırımağa məcbur olan tərəfdaşlar tərəfindən çox səy tələb edir. // ANLAŞMA

Həyat yoldaşlarından birinin və ya hər ikisinin tez-tez şikayətlərindən biri qarşılıqlı anlaşmanın olmaması ilə bağlıdır: "o, məni başa düşmür". Bu vəziyyət

tərəfdaşlar arasında qarşılıqlı əlaqənin zəiflədiyini göstərir.

"O (o) məni başa düşmür" sözləri kin hissini əks etdirir və partnyor hökmü elan edən hakim kimi çıxış edir. İncil əmr: "Mühakimə etmə, yoxsa məhkum olunarsan" insanlar tərəfindən nadir hallarda istifadə olunur. Onlar sevdiklərini mühakimə etməkdən özlərini saxlaya bilmirlər.

İctimaiyyətin "sağdakı" və "soldakı"lara bölündüyü, yəni birinə yaxınlaşmaq mümkün, digərinə isə yaxınlaşmamalı olduğu belə bir məhkəmənin öz əhəmiyyəti var və hətta ətraf aləmdə əsas istiqamətləndirmə üçün zəruridir.

Belə bir məhkəmə qərarı adətən kifayət qədər əsaslandırılmadan verilir. Bəzən xoşagəlməz bir üz ifadəsi onu dərhal rədd etmək üçün kifayətdir. Və çox güman ki, bu, sadəcə

əvvəlcədən mövcud olan bir fikrə uyğunluqdur. Birini "sol tərəfdə" və ya "sağ tərəfdə" kimi təsnif etmək qərarı, bu qərarı izah edən hökmdən əvvəl verilməlidir.

Müttəhimlər kürsüsündə oturan şəxs də özünü səhv başa düşülmüş hiss edir. Məhkəmə atmosferi heç bir qrupda, xüsusən də bu uyğunluğun ən böyük olduğu bir ailədə birliyin yaranmasına kömək etmir. Bu atmosfer

qrupun bir üzvünü tamamilə və ya qismən kənarlaşdırır. Sonuncu halda, bir davranış forması pislənir.

"O (qadın) məni başa düşmür" sözləri yerinə yetirilməmiş arzular hissini ifadə edir və

həyatın dolğunluğunun erotik münasibətdə tapıla biləcəyinə ümid edir. Bu arada,

fiziki yaxınlığa baxmayaraq, zehni təcrid qalır. Anlaşılmazlıq hissi

burada başqa bir insanla əlaqənin olmaması ilə ifadə olunur. Sonra

ideal bir ana və ya ideal ata həsrəti yaranır, çünki yalnız onlar başa düşə və kömək edə bilərdilər.

// KLAN MÜNAQİŞƏLƏRİ

Klan münaqişələri tez-tez evli həyatın əvvəlində yaranır. Bunlar, həyat yoldaşlarından birinin ortaya çıxdığı ailə qrupu ilə əlaqənin yeni bir ailə qrupunda yeni bir əlaqənin yaranmasına mane olması faktından ibarətdir. Köhnə ailənin kölgəsi tərəfdaşları

bir-birindən ayırır. Onların hər biri iki rol oynamalıdır. Valideynləri üçün onlar həmişə uşaq olaraq qalacaqlar, amma partnyorları üçün yetkin və məsuliyyətli bir insan olmalıdırlar.

Evliliyin ilk illərində tez-tez baş verən ailə böhranları, çox vaxt partnyorun öz ailəsinə baxışı ilə əlaqələndirilir. Daha müstəqil olması gözlənilən kişi xüsusilə cəlbedici görünür. Qəfil devalvasiya baş verir. Bir doza romantizm və qəhrəmanlıqla bəxş edilmiş sevgilinin rolundan kişi "anasının oğlu" roluna keçir. Yeni evlənənlər valideynləri ilə, xüsusən də ərinin qayınanası ilə yaşadıda münaqişələr daha da şiddətlənir.

// MƏSULİYYƏT

Evlilik müəyyən öhdəliklər qoyur, azadlığı məhdudlaşdırır və gündəlik narahatlıqlar gətirir. Belə bir vəziyyətdə asanlıqla narazılıq yaranır, tez-tez həyat yoldaşlarından birinin bu ağır yükü təkbaşına daşıdığına dair ittihamlar irəli sürülür. Öz hüquqları uğrunda mübarizə atmosferi yaradılır ki, bu da ailə qrupunun müsbət təkamülünə töhfə vermir;

mərkəzdənqaçma qüvvələri mərkəzdənqaçma qüvvələrini aşma bilər.

Ailə həyatının yükünü daşımaq qabiliyyəti "emosional yetkinlik" anlayışını formalaşdıran müəyyən şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Burada "verməyin" "almaqdan" daha çox yayılmasından danışa bilərik. Kiçik bir uşaq verdiyindən daha çox götürür ki, bu da onun böyüklərdən asılı vəziyyətindən irəli gəlir. Emosional yetkinlik inkişaf etdikcə, "vermək ehtiyacı" artır. Bu ehtiyac artıq uşaqların kuklalara və ev heyvanlarına münasibətlərində müşahidə olunur. Emosional cəhətdən yetkin olmayan insanlarda "almaq" "verməkdən" daha çox üstünlük təşkil edir. Onlar zehnlərində "aldıqlarından daha çox verməli olduqları" zaman "sevilməmiş" və "məhrum" olduqlarını hiss edərək əsəbiləşirlər.

Emosional yetkinliyin əsas xüsusiyyətlərindən biri məsuliyyət hissidir. Bu, ailə qrupunun sabitləşməsində mühüm rol oynayır.

Məsuliyyət hissi müəyyən davranış normalarının kodlaşdırılması ilə əlaqələndirilir.

İnsanın istəyib-istəməməsindən, əhval-ruhiyyəsindən və hazırkı emosional vəziyyətindən asılı olmayaraq, başqa bir insana qayğı göstərmək ehtiyacından irəli gələn müəyyən bir davranış xətti qalır. Məsuliyyət hissi müəyyən dərəcədə kortəbiiyin əksidir.

Spontan davranış birbaşa mövcud emosional vəziyyətdən qaynaqlanır, məsuliyyətli davranış isə çox vaxt buna qarşı çıxmalıdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, insanın normal sosial sərhədi keçildikdə, hisslərin əks dəyərlər ("sevgi və nifrət") arasında asanlıqla tərəddüd etdiyi spesifik "emosional kondensasiya" baş verir. Belə bir vəziyyətdə, başqa bir insana qayğı və məsuliyyət hissinin yaranması üçün lazım olan emosional sabitliyi qorumaq çətindir. Uşaqla münasibətə gəldikdə isə, qayğı xüsusilə anada, əksər hallarda kortəbii şəkildə yaranır və bu hissi yaşamamaq üçün böyük eqoizm və emosional yetkinlik tələb olunur. Qayğı, uşağa qarşı emosional münasibətdə ifadə olunur, onun üzərində əylirik, onun üzərində dolaşırıq, onu bütün kədərlərdən və əzablardan qorumağa çalışırıq, onları həyat boyu məharətlə istiqamətləndiririk. Subyektiv mənada öz uşağı ilə bioloji əlaqə, yalnız hamiləlik dövründən daha uzun müddət davam edir və adətən uşağın böyüməsindən, eləcə də daimi qayğıya ehtiyacı olan kiçik bir uşağın çarəsizliyindən asılı olmayaraq, həyat boyu davam edir - bütün bunlar qəyyumluğu səfərbər edir. Valideynlərdə məsuliyyət hissi, xüsusən də anada təbii və kortəbii bir fenomendir və onun olmaması açıq bir patologiyayı göstərir.

Hər iki tərəfdaş arasındakı münasibət məsələsi fərqli görünür. Bu halda məsuliyyət hissi kortəbii və təbii hesab edilə bilməz; əvvəlcə inkişaf etdirilməlidir. Tərəfdaş çarəsiz bir uşaq deyil; onlar bioloji olaraq tərəfdaşları ilə ananın uşağa bağlı olduğu kimi bağlı deyillər. Cinsi əlaqə, əlbəttə ki, spesifik bir əlaqə kimi qəbul edilə bilər, lakin bu hərəkət qısamüddətli və analıq hisslərinin sabitliyindən məhrum olan spesifik təcrübələrlə əlaqələndirilir.

Üstəlik, yetkin bir insana həddindən artıq qayğı çox vaxt onları maneə törədir və məhdudlaşdırır. Yetkinlər həmişə bərabərhüquqlu tərəfdaş olmaq və azadlıqlarını qorumaq istəyərək aşağı tutulmağa dözmürlər. Onlar kiminsə narahatlığını despotik köləlik kimi qəbul edə bilərlər.

Beləliklə, tərəfdaşlar arasındakı münasibətlərdə məsuliyyət hissindən qaynaqlanan emosional münasibətlərin səmimiyyəti və kortəbiiyi ilə onların sabitliyi arasında daxili ziddiyyət qalır. Məsuliyyət hissi evlilik həyatı üçün təhlükəli olan mənfi emosiyaların yatırılmasını tələb edir, səmimiyyət isə normal ailə atmosferini qorumaq üçün vacibdir.

// "SAKİT" VƏ "FİRTINLI" EVLİ CÜTLÜKLƏR

Bu iki xüsusiyyəti - məsuliyyət və səmimiyyəti nəzərə alaraq, evli cütlüklərin iki ifrat növünü ayırd edə bilərik: sabit və qeyri-sabit və ya gərgin. Birinci halda, hər şey səthi olaraq sakitcə davam edir, lakin tərəfdaşlar tez-tez psixosomatik xəstəliklərdən və ya nevrozlardan əziyyət çəkirlər ki, bunun mahiyyəti çox uzunmüddətli və çox güclü şəkildə yatırılan mənfi emosiyalardadır. İkinci halda, tərəfdaşlar ayrılır və barışır, mübahisə edir və bir-birini öldürməyə hazırdırlar, lakin tezliklə bir-birini ömürlərinin sonuna qədər fədakarcasına və səmimi şəkildə sevirlər.

Bu modellərdən hər hansı birinin nevrotik olub-olmadığını demək çətindir. Mənfi emosiyaların yatırılması sağlamlığa mənfi təsir göstərir və onları ifadə etmək də sağlamlıq tədbiri hesab edilmir. Tez-tez tövsiyə edilənin, yəni "qəzəbi boşaltmağın" əksinə olaraq, bu,

həmişə rahatlıq gətirmir və ya yalnız müvəqqətidir. Qəzəb qəzəb doğurur.

Daha sonra qəzəbini tökən şəxs hərəkətlərindən utanır, özünü günahkar hiss edir və özü üçün gülünc bir vəziyyət yaratmaq ehtimalından qorxur.

cəmiyyət, yəni belə bir vəziyyətdə mənfi emosiyalar ortaya çıxır. Bu emosiyalar qəzəbin azalmasına deyil, artmasına səbəb olur. Üstəlik, hər bir təcavüz dalğası insanın məhv olmaq üçün yatmış arzusunu hərəkətə gətirir və bu hiss heç vaxt doymaq bilmir. İnsan buna əməl etməyə başladıqdan sonra onu cilovlamaq çətindir; o, uçuq kimi böyüyür. Dağıdıcı meyllərin həyatın qorunması ilə məhdudlaşdığı (aclığı yatırmaq və ya həyatı qorumaq üçün öldürdükləri) heyvanlar aləmindən fərqli olaraq, insanlarda bu meyl sonsuzdur. İnsanlar yaradılış naminə yaratdıqları kimi, məhv etmək naminə də məhv edirlər və hər iki halda da, Frommun dediyi kimi, ölümsüzlük ehtiyaclarını ödəyə bilirlər.

// MASKA PROBLEMİ

Evliliyi qorumaqla bağlı səy əsasən spontan reaksiyaların məsuliyyət hissi ilə əlaqələndirilməsindən asılıdır. Bu, maska problemidir.

İctimai həyatda maska taxmaq vacibdir. Bütün erotik münasibətlərdə olduğu kimi, bu qədər yaxın və kiçik ailə dairəsində də maska çıxarılmalıdır, çünki bu münasibətdə insan ətraf aləmlə tam anlaşma və birləşmə axtarır. İnsan maska taxır

çox gənc yaşlarından və yalnız özünü ayırmaq, başqalarının onların təcrübə dünyasını anlamasının qarşısını almaq üçün, heç kimin onların nə hiss etdiyini və düşündüyünü bilməməsi üçün.

Bu, hər kəsin tabe olmalı olduğu ictimai həyat normaları tərəfindən tələb olunur.

Lakin maska taxmaq yorucudur və erotik münasibətdə olan insan özü olmaq, həqiqətən olduğu kimi qəbul edilmək, onu başqalarından təcrid edən bu təbəqəni atmaq istəyir. Əgər tərəfdaş əldə etmə mərhələsində oynaq meyllər güclənirsə, bu zaman insan ən yaxşı işıqda görünməyə, kənardan müşahidə edən tərəfdaşın diqqətini cəlb etməyə çalışırsa - bu proses heyvanlar aləmində də baş verir - onda cütləşmənin həlledici anı çatanda bu meyllər aktuallığını itirir, məqsədə çatılır və sonra əks göstərişlər üstünlük təşkil edir - maskanı atmaq, özünü çılpaq göstərmək. Bu cür tez-tez baş verən məyusluqların mənbəyi budur; Toydan əvvəl partnyor fərqli idi. Buna görə də bir vaxtlar toydan əvvəl bəyin sərxoş olması adəti var idi ki, "ayıq kişinin ağlında olan sərxoş kişinin dilindədir" və onun əsl simaları üzə çıxsın ("in vino veritas").

Ev həmişə gün ərzində yığılan bütün şikayətləri boşaltmaq üçün bir yer kimi xidmət edir,

sanki özünü qaynayan hər şeydən təmizləmək üçündür ki, bunu başqa yerdə etmək mümkün deyil. Bu, tez-tez uşaqlar və böyüklərlə baş verir.

Ev atmosferi əsasən evin azadlığından,

heç nəyi bəzəmədən və ya aid etmədən olmaq istədiyiniz kimi olmaq imkanından asılıdır. Əks halda, atmosfer süni və

qeyri-səmimi olur. Digər tərəfdən, tək bir söz, jest və ya baxışın evlilik kimi yaxın münasibətdə olan birini incidə biləcəyi və bu yaraların yavaş-yavaş sağaldığı məlumdur.

Evlilikdə partnyorla tez-tez məyusluq və nəticədə yeni bir sevgi obyektini axtarmaq istəyi, kortəbii reaksiyaları məsuliyyət hissi ilə uzlaşdırmaq üçün çox zəruri olan əlavə səylərin tərki edilməsinə səbəb olur. Bu hisslər dəyişkəndir və iki qütb arasında dəyişir; gücləndirilməsə, yox olur.

// SONA QƏDƏR ÖYRƏNİN!

Müsbət hisslərin üstünlük təşkil etməsini və müəyyən bir sabitliyi qorumaq

Emosional əlaqəni anlamaq üçün xüsusi tədqiqatlar lazımdır; emosiyaların obyektini tam başa düşülə bilməz. Eynilə, estetik təcrübənin obyektini daim yeni təəssüratların mənbəyi olmalıdır. Rəsm, heykəl, sevimli kitab bizi onlara cəlb edir; biz tez-tez onlara qayıdırıq, onlarda yeni və naməlum bir şey kəşf edirik.

Üstəlik, insan daim yeni, bəzən gözlənilməz kəşflərin mənbəyinə çevrildiyi üçün tanınmazdır.

Psixiatriyada, gündəlik vəziyyətlərdə yeni və naməlum bir şeyi araşdırmadan əvvəl özümüzü sabit, sxematik bir obrazla müdafiə etdiyimiz kimi, onu müxtəlif etiketlərlə etiketləməklə özümüzü insanın tanınmazlığından qoruyuruq. Bu obraz,

təxəyyülümüzün yaradıcılığı olmaqla, hərəkətsiz və sərt və nəticədə axan və dəyişən reallığa uyğun gəlir. Erotik yaxınlığın ilkin mərhələsində bu qədər cəlbedici və həyəcanverici olan sirrini cazibəsi hazır "o (o) məhz belədir!" düsturu ilə əvəz olunur; Digər insanı tamamilə izah edən, lakin əslində danışanın öz emosional vəziyyətini əks etdirən bir düstur.

Sirr insanı cəlb edir, lakin uzun müddət ərzində dözülməz hala gəlir və ya qorxu yaradır; insan aydın bir məkanda hərəkət etməli, tapdalanmış yollarla getməlidir, əks halda özünü çarəsiz və itirilmiş hiss edir və buna görə də bilmədikləri hər şey öz təxəyyülünün hazır düsturları ilə doludur. Bu, hər bir insanda mövcud olan və onu sirri açmaq qorxusundan qoruyan bir dəli əhval-ruhiyyədən başqa bir şey deyil.

İnsanlar arasında daim yaşayan bir insan, hətta tamamilə tanımadığı insanları belə müəyyən edən hazır düsturlarla hərəkət etməlidir, çünki bütün bunlar onların ətraf aləmdə hərəkət azadlığını asanlaşdırır. Lakin, ailə kimi sıx təmasda və xüsusən də erotik yaxınlıqda, qurulmuş nümunələr belə yaxın, qarşılıqlı yaxınlıqda yaranan hisslərin təzyiqinə tab gətirə bilmir. Nümunələrin kaleydoskopu ortaya çıxır; bəzən biri digərinin "mələk", bəzən "şeytan" maskası taxdığını görür və bu emosional "yelləncəklərdən" qaçaraq partnyorundan uzaqlaşır və maskanın yerində qalmasına imkan verir. Lakin bu vəziyyət darıxma hissi, artıq onu maraqlandırmayan bir insanla əlaqələri kəsmək ehtiyacını oyadır.

// EVLİLİKDƏ "LİQƏSİZLİK"

Sevgi darıxmanın əksidir və darıxma müəyyən bir cəmiyyətdən qaçmağa çalışdığımız, amma bacarmadığımız zaman ortaya çıxır. Darıxma əzab verir; qaçmaq istəyirik və bütün enerjimiz bu istəyi yerinə yetirməyə yönəldilir, amma bu kifayət deyil və hər şey əvvəlki kimi qalır. İnsan heç vaxt sevdiyi insandan darıxmır | İnsan, çünki sevgi cəlb edir, darıxma isə dəf edir. Darıxma hissi insanın başqalarına qarşı emosional münasibətinin həssas bir göstəricisidir.

Ən çox evliliyin ilk illərindən sonra, bəzən isə bir neçə aydan sonra tez-tez "laqeydlik" kimi təyin olunan evlilik böhranı, darıxmanın münasibətlərdə əsas amilə çevrildiyi bir vəziyyəti təmsil edir. Emosional vəziyyət, xüsusən də qadınlarda cinsi həyata da təsir göstərir, çünki kişilərdə emosiyalar və seks arasında güclü bir ayrılıq olur; həddindən artıq hallarda kişi sevdiyi qadınla cinsi əlaqəni davam etdirə bilmir (Freydin Madonna-fahişə kompleksi). Darıxma da cinsi münasibətlərə hopur.

Cinsi həyatı daha cəlbedici etmək üçün edilən heç bir cəhd ekzemaya səbəb ola bilməz, çünki onlar texniki xarakter daşıyır, şüurlu şəkildə manipulyativdir və cinsi əlaqədir.

Spontanlıq həyatın ən vacib aspektidir. Nevrotik bir dairə yaranır. Cinsi disfunksiya (adətən qadınlarda anorgazm və kişilərdə potensialın azalması şəklində) emosional əlaqələrə mənfi təsir göstərir və mənfi hisslər də öz növbəsində cinsi həyata təsir göstərir.

Nevrozlar üçün cütlüklərin psixoterapiyasında qiymətləndirmənin vacib bir aspekti, tərəfdaşların mənfi emosiyaların ifadəsini qiymətləndirməklə yanaşı, kömək axtaranları psixiatrik baxımdan araşdırmaqdır, yəni problemləri və münaqişələri, həyat çətinliklərini və s. qiymətləndirməkdir. Digər insanı anlamaq mühakimə qiymətləndirməsinin gərginliyini azaldır; deyimdə deyildiyi kimi, "tot comprendre c'est tout affiner". Lakin mühakimə münasibəti digər insana qarşı mənfi hissləri gücləndirir. Evlilikdə qorxulu olan yaxın təmasda qaçılmaz olan və cinsi yaxınlıqdan qətl ovuna qədər dəyişən keçici təhdidlər deyil, əksinə, yavaş-yavaş artan spesifik mənfi hisslər - nifrət, nifrət, ikrah, qorxu və s.-dir.

Sonra insan və onun əsl şəxsiyyəti artıq görünmür, yalnız mühakiməedici, təhrif olunmuş qiymətləndirmədən toxunmuş yaradılmış və gücləndirilmiş bir obrazdır.

// HAKİMİYYƏT UĞRUNDA MÜBARİZƏ

Qrupun ölçüsü mübahisəli bir məsələdir və iki nəfərin, yoxsa üç nəfərin ("tres faciunt collegium" qaydasına görə) bir qrup hesab edilə biləcəyi bəlli deyil. Lakin, iki nəfər arasındakı münasibətdə güc məsələsi ortaya çıxır ki, bildiyimiz kimi, ordu kimi təcrübəli bir təşkilatda sadəcə bir əsgərin komandir olması ilə həll olunur.

Evlilikdə problem olduqca kəskin şəkildə ortaya çıxır və laqeyd hər haqqında məşhur zarafatlarda ifadə olunur. Kişi tez-tez bu rolu oynayır. Görünür, bu zarafat evlilik patologiyasında olduqca əhəmiyyətli bir məqama toxunur.

Emosional cəhətdən narahat olan bir qadın gücünü tətbiq etməklə məmnunluq tapır.

Qadının sevgiyə olan ehtiyacı kişidən xeyli güclüdür ki, bu da onun ana kimi bioloji rolu ilə bağlıdır. Buna görə də, sevgidən məhrum olan qadın daha asanlıqla körpə despotizminə düşür və tam qadın ola bilməyən kimi yenidən kiçik bir uşaq olur. Qadının xoşbəxt olması və inkişafda geriləməməsi üçün o, sevməlidir. Sabit bir evlilik üçün qadının kişidən daha emosional cəhətdən uyğun olması daha yaxşıdır. Birlikdə həyat müəyyən davranış nümunələrinin, ortaq maraqların, birləşdirici məqsədlərin, uyğunlaşmanın və evdən gətirilən adət və vərdişlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir (buna görə də sözdə qəbilə münaqişələri). Bu proses münaqişəsiz keçmir və qarşılıqlı "uyğunlaşma" bəzən illərlə davam edir. Adətən, bir tərəf qalib gəlir, digəri isə təslim olur. Çox vaxt qadın döyüşdə qalib gəlir; yuva qurmaq onun bioloji hüququdur və əgər o, belə bir maraq göstərmirsə, onda onun davranışı onun qadınlıqdan uzaq olduğunu və kişi istiqamətində gender kimliyində pozuntu olduğunu göstərir. Əgər bu dominantlıq çox qabarıq formalar alırsa və bir məqsəd üçün ("oğlan" tipli bir qadın) bir məqsədə çevrilirsə, onda onun partnyoruna qarşı hisslərinin zəif və ya sadəcə mənfi olduğundan şübhələnmək olar.

// EROTİK MÜNASİBƏTLƏRİN ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFINA TƏSİRİ

Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı düşüncələrdə təsirlərə çox diqqət yetirilir.

Genealoji ailə və subyektin öz ailəsinin təsiri nadir hallarda qeyd olunur. İnsan inkişafındakı müəyyən bir həddi nəzərə alsaq, bu başa düşüləndir,

sonradan heç vaxt keçməzlər. Lakin bu fərziyyə kökündən səhvdir, çünki insan mayalanma anından ölümünə qədər inkişaf edir.

Gündəlik müşahidələr başqa bir insanla erotik münasibətdə olan bir insanın dəyişikliyi göstərir. Onlar sevginin təsiri altında çiçəklənir və sevginin olmaması halında solur və solur. Erotik təmasda insanın özünə hörməti artır; insan özünü partnyorunun gözü ilə görür ki, bu da səfərbəredici təsir göstərə bilər və bu perspektiv sayəsində insan özünə inanır. Lakin, bu münasibət əzab gətirdikdə, demobilizasiyaedici təsir göstərdikdə, insan gücünü itirir və heç nəyə inanmır.

Nikahdankənar münasibətlər axtarmağın vacib amillərindən biri də həyat yoldaşında tapıla bilməyən daha yaxşı bir qiymətləndirmə ehtiyacıdır. Kişilər tez-tez sərxoş cəmiyyətdə, xüsusi, sərxoş intellektlə parlaya və içki içən dostların isti atmosferində rahatlaya biləcəkləri xüsusi cəmiyyətlərdə, erkən dostluqdan bir az homoseksual çalar olmadan öz imiclərinin təsdiqini axtarırlar.

Ərləri tərəfindən tərk edilmiş qadınlar, uşaqlarına şişirdilmiş qayğı göstərməkdə və ya iş məsuliyyətlərinə həddindən artıq emosional münasibət göstərməkdə öz dəyərlərinin bərpasını və əvəzini axtarırlar (buna görə də ən çox yayılmış şişirdilmiş qayğıkeş analar, həddindən artıq qoruyucu kimi müəyyən edilir və iş yerində evlərini təşkil edən, heç bir xüsusi ehtiyac olmadan yorulmadan işləyən və emosiyalarını boşalda bilməməkdən və güc əldə edə bilməməkdən əziyyət çəkən qadın işçilər).

// ŞƏXSİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN QÜTBÜLƏŞMƏSİ

Birlikdə yaşamaq qarşılıqlı güzəştlər tələb edir və qarşılıqlı anlaşma ya uyğun, ya da əks xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Ailə harmoniyası üçün ən yaxşı uyğunluq daha dərin şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən daha səthi deyil, daha səthi arasındadır. Tərəfdaşlar müəyyən bir müddət ərzində sosial davranış formalarına, tanışlıq dairələrinə, estetik, dini və siyasi baxışlarına, maliyyə əməliyyatları metodlarına və uşaq böyütmələrinə uyğunlaşırlar. Digər tərəfdən, dominantlıq və itaətkarlıq, ekstrovertlik və introvertlik, hissləri vermək və qəbul etmək ehtiyacı, egoizm və altruizm və s. kimi xüsusiyyətlər və nəticədə şəxsiyyət quruluşu ilə əlaqəli xüsusiyyətlər əks istiqamətlərdə inkişaf edir.

Əgər müxtəlif dərəcələrdə ifadə olunan müəyyən bir cüt əks xüsusiyyətə malik iki insan bir araya gələrsə, birlikdə yaşamaq nəticəsində onlardan biri daha güclü bir xüsusiyyət, digəri isə daha yüngül bir xüsusiyyətə sahib olacaq. Məsələn, belə bir xüsusiyyət dominantlıq və itaətkarlıqdırsa, daha az dominant meyllərə malik tərəfdaş güclü dominant xüsusiyyətlərə malik bir tərəfdaşla daimi təmas nəticəsində evlilikdən əvvəlkindən daha itaətkar olacaq.

Eyni şəxs daha zəif bir tərəfdaşla görüşəndə daha güclü dominant xüsusiyyətlər nümayiş etdirə bilər.

Beləliklə, tərəfdaşların şəxsiyyətləri bir-birini tamamlamağa çalışır. Oxşar vəziyyət bəzən eyni əkilərdə də baş verir. Artıq qeyd edildiyi kimi, onların müəyyən xüsusiyyətləri, eyni genetik quruluşlarına baxmayaraq, fərqli şəkildə inkişaf edir.

Əks istiqamətlər, məsələn, biri cəsarətli, digəri qorxaq, biri rəhbərlik edir, digəri dinləyir, biri verir, digəri götürür və s., sonra isə aralarında bir icma yaranır və birmənalı xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasını istisna edir. Genetik plan, görünür, iki əks istiqamətdən birinin inkişafına imkan verir.

Beləliklə, onların inkişafı müəyyən bir qütbləşmədən ibarət olardı, halbuki planda hər iki istiqamət potensial olaraq təmsil olunur.

Qrupun fəaliyyəti baxımından, ikinci dərəcəli xüsusiyyətlərin ardıcılığı və

ilkin xüsusiyyətlərin qarşılıqlı təsiri, görünür, faydalıdır. İkinci dərəcəli xüsusiyyətlər

tərəfdaşların davranış nümunələri və birgə planları ilə əlaqəlidir. Onların razılığı

evli cütlüyün bir qrup kimi fəaliyyət göstərməsini asanlaşdırır. Dərin xüsusiyyətlər

tərəfdaşlar arasındakı emosional münasibətlərin qarşılıqlı strukturunu müəyyən edir; onların fikir ayrılığı

qrupun emosional kompaktlığını artırır. Bir usta üçün tabeliyində olan biri ilə yaşamaq, hər biri onu verə bilən biri ilə sevgi arzulayan iki ustadan daha asandır və s. Nevrotik münaqişələr ikinci dərəcəli xüsusiyyətlər arasında uyğunsuzluq və ya tərəfdaşlar arasında daha dərin olanlar arasında koordinasiyanın olmaması zamanı yaranır.

İkinci növ münaqişə daha təhlükəlidir, baxmayaraq ki, onlar tez-tez birlikdə baş verir.

// MÜNAQİŞƏLƏR

Ailə münaqişələri həyatın digər aspektlərinə də təsir göstərir. Evdən gələn pis əhval-ruhiyyə işə və dostların dairəsinə keçir. Müasir insanlar gün ərzində bir neçə sosial rol oynasalar da, depressiyalı əhval-ruhiyyələrini tez bir zamanda dəyişə bilmirlər. Onlar bunu gizlətməkdə daha yaxşı və ya pis ola bilərlər.

Əlbəttə ki, iş münaqişələri ev atmosferinə təsir etdikdə bunun əksi də baş verə bilər. Ailə qrupu daxilindəki münaqişələr adətən tez-tez və güclü emosional sarsıntılara səbəb olur ki, bu da bu qrupun təbiətindən irəli gəlir, burada iki insan arasındakı yaxınlıq digər şəxslərarası münasibətlərdə misilsiz olaraq ən yüksək səviyyədədir.

Məhz bu yaxınlıq səbəbindən cinsi partnyorlar arasında münaqişələr qaçılmazdır.

Ailə həyatının patologiyası bu münaqişələrdən deyil, mənfi emosional vəziyyətlərin nə dərəcədə kök salmasından asılıdır. Sevgi və nifrətin güclü hisslər zamanı ən çox özünü göstərməsi nevroitik xüsusiyyət deyil; Bu, sadəcə normal bir emosional dinamikaadır. Lakin, nifrət, ikrah, xor və ya digər mənfi hisslər kök saldıqda, onlar daimi narahatlıq və daxili gərginlik mənbəyinə çevrilir. Bəzən həyat yoldaşlarında nevrozlar üçün psixoterapiya yolu ilə əldə edilə bilən partnyora fərqli bir baxış bu kök salmış emosional vəziyyəti sarsıda bilər.

Son illərdə ailə nevrozlarına və ailə psixopatologiyasına çox diqqət yetirilir. Nevrozların, eləcə də alkoqolizmin, psixosomatik xəstəliklərin və daha az rast gəlinən psixozların bir çox halında münaqişənin mərkəzi nöqtəsi partnyorla cinsi əlaqə məsələsidir. Çox vaxt məlum olur ki, müalicəyə ehtiyacı olan digər partnyordur, həkimə müraciət edən deyil. Eynilə, uşaq psixiatriyasında qayğı və psixiatrik müalicəyə ehtiyacı olan həmişə nevroitik pozğunluqlar və ya davranış çətinlikləri göstərən uşaq deyil, valideynləridir. Çox vaxt psixiatrik müraciət edən ailənin ən zəif üzvüdür, digərlərinə ən güclü nevroitik təsir göstərən şəxs deyil.

iş

// İŞƏ DUYĞU MÜNASİBƏTİN İKİ MODELİ

İşə qarşı emosional münasibətə iki baxımdan baxmaq olar. Biri Müqəddəs Kitabda, işin günaha görə cəza kimi qəbul edildiyi yerdə tapılır: "Alnınızın təri ilə çörəyinizi qazanacaqsınız" (Yaradılış 3:19). İkincisi etnoqraflar tərəfindən təsvir olunur: Polineziya adalarında iş zamanı dünyanın yaradılışını təsvir edən mahnılar oxunurdu; iş Yaradanın hərəkətinə daxil idi.

İşin bu ikili aspekti - müəyyən həyat məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi iş: yemək əldə etmək, istirahət təşkil etmək, sosial status və s. və işin özü - insanlara xas olan yaradıcı qabiliyyətləri ifadə etmək - hər bir iş növü üçün xarakterikdir; yalnız hər iki aspektin nisbətləri dəyişə bilər.

Küçə süpürgəsi də özünü yaradıcı işçi kimi hiss edir, çünki o, öz planına uyğun olaraq mühitin bir hissəsini yenidən formalaşdırır və buna görə də onu "öz imicində" dəyişdirir, bu da transformasiya üçün istifadə olunan materialdan asılı olmayaraq, hər bir yaradıcılıq aktı üçün vacibdir - süpürülən küçə, heykəltəraşın əlindəki mərmər, rəssamın kətan, sözlərlə doldurulacaq boş kağız vərəqi və ya təhsil almalı, müalicə almalı olan digər insanlar və s. Tanınmış yaradıcı işçi də heç vaxt pul, şöhrət, işinin daha böyük sosial əhəmiyyəti, qadınlarla uğur və sair kimi fikirlərdən əl çəkmir.

// ƏMƏK YARADICILIQ AKTİVİ KİMİ

Əməyin iki aspektinin - yaşayış vasitələri, yaradıcılıq aktının - özünəməxsus nevroitik potensialı var. Yaradıcılıq aktı ətraf mühitin yaradıcı şəkildə yenidən formalaşdırılması lazım olan hissəsindən daimi müqavimətlə qarşılaşır. Müqavimət ətrafdakı dünyanın spesifik xüsusiyyətlərinə aiddir; Bu vacib xüsusiyyət olmadan dünya real dünya olmaqdan çıxar, öz düşüncələrinin, istəklərinin və xəyallarının dünyasına çevrilərdi. Müqavimətin bu elementi polyak dilindəki "przedmiot" (obyekt) (kiminsə qarşısına atmaq) sözündə, eləcə də latınca "obyekt" (ob - qarşısında, əleyhinə və dasege - atmaq, atmaq) sözündə daha çox görünür. Reallıqda tüstülənən müqavimət, aktiv dəyişiklik aktı baş verdikdə xeyli artır. Bu müqavimət dəyişmiş obyektə qarşı ikili hisslər oyadır. Onu dəf etmək özünə, öz ətalətinə, rahatlığına, tənbəlliyinə və s., eləcə də say sayəsində getdikcə yaradıcı plana yaxınlaşan və bununla da yaradıcının bir hissəsinə çevrilən obyekt üzərində qələbə hissi yaradır. Obyektdən subyektə keçən ətraf aləm elastik, yaradıcının iradəsinə uyğunlaşır.

Özünə və ətraf aləmin bir hissəsinə qalib gəlmək hissəsinə əlavə olaraq, öz nizamını xaos kimi görünən bir şeyə, formasız bir kütləyə daxil etməkdən qaynaqlanan məmnunluq hissi də gəlir.

Öz nizamı ilə harmoniya təşkil edən nizam həmişə məmnunluq hissi yaradır. Nizamlı harmoniya təşkil etməyən hər şey isə mənfi narahatlıq,

qorxu, təcavüz və nizam hissləri yaradır.

Emal, formasız, bərk kütlə hesab olunur. Heykəltəraşlıq üçün nəzərdə tutulmuş mərmər blok öz daxili nizamına, özünəməxsus gözəlliyinə malikdir. İnsanın öz nizamı müsbət işarə ilə, xarici nizam isə çox vaxt mənfi işarə ilə qəbul edilir. Ətraf mühitdə öz nizamını qurmaq meyində canlı təbiətin mənfi entropiya kimi müəyyən edilən xarakterik xüsusiyyətlərini tapmaq olar. Hər bir canlı orqanizmin özünəməxsus nizamı (mənfi entropiya) var və ətraf mühitlə daimi enerji və informasiya mübadiləsi yolu ilə onu öz nizamına çevirir. Bu mənada, hər bir canlı orqanizm üçün ətraf aləmin nizamı özündən daha pisdır, çünki o, məhv edilməli və öz nizamı ilə əvəz olunmalıdır. Bu anlayışda həyat həm də öz nizamını qurmaq üçün davamlı mübarizəni təmsil edir. // YARADICI İŞİN TRANSCENDENTAL XÜSUSİYYƏTİ

Bitki və heyvan aləmində müəyyən bir orqanizm üçün spesifik nizam bioloji sərhədlərdən kənara çıxmır, yəni həyatın özü və onun iki əsas qanununa - öz həyatının və növün həyatının qorunmasına riayət etmək. İnsan cəmiyyətində nizam özlüyündə bir məqsədə çevrilir. İnsanlar öz həyatının və növün həyatının qorunması qanunları ilə məhdudlaşmırlar. Onlar nizamlarını ətraf mühitə köçürmək, iz buraxmaq, tamamilə ölmək istəyirlər ("Xeyr, mən tamamilə ölməyəcəyəm!").

Bu ölümsüzlüyə can atmaq, bitki və heyvan aləmindən fərqli olaraq, insanlarda informasiya mübadiləsinin hipertrofiyaya məruz qalması, enerji mübadiləsinə tamamilə tabe olmağı dayandırması və öz müstəqilliyini qazanması faktından irəli gələ bilər ki, söz və ya fikir şəklində bir signal guya həyat qanunlarının əsarətindən azad olur və beləliklə, spesifik bir ölümsüzlüyə nail olur. Bu signalar

insan mədəniyyətini yaradır. Onu yaradan insanlardan əsər-əlamət qalmayıb, onlar yaşamağa davam edirlər. İnsanın mənfi entropiyası əsasən heyvan və bitki aləmində baş verdiyi kimi, xarici mühitlə enerjili deyil, informasiya mübadiləsində olur.

İşə qoyulan hər bir səy mədəniyyət yaradan bu universal və xüsusən də ölməz məlumat toplusuna töhfə verir.

Bitki və heyvan aləmindən fərqli olaraq, insanlar təkcə bioloji deyil, həm də mədəni irsiyyətə tabedirlər. Növlərin qorunması qanununa tabe olmaqla,

hər bir canlı orqanizm müəyyən dərəcədə ölümdən azad olur, çünki

həyat növbəti nəsə ötürülür — genetik plan öz yolu ilə ölməkdir.

Mədəni irsə tabe olmaqla və ona töhfə verməklə, insanlar, sanki, ölümsüzlüklərini ikili şəkildə — genetik substansiyaları və

yaratdıqları mədəniyyətin ölməzliyi vasitəsilə təmin edirlər. Lakin bioloji (genetik) və yaradıcı ölməzlik arasında fundamental fərq var. Birincisi şüursuzdur, biz ona tabeyik və onu idarə etmək mümkün deyil, ikincisi isə tamamilə şüurlu səy tələb edir.

Buna görə də, insan dəfələrlə əməyin çətinliklərindən şikayət etsə də, onsuz keçinə bilməz. Məhz əmək vasitəsilə o, öz transsendental meyllərini dərk edir. Yarada bilməyərək məhv etməyə başlayır.

// ƏMƏYİN MƏNASIZLIĞI HİSSİ

Dağıdıcı meyllər əmək təmin edə bilmədikdə özünü göstərir.

gözlənilən nəticələr və emal olunan materialın müqaviməti çox böyük olduqda. Lakin, işin öz planına uyğun olaraq yerinə yetirilməsi nadir haldır; daha çox vaxt başqaları tərəfindən formalaşdırılır. Verilmiş bir tapşırıq yerinə yetirilməlidir, insanın etmək istədiyi şey deyil. "Planın ağası" kim olursa olsun - kölələrin, pulun və ya istehsal sisteminin sahibi - əgər onu yerinə yetirən şəxs bu planı özününkü kimi qəbul etmirsə, bu, həmişə onlarda aqressivlik oyadır.

İstəyə zidd olaraq, mənasızlığı hissi ilə görülən iş həmişə darıxdırıcı və çətinidir, çünki hər bir vəzifəni yerinə yetirmək üçün tələb olunan fiziki səylə yanaşı, aqressiv əhval-ruhiyyə ilə əlaqəli bədənin səfərbərliyi də gəlir. Sevdidiyi iş əzab vermir və hətta "sağlam" yorğunluq başlasa belə, sonradan qalan istirahət xoşdur, çünki görülən işdən məmnunluqla müşayiət olunur. Digər tərəfdən, yorğunluq mənfi emosional vəziyyətlə əlaqəli vegetativ və endokrin sistemlərin səfərbərliyindən qaynaqlandıqda, istirahət uydurmaz. İş bitsə də, bədənin mübarizə və ya qaçış üçün səfərbərliyi davam edir, hətta artır və bu cür istirahət zamanı mənfi hisslər daha da "çeynəyir".

Sonra insan dincələ bilmir, daimi gərginlik və yorğunluq hiss edir, daimi tələş içində yaşayır və hazırkı həyatı xoşagəlməz olur. Onlar bu yükdən

azad olmaq və daha yaxşı vaxtları gözləmək, yaşamaq yox, yalnız yaşamaq niyyətində olmaq istəyirlər.

Bəzən işdən inanılmaz dərəcədə yorğunluq hissi ilə ayrılaraq, ötən günü qiymətləndirirlər: nəyə nail olunub? Məlum olur ki, çox az şey əldə edilib; iş vaxtı xoşagəlməz söhbətlərə, darıxdırıcı görüşlərə və müxtəlif "heç nə etməməyə" sərf olunub. Həqiqi, sevincli işlə dolu bir iş günü dərin məmnuniyyət hissi verir və yorğunluq bizi narahat etmir.

Boş vaxtdan qaynaqlanan yorğunluq, məqsədsiz fəaliyyətə və xaosa müqavimət göstərən, mənfi emosiyaları oyandıran və avtonom sinir sisteminin əlaqəli səfərbərliyinə səbəb olan içimizdəki dərin kök salmış nizam hissinin pozulmasından irəli gəlir. Bu cür fəaliyyət həyatın fundamental meylinə, yəni mənfi entropiyaya ziddir və həyatın fundamental qanunlarının pozulması adətən bədəndə kəskin mənfi reaksiya doğurur.

İşə qoyulan məna, məqsəd və səyin effektivliyi hissi işə müsbət münasibət üçün vacibdir. İşlə ifadə olunan bədənin fəaliyyəti,

daha yüksək fəaliyyət nizamına aiddir, çünki ətraf aləmə öz nizamı

təqdim edildiyi yerdədir. Buna görə də, işdə məna və məqsəd hissi onun vacib elementlərindən biridir. Əgər insanın etdiyi hər şey mənasızdırsa, onda insan özünü mənasız itirir.

İşdə mənasızlıq hissi, məsələn, təyin olunmuş iş insanın daxili maraqlarına cavab vermədikdə belə, başlamazdan əvvəl yarana bilər. Belə hallarda, qalan yeganə seçim görülən işə görə mükafat almaq imkanındır. Bu, "müqəddəs kitab" işinin modelidir və həqiqətən də insanın alnının təri ilə yerinə yetirilir, daxili müqaviməti oyandırır. İşə və onun icrasını tələb edən insanlara qarşı mənfi emosional vəziyyət, bədənin döyüş və ya qaçış üçün səfərbər olması nəticəsində yaranan yorğunluğu tamamlayır. Mənasız işin başqa bir nümunəsi, yalnız peşə naminə görülən lazımsız iş ola bilər.

boş vaxt, yaxud sadəcə darıxma və ya əsəb gərginliyi; istənilən fəaliyyət rahatlıq gətirir və daxili səfərbərlik vəziyyətini yüngülləşdirir.

Oyun zamanı müxtəlif hərəkətlər də yerinə yetirilir, lakin nəticələrin olmaması əvvəlcədən məlum olur və məqsəd və məna hissi proses boyunca qalır.

Bu hallarda ətraf mühit müqaviməti "ciddi" fəaliyyətlərə nisbətən xeyli azdır və buna görə də planınızı həyata keçirmək daha asandır. Çimərlikdə qum qalası tikmək realdan daha asandır. Öz planınızı həyata keçirməyin və oyunda ətraf mühit müqavimətini dəf etməyin asanlıığı özünəinamını artırır. Oyun uşağı real işə hazırlayır və böyüklər üçün bu, hazırda populyar istirahət formalarından birinə çevrilir.

Hobbinin cəlbediciliyi ilk növbədə insanın öz vəziyyətinin ağası olmasındadır. Onlar sevdiklərini edirlər və bu, onlara nəinki əzab vermir, həm də özlərinə baxmayaraq gördükləri işdən fərqli olaraq istirahət və məmnunluq gətirir. Sərf edilən səy yalnız müəyyən bir işə, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən, hətta başqaları tərəfindən mənasız hesab edilən bir işə həsr olunsa da, müəyyən bir məqsədə çatmaq həyəcanverici və maraqlıdır. Məsələn, kibrit qutusu kolleksiyaçısı kolleksiyasının mənasızlığını anlayır, lakin kolleksiyasına nadir bir kibrit qutusu əlavə etmək bəzən ona təsvirolunmaz bir sevinc gətirir.

Proses zamanı və tamamlandıqdan sonra onun zəruriliyi ilə bağlı şübhələr tez-tez yaranır.

Çox vaxt icrası əvvəlcə planlaşdırılardan daha az uğurlu olur; iş zamanı aşılın müxtəlif maneələr çox əhəmiyyətli ola bilər və ətrafınızdakılar işi mənfi qiymətləndirirlər. Bütün bunlar bu işə sərf olunan səyin mənasını qiymətləndirmələrinə mənfi təsir göstərir. Tamamlanmış işə qarşı mənfi emosiyalar yaranır və onu məhv etmək və ya tərək etmək istəyi tez-tez hiss olunur. Buna görə də, asanlıqla əldə edilən iş yorucu deyil, "sadəcə alınmayan" çətin iş isə ağırlı yorğunluq hissi yaradır. Müəyyən bir məqsədə can atan insan gördüyü iş haqqında mənfi emosiyaları dəf etməlidir, əks halda onu daim dayandıracaq və nəticədə onu tamamlaya bilməyəcək. Özünə bu mübarizə, işin insana tətbiq etdiyi ən böyük iradə səyi ola bilər və eyni zamanda, onun xarakteri üçün bir məktəb rolunu oynaya bilər.

// PLAN VƏ REALLIQ ARASINDAKI MÜNAQİŞƏ

Yaradıcı işin nevroitik anları plan və reallıq arasında ziddiyyət təşkil edir. Reallıq tamamilə fərqli tapşırıqların həyata keçirilməsini tələb etdikdə, öz planınız dərhal atıla bilər və sonra ya başqasının planını qəbul edib sonda onu özününkü hesab etməli, ya da daim bu plana qarşı çıxmalı və zərurətdən öz iradəsinə zidd işləməli olursunuz.

Reallığı yenidən formalaşdırmaq üçün öz planınız qeyri-real ola bilər,

onda onu dəyişdirməli və mühitinizin real şərtlərinə və

öz imkanlarınıza uyğunlaşmalı olacaqsınız. Bu, reallığa müqavimətdən qaynaqlanan bir münaqişədir. Bu münaqişə reallığa təslim olmaq və uyğunlaşmaq bacarığını tələb edir; bu, qalib gəlmək və məğlub olmaq

alternasiya etdiyi əsas obyektlə mübarizədir. Görülən işi ümumiləşdirərək, özünüzü ya qalib, ya da məğlub hiss edə bilərsiniz. Nəticə, bir qayda olaraq, heç vaxt tamamilə obyektiv olmur. Hər şey əsərin hansı əhval-ruhiyyədə izlənilməsindən asılıdır.

// SƏY VƏ MÜKAFAT

Əgər iş maddi təminat vasitəsi kimi qəbul edilirsə və ya başqa bir məqsəd (vəzifə, daha yaxşı sosial mövqe və s.) güdürsə, onda dominant ziddiyyətli sual mənim işimin necə qiymətləndiriləcəyi və bundan nə əldə edilə biləcəyidir. Əməyin qiymətləndirilməsinin bu aspektində ağırlıq mərkəzi son ana - əməyin "bəhrələrinin" qiymətləndirilməsinə keçir. Yaradıcı aspektdə bu ağırlıq mərkəzi işin ilkin mərhələsində və icrası zamanıdır.

İki aspekt bir-biri ilə əlaqəlidir; mükafat perspektivi olmadan ətraf mühiti dəyişdirmək səyi və əvvəlki səy olmadan mükafat öz mənasını itirəcəkdir. Səy və mükafat ardıcılığı canlı təbiətin fundamental strukturlarından birinə aiddir. Bu məsələni ümumiləşdirərək demək olar ki, öz həyatını və növün həyatını qorumaq daimi səy tələb edir və həyatın özü burada mükafatdır.

Bütün öyrənmə formaları mükafat və cəza sisteminə əsaslanır. Şərtsiz stimullar müsbət (mükafat) və mənfi (cəza) bölünür.

// ƏTRAF MÜHİTİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ

İşin hər iki aspektində ətraf mühit fərqli şəkildə qəbul edilir. Yaradıcı aspektdə ətraf mühit işimizdə emal üçün zəruri olan material kimi qəbul edilir. Bu material müqavimət göstərir və münaqişənin əsas mənbəyinə çevrilir. İstehlakçı aspektində ətraf mühitə işimizi qiymətləndirən və mükafatlandıran bir hakimin baxış bucağından baxılır. Bu halda münaqişənin mənbəyi bu qiymətləndirmə ilə əlaqəli narazılıq hissi və daha az hallarda işimizin gözləntilərimizi doğrultmadığına görə günahkarlıq hissi olacaq.

Hər iki aspekt ətraf mühitə fərqli münasibət oyadır. Yaradıcı aspektdə ətraf mühitlə mübarizə baş verir, bu zaman insanın öz planı dəyişdirilir,

ətraf mühit ilkin şərtləri qəbul etmədikdə və ya ətraf mühit məğlub olduqda və insanın nəzərdə tutulan planı yerinə yetirilə bildikdə. Bu hallarda ətraf mühitlə təmas intimdir, çünki planın həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühit onun niyyətlərinə tabe olur, işinin yaradıcısı isə ətraf mühitdən təsirlənir - o, yaradır və yaradılır.

İş başa çatdıqdan sonra bu qarşılıqlı təsir kəsilir; tamamlanmış əsər artıq yalnız müəllifə məxsus deyil, sanki yadlaşır və bir müddət sonra tənqidi şəkildə nəzərdən keçirilə bilər. Əsər ətraf aləmlə birləşməyin yollarından biri ilə bağlıdır, lakin cinsi və ya metabolik birləşmədən fərqlidir.

Ətraf aləmlə birləşmə və onun yenidən formalaşması, yaxud ətraf aləmin orqanizmə və onun transformasiyasına təsiri canlı təbiətin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Metabolik birləşmədə ətraf aləmdən maddələr - hava, su, qida - sorulur və orqanizmin spesifik quruluşuna çevrilir.

Cinsi birləşmədə tərəfdaşla müvəqqəti əlaqə yeni bir quruluşa malik olsa da, hər iki ana strukturun orijinal elementlərini özündə birləşdirən yeni bir orqanizmin yaranmasına səbəb olur. Ətraf mühitin bu transformasiyası "öz imicində" kortəbii olaraq, yəni canlı orqanizmin şüurlu səyi olmadan baş verir; səy orqanizmi ətraf mühitlə o qədər sıx təmasa gətirməyə yönəlib ki, bu transformasiya prosesi (qida, cinsi partnyor əldə etmək) başlaya bilər.

İş yerinə yetirərkən səy transformasiya prosesinin özünə yönəldilir;
ətraf mühitin dəyişdirilməsi planı konsepsiya şəklindədir və buna görə də
qeyri-sabit, qeyri-müəyyən və dəyişkən ola bilər, enerji
metabolizmi və cinsi çoxalmada isə bu plan dəqiq şəkildə yerinə yetirilir. Şüur
dəyişkən, qeyri-sabit və qeyri-müəyyən həyat
prosesləri ilə inteqrasiya olunur.

İnsanlarda signal sisteminin inkişafı ətraf mühitlə təmasın ağırlıq mərkəzinin iş keçməsinə gətirib çıxarır.
Bu sistem ən böyük əksini işdə tapır. Enerji metabolizması və çoxalma prosesi

daha sadə signal sistemi tərəfindən idarə olunur.

İnsanda ətraf mühitlə metabolik və cinsi birləşmə yoxdur.

Nevrotik narahatlıq insanın ətraf mühiti aktiv şəkildə dəyişdirmək imkanından məhrum olduğu və onun
hərəkətsizliyinin sadəcə məcbur edildiyi bir vəziyyətlə müşayiət olunur. Mənfi entropiya insanda şüurlu
səylə birləşdirilməlidir və işdə özünü göstərə bilər; bu, insanın şüurundan kənarda baş verən ətraf
mühitdə öz nizamını qurmağın daha ibtidai formaları ilə məhdudlaşa bilməz.

// "EX VACUO" NEVROZLARI

Şüurlu mənfi entropiyanın olmamasının nəticələrinin tipik bir nümunəsi, zahirən nevroitik faktorları
olmayan nevrozları əhatə edən "ex vacuo" nevrozlarıdır. Əksər hallarda bu tip nevrozdan əziyyət çəkən
insanlar həyatda yaxşı vəziyyətdə olurlar; həyatın çətinliklərini, problemlərini və ya münaqişələrini
yaşamırlar və

həyatda sanki asfalt yolda gəzirlər.

Lakin, asfalt yolda yürüş dağ yolundan daha əzablı olduğu kimi,

onlar da özlərini yorğun və halsız hiss edirlər. Yol öz monotonluğu ilə yorucudur; insan hər diqqətsiz
addımın təhlükə yarada biləcəyi, eyni zamanda yeni təəssüratlar gətirdiyi və yeni səylə tələb etdiyi dağ
yolu ilə eyni şəkildə ona qoşulmur.

Həyatın yaradıcı və şüurlu hərəkəti, mahiyyət etibarilə, bu daimi "yeni çətinliklərin aradan
qaldırılmasından" ibarətdir. Yuxarıda şüurlu səyin iştirakı olmadan baş verən əsas bioloji proseslərin
mənfi entropiyası kimi müəyyən edilmiş səyi aradan qaldırmaq qabiliyyətindən məhrum olan insanlar
boşluqla əhatə olunmuşdur; Ətraf mühitlə birləşmə səthi xarakter daşıyır, çünki onlar həyatda heç nəyi
dəyişmədən, rahat hərəkət edirlər. Bu tip nevrozlar səylə tələb edən vəziyyətlərdə, insanlar maraqlı bir
peşə, fəaliyyətləri üçün aydın bir məqsəd tapdıqda, öz həyatları və yaxınlarının həyatı təhlükədə olduqda
və ya maddi vəziyyətləri pisləşdikdə yox olur.

// "REJİSSOR" NEVROZU

Əksinə bir nümunə "rejissor" nevrozudur. Bunun səbəbi əksər hallarda ətraf mühitin direktor
mövqeyindən həddindən artıq tələsik transformasiyasıdır. Ətraf mühit həmişə mülayim və rahat olmur
və bütün səylər fəlakətli sonluğa gətirib çıxardıqda və ətraf mühiti öz impetuasıya ilə dəyişdirən şəxs
vəziyyəti düzgün qiymətləndirə və real şəraitə uyğunlaşa bilmədikdə, bütün bunlar daha da ağırlaşan
şəxsi aşağılıq vəziyyətinə gətirib çıxarır.

Tabeliyində olanların təcavüzünə görə. Ətraf mühit müqaviməti ilə mübarizə vegetativ və endokrin sistemlərin böyük bir səfərbərliyinə gətirib çıxarır. Ürək-damar sistemi bu hallarda xüsusilə həddindən artıq yüklənir, çünki bədən toxumalarına enerji axınını tənzimləyir və vegetativ və endokrin sistemlərdən gələn hər bir signala cavab verir. Miokard infarktları ətraf mühit müqaviməti ilə bu bacarıqsız mübarizəyə ümumi bir reaksiyadır.

"Ex vacuo" nevrozlarında tez-tez hipokondriakal əhval-ruhiyyəyə rast gəlinir. Ətraf aləmin boşluğu normal vəziyyətdə şüur tərəfindən qəbul edilməyən öz bədəninin təsviri ilə doludur. // ƏMƏYİN YARADICI VƏ İSTEHLAKÇI ASPEKTLƏRİ (MÜBARİZƏ VƏ GÖZLƏMƏ VƏZİYYƏTİ)

İşin "yaradıcı" aspektində ətraf aləmə münasibət mübarizə (müsbət mənada mübarizə, hücum obyektinə məhv etmir, əksinə onu öz planına uyğun olaraq dəyişdirir və hücumçu onun dəyişdirici təsirinə təslim olur) olsa da, "istehlakçı" aspektində ətraf mühitə münasibət gözləntidir. İşə qoyulan səyə görə mükafat və ya cəza gözlənilir və işin ətrafındakılar iki qrupa bölünür - hakimlər və rəqiblər. Birincilər görülən işi qiymətləndirir, ikincilər isə daha yaxşı qiymət almağa mane olurlar. Vəziyyət bir qədər ailə qrupundakı emosional münasibətləri xatırladır - valideynlər hakim, bacı-qardaşlar isə rəqib kimi çıxış edirlər. Digər tərəfdən, "yaradıcı" aspektdə, xüsusən də "rejissor" nevrozu kimi patoloji formasında erkən uşaqlıq despotizmi ilə bənzətmə aparmaq olar.

İşə bu "istehlakçı" yanaşmasında yaranan nevroitik emosional vəziyyətlər hakimlərə qarşı kin və ya günahkarlıq hissləri və rəqiblərə paxılıqdır. Bunlar ətraf mühit müqavimətinə qarşı mübarizə ilə müşayiət olunanlardan daha az dinamik hisslərdir, lakin daha davamlı və dağıdıcıdır. Görünür, bu hallarda vegetativ və endokrin sistemlərin səfərbərliyi fərqli şəkildə davam edir. Ətraf mühit müqavimətinə qarşı mübarizədə səfərbərlik enerjiden istifadəyə yönəldilir (katabolik proseslərin yayılması) və buna görə də qan dövranı sisteminin böyük yüklənməsinə.

Mükafat gözləyərkən bədən ilkin səfərbərliyi xarici mühitdən enerji almağa yönəldilir (anabolik proseslər üstünlük təşkil edir) və sonra həzm sistemi, digər şeylər arasında, həddindən artıq yüklənir; tipik psixosomatik xəstəliklərə mədə xorası, öd kisəsinin müxtəlif disfunksiyaları və digərləri daxildir.

Bu hallarda mübarizə üçün səfərbərlik ikinci dərəcəli olur, anabolik səfərbərliyin olmamasından, yəni mükafat gözləntisindən sonra ortaya çıxır və sonra təcavüz hakimlərə və rəqiblərə, hətta özünə qarşı yönəldilir (günahkarlıq). // İŞİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İşin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, "onları bəhrələrindən tanıyırsınız" prinsipinə əsasən, insanın özünün qiymətləndirilməsi ilə birləşdirilir. Yaxşı meyvə yaxşı ağac, pis meyvə isə pis ağacdır. İşdəki uğurlar və uğursuzluqlar insanın özünün portretinin formalaşmasında rol oynayır. Özünəhörmət də böyük ölçüdə onlardan asılıdır. İşin yaradıcı aspektində ətrafınızdakılar fəaliyyət planını qiymətləndirirlər, lakin burada bu fəaliyyətin qiymətləndirilməsi müəyyən dərəcədə işçinin özünün qiymətləndirilməsindən asılıdır.

Buna görə də, əməyin istehlakçı aspekti həmişə insanın özünəhərmətinə və dolayısı ilə özü və imici uğrunda mübarizəyə görə daimi nevroitik təcrübələrə (narazılıq, günahkarlıq, paxıllıq hissləri) müəyyən təhlükə yaradır.

Bu hallarda eqosentrik mövqe üstünlük təşkil edir; əməyin yaradıcı aspektində dünyanı dəyişdirmək üçün mübarizə gedir, istehlakçı aspektində isə bu, insanın öz mənfəəti və özünəhərməti üçündür. Burada ətraf mühitlə birləşmə yoxdur, bu da onun müxalifətinə qarşı mübarizəni zəruri edir. Burada ətraf mühit insanın öz imicinin əks olunduğu sosial güzgü rolunu oynayır.

/ ƏMƏYİN HƏR İKİ ASPEKTİNİN ŞƏXSİYYƏTƏ TƏSİRİ

Əməyin istehlak aspektində ətraf mühit yalnız insanlardan (hakimlərdən və rəqiblərdən) ibarətdir, yaradıcı aspektdə isə yalnız insanları deyil, həm də cansız obyektləri, canlı təbiəti və nəhayət, işçinin özünü, yəni insanın əməyi nəticəsində çevrilə bilən hər şeyi əhatə edə bilər. Ətraf mühitlə qarşılıqlı təsir dairəsi daha genişdir və qarşılıqlı təsir imkanları da daha böyükdür. Bu hərəkət prinsipə uyğun olaraq qurulur: Mən ətraf mühiti dəyişdirirəm və o da məni dəyişdirir. Məlum bir həqiqətdir ki, "emal olunan" material müəyyən dərəcədə insanın özünü "emal edir"; deməli, müəyyən peşəkar şəxsiyyət xüsusiyyətləri. Müəyyən ixtisaslaşmış peşələr, məsələn, fermer, mədənçi, dənizçi, pilot, müəllim, həkim, işçi və s. müəyyən edilə bilər. Əməyin istehlak aspektində çevrilmiş obyektin dəyişdirən subyektə birbaşa təsiri yoxdur; qarşılıqlı təsir sosial mühitin qiymətləndirilməsinə və nümunələrinə əsasən baş verir və buna görə də dolayı yolla. İşçi sosial tələblərə uyğunlaşmağa və işdə üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışır. İşin yaradıcı aspektində fəaliyyət planı dəyişkən, daim dəyişən və dəyişdirilən obyektin təsiri altında dəyişkən olsa da, istehlakçı aspektində plan daha az çevikdir, çünki o, sosial mühitin tələbləri ilə müəyyən edilir. Burada vacib olan işin özü deyil, sosial mühit tərəfindən qiymətləndirilən onun nəticəsidir. Kiminsə işdə necə, harada və ya nə vaxt mübarizə apardığı deyil, necə tamamlandığı vacibdir. Hər bir iş üçün işçinin öz anlayışına zidd olsa belə, ona tabe olmalı olduğu ideal nəticə modeli mövcuddur.

Buna görə də, istehlakçı aspektində iş planı daha hərəkətsizdir.

// MƏYUSİMLİK

İş insanın öz planlarını reallaşdırmağın, gizli potensialını nümayiş etdirməyin ən vacib yollarından biridir. Bəzən insan özünün xəbərsiz olduğu, lakin müəyyən iş şəraitində özünü göstərən gizli potensialları gizlədir. Boşa sərf olunmuş həyatın nevroitik hissi əksər hallarda insanın işindən narazılıq hissi ilə birləşir.

Bioloji baxımdan, insanlar mövcud potensiallarının yalnız kiçik bir hissəsindən istifadə edirlər; onların genetik planı tam reallaşdırılmayıb və sinir sistemi, digər bədən sistemləri kimi, imkanlarının nisbətən kiçik bir hissəsində normal fəaliyyət göstərir. Genetik planın inkişaf istiqaməti və onun yerinə yetirilməsi ətraf mühit şəraitindən asılıdır. Əlbəttə ki, heç kim bu planı və ya potensialının miqyasını bilmir, lakin insanlar tez-tez həyat potensiallarını boşa sərf etdiklərinə, daha yaxşı işləyə biləcəklərinə və s. inanırlar. İş, onunla

Başqaları tərəfindən qiymətləndirilən real təsirlər, insanların ümumi səylərinin bir hissəsini yaradıcılığa töhfə verməklə, insanın öz imkanlarını ən yaxşı şəkildə qiymətləndirir və buna görə də onların məyusluğunu buna yönəldir.

Bu hiss, insanın niyyətlərini həyata keçirməyin yolları nə qədər çox olarsa, bir o qədər böyükdür. Məhdud karyera seçimləri olan bir cəmiyyətdə (məsələn, insan yalnız fermer, ovçu və ya sənətkar ola bildikdə) başqa bir iş tapmaq istəyi yoxdur, çünki bu, sadəcə mümkün deyil. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, müxtəlif imkanlar mövcud olduqda, itirilmiş imkanlar hissi daha da acı olur. Paradoksal səslənsə də, cəmiyyətin iqtisadi və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə məyusluq hissi artır.

SOSIAL DAİRƏ

// NEVROTİK ASPEKT

Ailə və iş mühiti ən çox xəstəni maraqlandırır və narahat edir, baxmayaraq ki, bu mövzular sonuncularda ön plandadır,

sosial mühit nadir hallarda nevrotik amil kimi qiymətləndirilir. Şübhəsiz ki, ailəyə və iş mühitinə təsir edən sosial, iqtisadi, sosial və siyasi amillərin xəstələr tərəfindən nevrotik təcrübələrinin mənbəyi kimi qiymətləndirilməməsi təəccüblüdür. Bu hallarda istisna şizofreniya ola bilər ki, burada sosial dairələrin pozulması tez-tez müşahidə olunur.

Normalda, ailə dairəsi ən yaxın, ardınca iş dairəsi və daha da uzaqda daha geniş sosial dairə gəlir. Şizofreniyada "köynək artıq bədənə uyğun gəlmir" və

xəstə ailəsi və ya işi ilə müqayisədə sosial məsələlərlə daha çox maraqlana bilər.

Nevrotik xəstə normal sosial mövqe iyerarxiyasını saxlayır və onların münaqişələri

ən yaxın iki dairə daxilində cəmləşir. Bu münaqişələr, xəstənin mənşəyindən, siyasi inanclarından və s. asılı olmayaraq, mahiyyətə oxşardır. Nevrozların formaları dövrdən və sosial dairədən asılı olaraq dəyişir, lakin nevrotik münaqişələr, ən azı əsas strukturlarında eyni qalır.

Bu, sosial dairələrin nevrotik hərəkət edə bilməyəcəyi anlamına gəlmir;

Onlar, xüsusən də ailə həyatında və işdə şəxslərarası münasibətlərə təsir göstərir, müəyyən bir qiymətləndirmə sistemi yaradır və bütün bunlara, hətta buna xüsusi bir istək olmadıqda belə, tabe olmaq lazımdır. Nevrotik hərəkət bu hallarda dolayı yolla özünü göstərir. Erkən uşaqlıqdan insan bu adətlərin təsirinə məruz qalır və buna görə də onların patoloji təsirlərindən həmişə xəbərdar olmur. Və onların zərərli təsirlərindən xəbərdar olsa belə, insan yenə də aciz qalır.

// "QIZIL DÖVR"

Köhnə psixiatriya dərslərlərində (təxminən yüz il əvvəl nəşr olunmuş) sivilizasiyanın mənfi təsirləri ruhi pozğunluqların əsas səbəbləri arasında sadalanır. 1930-cu illərdə ABŞ-da əsasən xəstənin sosial dairəsindəki amillərə diqqət yetirən sözdə sosial məktəb (Sullivan, Fromm, Karen, Horney) yarandı. Hal-hazırda bir çoxları

Psixiatrlar müasir sivilizasiyada rast gəlinən nevroitik amilləri təhlil edirlər.

Lakin unutmamalıyıq ki, sivilizasiya ilə bağlı şikayətlər və insanların təbiətin qoynunda sərbəst və maneəsiz yaşadıkları "qızıl dövr"ə olan həsrət yeni bir şey deyil. İnsanlar həmişə cənnəti özləri yaratmış cəmiyyətdə deyil, təmiz və gözəl bir təbiətdə təsəvvür ediblər.

Bu xəyallarda insanlar həmişə yaratdıqlarından narazıdırlar və birləşmək istədikləri təbiətə can atırlar. Belə bir birləşmə yalnız insan dünyasında deyil, heyvan dünyasında mümkündür. Məhz təbiətin transformasiyası, ona öz təsirini tətbiq etmək tipik insan xüsusiyyətlərindəndir. Sivilizasiya ilə bağlı kədərə müəyyən dərəcədə atavistik perspektivdən baxmaq olar,

təbiətlə əlaqə qurmaq, onun nizamına tabe olmaq istəyi yarandıqda, heyvanların və bitkilərin yaşadığı və Müqəddəs Kitabda deyildiyi kimi, insanın xeyir və şər şüuru ağacının meyvəsini dadmaqla, tanrılarla bərabər olmağa çalışmaqla itirdiyi zaman.

// NAQILIN KƏDƏRİNİN HƏQİQƏTƏ ÇIXMASI

Son əsrdə elm və texnologiyanın fəvqəladə inkişafı insana ətraf mühit üzərində əvvəllər heç vaxt olmadığı qədər güc vermişdir. Bu gün nağıl uydurmaq çətinidir, çünki

onların əksəriyyəti gerçəkləşib. Və bugünkü dövrün kədəri nağılın və gerçəkləşən bir xəyalın kədərindən başqa bir şey deyil.

İnsanın mühiti getdikcə təbii mühitdən texnoloji mühitə, yəni insan tərəfindən yaradılan mühitə dəyişir. Sürətli şəhərləşmə ilə bu dəyişiklik daha da qabarıq şəkildə özünü göstərir.

Sual yaranır: xarici mühitdə belə böyük bir dəyişiklik hansı nəticələrə səbəb ola bilər?

Texnoloji mühitin mənfi təsirləri düzgün müəyyən edilmişdir: təbiətin üç elementinin - hava, su və torpağın zəhərlənməsi; həddindən artıq əhali artımı və nəticədə insan yaşayış sahəsinin azalması; həddindən artıq məlumat axını,

zehni həzmsizliklə nəticələnir; Çoxlu sayda qıcıqlandırıcı, xüsusən də eşitmə və vizual, yüksək intensivliyə malik və çox vaxt informasiya dəyəri olmayan, uzun müddət təsir altında müvafiq reseptorlara və sinir sisteminə zərər verən qıcıqlandırıcılar; insanların uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyi həddindən artıq yüksək sürətlər; iqtisadi və siyasi münasibətlərin mürəkkəbliyi - bütün bunlar qarışıqlıq və acizlik atmosferi yaradır. Nəticədə, ümumi "qeyri-mümkünlük" hissi yaranır, istehlakçı münasibət yaradıcı münasibətdən üstün gəlir və "dəli bir dünyada" yaşamaq hissi, ətraf aləmin mənzərəsini təşkil etməyin çətinliyi, bir növ nizama, "inteqrasiyaya" can atmaq və tamamilə məhv olmaq qorxusu yaranır.

// TƏKAMÜL SİÇRALASI

Təbiətdə qəfil ətraf mühit dəyişikliyi təkamül sıçrayışına səbəb olur. Yeni şəraitdə,

yalnız onlara ən yaxşı uyğunlaşan canlı orqanizmlər yaşaya bilər və

yalnız onlar çoxala bilər. Əvvəlki şəraitdə əhəmiyyətsiz olan və istifadə olunmamış qalan müəyyən genetik potensiallar yeni şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər qəfil ətraf mühit dəyişikliyi insanlara bütün canlı təbiətdə olduğu kimi təsir edərsə, insanların təkamül sıçrayışının astanasında olduğunu güman edə bilərik. İnsanların hansı istiqamətdə dəyişəcəyini proqnozlaşdırmaq çətinidir. Yeni ətraf mühit şəraiti

Həm seçim, həm də integrasiya baxımından daha böyük insan imkanları, daha böyük reaksiya sürəti və aqressiyanı yatırmaq üçün daha böyük qabiliyyət tələb olunur.

Müasir məhvetmə vasitələri nəzərə alınmaqla aqressiya insanı tam fəlakətlə təhdid edir.

Fərdin həyatında nevroz tez-tez həyatda çıxılmaz vəziyyətə düşmüş bir şeyi dəyişdirmək ehtiyacının signalıdır və bununla da normal inkişafı gecikdirir.

Eynilə, müasir dövrün nevroitik vəziyyəti insan dəyişikliyinə ehtiyacın signalı kimi qəbul edilə bilər.

DUYGU STEREOTİPI

// GİRİŞ QEYDLƏRİ

Xəstə ilə söhbətlər zamanı onların yuxarıda qeyd olunan üç dairə daxilindəki emosional əlaqələri aşkar edilir: ailə, iş və sosial. Bu dairələrdən asılı olmayaraq müəyyən xarakterik emosional reaksiya növləri təkrarlanır. Məsələn, kimsə öz hüquqları uğrunda inadkarlıqla mübarizə aparır və ya daim incik hiss edir, ətraf mühitindən və öz davranışlarından daim narazıdır və ya başqalarının maraqlarının mərkəzində olmaq istəyir, xüsusi diqqət tələb edir və s. Bu tip reaksiya xəstədə uşaqlıq dövründə evində, daha sonra özlərini yaratdıqları ailədə, işdə və cəmiyyətdə mövcud idi. Onların emosional strukturunun bu xüsusi təhrifi, özlərini tapdıqları şəraitdən asılı olmayaraq, həyatda onlara mane olur.

Psixiatrix xəstənin mühitinə və xəstənin özlərinə necə baxmasından asılı olaraq, onlar patologiyaları xarici mühitdə və ya xəstənin özlərində axtaracaqlar. Bəziləri nevroz diaqnozu qoyacaqlar, çünki bu diaqnoz fərd və onun mühiti arasındakı münaqişəni əhatə edir, digər psixiatrlar isə psixopatiyanı tanıya bilərlər, çünki bu diaqnoz şəxsiyyət strukturunun davamlı təhrifini birmənalı şəkildə ortaya qoyur. // ERKƏN UŞAQLIQ DÖVRÜNÜN TƏHLİLİ

Ətraf mühitin təbiətindən asılı olmayaraq münaqişələrin təkrarlanma meyli,

xüsusilə psixanalitik yanaşmaya malik psixiatrların diqqətini xəstənin inkişafının ən erkən dövrlərinə yönəltməyə meylli olmasına gətirib çıxarır.

Onlar münaqişənin mənbəyini müəyyən etməyin, yəni insanın emosional strukturunda ilk təhrifin yarandığı anı müəyyən etməyin,

həyatın sonrakı dövrlərində yaranan və eyni zamanda bir qədər dəyişdirilmiş formada eyni neqativdən fotosəkillər kimi qəbul edilə bilən münaqişələri anlamağın və eyni zamanda aradan qaldırmağın açarı ola biləcəyindən irəli gəlirlər.

Şübhəsiz ki, bu mülahizədə müəyyən həqiqət payı var və demək olar ki,

əsas emosional struktur insanın həyatının ən erkən dövrlərində yaradılır və emosional reaksiyalar yalnız vəziyyətlər dəyişməklə həyat boyu təkrarlanır.

Lakin bu mövqe mütləq hesab edilə bilməz və pisliliyin bütün səbəblərinin erkən uşaqlıqda olduğu ilə razılaşmaq çətinidir. Həkim terapevtik yanaşmasının düzgünlüyünə əmin olsa belə, xəstə ilə bu cür söhbətlər aparmaq mümkün deyil.

Əgər xəstə həyat yoldaşından, müdirindən, çətin övladlarından və s. şikayət edərsə və psixiatr onlardan daim erkən travmalar və uşaqlıq təcrübələri barədə soruşursa, onda xəstənin həkimin peşəkar bacarıqlarına etibar etməsi həqiqətən çətinidir.

Xəstələrlə söhbətlər nadir hallarda Freydin mübahisəsiz parlaq kəşflərini verir: Edip kompleksi, kastrasiya kompleksi və s. Uşaqlıqda belə komplekslərin mövcudluğunu yalnız dolayılıqla təxmin etmək olar. Psixanalitik ədəbiyyata yaxşı bələd olan xəstələr bəzən özlərində belə kompleksləri kəşf edirlər. Xəstələr hazırkı həyatları boş olduqda və ya infantil və ya isterik şəxsiyyətə sahib olduqda asanlıqla uşaqlıq xatirələrinə qayıdırlar.

// VƏZİYYƏT, XRONİK VƏ SİKLİK NEVROZLAR

Nevrozların gedişi müxtəlifdir; onlar qısa və ya daha uzun müddət davam edə bilər və müalicə olmadan belə bir neçə aydan sonra keçə bilər və ya illərlə davam edə və müalicəyə davamlı ola bilər. Müalicə çox vaxt yalnız keçici təsir göstərir; bəzən nevrozlar daha çox və ya daha az qısa müddət ərzində siklik olaraq ortaya çıxır. Qısamüddətli nevrozlarda nevrotik vəziyyət adətən ön plana çıxır; nevroz xəstənin vəziyyətində dəyişikliklə aradan qalxır və ya xəstə sadəcə mövcud vəziyyətə alışır.

Xroniki nevrozlarda xəstəliyin əsas səbəbi xəstənin özündə, onların təhrif olunmuş emosional şəxsiyyət strukturunda olur. Bu hallarda, psixanalitik məktəblər tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, psixopatik xüsusiyyətləri və ya "xarakter nevrozunu" aşkar etmək olar.

Eyni şey, kiçik bir nevrotik vəziyyətin təsiri altında dəfələrlə, ümumiyyətlə kortəbii olaraq ortaya çıxan və bəzən ilin müəyyən vaxtlarında, məsələn, yazda və ya payızda müşahidə olunan siklik nevroz üçün də keçərlidir, bəzən siklofreniya və ya müəyyən psixosomatik xəstəliklərdə, məsələn, mədə xorasında baş verir.

Almandilli psixiatrlar Kernneurose və Randneurose terminlərindən istifadə edirlər:

birinci halda, nevrotik şəxsiyyət strukturu mövcuddur və problem xəstənin şəxsiyyətindədir və bu nevrozlar xroniki və ya remitentdir. İkinci halda, nevroz ətraf mühitlə münaqişə nəticəsində yaranır və xəstənin şəxsiyyət strukturunun özü əhəmiyyətli sapmalar göstərmir. Belə xəstələrdə nevrozların gedişi adətən qısamüddətli olur.

/ PATOLOJİ ŞƏXSİYYƏT STRUKTURU

Şəxsiyyət strukturunu müəyyən etmək və onu normal və ya patoloji olaraq təsnif etmək həmişə mümkün olmur və hər halda asan məsələ deyil. Bu, normal və patoloji arasındakı sərhəd məsələsini ortaya qoyur. Kiçik psixiatriyada* bu, əsas psixiatriyadan* daha çətin, çünki qəbul edilmiş davranış və təcrübələrin orta səviyyəsindən sapmalar azdır. Üstəlik, qəbul edilmiş orta davranış həmişə normal deyil və qeyri-adi davranış həmişə patoloji hesab edilmir.

Normal şəxsiyyət strukturunu necə təyin etmək ümumiyyətlə məlum deyil. Müəyyən mənada, bu, mücərrəd bir fikir hesab edilə bilər - insanın ideal modeli müxtəlif psixiatrlar tərəfindən fərqli şəkildə müəyyən edilir. Freyd bu modelə sevgi və işləməyə qadir olan bir insanın xüsusiyyətlərini ("ora et labora" - "dua et və işlə" əvəzinə) bəxş edir.

Psixiatrlar, bir qayda olaraq, ehtiyacdan asılı olaraq xəstə ilə qısa və ya uzun təmasdan sonra hər bir fərdin strukturunda müəyyən sapmalar aşkar edə bilərlər.

Şəxsiyyət xüsusiyyətləri — xəstə üçün zərərli olan dərin komplekslər — yalnız özünəhörmət və s.

Heç bir insanın mükəmməl strukturlaşdırılmış şəxsiyyətə malik olmadığını güman etmək olar.

Bir çox insan psixiatra müraciət etməyə ehtiyac hiss etmir və bu etiraf istəyi olmadan psixiatrik müayinə nəticədə heç bir dəyərli nəticə vermir.

Lakin, bu insanların psixiatrik

köməyə ehtiyacı olmadığına dair heç bir dəlil yoxdur. Onların həyatlarını kənardan müşahidə edərək, qabiliyyətlərini necə boşa çıxardıqlarını,

özlərini öldürdüklerini, müxtəlif

xırda məşğuliyyətlərlə depresif əzablarını necə boğmağa çalışdıqlarını görərək, onların zehni quruluşunu qeyd-şərtsiz qəbul etmək çətindir.

* "Kiçik psixiatriya" "ümumi dairəyə" uyğun gələn xəstələrə və buna görə də nevrozları, psixopatları, narkomanları, alkoqolikləri,

psixosomatik xəstəlikləri və s. olanlara aiddir. "Kiçik" və "əsas" psixiatriya arasındakı sərhəd ən aydın şəkildə ağılın qiymətləndirilməsində müəyyən edilir. Birinci qrupdakı xəstələr ağılı başındadır və ya qismən məhdud ağılı başındadırlar, digər qrupdakılar isə ağılı başında deyillər.

** "Əsas psixiatriya" "ümumi insan dünyasına" uyğun olmayan xəstələri əhatə edir; onlar "başqa", "müxtəlif", "yadplanetlilər"dir və buna görə də psixozlardan, oliqofreniyadan, yəni əqli cəhətdən geri qalanlardan və epilepsiya xəstələrindən əziyyət çəkirlər. Epilepsiyada anormallıq dövrü adətən qısa olur və tutma müddəti ilə məhdudlaşır.

// İnsan Təbiətinin Təhrif (Asimmetriya)

Bəlkə də bu təhrif insan təbiətinə xasdır. Hətta insan sinir sisteminin strukturunda belə, heyvanlar aləminin digər nümayəndələrinin sinir sistemləri ilə müqayisədə, bir beyin yarımkürəsinin digərindən üstünlüyü, bir asimmetriya mövcuddur. İnformasiya nəzəriyyəsi baxımından, asimmetrik bir sistem simmetrik sistemdən daha çox məlumatı yerləşdirə bilər. Bir neçə məlumat parçası ilə simmetrik şəkildə düzülmüş kvadratların strukturu ötürülə bilər, onların asimmetrik düzülüşü isə xeyli çox məlumatın ötürülməsini tələb edir. İnsanların tez-tez razılaşmadığı, mübarizə apardığı və dəyişməyə çalışdığı ətraf mühitlə uyğunsuzluq heyvanlar aləminin xarici mühitlə sintonik əlaqəsindən kəskin şəkildə fərqlənir. Subyektiv anlayışda insanın öz asimmetriyası və ətraf mühitlə uyğunsuzluğu əzab mənbəyi ola bilər ki, bu da heyvanlar aləmindən daha çox insanın taleyi ilə sıx bağlıdır.

Nevrotiklərdə təhrif olunmuş şəxsiyyət quruluşunu, həyatda onlara mane olan "zehni donqarlıq" aşkar etmək daha asandır. Nevrozlu bir xəstə təcrübələrini psixiatra daha asanlıqla açıqlayır; yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu cür təmasdan qaçan insanlarla psixiatrik əlaqə xeyli çətin və çox vaxt tamamilə qeyri-mümkündür. Bundan əlavə, nevrozda "zehni donqar" aşkarlanır və şişir. Psixopatik şəxsiyyət xüsusiyyətləri, dərin travmalar və tənha bir küncdə yatmış komplekslər nevroz zamanı üzə çıxır və bu da xəstənin digər insanlara və özlərinə dözmək qabiliyyətini daha da maneə törədir. Nevrotizmin qəddar bir dövrü başlayır: təhrif olunmuş şəxsiyyət strukturunun aşkarlanması nevrotik təzahürləri artırır və bu da öz növbəsində xəstənin ağırlı nöqtələrini daha da üzə çıxarır.

// TARAQLIY POZULMASI VƏ HƏRƏKƏT QALMAQ

Niyə nevrozda bu qədər çox özünə bağlı problemlər var?

Eyni insan nevroz inkişaf etməzdən əvvəl öz problemləri ilə mübarizə aparır, lakin sonra öz problemlərini, münaqişələrini, travmalarını, dərin şikayətlərini, komplekslərini və s. həll edə bilmir, aciz qalır. Onlar hərəkətlərini idarə edə bilmir və nevrozik simptomları və öz təbiətlərinin mənfi xüsusiyyətləri ilə əhatə olunmuş şəkildə ətrafda gəzirlər.

Əgər bütün mürəkkəb sistemlərdə olduğu kimi, insan tarazlığının da qeyri-adi dərəcədə qeyri-sabit olduğunu qəbul etsək, nevrozlara bu tarazlığın pozulması perspektivindən baxmaq olar, bu da fərd daxilində daha az sabit nöqtələri, tarazlıq qorunduqda adətən nəzərə çarpmayan nöqtələri ortaya qoyur.

Nevrozdan əziyyət çəkənlər başqalarında və hətta özlərində belə bir təəssürat yaradırlar ki,

tələyə düşdükləri dairədən çıxış yolu olmadan təkərdəki dələ kimi fırlanırlar. Xəstənin təcrübələri və davranışları itirilmiş tarazlığını bərpa etməyə çalışan bir insanın təcrübələrinə bənzəyir. Belə bir insan artıq irəliləmir, əksinə məqsədsiz olaraq

qollarını yelləyir, ayaqları yerə möhkəm basılmamış halda bir şeydən yapışmağa çalışır. İnsan bədrəyəndə tarazlığın itirilməsi yalnız hərəkət sisteminə aiddir, lakin nevrozda bu, insan bədəninin bütün harmoniyasına təsir göstərir.

Tarazlığın itirilməsi irəliləmənin gecikməsinə səbəb olur. Eynilə, nevrozda insan

inkişafında gecikir, hərəkətsiz qalır və buna görə də, digər şeylər arasında,

ümitsizlik hissi yaranır. Bu günə qədər nevrozun qənaətbəxş bir tərfi yoxdur. Nevrotik xəstələri, onların əzabverici, uzunmüddətli

əziyyətlərini, intellektual və emosional potensiallarının boşa getməsinə,

saysız-hesabsız münaqişələrini, hər şeydən və hər kəsdən narazılıqlarını müşahidə etmək - insanda insanların qaranlıqda hərəkətsiz dayandığı təəssüratı yaranır. Nevroz tez-tez çətin həyat şəraitində aradan qalxır, çünki bu şərtlər hərəkəti zəruri edir və insanın top kimi fırlanmasına mane olur.

// ƏQLİ SİFARIŞ

Sonrakı müsahibələr vasitəsilə xəstəni tanıyan psixiatr, onun haqqında toplanan məlumatları məntiqi, səbəb-nəticə ardıcılığına uyğunlaşdırmağa çalışır. Elmi baxışlarından asılı olaraq, psixiatr ya konstitusional amilləri, məsələn, nevrozda şübhəsiz ki, əhəmiyyətli rol oynayan avtonom və endokrin sistemlərin fitri labilliyini, ya da insanın əsas emosional quruluşunu formalaşdıran uşaqlıq təcrübələrini, ya da mövcud münaqişələrini nəzərə alacaq. Bir psixiatr üçün xarici mühitin zərərli təsirləri daha vacib, digəri üçün isə xəstənin şəxsiyyət quruluşunun əvvəllər qazanılmış təhrifini nəzərə alacaq.

Bu sıralama xəstəni öyrənmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu, insan zehninin xüsusiyyətidir və materialı eyni zamanda müəyyən bir şəkildə təşkil etmədən, çox vaxt materialdan daha çox özü üçün heç nə öyrənmə bilmir. Bu, xəstənin müalicəsi üçün də vacibdir, çünki psixiatr tərəfindən müəyyən edilmiş sıralama müsahibələr zamanı xəstəyə ötürülür və ən azı müəyyən dərəcədə şüurun pozğun və xaoslu proseslərində itirilmiş tarazlığı bərpa edir.

Qəbul edilmiş elmi baxışdan asılı olmayaraq, bu effektin xəstə ilə düzgün münasibət qurmaqla əldə edilə bilməsi də təəccüblüdür. Çox vaxt xəstənin növündən asılı olmayaraq bu səbəb sıralamasından istifadə etdiyi görünür.

Bəzən nevrozun başlanğıcını və səbəbini izah edən ən məntiqi səbəb əlaqəsi səhv olur, məsələn, nevrotik sindromun səbəbi sonradan somatik xəstəlik olduğu müəyyən edildikdə. Lakin, bu səhvə baxmayaraq, xəstə psixiatrla müzakirələr zamanı özünü daha yaxşı hiss edir.

Psixiatrla əlaqə və həkimlə müzakirələr zamanı yaranan emosional reaksiyaların müəyyən tənzimlənməsi somatik xəstəliyə müşayiət olunan nevrotik təzahürləri azaldır və hətta müəyyən dərəcədə vegetativ və endokrin sistemlərin təsiri ilə xəstəliyin özünə müsbət təsir göstərə bilər.

Həmçinin, psixiatrın əhəmiyyətli bir nevrotik amilin xəstənin sevilən birinə, məsələn, valideynə, həyat yoldaşına və s. qarşı mənfi münasibəti olduğuna əmin olduğu da olur ki, bu da nevrozun səbəbi ola bilər. Lakin, məlum olur ki, bu dominant hiss psixiatrın heç bir müdaxiləsi olmadan qəfil dəyişir, əlamətini aradan qaldırır və ya müsbətə çevirir. Daha sonra xəstənin emosional vəziyyətindəki bu dəyişikliyin səbəbini anlamaq çətindir. Bəzən elə görünür ki, nevrotik təsir göstərən mənfi emosiyalar insanın daxilində

xarici vəziyyətdən asılı olmayaraq mövcuddur. Onlar heç nə ilə və ya heç kimlə əlaqəli deyillər, lakin kiçik bir travma onların yaxın birinə yapışması üçün kifayətdir.

"Sərbəst üzən narahatlıq" termininə bənzər şəkildə, qeyri-müəyyən aqressiv hissləri "sərbəst üzən təcavüz" adlandırmaq olar.

İnsanın daxilində toplanan qorxu və təcavüz hissləri çıxış yolu axtarır və əksər hallarda ailədə və işdə yaxınlarına əks olunur. Bu mənfi hisslərin hədəfi olan insanlar özlərini heç nəyə görə günahlandırma bilməzlər. Bəlkə də bu mövqe insan həyatının sülh dövründən xeyli aşağı hesab edildiyi müharibənin emosional atmosferi ilə ən yaxşı şəkildə təsvir olunur. Müharibə sülh dövründə harmoniya içində yaşaya biləcəyi insanlarda ən mənfi qorxu və nifrət hisslərini ortaya çıxarır.

Nevrozun mənbəyini axtaran bir psixiatrın məruz qaldığı bu illüziya nümunələri onu bu cür tədqiqatlardan çəkindirə bilməz; onun vəzifəsi xəstə haqqında biliklərini təşkil etmək və səbəb-nəticə əlaqəsi yaratmağa çalışmaqdır. Buna baxmayaraq, bu səylərdə psixiatr həmişə tənqidi münasibət saxlamalıdır ki, lazım gələrsə, işlək fərziyyələrini dəyişdirsin.

ÜMUMİ QEYDLƏR

// İBTİDAİ TƏBABƏT

Nevrozların müalicəsi artıq ibtidai tibb tərəfindən həll edilən tibbi problemdir. İbtidai tibbdə istifadə edilən müalicə üsulları maskaların, sehrli tilsimlərin, rəqslərin və sair kimi şeylərin istifadəsinə qədər azaldılıb ki, bunların hamısı əsasən xəstəliyin nevrotik komponentini həll edirdi. Somatik xəstəliklərdə hər hansı bir yaxşılaşma bu spesifik təsir sayəsində baş vermişdir. Bu günə qədər əhalinin ənənəvi sehrbazlarının* və müasir tibb həkimlərinin xidmətlərindən istifadə edə biləcəyi inkişaf etməmiş ölkələrdə, məsələn, cərrahiyyə tələb edən somatik xəstəlikləri olan xəstələr elmi tibb mütəxəssislərinə müraciət edirlər, nevrotik komponentli somatik xəstəlikləri və zehni pozğunluqları olanlar isə ibtidai tibb mütəxəssislərinə müraciət edirlər.

İbtidai tibb əsasən xəstənin şüuruna təsir edən psixoterapevtik adlandırıla bilən qeyri-müəyyən bir müalicəvi elementdən istifadə edirdi. Belə hallarda, sehrbazın xəstəni qorxutmağa və öz limitsiz gücünə inamını oyatmağa çalışdığı, tez-tez hipnoz yaratdığı kəskin hərəkətlərdən istifadə olunurdu.

Daha yüngül metodlar da istifadə olunurdu, məsələn, xəstə ilə danışmaq və onlara xəstəliyinin təbiətini izah etmək (xəstə kiminsə ona sehr etdiyini və xəstəliyinin sehrbazın sehrli gücü vasitəsilə bədənindən heyvanın və ya düşmənin xəstəliyinə keçə biləcəyini; ya da xəstəliyinin hansısa bir cinayət üçün onlara göndərildiyini və sehrbazın onları bundan təmizləyə biləcəyini öyrəndi).

// BƏDƏNƏ HALİSTİK VƏ QİSMƏN TƏSİRLƏR

Şüur subyektiv olaraq hazırda bədəndə baş verən hər şeyi əks etdirir və öz növbəsində, şüurun hər bir hərəkəti hər bir orqanın, hətta bədəndəki hər bir hüceyrənin funksiyasına təsir göstərir. Buna görə də, holistik yanaşma tətbiq etməklə müxtəlif orqanların funksiyalarına təsir göstərmək mümkündür. Bu problem xüsusilə psixosomatik xəstəliklərdə əhəmiyyətlidir. Lakin elmi tibbin inkişafı bədənə qismən təsirlərə doğru irəliləmişdir. Tədqiqat sahəsinin yalnız daralması daha da öyrənilməyə və eyni zamanda daha effektiv müdaxiləyə səbəb olmuşdur. Bədənin müəyyən bir hissəsinə diqqət yetirilməsindən və istifadə edilən tədqiqat metodlarından və terapevtik müdaxilələrdən asılı olaraq tibbdə müxtəlif ixtisaslaşmalar yaranmışdır.

Lakin, ixtisaslaşmadan asılı olmayaraq, xəstə ilə hər təmasda onlara vahid təsir görünür. Bu, ibtidai tibbin qalıdır.

Həkim həmişə xəstəni müalicə edir, xəstə orqanı yox. Məlumdur ki, sadəcə həkimə dəfələrlə müraciət etmək xəstənin əzablarını yüngülləşdirir. Eyni diaqnostik və terapevtik tədbirlər fərqli təsirlər yaradır və onların tətbiq üsulundan və onları tətbiq edən şəxsdən asılıdır. Xəstə tərəfindən qiymətləndirilən "yaxşı və pis həkimlər" anlayışı həmişə həkimin peşəkar qabiliyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsinə uyğun gəlmir. Yalnız dərmanlar və müdaxilələr terapevtik təsirə malik deyil, həm də həkimin şəxsiyyəti də var. Hər bir xəstəliyin nevroitik elementi var, çünki hər bir xəstəlik

bütün bədənə təsir edir. Diş ağrısı baş verərsə, insan özünü yorğun,

bədbəxt hiss edir, işə diqqətini cəmləməkdə çətinlik çəkir, əyləncəni unudur, yata bilmir və s.

// METOD VƏ YA ŞƏXSİYYƏT

Nevrozların müalicəsində istifadə olunan müxtəlif metodları müşahidə etdikdə, onların hamısının nəticə verdiyi təəssüratından qaçmaq olmaz və fərqlər metodlardan deyil, onları tətbiq edən insanlardan çox asılıdır. Bəziləri ümumi toniklərdən, bəzi hallarda sedativlərdən, gimnastikadan, masajdan və hidroterapiyadan istifadə edərək sırf somatik tədbirlərlə əhəmiyyətli nəticələr əldə edirlər. Bəzən diqqətlərini müəyyən bir orqana və ya sistemə yönəldirlər. Məsələn, əgər qan dövranı sistemində vegetativ distoniya dominantdırsa, həkimlər ürək dərmanları təyin edirlər. Digər həkimlər nevrozlu bir xəstənin yalnız çətin vəziyyətlərdə səfərbər ola və itirilmiş tarazlığını bərpa edə biləcəyinə inanaraq kəskin tədbirlərdən istifadə edirlər. Bu həkimlər intensiv peşə terapiyasından istifadə edir, idman düşərgələrinə səyahətlər, pəhriz məhdudiyyətləri, sadələşdirilmiş pəhriz və s. təklif edirlər.

Bəzi psixiatrlar nevrozlu xəstəyə çox əlverişli şərait yaradılmalı olduğuna inanaraq əks mövqe tuturlar. Onlar qidalanmanın yaxşılaşdırılmasını, travmatik amillərdən qorunmanı təklif edir və xəstəyə ürəyinin istədiyi hər şeyi təmin etməyi tövsiyə edirlər. Nevrozun kəskin mərhələlərində xəstəni uzunmüddətli yuxu vasitəsilə reallıqdan ayırmağı məsləhət görürlər.

Dramatik müalicə üsulları da nəzərdən keçirilir. Bir və ya bir neçə hipnotik seans ərzində bəzən nevroitik simptomlar aradan qaldırıla bilər. Digər həkimlər oxşar nəticələrə "möcüzəvi" bahalı dərmanlardan istifadə etməklə nail olurlar; bəzi həkimlər xəstəni ağır xəstələr üçün psixiatriya şöbələrinə yerləşdirməklə və ya onlara nevroitik problemlərinin əsl səbəbini və həqiqətini qəfil izah etməklə şoka salırlar.

Psixoterapiyanın nevrozlar üçün ən yaxşı müalicə olduğuna inanılır. Onun əhatə dairəsində geniş metodlar da mövcuddur, çünki analitik psixoterapiya, suggestiv psixoterapiya, hipnoz, dəstəkləyici və təhsil psixoterapiyası və Pavlovun təlimlərinə əsaslanan psixoterapiyanın müxtəlif istiqamətləri mövcuddur.

// İMAN

Psixiatr adətən öz müalicə metoduna əmindir və tez-tez onu müdafiə edir, digər metodlara qarşı ayrı-seçkilik edir. Görünür, öz metoduna olan bu inam effektiv nəticələr əldə etmək üçün olduqca vacibdir. Bu inam ən aydın şəkildə suggestiv psixoterapiya və hipnoz metodlarında özünü göstərir. Hipnoza inanmayan və onu sınayarkən özünü gülünc hiss edənlər heç vaxt xəstəni hipnotik vəziyyətə sala bilməyəcəklər. İbtidai tibbdə istifadə olunan bütün terapevtik metodlarda da eyni inam elementi vacibdir. İnsan inana bilər ki, yalnız xəstənin imanı ola bilər və həkim müxtəlif müalicə metodlarına tənqidi yanaşmalıdır. Emosional psixologiya baxımından bu mövqe şübhəlidir. Emosiyalar sırf şəxsi məsələ hesab edilə bilməz; onlar xaricə yayılır və başqalarına ötürülür. Fikirlərini özünə saxlamaq asan olsa da, öz hisslərini gizlətmək bəzən böyük səy tələb edir - üz ifadələrini, səs moduliyasını, jestləri və s. idarə etmək. Emosiyalar subyektiv olaraq insanın ətraf aləmlə əlaqəli motor vəziyyətini əks etdirir və bir qayda olaraq, həmişə bədənin ümumi səfərbərliyində (vegetativ və endokrin sistemlərin səfərbərliyi, əzələ gərginliyinin artması və beləliklə, üz ifadələrinin, bədən vəziyyətinin dəyişməsi və s. ilə özünü göstərən motor orqanlarının səfərbərliyi) özünü göstərir.

Həkimin inamı xəstəyə ötürülür. Xəstənin inamı da öz növbəsində həkimə öz qabiliyyətlərinə inam verir. Qapalı bir dairə yaranır, lakin bu halda müsbət əlamətlə. Həkimin xəstənin həyatını sona qədər qorumaq üçün mübarizə aparmalı olduğu, hətta hər şeyin itirildiyi görünə belə, uzun müddətdir mövcud olan tibbi qayda böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu halda həkimin inamı xəstəyə ötürülür. Xəstə ölüm hökmünü həkimin üzündə oxuya bilər və buna görə də həkim ümidini itirməməlidir.

Bəzən həkimlərin niyə xəstənin həyatını cəmi bir neçə saat uzatmaq üçün bu qədər lazımsız səy sərf etdiklərini düşünmək olar. Lakin, bu səy həmişə zəruridir,

əgər xəstə ömrünün sonuna qədər öz sağlamlığına inanırsa.

Tibbdə gözlənilməz hadisələrin baş verdiyi, məsələn, xəstənin pis nəticə gözləntilərinə baxmayaraq sağaldığı və əksinə, hamı üçün gözlənilmədən öldüyü məlumdur.

Ruhi sağlamlıq məsələsində iman məsələsi somatik tibbdən daha böyük rol oynayır. Valideynlər və müəllimlər tərəfindən axmaq və ya pis hesab edilən uşağın əslində nə qədər tez-tez belə hala gəldiyi gündəlik təcrübədən yaxşı məlumdur və böyüklər üçün onları sadəcə bir uşaq kimi qəbul etmək onların rifahına və davranışına da təsir göstərir.

Əgər bir insana inam itirilərsə, o zaman onlar sosial ölümə məhkumdurlar. Psixiatriyada həkim insan cəmiyyətinin kənarında və ya xaricində insanlarla qarşılaşdıqda bu inam xüsusilə vacibdir. Yalnız diaqnostik etiketləri görən, proqnozları elmi həqiqət kimi qəbul edən psixiatr xəstəni uçuruma itələyə bilər; eynilə tələbəsinə azyaşlı kimi baxan müəllim kimi.

Beləliklə, psixiatrik müalicədə inam vacib bir elementdir. Xəstəyə inam və insanın müalicə metoduna inam. Psixiatriyada müxtəlif müalicə metodlarının effektivliyinin əks qiymətləndirmələri əsasən onların bəzi hallarda effektivliyinə böyük inamla, digərlərində isə böyük şübhə ilə və ya heç bir inam olmadan tətbiq olunmasından irəli gəlir.

SƏBR

// İTİRİLMİŞ XƏYALLAR?

İmandan başqa, psixiatrik müalicənin hər bir cəhdində və xüsusən də nevrozların müalicəsində vacib olan digər bir amil səbrdir. Psixiatr səylərinin tez-tez uğursuz olduğu fikrinə alışmalıdır.

Xəstə ilə aylarla, hətta illərlə aparılan müntəzəm müzakirələr, bu və ya digər somatik müalicə metodunun sınaqları nəticəsiz qalır və bütün bunlar istənilən nəticəni vermir və ya onun təsiri çox əhəmiyyətsiz olur.

Lakin, xəstə vəziyyətində yaxşılaşma olmamasına baxmayaraq, həkimə gəlir və ona etibar edir. Psixiatr xəstənin hələ də ona ehtiyac duyduğundan məmnun ola bilər. Bəzən, xəstə həkimlə əlaqəni dayandırdıqdan sonra yaxşılaşma baş verir. Belə hallarda, bu yaxşılaşma spontan ola bilər, lakin müalicənin gecikmiş təsiri istisna edilə bilməz.

Xüsusilə də şəxsiyyət təhrifinin əhəmiyyətli bir elementi olan xroniki nevrozları, tanış psixopatik tikanla müalicə edərkən, psixiatrın səbri sözün əsl mənasında sonsuz olmalıdır. Bir insanı dəyişdirmək çətinidir; bəziləri bunun qeyri-mümkün olduğuna inanır, lakin müalicənin nəticəsi bundan asılı olduğundan dəyişiklik zəruridir.

Digər tərəfdən, bir insan daim dəyişir; onlar heç vaxt eyni qalmırlar.

İnsan təbiətinin dəyişkənliyinin çətin başa düşülən dialektikası belə hallarda ümidli qalmağımıza imkan verir.

Psixopatları necə müalicə etmək sualına cavab tapmaq mümkün olmasa da, bəzən xəstədə gözlənilməz müsbət dəyişikliklərə səbəb olan həkimin səbridir.

// NEVROTIKLƏRİN MÜALİCƏSİ NİYƏ BU QƏDƏR AĞRILIDIR?

Əksər psixiatrlar nevrozların müalicəsinin psixozların müalicəsindən daha ağırlı olduğu ilə razılaşırlar. Nevrotiklərlə bir neçə saatlıq söhbətlərdən sonra həkim

çox vaxt ağır fiziki əməkdən sonra olduğu kimi qeyri-adi dərəcədə yorğun hiss edir,

halbuki psixotik xəstələrlə söhbətlər bu nevrotik yorğunluğa səbəb olmur.

Yorğunluq, görünür, cansızlıqdan qaynaqlana bilər. Bir çox psixiatr üçün nevrotik təcrübə dünyası psixotik xəstəninkindən daha az maraqlıdır. Lakin,

bəzi psixiatrlar var ki, nevrotik xəstələrin gündəlik münaqişələrinin məzmunu ruhi xəstələrin fantastik təcrübə dünyasından daha maraqlıdır. Və bütün bunlara baxmayaraq, nevrotik xəstələrlə söhbətlər daha yorucu və ağırlıdır.

Nevrozlu xəstə adətən həkimdə psixozlu xəstədən fərqli emosional reaksiya doğurur. Psixozu fərdi bürüyən və psixiatrın nəzarətindən kənar olan bir "şər" baxımından baxılır. Psixiatr bilir ki, xəstə onlara xəstəliklərinə qarşı ümumi mübarizədə kömək edə bilməz; Belə bir vəziyyət, somatik xəstəlikdə olduğu kimi, faydasız olardı. Bəlkə də psixiatriyada psixozları az-çox "üzvi" xəstəliklər kimi görmək meylinin mənbəyi budur. Digər tərəfdən, nevroz, insanın öz iradəsi ilə, ən azı qismən azad ola biləcəyi bir "pislik" hesab olunur.

Nevrozlu bir xəstənin vəziyyətinə girən psixiatr, nevrozun inkişafına səbəb olan "səhvləri və təhrifləri"ni görür. Onların hakim və maarifçi mövqeyindən uzaqlaşması çətinidir. Psixiatr onların nə əlaqçı, nə də müəllim olduqlarını bilsə də, özlərini mühakimə etməkdən və maarifləndirməkdən çəkindirməlidirlər. Həkim nevrozlu xəstəyə qarşı iddialar irəli sürür və sağlamlılıqlarının yaxşılaşmamasında onları günahlandırır. Xəstə nevrotik problemlərindən uzaqlaşmalıdır və əgər həkim belə bir əməkdaşlığı görmürsə, onda söylərinin boşa getdiyinə inanırlar.

Nəhayət, eqosentrizm kimi tanınan və başqalarının sadəcə eqoizm kimi qəbul etdiyi nevrotik eqosentriklik, həkimin xəstəyə qarşı mənfi emosional vəziyyətinə də təsir göstərir və onlar bunu daim nəzarətdə saxlamalıdırlar. Buna görə də, nevrozlu xəstələrlə işləyərkən həkimdən psixotik xəstələrlə müqayisədə daha böyük daxili mübarizə tələb olunur. Mənfi emosional reaksiyaların daimi nəzarətinə olan bu ehtiyac, nevrozlu xəstələrin müalicəsində yorğunluğa səbəb olur.

ANLAMAQ QABİLİYYƏTİ

// İDRAKI PROSESİNİN SONSUZLUĞU

Nevrozların müalicəsində üçüncü vacib element xəstəni anlamaq qabiliyyətidir. Çox vaxt xəstənin tam başa düşüldüyü görünür, lakin növbəti görüşdə o, tamamilə fərqli bir işıqda görünür. Çox vaxt böyük çətinliklə qurulan etioloji təhlillər yersiz olur və yeni konstruksiyalar yaradılmalıdır. Psixiatriyada idrak prosesinin sonsuz olduğunu nəzərə almaq lazımdır və buna öyrəşmək lazımdır.

Terapevtik proses üçün, görünür, vacib olan anlayışın özü deyil, anlamaq istəyidir. Həkimin xəstəni necə başa düşməsindən asılı olmayaraq, buna nail olmaq mümkündür

Müsbət müalicə nəticələri. Bu, xəstə, onun təcrübəsi və genezisi haqqında obyektiv həqiqətin olmaması demək deyil. Psixiatrlar, psixiatrik baxışlardakı və istifadə etdikləri terminologiyadakı fərqlərə baxmayaraq, ümumiyyətlə xəstənin şəxsiyyət strukturunu qiymətləndirməkdə və əsas münaqişə amillərini qiymətləndirməkdə razılaşırlar. Bu, ardıcılıq, məsələn, rentgen müayinəsi zamanı həkimlərin daha spesifik məlumatları müəyyən etməsindən daha çoxdur. Lakin, psixiatr başqa bir insanın həyatını öyrənərkən biliklərin sonsuzluğunu unutmamalıdır. Onların düşüncələri heç vaxt mütləq olmamalıdır və bu gün mübahisəsiz bir həqiqət kimi görünən şey sabah yalnız əhəmiyyətsiz bir hissə ola bilər.

// PSIXOTERAPIYANIN AKTİV VƏ PASSİV METODLARI

Xəstə ilə söhbətlər zamanı yalnız psixiatr xəstə haqqında məlumat əldə etmir, həm də xəstənin özü haqqında məlumat əldə edir. Özünü kəşf etmə prosesində psixiatrın iştirakı əsasən həkimin şəxsiyyətindən asılı olaraq daha çox və ya daha az ola bilər.

Daha çox dinamizmə malik psixiatrlar xəstəyə öz şərhlərini izah etməyə daha çox meyillidirlər. Psixoterapevtik metodlar daha çox və daha az aktiv metodlara bölünür. Bu metodun effektivliyi ilk növbədə psixiatrın öz düşüncə tərzini xəstəyə çatdırma dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Daha az aktiv metodlarla belə, xəstə öz portretini çəkərkən psixiatrın təsirindən tamamilə azad olmur.

Həkimin sual vermək metodu, bəzilərinin xarakter xüsusiyyətlərini və davranış nümunələrini incə və adətən səmimi şəkildə qəbul etməsi və bəzilərinin inkar etməsi, xəstənin söhbət zamanı özünü necə göstərməsindən asılı olaraq xəstəyə qarşı emosional əhval-ruhiyyənin dəyişməsi və heç bir təcrübəli psixiatrın xəbərdar olmadığı digər amillər xəstənin öz portretinin formalaşmasına təsir göstərir. Buna görə də psixiatrla söhbətlər zamanı baş verən özünü tanımanın onların birgə prosesi olduğu qəbul edilə bilər. Bu mövqe, əsas xüsusiyyətlərinə görə, öz portretinin yaradılmasına ümumi qəbul edilmiş baxışla uyğundur. Müəyyən dərəcədə "sosial əks etdirmə"nin təsiri altında formalaşır. İnsanın özünəinam anlayışı heç vaxt sırf şəxsi deyil, əksinə, az və ya çox dərəcədə ətraf mühitin qiymətləndirilməsini əhatə edir.

// "GNOTHISEAUTON"

"Gnothi seauton" ("özünü tanı") - bu, xəstəyə kömək edirmi? Psixiatrlar vaxtlarının çox hissəsini xəstələrlə söhbətlərə həsr edirlər. Bu görüşlər vasitəsilə onlar xəstələrini, xəstələr isə özlərini tanıyırlar. Bu biliyin yalnız nisbi olduğunu və xəstəyə əzablarında kömək etməsinin ehtimalının az olduğunu anlamaq psixiatr üçün çox kədərli bir hadisə olardı. Onların səyləri gözlənilən nəticələrə gətirib çıxarmazdı.

Klassik psixoanaliz, bilinçaltıya yeridilən özü haqqında həqiqəti çıxarmağa əsaslanır və sonra bir dəfədən çox nevroitik simptomların aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür. Digər tərəfdən, istənilən psixiatr bəzən uzun illər psixiatrlarla təmasda olması sayəsində nevroitik mexanizmləri haqqında çoxlu məlumata malik olan və heç bir şəkildə əzablarını yüngülləşdirməyən xəstələrlə qarşılaşa bilər. Hətta psixiatr özü də müəyyən dərəcədə onlardan azad olmur, baxmayaraq ki, təcrübəsi sayəsində onların mənşəyini daha asan başa düşə bilər.

Bu qeydlərə cavab olaraq, özü haqqında həqiqətin qeyri-səmimi olduğu hallarda faydalı olmadığını demək olar. Bəs bu, əsl həqiqət nə vaxt olur? Əgər onlar kimi

Psixoanalitiklər şüurdan sıxışdırılmış və silinmiş şeylərə diqqət yetirirlər. Sonra içimizdə olanı və bizi dəfələrlə qorxudanı həqiqət kimi qəbul edə bilərik və ya həqiqət olaraq üstümüzdə olanı, qəbul ediləni adlandıra bilərik, amma bütün bunlar bizim haqqımızda yalnız qismən bir həqiqətdir.

// MƏNBƏNİN DİGƏR TƏRƏFİ

Qərar qəbul etmənin hər anında əks funksional strukturlar arasında seçim edilir - biri rədd edilir, digəri qəbul edilir və həyata keçirilir, lakin hər biri özümüz haqqında həqiqəti ehtiva edir. Hərəkətlərimiz (yəni funksional strukturların həyata keçirilməsi) başqaları tərəfindən qiymətləndirilir. Lakin, psixiatr üçün daha maraqlı və vacib olan qərar verilməzdən əvvəl baş verən hər şey və onun həyata keçirilməsindən sonra xarici fəaliyyətdə özünü göstərməyən şeylərdir. Mərcənin bu digər tərəfi əksər hallarda patogen amildir. Onun kəşfi xəstəyə rahatlıq gətirir.

Şifahi əlaqə ehtimalı bu əks tərəfi həmişə "rəsmi" deyil, yenə də bu şəxsin xarici tərəfi olan bir fəaliyyət formasına çevirir. İçəridə gizlədilən hər şey atılır (çıxış edir) və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən bir signala çevrilərək adi insan dünyasına daxil olur. Psixiatr, tolerant münasibəti ilə atılmış strukturların "yenidən sosiallaşması" prosesini asanlaşdırır; çox vaxt psixiatr bu strukturların şifahi şəkildə təqdim olunduğu sosial mühitin ilk nümayəndəsidir.

Karikaturalarda tez-tez insanlar başlarının üstündə buxar buludu ilə təsvir olunur, gizli düşüncələri ilə yazılır, məzmunu adətən onların xarici görünüşünə tamamilə zidd olur. Psixiatr bu "buxar buludlarını" oxuyan şəxs ola bilər.

Və oxuduqları vasitəsilə onlar insan signalları dünyasına qəbul edirlər. Bu, müəyyən bir insanın "sikkənin digər tərəfinin" dərk edilməsidir və bunun sayəsində eyni şəxs haqqında iki əks məlumatın birləşməsi ehtimalı artır.

Bir insan haqqında qəti bir həqiqət varmı, yoxsa insan "ziddiyyətlər toplusudurmu?" Psixiatrın xəstənin dərinliklərindən çıxardığı, çox vaxt uzun və uğursuz sınaqlardan sonra, tez-tez bu şəxsin rəsmi xarici görünüşünə tamamilə ziddiyyət təşkil edən və ya psixozda, xüsusən də şizofreniya tipində baş verən kəskin reaksiya şəklində kortəbii şəkildə ortaya çıxan şey, onların əsl simasını nə dərəcədə əks etdirir, yoxsa həqiqət onların gündəlik davranışları ola bilərmi? Eyni sual son dərəcə çətin vəziyyətlərdə də ortaya çıxır. İnsanın əsl simasını yalnız belə vəziyyətlərdə görmək mümkündürmü? Yalnız həyatı təhlükə anında, müharibə zamanı, həbs düşərgəsində və s.? Bir insanın fərqli bir tərəfi ortaya qoyduğu bu tək an, qəti cavaba ehtiyac duyana qədər bütün həyatı boyu sərf etdiyi bütün səyləri silə bilərmi? Görünür, bu suala yalnız Paskalın insanı qiymətləndirmək yanaşmasını mənimsəməklə, yəni bir insanın əksliklərin müəyyən bir sintezini təmsil etməsi ilə cavab vermək olar. Xəstə ilə söhbətlər zamanı tez-tez onlar haqqında əks fikirlər yarana bilər - xəstə kimisə sevib-nifrət etdikdə, onun yaxşı və pis, zəhmətkeş və tənəbəl olması,

şən və kədərli təbiəti, səxavəti və xəsisliyi, təvazökarlığı və

güc ehtiyacı, pedantlığı və diqqətsizliyi. Psixiatr tez-tez bu əks fikirləri uzlaşdırma bilməyərək çətin vəziyyətdə olur.

Xəstənin şəxsiyyət xüsusiyyətləri onun əsl simasını yenidən qurmaq üçün istifadə olunur.

Əks cəhətlər xəstədə yalançılığı göstərmir; əksinə, xüsusiyyətlərin qeyri-müəyyənliyindən yalançı bir mənzərə yaranır, çünki sikkənin digər tərəfi ya nəzərə alınmır, ya da sadəcə nəzərdən qaçırılır.

// İLK TƏƏSSÜR

Bəzən, xəstə ilə çoxsaylı görüşlərdən sonra psixiatr kədərli bir nəticəyə gəlir ki, ilk görüş zamanı xəstənin obrazı onunla sonrakı söhbətlərdən daha başa düşülən və əlçatan olub. Bu təəssüratı yeni bir şəhər, sənət əsəri, yeni bir insan və s. ilə ilk qarşılaşma ilə müqayisə etmək olar. Sonrakı qarşılaşmalar artıq eyni təəssürat zənginliyini buraxmır; çox vaxt ilk görüş daha asan görünən obyektin sintezinə imkan verir. İlk baxışın bu qabiliyyəti, istiqamətləndirmə refleksinin bir az solması və eksteroreseptorların sürətli uyğunlaşması kimi tanınmış fizioloji qayda ilə uyğundur; Siqnal sistemi yaxşı hesabat əsasında işləyir - xarici mühitdən yalnız yeni siqnalları qəbul edir, köhnələrini rədd edir.

Bu qabiliyyət yalnız psixiatrda deyil, həm də xəstədə inkişaf edir. Həkimin ilk təəssüratı çox vaxt onunla qarşılıqlı əlaqəsinin gedişatını müəyyən edir. Buna görə də, xəstə ilə ilk təəssürat və ünsiyyət təkcə psixiatrlar üçün deyil, hər bir həkim üçün vacibdir. Xəstənin etibarını bundan asılıdır ki, bu da yalnız psixiatrik müalicədə deyil, istənilən müalicədə vacibdir.

Xəstə ilə ilk görüş daha çox vaxt tələb edir; tələsməmək lazımdır.

Somatik xəstəlik halında, xəstə ilə hərtərəfli müsahibə aparmaq və hərtərəfli müayinə aparmaq lazımdır. Psixiatriyada anamnestik məlumatların toplanması xəstə ilə çoxlu söhbətlər tələb edir və bu müddət ərzində həkim xəstəni daha yaxşı tanıyır. Buna baxmayaraq, xəstə ilə ilk görüş zamanı mümkün qədər çox məlumat toplamaq lazımdır, yəni xəstəyə şikayət və şikayətlərini sərbəst şəkildə ifadə etməyə imkan vermək və heç olmasa həyat tarixçəsini təxmini qiymətləndirmək lazımdır. Bəzən psixiatr xəstəni səbirlə dinləyən ilk şəxs olur. Özləri haqqında danışmaq üçün bu fürsət xəstəyə həkim tərəfindən başa düşüldüyünə və qəbul edildiyinə inam hissi verir.

PSIXIATRİK ƏLAQƏ

// BIOLOJİ VƏ PSIXOLOJİ FƏRDİLİK

Anlama və qəbul ehtiyacı insan təbiətinin sosial təbiəti ilə bağlıdır. Hər bir insan özünü fərd hesab edir ki, bu da, görünür, hər bir canlı orqanizmin bioloji fərdiliyinə uyğun gəlir.

İnsan tez-tez öz sözlərini və hərəkətlərini daxilində mövcud olan hər şeyi örtən xarici maskanın ifadəsi kimi görür və sosial mühitin təzyiqi səbəbindən onun geyinilməsini zərurət kimi qəbul edir. Digər tərəfdən, insan mütləq fərdilik istəmir, çünki bu, başqaları tərəfindən başa düşülməyə və ya qəbul edilməyə bilər.

Başqalarının oxşar vəziyyətlər yaşadığının fərqi olmaq, insanı təkliddə dəstəkləyir ki, bu da digər şeylər arasında bioloji fərdilikdən irəli gəlir.

Hətta psixoloji fərdiliyin bioloji fərdiliklə ayaqlaşma bilmədiyini demək olar. Orqanizm öz bioloji fərdiliyini təbiətinin bütün qüvvələri ilə artıq strukturunun ən aşağı səviyyələrində, yəni biokimyəvi səviyyədə immunoloji reaksiyalar vasitəsilə müdafiə edir. Digər tərəfdən, psixoloji fərdilik,

Daim statusunda qalır, xarici aləmdən gələn yeni məlumatlarla daim zənginləşir. Öz unikalılığı hissi insan oxşarlığı hissi ilə mübarizə aparır; "biz" əvəzliyi, xüsusən də yeni və çətin vəziyyətlərdə "mən" əvəzliyini üstələyir.

Bir çox hallarda zehni patologiya, ən azı sosioloji baxımdan, "biz"dən "mən"ə həddindən artıq keçid kimi qiymətləndirilə bilər. Canlı bir orqanizmə açıq bir sistem, yəni ətraf mühitlə daim enerjili və informasiya mübadiləsində qalan bir sistem kimi baxdıqda, onun fərdiliyinin ən aşağı molekulyar səviyyədə (biokimyəvi fərdilik) ən çox ifadə olunduğunu və daha yüksək səviyyələrdə - sitoloji (hüceyrə), anatomik, fizioloji və nəhayət, psixoloji səviyyədə daha az ifadə olunduğunu söyləmək olar.

Bu daha yüksək səviyyələrdə ətraf mühitdən elementlərin nüfuz etməsinə qarşı müdafiə olduqca zəifdir, ən azı aşağı səviyyələrdəki qədər dramatik deyil. Bu başa düşüləndir, çünki əks halda həyatın mahiyyətini təşkil edən xarici mühitlə mübadilə mümkün olmazdı. Görünür, orqanizmin inteqrasiyasının ən aşağı səviyyəsində öz fərdiliyini qorumağın dramatik təbiəti, bu mübadilə zamanı enerjili və informasiya elementlərinin orqanizm tərəfindən öz strukturunu qurmaq üçün istifadə edilə biləcək bir azalmaya məruz qalması faktından irəli gəlir. Bu ən aşağı səviyyədə yadlıq atılır, çünki daha sadə elementlərə parçalanma qeyri-mümkün olur.

Bioloji təbiətli bu ümumi müşahidələr həkim və xəstə arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdə müəyyən əhəmiyyətə malikdir. Aralarındakı məlumat mübadiləsi öz izini qoyur. Həm xəstə, həm də həkim bu qarşılaşmadan bir şey qazanır. Lakin onların hər biri öz strukturunu saxlayır, çünki bu mübadilənin təsiri altında başqası ola bilməz. Nəzəri olaraq, hipnoz zamanı belə yaxın, spesifik təmasda belə bir ehtimal mövcuddur. Hipnoz edilmiş subyekt hipnozçunun təklifinin təsiri altında dəyişə bilər, lakin bu dəyişiklik yalnız müəyyən dərəcədə isterik və ya infantil şəxsiyyət xüsusiyyətləri olan xəstələrdə müşahidə olunan dəyişikliyə bənzəyir, onlar terapevti məmnun etmək və ya əksinə, narazı salmaq və ya hətta qəzəbləndirmək üçün "dəyişirlər".

Bu o demək deyil ki, insan başqa bir insanın təsiri altında dəyişə bilməz. Lakin, bu dəyişiklik enerji mübadiləsində olduğu kimi, tam assimilyasiyaya əsaslanaraq baş verməlidir: kənardan gələn hər şey öz struktur planına uyğun olaraq yenidən formalaşmalıdır, necə ki, yad zülal assimilyasiya prosesləri vasitəsilə öz zülalına çevrilir.

Psixoterapevtlər, xüsusən də gəncliyin qızgın illərində, bəzən bu psixoloji və bioloji fərdiliyi unudurlar. Onlar xəstəni dəyişdirmək istəyirlər, amma istəkləri nə qədər güclüdürsə, məyusluqları bir o qədər çox olur, çünki gözlənilən dəyişiklik əvəzinə xəstədən çox güclü müqavimətlə qarşılaşırlar (mexanikanın hərəkətin reaksiyaya bərabər olduğu qaydasına görə). Həqiqətən də, xəstələr psixiatrla təmasın təsiri altında dəyişirlər, lakin onlar müstəqil şəkildə dəyişirlər, həkim onları dəyişdirmir. Maddələr mübadiləsi prosesi aktivdir; canlı orqanizm özü xarici mühitdən nə götürməli olduğunu seçir; onun fəal iştirakı olmadan heç nə mübadilə edilə bilməz.

Əks təqdirdə, yalnız protez və ya transplantasiya olardı və buna görə də, transplantasiya vəziyyətində olduğu kimi, bədənin rədd edə biləcəyi yad bir şey olardı.

// SÜKÜTLÜK QIZILDIR

Xəstə haqqında həqiqəti onlara gümüş lövhədə vermək olmaz; onlar bunu özləri kəşf etməlidirlər. Psixiatrla əlaqə yalnız özünü kəşf etmə prosesini sürətləndirməlidir. Psixiatr bu proses üçün "katalizator" rolunu oynayır. Onlar nə qədər az danışsalar, xəstənin özünü kəşf etməsinə bir o qədər az müdaxilə edir və daha yaxşı kataliz aparmağa kömək edir. Nitq, xüsusilə insan siqnallarını başqalarına ötürməkdən ibarət olan aktiv bir formadır. İki nəfər eyni vaxtda hərəkət edə bilməz; biri siqnalları "göndərəndə", digəri siqnalları "qəbul edir". Psixiatr danışmağa başlasa, xəstə özü haqqında danışmağı dayandırır. Özü haqqında danışmaq asan deyil; insan bir çox daxili reaksiyaları, ən azı utanc və səhv başa düşülmək qorxusunu dəf etməlidir. İnsan hiss etdiklərini və yaşadıklarını sözlə ifadə etmək çətinliyini dəf etməlidir. Psixiatr ən uyğun olmayan anda, məsələn, xəstə özü haqqında çox vacib hesab etdiyi bir şeyi demək istədiyi, lakin bunu sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyi zaman xəstəni kəsə bilər; onlar hələ nə deyəcəklərinə və ya ümumiyyətlə deyəcəklərinə qərar verməyiblər. Psixiatr söhbətə müdaxilə etdikdə və tez-tez xəstəni çətin vəziyyətdən xilas etdikdə, xəstə danışmağı dayandırır və sonra danışanın təklif etdiyi başqa bir mövzuya keçə bilər. Buna görə də, sükut sənəti psixiatr üçün çox vacibdir.

Lakin, bu sükut mütləq ola bilməz; belə sükut narahatlıq hissi yaradacaq və siqnal mübadiləsinin ümumi qəbul edilmiş qaydasına uyğun gəlməyəcək,

yəni göndərilən siqnal ətraf mühitdə reaksiya doğurur və bu da öz növbəsində geribildirim siqnalına çevrilir və sonrakı siqnalları modulyasiya edir. Psixiatr söhbətin ümumi axınına baxışlar, üz ifadələri, jestlər və xəstəni hekayəsini davam etdirməyə təşviq edən incə şərhlerle cavab verir. Bu tip geribildirim siqnalları tez-tez xəstənin hekayəsinin məzmununa böyük təsir göstərir; onların təsiri altında xəstə danışmağı dayandırır, söhbətin məzmununu dəyişir, psixiatrdan inciyir və s. bilər. Psixiatr yuxarıda qeyd olunan sükutun qızıl olduğu qaydasına riayət etməlidir,

çünki onlar xəstəni səhv başa düşə bilərlər və ikincisi, onların təfsiri xəstə tərəfindən fərqli şəkildə qəbul edilə və başa düşülə bilər. Bəzən həkim xəstənin sözlərini sitat gətirərək səhv şərh etdikdə həqiqətən təəccüblənir. Öz təcrübələrinin şifahi ünsiyyəti digər şifahi ünsiyyət növləri arasında təhriflərə ən çox məruz qalır. Hər bir hərəkət kimi ən yüksək hərəkət formalarına aid olan nitq xarici aləmə yönəldilir. Buna görə də, xarici aləmin hadisələrini təyin edən lüğət daxili aləmin hadisələri üçün istifadə edilən lüğətdən xeyli böyük və zəngindir. Ən güclü təcrübələrimizi təsvir edərkən, biz zəif ifadəyə məhkumuq. "Sevgi", "qorxu", "nifrət" sözləri, onlarda ifadə olunan duyğuların məzmunu və dərəcəsi müxtəlif ola bilsə də, eyni sözlər olaraq qalır. Təcrübələr nə qədər intensiv olarsa, şifahi ifadənin qeyri-kafiliyindən qaynaqlanan təhriflər bir o qədər çox olar, çünki dil spesifik deyil, adi təcrübələrə uyğunlaşdırılıb. Xəstənin təcrübələrini təsvir edərkən həmişə onun çətinliklərini nəzərə almaq lazımdır. Şifahi ünsiyyətin ilk təhrif olunması, söhbətin lap əvvəlindən özünü, xüsusən də ümumi və uşaq psixiatriyası hallarında özünü göstərən təcrübələrini ifadə etməkdə çətinlik çəkmə nəticəsində ortaya çıxır. Ruhi xəstənin təcrübələri hər dilin uyğunlaşdığı "ümumi dünya"dan kənara çıxır və uşağın nitqi hisslərini ifadə etmək üçün kifayət qədər strukturlaşdırılmayıb. İkinci deformasiya psixiatrın xəstənin sözlərini düzgün başa düşə bilməməsindən irəli gəlir. Psixiatrın xəstənin dediklərini başa düşməsinə onun digər xəstələrin oxşar təcrübələrini bilməsi, üz ifadələrini, jestlərini anlamaq qabiliyyəti kömək edir.

Xəstənin səs modulyasiyaları, emosional vəziyyətini və nəhayət, xəstənin daxili dünyasına nüfuz etmək qabiliyyətini əks etdirir. Dəqiq müəyyən edilməsi çətin olan bu son qabiliyyət, xəstənin nələr yaşadığını təsəvvür etmək qabiliyyətindən ibarətdir. Artıq qeyd edildiyi kimi, əgər kimsə ona qarşı müsbət münasibət bəsləməsə, onun hisslərinə empatiya qurmaq mümkün deyil. Hər hansı bir mənfi əhval-ruhiyyə insanı hisslərinin obyektindən uzaqlaşdırır və bununla da onun başa düşməsinə mane olur. Daha sonra anlama səthi hala gəlir, yalnız insanın pis olduğunu sübut edən və ya onun pis niyyətlərini göstərən xarici faktları qəbul edir.

Üçüncü deformasiya, bu halda, psixiatr üçün şifahi ifadənin çətinliyidir. Onlar dəfələrlə xəstə haqqında düşündükləri hər şeyi, mövcud təcrübələrini necə başa düşdüklerini sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Onların formulları bəzən qeyri-dəqiq ola bilər. Və sonra xəstənin onları dinləyəndə həkim tərəfindən səhv başa düşüldüyünə inanması təəccüblü deyil, baxmayaraq ki, əslində psixiatr onu düzgün başa düşüb, yalnız öz baxış bucağını yöndəmsiz şəkildə ifadə edib. Həmçinin yadda saxlamaq lazımdır ki, psixiatriin sözləri xəstə tərəfindən qəbul edilmə prosesində deformasiyaya uğrayır. Çox vaxt xəstə yalnız onun üçün müsbət olanı, özünə hörməti və ya münaqişə vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə uyğun gələnı seçir və ya psixiatra qarşı müdafiə mövqeyi tutmağa imkan verir, çünki psixiatr onları başa düşmür və sonra onların köməyindən imtina etməli olur.

Yuxarıda təsvir edilən şifahi ünsiyyətdəki dörd transformasiyanı nəzərə alsaq, təriflərimizdə çox diqqətli olmaq lazımdır, hətta onlar demək olar ki, xəstənin düşüncələrinin sözbəsöz təkrarı olsa belə. Sözlərimizin səhv şərh olunması həmişə mümkündür.

// SÖZDƏNKƏNAR ƏLAQƏ

Üz ifadələri, jestlər və sair kimi sözdənkənar işarələr psixoterapevtik təmasda xüsusilə vacib rol oynayır. Əksər hallarda, onlar şifahi işarələrdən fərqli olaraq iradədən asılı deyillər. Üz ifadələri, jestlər və səs modulyasiyası müəyyən dərəcədə idarə oluna bilər, lakin xəstə, uşaq kimi, maskanı asanlıqla tanıyır və aldadıcılığı hiss edir. Maskanın altından qeyri-iradi olaraq xarici aləmə həqiqi emosional reaksiya siqnalları nüfuz edir: kəskin və ya "məyusedici baxış", qıcıqlanmış üz ifadəsi, narahat jest. Psixiatr maska taxa bilməz; bu, xəstənin qorxusunu artırır. Nevrozlu bir xəstə, daha da çox, psixozlu bir xəstə, xarici mühitdən gələn geribildirim siqnallarına, yəni başqalarının onlara reaksiyasına xüsusilə güclü reaksiya verir. Təhlükəsizlik hissi xəstə üçün səthi təsdiqdən daha vacibdir, çünki heç kimin altında nəyin olduğunu bilmədiyini gizlədir. Gündəlik sosial qarşılıqlı əlaqələrdə adi dostluq formaları qəbul edilir, çünki insanlar arasında əlaqə olduqca səthi olur; onlar müəyyən bir sosial sərhəd ilə ayrılır. İnsanlar yaxın münasibətlərdə və ya qarşılıqlı asılılıq hallarında və ya bir şəxs digərini təhdid etdikdə maska kifayət etmir. Sonra hər bir əhəmiyyətsiz görünən jest, baxış və ya üz ifadəsi nəzərə alınır.

Psixiatrla xəstə arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə qarşılıqlı, qeyri-bərabər siqnal mübadiləsi baxımından baxılmalıdır. Psixiatr xəstənin verbal və ekstraverbal siqnallarından istifadə edir, xəstə isə əsasən yalnız ekstraverbal siqnallardan istifadə edir. Heç bir xəstə psixiatrdan özü haqqında danışmasını gözləmir.

Başqa bir şəxslə hər təmasda "Bu necə insandır?" sualına cavab gözlənilir və bu sual əsasən psixoloji qiymətləndirməni nəzərdə tutur. Psixiatr və ya psixoloq bu suala peşəkarcasına uyğunlaşır. Xəstə də bu sualı özünə verir, lakin onların cavabı daha kiçik məlumat bazasına əsaslanır. Adətən, xəstə psixiatrın və ya psixoloqun onlarda qoyduğu təəssürata güvənir. Və bu ümumi təəssürat əsasən sözdənkənar işarələrə əsaslanır. "Bu necə insandır?" sualına cavab verərkən xəstə digər şəxs haqqında həqiqəti tapmağa, taxdığı maskanı nüfuz etməyə çalışır.

Buna görə də, psixiatrik təmas zamanı xəstəyə qarşı səmimi emosional münasibət vacibdir. Şirin sözlər, sakit üz ifadəsi və s. emosional reaksiyalar mənfi olarsa (qorxu, təcavüz, ikrah və s.) kömək etmir.

Həkimin mənfi əhval-ruhiyyəsi xəstənin münasibətlərinin zəifləməsinə səbəb olur. O, demək istədiyi hər şeyi deməyəcək, susur və ziyarətlərə gəlməyi dayandırır. Ruhi xəstələrdə bu vəziyyət daha da özünü göstərir. Reaksiya tez-tez qəfil baş verir; həkimin xəstəyə qarşı gizli mənfi münasibəti qorxu və aqressiyaya səbəb olur.

// "PSIXOLOJİ DUYĞU"

Uşaqlar emosional reaksiyaları asanlıqla qavrayırlar. Məlumdur ki, uşaqlar sadəcə olaraq

təbii olaraq "şirinlik"ə dözə bilmirlər; "şirinlik"lərinin altında uşaqlar

laqeydlik və ya düşmənçilik hiss edirlər. Körpələr anaları onları böyük sinir gərginliyi altında yedizdirdikdə qusma, qışqırıq və ağlama ilə reaksiya verirlər və bunu boş yerə sülh maskası ilə gizlətməyə çalışırlar. Vəziyyətə qarşı bu həssaslıq heyvanlarda da müşahidə edilə bilər; it, göstərmək istəməsə də, qorxu ilə yaxınlaşdıqda aqressiv olur. Sahibi sakit bir görünüş saxlamağa çalışsa da, it tez-tez sahibinin əhval-ruhiyyəsini hiss edir.

Bütün bunlara "psixoloji intuisiya" və ya "başqasının ruhi vəziyyətini hiss etmək" və ya daha dəqiq desək, "başqasının emosional vəziyyətini hiss etmək" deyilə bilər.

Psixiatrlar arasında Stek Sallivan bu məsələni araşdırdı. O, insanlar arasında ünsiyyətin üç növünü ayırd etmişdir: prototaktik, parataktik və sintaktik.

Birincisi, adətən körpələrdə baş verən emosiyaların bir insandan digərinə birbaşa ötürülməsindən (sözde empatiya) ibarətdir. İkinci növdə, emosiyalar signal - jest, üz ifadəsi, sözlər və s. vasitəsilə ötürülür. Signal sehrli güc qazanır və təmasda olduğumuz insanda gözlənilən effektə səbəb olur; məsələn, uşağın təbəssümü ananın təbəssümünü xatırladır. Bu ünsiyyət növü anal inkişafın (3-6 il) dövrü üçün xarakterikdir və Sullivana görə, regressiya şəklində şizofreniyada özünü göstərir. Və nəhayət, üçüncü ünsiyyət növü, bütün zehni funksiyaların - idrak, emosional və iradi - iştirak etdiyi başqa bir insanın tam anlaşılmasını əhatə edir. Lakin, fərz etmək olar ki, insan inkişaf etdikcə hərəkətə getdikcə daha çox uyğunlaşır və buna görə də başqa bir insanın necə hiss etdiyinə getdikcə daha az diqqət yetirir; onlar əsasən davranışlarına diqqət yetirirlər.

Başqa sözlə, şəxslərarası təmaslarda maska insanın faktiki emosional vəziyyətindən daha böyük rol oynayır.

Yaş artdıqca insan fitri psixoloji intuisiyasını itirir, bu keyfiyyət isə insanın başqa bir insanın emosional vəziyyətini dərhal hiss etməsinə imkan verir. Bioloji baxımdan, o, ətraf mühətdə mühüm istiqamətləndirici rol oynayır.

Dünya və digər insanın emosional vəziyyətinin necə qəbul edilməsindən asılı olaraq, əlaqə qurulur və ya əksinə, əlaqə zəifləyir,

və ya daha da çox, şəxsə hücum edilir. Ontogenez zamanı, dəqiq davranış formaları inkişaf etməmişdən əvvəl, ətraf mühitdə iki vektordan ibarət olan əsas hərəkət forması artıq ortaya çıxır:

"əvvəl" və "dan", bu da itələmə və geri çəkilmə və ya

müsbət və mənfi şərtsiz reflekslər kimi anlayışlara uyğundur. Ətraf aləmdə və şəxsi (subyektiv) aləmdə bu əsas hərəkət forması iki fundamental emosional reaksiyaya uyğundur: "əvvəl" - sevgi və "dan" - nifrət və qorxu.

Zehni və əsəbi xəstələr ətraf aləmdə zəif uyğunlaşır və bu, onların maskalara qarşı həssaslığını və zehni cəhətdən sağlam insanlardan daha çox başqa bir insanın əsl emosional vəziyyətini müəyyən etmək qabiliyyətini izah edə bilər. Bunun bütün ruhi xəstəliklərə xas olan ontogenetik inkişafın erkən mərhələlərinə regressiyadan qaynaqlanması mümkündür.

Praktik baxımdan, müalicə qrupunun hər bir üzvü (psixoloq, sosioloq, tibb bacısı, baxıcı və s.) kimi psixiatr üçün də xəstəyə qarşı səmimi emosional münasibət inkişaf etdirməyə çalışmaq vacibdir. Öz hisslərini gizlətmək gündəlik həyatda təsirli olsa da, əqli və sinir pozğunluqları olan xəstələrin müalicəsində uğursuz olur. Maska altında naməlum bir şeyin gizləndiyi üçün onların narahatlığını artırır.

Müalicə qrupunun üzvü, hər bir insan kimi, mənfi emosiyalardan azad deyil və xəstə qorxu, ikrah, qınaq və təcavüz hissləri oyada bilər. Əlbəttə ki, kiminsə müalicə qrupunun üzvü olması onların bu hissləri ifadə etməsinin qarşısını alır; lakin onları gizlətmək təsirsizdir. Xəstəyə qarşı tolerant münasibət inkişaf etdirmək lazımdır ki, bu da mənfi emosiyaları dərhal aradan qaldırır. İlk təmasda xəstə şışirdilmiş simptomları, kobud davranışları, yaxınlarına qarşı pis münasibəti ilə "əsəblərini poza" və ya sadəcə psixiatra tanış olduğu xoşagəlməz bir insanı xatırlada bilər. Lakin, həkimin xəstəyə qarşı belə ilkin mənfi münasibəti, adətən, xəstə ilə daha yaxın münasibət qurulduqca dəyişir. Xəstənin həyat hekayəsini öyrənərək və onun təcrübə dünyasına daxil olmaqla, psixiatr xarici davranışın təəccüblü formalarını görməyi dayandırır. Bir insanın daxili tərəfini tanımaq onun xarici tərəfinə qarşı tolerantlığı artırır. // DUYĞU MÜNASİBƏTİ Gündəlik həyatda insan özünü xarici dünyaya münasibətdə iki qütb - müsbət və mənfi - arasında tapır. İnsan qorxu, nifrət, xor baxma və insanlara qarşı digər mənfi hisslərdən qaça bilməz. Sosial həyat daim mühakimə tələb etdiyi üçün İncilin "Mühakimə etməyin, yoxsa məhkum olunacaqsınız" ayəsinə də əməl etmək olmaz. Bunlardan bəziləri solda, digərləri sağdadır: solda olanlar mənfi emosional hisslərə məhkumdurlar. Ruhi xəstələrlə təmasda olduqda, şəxslərarası münasibətlərin mənfi tərəfini atmaq lazımdır; xəstəyə qarşı mühakimə (mühakimə) münasibəti qəbul etməməli və ona yığılmış mənfi hisslərlə yanaşmamalıdır. Psixiatriya xəstəxanalarının köhnə adı — asil — düzgündür, çünki xəstələrin, xüsusən də ruhi xəstələrin yerləşdiyi yer "azad" olmalıdır.

"zorakılıq" (yunanca "asyllos" sözünün hərfi mənası). Mənfi hisslər,

mənfi qiymətləndirmə zamanı hakim münasibəti,

başqa bir şəxsə hücum kimi qəbul edilə bilər. Bu hücum qarşı insan özünü müdafiə etməlidir və xəstə insan belə müdafiəyə qadir deyil. Bu, somatik xəstəlik halında başa düşüləndir. Ruhi xəstə insan qayğıya ehtiyacı olmayan biri kimi görünə bilər, amma o, daha

müdafiəsizdir; "asyl" sözündə olan təhlükəsizlik hissi və sakit atmosfer onun üçün somatik xəstəliyi olan xəstədən daha vacibdir. Somatik xəstəliyi olan xəstə,

hər şeyə baxmayaraq, yenə də insan cəmiyyətinə aiddir,

ruhi xəstə isə oradan uzaqlaşdırılır (əgər o, kiçik psixiatriyaya aiddirsə) və ya tamamilə rədd edilir (əsas psixiatriyaya aiddirsə). Psixiatrların və xəstəxana işçilərinin xəstəyə verə biləcəyi şey anlayış və kiçik bir ürəkdir. Bu, həddindən artıq sentimental səslənə bilər, amma bu doğrudur.

Nəticədə, bu, yalnız ruhi xəstələr üçün deyil, texniki tibb dövründə getdikcə daha az hiss və anlayış alan hər bir xəstə üçün problemdir. Psixiatrik xəstələr üçün bu problem çox vacibdir. Xəstəyə münasibət düzgün deyilsə, bütün müalicə üsulları təsirsiz olur. Psixiatriyada, hətta eyni dərmanlar və müalicə üsulları ilə belə, sıfırdan yüzə qədər belə kəskin fərqlərin mənbəyi, yəqin ki, budur!

// "PSIXIATRİK ÜÇBUCAQ"

Psixiatriyada diaqnostik proses (xəstəni tanımaq) terapevtik proseslə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Xəstəni tanımaqla eyni zamanda onların özlərini tanımalarını asanlaşdırırıq. Psixiatrik əlaqə sxematik olaraq üçbucaq kimi təmsil oluna bilər: onun əsası xəstə ilə psixiatr arasındakı emosional əlaqə ilə formalaşır və zirvədə xəstə və onlarla söhbətdir. Lakin bu, real insan deyil, xəstə və psixiatr tərəfindən yaradılan onun obrazıdır (əsl insan üçbucağın əsasını məhdudlaşdıran nöqtədir). Bu obrazın yaradılması müəyyən dərəcədə psixiatr və xəstə arasında ortaq bir vəzifədir. Əlbəttə ki, bu obrazlar bir-birindən fərqlənə bilər və onların fərqləri ilkin təmaslarda xüsusilə nəzərə çarpır, lakin xəstə özünü daha yaxşı tanıdıqca və psixiatr xəstəni daha yaxşı tanıdıqca tədricən azalır. Bu, psixiatrın xəstəyə xəstəyə necə baxdığını göstərəcəyi, "Sən beləsən, elə deyil" deyəcəyi və ya problemlərini göstərəcəyi anlamına gəlmir. Lakin bəzən söhbət çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə bu, zəruri hala gəlir.

Üçbucağın əsası xəstə ilə həkim arasındakı söhbətlər zamanı yaranan emosional əlaqələrin dinamikasını təmsil etməlidir. Üçbucağın tərəfləri isə hər iki iştirakçının xəstəni (zirvəni) tanımağa yönəlmiş idrak səyini təmsil edir. Bu model psixiatrik diaqnostik və terapevtik prosesdə iki vacib amili təmsil edir: emosional və Koqnitiv. Proses hər iki amili tənzimləməyə yönəlib. O, insanda entropiyanın - pozğunluq və xaosun - yatmış meyllərinə qarşı çıxır və buna görə də hər iki tərəfdən səy tələb edir.

PSIXOTERAPIYA

// ƏN YAXŞI METOD

Əksər psixiatrlar psixoterapiyanı nevrozların ən yaxşı müalicəsi hesab edirlər.

Farmakoterapiya, yaşayış şəraitində dəyişikliklər, sanatoriya müalicəsi və s. kimi digər üsullar nevroitik simptomları azalda və ya hətta tamamilə aradan qaldıra bilər, lakin onlar nevroitik davranışı davam etdirən psixiyanın mənbəyini aradan qaldırmır.

Həm ətraf mühitlə, həm də özünə münasibətdə emosional təzahürlər. Yalnız psixoterapiya prosesində bu münasibətlər dəyişə bilər.

Bu baxış iki əsasə əsaslanır: biri nevrozların genezisi, ikincisi isə psixoterapiyanın təbiəti ilə bağlıdır. Nevrozlarda psixoloji

səbəb-nəticə əlaqələri qurula bilər və buna görə də psixoloji müdaxilə, yəni psixoterapiya, bu

əlaqələrin adətən görünməz olduğu psixozlardan fərqli olaraq ən uyğun müalicə metodlarından biridir. Buna görə də, psixozlarda somatik

müalicə metodlarından istifadə edilməlidir. Başqa sözlə, psixoloji səbəb psixoloji müalicə tələb edir;

naməlum səbəb somatik müalicə tələb edir. Bu cür mühakimə insan təbiətinin dualist konsepsiyasına əsaslanır. Səbəb-psixoloji münasibətlər

səbəb-nəticə somatik münasibətlərdən ayrıca nəzərdən keçirilir.

Nəzəri baxımdan, bu mühakimə doğru hesab edilə bilər, çünki somatik təzahürlərin öyrənilməsi təbiətə zehni təzahürlərdən fərqlidir. Praktik baxımdan bu mövqe əsassızdır.

Hər bir praktik həkim bilir ki, bir qrup fenomendəki və digərindəki səbəb-nəticə əlaqələri bir-biri ilə əlaqəlidir. Deyilənə görə: "Əməliyyat uğurlu oldu, amma xəstə öldü", somatik terapiya müvafiq psixoterapevtik proseslə birləşdirilmədikdə istənilən nəticəni verməyə bilər. Digər tərəfdən, nevrotik sindromların tez-tez danılmaz psixoloji səbəblərlə xarakterizə oluna biləcəyi, lakin sonradan əsas nevrozun somatik xəstəlik olduğu aşkar edildiyi məlumdur. Məlumdur ki, həkim xəstəyə yalnız müalicəyə olan inamla, varlığı ilə və s. kömək edə bilməz. Somatik xəstəliklərdə isə, digər tərəfdən, xəstənin zehni vəziyyətinin pisləşməsinin fiziki vəziyyətinin pisləşməsinə və hətta ölümünə səbəb ola biləcəyi məlumdur.

Təcrübəli həkim xəstəyə hər tərəfdən yanaşmalıdır. Bu vəziyyət hətta ən təcrübəli psixoterapevti belə məcbur edir.

Tez-tez nevrozlarla hər şeyin psixoloji çərçivəyə uyğun olduğu görünür, lakin

bir çox sualın izahat tələb etməsi mümkündür. Məsələn, sırf emosional amillər

bədəndə daimi və davamlı nəticələr yarada bilər. Ən yaxşı nümunə

psixosomatik xəstəliklərdir.

Nevrozların bir çox halında, vegetativ və endokrin sistemlərin konstitusional zəifliyi, emosional stress vəziyyətlərində tam səfərbərliklə onların həddindən artıq reaksiyasına meyillilik mövcuddur ki, bu da öz növbəsində bədənin sürətli tükənməsinə səbəb olur. Obsesif-kompulsiv pozğunluqda simptomların davamlı təbiəti mərkəzi sinir sisteminə əvvəllər müəyyən edilməmiş zədələnmə şübhəsini yaradır. Emosional vəziyyətlərin sinir sisteminin icra funksiyalarına asanlıqla ötürülməsi isterik nevrozdan əziyyət çəkən insanlarda inhibisiya proseslərinin zəiflədiyini göstərə bilər. Lakin nevrozların psixoloji genezisini inkar etməməklə yanaşı, onların inkişafında rol oynayan somatik amilləri də görməzdən gəlmək olmaz. Bu amillər hələ kifayət qədər aydınlaşdırılmayıb və sinir sisteminin, xüsusən də vegetativ və endokrin sistemlərin genetik olaraq müəyyən edilmiş meyli və ya bu sistemlərdə güclü emosional amillərin və ya fiziki travmanın (mexaniki, toksik, yoluxucu və s.) təsiri altında dəyişikliklər kimi müəyyən edilir. Nevroz və "pseudonevroz" arasındakı sərhəd həmişə bulanıqdır və diaqnoz qoymaq çətinidir. Eyni şey psixopatiya və karakteropatiya arasındakı sərhədə də aiddir. Xarakteropatiya (characteropathia) termini Tadeuş Bilikieviç tərəfindən mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif üzvi zədələnmələrindən qaynaqlanan psixopatik dəyişiklikləri ayırd etmək üçün təqdim edilmişdir.

Sistemlər.

"Psixoterapiya" termini bu metoddə terapeutik amilin farmakoterapiyada farmakoloji təsir, hidroterapiyada suyun istifadəsi, rentgen terapiyasında isə şüalanma olduğu kimi zehni təsir olduğunu göstərir. Zehni qarşılıqlı təsir insanlar arasındakı hər bir təmasda mövcuddur. Üstəlik, hətta insan-heyvan təmaslarında belə eyni fenomen müşahidə edilə bilər. Yəqin ki, bu, heyvanların özləri arasında da mövcuddur. Bu qarşılıqlı təsir başqa bir insanın təsiri altında təcrübə və davranışda dəyişiklik kimi təyin edilə bilər və sözlərdə, üz ifadələrində, jestlərdə və nəhayət, digər insanın iştirakı ilə özünü göstərə bilər.

Bu, sözün tam mənasında fiziki təsir deyil, çünki digər şəxs mexaniki, istilik, elektrik və ya kimyəvi enerjiden təsirlənmir.

Fiziki stimullaşdırma tibbdə geniş istifadə olunur və texniki tibbin inkişafına əsasən bərabər olan elmi tibbin inkişafı sayəsində, zehni stimullaşdırmanı arxa plana keçirərək, terapiyada böyük rol oynayır. JB

Köhnə günlərdə həkimlər əsasən psixoloji stimullaşdırma metodlarından istifadə etməyə məcbur idilər.

Zehni stimullaşdırma hansısa naməlum və sirli "psixi enerji" vasitəsilə stimullaşdırma demək deyil. Eynilə, fiziki stimullaşdırmada olduğu kimi, burada da müxtəlif enerji növləri işləyir, lakin rol oynayan enerjinin miqdarı və keyfiyyəti deyil, əhəmiyyəti. Bədəndə əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratmaq üçün minimum miqdarda enerji kifayətdir. Pıçıldanan bir söz maşının dəhşətli səs-küyündən daha əhəmiyyətli ola bilər; yüngül toxunuş güclü zərbədən daha böyük reaksiyaya səbəb ola bilər. Enerji mübadiləsini hər bir orqanizmin vacib xüsusiyyəti kimi nəzərə alsaq, fiziki stimullaşdırmanın enerji mübadiləsi çərçivəsində, zehni stimullaşdırmanın isə informasiya mübadiləsi çərçivəsində olduğunu deyə bilərik.

Enerji mübadiləsi sahəsinə yönəlmiş müasir tibbin inkişafında müəyyən bir uyğunsuzluq müşahidə etmək olar, halbuki filogenetik inkişaf insanları signal mübadiləsi baxımından ön plana çıxarıb, çünki enerji mübadiləsində insanlar heyvanlar aləminin üzvlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmirlər. Təbabətin spesifikasiyi ilə insan təbiətinin xüsusiyyətləri arasındakı bu ziddiyyət, ehtimal ki, müasir tibbin insanlaşdırılmasının əsasını təşkil edir. Yalnız informasiya mübadiləsinin sərhədləri daxilində uyğunlaşan bir metod kimi psixoterapiyanın inkişafı, dinamik prosesini yavaşlatmaq çətin olan tibbin texnikləşdirilməsinə qarşı bir antidotum ola bilər.

Onu dayandırmaq elmi tibbin inkişafına mənfi təsir göstərə bilər.

// ÜMUMİ HƏYAT

İnsanların bir-birlərinə yaxınlaşdıqları və ya bir-birlərindən uzaqlaşdıqları, başqalarına təsir etdikləri və ya özlərinin başqalarının təsiri altına düşdükləri qarşılıqlı zehni təsir, həyatın sosial təbiətindən irəli gəlir. Canlı orqanizm tək ola bilməz.

Tənhalıq, ən azından cinsi çoxalmanın mövcud olduğu növlərdə növlərin məhv olmasını təhdid edir və onlar böyük əksəriyyəti təşkil edirlər. Üstəlik, öz həyatını və növün həyatını qorumaqla bağlı səylər təcrid olunmuş vəziyyətdən daha asan olur. Həyat fenomeni entropiyanın ümumi qaydasına o qədər fəvqəladə və kəskin ziddiyyətlərə aiddir ki, görünür, bir qrupda birləşmək meylli zəruridir. Genetik planların istehsalında təbiətin zahirən lazımsız israfçılığı, bunlardan yalnız

Az sayda insanın gerçəkləşəcəyi (ömür boyu istehsal olunan sperma və xayaların sayını nəsillərin sayı ilə müqayisə etmək olar) həyatın kollektiv təbiətinin sübutlarından birini təşkil edir. Bu israfçılıq həyatın tənha təbiətinə qarşı bir növ təminat yaradır. Həyatın sosial təbiətini yalnız insan cəmiyyətində və heyvanlar aləmində deyil, həm də bitkilər arasında izləmək olar.

Təşkilatlanma forması nə qədər yüksəkdirsə və buna görə də entropiya qaydasından nə qədər çox kənara çıxma və onu qorumaq nə qədər çətin olarsa, sosial həyata ehtiyac bir o qədər aydın olur. Bu mənada insanlar bütün canlılar arasında ən sosial varlıqlardır.

Psixi təsir yalnız orqanizmin signal sisteminə malik olduğu zaman müzakirə edilə bilər. Signal enerji dəyərinə deyil, mənaya əsaslanan yeganə məlum hərəkət vasitəsidir. Signal orqanizmin davranışını dəyişdirə bilər və buna görə də onun idarəetmə sisteminə təsir göstərir. İnformasiya mübadiləsi sayəsində canlı orqanizmlər bir-biri ilə ünsiyyət qura və bir-birinə təsir edə bilərlər; onlar tənhalığa məhkum deyillər.

/ PSIXOTERAPIYANIN GENİŞ VƏ DAR ANLAYIŞI

İnsanlar arasında psixoloji təsirin bir çox formalarından psixoterapiya həkim-xəstə münasibətləri üçün ayrılmış formaya aiddir. Bu, psixoterapiyanın çox geniş bir anlayışıdır. Xəstəliyin spesifik təbiətindən, xəstənin hazırkı vəziyyətindən, həkimin şəxsiyyətindən və tibbi ixtisasından, mövcud tibbi adətlərdən və s. asılı olaraq müxtəlif növ psixoloji müdaxilələri əhatə edir. Psixoterapiyanın bu geniş anlayışı, onu nevrozların müalicəsi üçün ən yaxşı metod kimi görən psixiatrlarla müqayisə edilir. Nevrozların psixoloji səbəbiyyəti fərziyyəsinə əsaslanaraq, onlar psixoterapiya termininin eyni zamanda həm terapevtik amilin, həm də müalicə olunan obyektin yalnız "zehni" ola biləcəyinə işarə etdiyinə inanırlar. Artıq qeyd edildiyi kimi, tibbdə bu cür terminlər yalnız aktiv agentə aiddir, nəzərə alınmaqla, bu agentin bütün bədənə təsir etdiyi, məsələn, farmakoterapiya, hidroterapiya və digər terminlər. Bir tərəfdən, bu, terminin mənasını genişləndirir, çünki o, hərəkət edən subyektə təyin etməkdən bu hərəkəti alan obyektə təyin etməyə keçir, digər tərəfdən isə eyni obyektə onun psixi komponentinə qədər daraldır. Əgər psixoloji səbəblərin məntiqi zənciri nevroza gətirib çıxarırsa, onda xəstəyə zehni təsirin də məntiqi səbəb-nəticə əlaqəsinə əsaslandığını gözləmək olar. Başqa sözlə, müəyyən manipulyasiyalar vasitəsilə xəstənin həyatı boyunca təhrif olunmuş şeyləri düzəltmək olar.

Aydın olur ki, başqa bir insana təsir etmək, daha doğrusu, onun zehni həyatını manipulyasiya etmək üçün bu cür bacarıq xüsusi təlim tələb edir.

Yalnız nevroza aparan müxtəlif mexanizmləri deyil, həm də xəstəyə təsir edə biləcək mexanizmləri anlamaq lazımdır.

Ziqmund Freyding dövründən bəri insan təbiətinin tapmacasını həll etməyə çalışan və davranış yollarını göstərən bir çox psixoterapevtik məktəblər yaranmışdır. Bu məktəblərin nümayəndələrinin insanları öyrənməyə və psixoterapevtik davranış metodlarının inkişafına sərf etdikləri əməyin dəyərini inkar etmədən, onların təkəbbürlü olduqlarını görməmək mümkün deyil. Onlar özlərini insan psixikasının mütəxəssisi hesab edir və ona təsir etmək üçün metodlar təklif edirlər. Bəlkə də, müxtəlif psixoterapiya məktəblərinin nümayəndələri arasında bu cür kəskin antaqonizmlərin mənbəyi də elə budur. Özünəinam

İnsan təbiətinin əsl açarının kəşfi digər açarların qəbul edilməsinə mane olur.

Psixiatriyada insan daimi gəzməyə və qeyri-müəyyənliyə məhkumdur; bu, yol nişanlarının axtarışını və onlara yapışmağı izah edir.

Psixoterapiyanın psixiatriyada ixtisaslaşmış bir sahə kimi yaradılması ixtisaslaşma təhlükəsini doğurur. Bu, məsələn, diş həkiminin zədələnmiş diş düzəltdiyi kimi, "zədələnmiş psixikanı" bərpa edə bilən bir növ "insan ruhunun sehrbazı"nın ortaya çıxmasından ibarətdir. Bu halda, onlar insanlığa xas olan bir xətti izləyir: xəstə, zədələnmiş və ya pis olan hər şeyi rədd etmək meylli.

Diş ağrımadağı müddətcə bədənin ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir və nəzərə alınmır.

Ağrımağa başlayanda şüurun mərkəzi hissəsini tutur, eyni zamanda ağrını yüngülləşdirmək üçün müxtəlif manipulyasiyaların aparıldığı bir obyektə çevrilir. Nevrozlu bir xəstə də özünü könüllü olaraq bir mütəxəssisə təslim edir - kaş ki, onu tez bir zamanda "düzəldib", normal vəziyyətinə qaytara bilsəydi. Lakin o, bütün özünü mütəxəssisə təslim etmir, yalnız "psixikasının xəstə hissəsini" təslim edir. Bu, psixikanın "pis" hissəsinin rədd edilməsi ilə eynidir, məsələn, kimsə "Mən bunu edə bilməzdim" dedikdə, hətta bunu edib indi utanır və peşman olur. Lakin insan özünü tamamilə rədd edə bilməz; bu, özünü tamamilə bir obyektə çevirməyə bərabər olardı. Bu, kiçik və böyük psixiatriya arasındakı əsas fərqlərdən biridir.

Kiçik psixiatriya xəstələri, bir qayda olaraq, özlərinin xəstə hissəsini rədd edə bilirlər, çünki

güvənəcəkləri bir şey var; psixikalarının bir hissəsi sağlamdır. Böyük psixiatriya şəraitində olan xəstə bunu edə bilməz; burada hər şey "fərqlidir", dəyişdirilib. Buna görə də, ən azından xəstəliyin kəskin mərhələsində onlar tibbi yardım almırlar. Psixoterapevtlərin nevrozların müalicəsində məhdudlaşmasının nevrozlu xəstələrin psixikalarının bir hissəsini rədd edib onu psixoterapevtik manipulyasiyaya həsr edə bilmələrindən qaynaqlanması mümkündür. // MANİPULYASIYA

"Manipulyasiya" sözü xəstənin psixikasına təsir etmək və psixoterapevtin onun proseslərini modelləşdirmək qabiliyyətini ifadə edir. Bu manipulyasiya tibb elminin digər ixtisaslarında olduğu kimi, yalnız müxtəlif ixtisaslı həkimlər bədənin müxtəlif orqan və sistemlərinə müəyyən bir plan əsasında təsir göstərirlər, psixoterapevt isə psixikaya təsir göstərir.

İnsanların qarşılıqlı təsiri fəvqəladə dərəcədə mürəkkəb bir fenomendir və həmişə məntiqi anlayış qaydalarına tabe olmur. Şübhəsiz ki, psixoterapevtlərin böyük ləyaqəti xəstə ilə psixoterapevt arasında psixoterapiya seansları zamanı baş verən bir çox əlaqə proseslərinin izahıdır. Lakin bu elmi mövqə psixoterapiyada ən vacib olanı - onun kortəbiiyini sarsıdır. Əgər psixoterapevt xəstəyə müəyyən bir plana uyğun olaraq davranışları vasitəsilə təsir etmək istəyirsə, psixoterapiya təbiiyini itirir, süni olur və özünə müəyyən bir metod tətbiq edir.

Gündəlik həyatda insanlar cəmiyyətdə istədikləri effektdə nail olmaq üçün tez-tez komediya oynayırlar. İsterik şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik insanlar bu cür rolları oynamağa xüsusilə meyllidirlər (isterik xəstələr tez-tez terapevtlərini manipulyasiya etməyə, yəni müvafiq oyun vasitəsilə onları müəyyən bir ruhi vəziyyətə salmağa çalışırlar). Xəstə ilə psixiatrik təmasda özünüz olmaq vacibdir; hər hansı bir sünilik xəstə tərəfindən dərhal qəbul edilir və ruhi xəstələr buna həssasdırlar.

Bunun zərərli təsiri ola bilər (maska psixotik qorxunu artırır). Buna görə də, xəstələri manipulyasiya etməkdən zövq alan psixoterapevtlər nevroitik pozğunluqları olan xəstələri seçirlər, çünki onlar psixoterapiya zamanı süni nəzarətə ruhi xəstələrə nisbətən daha az həssasdırlar.

HƏKİM ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ DƏRMANDIR

Spontanlıq qarşılıqlı psixoloji təsirin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir.

Heç kəsi istədiyimiz kimi davranmağa məcbur edə bilmərik. Heç kəsi

müsbət hisslər ifadə etməyə, sevinc və kədəri kiminləsə bölüşməyə və s. meyl edə bilmərik, Polşa yazıçısı və həkimi Bojanın sözləri ilə desək, "caly w tym ambaras, aby dwoje chcialo naraz" (bütün məsələ budur ki, iki nəfər bunu eyni anda istəyir!). Emosional

vəziyyət şüurlu qərara tabe deyil; onu iradə aktı idarə edə bilməz; yalnız şüurlu şəkildə ifadəsini azalda və ya artırma bilər. Bu

ifadə vasitəsilə ətraf mühitdə müvafiq emosional reaksiyalar oyada bilərik. Bu,

aktyorluq və psixoterapevtik manipulyasiya sənətidir. Lakin bu, səthi və çox güman ki, qarşılıqlı psixoloji təsirin süni təbəqəsidir.

Emosiyaların şüalanması, yəni onların bir insandan digərinə ötürülməsi, iradi fəaliyyətimizin xaricində və çox vaxt şüurumuzun xaricində baş verir. Rəğbət, antipatiya, hörmət, sevgi, nifrət və bu kimi şeylər kortəbii olaraq oyanır və kortəbii olaraq digər insanlara ötürülür. Adətən, yalnız müəyyən bir hiss ifadə edildikdən sonra onun motivlərinin axtarışı başlayır. Müəyyən hisslərin başqa bir insana ötürülməsi metodlarla deyil, şəxs tərəfindən baş verir. Bu prinsip aktyorlara da aiddir; məşhur aktyorların da böyük fərdiyyətçi olduqları məlumdur. Bir ingilis psixiatrı M. Balint*-in dediyi kimi, tibbdə ən vacib tibb həkimidir. O, xəstəyə bütün şəxsiyyəti ilə təsir göstərir və görünür, bu, psixoterapevtik hərəkətin mahiyyətini - öz fərdiliyinin xəstəyə təsirini təşkil edir.

Psixiatr, bəlkə də heç kim kimi, insan təbiətini anlamaq imkanına malikdir.

İnsan özünü daha yaxşı tanıyır və bu da onun şəxsiyyətində iz qoyur. Psixiatrın şəxsiyyəti xəstəyə müsbət təsir göstərməlidir. Yaxşı psixoterapevt müxtəlif metodları və ya psixoterapevtik fəndləri öyrənmiş biri ola bilməz, əksinə xəstələrlə təmas yolu ilə digər insanı getdikcə daha çox başa düşən və öz təcrübə dünyasını zənginləşdirən biri ola bilər. Psixiatrik biliklər tibbin digər sahələrində olanlardan daha dərinidir; bu mənada daha dərinidir ki, psixiatr digər insanı öz prizmasından tanıyır. Psixiatrik qiymətləndirmənin böyük fərdiliyi buradan qaynaqlanır, həmişə elmi qiymətləndirməyə bənzəmir, lakin bunun sayəsində psixiatriyada digər tibbi ixtisaslardan daha çox həkimin öz şəxsiyyətinin modelləşdirilməsi mövcuddur.

* M. Balint: Həkim, onun xəstəsi və xəstəliyi. London, 1957.

// PSIXIATRİK ƏLAQƏ MƏRKƏZİ

Müxtəlif şəxsiyyət tiplərinə malik insanlar psixiatr kimi çalışırlar və heç bir şəxsiyyət tipinin belə bir ixtisasda qəbul edilə bilməyəcəyini demək olmaz.

Bu işin vacib bir aspekti, şübhəsiz ki, bir növ iz buraxmağa əsaslanan ruhi xəstələrə münasibətdir və bu münasibət psixiatrik praktikanın ilk illərində formalaşır; sonradan, ixtisaslaşmasına baxmayaraq, bu münasibəti dəyişdirmək çətinidir. Psixiatrik terapiyanın əsaslandığı xəstəyə bu münasibət

Təmas psixoterapevtik təlimin təsirsiz qalmasının təməlini təmin edir.

Həkimin xəstəyə münasibətini xəstənin şifahi qiymətləndirməsi ilə asanlıqla ayırd etmək olar.

Hər bir şəxslərarası təmasda onun müstəvisi müəyyən edilə bilər, bu, biri üstün olduqda meylli, ikisi eyni xəttə olduqda isə üfüqi ola bilər. İnsanlar da heyvanlar kimi özlərini

başqalarından üstün tutmağa meyllidirlər; hər kəs başqalarından daha vacib olmaq, sosial qrupda daha yaxşı yer tutmaq, bununla da daha yaxşı yaşayış şəraiti və daha yaxşı tərəfdaş əldə etmək istəyir. Özünü yüksəltmək meylinə hər iki fundamental bioloji qanun iştirak edir.

Özünü ruhi xəstələrdən, xüsusən də patoloji davranış reaksiyaları nəticəsində sosial dairədən kənarlaşdırılmış əsas psixiatriya xəstəsindən yuxarı qaldırmaq çətin deyil. Hətta ən humanist düşüncəli psixiatr belə xəstə ilə ünsiyyət qurarkən bəzən qeyri-ixtiyari olaraq "Mən ondan daha yaxşıyam" deyə düşünür. Əlbəttə ki, bu, insanın öz rifahının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir, eyni zamanda təmas müstəvisini avtomatik olaraq üfüqindən mailiyə dəyişir. Xəstə daha pis, psixiatr isə daha yaxşı bir şeyə çevrilir. Öz böyüklüyünün zirvəsindən baxdıqda, mühakimə etmək, günahlandırmaq, müəyyən etmək, manipulyasiya etmək və sair daha asandır. Bu, həm də yalançı elmi mövqedir,

bu mövqedə hər şey başqa bir insan haqqında məlumdur və sonra onun davranışını təsnif etmək və proqnozlaşdırmaq asandır; hər şey kitabdakı təsvirə bənzədiyi üçün məlum olur.

Mayillı müstəvilərdə digər insan tədricən bir obyektə çevrilir, çünki

kimdənsə üstün olduğumuz üçün biz ona sahibik, müəyyən dərəcədə onları idarə edə bilərik, başqası isə

bizdən asılı vəziyyətə düşür. Bu vəziyyət somatik tibbdə xəstələr tərəfindən asanlıqla tolere edilir, çünki xəstənin özü bədəninin xəstə hissəsini rədd edir və onu "təmir" üçün mütəxəssisə təhvil verir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu tip "psixikanın xəstə hissəsi" nevrozlu xəstələrdə də müşahidə olunur. Buna görə də, nevrozlu xəstə psixiatriyanın dominant mövqeyini yaşayır, o, problemlərini bilir və onları həll edə bilər. Daha sonra eniş spiralı xəstəyə bütövlükdə deyil, yalnız qırıq hissəyə aiddir.

Xəstə həkimə münasibətdə özünü yuxarı spiralda yerləşdirə bilər; onlar həkimdən qayğı, dəstək və qurtuluş axtarırlar. Bu, təkcə psixiatriyada deyil, uşaqlığa tipik bir regressiyadır. Həkimin xəstə tərəfindən onlara tətbiq edilən eniş spiralından azad olmaq hüququ yoxdur; onlar xəstəyə deyə bilməzlər: "Biz bərabərik, özünə yaxşı bax, mən sənə üçün məsuliyyət daşıya bilmərəm". Belə bir mövqe həkimin uzun müddətdir mövcud olan rolu ilə uyğun gəlmir.

Həkimin spesifik rolundan irəli gələn təmas müstəvisinin meylini onun üfüqliliyi ilə necə uzlaşdırmaqla bilərik, bu da fərdi mümkün qədər dərindən tanımağa çalışan tibbi intizam olan psixiatriyanın spesifikliyindən irəli gəlir, bu da öz növbəsində xəstə ilə orijinal münasibət tələb edir və buna görə də yalnız üfüqi müstəvidə oynana bilər. Xəstə ürəyimizi, qaraciyərimizi, ağciyərlərimizi və hətta "sınırlərimizi", vərdişlərimizi, münaqişələrimizi və sair şeyləri həkimə "verəndə" onu qəbul edə bilərik, amma həkimin üstün mövqeyinin bu qismən tanınması belə çətinliklə baş verir. Həkimlər zarafatların sevimli mövzuları idilər və hələ də belədirlər; həkimlər iqtisadi cəhətdən xəstədən və ya dövlətdən asılı idilər. Beləliklə, ucaltma alçaldıcılığa, ucaldılmış isə alçaldıcıya çevrildi.

Psixiatrlara gəldikdə, həkimin əhəmiyyətini xəstənin tanıması yalnız xəstənin özündən gələ bilər. Psixiatr insan təbiətinin öyrənilməsi və korreksiyası üzrə mütəxəssis olduğuna görə tərif tələb edə bilməz və xəstə həkimin onları anlamağa və kömək etməyə hazır və qadir olduğunu hiss etməlidir.

Hər şey meylli təmas müstəvisini kimin qurmasından asılıdır. İnsan özü könüllü olaraq etibar edə biləcəyi, təqlid edə biləcəyi və çətin qərarların yükünü kimə həvalə edə biləcəyi "üstünlüklər" axtarır. "Ata" axtarışı gənclikdə bitmir; bəzən qocalığa qədər davam edir. Lakin, təmas müstəvisinin meylinin zorla tətbiq edildiyi vəziyyətlərə dözmək çətinidir. Sonra bu ucalan insanı alçaltmaq istəyi oyanır. Belə təmas kortəbii olmağı dayandırır və öz müstəvisi kimi, zorla tətbiq olunur.

Əgər böyük bir uşaqla oynamaq istəyirsə, ya özünü onların səviyyəsinə endirir, ya da uşağı öz səviyyəsinə qaldırır. Eyni şey ruhi xəstələrlə təmasa da aiddir; Onlara "zehni cəhətdən sağlam" mövqeyindən yanaşmaq olmaz, çünki məhz təmas müstəvisinin əyilməsinə səbəb olan zehni pozğunluq nöqtəsidir. Xəstənin təcrübələri dünyasına daxil olmaq üçün öz daxilində nevroz və ya psixozun gizli elementlərini kəşf etmək lazımdır ki, bu da onların pozğunluqlarına uyğundur. Tamamilə yad bir təcrübəni anlamaq mümkün deyil; o, həyasız psixikadakı rezonansla üst-üstə düşməlidir. Bu rezonansın baş verməsi üçün öz təcrübələrimizdə analogi bir şey tapmaq lazımdır. Bu mənada, psixiatrik tədqiqat bədii təcrübəyə yaxınlaşır. O, terapevtin dərin gizli psixi təbəqələrini aktivləşdirir. Psixanalizin baniləri bundan xəbərdar idilər və psixoterapiya tələbələrindən əvvəlcə özləri psixanalizdən keçməyi tələb edirdilər. Bu şəkildə onlar özlərində sonradan xəstələrində kəşf edəcəkləri şeyləri kəşf etdilər. Psixiatrik təmasın üfüqi müstəvisinin qəbul edilməsi normalıq və patologiya arasında kəskin bir sərhədin olmamasına əsaslanır və patologiya hər kəsdə tapıla bilər. Əgər bu iz patoloji elementlər "zehni cəhətdən sağlam" psixiatrlarda olmasaydı, onlar xəstələrini başa düşə bilməzdilər. Psixiatriyanı kitabdan öyrənmək olmaz; xəstənin təcrübələrini hiss etmək və müəyyən dərəcədə onları özünüz yaşamaq lazımdır və bu, xəstə ilə psixi yaxınlıq tələb edir. Əks təqdirdə, belə bir xəstə yadlaşır - "yadplanetli" və "varius" olur və psixiatrik müalicədə ilk addım xəstəni yadlığın dairəsindən azad etmək olmalıdır. Əgər psixiatr təlimin əvvəlindən xəstə ilə düzgün münasibət qura bilmirsə, böyükləşmə meylli üstünlük təşkil edəcək. Psixikada normalıq və patologiya arasındakı boşluq dərinləşəcək və qarşılıqlı anlaşma daha da çətinləşəcək. //

MÜNASİBƏTLƏRDƏ ÜÇ SƏHV. PSEUDO-ELMI DESERSANALİZASIYA

Xəstənin rezonans əsasında öyrənilməsi psixiatrik təmas müstəvisi, yəni eyni zamanda özünü öyrənərkən xəstəni tanımaq,

üç səhv psixiatrik münasibəti istisna edir: pseudoelmi depersonalizasiya,

maskalama və mənəvi mühakimə. Bioloji elmlərdə araşdırılan obyektlə meylli təmas müstəvisi zəruridir. Obyekt sanki yuxarıdan müşahidə olunur, müəyyən bir güc onun üzərində uzanır; təcrübələr əvvəlcədən müəyyən edilmiş

plana uyğun olaraq aparıla bilər və obyekt daha az və ya daha çox dərəcədə manipulyasiya edilə bilər. Üfüqi müstəvidə fərqli bir perspektivdən müşahidə imkanı da var.

Əgər yuxarıdan baxırıqsa, onda ilk növbədə faktlarla, yəni müşahidə olunan obyektin yaratdığı hərəkətlərlə maraqlanırıq. Əgər üfüqi mövqedən baxırıqsa, onda ilk növbədə təcrübələrlə, içəridə olanlarla, nə ilə maraqlanırıq.

Bu, müşahidə etdiyimiz subyektlə edilir. Və bu daxililik yalnız daxililiyimizin rezonansı vasitəsilə öyrənilə bilər. Psixiatr eyni zamanda xəstəni və özlərini müşahidə etməlidir. Onların xəstəyə reaksiyaları xəstənin təcrübələri qədər vacibdir. Buna görə də, sözdə rəhbər psixoterapiyada, yəni baş psixiatr tələbə ilə psixoterapevtik seanslar haqqında danışdıqda, etibar və müəyyən bir yaxınlıq mühiti vacibdir, çünki gənc psixoterapevt xəstə ilə söhbətin məzmununu çatdırmaqla istər-istəməz baş həmkarına öz problemlərini və zehni təhriflərini açır.

Üfüqi müstəvidə qiymətləndirmə aparmaq elmi adlandırılabilirmi? Cavab elmin tərifindən asılıdır. Əgər elmə sehrin varisi baxımından, yəni əsas məqsədi ətraf mühit üzərində güc qazanmaq baxımından baxılırsa, şübhəsiz ki, meyli müstəvidə qiymətləndirmə daha yaxşı nəticələr verir;

onda müşahidə subyekti üzərində güc daha böyükdür. Əgər Eynşteynə* görə, elmin məqsədi fiziki və zehni hadisələrin nizamlanması kimi qəbul edilsə, üfüqi müstəvidəki bilik meyli müstəvidəki biliyə bərabərdir və zehni hadisələr halında isə ondan daha üstündür. Xəstəsinin və eyni zamanda özünün zehni təcrübələrini nizamlamaqla psixiatr çətin yollarla zehni təcrübə sahəsində hökm sürən nizamları anlamağa nail olur. Zehni təcrübələr, hər bir insanda fərqli şəkildə görünsə də, əsas strukturlarında ortaq xüsusiyyətlərə malikdir.

// MASKA

Üfüqi təmas müstəvisində maskalanmaya ehtiyac yoxdur; hər şey həqiqətən real görünür. Bərabərlikdən qaynaqlanan azadlıq, təmasın meyli müstəvisində yox olur. Yuxarı və hətta aşağı səviyyəli şəxslər tərəfindən mühakimə olunmaq qorxusu yaranır. Qorxu davranış azadlığını iflic edir; insan normativ davranış maskası arxasında gizlənir ki, bu da onu mühakimədən qoruyur. Üfüqi təmas müstəvisində oxşarlığa vurğu edilir: insanlar oxşar olduqları üçün bərabərdirlər. Meyli müstəvidə vurğu bəzilərinə üstün, digərlərinə isə aşağı edən fərqlərə yönəlir. Üfüqi müstəvidə təcrübələr daha vacibdir, meyli müstəvidə isə faktlar daha vacibdir. Qiymətləndirmə şkalasında yuxarı və ya aşağı hərəkət edərkən təcrübələr deyil, faktlar nəzərə alınır.

Artıq qeyd edildiyi kimi, insanın başqasının emosional əhval-ruhiyyəsini qavramasına imkan verən spesifik psixoloji intuisiya yaşla zəifləyir. Uşaqlar maskalara öyrəşmiş kimi görünən böyüklərdən daha çox meyliidirlər. Bəlkə də psixoloji intuisiyanın bu zəifləməsi, bəzən həyat boyu öz maraqları uğrunda mübarizə aparmaq ehtiyacından irəli gəlir. Meyli müstəvidə təmas daha vacib və tez-tez olur; faktlar təcrübələrdən daha çox hesab olunur və insanlar öz hərəkətlərinə görə mühakimə olunurlar. Bütün bunlar psixoloji həssaslığı azaldır, burada psixoloji intuisiya adlanır və insanın zehni vəziyyətlərinin daha yaxşı maskalanmasını öyrədir.

Xüsusilə əsas psixiatriya dairəsində olan ruhi xəstələr özlərini insan cəmiyyətində itirilmiş hiss edirlər. Sosial narahatlıq, yəni insanlardan və onların mühakiməsindən qorxmaq psixiatriyada olduqca yaygındır. Bu, maskanın uşaqcasına başa düşülməsinə regressiyaya səbəb ola bilər. Maska qorxu oyadır, özünəinamsızlıq hisslərini artırır və

insanın bunun altında nəyin gizləndiyini bilmir.

Bəzən kəskin psixozda, xüsusən də şizofreniya tipində, xəstə sanki

insanın əsl siması onun qarşısında açılmış kimi hiss edir; o, sevdiklərini fərqli bir işıqda görür, onların üzləri dəyişir - gözəl və ya çirkin, bəzən isə onların üzündə açıq şəkildə maska görür. Əlbəttə ki, belə ekstremal hallarda, insanın özünün köçürülməsi...

Emosional əhval-ruhiyyə başqalarına təsir göstərə bilsə də, bu cür hallar başqa bir insanın əsl üzünü axtarmaq adlandırıla biləcək bir şeye nümunə ola bilər. Bu "əsl üz" psixoloji şəxslərarası təmasda ən vacibdir. İnsanlar tez-tez müxtəlif növ maskalar taxır və müxtəlif pozalar qəbul edirlər ki, bu da yalnız çox qısamüddətli təsir göstərir, psixoloji təsirdə isə yalnız insanın əsl üzü nəzərə alınır. Müxtəlif pozaların və maskaların qəbul edilməsi heyvanlarda da müşahidə olunur, məsələn, bir qadının və ya düşmənin diqqətini cəlb etmək üçün.

Bundan əlavə, maska taxmaq yorucudur. İnsan süni pozasını qorumaq üçün iradə gücündən istifadə etməli, həqiqi emosiyaların ifadəsini boğmalıdır.

Əlbəttə ki, hər şeyi gizlətmək mümkün deyil; bütün emosional vəziyyətlərdə vacib olan vegetativ reaksiyalara təsir etmək mümkün deyil və gözlərin ifadəsinə təsir etmək nadir hallarda mümkündür. Buna görə də, maska adətən natamam olur; altından bir şey görünür. Əsl emosiyaları boğmaq ağırlıdır. Yorgunluq tez-tez psixiatr üçün xəstə ilə emosional münasibətlərinin dəqiq göstəricisi ola bilər. Psixiatr, hər kəs kimi, xəstəyə diqqətini cəmləşdirməyə mane olan münaqişələr və bədbəxtliklərlə qarşılaşır; xəstə şüurunun səthi hissi ilə məşğul olur, daha dərin düşüncələr isə onları əzablandırır. Belə hallarda, onlar maska taxmalıdırlar; onlar bunu hiss etməsələr də, xəstə ilə marqlanmış kimi davranırlar. Ruhi xəstə çox vaxt tələb edir; psixiatrın həmişə buna imkanı olmur, çünki onları digər xəstələr və digər məsələlər gözləyir, bəzən xəstəni dinləməkdən daha vacibdir. Psixiatr xəstə haqqında düşünmək əvəzinə, onun qarşıdakı fəaliyyətləri haqqında düşünür; xəstə qıcıqlandırıcıdır, dəyərli vaxtını alır. Lakin onlar maraq və diqqət göstərməlidirlər. Bəzən xəstə teatr davranışı, inadkarlığı, öz şəxsiyyətləri ilə bağlı suallara cavab verməkdən imtina etməsi və bəzən hətta xarakter xüsusiyyətləri və ya problemləri həkimə öz sınınamış xüsusiyyətlərini və gizli problemlərini xatırlatması ilə qıcıqlanır. Adətən, xəstəni dərinədən tanımaqla bu mənfi münasibət yox olur, lakin əvvəlcə psixiatr maskalanır.

Heç bir başqa tibbi sahə psixiatriya qədər güclü bir məyusluq hissi oyadır.

Digər sahələrdə həkim, yaxşı və ya pis bir şey edir, amma o, bir şey edir. Psixiatriyada həkim nə qədər aktivdirsə, xəstə üçün bir o qədər pisdır. Bu, həm somatik, həm də psixoterapevtik müalicəyə aiddir. Psixiatrik müalicə tarixindən məlumdur ki, həddindən artıq aktiv somatik müalicə ruhi xəstələrə ən böyük zərər vurub. Psixoterapiyada həkim xəstəyə nə qədər aktiv təsir göstərməyə çalışırsa - ağırlı simptomlarını tez bir zamanda aradan qaldırmağa, qüsurlu şəxsiyyət strukturunu dəyişdirməyə çalışırsa - xəstə bir o qədər inadkar olur və müalicənin təsiri bir o qədər zəifləyir. Çox vaxt xəstəyə həsr olunmuş çoxlu saatlara baxmayaraq, onların ruhi vəziyyətində heç bir görünən irəliləyiş olmur. Bəzən səylərimizdən asılı olmayaraq irəliləyiş baş verir.

Psixiatr xəstənin daxili təcrübələrinə və xarici vəziyyətinə qarşı acizdir. Onlar xarakterlərini və ya həyat şəraitlərini dəyişə bilmirlər. Onların edə biləcəyi, daha doğrusu etməli olduğu tək şey xəstəyə empatiya etməkdir - təcrübələrini anlamaq və onları rəşional şəkildə təşkil etməyə çalışmaq mənasında empatiya etməkdir.

Fəaliyyətdən belə imtina etmək hər kəs üçün çətindir. Mühakimədən yayınmaq üçün, hətta sözlə belə hərəkət etmək istəyinə qarşı durmaq üçün böyük daxili intizam tələb olunur.

Xəstəyə məsləhət vermir, hətta ən kiçik bir səbirsizlik jesti ilə belə onları mühakimə etmir. Dinləmək böyük bir sənətdir. Yalnız hərəkət etmək istəyini cilovlamaqla yanaşı, həm də xəstənin demək istədiyini oxumağa diqqət yetirmək, daim "həyatının bir görüntüsünü yaratmaq, onları keçmişdə, indi və gələcəkdə görmək" lazımdır. Bu görüntü düzəldilə bilməz; xəstə haqqında yeni məlumatların təsiri altında daim dəyişməlidir.

Xəstə ilə əlaqə, şübhəsiz ki, yaradıcı bir prosesdir. Bu, xəstənin daim yeni portretlərini yaratmaq kimidir. Psixiatrik işin bu yaradıcı elementi "mənfi emosional vəziyyətləri" aradan qaldırır. Xəstə ilə əlaqə yorucu deyil, çünki özünüz ola bilərsiniz. Həmçinin psixiatrın özünü sağlam insanlardan daha yaxşı hiss etməsi də olur. Xəstələrlə əlaqəsi daha dərinir və onlarla maskaya ehtiyacı yoxdur.

* A. Eynşteyn: Xsto-ta teorii wzglQdnosci. PWN, Varşava 1962

// MƏNƏVİ QIYMƏTLƏNDİRMƏ

İncildəki "Mühakimə etməyin, yoxsa məhkum olarsınız" əmrinin əksinə olaraq, insanlar çox vaxt başqalarını mühakimə etməkdən zövq alırlar. Onlar subyektlərini yaxşı və pis, ağıllı və axmaq, xoşagələn və xoşagəlməz və s. bölməyə ayırırlar. Bu qiymətləndirmə vasitəsilə ətraf aləmdə əsas istiqamətləndirmə mümkün olur; bəzilərinə artı işarəsi ilə yaxınlaşmaq olar, digərlərinə isə mənfi işarə ilə qarşı-qarşıya gəldikdə və ya hətta döyüşərkən tərəfləri dəyişmək lazımdır. Bu qiymətləndirmənin hansı əsasda formalaşdığını müəyyən etmək asan deyil. Görünür, onu formalaşdırmaq bacarığı çox erkən görünür; körpənin bəzilərinə qollarını uzadıb onları başqalarından gizlətdiyi və qışqıraraq özünü müdafiə etdiyi məlumdur. Heyvanlar həmçinin müxtəlif qiymətləndirmələr ifadə etmək bacarığını nümayiş etdirirlər. Bu, əlbəttə ki, onların qazandıqları təcrübədən asılıdır. Onlar təhlükə, ağrı və ya problem gətirə biləcək sosial dünyanın nümayəndələri ilə qarşılaşmaqdan qaçırlar və sevinc və sülh gətirə biləcəkləri axtarırlar.

Seçimlər ehtimala — ətraf aləmin müəyyən bir nümayəndəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda qarşılaşa biləcəklərinə əsaslanaraq edilir. Bu cür qərar, əlbəttə ki,

yalnız sosial mühitlə deyil, həm də ətrafdakı bütün

obyektlərlə əlaqəli olaraq qəbul edilir. Lakin, müəyyən bir ehtimal sisteminin ən mürəkkəb və eyni zamanda ən formalaşdırıcısı ətraf mühitlə əlaqəli qərarlardır. Bu ehtimal sistemi həmişə sadəcə ehtimal olaraq qalır və buna görə də sosial mühitin qərar sisteminin təsiri altında gücləndirilir. Başqalarının təcrübəsinə əsaslanaraq hazır düsturlar qəbul edilir. Bu şəkildə, əvvəlcədən mövcud olan ehtimal sisteminə daxil olmaq olar; hansı insanlara yaxınlaşmaq mümkün olduğu və hansılarından

qaçınmaq və ya mübarizə aparmaq lazım olduğu əvvəlcədən məlumdur. Bu sistem həm insanlara, həm də onların davranış modellərinə tətbiq oluna bilər. Müəyyən insanlar həmişə artı və ya mənfi işarə ilə təyin olunurlar (məsələn, bir və ya əks sosial qrupa mənsub olmaqla). Müəyyən davranış modelləri bir şəxsi təyin etmək üçün müəyyən bir işarəni göstərir; məsələn, müəyyən davranış modelləri bir insanı sosial tənqidə məhkum edir. Bu sosial sistemdə psixiatrik xəstələr əksər hallarda mənfi işarə ilə, yəni "varii" ilə təyin olunur və bu vəziyyət xüsusilə böyük psixiatrik müəssisələrdəki xəstələrə münasibətdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Psixiatrik personal bu ehtimallar sosial sistemini pozur və məsafə saxlamaq əvəzinə, psixiatrik xəstəyə yaxınlaşır.

Xəstə. Lakin, müxtəlif davranış formalarının qiymətləndirildiyi sistem qalır.

Xəstələri xəstə kimi qəbul etmək mümkün olsa da, onların müəyyən davranış və təcrübə formalarına dözmək çətinidir. Bu tolerantlıq əsas psixiatriya xəstələri üçün daha çoxdur. Onların tamamilə "fərqli" olmaları, böyük tələblər olmadan fərqli münasibətə imkan verir; onlar özləri üçün məsuliyyət daşıyırlar; hər şeyə icazə verilir. Belə bir "üstünlük dərəcəsi" həmişə insan üçün alçaldıcıdır, çünki bu, onların aşağılığının tanınmasından irəli gəlir.

Kiçik psixiatriya xəstələri hələ də sosial qrupun, yəni normal insanların sərhədləri daxilindədirlər və onlara üstünlük verilən münasibət tətbiq etmək daha çətinidir. Onlar qeyri-iradi olaraq tənqid olunurlar, davranışları pislənir ki, bu da təkcə onlara deyil, həm də yaxınlarına zərər verir. Onların dərin travmalarının, yaxınlarına nifrətinin, gizli despotik meyllərinin, kin hisslərinin və s. onların sağlamlığına necə təsir etdiyi aydındır.

Onlara demək istərdim: "Dəyişməlisiniz, sonra xəstəlik keçib gedəcək." Əlbəttə ki, nevrotik problemlərə mənəvi baxımdan baxmaq olar. Nevrozlarda tez-tez narazılıq və günahkarlıq hisslərinin yaranması xəstənin bu məsələlərə qarşı həssas olduğunu, özü üçün ədalətli qiymətləndirmə və günahından bağışlanma axtardığını göstərir. Lakin həkim hakim deyil və xəstəni, onun davranışını və təcrübələrini mühakimə etmək, onları yaxşı və ya pis kimi qiymətləndirmək onların işi deyil. Onlar xəstənin sağlamlığına vurduqları zərəri qiymətləndirə bilirlər, lakin bu, az kömək edir.

Xəstə bu hissləri dəf edə bilməsə, nifrətinin baş ağrısına və ya mədə xorasına səbəb olduğunu öyrənməsinə kömək edəcəkmi? Buna baxmayaraq, bu özünə zərər vermək qıcıqlandırıcıdır. Əsas psixiatriyada hakim mövqeyi yox olur və hər şey xəstəliyə aid edilir - xəstə heç bir məsuliyyət daşımır. Kiçik psixiatriyada bu əhval-ruhiyyə ilə mübarizə aparılmalı və xəstənin patoloji vəziyyətlərinin inkişafına müəyyən dərəcədə səbəb olmasına baxmayaraq, özünün xəstə tərəfindən mənfi qiymətləndirilməsinə yol verilməməlidir. Mühakimə və qınama ilə mübarizə, və buna görə də xəstəyə qarşı mənfi emosional münasibət nevrozlu xəstələrlə qarşılıqlı əlaqə zamanı yaranan yorğunluğa gətirib çıxarır.

Həkim xəstənin təcrübə dünyasına daha dərinə daxil olduqda və onun həyat hekayəsini öyrəndikdə hakimin mövqeyi arxa plana keçir. Sonra xəstənin emosional vəziyyətini daha yaxşı başa düşmək olar və özünü bu zərərli təcrübə yollarına görə onları mühakimə etmək istəyi yox olur. Psixiatriyada "hər şeyi bağışlamaq və unutmaqdan daha yüksək güc yoxdur" ("tout comprendre c'est tout pardonner") olmasına baxmayaraq, uzun illər psixiatrik təcrübədən sonra belə, dərin kök salmış qınamaq istəyini boğmaq çətinidir.

// PSIXIATRIN ŞƏXSİYYƏTİ

Başqa bir insanın zehni vəziyyətinə təsir edən müxtəlif elementlərdən ən əhəmiyyətli, belə bir hərəkəti yaşama prosesi zamanı inkişaf edən emosional əlaqədir. Buna görə də, psixiatrın təlimin əvvəlindən xəstəyə düzgün yanaşma tapması xüsusilə vacibdir. Əlbəttə ki, həkimin müəyyən şəxsiyyət xüsusiyyətləri bu axtarışı asanlaşdırır və ya mane ola bilər. Məsələn, despotik, aqressiv və emosional cəhətdən soyuq insanlar xəstəyə uyğun emosional yanaşmanı tolerant, sakit və həssas insanlardan daha çətin tapırlar.

Lakin, müəyyən xarakter xüsusiyyətlərinin psixiatriyada işləmək imkanını istisna etdiyini demək olmaz.

Xəstələr müxtəlif növ psixiatrlara yönləndirilir; bəziləri qətiyyətli və hətta despotik psixiatrlara daha çox etibar edir, digərləri həssas psixiatrlara, digərləri isə soyuq və rəşional psixiatrlara üstünlük verirlər. Qarşılıqlı psixoloji təsir üçün optimal şərtləri müəyyən edən bir növ spesifik təbii seleksiya mövcuddur. Psixiatrik səhiyyə sistemimizdə xəstə nadir hallarda öz psixiatrını seçə bilər.

Və əgər bu mümkündürsə, onda müəyyən növ xəstələrin müəyyən növ psixiatrların ətrafında toplaşdığını görmək olar. Görünür, bu spesifik "təbii seleksiya" cinsi həyatda təbii seleksiyaya bənzəyir, çünki insanlar partnyorlarında tamamlayıcı xüsusiyyətlər axtarırlar. Sakit və təvazökar insan hökəmrən partnyor, kədərli insan şən, emosional cəhətdən soyuq insan isti, dəyişkən və xəotik insan isə ardıcıl və sistemli bir partnyor axtarır. "Les extremes se touchent" qaydasına görə belə bir seçimin psixoterapiya prosesinə necə təsir etdiyi məlum deyil. Hər halda, bu, xəstə ilə müalicə edən həkim arasında uzunmüddətli münasibətlər qurur.

// PSIXIATRİK ƏLAQƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bu günə qədər psixoterapiyanın nə hesab edilə biləcəyi barədə mübahisələr mövcuddur: həkim və xəstə arasındakı hər təmasda mövcud olan psixoloji təsir elementi, yoxsa psixoterapevtik prosesə xas olan uzunmüddətli və qismən planlaşdırılmış təsir.

Birinci tezis daha rəşional hesab oluna bilsə də, əsasən "mütəxəssis" psixoterapevtlər tərəfindən təmsil olunan ikinci təklifi nəzərdən qaçırmaq olmaz, çünki həkim və xəstə arasında müntəzəm və uzunmüddətli təmaslar yeni problemlər yaradır və təsadüfi və kortəbii təmaslardan fərqli bir spesifiklik yaradır.

Bu sensu stricto psixoterapiyasında həkim-xəstə təmasları 45 dəqiqədən az və həftədə bir dəfədən az olmamalıdır (klassik psixoanalizdə onlar gündəlikdir).

Adətən, psixoterapevtik müalicə bir neçə ay davam edir. Ümumilikdə, psixiatr xəstəsi ilə onlarla, bəzən isə yüzlərlə saat keçirir.

Müxtəlif insan təmaslarını araşdırarkən oxşarlarını tapmaq çətindir. Əlbəttə ki, başqa bir insanı anlamaq və ona bacardığı qədər kömək etmək ehtiyacı yalnız psixoterapevtik münasibətlərdə deyil.

İnsanlar problemlərini müxtəlif həyat vəziyyətlərində bölüşürlər və bu, çox vaxt müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan, psixoterapevtik təsir qeyri-spesifikdir. Spesifiklik yalnız başqa bir insanı anlamaq və mənfəi təsirlərdən qaçınmaq üçün daha böyük bacarıqla məhdudlaşacaq ki, bu da psixiatrdan tələb olunur. Əgər əlaqə müntəzəmdirsə və bu qədər uzun müddət davam edərsə, gündəlik həyatda rast gəlinməyən yeni bir vəziyyət yaranır.

Əlbəttə ki, uşaqlarla, cinsi partnyorlar, dostlar və s. arasında daha davamlı, daha güclü əlaqələr də mövcuddur. Xəstə tez-tez həkimlə əlaqəsini bunlarla müqayisə edir. Belə hallarda həkim xəstənin həyatında vacib bir insanı (ata, ana, dost, cinsi partnyor və s.) əvəz edir,

onların yoxluğunu xəstə kəskin şəkildə hiss edir. Xülasə, xəstənin həyatındakı vacib insanlar,

yəqin ki, psixoterapevtdən daha çox onlarla vaxt keçirirlər, lakin bu vaxt

yalnız ruhi sağlamlıq problemlərinə həsr olunmur; onlar xəstə ilə müxtəlif və dəyişən emosional bağlar vasitəsilə bağlıdırlar və qarşılıqlı əlaqələri fərqli məqsədlərə xidmət edir. Psixoterapevtik qarşılaşmada iki tanımadığı şəxs qarşılaşır, biri kömək axtarır, digəri isə kömək edir; hər şey xəstənin problemlərinə yönəlib və başqa heç nəyə.

Artıq söhbət yoxdur. Bu əlaqə müvəqqətidir; xəstə həkimə gəlməyə bilər və insanlarla, hətta tanışlar kimi nisbətən səthi münasibətlərdən fərqli olaraq, onları heç nə psixoterapevtlə əlaqələndirmir.

Psixoterapevtik təmasın xüsusiyyəti, xüsusən də bu əlaqə ilk dəfə qurulduqda, həm xəstələr, həm də həkimlər üçün tez-tez narahatlıq mənbəyidir. Bu narahatlıq sualda ifadə edilə bilər: birlikdə keçirilən bu saatlarda nə etməli? Buna görə də, bir psixoterapevtik seansa digəri arasındakı fasilələrdə həm xəstə, həm də həkim tez-tez düşüncələrində, hətta xəyallarında görüşlərinə qayıdır, növbəti söhbətlərini planlaşdırırlar. Görüşlər onların təcrübələrinin əsas mövzusunə çevrilir ki, bu da həkimdən daha çox xəstə üçün daha intensivdir. Xəstə soruşan kimi davranır və soruşan həmişə vəziyyəti kömək edəndən daha intensiv şəkildə yaşayır. Bu, yenə də təmas səthinin meyl problemdir; Verən soruşandan üstündür və bu üstünlük nəticəsində onlar vəziyyəti daha az güclü şəkildə yaşayırlar (deyirlər ki, "vermək istəməkdən daha asandır").

// KÖÇÜRMƏ VƏ ƏKS KÖÇÜRMƏ

Psixoterapevtik ədəbiyyatda sözdə transfer (transferensiya nevrozu) və əks-köçürmə nevrozu adlandırılan vəziyyətə çox diqqət yetirilir. Xəstə birincisindən, psixoterapevt* isə ikincisindən əziyyət çəkir. Bu nevroz insanın öz münasibətlərinin həyatındakı vacib insanların nümayəndəsinə çevrilən əlaqə tərəfdaşına proyeksiyasından ibarətdir; onlar ata, ana, sevilən insan və s. üçün əvəzedici fiqura çevrilirlər.

Transferensiya nevrozlarının əks-köçürmə nevrozlarından daha çox yayıldığını təxmin etmək asandır. Psixoterapevt bütün vəziyyəti xəstədən daha az güclü şəkildə yaşayır. Buna baxmayaraq, bunlar, xüsusən də prosesə emosional yanaşması və terapevtik uğur arzusu təcrübəli terapevtlərdən xeyli çox olan təcrübəsiz psixoterapevtlər arasında baş verir.

Transferensiya nevrozunun və ya tərs transferensiya nevrozunun ortaya çıxması, görünür, uzunmüddətli psixoterapevtik görüşlər zamanı yaranan qeyri-adi vəziyyətdən çox asılıdır. Belə qarşılaşmalara gündəlik vəziyyətlərdə rast gəlinmir;

Etibar ediləcək heç nə yoxdur, uyğun modellər yoxdur, bir növ sosial boşluq yaranır ki, problemləri müəyyən bir sosial rolu olan biri ilə görüşməkdən daha asan olan problemlərə yönəltmək daha asandır. Valideynlər üçün bu, uşaq, müdir, təbəci, həmkar, həmkar, cinsi partnyor, sevgili deməkdir.

Psixoterapevtik görüşlərdə rollar da müəyyən edilir: iştirakçılardan biri həkim, digəri isə xəstədir. Lakin bu görüş bir neçə saat davam etdikdə rollar bulanıqlaşır. Onlar həkim və xəstə arasındakı adi davranış nümunələrinə cavab verməyi dayandırırırlar.

Həkimin yerində ana, ata, sevilən insan, dost və s. obrazı görünür.

Psixoterapevt də oxşar şəkildə həyat tarixindəki vacib fiqurları əvəz edə bilər və tərs köçürmə də budur. Bu vəziyyət nadirdir və psixoterapevt uyğun bir rol oynayır və bütün vəziyyətə lazımi atmosferi və tənqidi baxışı qoruyur.

Sosial qarşılıqlı əlaqələrdə tamamilə yeni bir insanla heç vaxt qarşılaşılır, çünki

onlar artıq tanınan birinin ətrafında qurulublar. İnkişafın ən erkən dövründə bütün sosial mühit anaya (və ya onun rolunu oynayan birinə) endirilir.

Sosial əlaqələr tədricən daha geniş və daha müxtəlif olur, lakin yeniləri həmişə köhnələrinə toxunur. Bu, təkcə sosial dünyanı deyil, ətrafımızdakı dünyanı anlamağın ümumi qaydasıdır ki, yenisi köhnə ilə təmasa girməlidir, deyimdə deyildiyi kimi, "nihil novi sub sole".

Əgər qarşılıqlı əlaqə quran insanlar bir-birini tanımırlarsa, yəni müəyyən bir rolunu yerinə yetirmələrini tələb edən xüsusi sosial əlaqələrlə bağlı deyillərsə, yaranan vəziyyətdə daha çox hərəkət azadlığına malikdirlər. Bu insanlar öz tərəfdaşlarını həyatlarında rastlaşdıqları müxtəlif insanlarla eyniləşdirə bilirlər; davranışlarına müxtəlif həyat vəziyyətləri təsir edə bilər və tərəfdaşlarının qəribə olması özləri haqqında məlumat paylaşmaqda səmimiyyətə kömək edir. Eyni səbəbdən, səyahət edən insanlar təsadüfən rastlaşdıqları sənişinlərlə özləri haqqında məlumatı könüllü olaraq paylaşirlar.

// NƏ HAQQINDA DANIŞMALI? DİAQNOSTİK VƏ TERAPEVTİK

PROSESLƏR ARASINDAKI ƏLAQƏ

Xəstə ilə ilkin söhbətlər heç bir çətinlik yaratmır. Adətən, xəstə könüllü olaraq özü, şikayətləri və daha sonra, söhbətin müəyyən bir fokusu nəzərə alınmaqla, həyat tarixçəsi və narahatlıqları haqqında danışır. Bu söhbətlər adi psixiatrik müayinədən heç də fərqlənmir. Ümumiyyətlə, bəzi psixoterapevtik müayinələr sünilik qoxusu verir. Hər bir psixiatrik əlaqə, həmişə müsbət olmasa da, psixoterapevtik təsirlə əlaqələndirilir. Digər tərəfdən, psixoterapiya zamanı həkim xəstəni getdikcə daha yaxşı tanıyır və psixoterapevtik proses eyni zamanda diaqnostik prosesə çevrilir.

Əksər psixiatrlar xəstə ilə ilkin söhbətlər zamanı özlərini rahat hiss etsələr də, sonrakı söhbətlərdə, xüsusən də əvvəlcədən planlaşdırıldıqda, qısa və müntəzəm fasilələrlə bir saatlıq əlaqə qurulduqda, həkim özünəinamını itirir, başqa nə soruşacağılarından əmin deyil. Onlar xəstə ilə başqa hansı məsələlərin müzakirə edilə biləcəyini və belə bir söhbətin gedişatını necə müəyyənləşdirəcəyini düşünürlər. Seansın planlaşdırılması onun kortəbiiyini azaldır və tez-tez ikitərəfli məyusluğa səbəb olur: psixiatr psixoterapiya seansını planlaşdırıldığı kimi həyata keçirə bilmədiklərindən narazıdır və xəstə bütün narahatlıqlarını ifadə etməyə icazə verməyən həkimdən narazıdır.

"Nə etməliyəm?" sualı xəstəyə etibar etmək və söhbətdə təşəbbüs göstərməyə icazə vermək daha cəsarətli olduqda, iştirakını onu dinləməklə məhdudlaşdırdıqda nevroitik xarakterini itirir. Gündəlik həyat nadir hallarda özü haqqında sərbəst söhbətə imkan verir və buna görə də dinləməyə hazır olan və eyni zamanda insan münasibətləri üzrə mütəxəssis olan birinin xəstəyə stimullaşdırıcı təsir göstərməsi faktı da belədir.

Narahat bir sükut anlığı baş verərsə, sadəcə susmaq lazımdır. Çox vaxt belə anlarda xəstə bəzi çox vacib məsələləri ifadə etmək üçün daxili müqavimət yaşayır. Sükutu çox tez pozmaq onları çətin qərardan azad edir: "danışmaq, ya yox?" Sonra onlar həvəslə həkimin təklif etdiyi mövzuya qoşulurlar.

"Nə etməli?" sualı psixoterapevtik proses diaqnostik proseslə paralel olaraq nəzərdən keçirildikdə əhəmiyyətsizləşir. Belə hallarda xəstə ilə söhbət onun həyat tarixçəsini və mövcud təcrübələrini daha da araşdırmaq məqsədi daşıyır. Həkim konkret tapşırıqlar qoyur. Əgər hər iki proses nəzərə alınarsa

Ayrı-ayrılıqda, müayinənin diaqnostik hissəsini tamamladıqdan sonra həkim terapeutik hissədə çıxılmaz vəziyyətə düşür.

// Şüurlu Qərar Qəbuletmə Sahəsinin Genişləndirilməsi

Xəstənin muxtariyyətini unutmamalıyıq. Bütün sistemi pozmadan qərar qəbuletmə prosesinin formalaşmasına təsir göstərmək mümkün deyil; sistem özü nə etməli olduğunu seçməlidir. Hətta texnologiyada belə, bütün dizaynı tamamilə dəyişdirilmədikcə, özünüidarə edən aparatı qurulmuş proqramına zidd hərəkətlər etməyə məcbur etmək mümkün deyil. Bu, canlı, özünüidarə edən orqanizmlərdə və xüsusən də insan kimi mürəkkəb bir sistemdə daha da qeyri-mümkündür. Əlbəttə ki, bir insanı bu və ya digər şəkildə davranmağa məcbur etmək mümkündür, lakin bu halda onun qərar qəbul etməsi öz qərarları deyil, xaricdən əmr ediləcəkdir. Sosial mühitin təzyiqi insanı çox erkən yaşlarından bu yad qərarları verməyə məcbur edir ki, bunların çoxu öz qərarlarına çevrilir. Bu, insanın sosial təhsilində çox vacib olan daxililəşmə prosesidir.

İnsan muxtariyyəti bioloji deyil, sosial muxtariyyətdir.

Yəni, nəzarət prosesi əsasən sosial qaydalarla müəyyən edilir və öz qərarlarını ətraf cəmiyyətin qərarlarından ayırmaq çətinidir.

Psixoterapevtik proses təhsil prosesinin bir hissəsi deyil, baxmayaraq ki,

bəziləri bunu belə hesab edir. Onlar hesab edirlər ki, xəstəyə

düzgün (sağlam) davranış öyrədilməli və pis (xəstə) davranışdan uzaqlaşdırılmalıdır.

Beləliklə, xəstələr yaxşı davranışı mükafatlandırmaq və pis davranışı pisləməklə təhsil ala bilərlər.

Şərtləndirməyə əsaslanan bu metod bəzi psixiatrlar tərəfindən istifadə olunur. Təhsil elementləri, şübhəsiz ki, vahid psixoterapevtik prosesin bir hissəsi olsa da, onlar onun mahiyyəti deyil.

Nevrozun sosial mühitin təzyiqinə qarşı üsyanı, belə bir üsyan nəticəsində pis qərarlar qəbul etmək zəruriliyini nə dərəcədə əks etdirdiyini və ya başqa sözlə, bu qərarın xəstədə

natamam daxililəşmənin təsiri altında nə dərəcədə yarandığını müəyyən etmək lazımdır. Normal insanların dairəsində qalmaq üçün nevrotik bu dairə daxilində qəbul edilməz olan hər şeyi yatırmalıdır. Onlar özlərini bütün gücləri ilə mübarizə aparan, özlərini ipdən tutmuş, partlayışdan, dəli olmaqdan, ölməkdən və s. qorxan kimi hiss edirlər.

Ekoloji təzyiqə qarşı natamam daxililəşmə və ya üsyan problemi digər ruhi xəstəliklərdə də özünü göstərir. Alkoqol və ya narkotik asılısı istədikləri ilə həddindən artıq vasitələrlə əldə edilə bilən şeylər arasında uyğunsuzluq hissini azaldır. Şizofreniyada yatırılan şey partlayır. Depressiv vəziyyətdə insan sosial davranış normalarının, xüsusən də öz daxilində daxililəşdirilmiş normaların (supereqo və onun şüurlu hissəsi - vicdan) təzyiqi altında məhv olur.

Psixosomatik xəstəliklərdə xaricdən tətbiq edilən hər şeyə qarşı üsyan fizioloji funksiyalara təsir göstərir və tez-tez dönməz dəyişikliklərə səbəb olur.

Belə bir vəziyyətdə əlavə normaların tətbiqi, görünür, zərərliyə. Digər psixiatrik tədqiqatlarda olduğu kimi, psixoterapiyada da xəstənin rədd etdiyi və üsyanının mənbəyini təşkil edən şeyləri vurğulamağa çalışmaq lazımdır.

xarici reallığa qarşı. Psixiatr, insanın həyatda taxmağa məcbur olduğu maska deyil, onun altında gizlənən hər şeydən daha çox, sikkənin digər tərəfi ilə marqlanır. Bu vahid qəbul, təkcə xarici amillərin deyil, xəstənin seçim prosesinin yenidən qurulmasını asanlaşdırır. Psixoterapiya zamanı basdırılmış funksional strukturların çıxarılması və onları vurğulamaq, onların basdırılması ilə əlaqəli emosional yükü azaldır. Beləliklə, xəstə qərar qəbul etməkdə daha sərbəst olur, hər şeyi məcbur etmir.

Bu anlayışda psixoanaliz psixoterapiyanın ən düzgün forması olardı, çünki terapevt basdırılmış olanı azad etməyə çalışır. Əlbəttə ki, qərar qəbul etmə anında atılan hər şey bilinçaltı hala gəlmir. Çox vaxt insan sikkənin digər tərəfini çox yaxşı bilir və tətbiq edilən maska ona dəfələrlə mane olur. Şizofreniya, xarici ilə daxilində gizlənən arasındakı əlaqənin olmaması, tez-tez nevroitik münaqişələrin səbəbinə çevrilir.

Təkrarlama yolu ilə əksər qərarlar avtomatlaşdırılır, yəni şüuraltı olaraq qəbul edilir. Avtomatlaşdırılmış davranış və təcrübələrin müəyyən nümunələri kök salmış şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə çevrilir. Məsələn, müxtəlif təcrübələr nəticəsində kimsə

daim aqressiv reaksiya verə və ya çətin vəziyyətlərdən qaça bilər, günahkarlıq və ya kin hisslərindən əziyyət çəkə bilər və s. Bu reaksiyalar başqaları və

insanın özü üçün xoşagəlməz olur. Onlar artıq müəyyən bir vəziyyətdə məhz bu davranışın seçiminin nə vaxt və necə yarandığını xatırlamırlar; qərar şüurdan kənarda yarandı.

Psixoterapiya zamanı xəstə bu

reaksiyaların necə inkişaf etdiyini və bu xüsusi davranış və təcrübə formasının niyə yarandığını xatırlaya bilər.

Şüuraltı bir hərəkətə çevrilmiş bir şeyi avtomatlaşdırma yolu ilə bərpa etmək

yenidən şüurlu bir hərəkətlə bağlı qərar qəbul etmə prosesinə gətirib çıxara bilər. Buna terapevtik regressiya deyilə bilər, çünki

bu, xəstənin həyatının müəyyən bir davranış və təcrübə modelinin ortaya çıxdığı dövrə qayıtmağı əhatə edir. Bu, ən azı müəyyən dərəcədə,

müəyyən bir fəaliyyətlə əlaqəli emosional gərginlikdən asılı olaraq,

qərarın yenidən nəzərdən keçirilməsinə və fərqli bir təcrübə formasının seçilməsinə

səbəb olur. Yalnız şüur sahəsində qalan şeylərə təsir etmək olar; Avtomatlaşdırılmış və muxtar hərəkətlər şüurlu qərar və ya – başqa sözlə – azad iradə çərçivəsindən kənardır.

Psixoterapevtik proses azad seçim dairəsini genişləndirməlidir. Bu, bir qədər narahatedicidir, çünki azad seçim təcrübəsi sahəsi genişləndikcə narahatlıq artır. Hər bir şüurlu qərar tərəddüd və narahatlıq hissi ilə əlaqələndirilir. Xəstə üçün psixoterapevtik proses yalnız xoş bir seans deyil; böyük səy tələb edir. Biz "transfer" nevrozundan, yəni psixoterapevtik prosesin özündən qaynaqlanan nevrozdan danışırıq və bu spesifik nevrozun səbəblərindən biri əvvəllər aydın olmayan, avtomatlaşdırılmış qərarların fərqiində olmaqdır.

Repressiya

Psixoanalitiklər bilinçaltının məzmununu öyrənərkən əsasən ona nəyin daxil edildiyinə diqqət yetirirlər, çünki bu, eqonun, yəni şüurun düzgün işləməsinə təhdid edir. Bilinçaltıya repressiya və ya repressiya müdafiə mexanizmi kimi xidmət edir, bu mexanizmlə şüur özünü təhlükəli olan hər şeydən, özünəinam hissini təhdid edən hər şeydən, özünəinamını gizlədən hər şeydən qoruyur.

Nəhayət, bu, şüurlu proseslərin integrasiyasını təhdid edir. Beləliklə, məsələn, sevilən birinə qarşı nifrət hissləri bilinçaltına yeridilir, çünki onlar insanın öz imicinə yönəldilir və şüurlu emosional vəziyyətlərin integrasiyasını təhdid edir.

Bu cür basdırılmış təcrübə və davranış formaları şizofreniyada ən çox özünü göstərir. Xəstələr ətrafdakıları bununla təəccübləndirirlər. Şizofrenik parçalanma, basdırılmanın həqiqətən vacib bir müdafiə mexanizmi olduğunun ən yaxşı sübutudur.

Freyd, basdırılmanın bəzən yuxularda və səhv hərəkətlərdə necə təzahür etdiyini nümayiş etdirdi. Yuxuların tez-tez unudulması şüuru yuxularda aşkar edilən məzmunun dağıdıcı təsirlərindən qoruyur. Psixoterapiyada, xüsusən də psixoanalitik göstərişlər üçün aparıldıqda, terapevt, şüurun xaricində olduqları üçün şüurlu proseslərdən daha böyük bir nevroitik qüvvəyə sahib olduqları düzgün fərziyyəsinə əsaslanaraq, bu basdırılmış zehni əhval-ruhiyyələri aşkar etməyə çalışır. Bu, özünüidarəetmə sistemi ilə şüursuz proseslərin muxtariyyətindən irəli gəlir. Onlarda şüurlu proseslərdə mövcud olan seçim azadlığı yoxdur. Onlar yalnız tam şüurun işığına çıxarıldıqda zəiflədilər bilən Yunan faciəsinin anankesini ehtiva edir.

Digər tərəfdən, bilinçaltında gizlənmiş hər şeyin fərqiində olmaq şüurlu proseslərin (eqo funksiyalarının) integrasiyasını təhdid edir. Buna görə də, psixoterapiyada xəstəyə qarşı müvafiq emosional münasibət vacibdir. Xəstə, hətta bütün şüurunun təzyiqli təhlükə hissi ilə örtüldüyü hallarda belə, terapevtinin yanında özünü təhlükəsiz hiss etməlidir. Psixiatrın niyə hakim kimi çıxış edə bilmədiyini aydın olur. O, xəstənin ləyaqət və səlahiyyət hissini daim gücləndirməlidir və beləliklə, həkim psixoterapiya zamanı yaranan dağıdıcı amillərə qarşı mübarizə aparır.

// XƏSTƏDƏ DƏYİŞİKLİK. QƏRAR PROSESİNİN YENİDƏN QURULMASI

Psixoterapiya xəstədə dəyişiklik üçün çalışır. Özlərinə və başqalarına əzab verməyi dayandırmaq üçün onların daxilində bir şey dəyişməlidir. Lakin, yaxşılıq mükafatlandırmaq və pisləri qınamaq şəklində birbaşa təzyiq tətbiq etmək olmaz. Xəstə nə qədər çox tələbkardırsa, bu tələblərə bir o qədər az əməl edir; xəstə şüurlu və ya şüursuz şəkildə özünü müdafiə edir və müqavimət göstərir.

Bu, iktidarsızlıq və ya yuxusuzluq hallarına bənzəyir: insan nə qədər çox istəsə, bir o qədər az şeyə nail ola bilər. Burada da muxtariyyət qaydası göz qabağındadır. Başqa bir insana təsir etmək

yalnız öz daxilində dəyişiklik yolu ilə baş verə bilər. Psixoterapevtik

hərəkət halında, insanın öz qərarı xəstəyə ötürülə bilməz; onlar bunu özləri etməlidirlər.

Psixoterapiyaya qərar prosesinin yenidən qurulması kimi baxaraq, onun daxilində

üç sahəni ayırd edə bilərik: şüurlu funksional strukturlar sahəsi, avtomatlaşdırılmış

funksional strukturlar sahəsi və basdırılmış funksional strukturlar sahəsi.

Hər şüurlu qərarla,

iki potensial, lakin əks funksional

struktur arasında seçim ilə əlaqəli bir qeyri-müəyyənlik anı yaranır. Hər ikisi potensial strukturlardır; seçim anından etibarən biri

qəbul edilir, digəri isə rədd edilir.

Atılan qərar müəyyən bir müddət şüurda qalır və tez-tez narahatlıq mənbəyinə çevrilir. Bu qərar müsbət qiymətləndirilə bilər və sonra xəstə məhz bu şəkildə hərəkət etmədiyinə, atdığı şeyi seçmədiyinə görə peşman olur. Bəzən bu qərar pis bir qərara çevrilə bilər və sonra xəstə səhv və layiq olmayan bir şey düşündüyünə görə özünü günahlandırır. Qərar, iki ehtimaldan biri müəyyən bir fəaliyyət şəklinə reallaşdığı, digəri isə daxili olaraq qaldığı və nəticədə həyata keçirilməsi nəticəsində ətraf aləmin bir hissəsinə çevrildəndən daha şəxsi və intim kimi qiymətləndirildiyi bir andır. Həkimlə söhbət xəstəyə bu atılan ehtimal haqqında danışmaq imkanı verir. Söhbət müəyyən bir fəaliyyət forması kimi qəbul edilə bilər ki, bu da daxilində gizlənmiş hər şeyin üzə çıxmasına səbəb olur. Beləliklə, daxili və xarici, təcrübəli və icra edilən arasındakı dixotomiya azalır.

Avtomatlaşdırılmış funksional

strukturlar halında vəziyyət fərqlidir. İnsan qərar qəbul etmə anından xəbərsizdir.

Tez-tez təkrarlanma nəticəsində qərar qəbul etmə prosesi şüurdan kənarda baş verir. Buna baxmayaraq, bu qərarlar nevroitik təsir göstərə bilər, məsələn, kök salmış mənfi emosional əhval-ruhiyyələr ("kök salmış hisslər") halında. Psixoterapiya zamanı xəstə müəyyən bir qərar qəbul etmə prosesindən, bu təcrübə üsulunun baş verdiyindən xəbərdar olduqda, müvafiq qərarı şüurda saxlamaqla, avtomatlaşdırılmış və şüurdan kənarda qaldığından daha asan idarə edə və dəyişdirə bilərlər. Yalançı və kök salmış qərarın nəticələrindən qaynaqlanan nevrozlar, sanki psixoterapiyada qərarın özünün nevrozu, gücləndirilmiş və avtomatlaşdırılmış funksional strukturla mübarizə aparmaq və onu yeni və daha yaxşısı ilə əvəz etmək ehtiyacı ilə əvəz olunur, çünki bu, nevroitik nəticələr yaratmır.

Üçüncü fəaliyyət sahəsi repressiya olunmuş strukturlarla bağlıdır. Freydə görə, psixoanalitiklər şüurdan kənarda yerləşən repressiya olunmuş strukturları şüurlu strukturlardan daha dinamik hərəkətlər kimi düzgün qiymətləndirirlər. Şüurun aydın sahəsində həmişə yaşananlara müəyyən bir tənqidi yanaşma mövcuddur və buna görə də seçim etmək imkanı var. Şüurun qaranlıq sahəsində bu element yoxdur; insan baş verənlərdən təsirlənir və tam təsəvvür edilə bilməz. Burada seçim imkanı yoxdur; insan bilinçaltı funksional strukturların köləsinə çevrilir.

Eksperimental olaraq, funksional bilinçaltı strukturların gücü

hipnotikdən sonrakı əmərlərdən və ya alt hədd stimullarından istifadə etməklə nümayiş etdirilə bilər. Birinci halda, hipnozçunun hipnotik transda verdiyi əmr,

tam şüura qayıtdıqdan sonra yerinə yetirilir və əmr yerinə yetirən şəxs başqasının əmrini yerinə yetirdiyindən xəbərsizdir və bu fəaliyyətin öz iradəsi ilə yerinə yetirildiyinə əmindir. İkinci halda, alt hədd stimulları, şüura çatmasa da, qərar qəbul etməyə təsir göstərir (məsələn, televiziya ekranlarında şüurlu qavrayış üçün lazım olduğundan daha qısa müddətə göstərilən reklamlar, ənənəvi reklamlara nisbətən həyata keçirilməyə daha güclü təsir göstərir).

Basdırmaq haqlı olaraq patoloji müdafiə mexanizmi hesab olunur. Şüurlu şüur düzgün işləməyi təhdid edən travmatik təcrübədən azad olsa da, bilinçaltının qaranlıq aləmində eyni təcrübə eyni zamanda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şüurlu şəkildə qarşısı alına bilmədiyi üçün onun nevroitik təsiri xeyli güclüdür.

Klassik psixoanalizin əsas terapevtik elementi şüurlu fəaliyyətdə basdırılanların fərqləndirilməsidir.

// Xəstə Muxtariyyəti

Hər bir həkim xəstənin sağlamlığını yaxşılaşdırmağa çalışır. Hər bir psixoterapevt də bu istəyi nümayiş etdirir. Lakin, bu hərəkət çox birbaşa ola bilməz. Təklif olunan fəaliyyət forması tez-tez insanın öz formasına çevrilsə də (bu, təhsildə zəruri olan daxililəşmə prosesidir), psixoterapiyaya təhsil metodu kimi baxıla bilməz. Psixoterapiya ilə təhsil prosesi arasındakı əsas fərq digər şəxsin muhtariyyətinə xüsusi diqqət yetirməsindədir. Bu prinsip psixiatrların xəstələrə daha humanist yanaşmasından deyil, gündəlik peşəkar təcrübədən irəli gəlir ki, bu da öyrədir ki,

insanın başqa bir insanı dəyişdirmək istəməsi nə qədər çox olarsa, o qədər də uğurlu olmur;

ağrılı təzahürlər daha kəskinləşir, nevroitik emosional vəziyyətlər güclənir,

həkimə qarşı müqavimət artır. Davranışı dəyişdirmək qərarı insanın özünün qərarı olmalıdır, bəlkə də ona görə ki, digər şeylərlə yanaşı, burada xarici davranış formalarından deyil, xəstənin psixikasında kök salmış daha dərin, daha kök salmış problemlərdən danışırıq. Buna görə də, psixoterapiya problemi burada qərar qəbul etmə baxımından təqdim olunur, lakin bu, əlbəttə ki, yeganə perspektiv deyil və psixoterapiyaya başqa perspektivlərdən də baxmaq olar.

// DUYĞU ƏLAQƏSİ. TİBBİ FUNKSİYANIN GENESİSİ

Psixoterapiyanın mahiyyəti və forması ilə bağlı fərqli fikirlərə baxmayaraq, müəllifləri arasında xəstə ilə psixoterapevt arasında emosional əlaqənin əhəmiyyəti barədə ortaq bir anlayış mövcuddur.

Psixoterapevtik prosesin müddətindən asılı olmayaraq, istər xəstə ilə müntəzəm görüşlər, istərsə də müvəqqəti, təsadüfi təmaslar olsun, emosional əlaqənin gücü onun effektivliyi üçün çox vacibdir. Bu emosional element hər bir həkim-xəstə münasibətində mövcuddur, lakin psixoterapiyada müalicənin mahiyyətini təşkil edir.

Bu əlaqənin əhəmiyyətini anlamaq üçün iki insan - həkim və xəstə arasında spesifik təmasın genezisini anlamaq lazımdır. Şəxslərarası münasibətlərin bir çox formaları arasında bu əlaqə ən qədimdir. Ən sadə formasında müalicə funksiyası valideynlər, xüsusən də ana tərəfindən yerinə yetirilir. Analar uşaqlarına qayğı göstərir və mümkün olduqda onları müalicə edirlər.

Bu tip "həkim"ə - ana və ya ataya - heyvanlar aləmində də rast gəlmək olar.

Böyük sosial qruplar formalaşdıqca, sağalma funksiyası valideynlərdən yadlara keçdi. Sosial həyatın ibtidai formalarında başçı həkim və keşif funksiyalarını birləşdirirdi. O, qrup üzvlərini ölümdən və naməlumdan qoruyurdu. Lakin başçının sağlam insanlara ehtiyacı var idi və tezliklə başçı funksiyası keşif və həkim funksiyasından ayrıldı. Zamanla sonuncu funksiya da iki ayrı funksiyağa bölündü: biri fiziki sağlamlıqla, digəri isə ruhi sağlamlıqla bağlı idi. Bəşəriyyətdə zehni və somatik funksiyalar ayrıla bilməz və buna görə də həkimin funksiyası xəstənin ruhi vəziyyətinə qayğı göstərməkdə qalır.

// Etibar

Həkim rolunun inkişafına tarixi baxış bizə ən vacib elementin nə ola biləcəyini anlamağa imkan verir: etibar. Liderə etibar edilməlidir, ona inanılmalıdır, əks halda onun liderliyi yalnız uydurmadır, ənənəyə və ya

Güc. Lider, özünəinamın tükəndiyi anlarda, təhdid və təhlükə vəziyyətlərində xüsusilə ehtiyac duyur. Daha sonra, qorumağa və məsləhət verməyə qadir olan yaxın bir insana inam səfərbəredici qüvvə kimi çıxış edir; insan özünü məğlub edir və lideri izləyir. Lider, müəyyən bir vəziyyətdə həmfikir həmkarlarında çatışmayan integrativ qüvvələri təmsil edir. Daha çox şey edə bilən güclü birinə inam, xüsusilə çətin həyat vəziyyətlərində öz gizli potensialını kəşf etməyə və həyata keçirməyə imkan verir. Bu mənada, "iman möcüzələr yaradır", uğur üçün imkanlar açır, baxmayaraq ki, bu "sirdaş" həmişə həqiqi etibara layiq deyil.

Lider, daxili və xarici vəziyyətlər tərəfindən sıxışdırılan bir insanın daxilində mövcud integrativ meylləri cəlb edir. İmanı tapan bir insan daxili xaosdan çıxır; nizam və gələcəyi planlaşdırmaq qabiliyyəti onlara qayıdır. Öz növbəsində, ardıcıllarının inamları liderə integrasiyaedici təsir göstərir, ona özünəinam verir və planlarını aydın şəkildə formalaşdırmağa məcbur edir. Lider və onun davamçıları arasında qarşılıqlı ehtiyacın qapalı bir dairəsi yaranır:

lider davamçıları olmadan keçinə bilməz, onlar da lidersiz keçinə bilməzlər.

Lider, keşiş və həkim müxtəlif problemlərlə məşğuldurlar və buna görə də hər biri öz sahəsində fəaliyyət göstərir. Birincisi, fəaliyyət sahəsi sosial və siyasi həyat, ikincisi naməlumla təmas, üçüncüsü isə xəstəlik və ölüm təmasıdır. Hər biri öz "möminini" müəyyən bir təhlükədən qorumaqdır: lideri sosial və siyasi həyat təhlükəsindən,

keşisi varlığın sirri ilə qarşılaşma təhlükəsindən və həkimi xəstəlik və ölümdən.

Onların hər biri davamçılarından üstündür; onlar özlərini tanıyır və onlardan daha bacarıqlıdılar və hər şeydən əvvəl,

etibar edə biləcək insanları təmsil edirlər.

// Proyeksiya

Həkim və xəstə arasında inkişaf edən emosional əlaqələrdə "ata" elementi, ehtimal ki, ən əhəmiyyətlisidir. Bu, psixoterapevtik prosesə xas olan digər emosional əlaqələrə səbəb olur.

Psixoterapevtik proses insanın həyatının təhlilinə, mövcud təcrübələrin kəşimə təhlilinə və indiki ana qədər həyat tarixinin uzunmüddətli təhlilinə, eləcə də gələcəyə proyeksiyaya çevrilir. Belə təhlil eyni zamanda diaqnostik proses kimi xidmət edir. Özünü tədqiqat prosesi emosional təcrübələr olmadan baş vermir. Bu, sanki cari və ya keçmiş vəziyyətlərin təcrübəsi ilə əlaqəli bir sıra emosional boşalmaları əhatə edir. Bu boşalmalar rezonans doğurmalıdır. Transferensiya fenomeni buradan qaynaqlanır. Xəstə hisslərini psixoterapevtə çatdırır. Real həyatda tam şəkildə həyata keçirilməyən və ya hazırda həyata keçirilən emosional proseslər burada yenidən yaşana və tamamlana bilər.

Psixoterapevtə ürəyinizdəki hər şeyi ifadə edə bilərsiniz: həyat yoldaşınıza və ya müdirinizə qarşı qəzəb, həyatınızda çox kiçik olan bir ana və ya ataya qarşı sevgi hissi yaşaya bilərsiniz, mənfi həyat balansınız üçün bəraət axtara və ya sevmək ehtiyacınızı ödəyə bilərsiniz. Xəstənin əslində yaşadığı hisslərdən asılı olaraq, psixoterapevt surroqat, yəni həyatındakı real obrazı əks etdirən şəxsə çevrilir. Bu unikal

real insanın manekeni, keçmişdə və ya indiki zamanda kompleksin mərkəzinə çevrilmiş hisslərin oynanmasını asanlaşdırır. Psixoterapevti əvəzedici kimi görmək, onların "atalıq", qəbuledici roluna görə mümkündür.

təhlükəsizlik hissi yaratmaq. Psixoterapiya seansları zamanı psixoterapevt az danışır; xəstə onların şəxsi həyatını bilmir; onlar onlarla yalnız psixoterapiya görüşlərində görüşürlər. Psixoterapevt, müəyyən bir şəxsiyyətə malik birindən daha asan həyatındakı insanları təsvir edə bilən olduqca qeyri-müəyyən bir insandır.

Psixoterapevt istənilən anda xəstəyə kim kimi göründüklərini müəyyən etməlidir. Bu asan iş deyil, çünki xəstənin şəxsi həyatında müəyyən rol oynayan vacib fiqurlar haqqında məlumatlar çox vaxt qısaldılır.

Ata obrazı sevilən bir insanın obrazı və ya cinsi ideal ilə əlaqələndirilə bilər; anaya münasibət bütün qadınlara münasibəti əks etdirə bilər, ataya münasibət isə avtoritetə, rəqabətə və s. münasibət məsələlərini əks etdirə bilər. Emosional proyeksiyanın mürəkkəbliyi fərqli ola bilər və psixoterapevt bu proyeksiyanı qavramağı və onu təşkil etməyə çalışmalıdır. Nizam-intizam yaratmaq yalnız xəstənin psixikasını öyrənmək üçün deyil, həm də psixoterapevtik proses üçün vacibdir. Psixoterapevt xəstəyə emosional "materialını" təşkil etmək üçün öz metodunu təqdim etmir, lakin bu nizam bir şəkildə xəstəyə çatdırılır. Bəlkə də burada xəstənin daxili vəziyyəti, terapevt tərəfindən qəbul və anlaşma şüuru rol oynayır.

// Qəbul

Qəbul anı xəstənin emosional həyatının təşkilində çox vacibdir. Qəbul edildiyini hiss edən insan özünəinamını gücləndirir və özünə qarşı mənfi hissləri zəifləyir. Bu da öz növbəsində, emosional rəngləmənin homojenliyi qaydasına görə, başqalarına qarşı mənfi emosiyaların intensivliyini azaldır. Emosional problemlərə gəldikdə, xarici və daxili mühit arasındakı sərhəd kəskin deyil və hər iki tərəfdəki rəngləmə oxşardır. Daxili qaranlıq hiss etdiyimiz zaman ətrafımıza da hakim olur və ruhumuzda hər şey aydın və parlaq olduqda, dünya gözəl görünür. Öz-özünəinam müxtəlif emosiyaların və əhval-ruhiyyələrin daha asan qiymətləndirilməsi səbəbindən emosional quruluşumuzu əks etdirir. Emosional quruluşumuzu yaxşılaşdırmağın ən asan yolu avtoportretimizi yaxşılaşdırmaqdır.

Bu, kiminsə özünə qarşı müsbət emosiyalarını müəyyən etmək üçün bir üsuldur. Düzgün yerləşdirilmiş bir iltifatla əldə edilən yaxşılaşdırılmış rifah, mənfi emosional əhval-ruhiyyəni müsbətə dəyişə bilər. Uğur arzusu əsasən öz rifahını yaxşılaşdırmaq istəyindən irəli gəlir.

Uğur özümüzlə olan baxışımızı aydınlaşdırır və bu da daxili və xarici dünyalarımızın emosional quruluşuna müsbət təsir göstərir.

Əlbəttə ki, psixoterapiya xəstəyə tərif demək və ya həyat çətinliklərini yüngülləşdirmək demək deyil, lakin özünü qəbul etmək üçün əlverişli ümumi bir mühit yaradır. Əgər bunun sayəsində onların rifahı yaxşılaşarsa, xəstənin ətrafdakı dünyaya münasibəti avtomatik olaraq dəyişəcək. Mənfi emosiyaların azalması öz emosional reaksiyalarının və tənzimlənməsinin daha rəasional təhlilinə gətirib çıxarır.

// Şüur

Beləliklə, xəstə özünə müəyyən bir tənqidi baxışla baxmağa başlayır,

tədricən öz emosional reaksiyalarını, travmalarını və

komplekslərini anlamağa başlayır və öz psixiatrına çevrilir. Bəzən əsl psixiatr bu həvəskar psixiatra kömək etməlidir, lakin psixiatriyada bunu nəzərə alaraq...

Şüür yalnız fenomeni yaşamaqla mümkündür. Heç bir izahat xəstəyə öz təcrübələrini anlamağa kömək etməyəcək, əgər onlar müvafiq yerə düşməsələr, yəni öz izahlarını təqdim etməsələr. Xəstə bu izahlara özü gəlməlidir və psixiatr onlara onları konkret sözlərlə ifadə etməyə kömək edir. Delphic "gnothi seauton" ("özünü tanı") anlayışının insana həyat çətinliklərində nə dərəcədə kömək etdiyi məlum deyil. Əlbəttə ki, bu, şüurun aydın sahəsini genişləndirir; təşkilatlanma və müəyyən bir rasionallaşdırma yolu ilə hisslər əvvəlki dinamikasını itirir və bu dinamika naməlumun qaranlığında xeyli böyüyür.

Digər tərəfdən, hər şeyi şüurun aydın sahəsinə köçürmək mümkün deyil.

Sadə dillə desək, şüurun əhatə dairəsi məhduddur və şüurlu proseslərin düzgün getməsi üçün hazırlıq prosesləri şüurun astanasından aşağıda baş verməlidir. Əgər insan oxumaq və yazmaq kimi funksiyaları müşayiət edən fəaliyyətinin bütün təzahürlərindən xəbərdar olsaydı, heç vaxt yaza və ya oxuya bilməzdi, çünki şüurları oxumaq və yazmaq aktı ilə əlaqəli funksiyalarla dolu olardı və məzmun üçün yer qalmazdı. Və ya başqa bir nümunə: əgər kimsə tanışını salamlayaraq münasibətlərinin tarixini, bütün xoş və xoşagəlməz aspektlərini tam başa düşsəydi, isti əl uzatmaq əvəzinə, onu bir dəfə aşağı salıb yenidən uzadardı və son qərarı verə bilmirdi. Həm yazı, həm də salamlama aktı ilə əlaqəli funksional strukturlar mərkəzi sinir sistemində möhkəmlənmişdir. Yalnız davranışın son formasını müəyyən edən uzun proseslər zəncirinin son nəticəsi şüura nüfuz edir. Nevrastenik komplekslərdə, xüsusən də şizofreniyada, şüur sahəsi genişləndikdə, normalda şüurun astanasından aşağıda olmalı olan müəyyən funksional strukturlar ona nüfuz etdikdə nə baş verdiyini görmək olar. Nevrastenik simptom komplekslərində avtomatlaşdırma pozulduqca hətta ən kiçik fəaliyyət belə çətin və ağrılı olur. Normalda basdırılacaq fərdi elementlər şüura daxil olur. Xəstə sağlam olduqda şüuruna nüfuz etməyəcək müxtəlif xışıltılar və səslər eşidir və bir vaxtlar avtomatik olaraq yerinə yetirdiyi sadə hərəkətləri necə yerinə yetirəcəyini düşünür. Şizofreniyada normalda gizli emosional mexanizmlər ortaya çıxır. Əlimi kiməsə uzatsam, həmin şəxslə əlaqəli bütün xatirələr dərhal şüuruma daxil olmur; bu hərəkət bu təcrübələrin başlanğıc nöqtəsini təmsil edir. Şizofreniya xəstəsində emosional vəziyyətin bütün mürəkkəb mexanizmi ifşa olunur, ona görə də onlar əllərini uzadıb gizlədir, gülümsəyir və nifrətlə baxırlar.

Şüur sahəsinin genişlənməsi qeyri-müəyyənliyi və tərəddüdü artırır və beləliklə,

Dekart "cogito ergo cəm"i reallaşır ("cogito" sözü bu

tərəddüd və qeyri-müəyyənlik elementini ehtiva edir). Yalnız şüurda azad

seçim imkanı mövcuddur və buna görə də şübhə və qeyri-müəyyənlik yaranır. Dəfələrlə qeyd edildiyi kimi, əks-funksional strukturlar arasında seçim bütün sinir sisteminin fundamental

xarakteristikasıdır, lakin yalnız şüurlu seçim iradə aktı kimi qəbul edilir. Şüurun astanasından aşağıda baş verən bütün digər qərarlar heç bir şəkildə

qavranılmır və ya aktiv

təsir olmadan qalan reaksiyalar kimi qəbul edilir. Beləliklə, avtonom, avtomatlaşdırılmış funksiyalarımız,

emosional vəziyyətimiz və əhvalımız fəaliyyət göstərir. Psixoterapiya zamanı emosional təcrübələr üçün şüurun həddi sadəcə xəstənin nitqinin əsas mövzusu olduğuna görə aşağı düşür. Onlar diqqət mərkəzində olur və onları təhlil etməyə və mənşəyini kəşf etməyə çalışırlar. Öz emosional vəziyyətlərinin bu şəkildə dərk edilməsi onların dinamikasını zəiflədir və eyni zamanda müəyyən bir fürsət yaradır.

Onları idarə etmək.

// Katarsis - Təmizləmə

Psixoterapiyanın iki insan arasında tipik qarşılıqlı təsir xarakteri daşımaması, birinin hərəkətinin digərinin reaksiyası ilə dərhal qarşılanması, xəstənin yığılmış hisslərini ifadə etməsini asanlaşdırır. Psixiatrik tədqiqatlarda olduğu kimi, psixoterapiyada da terapevtin rolu alıcının rolu ilə müəyyən edilir. Xəstə müalicənin onun üçün müsbət olduğunu hiss edirsə, xəstənin başqa bir insanın reaksiyasını nəzərə almalı olduğu hallardan daha çox, hər şeyi ifadə etməsi daha asandır. Psixiatr özünü təmizləmək üçün bir növ azad, lakin qonaqpərvər bir məkan kimi çıxış edir.

Normal mühit fəaliyyətimizə müəyyən bir müqavimət təklif edir. Hərəkətlərimiz onların reaksiyaları ilə qarşılanır və bu da öz növbəsində fəaliyyətimizi dəyişdirir. Psixoterapevtin bu müqavimətinin olmaması xəstədə daha səmimi davranışı təşviq edir; onların ifadələri

sərbəst assosiasiyalar şəklində ola bilər və emosional reaksiyaları daha az

boğulacaq. Effektiv psixoterapiya zamanı xəstə tez-tez sanki yeni bir doğuş, bütün pisliklərin yuyulub getməsi kimi bir təmizlənmə hissi yaşayır. Bu, psixoterapevtik prosesin vacib bir təsiridir; xəstə üçün bu, hətta dramatik bir təcrübə, anlayış, yenidənqurma və s. ola bilər. Bu cür simptomların görünüşü xəstənin nevrotik dövrü pozduğunu və fərdi təkamül yoluna qədəm qoya biləcəyini göstərir. Belə bir "təmizlənməyə" (katarsis) nail olmaq üçün psixoterapevtik qarşılıqlı təsirlər üçün uyğun bir atmosfer yaratmaq lazımdır. Gərginliyin azaldılması onun vacib amillərindən biridir.

// BƏZİ TEXNİKİ QEYDLƏR Freyd psixoterapiyada gərginliyin azaldılmasının vacibliyinə diqqət çəkən ilk şəxs idi.

O, xəstənin terapevtlə müsahibə zamanı arxası üstə uzanmış vəziyyətdə qalmasını tələb etdi ki, bu da yuxuya getməzdən əvvəl baş verdiyi kimi, gərginliyin aradan qaldırılmasını və sərbəst assosiasiyalar şəklində düşüncə azadlığını asanlaşdırır. Məlum olduğu kimi, sərbəst assosiasiya metodu psixanalitik metodun mahiyyəti idi. Freydin istifadə etdiyi ilk hipnotik transu əvəz etdi.

Psixoterapevt xəstənin başında, gözdən uzaqda oturur və beləliklə, xəstə terapevtin üz ifadələrini, yəni insanlar arasındakı vacib və spesifik təması görmür. Psixoterapevtik təmasın yad təbiəti artıq tərəfdaşların öz mövqeyində özünü göstərir: biri uzanır, digəri oturur. Arxaya üstə durma, bəlkə də sərbəst əlaqəni asanlaşdırır, amma bu, həssas bir vəziyyətdir.

Oturan insanın hərəkət etmək üçün daha çox imkanları var. Unutmaq olmaz ki,

Freud psixiatrik məsələlərə toxunmazdan əvvəl yaxşı bir nevroloq idi.

Nevroloji müayinədə arxaya üstə durma başlanğıc nöqtəsidir və nevroloji müşahidəyə başlamaq daha asandır. Nevroloji müşahidə qeyri-adi dərəcədə dəqiqdir və hər bir əlamət vacibdir. Çox vaxt əhəmiyyətsiz və təcrübəsizlər üçün nəzərə çarpmayan bu əlamətlərdən sinir sisteminin strukturuna ziyan vurulması ilə bağlı bir fərziyyə qurulur. Freyd, ehtimal ki, ruhi xəstələr üzərində apardığı tədqiqatlarda nevroloji izini saxlamışdır. O, nevrologiyada müşahidələrə bənzər müşahidələr aparmağa çalışdı; hər kiçik fakt rol oynadı. Bəzən səhv hərəkətlər kimi kiçik detallar xəstəyə yeni işıq salır. Gündəlik həyat hadisələri tərəfindən adətən yaddaşdan tez silinən yuxular, gərginliyin azaldığı və aktiv hərəkətin (arxa üstə uzanma) mümkünsüzlüyü atmosferində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu spesifik vəziyyətdə yuxu ilə oyaqlıq arasındakı sərhəd

Vəziyyət qaralmağa başlayır.

Fəaliyyətin olmaması özünüdərk etməyə təşviq edir. Əgər xəstə həkimə etibar edirsə, adətən xaos və məntiqi quruluşla əlaqəsiz olan müşahidələr

öz-özünə atılır və başqa bir şəxsə adi qarşılıqlı əlaqədə adətən zəruri olan maskanı atır. Bu şəkildə müşahidə sahəsi genişlənir, xəstə sanki nevroloji müayinədə olduğu kimi ifşa olunur və bunun sayəsində normal şəraitdə (xəstə sözün həm sanki, həm də məcazi mənalarında "geyindirildikdə") görünməyən detallar görünür.

Freydin orijinal anlayışında bir psixoterapevt, nevroloq kimi, müşahidə mövqeyi tuturdu. Müşahidə edilən simptomlardan o, psixikanın quruluşuna mümkün zərər anlayışını inkişaf etdirdi. Freyd özü tezliklə psixoterapiyada neytral müşahidəçi mövqeyini qorumağın mümkün olmadığına və bu prosesdə ən vacib şeyin həkimlə xəstə arasında emosional əlaqə olduğuna əmin oldu. Stek Sallivan, fenomenin axışını pozmadan müşahidənin sadəcə uydurma olaraq qaldığına əsaslanaraq, psixoterapevtin xəstə ilə münasibətini "iştirakçı müşahidəçi" münasibəti kimi təyin etdi. O, xəstənin klassik arxası üstə uzanma mövqeyindən uzaqlaşaraq, bunu bərabərsizlik mövqeyi hesab etdi. Belə bir vəziyyətdə psixoterapevt "xəstənin üstündədir" və xəstə müdafiəsizdir. Sallivan psixoterapevtik qarşılaşmada hər iki tərəfdaşa bərabər baxılmalı olduğuna və bu bərabərliyin hər şeydə, ən əsası isə müayinə zamanı tutduqları mövqedə özünü göstərməli olduğuna inanırdı. Hər iki tərəfdaş bir-birinin qarşısında deyil, bir az yan tərəfdə oturlar. Bu mövqe ən təbiidir və bu baxımdan, yaqin ki, arxası üstə uzanma mövqeyindən daha yaxşıdır.

Psixoterapiya ilə baqlı dərslilər və məqalələr məsələnin texniki aspektlərinə çox yer ayırır: söhbətə necə başlamaq, psixoterapiyanı necə və nə vaxt bitirmək, fiziki müayinənin aparılması mümkün olub-olmaması, transfer fenomenlərini necə idarə etmək, xəstənin müqavimətini necə azaltmaq və s. Əgər psixiatr özü ola bilmirsə, hətta ən yaxşı texnika belə faydasız olacaq. Təbiilik psixoterapiyanın əsas tələbidir.

Bu işdə dəfələrlə qeyd edildiyi kimi, ruhi xəstə olan insan vəziyyətdəki hər hansı bir süniliyi səhsiz hiss edir.

Bir çox psixoterapevt psixoterapiyanın bütün fiziki müayinə və müalicə metodlarını istisna etdiyinə inanır, yəni psixoterapiya aparən həkim xəstəni fiziki olaraq müayinə edə və ya dərman təyin edə bilməz. Əgər psixoterapevt həkimdirsə, əlbəttə ki, həkim olaraq qalmalı və fəaliyyətlərini xəstənin həyatının yalnız bir aspekti, yəni zehni həyatı ilə məhdudlaşdırmamalıdır. Psixoterapevt həmişə tibbdə bu qədər vacib olan psixofiziki birliyi xatırlamalıdır.

Xəstə müalicə olunmaq istəyir. Cəmiyyətin, xüsusən də Polşanın nəzərində müalicə anlayışı fiziki müayinə və dərmanların təyin edilməsi ilə əlaqələndirilir. Çox vaxt olur ki, çox saat həsr olunmuş bir xəstə həkimin fiziki müayinə aparmadığı və dərman təyin etmədiyi üçün heç bir müayinə və ya müalicə olunmadığından şikayətlənir. Nevrotik simptomlar tez-tez somatik xəstəliklərin, çox vaxt ciddi xəstəliklərin xəbərcisidir. Xəstənin hərtərəfli müayinəsi həkimə özünəinam və somatik xəstəliyi istisna etmək və psevdonevroz deyil, nevroz diaqnozunu təsdiqləmək imkanı verir. Əlbəttə ki, başqa, bəlkə də daha təcrübəli mütəxəssislərin müayinələrinin nəticələrinə etibar etmək olar, amma psixoterapevtin xəstəni yenidən müayinə etməsi heç kimə zərər verməz.

Hazırda farmakoloqlar üçün mövcud olan zəngin dərman arsenalından - stressi azaldan, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran və vegetativ disfunksiyanı və əlaqəli ağrıları aradan qaldıran dərmanlardan - sadəcə psixoterapiyanın digər müalicə üsulları ilə "çirklənməməsi" səbəbindən imtina etmək olmaz. Bu vəziyyət öz müalicə metoduna həddindən artıq güvənmək kimi qəbul edilə bilər. Psixiatriyada müalicə psixiatrik diaqnostika ilə eyni çərçivəyə düşən bir çox amillərdən və buna görə də bioloji, psixoloji və sosioloji amillərdən ibarətdir. Müalicə metodları

əlaqəli şəkildə tətbiq olunmalıdır.

FARMAKOTERAPİYA

// DƏRMAN QIYMƏTLƏNDİRMƏSİ

Təxminən bu əsrin ortalarından bəri psixofarmakoterapiya sürətli inkişaf dövrü yaşamışdır. Əczaçılıq sənayesi antibiotiklərlə yanaşı, ən zəngin gəlir mənbəyini təşkil edən psixotrop dərmanların istehsalına diqqət yetirir. Hər il bazara bir neçə yüz yeni psixotrapevtik agent çıxarılır. Hətta bir mütəxəssis belə onların adlarını oxuya bilmir, təsirlərini isə oxuya bilmir. Fərdi dərmanların effektivliyinə həsr olunmuş çoxsaylı tədqiqatlar daim dərc olunur. Kapitalist ölkələrində bu tədqiqatlar tez-tez əczaçılıq şirkətləri tərəfindən maliyyələşdirilir ki, bu da nəticələrin şərhində şüurlu deyilsə, bilinçaltı motivasiyaya təsir göstərir. Onlar müxtəlif elmi metodlardan, məsələn, nəzarət qruplarından, yəni öyrənilən dərmanla eyni dad və qoxuya malik plasebo (neytral dərman) qəbulundan, nəticələrin statistik təhlilindən və s. istifadə edirlər. Bu metodlara baxmayaraq, gündəlik müşahidələr həmişə dərman qiymətləndirmələrinin elmi nəticələrini təsdiqləmir. Effektivliyinin çox yüksək elmi qiymətləndirmələrinə malik dərmanlar orta və ya sadəcə zərərli olur. Psixiatriyada hər hansı bir müalicə formasının effektivliyini qiymətləndirmək çox mürəkkəbdir, çünki xəstənin zehni vəziyyətinə müsbət və ya mənfi təsir göstərən çoxsaylı amillər mövcuddur. Səbəb-nəticə əlaqələrinin müşahidələri təcrid olunmuş sistemlərin, yəni yalnız bir amilin müəyyən bir sistemə təsir etdiyi, digər amillərin təsirlərinin isə istisna edildiyi və ya yaxşı məlum olduğu sistemlərin yaradılmasını tələb edir.

Belə bir modelin psixiatrik tədqiqatlarda istifadəsi mümkün deyil. İnsana təsir edən müxtəlif amilləri istisna etmək mümkün deyil və onların təsirləri, əksər hallarda, öyrənilən amilin təsiri qədər məlum deyil.

Həkimlərin və xəstələrin elmi və praktik qiymətləndirmələri arasında tez-tez rast gəlinən uyğunsuzluqlar, ən azı müəyyən dərəcədə, bu modelin psixiatrik tədqiqatlar üçün uyğunsuzluğundan qaynaqlana bilər. Bir qayda olaraq, yeni bir psixotrop dərman praktik həkimlərin əksəriyyəti tərəfindən tez bir zamanda qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmə, müəyyən bir dərman qəbul edən xəstələrin klinik müşahidələrinə əsaslanır. Bu müşahidələr tələb olunan elmi meyarlara cavab verməsə də, xəstəyə təsir edən müxtəlif amilləri nəzərə alaraq vahiddir. Beləliklə, praktik həkim öz təcrübəsinə əsaslanaraq hər bir halda dərman kimi əlavə bir amilin təsirini nəzərdən keçirə bilər.

Və müəyyən bir xəstə qrupunun müşahidələrinə əsaslanaraq, dərmanın effektivliyini müstəqil olaraq qiymətləndirə bilər. Əlbəttə ki, dərmanın effektivliyini qiymətləndirməyin bu köhnə və elmi olmayan metodu müxtəlif irrasional fərziyyələrdən azad deyil.

Qərəzlər və ya həvəslər, intuitiv qiymətləndirmələr və s. Lakin, ümumilikdə, bu metod sözdə elmi metodlardan daha etibarlıdır.

Uzun müddət müxtəlif farmakoloji dərmanlar qəbul edən xəstələr var ki, bu da bugünkü narkotik asılılığında nadir hal deyil.

Belə hallarda, müəyyən bir müddət ərzində onların istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ya tamamilə dayandırmaq, onu psixoterapevtik və ya sosioterapevtik müdaxilələrlə məhdudlaşdırmaq lazımdır.

Psixoterapiya ilə bağlı şərtləri ümumiləşdirmək üçün demək olar ki, bu, həkim-xəstə münasibətlərinin ayrılmaz hissəsini təşkil edir, xəstə ilə görüşən hər bir həkim, xüsusən də psixiatr psixoterapevt olmalıdır və psixiatriyada diaqnostik proses psixoterapevtik prosesdən ayrıla bilməz. Psixoterapiyanın müxtəlif metodları mövcuddur, lakin onlardan ən vacibi həkimin xəstəyə uyğun münasibətidir.

// HƏYƏCANLANDIRMA VƏ İNHİBAT

Müasir psixiatrik farmakologiya mərkəzi sinir sisteminin funksiyalarına yeni işıq salmışdır. Neyrokimya və neyrofiziologiya ilə birlikdə, bu, ali sinir fəaliyyəti haqqında biliklərimizin təməlini təşkil edir. Böyük tədqiqat söylərinə baxmayaraq, bu biliklər hələ də qeyri-kafi və xaotik olaraq qalır.

Mümkün işçi fərziyyəni belə formalaşdırmaq çətindir. İndiyə qədər yalnız Pavlovun sinir sisteminin və onun fəaliyyətini həm aşağı, həm də daha yüksək səviyyələrdə həyəcanlanma və inhibə proseslərinə bölməsi təsdiqlənib. Müəyyən

kimyəvi maddələr neyronun hüceyrə membranına depolyarizasiyaedici şəkildə təsir göstərir (yəni, onlar onun xarici və daxili səthləri arasındakı elektrik potensial fərqi azaldır və bununla da keçiriciliyini artırır), beləliklə, sinir impulsunun yaranmasını və neyronun neyrona ötürülməsini asanlaşdırır. Digər maddələr neyronun hüceyrə membranının hiperpolarizasiyasına səbəb olur (yəni, hüceyrə membranının xarici və daxili səthləri arasındakı potensial fərqi artırır və bununla da keçiriciliyini azaldır), sinir impulslarının yaranmasını və keçirilməsini maneə törədir.

Sinir sisteminin ümumi fəaliyyətinə gəldikdə isə, həyəcanverici və inhibəedici maddələrə də bölünür. Birincilər əhval-ruhiyyəni və ümumi canlılığı yaxşılaşdırır, ikincilər isə inhibəedici təsir göstərir. Canlılıq azalır (bu dərmanlar enerji mübadiləsini azaldır və buna görə də qış yuxusu üçün istifadə olunur), zehni proseslər daralır, ağrı qavrayışı azalır, ağrılı münaqişələr uzaqlaşır və motor fəaliyyəti, xüsusən də əsas motor bacarıqları (bədənin mövqeyi və emosional ifadə ilə əlaqəli) azalır və Parkinson simptomlarının yaranmasına səbəb olur.

Bəzi müəlliflər psixotrop dərmanların bu həyəcanverici və inhibəedici təsirini aşağıdakı kimi izah etməyə çalışırlar. Onların əsas təsir sahəsinin beyin kötüyü və diensefalonun retikulyar formalaşması olduğuna inanılır. Bu sistem beyin qabığına aktivləşdirici təsir göstərir və beləliklə, şüurun vəziyyətini tənzimləyir. Bir psixotrop dərman (lucidryl, santrophenaxine) şüurun vəziyyətinə nəzərəcarpacaq dərəcədə təsir göstərir (koma və yuxulu vəziyyətlərdə istifadə olunur), müəlliflər bunu eyni sistemin aşağı bölgələrinə təsirinə aid edirlər.

// DİAQNOZ VƏ MÜALİCƏ

Somatik tibbdə müalicə məsələsi diaqnozla sıx bağlıdır. Düzgün diaqnoz qoyulmadan səbəbli müalicəyə başlamaq mümkün deyil. Səhv diaqnoza əsaslanan müalicə, məsələn, appendisit dispepsiya kimi müalicə edildikdə, dönməz nəticələrə səbəb ola bilər. Psixiatriyada diaqnoz məsələsi, ən azı müasir formasında, müalicənin planlaşdırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir. Nozoloji diaqnozdan daha çox dominant simptomlara diqqət yetirilir.

Əsas xəstəlikdən - endogen depressiya, şizofreniya və ya üzvi psixozdan asılı olmayaraq, fobiya üstünlük təşkil etdikdə, onları azaltmaq üçün dərmanlar verilir. Depressiv əhval-ruhiyyənin simptomları nəzərə çarpırsa, nozoloji diaqnozdan asılı olmayaraq, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran dərmanlar təyin olunur. Bulanıq şüur hallarında, əsas səbəbindən asılı olmayaraq, Lucidril tətbiq olunur. Eyni şey psixiatriyada digər somatik müalicə üsullarına (elektrik stimulyasiyası terapiyası, komatik və ya subkomatik insulin müalicəsi) və hətta psixoterapiyaya da aiddir.

// PSIXOTROP DƏRMANLARININ TƏSNİFATLARI

Xəstənin zehni vəziyyətinə təsirindən asılı olaraq, psixotrop dərmanlar bir neçə qrupa bölünür.

1. Antipsixotiklər narahatlığı və psixomotor oyanıqlığı azaldır,

katatonik stupor kimi motor geriliyinə və ekstremal hallarda

Parkinsonizmə (largaktil və ya xlorpromazin, nozinan, trilafon və güclü mazheptil və haloperidol) səbəb olur.

2. Oxşar şəkildə, lakin daha az dərəcədə təsir göstərən ataraksik dərmanlar

əsasən nevrozlar üçün istifadə olunur, çünki onlar narahatlığı və əlaqəli avtonom disfunksiyanı (elenium, meproamat, valium, ataraks) azaldır.

3. Timoleptiklər əhval-ruhiyyəni qaldıran dərmanlardır (tofranil və ya melipramin və sözdə MAO inhibitorları (monoamin oksidaza, serotonin və katexol aminləri, məsələn, adrenalin və norepinefrin) və buna görə də sinir sisteminin funksiyasına həyəcandırıcı təsir göstərir. MAO inhibitorları (nialamid, nuredal) nəzəri mənada depressiv simptomları azaltmağa yönəlsələr də, praktikada uğursuz olublar və tofranildən çox geridə qalıblar. Onlar ağrı sindromlarında və zehni gerilikdə daha geniş istifadə tapıblar.

MAO inhibitorlarının tofranil ilə birlikdə istifadə edilməməli olduğunu xatırlamaq vacibdir, çünki onlar zəhərli təsirlərə səbəb ola bilər və bu müalicə ilə ölüm halları bildirilib.

Bütün psixotrop dərmanlar alkoqol və narkotik maddələrin təsirini artırır və buna görə də, müalicə zamanı, hətta az miqdarda dərman və alkoqol qəbul edərkən belə, xəstəni alkoqol içməyin potensial təhlükəsi barədə həmişə xəbərdar etmək lazımdır. Bu müalicə zamanı alkoqol istehlakından sonra ölüm halları bildirilib.

4. Disleptiklər, yəni halüsinogen narkotiklər (LSD, psilosibin), informasiya mübadiləsinin strukturunu dəyişdirən və nəticədə özünün və ətraf aləmin qavranılmasının dəyişməsinə səbəb olan maddələr. Bəziləri minimal dozalarda (qramın milyonda biri qədər) təsirli olur. Əksər hallarda vizual halüsinasiyalar əvvəlcə yalnız gözlər bağlı olduqda görünür; daha güclü dozada isə illüziyalar və halüsinasiyalar gözlər açıq olduqda görünür. Tez-tez bir fenomen baş verir

Bədən və ətraf mühit sxemindəki pozğunluqlar, müxtəlif duyğu pozğunluqlarının birləşməsi; məsələn, eşitmə stimulları eyni zamanda vizual və ya toxunma pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Bəzi subyektlərdə özünüdərkdə və ətraf aləmdə bu dəyişiklik, xəyalpərəst əhval-ruhiyyə ilə birlikdə zehni tükənmə və təhlükə hissi yaradır, digərlərində isə ekstazla sərhəddə olan coşğunluğa səbəb olur. Əksər psixiatrlar disleptiklərin müalicədə istifadə edilməməli olduğuna inanırlar, çünki onların təsiri altında şizofreniya inkişaf riski var (bu cür hallar təsvir edilmişdir). Lakin bəzi psixiatrlar onları psixoterapiyada əlavə kimi istifadə edirlər. Bu dərmanların yaratdığı müəyyən təcrübələr xəstəyə özünə yeni bir baxış bucağı verir və ətraf mühitə və onlarla münasibətlərinə fərqli baxmağa imkan verir.

// FARMAKOMANIYA

Psixotrop dərmanların ən böyük təhlükəsi, şübhəsiz ki, asılılıqla sərhəddə olan vərdişli istifadəsidir. Bir həblə xoşagəlməz ruhi pozğunluqları aradan qaldıra və bir müddət demək olar ki, xoşbəxt hiss edə biləcəyinizin dərk edilməsi, müqavimət göstərmək çətin olan böyük bir cazibədir. Bir çox insan nevroitik narahatlığı azaltmaq və rifahını yaxşılaşdırmaq üçün illərlə müxtəlif növ ataraktik və neyroleptik dərmanlar qəbul edir. Belə bir vəziyyətdə "möcüzəvi müalicənin" olmamasından ikinci dərəcəli qorxu yaranır. Bu olmadan xəstə özünü etibarsız hiss edir, narahatlıq keçirir və bütün bunlar sakitləşdirici və ya stimullaşdırıcı həb olmadan yaşaya bilməyəcəklərini anlamağa gətirib çıxarır. Kapitalist ölkələrdə, xüsusən də gənclər arasında disleptik istismar ciddi bir sosial problemə çevrilib. Bu dərmanlar insanın reallıqdan qaçmasına və qeyri-adi təcrübələr dünyasına aparılmasına imkan verir.

// PSIXOTERAPIYA VƏ ƏCZAXANA TERAPIYASI

Bir çox psixoterapevt psixoterapiyanın psixotrop dərmanların istifadəsini istisna etdiyinə inanır. Onların fikrincə, dərmanların istifadəsi psixoterapevtik münasibətlərdə hər iki tərəfdaşı kimyəvi vasitələrə müraciət etdikdə alçaldır. Bu fikir xəstə uzun müddətdir dərman qəbul edirsə və tədricən onların köləsinə çevrilibsə, doğrudur. Digər tərəfdən, xəstəyə psixotrop dərmanlar lazım olduqda, onlardan imtina etmək olmaz, çünki onlar narahatlığı azalda, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır və vegetativ disfunksiyanı yüngülləşdirə bilər. Eyni nəticənin əhəmiyyətli dərəcədə az səylə və dərmanların verilməsi ilə daha yüksək effektivliklə əldə edilə biləcəyi hallarda, təkcə psixoterapiyanın istifadəsi, görünür, psixoterapevtik imkanların həddindən artıq qiymətləndirilməsindən irəli gəlir. Bəzən psixoterapevtlər müalicəni yalnız öz müdaxilələri ilə məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Bu arada, xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşmasına nəyin səbəb olduğu tamamilə məlum deyil. Etiologiya kimi müalicə də çoxfaktorludur. Psixoterapevtik müdaxilə, bəlkə də digər üsullar arasında, müalicədə şərəfli yer tutur, lakin psixiatriyada yeganə müalicə üsulu deyil.

SOMATİK MÜALİCƏNİN DİGƏR METODLARI

// Giriş

Nevrozlar üçün digər somatik müalicə üsullarına insulin terapiyası, elektrik stimulyasiyası və ümumi tonik dərmanların istifadəsi daxildir.

Hidroterapiya, masaj və gimnastika.

Subkomatoz insulin terapiyası (xəstənin qan şəkərinin aşağı olması səbəbindən əlaqədarlıq vəziyyətində olması, lakin tamamilə huşunu itirməməsi; əlaqəli vegetativ pozğunluqlar, əsasən çox tərləmə) baş ağrısı, iştahsızlıq və yuxusuzluq kimi davamlı vegetativ pozğunluqlarla uzunmüddətli nevrozlarda təsirli ola bilər. Bəzən müalicəyə ən davamlı olan obsesif-kompulsiv pozğunluqda yaxşılaşma müşahidə olunur.

İnsulin koması (insulin terapiyasının komatik forması) və yüksək dozada antipsixotiklər kimi elektrostimullaşdırma qəhrəmanlıq müalicəsi hesab olunur və əsas psixiatriya üçün nəzərdə tutulub. Əgər dominant simptom depressiv əhval-ruhiyyədirsə, dərmanlara davamlıdırsa, elektroşok yaxşılaşma gətirə bilər.

Vitaminlər, biostimin inyeksiyaları, opotonin, C vitamini ilə qlükoza və s. şəklində ümumi toniklər nevrozların müalicəsində olduqca geniş istifadə olunur.

Əlbəttə ki, onlar müəyyən gücləndirici təsirə malikdir, lakin daha çox təklifedici təsir göstərir.

Onların sayəsində xəstə özünü sağalmış hiss edir (cəmiyyətimizin bəzi dairələrində iynələrə inam hələ də kifayət qədər güclüdür!) və həkim nevrotik simptomlarla mübarizə aparmaqda acizlikləri nəticəsində onlarda oyanan narahatlığı sakitləşdirir.

Hidroterapiya bu gün bəlkə də səhv qiymətləndirilən nevrozların müalicəsinin ən qədim üsullarından biridir. Hidroterapiya sinir sisteminə, xüsusən də baş ağrısı və ürək ağrısı, paresteziya, barmaqlarda və ayaq barmaqlarında soyuqluq hissi və s. yaradan vazomotor pozğunluqlara müsbət təsir göstərir.

Bundan əlavə, xəstəyə səfərbəredici təsir göstərir, nevrastenik yorğunluğu azaldır.

Elektrikləşmə kimi masaj və fizioterapiya prosedurları isterik pozğunluqlar, yazıçı qıcolmaları və digər funksional hərəkət pozğunluqları üçün göstərilir. Konversiya hallarında pozulmuş funksiyaya diqqət yetirmək yolverilməz olsa da, müəyyən prosedurlar zəruridir, çünki xəstə heç kimin ona kömək etmək istəmədiyini hiss edir və əzabları ciddi qəbul edilmir.

Ümumi masaj və idman xəstənin ümumi rifahında müsbət nəticələr verir, fiziki gücünə inam yaradır və vegetativ disfunksiyanı azaldır.

Ekskursiyalar mühüm rol oynayır. Xəstə, hətta qısa müddətə olsa belə, ətraf mühitdən təcrid olunur və müxtəlif münasibətlərə uzaqdan fərqli bir perspektivdən baxa bilir ki, bu da təbiətlə qarşılıqlı əlaqədə olarkən həmişə baş verir. Bundan əlavə, ekskursiyalar fiziki və zehni rifaha müsbət təsir göstərir. Daha çətin ekskursiyalar və idmanla əlaqəli səylər də gizli aqressiyanı aradan qaldırmaqla işləyir. Mənfi hisslərlə əlaqəli vegetativ və endokrin sistemlərin səfərbər edilməsi bu halda müsbət mənada istifadə olunur.

// SOSIOTERAPIYA. XƏSTƏXANA ATMOSFERASI

Üçüncü terapevtik ölçü sosioterapiyadır. Terapevtik mühit təkcə ruhi xəstəliklərin deyil, həm də somatik xəstəliklərin müalicəsində mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, bəzi xəstəxanalar eyni vəziyyətlərə baxmayaraq, xəstələri digərlərindən daha yaxşı müalicə edirlər.

terapevtik üsullar və bəlkə də nəticədə istənilən nəticələrə nail ola bilmədikləri xəstəxanalarda daha da yaxşıdır. Müalicədə həlledici amil xəstənin terapiya zamanı rifahıdır ki, bu da müəyyən edilməmiş bir amildən, yəni müəyyən bir xəstəxananın sözdə "atmosferi" və ya "iqlimi"ndən asılıdır. Gündəlik təcrübədən bilir ki, insanın özünü yaxşı hiss etdiyi və könüllü olaraq onlara qayıtdığı, bəzi yerlərdə isə özünü pis hiss etdiyi və onlardan qaçdığı yerlər var.

Bəzən insanlar müəyyən bir yerdə dəyişirlər, amma iqlim qalır; biz həmin qurumu təşkil edən insanlardan daha sabit olan "dahi" lokusdan danışırıq.

Sosioloji strukturların psixoloji strukturlardan daha uzun müddət davam etdiyini güman etmək olar, buna görə də "kilsəyə keşisdən daha yaxın" deyimi var. "Atmosfer"in keyfiyyəti ən yaxşı şəkildə "soyuq" və "isti" sifətləri ilə müəyyən edilir. Soyuq iyrəncdir; insan büzülür, maska taxır, gərgin və məhdud hiss edir, başqalarından məsafə ilə ayrılır. Lakin istilik cəlbedicidir; istilik yaxşı və sərbəst hiss olunur, hərəkətlər dəyişkəndir, insan özünü rahat hiss edir, maskasını ata bilir və insanlar xoş və mehriban görünürlər. "İsti" atmosferdə ətraf mühitdən "əvvəl" mövqeyi üstünlük təşkil edir, "soyuq" atmosferdə isə ətraf mühitdən "yüksək" və ya "yüksək" mövqeyi üstünlük təşkil edir; sonuncu halda, ətraf mühitə bir obyekt kimi baxılır və şəxs onu idarə etməyə və öz modelinə və planına uyğun olaraq yenidən qurmağa çalışır.

// KİÇİK QRUP

Psixiatriya şöbəsi insanlar arasında birbaşa - "üz-üzə" əlaqənin olduğu kiçik bir qrupla xarakterizə olunur. Belə qruplar rəsmi və qeyri-rəsmi və ya oyun əsaslı bölünür. Birinci qrupda üzvlər yerinə yetirilməli olan ümumi bir tapşırıqla bağlıdırlar və buna görə də yalnız müəyyən bir tapşırıqla bağlı biliklər nəzərə alınır (hakimlər heyəti belə bir qrup ola bilər). Qeyri-rəsmi qruplarda qrup üzvləri qarşılıqlı əlaqə ilə bağlıdırlar; tapşırıqlar dəyişkən və əhəmiyyətsizdir; fərdlər qrup tapşırığını yerinə yetirmək üçün bir vasitə kimi deyil, yalnız fərdlər kimi qiymətləndirilir. Şəxsiyyət xüsusiyyətləri qrup tapşırıqları ilə bağlı bilik və bacarıqlardan daha vacibdir. Qeyri-rəsmi qruplarda insan özü ola bilər; rəsmi qruplarda isə qrup tərəfindən təqdim edilən tapşırıqla uyğunlaşmalıdır (məsələn, hakim ləyaqətini qorumaq). Psixiatriya şöbəsidəki bir qrupun qeyri-rəsmi qrup modelinə aid olduğunu təxmin etmək asandır.

// OYUN

Oyun da qeyri-rəsmi qrupun vacib və xarakterik xüsusiyyətidir.

Oyunun xüsusiyyətlərindən biri hər şeyin "saxtakarlıqla" edilməsidir; hər şeyin ciddi və ağırlaşdığı "ciddi vəziyyətlərdə" mümkün olmayan müxtəlif davranış nümunələrini mənimsəmək olar. Oyun xəstələrin psixiatrik problemlərinin ağırlığı ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir ki, bu da onların gücünü aşır və dağılmaya səbəb olur.

İnsan əzablarının dərinliyinə düşən xəstələr, həyatda demək olar ki, bütün bədbəxtliklərə dözmüş bir insanın yalnız gülümsəyə biləcəyi kimi, bu yüngül, "uydurma" atmosferində itirilmiş tarazlıqlarına normal, ciddi həyatda olduğundan daha asanlıqla qayıdırlar.

Bundan əlavə, oynaq atmosfer insana müxtəlif davranış nümunələrini sınağa imkan verir; normal həyatda olduğu kimi böyük məsuliyyət hissi yoxdur. Oyundakı uşaq

xeyallarındakı qəhrəmanları və s. təqlid edərək "böyük" ola bilər. Müxtəlif potensial funksional strukturları sınaqdan keçirməyin bu anı oyunda vacib bir təhsil amili təşkil edir. Ruhi xəstə insanlarda oynaq bir atmosfer onlara müxtəlif davranış nümunələrini sınağa və normal həyata qayıtmağa imkan verir ki, bu da

Onlar sıxışdırılıb çıxarıldılar.

// XƏSTƏYƏ QARŞI EMOSİONAL MÜNASİBƏT

20 ildən çox əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ruhi pozğunluqların müalicəsinə həsr olunmuş hesabatında* müxtəlif müalicə üsulları arasında ən vacib rolunu xəstəxananın "iqlimi" və ya "atmosferi" adlanan müəyyən edilə bilməyən bir elementinin oynadığı vurğulanırdı. "İqlim" fərmanla planlaşdırıla və ya yaradıla bilməz. Bu, işçilərin münasibəti, işdən məmnunluq, məna hissi və müəyyən bir müəssisədə hökm sürən ədalətli qayda və s. kimi bir çox amillərin nəticəsidir. Lakin, şübhəsiz ki, bunlardan ən vacibi xəstəyə qarşı müvafiq münasibət olaraq qalır və bu, rəsmi vəzifədən deyil, həqiqi emosional vəziyyətdən irəli gəlir. Həkimlərin, xüsusən də rəhbər vəzifələrdə olanların rolu çox əhəmiyyətlidir, çünki onların xəstələrə qarşı münasibəti tez-tez digər tibb işçiləri üçün nümunə olur. Əgər xəstə xəstəxanaya işçilərindən və onların səylərindən razı qaldığını hiss edirsə və onlara inanırsa, bu vəziyyət təhlükəsizlik hissi aşılayır və özünə və insanlara inamını bərpa edir. Bu təhlükəsizlik hissi, sözdə "terapevtik iqlim"də ən vacib amildir. Təhlükəsizlik, xəstənin mühitindəki bütün pisləklərdən və xoşagəlməzliklərdən qorunmaqla yanaşı, eyni zamanda onların əsas ehtiyaclarını ödəməkdir. Əgər uşaqlıq dövründə insanlar və ya heyvanlar ana axtarma reaksiyası yaşayırlarsa, bu, məhz ananın ətraf aləmin bir hissəsi olması və təhlükəsizliyi təmin etməsi ilə bağlıdır. Bu "isti varlıq"a həyatda, xüsusən də davamlı uğursuzluqlar və bədbəxtliklər zamanı çox vaxt ehtiyac duyulur. Bu, "sığınacaq" (zorakılıqdan təhlükəsiz yer) sözünün əsl mənasıdır.

* BMT Texniki Hesabatı. Ruhi sağlamlıq üzrə Ekspert Komitəsi, üçüncü hesabat 1953; Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Cenevrə, Texniki hesabat seriyası. № 73, səh. 17-18.

// Sığınacaq

Sosial terapiya, xüsusən də xarici dünya qorxusunun ən güclü olduğu şizofreniya tipində psixozlarda mühüm rol oynayır. Lakin, bütün ruhi pozğunluqlarda, hətta artan canlılığın başqaları ilə daha asan təması asanlaşdırdığı maniyada belə, sığınacağa, sığınacağa, təhlükəsiz yerə ehtiyac var.

Nevrozlarda "sığınacaq" problemi, xüsusən də kəskin psixozlarda olduğu kimi əhəmiyyətli deyil. Lakin, nevroitik xəstənin müvəqqəti olaraq təhlükəsiz bir yer tapmalı və özünü ətraf mühitdən təcrid etməli olduğu vəziyyətlər var. Bu ehtiyac mühitin nevroitik dəyişiklikləri (məsələn, ailə və ya iş münaqişələri və s.) tetiklediği hallarda yarana bilər. Münaqişənin mənbəyindən müvəqqəti təcrid bütün vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan verir. Bəzən

nevroitik narahatlıq o qədər şiddətlidir ki, həkim onu ambulator şəraitdə azalda bilmir; eyni şey depressiv əhval-ruhiyyəyə və

intihar düşüncələrinə də aiddir. Bəzən həkim narahatlıq ifadə edir, çünki onlar həmişə nevroz diaqnozunda əmin deyillər və ya ağır nevroitik təzahürləri müalicə etməkdə aciz hiss edirlər. Belə hallarda xəstəni xəstəxanaya yönləndirmək həm həkimi, həm də xəstəni sakitləşdirir. Xəstəxanaya yerləşdirmə üçün dəqiq göstərişlər vermək çətinidir. Bir qayda olaraq, ambulator müalicə mümkün qədər uzun müddətə aparılır və müalicə

Qapalı tibb müəssisələrində bu, son qaçqın kimi istifadə olunur. Psixiatriya palatasının təhlükəsizlik hissi təkcə nevroitik narahatlığı deyil, həm də nevroitik eqosentrizmi azaldır.

// PSIXIATRİK PALANIN "İKİNCİ HƏYATI" VƏ XƏSTƏNİN EQOSENTRİK DAVRANIŞI

İşçilər, xüsusən də tibb işçiləri, palatada əslində baş verən hər şeyi yalnız qismən görür və bilirlər. Əksər psixiatrlar bu vəziyyətdən xəbərdardırlar. Hətta palata həyatını xəstənin baxış bucağından yaşamaq üçün xəstə rolunu öz üzərinə götürən psixiatrlar da var idi.

Palatada xəstələr arasında dostluq münasibətləri və ya antaqonizmlər yaranır; xəstələr bir-birini sakitləşdirir və ya əksinə, bir-birini qorxudur, həyatları haqqında danışır və həkimə demədikləri sirləri açırlar. Kliklər kimi kiçik qruplar yaranır, intriqalar yaranır, palatada ən yaxşı mövqe uğrunda mübarizə aparır və s. Sosioloq üçün bu cəmiyyət xüsusilə maraqlıdır, çünki onun üzvləri nəinki daim

dəyişirlər, həm də müxtəlif sosial qruplardan gəlirlər, müxtəlif

psixi pozğunluqlardan əziyyət çəkirlər və fərqli şəxsiyyət tiplərini təmsil edirlər.

Bəzən xəstənin davranışının həkim və işçi heyətinin yanında tək xəstələrlə müqayisədə tamamilə fərqli olduğunu görmək təəccüblüdür.

Palatada həyat, digər xəstələrlə söhbətlər, onların əzabları və münaqişələri haqqında məlumat əldə etmək nevroitiklərin eqosentrik davranışını tədricən azaldır; onlar başqaları ilə maraqlanmağa başlayırlar və bu, artıq sağalma yolunda ilk addımdır. Fərdi psixoterapiyada, tez-tez, psixoterapevtlərin böyük səylərinə baxmayaraq, xəstə öz bədbəxtliyinə inamlı qalır, heç kim və ya heç nə ilə müqayisə olunmazdır və bu inam müəyyən dərəcədə bu barədə çox şey deyilməsi ilə təsdiqlənir.

Digər xəstələrlə söhbətlər onun gözlərini adi insan əzablarına açır. O, tək qalmaqı dayandırır; başqaları da, bəlkə də daha çox əziyyət çəkir; özü kimi insanlarla, yəni xəstələrlə təmasda olmaqla, o, sosial dairələrə qayıdır. Xəstələrin bu qarşılıqlı təsiri həkim təsirindən üstündür, çünki bu halda hər iki tərəf - aktyor və qəbul edən - ortaq bir tale ilə birləşir, psixoterapiyada isə aktyor tərəfi həmişə sağlam insanların, müəyyən mənada daha yaxşı, ətrafdakı realığa uyğunlaşdırılmış bir dünyasını təmsil edir. Buna görə də, həkim üçün xəstənin nevroitik eqosentrizmini qırmaq bəzən çətin olur. Eqosentrizm insanların əziyyət çəkmədiyi, belə dəhşətli münaqişələr yaşamadığı və xoşbəxt olduğu sağlam insanların dünyasına qarşı spesifik bir müdafiəni təmsil edir. Gerçəkliyin bu örtülü təsviri xəstəni öz taleyi üçün məsuliyyəti qəbul etməkdən qoruyur: "Mən çox əziyyət çəkirəm, çox bədbəxtəm, dünyada heç kim kimi deyiləm", "heç kim məni başa düşmür, ağlım tükənib, çünki

heç kim bu qədər əziyyət çəkmir." Özünə və ətrafındakı dünyaya bu cür baxışla xəstəyə başqalarının da əziyyət çəkdiyini və çox vaxt daha da şiddətlə onun nevroitik əzablarının əksəriyyətinin yalançı emosional reaksiyaları ilə əlaqəli olduğunu və müəyyən bir səylə özünün çox şey dəyişə biləcəyini izah etmək çətinidir. Müalicə məsuliyyətini xəstəyə yükləmək olmaz; həkim bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir, baxmayaraq ki, müalicənin nəticəsinin yalnız xəstədən, yəni onun dəyişmə dərəcəsindən asılı olduğunu bilir. Digər xəstələrdə xəstənin eqosentrik davranışı öz mənasını itirir. Onlar heç bir şəkildə kömək edə bilməzlər, çünki özləri xəstədirlər. Öz əzablarını, özəlliyini vurğulamaq da heç nəyə nail olmur.

Xəstələr tibb və digər xəstəxana işçilərinə qarşı daha tələbkər ola bilirlər, "mən başqalarından daha çox əziyyət çəkirəm və buna görə də daha çox tələb edirəm" deyər düşünlər. Xəstələr öz aralarında özlərini evdəki kimi hiss edirlər; bu, artıq əziyyət çəkənlərə kömək etməyə tələsmək vəzifəsi olan sağlam insanların dünyası deyil, amma təəssüf ki, bu dünya bunu etmək istəmir; buna görə də ətrafdakı dünyaya qarşı şərti kin hissi yaranır. Xəstələr arasında antaqonizm yox olur; bu insanlar xəstə ilə eynidir. Onlar onu daha asan başa düşə bilirlər, çünki özləri də əziyyət çəkirlər, onlar da normal həyatın axarı ilə ayaqlaşmayıblar.

Əlbəttə ki, bu qarşılıqlı təmasların mənfi cəhətləri də ola bilər, çünki

xəstələr bir-birini ağır simptomlarının təhlükəsi ilə qorxudurlar. Lakin,

müsbət cəhətlər üstünlük təşkil edir. Çox vaxt nevroitik xəstə palatada bir neçə saat, gün və ya həftə qaldıqdan sonra yaxşılaşır və vəziyyətindəki bu yaxşılaşma palatanın atmosferinin psixoterapevtik təsiri ilə əlaqələndirilə bilər. Nevrotik xarici mühitdən - evdən və ya işdən - təcrid olunma da təsir göstərir. Bu yaxşılaşma xəstənin istirahət evinə və ya sanatoriyaya köçürüldüyü hallardan daha çox nəzərə çarpır. Əhəmiyyətli rol mühitdəki dəyişiklikdən çox palatanın özü oynayır. Bu ilk irəliləyiş əlamətləri bəzən işçilər psixoterapevtik və ya farmakoloji müalicəyə başlamazdan əvvəl görünür və bu, xəstənin eqosentrik davranışındakı dəyişikliklə əlaqədardır. Xəstə artıq dünyada sözdə sağlam, güclü və yaxşı uyğunlaşmış insanlar arasında tək deyil; xəstə artıq kömək çağırır və ya heç nə istəmir. Tənha "mən" "biz" ilə əvəz olunur.

Müalicə nəticələri üçün vacib olan xəstələr arasında əksər məsələlər tibb işçilərindən kənarda həll olunur. Tibb bacıları daha çox şey görürlər, çünki onlar xəstələrlə daha tez-tez qarşılıqlı əlaqədə olurlar.

// "TERAPEVTİK CƏMİYYƏT." PSIXIATRIYADA "AÇIQ QAPILAR" UĞRUNDA MÜBARİZƏ

Müasir psixiatrik müalicə metodlarında sözdə "terapevtik cəmiyyət"ə əsas rol verilir. Psixiatriya palatasında qalmağın terapevtik təsiri olmalıdır. Bu, həm xəstələr, həm də işçilər arasında qrup əlaqələrinin formalaşmasını, eləcə də ruhi xəstə xəstələrin yenidən sosiallaşmasına müsbət təsir göstərəcək işçilər və xəstələr arasında əlaqələrin qurulmasını əhatə edir. Palatadakı bütün insanlar terapevtik cəmiyyəti təşkil edir: xəstələr, həkimlər, tibb bacıları, baxıcılar, inzibati heyət və s.

Həm kiçik, həm də ağır psixiatrik şəraitdə bütün psixi pozğunluqların müalicəsində terapevtik cəmiyyət böyük rol oynayır. Hətta ağır üzvi demensiya və zehni gerilik hallarında belə, o, həmçinin rol oynayır. Lakin bu, xüsusilə şizofreniya və nevrozların müalicəsində dəyərlidir. Bu xəstəliklərdə insanlarla emosional əlaqə, daha doğrusu, onun pozulması xəstəliyin əsas problemini təşkil edir.

Psixiatriqların terapevtik cəmiyyətə marağı İkinci Dünya Müharibəsinə gedib çıxır.

Sosial sabitliyin pozulması nəticəsində demək olar ki, hər bir global fəlakət cəmiyyətin diqqətini psixiatrik məsələlərə yönəldir. Bütün cəmiyyət sosial norma böhranı yaşadığıca xəstələr daha çox ünsiyyətçi və başa düşülən olurlar. Sonuncu dünya müharibəsi zamanı və dərhal sonra İngiltərədə "psixiatriyada açıq qapılar uğrunda mübarizə" kimi tanınan psixiatrik hərəkət başladı. Onun iştirakçıları ruhi xəstələri sözdə normal insanlardan ayıran boşluğu azaltmağa çalışdılar. Onlar xəstələrə maksimum sərbəstlik verməyə, təşəbbüslərinə mane olmaq əvəzinə, onları təşviq etməyə və özlərini təsdiqləmələrini gücləndirməyə çalışdılar.

Ləyaqət.

Bu hərəkət yeni idimi? İngilislər ötən əsrin birinci yarısındakı kiçik ingilis xəstəxanalarına terapevtik cəmiyyət üçün bir model kimi baxırdılar. Bu xəstəxanalarda ailəvi münasibətlər mövcud idi. Həkimlər xəstəxanalarda yaşayırdı, xəstələrlə birlikdə yemək yeyir və onlarla çox vaxt keçirirdilər. Hamı bir-birini yaxşı tanıyırdı. 19-cu əsrin ikinci yarısında birlikdə vaxt keçirməyin mümkün olmadığı böyük psixiatrik xəstəxanalar modeli qəbul edildi. Xəstəxana psixiatrik yardımının təşkili üslubundakı bu dəyişiklik zamanla psixiatriyada elmi istiqamətin yüksəlişi ilə üst-üstə düşdü - zehni pozğunluqların etiologiyasını aydınlaşdırmağa çalışan genetik və üzvi baxışlar və məntiqi psixoloji konstruksiyalar şəklində. Bu gün kiçik psixiatrik xəstəxana modelinə doğru meyl yenidən üzə çıxır və çarpayıların ümumi sayının yüzdən çox olmamasına inanılır. // İki Sərhəd: İşçi həyatı - Xəstə, "Normal" - "Anormal"

Terapevtik cəmiyyət yaratmaq üçün iki sərhəd keçilməlidir: biri xəstəxana işçilərini xəstələrdən, digəri isə sağlamaları ruhi xəstələrdən ayırır. Terapevtik cəmiyyət insanları bölməməli, birləşdirməlidir; əgər onun daxilində sərhədlər varsa, bu cəmiyyətə mənsub olan insanlar avtomatik olaraq iki düşərgəyə - sərhədin hər iki tərəfinin bir tərəfində - "biz" və "onlar" düşərgəsinə bölünür. Sərhəd həmçinin avtomatik olaraq əks düşərgələrdən olan insanlar arasında düşmənçiliyi artırır.

Bu sərhədləri keçmək asan deyil. Həkim və ümumiyyətlə, xəstəxana işçilərini xəstədən ayıran sərhəd müalicənin mahiyyətindədir: kimsə müalicə olunması üçün kimsə müalicə etməlidir. Burada hərəkət edən subyektlə bu hərəkəti alan obyekt arasında fərq olmalıdır. Və kimsə müalicəçinin bacarığına və xoş niyyətinə inanmalıdır. "Ağ geyimli kişilər" xəstələrdən ayıran "qapalı qapılar" həmişə mövcud olub. Qədim dövrlərdən bəri, tibb əsasən sehr olduğu və daha sonra elmə çevrildiyi dövrdən bəri, həkim xəstə üçün sağlamlığı və həyatı üzərində sehrli gücə sahib olan bir insan olaraq qalırdı. Həkimlərin sehrli gücünə olan bu inam elementi, elmi nailiyyətlərə və ya sadəcə xurafata əsaslanmasından asılı olmayaraq, terapiya üçün əhəmiyyətsiz deyil. Bu inamı qorumaq üçün həkim müəyyən bir məsafəni və təcrid olunmuş vəziyyətdə olmalıdır. Qapılar tamamilə açılsaydı və xəstələr pərdə arxasında baş verən hər şeyi, tibb teatrını görsəydilər, onların imanı yəqin ki, zəifləyər və bu da öz növbəsində müalicə nəticələrinə mənfi təsir göstərərdi. Müalicə nəticələri üçün vacib olan həkimin sehrli gücünə olan inam elementi psixiatriyada böyük rol oynamır və bəzən hətta zərərliyə. Bu element nevrozlarda və psixosomatik xəstəliklərdə öz əhəmiyyətinə malikdir və psixozlarda reallıqdan uzaqlaşmaqdan qaynaqlanan o qədər çox sehrli element var ki, başqa birinin əlavə edilməsi çətin ki, heç bir faydası olsun. Xəstə ilə yaxınlıq elementi, onun reallığa qayıtmasına imkan verən element, psixiatriyada həkimin sehrli gücünə inam elementindən xeyli vacibdir.

Xəstənin sağlamlığı və həyatı üzərindəki güc, hər hansı bir güc kimi, psixiatrın aradan qaldırılmalı olduğu məsafə yaradır, çünki xəstə üçün ən vacib amil etibar edə biləcəyi bir həkimin yaxınlığıdır.

Psixiatriyada subyekt-obyekt münasibəti mümkün deyil, bu da insanları müalicə edənlərə və müalicə olunanlara bölür. Psixiatr həm diaqnostik, həm də terapevtik müdaxilələrdə,

Xəstənin ətraf aləmlə müəyyən bir emosional əlaqə quran və planlaşdıran bir subyekt olduğunu bir an belə unutma. Psixiatr xəstəyə dəyişmək söylərində kömək etməlidir, lakin onları özü dəyişdirə bilməz. Başqa bir insanı dəyişdirmək istəyi onun subyektivləşməsinə ziddir. Başqa sözlə, ruhi xəstələr özlərini müalicə edirlər və psixiatr sadəcə onlara kömək edir, köhnə tibbi deyimdə deyildiyi kimi: "medicus curat, natura sanat". Bu problem xüsusilə nevrozlarda özünü göstərir,

xəstə tez-tez həkimdən müxtəlif dərmanlar, prosedurlar, hipnoz təyin etməsini tələb edir - bir sözlə, həkimin onlara bir obyekt kimi yanaşmasını tələb edir, halbuki həkim öz növbəsində bu müalicələrin xəstənin emosional reaksiyalarını, istəklərini, planlarını və s. dəyişdirmədiyi təqdirdə az kömək edəcəyini bilir. Bəlkə də belə bir dəyişiklik tamamilə xəstənin iradəsindən asılı deyil, çünki insanın əhval-ruhiyyəsini və ya hisslərini idarə etmək mümkün deyil. Bununla belə, dəyişiklik xəstənin daxilində kortəbii şəkildə baş verməlidir. Sözdə normal insanları anormal insanlardan ayıran ikinci sərhədi keçmək daha da çətinidir, çünki bu, insanın dərin gizli meyllərini - fərqli olanı rədd etməyi əks etdirir. Fərqli dəri rəngi, geyim və ya sosial davranış tez-tez insanın rədd edilməsinə, özünü ümumi dünyanın Heraklit dairəsindən kənarda tapmasına səbəb olur. Bu meyl heyvanlar aləmində də mövcuddur. Bir albinos sərçə sürüsündə peyda olduqda, boz quşlar onu dimdikləyərək öldürürlər. Bəlkə də, sosial qrupun yaranması üçün "ümumi"ni "digərindən" ayıran bir sərhəd çəkilməlidir. "Digərinə" qarşı təcavüz cəmiyyəti şəxsiyyətinin pozulmasından qoruyur. Eynilə, hər bir canlı orqanizm özünü yad biokimyəvi strukturun işğalından qoruyur və anafilaktik şok belə bir reaksiyaya nümunə ola bilər. Sərhədlərin yaranması təbiətdə yaygındır; hətta eyni orqanizmin daxilində oxşar funksiyaya və morfoloji quruluşa malik hüceyrələr qonşularından birləşdirici toxuma sərhədləri ilə ayrılır. Hər bir sosiologiyada - insan, heyvan, bitki - qrupların və qruplar arasında sərhədlərin yaranması fundamental problemdir. İnsanlara gəldikdə isə, bəşər tarixində sərhədlərin əhəmiyyətini, onların törətdiyi qan tökülməsini və gətirdiyi əzabları vurğulamağa ehtiyac yoxdur.

Psixiatrlar, məlum olduğu kimi, sağlam və ruhi xəstələr arasındakı sərhədlərin keyfiyyətə təbiətə malik olduğuna inanaraq normallıq və patologiya arasındakı sərhədləri qəbul edənlər və bu sərhədi rədd edənlər, arqumentlərini hər bir insanda nevrotik və psixotik elementlərin mövcud olduğuna və sağlam və ruhi xəstələr arasındakı fərqi yalnız kəmiyyətə olduğuna əsaslanaraq bölüşdürüblər. Bir çox arqument hər iki fikri dəstəkləyir, lakin bu günə qədər heç biri sübut edilə bilmir. Nəticədə, birini və ya digərini qəbul etmək yalnız iman məsələsidir və

inamda hər şey güclü emosional əlaqə ilə bağlıdır. Bu, bəlkə də psixiatrın verdiyi ən

əsas qərarlardan biridir: istər xəstəni insan təbiətinin möcüzəsi, istərsə də öz təcrübələrinin əksi, bəzən tamamilə şüurlu olmayan və

xəstənin dünyasında, faciəvi şəkildə şişirdilmiş şəkildə görmək istəmələri. Xəstəyə münasibətə gəldikdə, normal və patoloji arasındakı sərhədə nəzəri yanaşma emosional reaksiya, xəstənin təcrübə dünyasına daxil olmaq istəyi və xəstəyə yaxınlaşmaq və onu anlamaq üçün tələb olunan səydən daha az əhəmiyyətlidir. Xəstəni anlamaq həmişə ona yaxınlaşmaq istəyi ilə bağlıdır; əksinə, uzaqdan heç nə başa düşülə bilməz. Dostumuz olan it bizim üçün başa düşüləndir; onun psixologiyası Jaspersin "Ən Yaxşı Psixologiya"sına uyğundur. Digər tərəfdən, insanları ayıran məkan bəzilərinin digərlərinə tabe olmaq istəyi ilə bağlıdır; komandir əmr verməzdən əvvəl bir qrup tabeliyindən uzaqlaşmalıdır.

Terapevtik cəmiyyətlər haqqında ədəbiyyatda iki əks mövqeyə çox diqqət yetirilir: avtoritar və bərabərlik. Birincisi, qrup strukturunun iyerarxik səlahiyyəti saxladığı və buna görə də, liderliyin zirvədə, bazanın isə adi qrup üzvlərindən ibarət olduğu bir piramida təmsil etdiyi hallarda ortaya çıxır. İkincisi, oyunda olduğu kimi, hər kəsin bərabər olduğu üfüqi qrup strukturunu təmsil edir.

Normallıq və patologiya arasında kəskin sərhəddə dayanan bir psixiatr üçün ən vacib şey, xəstəni normal vəziyyətə qaytarmaq və bu normadan kənara çıxan strukturları aradan qaldırmaqdır. Lakin, tibbi baxımdan düzgün olan bu istək, anormal olandan uzaqlaşma hissi ilə əlaqələndirilə bilməz. Emosional baxımdan bu problem olduqca mürəkkəbdir, çünki məhv etmək istəyi həmişə bizi ətrafımızdakı dünyadan ayrılan mənfi emosiyalarla əlaqələndirilir. Söhbət körpəni vanna suyu ilə birlikdə atmamaqdan gedir. Terapevtik həvəs dalğasında, eyni zamanda xəstəni məhv edərkən patoloji təcrübə formalarını aradan qaldırmaq olar.

Xəstə ilə düzgün münasibətin ilk şərti olan yaxınlaşma olduqca çətin bir işdir. Bu, həkimdən böyük emosional və zehni səy tələb edir və eyni zamanda onları həm idrak, həm də fəaliyyət sahəsində daimi məyusluqlara məruz qoyur.

Xəstə ilə yaxınlaşma, xəstənin dünyasına daxil olmaq, əlamətlərindən asılı olmayaraq hisslərini qəbul etmək və, ehtimal ki, qınamaq mümkün olsa da, mühakimə rolundan imtina etməklə əlaqəli bir səy deməkdir. Belə bir vəziyyətdə, xəstəyə daimi kömək göstərilməlidir, eyni zamanda bu yardımın təsirsiz ola biləcəyini dərk etməlidir. Təcrübələr Xəstələr tez-tez özlərinin, həmişə şüurlu şəkildə tanınmayan problemləri ilə qarşılaşırlar. Biz xəstəni öz düşüncələrimiz vasitəsilə tanıyıırıq və buna görə də psixiatriyanı kitablardan və mühazirələrdən öyrənmək mümkün deyil. Xəstəni tanımaqla özünüdərk etməyin bu zənginləşdirilməsi, şübhəsiz ki, psixiatriyanın ən möhtəşəm, eyni zamanda ən yorucu aspektidir. Hər kəs özü haqqında məlumatları yalnız müəyyən dərəcədə qəbul edir.

Psixiatrik bilik çox ehtimal olunandır. Bəzən elə görünür ki, biz artıq sirrin mənbəyini tapmışıq, lakin növbəti görüşdə bütün konsepsiyanın qüsurlu olduğunu aşkar edirik. Terapevtik təsirləri qiymətləndirmək də çətinidir. Biz irəliləyişlərimizi psixoterapiya, elektroşok, insulin terapiyası və antipsixotiklərlə əlaqələndiririk. Əslində, yaxınlaşma əsasən tibb bacısının isti münasibətindən, palatadakı xəstə ilə dostluq münasibətindən və ya hətta flirtdən qaynaqlana bilər. Hər bir insana xas olan yaradıcılıq fərdin öz işini qiymətləndirməsini tələb edir. Psixiatr məyusluğa məhkumdur. O, nəyə nail olub? O, "insanı tanıdığını və ya həqiqətən ona kömək etdiyini" deyə biləmi? Yaradıcılığın obyektivliyi subyektiv qiymətləndirmələrlə bulanıqlaşır və hətta idrak və terapevtik fəaliyyətin dəyərini aydınlaşdırmalı olan ən sərt elmi qaydalar belə kömək etmir.

Buna görə də, psixiatrın xəstəyə münasibəti ikili kimi müəyyən edilə bilər.

O, xəstəyə cəlb olunur, onsuz keçinə bilmir, sözdə "normal" insanlarla münasibətlər darıxdırıcı olur, onlar onda qıcıqlanma hissi oyadır;

O, xəstələrin dinamik dünyasına cəlb olunur, lakin xəstə özünü böyük hisslər, faciələr, sirrlər dünyasında itirilmiş və səylərində aciz hiss etdikdə onu dəf edir; o, hisslərinin solğunlaşdığını, sənət qalereyasında mühafizəçi kimi ustaların böyük əsərlərini laqeyd şəkildə izləyir.

Xəstə təhlükəsiz bir yerə, təşkilati işlərin, nəzəriyyələrin, elmi biokimyəvi tədqiqatların, fizioloji təcrübələrin, statistik tədqiqatların burulğanına qaçır və burada xəstə ilə təmasın minimuma endirilməsi müşahidə olunur. Bəşəriyyətin sirri diaqnostik etiketlər, hazır həyat tarixi diaqramları, etioloji cəhətdən müxtəlif təbiətə və dəyərə malik hazır konsepsiyalar, elmi atmosfer yaradan sirli yunan və latın sözləri və son zamanlar ingilis sözləri ilə peşəkar dil tərəfindən qorunur.

// "Dömə qaydası"

Sosial həyatda təkcə insanlar arasında deyil, həm də heyvanlar arasında güc iyerarxiyası müşahidə olunur. Daha yüksək sosial statusa malik toyuq aşağı səviyyəli toyuğu dimdikləyir,

sonuncu buna itaətkarlıqla dözürlü, lakin öz növbəsində toyuq aşağı səviyyəli toyuğa qarşı aqressiya göstərir. Bu, sözdə "dimdik qaydası"dır. Təkcə aqressiya iyerarxiyə görə boşalmır. Sosial təqlid, əksər hallarda,

bir qrup daxilində eyni şəkildə yayılır. Müəyyən bir sosial qrupda həkimlər xəstələrdən daha yüksək güc iyerarxiyasındadırlar və buna görə də onların xəstəyə münasibəti çox vacib bir məsələdir.

Bir qrupun homogenliyi "biz" əvəzliyini, yəni "hiss etdiyimizi" istifadə etmək qabiliyyəti ilə sübut olunur. Bir qrup daxilində üzvlərini "biz" və "onlar"a bölən bir sərhəd yaranarsa, bir qrup əvəzinə iki qrup ortaya çıxır. Burada təqdim olunan normallıq və patologiya arasındakı sərhəd problemi yalnız nəzəri əhəmiyyətdən daha çox şeyə malikdir. Terapevtik bir cəmiyyətin yaranması üçün "ağ geyimli insanlar" və "pijama geyinmiş insanlar" ortaq "biz" əvəzliyi ilə birləşdirilməlidir. Əgər sonuncu "varii" olaraq qalarsa, onda daha böyük olsa da, sosial iyerarxiyanın ən aşağı səviyyəsində, anormallıq əlaməti ilə təyin olunan ayrı bir qrup yaradılır.

"Ağ geyimli kişilər" üç alt qrupa bölünür. Hər birinin fərqli sosial və iqtisadi statusu var və müəssisənin iyerarxiyasında (psixiatriya xəstəxanası və ya şöbəsi) fərqli bir mövqe tutur. İyerarxiyada mövqe nə qədər yüksək olarsa, xəstə ilə təmas bir o qədər az olur. Xəstə ilə ən çox vaxt keçirənlər, müəssisənin direktoru isə ən az vaxt keçirir. Əlbəttə ki, bu, əlaqənin keyfiyyəti ilə deyil, miqdarı ilə bağlıdır, çünki həkim-xəstə münasibətləri tibb bacıları və tibb bacılarının münasibətlərindən fərqlidir. Bu vəziyyət xəstələr üçün olduqca çətinliklidir, çünki onlar əksər hallarda aşağı sosial statusları və aşağı əmək haqqı səbəbindən kinli ola biləcək və yuxarıda qeyd edildiyi kimi, "əmmə" qaydasında yalnız xəstələrə aqressivliyini bildirə biləcək insanlarla qarşılaşırlar, çünki xəstəxana iyerarxiyasında yalnız onlar daha aşağıdadırlar.

// Tibb bacısı

Psixiatriya şöbəsində xəstənin əsas problemlərindən biri onun

xarici dünyadan emosional təcrid olunmasıdır. Bu, özünü müxtəlif formalarda göstərir,

lakin həmişə isti, qonaqpərvər atmosfərə və demək olar ki, ana qayğısına ehtiyacla birləşir. Bu problem xüsusilə şizofreniya xəstələrində kəskindir və bir çox müəllifə görə, xəstəyə qarşı isti münasibət bu xəstəliyin ən vacib terapevtik amili təşkil edir.

Şöbədə tibb bacısı əsasən xəstənin emosional aclığını yatırır. Bu, ehtimal ki, onları bu peşəyə meyilli edən müəyyən şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən irəli gəlir və bu peşəni daha dəqiq peşədən daha çox çağırış adlandırmaq olar.

Həm psixoloji, həm də somatik terapevtik metodların nəticələrini qiymətləndirərkən tibb bacıları tərəfindən göstərilən qayğıya çox az diqqət yetirilir.

Tibb bacılarının işi kölgədə baş verir, bütün işıq isə həkimin işinə yönəlir. Xəstə baxımının yükünü daşıyanlar isə tibb bacılarıdır; onlar çox çətin improvizə edilmiş psixoterapiya sənətini, yəni münaqişələri həll etmək bacarığını, xəstənin ağrılı gərginliyini azaltmaq, müqavimətini dəf etmək bacarığını öyrənməlidirlər və xəstənin üzünə təbəssüm gətirməyi bacarmalıdırlar. Psixiatriya dərslərlərində bu sənət haqqında az şey yazılıb, lakin bu, rəsmi olaraq psixoterapiya adlandırılandan daha çətinidir. Tibb bacılarının daimi olaraq mövcud olduğu və həkimlərin növbələşdiyi şöbələrdə onlar mərkəzi fiqurlar, yəni şöbənin iqlimini yaradanlardır.

Həkimlərə gəldikdə, onların psixiatrik icmanın iyerarxik strukturundakı liderlik rolu əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir və bu rolun nəticəsi olaraq, onların düşüncə və davranış tərzləri tez-tez aşağı alt qruplarda daha böyük güclə rezonans doğurur.

Bu, xüsusilə də baş həkimlər və sözdə liderlik üçün doğrudur.

Psixiatrik ədəbiyyatda təsvir edilən məlum bir faktdır ki, həkimlər və tibb bacıları arasında münaqişələr xəstələrin ruhi vəziyyətinə təsir göstərir. Həkimlər arasında hökm sürən iqlim digər alt qruplara, xüsusən də xəstələrə təsir göstərir.

/ Xəstələr

Şöbə işçilərindən ibarət nisbətən sabit alt qruplardan fərqli olaraq, xəstə alt qrupları daim dəyişir. Sosioloq üçün bu qrup maraqlı ola bilər, çünki o, daimi olaraq status-kvotadadır. Palatada nisbətən qısa müddət qalmasına baxmayaraq, xəstələr arasında qrup əlaqələri adətən asanlıqla və tez yaranır. Bəzi xəstələr üçün bu əlaqə daha sabit, digərləri üçün daha zəifdir və bəziləri qonşuları ilə əlaqə qurmur, xəstəxanada qaldıqları müddət ərzində özlərini onlardan təcrid edirlər.

Görünür, qrup əlaqəsinin gücü müalicə nəticələri ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqəlidir və terapiyada mühüm rol oynayır. Xəstələrdə simpatiya və antipatiya inkişaf edir, bir-biri və işçi heyəti ilə spesifik qarşılıqlı əlaqə üslubları inkişaf edir, dedi-qodular yayılır və bəzən işçi heyəti haqqında çox kəskin fikirlər səsləndirilir və s. Bəzən palatada qurulan dostluqlar illərlə davam edir və sevgi ifadələri və sonrakı evlilik əlaqələri də yayındır.

Xəstələrin sosial həyatı olduqca zəngindir, lakin tibbi müşahidə üçün həmişə əlçatan olmur. Xəstəni palatadakı sosial həyatı vasitəsilə tanımaq psixiatrik üfuku genişləndirir. Psixiatr tez-tez xəstə haqqında az məlumatından təəccüblənir. Katatonik stupor klubda rəqs edərkən yox olur, şizofrenik autizm başqa bir xəstənin əzablarına canlı reaksiya verir və xəstə klubunun tərəvətləndirici otağında işləyərkən şışirdilmiş dürüstlükdə dəyişiklikləri oğurlamaq meyli yaranır. Xəstələrin qarşılıqlı psixoterapevtik təsiri də böyük əhəmiyyət kəsb edir; əlbəttə ki, təsirin mənfi əlamətlə qeyd olunması baş verə bilər, amma bu, çox təcrübəli psixiatrlar arasında da baş verir. Xəstələr yeni gələnləri palatanın həyatı ilə tanış edir, əzablarını yüngülləşdirməyə çalışır və özləri haqqında danışirlar.

Onlar təcrübələrini bölüşür və başqalarının hekayələrini dinləyir, zərərsiz zarafatları və yumor hissini qiymətləndirir və problemlərinə daha az ciddi yanaşmağı öyrənirlər. Xəstələrin özlərini sağaltdıqlarını və bu prosesə müdaxilə edilməməli olduqlarını iddia etmək çox cəsarətli ola bilər; lakin, psixiatriya palatasının müvafiq atmosferində xəstələr arasında qarşılıqlı əlaqə əhəmiyyətli terapevtik rol oynayır.

Xəstələrin sosial həyatını daha yaxşı başa düşmək üçün sosioloqun köməyi tələb olunur, lakin bu həyat öz yaxınlığını qorumaqdır ki, bu da onun kortəbii olması üçün ilkin şərtədir. Bu həyatı tanımaq mənasında həddindən artıq müdaxilə ona təsir etmə prosesi ilə birləşdirilir ki, bu da onun kortəbiiliyini inkar edir. Qrup psixoterapiyası, peşə terapiyası, bədii və oynaq fəaliyyətlər və s. hamısı işçilərin xəstələrə təsir formalarıdır və eyni zamanda xəstələri daha yaxşı başa düşməyin yollarıdır. Lakin, palatada gərgin bir atmosfer hökm sürərsə, bu formaların heç biri öz rolunu yerinə yetirmir.

// QRUP PSIXOTERAPIYASI. TARİXİ QEYDLƏR

Qrup psixoterapiyasının inkişafı İkinci Dünya Müharibəsi ilə də əlaqələndirilir. Bu, əvvəllər məlum idi, lakin ilk cəhdləri psixiatriyada deyil, ftiziatriyada ortaya çıxdı.

O dövrdə məqsəd uzun müddət sanatoriyalarda saxlanılan vərəm xəstələrində nevroitik gərginliyi azaltmaq idi. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Müttəfiq ordularında əsgərlərin əhəmiyyətli bir hissəsi zehni pozğunluqlardan - nevrastenik vəziyyətlərdən şizofreniya tipli reaktiv psixozlara qədər əziyyət çəkirdi. Beləliklə, əməliyyatdan sonra psixiatriya ən vacib hərbi tibb sahəsinə çevrildi. Psixiatrlar çox sayda xəstəni tez bir zamanda müalicə etmək ehtiyacı ilə üzləşdilər.

Fərdi psixoterapiya, xüsusən də psixoanalitik formasında, çox vaxt aparırdı və zərurətdən qrup psixoterapiyası tətbiq edildi. Müharibədən sonra qrup psixoterapiyası getdikcə populyarlaşdı; həvəskarları arasında fərdi terapiyadan daha yaxşı qəbul edildi.

Qrup psixoterapiyası onları izah etmək üçün müxtəlif metodlardan və müxtəlif nəzəri yanaşmalardan istifadə edir. Bu mövzuda ədəbiyyat o qədər genişdir ki, hamısını əhatə etmək mümkün deyil; yalnız qrup psixoterapiyası məsələlərinə həsr olunmuş ixtisaslaşmış dövrü nəşrlər meydana çıxdı.

Qrup və Fərdi Psixoterapiya

Adındakı oxşarlığa baxmayaraq, fərdi və qrup psixoterapiyası arasında keyfiyyətcə fərq var. "Üç nəfərlik kollec". Bir qrupu neçə nəfər təşkil etdiyi qəti şəkildə müəyyən edilməsə də, görünür ki, yalnız üçüncü şəxsin təqdimatı ən kiçik qrupu təşkil edir. İki nəfər arasındakı qarşılıqlı münasibət üçüncü şəxsin təqdimatı ilə dəyişir. Əlbəttə ki, bir qrupun xarakterini müəyyən etmək üçün vacib olan bəzi xüsusiyyətlər, o cümlədən qarşılıqlı duran vəzifələr, davranış nümunələri və s. kimi iki və ya daha çox insandan ibarət bir qrupda da oxşar şəkildə görünə bilər. Lakin, və ən əsası, psixiatr üçün üçüncü iştirakçının təqdimatı ilə kökündən dəyişən emosional əlaqələrin təbiətidir. Buna görə də, sosioloqların fikirlərindən asılı olmayaraq, psixiatr qrup haqqında Roma tərifinə qoşulur.

Fərdi psixoterapiyada vacib terapevtik elementdir

Xəstə ilə terapevt arasındakı emosional əlaqə. Qrup psixoterapiyasında qrup üzvləri arasındakı əlaqə də oxşar amildir.

Psixoterapevt arxa plana keçir. Fərdi psixoterapiya psixoloji müalicə metodlarına, qrup psixoterapiyası isə sosioloji metodlara aiddir. Əlbəttə ki, bu bölmə olduqca sünidir, çünki xəstə həmişə sosial mühitin fonunda nəzərdən keçirilir. Lakin fərdi psixoterapiyada sosial mühit müəyyən dərəcədə mücərrəd bir şey kimi təqdim olunur; bunu xəstədən öyrənmək olar və psixoterapevt dəfələrlə xəstənin real mühitində mövcud olan boşluğu - diqqətli ata, dost və s. doldurur. Fərdi psixoterapiyada mərkəzi fiqur həmişə xəstə, onun təcrübələri, emosional əlaqələri, özünüdərkliyi olaraq qalır. Bu halda xəstənin eqosentrik mövqeyi qəbul edilir - hər şey ona yönəlir. "Psixoterapevtik üçbucaq" yaradılır ki, bunun əsası psixoterapevt və xəstə arasında qarşılıqlı emosional münasibət, zirvəsini isə söhbətlər zamanı ortaya çıxan xəstənin şəxsiyyəti təşkil edir. Fərdi psixoterapiyada xəstə, sanki, öz eqosentrik qarmağına yapışır. Onu narahat edən hər şeyin azad edilməsi və söhbətin hazırkı anında onların mərkəziliyinin fərqiində olmaq eqosentrik davranışı azaldır.

Qrup psixoterapiyasında problem bir qədər daha mürəkkəbdir. Bu halda, sosial mühit realdır və o, terapiya qrupunun çox real üzvlərindən ibarətdir ki, onlara qarşı müxtəlif hissləri ifadə etmək və qiymətləndirmələrini nəzərə almaq olar. Bu, gündəlik həyatda tez-tez rast gəlinən real bir vəziyyətdir. İştirakçılar "sosial əks olunma"nın mərkəzindədirlər və hər söz, jest və üz ifadəsi dərhal başqaları tərəfindən qiymətləndirilir - müsbət və ya mənfi qəbul edilir. Normal həyatın "ictimai əks olunması" ilə psixoterapiya qrupunda mövcud olan arasındakı fərq ondadır ki, normal həyatda bu əks olunma daha sərt və daha örtüldür, qrup psixoterapiyasında isə daha tolerant və açıqdır. Bu hal qrupun bərabərliyi ilə dikte olunur — hər bir üzv bu mühitdə özü və narahatlıqları haqqında danışmalı olduğunu bilir. Hər bir üzv tənqid oluna və başqalarını tənqid edə bilər. Bir saat və ya bir saat yarım ərzində insan qınanmaq və ya qrupdan kənarlaşdırılmaq qorxusu olmadan özü haqqında sərbəst danışa bilər.

Əgər fərdi psixoterapiya üçbucaq kimi təmsil oluna bilirsə, qrup psixoterapiyası dairə kimi təmsil olunur. Dairə qrup üzvləri arasında emosional əlaqələri təmsil edir və mərkəz müzakirə olunan şəxsin şəxsiyyəti və ya cari problemdir. Dairə hazırda dairənin mərkəzində yerləşən problemin "ictimai əksini" təşkil edir. Hər bir iştirakçı bu əksin bir hissəsidir, lakin istənilən an özünü dairənin mərkəzində tapa bilər. Əgər fərdi psixoterapiyada başlanğıc nöqtəsi eqosentrik mövqedirsə, qrup terapiyasında başlanğıc nöqtəsi həmrəylik hissidir — "biz hiss edirik" — "hər kəs eyni vəziyyətdədir", "hər kəs psixiatrik baxımdan bərabərdir", yəni problemləri, münaqişələri, travmaları, ağrılı hissləri və s. qarşısında. Bu cəmiyyətə daxil olmaq üçün insan özünü ortaya qoymalıdır və bu, asan bir iş deyil, özündəki ağrılı hər şeyi gizlətmək, utanc hissini gizlətmək, öz anlayışında başqalarınınkindən daha pis gildən hazırlanmış hər şeyi gizlətmək istəyinə qarşı daxili mübarizə tələb edir.

Hər bir psixoterapiya və hətta hər bir psixoterapevtik əlaqə,

yaxınlıq sferasının sərhədini keçməkdən ibarətdir. Xəstə ilə yaxşı münasibət xəstənin hekayəsində səmimiyyətin artması, ən yaxın düşüncələrin və təcrübələrin həkimə açıqlanması anında qurulur. Fərdi psixoterapiyada,

yaxın sferalara nüfuz etmək imkanı qrup psixoterapiyasından həmişə daha böyükdür. Açılmaq daha asandır.

Bir nəfər, xüsusən də simpatik biri, qrupun qarşısında deyil, qrup qarşısında.

Bəzən xəstə problemlərini terapevt qarşısında deyil, qrupun qarşısında daha çox açıqlayır. Belə hallarda, isterikada olduğu kimi, özünü göstərmək istəyindən və ya əksinə, qrup üzvləri tərəfindən qınaqla qarşılanma ilə özünü günahlandırmaq və ya özünü cəzalandırmaq istəyindən qaynaqlanan müəyyən bir zehni eksperimentizm növündən şübhələnə bilər.

Lakin, qrup psixoterapiyasında qrupun ortaq problemlərinə az-çox uyğun gələn səmimiyyət səviyyəsi nadir hallarda aşılır. Yaxınlıq sferası, normalda gizlədilən hər şey, yalnız qrup üzvləri ilə əlaqə qurmaq üçün lazım olan hədlər daxilində, yuxarıda qeyd olunan "hiss etdiyimiz" hədlər daxilində aşkar edilir.

Çox vaxt qrup psixoterapiyası prosesində xəstə bir şey demək istədikdə, lakin utandıqda, az danışdıqda, qorxduqda, özünə zidd olduqda və ya problemlərini yalançı işıqda təqdim etdikdə fərdi psixoterapiya metodundan istifadə etmək lazımdır. Məhz belə hallarda xəstə ilə fərdi söhbət onun əsl təcrübələrini aşkar etməyə imkan verir. Xəstənin problemlərini araşdırmaq da ən yaxşı şəkildə fərdi psixoterapiya kontekstində aparılır. Xəstə haqqında daha çox məlumatı fərdi söhbətdə öyrənmək olar və müəyyən hallarda, ən azı xəstəni qrup təcavüzündən qorumaq, təcrid hisslərini azaltmaq və ya şəxsiyyətini daha tam şəkildə açıqlamaq lazımdır. Çox vaxt qrup söhbəti zamanı xəstə özünü fərdi təmasda olduğundan fərqli şəkildə təqdim edir; müəyyən şəxsiyyət xüsusiyyətləri və müəyyən vacib münaqişələr qrup mühitində fərdi söhbətdə olduğundan daha asan aşkar edilir.

Fərdi və qrup psixoterapiyası arasındakı əsas fərq, əsasən, emosional iqlimdəki fərqdədir. Fərdi psixoterapiyada bu iqlim iki nəfər arasında emosional əlaqəni təşkil edir, qrup psixoterapiyasında isə emosional əlaqələr qrupun bir neçə üzvü arasında uzanır. Qrupda aşağıdakı emosional əlaqələr fəaliyyət göstərir: a) xəstə qrupunun fərdi üzvləri arasında, b) işçi qrupunun fərdi üzvləri arasında (əgər müalicə heyətinin bir neçə üzvü seansda iştirak edərsə), c) xəstə qrupu bütövlükdə və seans rəhbəri və ya işçi qrupu bütövlükdə, d) xəstə qrupunun fərdi üzvləri ilə görüş rəhbəri və ya işçi qrupunun fərdi üzvləri arasında.

Fərdi psixoterapiyada iki insan arasındakı emosional əlaqə adətən daha güclü və daha sabit olur. Hekayə danışmağın daha böyük yaxınlığı müşahidə olunur*; azadlığın itirilməsi qorxusu yoxdur, çünki povest istənilən əlverişli anda kəsilə bilər.

Başqa bir insanla ailə, erotik, peşəkar və ya digər əlaqə varsa, emosiyalar dəyişkən olur: müstəqillik və azadlıq arzusu mənfi əhval-ruhiyyənin yaranmasına səbəb olur.

Bir qrupdakı emosional əlaqələr daha mürəkkəbdir, bu cür əlaqələrin çoxluğundan irəli gəlir və nəticədə onlar daha zəif və daha stabil olurlar. Qrup üzvləri mövcud vəziyyətdən asılı olaraq fərdi üzvlərlə fərqli şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Bu, hazırda fikirlərini bölüşən birinə etibar edə bilsələr, aqressiyanı azaltmağı asanlaşdırır.

Aqressiyanı aradan qaldırmaq qrupdan kənarlaşdırılma ilə təhdid etmir. Fərdi psixoterapiyada xəstə terapevtə qarşı mənfi hisslərini gizlədir, onları itirməkdən qorxur.

Qrup psixoterapiyasında qrup qorxusu hekayənin kortəbiiyini məhdudlaşdırır.

Qrup qarşısında davranmaq onun rəğbətini qazanmaq tələb edir. Bəzən qrup qorxusu stimullaşdırıcı təsir göstərir, özünü günahlandırma meyillərini, digər qrup üzvlərinə qarşı aqressivliyi və liderlik etmək istəyini səfərbər edir. Lakin, xəstə haqqında qrup psixoterapiya seansından daha çox şey fərdi söhbətdə öyrənilə bilər. Digər tərəfdən, xəstənin qrupdakı davranışı onun başqalarına münasibətinə daha aydın işıq salır ki, bu da tez-tez xəstənin öz hekayəsində səhv təqdim olunur.

// Qrup Bağlanması

Qrup bağlanması psixoterapiya prosesində mühüm amil kimi görünür. Fərdi təmasda xəstə terapevtə, qrup təmasında isə qrupdan dəstək tapır. Xəstə artıq tək deyil; "Mən" "biz" ilə əvəz olunur və qrup həmrəyliyi hissi xəstənin özünü gücləndirmə hissini gücləndirir.

Bu fenomen kütləvi hərəkətlərdə müşahidə edilənə bənzəyir: insan cəmiyyət sayəsində özünü güclü hiss edir; O, özbaşına, qorxularına, əhval-ruhiyyəsinə, düşüncələrinə buraxılmaz, əksinə, sanki onlardan qaynaqlanan "mayelərin" və ya "titrəmələrin" təsiri altında başqaları kimi hiss etməyə və düşünməyə başlayır. Əlbəttə ki, insan öz təcrübə dünyasına qərq ola və qrupda təcrid olunmuş vəziyyətdən daha çox tək hiss edə bilər. Bu, insanın başqalarına münasibəti kəskin mənfi olduqda, qorxu və ya təcavüzlə dolu olduqda, özü ilə başqaları arasında bölücü bir xətt hiss etdikdə, onlarla deyil, onlara qarşı olduqda baş verir.

Qrup mənsəbiyyətinin - "biz hiss etdiyimiz"-in - kökündə, görünür, heyvanlar aləminin bəzi nümayəndələrində aydın şəkildə özünü göstərən sürü instinkti ilə əlaqəli atavistik bir hiss dayanır. Lakin insanlar bunu çətin vəziyyətlərdə, təhlükə qarşısında, müharibədə, həbs düşərgələrində, inqilab zamanı və s. də yaşayırlar. Özünü çarəsiz və çaşqın, öz cihazlarına buraxılmış hiss edir və başqalarına qoşulduqda güc qaydır. Ruhi xəstələrin vəziyyəti o qədər də dramatik görünməyə bilər, lakin onlar da normal həyatda özlərini itirmiş hiss edirlər və qrup psixoterapiyası onlara qrupa güvənərək güclərini bərpa etmək imkanı verir.

Qrup psixoterapiyası zamanı əhval-ruhiyyənin və emosional vəziyyətin qarşılıqlı ötürülməsi, sözdə "mayelər" və ya "titrəmələr", daha gərgin söhbətlərə gətirib çıxarır ki,

bunun məzmununu fərdi psixoterapiyaya nisbətən proqnozlaşdırmaq daha çətinidir. Xəstələrin özləri haqqında çox və həvəslə danışdıqları görüşlər var,

xəstələrin səssiz qaldığı və ya neytral mövzularda hekayələrlə məhdudlaşdığı görüşlər də var. Əlbəttə ki, psixoterapiyanın gedişi əsasən psixoterapevtin təcrübəsindən asılıdır.

// Fasilitatorun rolu

Qrup fasilitatorunun rolu asan deyil. Hər şeydən əvvəl, fasilitator özünü

rahat hiss etməlidir. Qrupda həmişə məhdud hiss edən insanlar var və onlar qrup psixoterapiyası aparmaqda xüsusilə çətinlik çəkirlər, çünki məhdudiyyət, qeyri-təbiiilik və özlərini gizlətmək ehtiyacı hissələri onların özləri olmalarına mane olur ki, bu da

hər psixoterapiya formasında əhəmiyyətli bir çətinlik yaradır. Onlar xəstə ilə özləri arasındakı sərhədi aşmalıdırlar. Bir qrup xəstə həmişə terapevti

piyada görmək istəyir. İlk görüşlər zamanı xəstə sadəcə olaraq terapevtə müləicə və diaqnozla bağlı şübhələrini izah etməsini tələb edir.

Belə hallarda, bu görüşlərin səmimi xəstə hekayələri və onları həll etmək cəhdləri üçün nəzərdə tutulduğunu açıq şəkildə bildirmək lazımdır. Lakin bu səmimi özünü açıqlamada rollar bərabər deyil. Terapevt deyil, xəstə danışır və hətta terapevt xəstələrlə bərabər şəraitdə olmaq üçün bütün səylərini göstərsə belə, onları ayıran sərhəd heç vaxt tamamilə aradan qaldırıla bilməz. Bəzi psixiatrlar, işçi heyəti ilə xəstələr arasında bərabərlik platformasının sadəcə uydurma olduğunu qəbul edərək, liderlik rolunu öz üzərinə götürməyə razıdırlar. Onlar özləri görüşlər keçirir, müzakirə mövzuları təklif edir, xəstələrin ifadələrini şərh edir və hətta onların fikirlərini qiymətləndirirlər. Düzdür, heç bir psixiatr tam bərabərlik prinsipini qəbul etsə də, psixoterapiya seansları zamanı münaqişələrini xəstələrlə eyni şəkildə müzakirə etməz, lakin onların çoxu xəstələrlə eyni hissləri keçirir və xəstələrin qaldırdığı məsələlər də çox vaxt onların öz problemləridir.

// Qrup Ölçüsü

Qrup nə çox böyük, nə də çox kiçik olmalıdır. Əgər çoxlu sayda xəstə görüşürsə, onda yalnız bəziləri fəal iştirak edir, digərləri isə dinləyir və ya qrup bir neçə alt qrupa bölünür və "alt müzakirələr" başlayır.

Böyük bir qrupda atmosfer həmişə daha rəsmi olur və avtomatik olaraq "danışanlar" və "dinləyicilər", "liderlər" və "adi üzvlər" arasında bölünmə yaradır. Əgər qrup çox kiçikdirsə, "boşaltma" çox tez-tez baş verir; hər kəs artıq danışır, heç kim yeni söhbət mövzusu açmır; deyiləcək şey əvvəlcədən məlumdur. Müşahidələrə əsasən, səkkiz nəfərlik qrup ən yaxşı hesab olunur.

// "Açıq" və "Qapalı" Qruplar

"Açıq" və "qapalı" qruplar arasında fərq qoyulur. "Açıq" qruplarda üzvlərin tərkibi dəyişir, "qapalı" qruplarda isə sabit qalır. Xəstəxana şəraitində yalnız "açıq" qruplar aparıla bilər, çünki şöbədəki xəstələrin tərkibi daim dəyişir. Ambulator şəraitdə daimi xəstə qrupu seçilə bilər.

Xəstənin xəstəxanada qalması adətən bir neçə həftə davam edir və buna görə də onlar yalnız bir neçə qrup seanslarında iştirak edə bilərlər ki, bu da qrup daxilində lazımi qrup bağı və "yaxınlıq" hissi yaratmaq üçün kifayət deyil. Yeni xəstələr daim mövcud qrupa əlavə olunur və bu, bu hissi pozur. Buna görə də, "açıq" qrupların təbiəti "qapalı" qruplardan daha səthi olur. Bunlar, sonuncular, bir neçə ay, bəzən illər ərzində eyni xəstə qrupu və müalicə heyəti ilə aparılır. İnsanlar bir-birini yaxşı tanıya, özlərini təhlükəsiz hiss edə və təcrübələrinin sirləri ilə bağlı ola bilərlər.

Qrupda müzakirə edilən təcrübələrin yaxınlığı səbəbindən, "qapalı" qrup üzvlərinin yalnız psixoterapiya seansları zamanı görüşməsi daha yaxşıdır.

Dostluq əlaqələri həmişə psixoterapevtik bağı zəiflədir. Bu prinsip fərdi psixoterapiyaya da aiddir. Terapevt öz xəstələri ilə ictimaiyyət qarşısında görüşməməlidir. "Qapalı" qrupların mənfi tərəfi, müəyyən bir durğunluq yarana biləcəyi üçün yeni üzvlərin axını şəklində "həyat verən" olmamasıdır.

// Xəstə Seçimi

Xəstə seçimi mübahisəli bir məsələ olaraq qalır. Əksəriyyəti həddindən artıq homogen qrupların testdən keçə bilmədiyinə inanır, çünki onlar oxşar şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik, forma və məzmun baxımından oxşar nevroitik təcrübələrdən əziyyət çəkən xəstələrdən ibarətdir.

Lakin digər tərəfdən, homogen qruplar hələ də təşkil olunur, məsələn, alkoqoliklər qrupları, şizofreniyalı və ya "çətin" uşaqların valideynləri, nevroitik ailə mənşəli xəstələr, cinsi çətinlikləri olanlar və s. Bu tip "homogen" qruplar bəzən "ümumi bir xəstəlik" əsasında qrup əlaqəsinin yaranmasına kömək edir. Belə qrupların müzakirələrə başlaması daha asandır.

Lakin bir qrupun homogenliyi üzvlərinin həyatlarının müxtəlifliyi ilə ziddiyyət təşkil edir.

Kiçik bir qrup müəyyən dərəcədə sosial mühiti əks etdirməli və beləliklə, heterojen olmalıdır. Ziddiyyətli problemlərin homogenliyi, xüsusən də psixoloji siluətlərin homogenliyi, insanları birləşdirmək əvəzinə, onları tez-tez bölür. İnsanlar öz həmkarlarını bəyənmir və əkslərinə cəlb olunurlar. "Heterojen" qruplarda xəstə seçimi aparılmır; Hər kəsin psixoterapiya qrupunda olmaq hüququ var. Yalnız demansa bənzər xüsusiyyətləri olan və ya kəskin psixotik vəziyyətdə olan xəstələrin davranışları digər qrup üzvlərini şoka sala biləcəyi üçün qrupdan kənarlaşdırılır.

Bir qrup, manik xəstələr kimi həddindən artıq dinamik xəstələr, eləcə də dominant şəxsiyyət xüsusiyyətləri olan xəstələr tərəfindən asanlıqla parçalana bilər; beləliklə, isterik bir şəxs bütün görüşü "monopolizləşdirir", yeganə iştirakçı olmaqla, öz fikirlərini başqalarına sıraya və terapevtin diqqətini özünə yönəltməyə çalışa bilər.

// Qrup Psixoterapiyasının Populyarlığı

Qrup psixoterapiyasının populyarlığını dövrümüzün spesifik iqlimi ilə müqayisə etmək olar. Təbii mühitin süni, texnoloji mühitə çevrilməsi şəxslərarası münasibətlərə təsir göstərir. Bu münasibətlər uyğunluğa əsaslanaraq səthi olur (necə ki, bir obyekt və ya şəxs lazım olduqda və faydalı ola bildikdə yaxşıdır) və başqa bir insanın gizli ehtiyacını ödəmir.

Psixoterapevtik qrup ümumi şəxsiyyətlərarası münasibətlər üslubu ilə ziddiyyət təşkil edir - bu üslubda təmas daha da dərinləşir, gündəlik həyatda daim taxmalı olduğu maskanı çıxarmaq olar (amerikalıların "gülümsəməyə davam et" dediyi kimi), özü olmaq və qrup tərəfdaşlarının anlayışına güvənmək olar. Sosial qiymətləndirmə ("sosial əks etdirmə") həyatda uyğunluq prinsipinə deyil, insanın bir şəxs kimi və buna görə də onun bütün şəxsiyyətinin, təcrübələri, əzabları, potensialı və s. ilə qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Üstəlik, spesifik dostluq atmosferi xəstəni qorxu və utanc reaksiyalarından qoruyur. Onlar başa düşüləcəklərini və qrupdan kənarlaşdırılmayacaqlarını bilirlər, yəni həyatda çox qorxduqları hər şeydən qaçacaqlar. Qrup psixoterapiyası müasir texnoloji sivilizasiyada olmayan sosial insan ehtiyaclarını ödəyir.

// Çətin Başlanğıc

Qrup psixoterapiyasına başlayarkən terapevt tez-tez xəstələr qrupundan qorxur, nədən danışacaqlarından, nə soruşacaqlarından və suallarına cavab verə biləcəklərindən əmin deyil; bəlkə də onlar susacaqlar və bu sükutu poza bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, psixoterapiya zamanı terapevt tez-tez özünü çətin vəziyyətdə tapır.

və bundan necə çıxacağını bilmir. Lakin, görüşlər, bəzən onları kimin və necə aparmasından asılı olmayaraq, əsasən uğurlu olur. Müşahidələrini, uzun-uzadı düşüncələrini və ortaq bir dili bölüşmək ehtiyacı xəstələrdə o qədər güclüdür ki, psixoterapiya aparan həkim və ya psixoloq tərəfindən edilən hər hansı bir səhvi düzəldirlər.

Görüşlərin düzgün təbiətini lap əvvəldən müəyyən etmək vacibdir. Xəstələr bu görüşlərin məqsədini xüsusilə aydın başa düşürlər. Görüşlərdə xəstəxana işçilərinin nümayəndələri iştirak etdiyindən, müalicə edənlər və müalicə olunanlar arasında bölünmə təbii hala gəlir. Buna görə də, xəstələrin ilk sualları müalicə üsulları, xəstəxanada qalma müddəti, xəstəlikləri haqqında məlumat və s. ilə bağlıdır. İlk görüşlərdə məktəb atmosferi olur: şagird-xəstələr müəllim-həkim və ya psixoloqdan xəbər gözləyirlər. Bu təbii meyillərə dərhal qarşı çıxmaq üçün xəstələrə görüşlərin məqsədinin həmişə öz problemlərini müzakirə etmək olacağını və bu görüşlərdə həkimin rolunun çox güman ki, passiv olduğunu və yalnız müstəsna hallarda problemi aydınlaşdırma biləcəklərini izah etmək lazımdır.

Tədricən, xəstə problemləri barədə getdikcə daha sərbəst danışmağa başlayır. Bəziləri daha asan, digərləri isə daha çətindir, bu, onların şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən, problemin dərinliyindən, qrupda özlərini necə hiss etmələrindən və s. asılıdır. Əvvəlcə susanlara təzyiq göstərməyin, çünki təzyiq altında onlar öz təcrübələrinə daha çox qərq ola bilirlər. Əvvəlcə qrupa alışırlar, sonra isə bəzən digər xəstələrin təsiri altında və ya özləri ümumi söhbət axınına qoşulmağa başlasınlar. Bəzi hallarda açıq qruplar xəstələrdən özləri, münaqişələri və həyatları haqqında etiraf etmələrini tələb edir. Tanış olmayan bir qrupla ilk təmas zamanı bu cür etiraf silinməz bir travma yaradır və bu cür metodlardan çəkinmək lazımdır.

// Ən Çox Görülən Söhbət Mövzuları

Söhbət ən çox üç mövzuya toxunur: xəstəlik, həyat problemləri və şöbədəki mövcud problemlər. Xəstələr əvvəlcə şikayətlərini bildirməyə hazırdırlar. Bu, daha az intim bir mövzudur və üstəlik, sağlamlıqları üçün məsuliyyət həkimin üzərindədir.

Xəstəlik haqqında danışmaqla həkim, sanki, özünü duela çağırır. Psixoterapevt özünü belə bir çətinlikdən qorunmalıdır; onlar xəstələrin xəstəlik, onun etiologiyası və müalicə üsulları haqqında söhbətlərinə cəlb olunmamalıdırlar, çünki bu zaman psixoterapiya psixiatriya üzrə mühazirəyə çevrilirdi. Bundan əlavə, ruhi xəstəlik nəzəriyyəsi hələ də qeyri-müəyyən və qeyri-müəyyəndir və buna görə də hətta ən yaxşı mühazirə belə xəstələri qane etməzdi. Qrup təzyiqi çox güclüdirsə, onda nevrozların əsas səbəblərindən birinin emosional münaqişələr olduğunu və bunları müzakirə etməyin psixoterapiyanın əsas məqsədi olduğunu izah etmək olar. Müzakirə üçün digər məşhur mövzu palatanın həyatıdır. Bu həyat çatışmazlıqlarla doludur və buna görə palata rəhbərləri məsuliyyət daşıyır. Yenə də müzakirə üçün məsuliyyəti müalicə heyətinə ötürmək meylli var. Palatadakı xəstələr arasındakı münaqişələri müzakirə etməklə, insan təbiətinə uyğun olan hakim kimi çıxış etmək olar. Lakin, bu mövzunu keçmək olmaz. Palatanın gündəlik həyatı adi həyatın bir modelidir. Kiçik məsələlər tez-tez ciddi münaqişələri və adaptasiya çətinliklərini əks etdirir. Xəstənin palatadakı davranışını müşahidə etməklə, onun normal mühitdəki davranışını asanlıqla təsəvvür etmək və özləri və ətrafdakı insanlarla çətinliklərini qiymətləndirmək olar. Beləliklə, palata həyatının kiçik problemlərini təhlil etmək, insanların qarşılıqlı əlaqələrindəki və öz şəxsiyyətinin strukturundakı əsas qüsurların təhlilinə keçməyə imkan verir.

Fərdi psixoterapiyada xəstələr gündəlik həyatın ümumi problemlərini də dəfələrlə müzakirə edirlər. Bacarıqlı rəhbərliklə söhbət xəstənin həyat tarixçəsinə və ya emosional vəziyyətinə keçə bilər. Bir insanın davranışındakı və təcrübələrindəki hər bir detalın onun keçmişini əks etdirdiyini, sanki bütün həyatının miniatürünü təmsil etdiyini təkrarlamağa ehtiyac yoxdur.

// Təfərrüatdan Bütövə

Həm diaqnozda, həm də psixiatrik terapiyada (burada psixoterapiyadan danışırıq) ən vacib bacarıq detaldan bütöv mənzərəyə keçmək bacarığıdır. Xəstələr bu bacarığı zamanla əldə edirlər. Təfərrüatdan başlayaraq bütövə doğru irəliləyərək, xəstələr keçmişləri, ən çətin təcrübələri, öhdəsindən gələ bilmədikləri hisslər və psixikalarında qalan travmalar haqqında danışirlar. Bu proses kortəbii şəkildə baş verməlidir; xəstəyə özləri haqqında danışmaq "əmr edilə bilməz". Nə psixiatrik müayinə, nə də psixoterapiya xəstənin həyat tarixçəsinə, hətta ən ətraflı şəkildə belə başa düşməsinə gözləmir. Psixiatrik müayinə araşdırma deyil.

Psixiatr xəstənin həyatını bilməlidir, lakin bu, tədricən öyrənilməli, onu müxtəlif, bəzən çox kiçik, əhəmiyyətsiz görünən fraqmentlərdən yenidən qurmalıdır. Fərdi və ya qrup psixoterapiyası zamanı xəstə öz psixiatri olmağı öyrənir. Onlar öz təcrübələri və davranış nümunələri haqqında müəyyən bir perspektiv əldə edirlər və hər birində həyatın bütövlüyünün əksini görməyə başlayırlar.

Qrup psixoterapiyası xəstəyə fərdi psixoterapiya ilə eyni dərəcədə olmasa da, təcrübələrini anlamağa imkan verir. Onların daxilində xaos və şüursuz olan hər şey müəyyən dərəcədə nizama salınır.

// Hipotetik Terapevtik Faktorlar

Fərdi psixoterapiyada özünü təhsil ən dərinidir. Bu vəziyyətə təmasın yaxınlığı və psixoterapevtin diqqəti təsir göstərir, bu diqqət yalnız bir xəstəyə yönəlib. Digər tərəfdən,* tanıma gücü, yəni özünü yeni bir işıqda görmək və özünü başqa bir insana göstərməklə əlaqəli emosional reaksiya, psixoterapiya zamanı yaşanan bu təmizlənmə hissi - katarsis, qrup psixoterapiyasından xeyli böyükdür. Böyük bir qrup insanın yanında özündən danışmaqla əlaqəli daxili müqaviməti dəf etmək lazımdır və bu cür müqaviməti dəf etmək təmizlənmə prosesinə daha çox güc verir.

Bu müqavimət, şübhəsiz ki, isterik ifadə xüsusiyyətlərinə malik insanlarda daha azdır. Onlar üçün zehni eksperimentizm məmnuniyyət mənbəyidir. Belə insanlar adətən özləri haqqında çox danışirlar və hər kəsin diqqətini cəlb etməyə çalışirlar. Buna görə də, bir qrup seçərkən isterik şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə malik xəstələrin sayını nəzərə almaq və onları bir yerə toplamamağa çalışmaq lazımdır.

Fərdi və ya qrup şəklində tətbiq olunan psixoterapevtik yardım, özünü təhsil prosesi ilə əlaqəli emosional vəziyyətlə mütənəsibdir ki, bu da öz növbəsində təmizlənmə prosesi zamanı daxili müqavimətlə mütənəsibdir. Bu müqavimət isterikada zəif olduğundan, psixoterapiya qənaətbəxş nəticələr vermir.

Daxili müqavimət anlayışı yuxarıda müzakirə edilən xarici müqavimətlə eyniləşdirilə bilməz. "Təmizlənmənin" mümkün olması üçün mühit dəstəkləyici olmalıdır.

Xəstəni qəbul edin, ona ən az müqavimət göstərin və xəstənin özü daxili müqavimətini dəf etməlidir. Daxili mübarizə nə qədər şiddətli olarsa, katarsis bir o qədər güclüdür.

Özünütəhsil elementi ilə təmizlənmə hissi birləşən qrup bağlantısı elementi - "hiss etdiyimiz" – qrup psixoterapiyasında ən böyük terapevtik rol oynayır. Xüsusilə autizm və insanlardan qorxmanın əsas simptomları arasında olduğu şizofreniyanın müalicəsində qrup psixoterapiyası xəstənin sosial mühitə qayıtmasını asanlaşdırır bilər. Nevrozlu bir xəstə, şizofreniyalıdan fərqli bir şəkildə olsa da, insanlardan təcrid olunmasını da yaşayır; o, tənha, yanlış başa düşülən, kinli, sosial

rolun yükünü daşımaqdan bezmiş hiss edir, onsuz cəmiyyətdən kənarlaşdırılırdı - bir sözlə, belə hallarda deyildiyi kimi "yadlaşmış". Onun özü kimi insanlar arasında olması, oxşar problemləri və hissləri olması, həmçinin ətraf mühitdən təhlükəyə məruz qalması özünəməxsus "korpus ruhu" yaradır.

İnsan təbiətinin sosial təbiəti, təhlükənin mənbəyindən və xarici (məsələn, müharibə zamanı) və ya daxili (məsələn, xəstəlik zamanı) yerindən asılı olmayaraq, xüsusilə çətin vəziyyətlərdə özünü göstərir. Bu zaman insan özünü güclü hiss etdiyi vaxtdan daha çox başqa bir insana ehtiyac duyur.

Tənhalıq yetkinlik əlaməti hesab olunursa, bu fenomen regressiya (ana, ata və s. axtarışı) simptomu kimi qəbul edilə bilər. Bu anların izahından asılı olmayaraq, çətin vəziyyətlərin qrup əlaqəsinə ehtiyac yaratdığını qeyd etmək vacibdir.

/ Dürğunluq Dövləri

Bütün psixoterapevtik görüşlər uğurlu olmur. Çox vaxt iştirakçıları sükut örtüyü bürüyür və ya söhbət neytral, əlaqəsiz mövzulara toxunaraq ləng gedir. Eyni şey fərdi psixoterapiyada da baş verir, bir sıra seanslar ərzində dəfələrlə heç nə baş vermir. Bəzən belə dürğunluq dövrləri müqavimət siqnalları ola bilər: xəstələr müəyyən bir nöqtəyə çatıblar ki, onlar bunu dəf etməli, öz təcrübələrini daha dərinləndirərək araşdırmalı, özlərini fərqli görməyə çalışmalıdırlar. Lakin onlar bunu etməyə gücləri çatmır və bəzən psixoterapevtin özü onlara depresif təsir göstərir. Xəstələrinin təcrübələrinin xaosundan qorxan psixoterapevt, döyülmüş yoldan yayınmır və təlaşla aşağıdakılara yapışır: simptom təhlili, davranış nümunələri, uşaqlıq təcrübələri və s. Belə dürğunluq dövrlərində gözləmək, sükutdan qorxmamaq, boş söhbətlərə sakitcə dözmək və insan təmaslarının təkamülünə inam saxlamaq daha yaxşıdır. İnsanlar arasında sıx təmasda həmişə bir şey baş verməlidir; onların münasibətləri dürğunlaşa bilməz; qarşılıqlı öyrənmə və emosional iqlim daim dərinləşməlidir. Əgər onlardan ən azı biri tərəfdaşına qarşı müsbət münasibət bəsləyirsə, nəticədə qaçmaq istəyini dəf edəcək. Münasibətlərin təkamülü evli həyatın ən vacib problemlərindən birini təşkil edir. Əgər bu təkamül yoxdursa, "evlilik əzab olacaq". Əlbəttə ki, psixoterapiyada cinsi partnyorlar arasında olduğu kimi güclü emosional gərginlik yoxdur və bu da psixoterapevtin qrup təmasda tərəfdaşa qarşı daim müsbət münasibət saxlamasını və qarşılıqlı fikir ayrılığının qarşısını almasını asanlaşdırır. Xəstə terapevtinin yanına qayıdacaq və sonra münasibətlər daha da zənginləşəcək.

// "Günah keçisi" axtarın

Qrup psixoterapiyasında iştirakçıların qrup üzvlərindən birinə münasibətdə hakim rolunu öz üzərinə götürmələri tez-tez baş verir. Hakim rolu insanların özlərində daşdığı roldur və dəvət olunmasa da, könüllü olaraq bu rolu öz üzərinə götürür.

Psixoterapevt bu mühakimə etmə meyllərini cilovlamaq üçün böyük səy göstərməlidir. Xəstələrdən belə bir səy gözləmək olmaz; onlara tolerantlıq öyrədilməlidir, lakin onların hakim kimi davranmaq istəyi təəccüblü olmamalıdır. Qrup üzvlərindən biri mühakimə olunarkən çətin bir vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün psixoterapevtdən böyük bir taktika tələb olunur.

Qrup aqressivləşdikdə və günah keçisi axtarıqda, psixoterapevtin məsuliyyəti mühakimə olunan şəxsə dəstək olmaqdır. Çətin vəziyyətlərdə ən yaxşısı "ekspert" rolunu mənimsəmək və nəticədə yaranan emosional vəziyyəti izah etməkdir (məsələn, mühakimə edənlərin aqressiv hərəkətlərini təhlil etməklə).

// Gözlənilməz Vəziyyətlər

Fərdi terapiyada olduğu kimi, qrup psixoterapiyasında da gözlənilməz vəziyyətlər həmişə yarana bilər. Bəzən xəstələrin ifadələri və onlarla terapevt arasında baş verən vəziyyətlər hətta ən təcrübəli psixoterapevtləri belə təəccübləndirə bilər. Çox vaxt vəziyyətə necə reaksiya verəcəyiniz, hansı cavabı verəcəyiniz bəlli deyil. Buna görə də, psixoterapiya zamanı daha passiv rol oynayanlar daha asan vəziyyətdədirlər. Lakin onlar da bəzən cavab verməlidirlər.

Belə hallarda səmimi olmaq - səriştəsizliyinizi etiraf etmək və ya fikrinizi bildirmək, bunun səhv ola biləcəyini vurğulamaq ən yaxşısıdır.

Bəzən qrup terapevtdən konkret bir vəziyyəti qiymətləndirməsini və ya daha da pisi, konkret bir şəxsi qiymətləndirməsini tələb edir. Psixiatriın rolu hakim deyil.

Psixiatriın işi mühakimə etmək deyil, anlamaqdır və məhz bu səbəbdən onlar xəstələrinə bu sənəti öyrətməlidirlər. Psixiatriyla yaxşı münasibət, onun təsiri altında başqa bir şəxs də müəyyən dərəcədə psixiatri olduqda yaxşı hesab edilə bilər.

// Sənədləşdirmə

Psixoterapiya zamanı baş verən hər şeyi qeyd etmək olduqca çətin bir işdir. Qrup üzvlərinin (yəni xəstələrin və müalicə heyətinin) ifadələrinə əsaslanaraq, onların təcrübələrini yenidən qurmaq və hər birinin şəxsiyyəti və həyat tarixi fonunda şərh etmək, həmçinin psixoterapiya zamanı qrup üzvləri arasında inkişaf edən emosional əlaqələrin kətanları ilə müqayisə etmək lazımdır. Əlbəttə ki, psixoterapiya seansı haqqında ən yaxşı hesabat belə arzuolunan idealdan çox uzaqdır.

Psixoterapiya zamanı baş verən hər şeyi xatırlamaq mümkün deyil. Buna görə də, qrup psixoterapiyasının gedişatına obyektiv baxış üçün başqa bir insanın (sözdə müşahidəçi adlanan şəxsin) olması tövsiyə olunur. Müşahidəçi baş verən hər şeyi kənardan, o cümlədən terapevtdən müşahidə edə bilər və buna görə də onlar tez-tez psixoterapevtdən daha çox şey görür və xatırlayırlar. Bəziləri maqnitofondan istifadə edirlər, lakin yadda saxlamaq vacibdir ki, qeydin özü psixoterapiya prosesini dəqiq əks etdirə bilməz. Maqnitofon yalnız şifahi ifadələri qeyd edir və bəzən heç nə deyilmədiyi anlar daha vacibdir. Üz ifadələri, jestlər və baxışlar çox vaxt daha vacibdir - psixoterapiya zamanı hökm sürən emosional iqlimin bütün xarici təzahürləri.

Fərdi psixoterapiyada bu vəziyyət daha sadədir, çünki iki nəfər müşahidə olunur — xəstə və terapevt. Psixoterapiya seansı zamanı onların təcrübələrini xatırlamaq və izah etmək daha asandır. Qrup şəklində

Psixoterapiyada hər bir qrup üzvünün yaşadığı hər şeyi eyni vaxtda ələ keçirmək demək olar ki, mümkün deyil. Diqqət mütləq qrup üzvləri arasındakı qarşılıqlı təsirin xarici simptomlarına yönəldilməlidir. Fərdi psixoterapiyada xəstənin fərdi mühitinə, yəni onun şəxsi təcrübə dünyasına dərinlən nüfuz etməyə çalışarkən, qarşılıqlı əlaqə zamanı psixiatr və xəstəsi arasındakı ortaq mühiti başlanğıc nöqtəsi kimi götürsək, qrup psixoterapiyasında ortaq məkanı, yəni sosial mühiti təhlil etməklə məhdudlaşmalıyıq. Fərdi psixoterapiya qrup psixoterapiyası ilə birləşdirilsə, fərdi söhbətlər vasitəsilə əldə edilən xəstənin obrazını qrupdakı obrazı ilə müqayisə etmək eyni insanı iki perspektivdən - daxili (fərdi mühitində) və daha xarici (sosial mühitində) baxımdan qiymətləndirməyə imkan verir. Birincisi, funksional, reallaşmamış strukturları, gizli emosiyaları, xəyalları, xatirələri və ifadə etmək çətin olan düşüncələri təsvir edir. İkincisi, reallaşmış strukturları - sözləri, jestləri, üz ifadələrini və qrupda yaranan müəyyən bir vəziyyətə cavab verməyin digər yollarını təsvir edir.

Fərdi mühit gələcək və keçmiş zamanların məkanını, sosial (ümumi) mühit isə indiki zaman məkanını təmsil edir.

Həm fərdi, həm də qrup psixoterapiyasında psixoterapiya görüşü başa çatdıqdan dərhal sonra baş verən hər şeyi qeyd etmək ən yaxşısıdır.

Hadisələrin və öz emosional reaksiyalarının yaddaşı daha kəskin olur. Həmçinin psixoterapiya zamanı təcrübələrinizi, xüsusən də emosional təcrübələrinizi qeyd etmək və hadisələrin qısa şərhini vermək tövsiyə olunur. Psixoterapiya görüşlərinin köhnə qeydlərini yenidən oxumaqla psixoterapevtik prosesin dinamikasını, onun dayanma vaxtlarını izləmək və öz səhvlərinizi və yanlış şərhələrinizi tanımaq olar.

Təqdim olunan şərhlər nevrozların psixoterapiyası ilə bağlı bütün problemləri və fikirləri əhatə etməyə belə başlamır. Yalnız praktik baxımdan ən əhəmiyyətli görünən məsələlər vurğulanır. Hər bir praktikant şəxsiyyətdən, xəstələrlə qarşılıqlı əlaqə zamanı təcrübələrinin təbiətindən, oxuduğu ədəbiyyatdan, yüksək vəzifəli həmkarlarının təsirindən, mövcud ehtiyaclarından (mütəmadi, uzunmüddətli psixoterapiya üçün həmişə kifayət qədər vaxt olmur) və s. asılı olaraq öz psixoterapiya tərzini inkişaf etdirməlidir. Nevrozların müalicəsini müzakirə edərkən, vurğu psixoterapevtik müalicəyə yönəldilir, çünki mənim fikrimcə, o, ən vacib, lakin yeganə rol oynamır.